

LIBRO DE BANCOS DE PREGUNTAS

DR: GUILLERMO GUEVARA ALIAGA

ÍNDICE PRUEBAS DE MEDICINA INTERNA

I) CARDIOLOGÍA

Prueba 1.....	Pág 04
Prueba 2.....	Pág 07
Prueba 3.....	Pág 10
Prueba 4.....	Pág 11
Prueba 5.....	Pág 17
Prueba 6.....	Pág 20
Prueba 7.....	Pág 24
Prueba 8.....	Pág 28
Prueba 9.....	Pág 32
Prueba 10.....	Pág 36
Prueba 11.....	Pág 40
Respuestas.....	Pág 43

II) RESPIRATORIO

Prueba 1.....	Pág 44
Prueba 2.....	Pág 47
Prueba 3.....	Pág 50
Prueba 4.....	Pág 54
Prueba 5.....	Pág 57
Prueba 6.....	Pág 61
Prueba 7.....	Pág 65
Prueba 8.....	Pág 69
Prueba 9.....	Pág 73
Prueba 10.....	Pág 17
Respuestas.....	Pág 77

III) GASTROENTEROLOGÍA

Prueba 1.....	Pág 78
Prueba 2.....	Pág 80
Prueba 3.....	Pág 84
Prueba 4.....	Pág 87
Prueba 5.....	Pág 90
Prueba 6.....	Pág 93
Prueba 7.....	Pág 96
Prueba 8.....	Pág 100
Prueba 9.....	Pág 103
Prueba 10.....	Pág 107
Prueba 11.....	Pág 44
Respuestas.....	Pág 111

IV) NEFROLOGÍA

Prueba 1.....	Pág 112
Prueba 2.....	Pág 115
Prueba 3.....	Pág 118
Prueba 4.....	Pág 121
Prueba 5.....	Pág 124
Prueba 6.....	Pág 128
Prueba 7.....	Pág 132
Prueba 8.....	Pág 135
Prueba 9.....	Pág 139
Respuestas.....	Pág 142

V) NEUROLOGÍA

Prueba 1.....	Pág 143
Prueba 2.....	Pág 146
Prueba 3.....	Pág 149
Prueba 4.....	Pág 152
Prueba 5.....	Pág 155
Prueba 6.....	Pág 158
Prueba 7.....	Pág 162
Prueba 8.....	Pág 165
Prueba 9.....	Pág 168
Prueba 10.....	Pág 171
Respuestas.....	Pág 174

VI) ENDOCRINOLOGÍA DIABETES Y NUTRICIÓN

Prueba 1.....	Pág 175
Prueba 2.....	Pág 178
Prueba 3.....	Pág 181
Prueba 4.....	Pág 184
Prueba 5.....	Pág 187
Prueba 6.....	Pág 190
Prueba 7.....	Pág 193
Prueba 8.....	Pág 196
Prueba 9.....	Pág 200
Prueba 10.....	Pág 202
Prueba 11.....	Pág 206
Prueba 12.....	Pág 209
Prueba 13.....	Pág 212
Prueba 14.....	Pág 215
Prueba 15.....	Pág 218
Prueba 16.....	Pág 221
Respuestas.....	Pág 225

VII) REUMATOLOGÍA

Prueba 1.....	Pág 227
Prueba 2.....	Pág 229
Prueba 3.....	Pág 232
Prueba 4.....	Pág 235
Prueba 5.....	Pág 239
Prueba 6.....	Pág 243
Prueba 7.....	Pág 246
Prueba 8.....	Pág 190
Prueba 9.....	Pág 196
Prueba 10.....	Pág 209
Respuestas.....	Pág 250

VIII) INFECTOLOGÍA

Prueba 1.....	Pág 251
Prueba 2.....	Pág 254
Prueba 3.....	Pág 257
Prueba 4.....	Pág 260
Prueba 5.....	Pág 263
Prueba 6.....	Pág 266
Prueba 7.....	Pág 269
Prueba 8.....	Pág 273
Prueba 9.....	Pág 276
Prueba 10.....	Pág 279
Prueba 11.....	Pág 282
Respuestas.....	Pág 285

IX) HEMATO-ONCOLOGÍA

Prueba 1.....	Pág 286
Prueba 2.....	Pág 289
Prueba 3.....	Pág 292
Prueba 4.....	Pág 295
Prueba 5.....	Pág 299
Prueba 6.....	Pág 303
Prueba 7.....	Pág 306
Prueba 8.....	Pág 093
Prueba 9.....	Pág 155
Prueba 10.....	Pág 282
Respuestas.....	Pág 309

X) MIX DE MEDICINA INTERNA

Prueba 1.....	Pág 310
Prueba 2.....	Pág 321
Prueba 3.....	Pág 332
Prueba 4.....	Pág 344
Prueba 5.....	Pág 354
Prueba 6.....	Pág 366
Respuestas.....	Pág 377

MEDICINA INTERNA

I) CARDIOLOGÍA PRUEBAS

Prueba 1

1) En un adolescente de 17 años la presencia de un soplo sistólico de eyección asociado a desdoblamiento fijo del segundo ruido permite sospechar el diagnóstico de:

- a) comunicación interauricular
- b) ductus arterioso persistente
- c) comunicación interventricular
- d) válvula aórtica bicúspide
- e) coartación aórtica

2) En Chile, las principales causas de insuficiencia cardíaca son:

- a) Cardiopatía hipertensiva y valvulopatías
- b) Cardiopatía coronaria y miocardiopatía dilatada
- c) Cardiopatía coronaria y cardiopatía hipertensiva
- d) Cardiopatía hipertensiva y miocardiopatía dilatada
- e) Cardiopatía coronaria y valvulopatías

3) Paciente de 30 años, sin antecedentes cardiovasculares de importancia. Consulta por disnea de esfuerzos, ortopnea y DPN de instauración progresivas, desde hace 2 meses. La RxTx muestra cardiomegalia y signos de congestión pulmonar. Usted solicita ecocardiografía que muestra dilatación de todas las cavidades, con FE: 50%. Las medidas farmacológicas más importantes para este paciente son:

- a) Aspirina, estatinas y betabloqueantes
- b) Diuréticos, IECAs y aspirina
- c) Betabloqueantes, diuréticos e IECAs
- d) Espironolactona, IECAs y aspirina
- e) Amiodarona, betabloqueantes y diuréticos

4) Mujer 53 años, con disnea de esfuerzos progresiva, de 2 años de evolución, actualmente CFIII. Refiere expectoración rosada en algunas ocasiones. Al examen, PA:120/70, FC:102x', RI2T, soplo diastólico III/VI. Crépitos bibasales. El ECG, sólo demuestra ACxFA. El diagnóstico más probable es:

- a) Cardiopatía hipertensiva.
- b) TEP crónico
- c) Miocardiopatía dilatada
- d) Estenosis mitral
- e) Insuficiencia aórtica

5) Paciente hipertenso, de 67 años, con dolor torácico intenso, de inicio súbito. Al examen físico FC: 110x', regular, PA:230/128, asimetría en los pulsos radiales y a la auscultación cardíaca destaca un soplo diastólico. La conducta inicial más adecuada a seguir, además de tomar un ECG es:

- a) Realizar coronariografía urgente
- b) Administrar oxígeno, morfina, nitroglicerina y aspirina inmediatamente
- c) Realizar ecocardiograma transesofágico urgente
- d) Realizar pericardiocentesis
- e) Solicitar radiografía de tórax

6) Mujer de 45 años, hipertensa, consulta por palpitaciones de 3 días de evolución. Ingres a buenas condiciones, PA: 160/100, FC:102x'. El ECG muestra fibrilación auricular. La conducta inicial más adecuada es:

- a) Realizar cardioversión farmacológica con amiodarona
- b) Realizar cardioversión eléctrica
- c) Iniciar anticoagulación inmediata con heparina
- d) Iniciar betabloqueo a permanencia, como control de frecuencia
- e) Indicar digoxina a permanencia

7) Paciente de 59 años, HTA, DM2, fumador, refiere dolor en pantorrilla derecha al caminar 2 cuadras, que le impide seguir caminando y que cede con el reposo. La conducta más adecuada ante este cuadro clínico es:

- a) Ejercicios diarios y control médico de sus factores de riesgo cardiovascular
- b) Solicitar angiografía femoral para ubicar sitio de obstrucción e intentar angioplastia
- c) Iniciar anticoagulación oral con cumarínicos
- d) Derivar a cirujano vascular para cirugía de reperfusión de EEl
- e) Solicitar ecografía-doppler de EEl

8) Mujer 30 años con palpitaciones muy intensas de inicio y término brusco, de minutos de duración en varias oportunidades en los últimos años. Ingresa a urgencias por cuadro de palpitaciones intensas que esta vez no ha cedido. Al examen: FC:180x', PA:110/70. El ECG muestra taquicardia regular a QRS angosto. La primera medida a seguir es:

- a) Administrar adenosina endovenosa
- b) Administrar amiodarona endovenosa
- c) Realizar cardioversión eléctrica
- d) Realizar maniobras vagales
- e) Administrar propafenona o flecainida oral

9) La cardiopatía congénita más frecuente es:

- a) Comunicación interauricular
- b) Comunicación interventricular
- c) Ductus arterioso persistente
- d) Derenaje venoso anómalo
- e) Tetralogía de Fallot

10) Paciente de 79 años, consulta por cefalea, tinnitus y mareos. Al examen: PA:210/130, FC:99x'. RR2T, aumento de la intensidad de R2, auscultación pulmonar normal, sin signos focales en el examen neurológico. El fármaco de elección, para el manejo de esta situación, es:

- a) Nifedipino sublingual
- b) Captopril oral
- c) Nitroglicerina sublingual
- d) Nitroprusiato endovenoso
- e) Enalapril oral

11) Mujer, 60 años, con estenosis mitral severa, inicia bruscamente disnea y palpitaciones. Al examen FC:140x', PA:85/35, MP(+), con crépitos intensos y difusos, RI2T con soplo diastólico IV/VI, mayor en á pex. La conducta inicial más adecuada es:

- a) Administrar amiodarona endovenosa en bolo
- b) Entregar oxígeno a FiO2 elevadas y soporte ventilatorio con Bipap
- c) Reponer fluidos con suero fisiológico
- d) Cardioversión eléctrica inmediata
- e) Administrar furosemida endovenosa, asociada a drogas vasoactivas

12) Paciente 58 años, DM2, HTA, cursa con dolor retroesternal de 45 minutos de duración, intenso. El ECG muestra supradesnivel del ST en DI, V5 y V6. La medida más importante, de entre las que se enumeran, es:

- a) Anticoagulación
- b) Terapia de reperfusión inmediata
- c) Manejo estricto de glicemia y presión arterial, con fármacos endovenosos
- d) Solicitar enzimas cardíacas de manera urgente
- e) Solicitar ecocardiografía de urgencia

13) Paciente diabético de 66 años, evoluciona con herida en maleolo externo, de 3 cms de diámetro, sin tendencia a la curación, dolorosa, con bordes irregulares y escaso eritema circundante. Presenta además disminución de la sensibilidad de ambos pies. El diagnóstico más probable es:

- a) Úlcera por presión
- b) Úlcera venosa
- c) Úlcera arterial
- d) Úlcera neurogénica
- e) Úlcera secundaria a infección polimicrobiana

14) Paciente de 15 años, cursando con herida penetrante torácica por arma blanca, evoluciona con hipotensión marcada e ingurgitación yugular. Al examen MP(+) simétrico. La conducta inmediata a seguir es:

- a) Realizar ecocardiograma
- b) Reposición de fluidos por vía periférica
- c) Realizar pericardiocentesis
- d) Realizar radiografía de tórax
- e) Solicitar electrocardiograma

15) Paciente de 60 años, fumador, HTA. Consulta porque hace 4 meses inicia dolor torácico opresivo, que aparece cuando el paciente camina 150 metros, o cuando sube 6 peldaños de la escalera. Cede con el reposo, durando cerca de 5 minutos. El ECG sólo muestra alteraciones inespecíficas de la repolarización. La mejor conducta a seguir, junto con controlar los factores de riesgo cardiovascular e iniciar aspirina, es:

- a) Indicar nitroglicerina sublingual en los episodios de dolor
- b) Solicitar angiografía coronaria a la brevedad
- c) Solicitar Test de esfuerzo a la brevedad
- d) Solicitar un nuevo ECG
- e) Evaluar respuesta a cambios de estilo de vida y aspirina, en 1 mes

16) Paciente DM2, IRC, en hemodiálisis, portador de ICC, de origen coronario, usando enalapril, espironolactona, atenolol, aspirina y estatinas. Evoluciona con obnubilación, asociada a bradicardia de 40x' e hipotensión. El ECG muestra complejos QRS anchos y ondas T picudas en todas las derivaciones. En sus exámenes destaca Na+:147, K+:8,0, Cl-:111. La primera medida a seguir es:

- a) Cardioversión eléctrica urgente
- b) Administrar gluconato de calcio endovenoso
- c) Iniciar insulino-terapia endovenosa, asociada a betaagonistas inhalados
- d) Indicar marcapasos externo
- e) Realizar diálisis de urgencia

17) Ante la sospecha clínica de TVP de extremidades inferiores, el medida diagnóstica de elección es:

- a) Flebografía de EEII
- b) AngioTAC de EEII
- c) Ecografía doppler de EEII
- d) Pletismografía de volumen
- e) Angiografía de EEII

18) Paciente hipertenso, de 70 años. Ha sufrido 3 síncope, relacionados al esfuerzo. En el último tiempo se agrega angina de pecho al caminar 1 cuadra. Al examen: soplo sistólico eyectivo III/VI. El diagnóstico más probable es:

- a) Cardiopatía coronaria
- b) Cardiopatía hipertensiva
- c) Miocardiopatía hipertrófica no obstructiva
- d) Miocardiopatía dilatada con insuficiencia mitral secundaria
- e) Estenosis aórtica

19) Paciente cursando con IAM con infradesnivel del segmento ST en DII, DIII y aVF. Evoluciona con hipotensión e ingurgitación yugular. Al examen FC:92x', PA:82/48, RR2T sin soplos, sin signología pulmonar. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar pericardiocentesis
- b) Indicar trombolisis de urgencia
- c) Administrar cristaloides y dopamina por vía endovenosa
- d) Solicitar ecocardiograma
- e) Solicitar derivaciones precordiales derechas

20) Paciente de 55 años, hipertenso y diabético, sufre infarto miocárdico no transmural, hace 15 días. Se recupera bien, con buena capacidad funcional y fracción de eyección normal, en la ecocardiografía. Se realiza un perfil lipídico que muestra LDL:120, HDL:45, TG:250. La conducta más adecuada para el manejo de sus lípidos es:

- a) Indicar dieta y ejercicios
- b) Iniciar atorvastatina
- c) Iniciar gemfibrozilo
- d) Iniciar una asociación entre un fibrato y una estatina
- e) Su perfil lipídico es normal, por lo que no es necesario indicar ninguna medida terapéutica

Prueba 2

1) Una paciente de 64 años, con antecedente de hipertensión en tratamiento con enalapril y estenosis mitral, secundaria a enfermedad reumática, presenta desde hace 4 meses palpitaciones, que en algunas ocasiones se hacen muy intensas y se asocian a disnea. El examen físico destaca pulso irregular, confirmándose mediante electrocardiografía, la presencia de fibrilación auricular. Las siguientes alternativas representan medidas válidas para el tratamiento de esta paciente, EXCEPTO:

- a) Acenocumarol oral
- b) Amiodarona oral
- c) Carvedilol oral
- d) Adenosina endovenosa
- e) Digoxina oral

2) Un paciente de 46 años, hipertenso en tratamiento con dieta hiposódica, presenta presiones arteriales cercanas a 150/90, durante los últimos 3 meses. No fuma ni padece otras patologías. El examen físico es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Controlar en 3 meses, sin necesidad de fármacos ni exámenes
- b) Solicitar un Holter de presión arterial
- c) Solicitar ecodoppler renal, índice de aldosterona/actividad de renina y metanefrinas urinarias
- d) Iniciar un diurético tiazídico
- e) Iniciar ácido acetilsalicílico

3) Un paciente de 69 años, con antecedente de insuficiencia cardíaca crónica, secundaria a una cardiopatía hipertensiva, de larga data, en tratamiento con enalapril, espironolactona, hidroclorotiazida, aspirina y atorvastatina, consulta por aumento de su sintomatología y progresión de su disnea, que actualmente aparece ante mínimos esfuerzos. El examen físico demuestra FC: 87x', regular, PA: 130/80, crépitations pulmonares escasas bibasales, y un RR2T sin soplos. La conducta más adecuada para mejorar el pronóstico en este paciente es:

- a) Cambiar el enalapril por un inhibidor del receptor de angiotensina 2
- b) Iniciar digoxina
- c) Iniciar propranolol
- d) Iniciar furosemida
- e) Iniciar carvedilol

4) Un paciente de 74 años ha presentado síncope relacionados con la actividad física. Además presenta angina de pecho al caminar 2 cuadras. En el examen físico destaca un pulso regular de poca amplitud y un soplo mesosistólico III/VI, con click de apertura. El diagnóstico más probable es:

- a) Estenosis aórtica
- b) Estenosis mitral
- c) Insuficiencia aórtica
- d) Insuficiencia mitral
- e) Miocardiopatía hipertrófica obstructiva

5) En el electrocardiograma las extrasístoles auriculares se caracterizan por presentar:

- a) Complejo QRS ancho y presencia de pausa compensatoria
- b) Complejo QRS angosto y ausencia de pausa compensatoria
- c) Complejo QRS ancho y ausencia de pausa compensatoria
- d) Alargamiento del segmento QT y alteraciones de la repolarización
- e) Acortamiento del segmento QT sin alteraciones de la repolarización

6) Paciente de 65 años, cursando el cuarto día luego de un infarto agudo al miocardio, evoluciona súbitamente con disnea y deterioro hemodinámico. Al examen destaca ritmo regular en 2 tonos, con un soplo holosistólico, asociado a frémito. El diagnóstico más probable es:

- a) Rotura de la pared libre ventricular
- b) Infarto de ventrículo derecho
- c) Rotura de músculo papilar
- d) Disección aórtica
- e) Infarto del nodo aurículoventricular

7) Un paciente de 65 años, sin antecedentes de importancia, inicia síncope, asociados a sudoración y desorientación. Al examen físico presenta FC: 29 lpm, PA: 70/30 mm/Hg, frialdad y palidez de las extremidades, RR2T, sin soplos. El monitoreo electrocardiográfico es compatible con un bloqueo aurículoventricular de tercer grado. La conducta inicial más adecuada es:

- a) Solicitar electrocardiograma de 12 derivaciones
- b) Administrar suero fisiológico por vía endovenosa
- c) Administrar epinefrina 1 mg por vía endovenosa
- d) Instalar marcapasos externo
- e) Realizar cardioversión eléctrica

8) Paciente hipertenso, de 67 años, con dolor torácico intenso, de inicio súbito. Al examen físico FC: 110x', regular, PA:230/128, asimetría en los pulsos radiales y a la auscultación cardíaca destaca un soplo diastólico. La conducta inicial más adecuada a seguir, además de tomar un ECG es:

- a) Realizar coronariografía urgente
- b) Administrar oxígeno, morfina, nitroglicerina y aspirina inmediatamente
- c) Realizar ecocardiograma transesofágico urgente
- d) Realizar pericardiocentesis
- e) Solicitar radiografía de tórax

9) Escoja la asociación correcta entre la cardiopatía congénita y su manifestación clínica

- a) Comunicación interventricular – Soplo sistodiastólico en maquinaria
- b) Comunicación interauricular - Soplo holosistólico, asociado a infecciones respiratorias recurrentes
- c) Ductus arterioso persistente – Soplo sistólico eyectivo, asociado a desdoblamiento fijo del segundo ruido
- d) Ventrículo único – Cianosis que no responde a oxígeno en altas concentraciones
- e) Coartación aórtica – Soplo diastólico, asociado a asimetría de los pulsos pedios

10) Una paciente de 58 años, hipertensa, en tratamiento con enalapril, presenta un cuadro de 60 minutos de evolución, de dolor retroesternal 9/10, opresivo, irradiado al hombro izquierdo. El examen físico muestra FC: 85x', PA: 140/100, ritmo cardíaco regular, en 2 tonos, sin soplos y examen pulmonar normal. El electrocardiograma muestra inversión de la onda T en las derivaciones DI, V5 y V6. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar aspirina, oxígeno, nitroglicerina y solicitar test de esfuerzo
- b) Iniciar aspirina, oxígeno, nitroglicerina y solicitar troponinas plasmáticas
- c) Solicitar enzimas cardíacas y realizar ecocardiograma transesofágico
- d) Realizar coronariografía de inmediato
- e) Administrar trombolíticos endovenosos

11) La cardiopatía congénita más frecuente es:

- a) Coartación aórtica
- b) Ductus arterioso persistente
- c) Tronco arterioso
- d) Comunicación interauricular
- e) Comunicación interventricular

12) Un paciente de 18 años presenta dolor precordial, de instalación progresiva, que aumenta con la inspiración. El examen físico no aporta mayor información. Se solicita electrocardiograma que demuestra supradesnivel del segmento ST en todas las derivaciones precordiales. El tratamiento de la patología descrita es:

- a) Estreptokinasa
- b) AINEs
- c) Corticoides
- d) Pericardiocentesis
- e) Quirúrgico

13) ¿Cual de los siguientes factores se asocia a menor mortalidad hospitalaria en casos de infarto del miocardio?

- a) Sexo femenino
- b) Presencia de diabetes mellitus
- c) Localización en la pared anterior
- d) Taquicardia sinusal
- e) Edad menor de 45 años

14) Un paciente de 67 años, cursando su segundo día de hospitalización por un accidente vascular encefálico hemorrágico, presenta un cuadro clínico compatible con una TVP de la extremidad inferior izquierda, la que se confirma mediante ecografía, con compromiso de la vena poplítea. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar aspirina
- b) Anticoagular con heparina
- c) Iniciar trombolisis con activador del plasminógeno
- d) Instalar filtro de vena cava inferior
- e) Resolver quirúrgicamente de inmediato

15) Un paciente de 67 años, diabético, en tratamiento con metformina y glibenclamida, mal controlado, presenta episodio actual, caracterizado por sudoración y palidez. El examen físico no aporta mayor información. Se solicita hemoglucotest, que resulta 233. La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio, aumentando la dosis de hipoglicemiantes orales
- b) Iniciar insulino terapia y agregar una estatina al tratamiento
- c) Solicitar un test de tolerancia a la glucosa oral, prolongado
- d) Solicitar electrocardiograma
- e) Solicitar un ecocardiograma

16) Un paciente de 40 años, fumador de 5 cigarrillos al día, sin otras patologías de importancia, presenta disnea de esfuerzos, progresiva, de 3 meses de evolución, asociada a ortopnea y edema de extremidades inferiores. Actualmente está en capacidad funcional III. Al examen físico presenta FC: 90x' regular, PA: 110/70, RR2T sin soplos, desplazamiento importante del choque de la punta, murmullo pulmonar simétrico, con crépitos escasos bibasales, edema de extremidades inferiores y reflujo hepatoyugular. La radiografía de tórax demuestra cardiomegalia, hilios pulmonares prominentes, con redistribución sanguínea hacia los ápices. El diagnóstico más probable es:

- a) Cardiopatía hipertensiva
- b) Taponamiento pericárdico
- c) Miocardiopatía dilatada
- d) Cardiopatía coronaria
- e) Pericarditis constrictiva

17) ¿Cuál de las siguientes opciones NO corresponde a un soplo funcional o inocente?

- a) Su intensidad es III/VI
- b) Presenta una tonalidad musical
- c) No tiene frémito
- d) Aumenta con el ejercicio
- e) Es diastólico

18) Un paciente de 70 años, cardiópata coronario, en CFIII, evoluciona con tos y expectoración mucopurulenta, agregándose disnea de reposo y rápido deterioro del estado general, con síncope y desorientación. Al examen físico se aprecia pálido, con extremidades frías y pulsos débiles. Se constata FC: 120x', PA: 66/31 mmHg, con RR3T y MP+ con crépitos bilaterales, mayor en lavase derecha. El monitoreo electrocardiográfico demuestra taquicardia sinusal. Se instala catéter de Swan-Ganz, obteniéndose PVC: 21 mmHg (VN: 0-8), PAP: 45/22 mmHg (VN: menor a 35) y PCP: 33 mmHg (VN: menor a 18). El diagnóstico más probable es:

- a) Shock cardiogénico
- b) Shock séptico
- c) Shock hipovolémico
- d) Shock anafiláctico
- e) Shock medular

19) Un paciente de 67 hospitalizado por shock séptico, presenta pérdida de conciencia, constatándose ausencia de respiración y pulso. Se inician ventilaciones y masaje cardíaco y se instala monitor electrocardiográfico. Luego de 5 ciclos continúa sin pulso y el monitor demuestra **asistolía. La conducta más adecuada es:**

- a) Realizar desfibrilación eléctrica y continuar el masaje cardíaco
- b) Realizar intubación orotraqueal, iniciar ventilación a presión positiva, con oxígeno al 100% y continuar masaje cardíaco
- c) Administrar adrenalina 1mg por vía endovenosa y continuar con el masaje cardíaco
- d) Instalar marcapasos externo y suspender el masaje cardíaco
- e) Realizar 5 ciclos más de masaje cardíaco y reevaluar

20) Un paciente de 61 años presenta dolor de la extremidad inferior derecha, de inicio súbito, asociado a parestesis y dificultad progresiva para mover los ortejos de esa extremidad. Al examen físico se aprecia palidez de la pierna derecha, con clara disminución del pulso pedio. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar Ecografía Doppler de extremidades inferiores
- b) Anticoagular con heparina y realizar angiografía femoral de urgencia
- c) Solicitar pletismografía de volumen de extremidades inferiores
- d) Instalar filtro de vena cava inferior
- e) Administrar trombolíticos endovenosos

Prueba 3

1) Paciente 58 años, DM2, HTA, cursa con dolor retroesternal de 45 minutos de duración, intenso. El ECG muestra supradesnivel del ST en DI, V5 y V6. La medida más importante, de entre las que se enumeran, es:

- a) Anticoagulación
- b) Terapia de reperfusión inmediata
- c) Manejo estricto de glicemia y presión arterial, con fármacos endovenosos
- d) Solicitar enzimas cardíacas de manera urgente
- e) Solicitar ecocardiografía de urgencia

2) Un paciente de 25 años, sin antecedentes de importancia, presenta PA: 160/110 en varias tomas, en días diferentes. En sus exámenes se constata hemograma normal, creatinina: 0,9 mg/dl, BUN: 12 mg/dl, sedimento de orina normal, K: 2,8 mEq/l, Na: 140 mEq/l, Cl: 103 mEq/l y normalidad del índice de aldosterona/actividad de renina plasmática. El diagnóstico de sospecha debe ser:

- a) Hipertensión esencial
- b) Hipertensión secundaria a nefropatía médica
- c) Hiperaldosteronismo primario
- d) Hipertensión renovascular
- e) Feocromocitoma

3) Un paciente de 47 años, con antecedentes de válvula aórtica bicúspide, presenta endocarditis infecciosa aguda por S. aureus, que evoluciona con rápido deterioro de la función cardíaca, constatándose mediante ecografía una rotura de los velos valvulares, con una insuficiencia aórtica severa. Se decide reemplazo valvular quirúrgico. ¿Cuál de las siguientes opciones representa la mejor alternativa de manejo?

- a) Instalar prótesis biológica, quedando con anticoagulación a permanencia, sin necesidad de profilaxis antibiótica para nuevas endocarditis
- b) Instalar prótesis biológica, indicando antibióticos como profilaxis, ante procedimientos invasivos, sin necesidad de anticoagular
- c) Instalar prótesis mecánica, indicando antibióticos como profilaxis, ante procedimientos invasivos, y anticoagulación a permanencia
- d) Instalar prótesis mecánica, indicando antibióticos como profilaxis, ante procedimientos invasivos, sin necesidad de anticoagular
- e) Instalar prótesis mecánica, quedando con anticoagulación a permanencia, sin necesidad de profilaxis antibiótica para nuevas endocarditis

4) ¿Cuál de las siguientes manifestaciones clínicas en MENOS probable de ser hallada en un paciente con miocardiopatía hipertrófica?

- a) Pulso de amplitud aumentada
- b) Ondas T invertidas y de gran amplitud en las derivaciones precordiales del ECG
- c) Desplazamiento importante del choque de la punta
- d) Soplo sistólico que aumenta con la maniobra de Valsalva
- e) Síncope relacionados con el esfuerzo

5) Un niño de 7 meses ha presentado 5 infecciones respiratorias bajas desde el nacimiento. Se fatiga rápidamente durante la succión, por lo que no ha aumentado correctamente de peso. Al examen físico se ausculta un soplo holosistólico intenso y algunas crepitaciones escasas en ambas bases pulmonares. No presenta cianosis. El diagnóstico más probable es:

- a) Coartación aórtica
- b) Ductus arterioso persistente
- c) Comunicación interauricular
- d) Comunicación interventricular
- e) Tetralogía de Fallot

6) La taquicardia paroxística supraventricular se manifiesta electrocardiográficamente como:

- a) Taquicardia regular, con frecuencia cercana a los 150 lpm, con ondas de serrucho en las derivaciones inferiores (DII, DIII y AVF)
- b) Taquicardia regular, con frecuencia cercana a los 190 lpm y complejos QRS angostos
- c) Taquicardia regular, con frecuencia cercana a los 180 lpm y complejos QRS anchos
- d) Taquicardia irregular, con frecuencia cercana a los 150 lpm y ausencia de onda P
- e) Taquicardia irregular, con frecuencia cercana a los 180 lpm y complejos QRS anchos y angostos alternados

7) Una paciente de 68 años, diabética e hipertensa, con antecedente de cirugía de revascularización miocárdica, hace 3 años, en tratamiento con enalapril, aspirina, carvedilol y atorvastatina, presenta un cuadro de 60 minutos de evolución, de dolor retroesternal intenso, opresivo, asociado a sudoración y disnea. El examen físico muestra FC: 110x' regular, PA: 140/100, RR3TSS, con presencia de R4 y examen pulmonar normal. El electrocardiograma muestra infradesnivel del segmento ST en las derivaciones DI, V5 y V6. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar aspirina, oxígeno y nitroglicerina y controlar con troponinas plasmáticas, decidiendo manejo según resultado
- b) Administrar oxígeno, aspirina y nitroglicerina y realizar coronariografía de inmediato
- c) Iniciar anticoagulación con heparina
- d) Realizar desfibrilación eléctrica
- e) Realizar trombolisis endovenosa de inmediato

8) La hiperkalemia severa es capaz de desencadenar arritmias severas, que incluyen bloqueo auriculoventricular y taquicardia ventricular. ¿Qué alteraciones electrocardiográficas son características en la hiperkalemia?

- a) Ondas T picudas y ensanchamiento del complejo QRS
- b) Ondas T invertidas y alargamiento del segmento QT
- c) Ondas P bifásicas y acortamiento del segmento QT
- d) Disociación auriculoventricular y desviación del eje a derecha

e) Ondas P invertidas y desviación del eje a izquierda

9) Un paciente presenta disnea de esfuerzos, ortopnea y disnea paroxística nocturna. Al examen físico se observa desplazamiento del choque de la punta cardíaca al quinto espacio intercostal, en la línea axilar anterior, se ausculta un soplo diastólico III/VI en todo el precordio y se palpa el pulso arterial periférico muy amplio (pulso Celler). El diagnóstico más probable es:

- a) Estenosis aórtica
- b) Estenosis mitral
- c) Insuficiencia aórtica
- d) Insuficiencia mitral
- e) Miocardiopatía hipertrófica obstructiva

10) Una paciente de 55 años, presenta cuadro de fiebre, CEG y artralgias de 7 días de evolución, sin síntomas digestivos, urinarios ni respiratorios. Al examen se aprecia febril, decaída, pálida y se ausculta un soplo diastólico III/VI, con examen pulmonar normal. El diagnóstico más probable y la conducta más adecuada son respectivamente:

- a) Fiebre reumática aguda e iniciar corticoides endovenosos
- b) Fiebre reumática aguda y administrar penicilina y aspirina en altas dosis
- c) Endocarditis bacteriana subaguda y solicitar hemograma, hemocultivos y ecocardiografía
- d) Endocarditis bacteriana subaguda y solicitar coronariografía y ventriculografía
- e) Endocarditis bacteriana subaguda e iniciar ceftriaxona endovenosa

11) Paciente de 60 años, fumador, HTA. Consulta porque hace 4 meses inicia dolor torácico opresivo, que aparece cuando el paciente camina 150 metros, o cuando sube 6 peldaños de la escalera. Cede con el reposo, durando cerca de 5 minutos. El ECG sólo muestra alteraciones inespecíficas de la repolarización. La mejor conducta a seguir, junto con controlar los factores de riesgo cardiovascular e iniciar aspirina, es:

- a) Indicar nitroglicerina sublingual en los episodios de dolor
- b) Solicitar angiografía coronaria a la brevedad
- c) Solicitar Test de esfuerzo a la brevedad
- d) Solicitar un nuevo ECG
- e) Evaluar respuesta a cambios de estilo de vida y aspirina, en 1 mes

12) Un paciente inicia un cuadro caracterizado por vómitos, lipotimias y prurito generalizado, mientras comía mariscos en un restaurante. Al examen físico presenta FC: 120x', PA: 74/36 mmHg y se observan placas pseudopapulares generalizadas. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar corticoides endovenosos y reponer la volemia con coloides
- b) Administrar adrenalina intramuscular y suero fisiológico endovenoso
- c) Administrar suero fisiológico y antibióticos endovenosos
- d) Administrar un litro de suero fisiológico y reevaluar periódicamente
- e) Administrar sales de rehidratación oral y reevaluar periódicamente

13) Un paciente de 57 años, sedentario, inicia bruscamente dolor torácico intenso, que aumenta con la inspiración y se asocia a disnea. Al examen físico sólo se observa edema marcado de la extremidad inferior izquierda, con dolor a la palpación muscular de la pantorrilla, sin otros hallazgos patológicos. El examen que con mayor probabilidad entregará el diagnóstico es:

- a) Angiografía femoral
- b) Dímero D
- c) Angio-TAC de tórax
- d) Electrocardiograma
- e) Radiografía de tórax

14) Un hombre de 76 años presenta varios síncope en las últimas horas. Al examen físico está soporoso, hipoperfundido, tiene una frecuencia cardíaca de 34 latidos por minutos y una presión arterial de 86/48 mmHg. Se ausculta un primer ruido cardíaco de intensidad variable. El diagnóstico más probable es:

- a) Bloqueo AV completo
- b) Enfermedad del nodo sinusal
- c) Síncope vasovagal
- d) Síndrome coronario agudo
- e) Fibrilación auricular

15) ¿Cuál de los siguientes medicamentos incide MENOS en el pronóstico de una insuficiencia cardíaca crónica, debida a cardiopatía coronaria?

- a) Furosemida
- b) Aspirina
- c) Enalapril
- d) Atorvastatina
- e) Carvedilol

16) Un paciente de 66 años, hipertenso, presenta dolor retroesternal intenso, irradiado a dorso. En el examen físico presenta FC: 127x', PA: 200/120 mmHg, SatO₂: 94%, pulsos radiales asimétricos, MP(+), sin ruidos agregados, RR2T con soplo de regurgitación aórtica. El diagnóstico más probable es:

- a) Infarto de ventrículo derecho
- b) Endocarditis aguda
- c) Tromboembolismo pulmonar
- d) Infarto miocárdico con rotura de músculo papilar
- e) Disección aórtica

17) Un paciente sufre un paro cardiorespiratorio en la sala de urgencias, donde usted trabaja. Se inician ventilaciones y masaje cardíaco y se instala monitor electrocardiográfico. Luego de 5 ciclos continúa sin pulso y el monitor demuestra actividad eléctrica, con complejos QRS a una frecuencia de 30 por minuto. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar desfibrilación eléctrica y continuar el masaje cardíaco
- b) Realizar intubación orotraqueal, iniciar ventilación a presión positiva, con oxígeno al 100% y continuar masaje cardíaco
- c) Administrar adrenalina 1mg por vía endovenosa y continuar con el masaje cardíaco
- d) Instalar marcapasos externo y suspender el masaje cardíaco
- e) Realizar 5 ciclos más de masaje cardíaco y reevaluar

18) Mujer, 60 años, con estenosis mitral severa, inicia bruscamente disnea y palpitaciones. Al examen FC:140x', PA:85/35, MP(+), con crépitos intensos y difusos, R2T con soplo diastólico IV/VI, mayor en á pex. La conducta inicial más adecuada es:

- a) Administrar amiodarona endovenosa en bolo
- b) Entregar oxígeno a FiO₂ elevadas y soporte ventilatorio con Bipap
- c) Reponer fluidos con suero fisiológico
- d) Cardioversión eléctrica inmediata
- e) Administrar furosemida endovenosa, asociada a drogas vasoactivas

19) Una paciente de 46 años presenta un cuadro de astenia y edema de EEII, progresivo, de 3 meses de duración. Al examen destaca hepatomegalia, edema blando de extremidades inferiores e ingurgitación yugular, con colapso "x" prominente en el pulso venoso. El examen pulmonar es normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Pericarditis aguda
- b) Miocardiopatía restrictiva
- c) Miocardiopatía dilatada
- d) Cardiopatía hipertensiva
- e) Pericarditis constrictiva

20) Un paciente fumador, dislipidémico e hipertenso, en tratamiento con enalapril y atorvastatina, con buen control de su presión arterial y de sus niveles lipídicos, presenta dolor en la pantorrilla derecha, que aparece al caminar cerca de 150 metros, limitándole la marcha y cede con el reposo. El examen físico no aporta mayor información. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar angiografía de EEII
- b) Solicitar ecografía doppler de EEII
- c) Iniciar ejercicios, suspender el cigarrillo e iniciar aspirina
- d) Suspender el cigarrillo e iniciar anticoagulación para alcanzar INR entre 2 y 3
- e) Resolver quirúrgicamente

Prueba 4

1) La onda V del pulso venoso coincide con:

- a) La sístole ventricular.
- b) El cierre de las válvulas sigmoideas.
- c) La contracción auricular.
- d) La diástole ventricular, después de la apertura de las válvulas auriculo-ventriculares.
- e) El periodo de contracción isométrica de la masa ventricular.

2) ¿Qué debe sospechar usted ante un paciente al que en bipedestación se le ausculta un soplo sistólico, que aumenta con la maniobra de Valsalva y que casi desaparece al auscultarlo en cucullas?:

- a) Fístula aorto-pulmonar.
- b) Comunicación interauricular.
- c) Miocardiopatía hipertrófica.
- d) Estenosis pulmonar.
- e) Insuficiencia mitral reumática.

3) En el post-operatorio inmediato, un politraumatizado está cianótico y muy hipotenso, auscultándose además muchas sibilancias. La medición de la presión venosa y de la presión capilar o de enclavamiento pulmonar están muy elevadas. ¿Qué medida terapéutica NO necesitaría en absoluto?:

- a) Oxigenoterapia.
- b) Noradrenalina.
- c) Reposición de la volemia.
- d) Diuréticos.
- e) Estimulantes beta2-adrenérgicos.

4) Señale de los propuestos, el procedimiento terapéutico de elección para un paciente con síndrome de preexcitación (Wolff-Parkinson-White) y taquicardias recurrentes no controladas con fármacos antiarrítmicos es:

- a) Implantación de un marcapasos endocárdico definitivo en modo VVI.
- b) Ablación de la vía accesoria mediante catéter.
- c) Cirugía con circulación extracorpórea para escisión de la vía anómala.
- d) Ablación por catéter del nodo aurículo-ventricular.
- e) Sustitución quirúrgica de la válvula mitral.

5) Una mujer de 70 años ingresa con un infarto agudo de miocardio de localización anterior es tratada con activador tisular del plasminógeno)A las 2 horas de dicho tratamiento refiere intenso dolor precordial y elevación marcada del segmento ST en derivaciones V2, V3, y V4)¿Cuál de las siguientes exploraciones le parece más indicada?:

- a) Una determinación urgente de troponina.
- b) Un ecocardiograma transesofágico.
- c) Una angiografía coronaria.
- d) Una gammagrafía de ventilación/perfusión.
- e) Una radiografía de torax.

6) Uno de los siguientes datos clínicos NO es característico del infarto de ventrículo derecho. Señálelo:

- a) Asociación con infarto inferior.
- b) Hipotensión arterial.
- c) Ingurgitación yugular.
- d) Edema agudo de pulmón.
- e) Hepatomegalia.

7) La auscultación en un niño de 5 años de un segundo ruido reforzado en segundo espacio intercostal izquierdo, línea paraesternal, debe hacer sospechar:

- a) Hipertensión pulmonar.
- b) Coartación de aorta.
- c) Estenosis pulmonar.
- d) Hipertensión arterial.
- e) Insuficiencia pulmonar.

8) En un paciente con pericarditis aguda se instaura bruscamente un cuadro de ortopnea, elevación extrema de la presión venosa, hipotensión arterial y pulso paradójico. La actitud que el médico debe tomar inmediatamente es:

- a) Administración de diuréticos por vía intravenosa y observar al paciente durante las próximas 12 horas.
- b) Administración de antiinflamatorios o aumento de la dosis si el paciente los tomaba previamente.
- c) Realización urgente de un ecocardiograma y a continuación pericardiocentesis si se confirma la sospecha clínica que Vd. tiene.
- d) Administración de digoxina por vía intravenosa para reducir la frecuencia cardíaca.
- e) Realización urgente de una radiografía de tórax y a continuación pericardiocentesis sólo si existe un gran aumento de la silueta cardíaca.

9) Un paciente de 81 años consulta por disnea de esfuerzo y un episodio de síncope. A la exploración física la tensión arterial es de 120/90 y la frecuencia cardíaca es rítmica a 90 lpm. El pulso carotídeo es de muy escasa amplitud y de ascenso lento y a la auscultación cardíaca se aprecia un soplo intenso y rudo en borde esternal izquierdo. El diagnóstico de este paciente es:

- a) Insuficiencia mitral severa.
- b) Estenosis aórtica severa.
- c) Insuficiencia tricúspide severa.
- d) Miocardiopatía hipertrófica obstructiva.
- e) Insuficiencia aórtica severa.

10) ¿Cuál de las siguientes es la causa más frecuente de isquemia arterial aguda?:

- a) Trombosis de un aneurisma.
- b) Traumatismo arterial.
- c) Compresión extrínseca.
- d) Claudicación intermitente.
- e) Embolia arterial.

11) Un paciente de 67 años, hipertenso, en tratamiento con dosis bajas de nifedipino, consulta por ortopnea y disnea de esfuerzos de grandes esfuerzos, de 3 meses de evolución. Al examen físico se constata PA: 150/90 mmHg, FC: 77x', sin otras alteraciones. La radiografía de tórax muestra un corazón de tamaño normal y cierto grado de redistribución de la vasculatura pulmonar hacia los ápices. El electrocardiograma demuestra signos de hipertrofia ventricular izquierda. La etiología más probable de su insuficiencia cardíaca es:

- a) Cardiopatía coronaria
- b) Cardiopatía hipertensiva
- c) Miocardiopatía hipertrófica
- d) Miocardiopatía restrictiva
- e) Pericarditis constrictiva

12) Un hombre de 65 años presenta síncope en varias oportunidades durante los últimos 15 minutos, asociados a disnea, por lo que es llevado a urgencias, donde se constata una taquicardia regular, a 180 lpm, con complejos QRS anchos. El diagnóstico más probable es:

- a) Taquicardia paroxística supraventricular
- b) Taquicardia ventricular
- c) Flutter auricular
- d) Fibrilación auricular
- e) Fibrilación ventricular

13) Una paciente de 60 años, sin antecedentes de importancia es diagnosticada de una ACxFA paroxística. Refiere episodios frecuentes, con síntomas muy intensos, consistentes en palpitaciones y sensación de angustia. No ha presentado angina ni disnea y el examen físico no agrega información relevante. El tratamiento farmacológico de elección para esta paciente, considerando lo molesto de los síntomas, es:

- a) Aspirina
- b) Acenocumarol
- c) Digoxina
- d) Amiodarona
- e) Carvedilol

14) Un paciente de 68 años presenta síncope frecuentes, sin relación con el esfuerzo. Tiene antecedente de hipertensión arterial, que trata con enalapril. Al examen físico destaca FC: 45x' irregular. El diagnóstico más probable es:

- a) Intoxicación por enalapril
- b) Fibrilación auricular
- c) Bloqueo AV de primer grado
- d) Bloqueo AV de tercer grado
- e) Enfermedad del nodo sinusal

15) La comunicación interventricular se presenta semiológicamente como:

- a) Cianosis y soplo sistólico
- b) Soplo holosistólico
- c) Soplo sistólico eyectivo y desdoblamiento fijo del segundo ruido
- d) Cianosis y soplo diastólico
- e) Soplo en maquinaria

16) Un paciente presenta un cuadro de varias semanas de evolución de astenia y edema de extremidades inferiores. Al examen físico se aprecia hepatomegalia moderada y se observa ingurgitación yugular, con un pulso venoso con colapso "y" prominente. La prueba diagnóstica de elección es:

- a) Electrocardiograma convencional
- b) Test de esfuerzo
- c) Electrocardiograma con derivaciones precordiales derechas
- d) Ecocardiografía
- e) Coronariografía

17) Una paciente de 69 años presenta síntomas de insuficiencia cardíaca. Al examen presenta desplazamiento importante del choque de la punta y un soplo diastólico. El diagnóstico más probable es

- a) Insuficiencia mitral
- b) Insuficiencia tricuspídea
- c) Estenosis mitral
- d) Estenosis aórtica
- e) Insuficiencia aórtica

18) Un paciente de 66 años sufre un síndrome coronario agudo, en cuyo electrocardiograma se demostraba inversión de la onda T en las derivadas inferiores, sin otras alteraciones. Fue manejado médicamente, con buenos resultados. Además, las troponinas se mantuvieron negativas durante toda la evolución. Actualmente está asintomático, con capacidad funcional y examen físico normales. ¿Qué fármaco se debe indicar en primer lugar para el manejo de este paciente, a partir de este punto?

- a) Enalapril
- b) Carvedilol
- c) Hidroclorotiazida
- d) Amiodarona
- e) Ácido acetil salicílico

19) Además del control de los factores de riesgo cardiovascular y del uso de estatinas y antiagregantes, la claudicación intermitente se trata habitualmente con:

- a) Angioplastia
- b) Bypass arterio-arterial
- c) Anticoagulación oral
- d) Vasodilatadores
- e) Ejercicios

20) Aumentan la sobrevida en los pacientes con insuficiencia cardíaca, EXCEPTO:

- a) IECAs
- b) Inhibidores de la angiotensina II
- c) Espironolactona
- d) Beta bloqueadores
- e) Digitálicos

Prueba 5 (CARDIOLOGÍA + RESPIRATORIO)

1) Un paciente de 67 años, diabético, en tratamiento con metformina y glibenclamida, mal controlado, presenta episodio actual, caracterizado por sudoración y palidez. El examen físico no aporta mayor información. Se solicita hemoglucotest, que resulta 233. La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio, aumentando la dosis de hipoglucemiantes orales
- b) Iniciar insulino terapia y agregar una estatina al tratamiento
- c) Solicitar un test de tolerancia a la glucosa oral, prolongado
- d) Solicitar electrocardiograma
- e) Solicitar un ecocardiograma

2) Un paciente con antecedente de EPOC tabáquico, severo, de 10 años de evolución, consulta por cuadro de astenia y mayor disnea de la habitual, asociada a edema de extremidades inferiores y hepatomegalia. Actualmente no fuma y sigue tratamiento con broncodilatadores y corticoides inhalados. El examen físico no aporta mayor información. El diagnóstico más probable es:

- a) Cardiopatía coronaria
- b) Fibrosis pulmonar
- c) Cáncer
- d) Cor pulmonar
- e) Hipertensión pulmonar

3) La hiperkalemia con frecuencia, se manifiesta electrocardiográficamente como:

- a) Alargamiento del segmento QT
- b) QRS angosto
- c) Ondas T picudas
- d) Infradesnivel del segmento ST
- e) Ondas T invertidas

4) La conducta más adecuada ante un paciente diagnosticado de neumonía ATS 1, que no responde al tratamiento con amoxicilina oral, luego de 72 horas, es:

- a) Mantener el tratamiento con amoxicilina y reevaluar en 24 horas
- b) Iniciar tratamiento con amoxicilina + ácido clavulánico
- c) Hospitalizar y solicitar radiografía de tórax
- d) Solicitar cultivo de expectoración con antibiograma
- e) Iniciar tratamiento con moxifloxacino oral

5) Un paciente de 45 años, consulta por fiebre, compromiso del estado general, tos con expectoración mucopurulenta y disnea. Al examen físico presenta FC: 110x', PA: 156/100, FR:34x', saturación de oxígeno: 88%. El examen pulmonar demuestra crepitos localizados en la mitad superior del hemicampo pulmonar izquierdo, asociado a matidez y aumento de transmisión de la voz. Se solicita radiografía de tórax que demuestra condensación del lóbulo superior izquierdo. El tratamiento antibiótico más adecuado es:

- a) Amoxicilina oral
- b) Amoxicilina + ácido clavulánico oral
- c) Ceftriaxona endovenosa
- d) Ceftriaxona + eritromicina endovenosas
- e) Claritromicina oral

6) Un paciente de 32 años, sin antecedentes de importancia presenta un síncope, relacionado con el ejercicio. El examen físico no aporta mayor información. Se solicita un electrocardiograma que demuestra signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo, asociados a ondas T invertidas gigantes en las derivaciones precordiales. El diagnóstico más probable es:

- a) Estenosis aórtica
- b) Miocardiopatía dilatada
- c) Miocardiopatía hipertrófica
- d) Síndrome de Brugada
- e) Displasia arritmogénica del ventrículo derecho

7) Un paciente de 24 años, consulta por dolor torácico de 3 días de evolución, al que se le ha agregado disnea de esfuerzo y dolor en hipocondrio derecho. Al examen se observa cansado, taquicárdico, con tendencia a la hipotensión. La yugulares se encuentran ingurgitadas, con un colapso transitorio marcado, durante el ciclo del pulso venoso. El examen pulmonar es normal y se palpa el hígado por 3 cm bajo el reborde costal, siendo moderadamente doloroso. El diagnóstico más probable es:

- a) Endocarditis aguda
- b) Tromboembolismo pulmonar
- c) Taponamiento pericárdico
- d) Infarto agudo al miocardio
- e) Miocarditis aguda

8) Un paciente de 17 años consulta por dolor torácico de inicio súbito, con tope inspiratorio, asociado a disnea. Al examen físico se observa en buenas condiciones, disneico, con frecuencia cardíaca y presión arterial normales. Se constata disminución del murmullo pulmonar en el hemicampo pulmonar derecho, asociado a hipersonoridad a la percusión. No se auscultan otros ruidos. La causa más probable del cuadro descrito es:

- a) Embolia pulmonar
- b) Pericarditis
- c) Derrame pleural
- d) Rotura de bulas pulmonares
- e) Neumotórax a tensión

9) Un paciente de 64 años, diabético e hipertenso, tiene antecedentes de cardiopatía coronaria, con una cirugía previa de revascularización miocárdica hace 2 años. Está en tratamiento con hipoglicemiantes orales, enalapril, hidroclorotiazida, atorvastatina y aspirina. Consulta por un cuadro de dolor precordial izquierdo, intenso, de carácter opresivo, irradiado al hombro izquierdo, de 20 minutos de duración y que cede espontáneamente 1 hora antes de la consulta. Actualmente se encuentra asintomático y el examen físico resulta normal, al igual que el electrocardiograma. La conducta más adecuada es:

- a) Hospitalizar, administrar oxígeno, aspirina, heparina y antianginosos y solicitar enzimas cardíacas
- b) Administrar analgésicos endovenosos y realizar test de esfuerzo inmediatamente
- c) Solicitar ecografía con dobutamina y decidir manejo según hallazgos
- d) Solicitar radiografía de tórax y decidir conducta según hallazgos
- e) Enviar a domicilio e indicar control ambulatorio con ecocardiograma

10) La presencia de un complejo QRS ancho, de morfología rSR' en las derivaciones V1 y V2, es característico de:

- a) Bloqueo aurículoventricular infrahisiano
- b) Bloqueo completo de rama derecha
- c) Bloqueo completo de rama izquierda
- d) Hemibloqueo izquierdo anterior
- e) Hemibloqueo izquierdo posterior

11) Un paciente con antecedente de tabaquismo y baja de peso, se realiza radiografía de tórax que demuestra la presencia de 3 nódulos pulmonares radiopacos y redondos, de bordes irregulares. El mayor de ellos de 3 cm, ubicado en el lóbulo superior derecho y los otros dos de 1,2 y 1,5 cm, ubicados en el lóbulo inferior derecho. El diagnóstico más probable es:

- a) Carcinoma pulmonar de células pequeñas
- b) Carcinoma pulmonar de células no pequeñas
- c) Complejo primario tuberculoso
- d) Metástasis de carcinoma
- e) Quistes hidatídicos

12) ¿Cuál de las siguientes opciones de informes espirométricos es más sugerente de EPOC?

- a) CVF: 85% del teórico; VEF1: 56% del teórico; VEF1/CVF: 42%, sin mejoría con salbutamol
- b) CVF: 62% del teórico; VEF1: 60% del teórico; VEF1/CVF: 83%, con mejoría con salbutamol
- c) CVF: 105% del teórico; VEF1: 96% del teórico; VEF1/CVF: 79%, sin mejoría con salbutamol
- d) CVF: 110% del teórico; VEF1: 60% del teórico; VEF1/CVF: 58%, con mejoría con salbutamol
- e) CVF: 51% del teórico; VEF1: 51% del teórico; VEF1/CVF: 80%, sin mejoría con salbutamol

13) Una paciente de 67 años consulta por disnea. Al examen físico destaca matidez y disminución del murmullo pulmonar en la base pulmonar izquierda. Se realiza radiografía de tórax que demuestra un derrame pleural izquierdo que ocupa el tercio inferior del hemitórax. Se realiza toracocentesis que demuestra proteínas: 2,2 g/dl; LDH: 30 UI; 12 células por ml, de predominio mononuclear, lactato: 2mg/dl; pH: 7,4. Proteínas plasmáticas: 7,8; LDH plasmática: 120 UI ¿Cuál de las siguientes etiologías es más probable?

- a) Empiema
- b) Derrame paraneumónico simple
- c) Tuberculosis
- d) Cáncer pulmonar
- e) Insuficiencia cardíaca

14) Un paciente obeso, de 57 años, con antecedentes de dislipidemia, diabetes y colelitiasis, inicia cuadro de vómitos y dolor abdominal intenso, diagnosticándose de pancreatitis aguda, con importante elevación de la lipasa. Evoluciona con dificultad respiratoria importante y desaturación arterial hasta 63%, con altísimos requerimientos de oxígeno para lograr saturación sobre 85%. Al examen pulmonar se constatan crépitos intensos, difusos y bilaterales. El diagnóstico más probable es:

- a) Neumonía
- b) Tromboembolismo pulmonar
- c) Edema pulmonar cardiogénico
- d) Distrés respiratorio
- e) Derrame pleural

15) Un paciente presenta disnea de esfuerzos, ortopnea y disnea paroxística nocturna. Al examen físico se observa desplazamiento del choque de la punta cardíaca al quinto espacio intercostal, en la línea axilar anterior, se ausculta un soplo diastólico III/VI en todo el precordio y se palpa el pulso arterial periférico muy amplio (pulso Celler). El diagnóstico más probable es:

- a) Estenosis aórtica
- b) Estenosis mitral
- c) Insuficiencia aórtica
- d) Insuficiencia mitral
- e) Miocardiopatía hipertrófica obstructiva

16) Una paciente, con antecedente de insuficiencia renal crónica en hemodiálisis, inicia un cuadro de malestar general, con fiebre hasta 38,5 y sudoración, de 3 semanas de evolución. Al examen físico está febril, con leve taquicardia y presión arterial normal. Se observan algunas Petequias conjuntivales y en los ortijos, el examen pulmonar es normal y se ausculta un soplo diastólico II/VI en el foco mitral. En sus exámenes de sangre destaca anemia leve, elevación de los parámetros inflamatorios, caída moderada en la función renal y elevación discreta de las transaminasas y la bilirrubina. El diagnóstico más probable es:

- a) Pericarditis aguda
- b) Miocardiopatía dilatada
- c) Endocarditis bacteriana subaguda
- d) Leucemia
- e) Infección por VIH

17) Una paciente de 23 años consulta por tos, con abundante expectoración, mayor en las mañanas, de algunos años de evolución. En ocasiones ha presentado expectoración hemoptoica. No fuma y no presenta otros síntomas. El examen físico es normal, al igual que la radiografía de tórax. El diagnóstico más probable es:

- a) Tuberculosis
- b) Cáncer pulmonar
- c) Bronquiectasias
- d) Bronquitis crónica
- e) Absceso pulmonar

18) Una mujer de 45 años, sin antecedentes de importancia, asintomática se realiza un electrocardiograma, como parte de un chequeo de salud, objetivándose un ritmo sinusal, con algunas extrasístoles, con QRS ancho y pausa compensatoria. La conducta más adecuada es:

- a) Tranquilizar a la paciente y explicarle que su condición no le traerá consecuencias negativas
- b) Solicitar Holter de arritmias
- c) Solicitar ecocardiografía
- d) Iniciar amiodarona
- e) Iniciar digoxina

19) Un paciente con antecedente de asma severo, con varias crisis asmáticas en el último mes, razón por la cual está actualmente en tratamiento con corticoides orales. Consulta en urgencia por cuadro de disnea sibilante, asociado a cianosis. Al examen físico presenta FC:120x', PA:110/70, FR:43x', cianosis perioral y tiraje. Se auscultan sibilancias inspiratorias y espiratorias, difusas. La saturación por pulsometría es 87%. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar 3 nebulizaciones con salbutamol cada 20 minutos y enviar a domicilio con dosis mayores de corticoides orales
- b) Administrar oxígeno, broncodilatadores nebulizados cada 20 minutos por 3 ocasiones, dexametasona endovenosa y enviar a domicilio con dosis mayores de corticoides orales
- c) Administrar oxígeno, broncodilatadores nebulizados, corticoides endovenosos y reevaluar en una hora, y si presenta buena respuesta; enviar a domicilio con dosis mayores de corticoides orales
- d) Hospitalizar, administrar oxígeno, broncodilatadores nebulizados, corticoides endovenosos y reevaluar periódicamente
- e) Realizar intubación orotraqueal y conectar a ventilador mecánico

20) Un paciente con antecedente de fibrilación auricular en tratamiento con digoxina, atenolol y acenocumarol, es traído a urgencias por cuadro astenia y luego compromiso de conciencia de 20 minutos de duración. Al examen físico está en sopor profundo, con frecuencia cardíaca regular, de 33 lpm y presión arterial de 66/32 mmHg. Las extremidades se aprecian pálidas y frías. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar suero fisiológico endovenoso rápido
- b) Realizar reposición de volumen con cristaloides y instalar bomba de norepinefrina
- c) Instalar marcapasos externo
- d) Administrar adrenalina 1 mg ev
- e) Iniciar masaje cardíaco

Prueba 6 (CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA)

1) Las siguientes condiciones pueden desencadenar una arritmia maligna en un niño portador de síndrome del QT largo, EXCEPTO:

- a) Hipocalcemia
- b) Bradicardia
- c) Hipokalemia
- d) Hiponatremia
- e) Hipomagnesemia

2) Un niño de 3 meses presenta un soplo sistólico eyectivo III/VI, asociado a un desdoblamiento fijo del segundo ruido. Usted debe sospechar:

- a) Comunicación interventricular
- b) Comunicación interauricular
- c) Ductus arterioso persistente
- d) Coartación aórtica
- e) Transposición de grandes vasos

3) Adolescente de 14 años inicia dolor torácico retroesternal de intensidad 7/10, que aumenta con la inspiración. El examen físico no aporta mayor información. Se solicita radiografía de tórax que resulta normal y electrocardiograma que demuestra elevación del segmento ST en todas las derivaciones precordiales. EL diagnóstico más probable es:

- a) Disección aórtica
- b) Endocarditis bacteriana aguda
- c) Taponamiento pericárdico
- d) Pericarditis aguda
- e) Infarto agudo al miocardio

4) El ductus arterioso persistente se manifiesta semiológicamente como:

- a) Chasquido de apertura, asociado a aumento del segundo ruido
- b) Click de apertura, asociado a disminución del segundo ruido
- c) Chasquido de apertura, asociado a soplo sistólico
- d) Soplo con componente sistólico y diastólico
- e) Soplo sistólico, asociado a desdoblamiento paradójico del segundo ruido

5) La cardiopatía congénita más frecuente es:

- a) Comunicación interventricular
- b) Comunicación interauricular
- c) Ductus arterioso persistente
- d) Canal auriculoventricular
- e) Drenaje anómalo de venas pulmonares

6) Un adolescente de 14 años, con antecedente de enfermedad de Kawasaki en su infancia, inicia dolor precordial opresivo, irradiado a cuello y hombro izquierdo, asociado a disnea. Al examen físico se aprecia pálido, taquicárdico a 120x', con ritmo cardíaco regular en 3 tonos, por presencia de R4, sin soplos. El diagnóstico más probable es:

- a) Miocarditis aguda
- b) Miocardiopatía dilatada
- c) Pericarditis
- d) Flutter auricular
- e) Infarto agudo al miocardio

7) Un recién nacido de término, sin antecedentes obstétricos de importancia, presenta cianosis intensa y desaturación arterial marcada, desde el nacimiento, que no responde a oxígeno al 100%. El examen físico no aporta mayor información. La conducta más adecuada es:

- a) Intubar y ventilar con presión positiva
- b) Derivar para resolución quirúrgica inmediata
- c) Administrar prostaglandina E y realizar ecocardiografía a la brevedad
- d) Administrar indometacina y realizar ecocardiografía a la brevedad
- e) Administrar antibióticos endovenosos, surfactante endotraqueal y oxígeno al 100%

8) La primera causa de hipertensión arterial en los niños es:

- a) Esencial
- b) Renovascular
- c) Insuficiencia renal
- d) Coartación aórtica
- e) Síndrome hemolítico urémico

9) Las cardiopatías congénitas con cortocircuito de izquierda a derecha, que son corregidas tardíamente, desarrollan característicamente:

- a) Endocarditis bacteriana
- b) Embolías cardíacas
- c) Hipertensión pulmonar persistente
- d) Hipertensión arterial
- e) Fibrilación auricular

10) Un niño de 3 años, cursando disentería aguda en tratamiento con cotrimoxazol, ingresa comprometido de conciencia, en malas condiciones generales. Al examen físico se encuentra mal perfundido, hipotenso y taquicárdico. Se monitoriza invasivamente con catéter de Swan-Ganz y línea arterial, demostrándose presión arterial baja, presión de enclavamiento pulmonar elevada y presión venosa central elevada. ¿Cuál es la causa más probable del shock?

- a) Hipovolémico
- b) Séptico
- c) Cardiogénico
- d) Neurogénico
- e) Anafiláctico

11) ¿Cuál de las siguientes cardiopatías congénitas se acompaña de cianosis?

- a) Drenaje anómalo de las venas pulmonares
- b) Comunicación interventricular
- c) Ventrículo único
- d) Ductus arterioso persistente
- e) Coartación aórtica

12) La primera causa de insuficiencia cardíaca en la edad pediátrica es:

- a) Canalopatías
- b) Miocardiopatía hipertrófica
- c) Miocardiopatía coronaria
- d) Malformaciones cardíacas
- e) Enfermedad coronaria

13) Un niño con antecedente de ventrículo único operado, con cirugía de Fontan, con buena evolución, debe ser sometido a un procedimiento dental. A modo de prevenir la aparición de endocarditis infecciosa debe administrarse, como primera opción:

- a) Clindamicina oral, luego del procedimiento
- b) Amoxicilina oral, previo al procedimiento
- c) Ampicilina y gentamicina, por vía endovenosa, previo al procedimiento
- d) Ceftriaxona endovenosa, previo al procedimiento
- e) Cefadroxilo oral, luego del procedimiento

14) Un recién nacido prematuro de 7 horas de vida, presenta temblor, mioclonías y luego sopor, convulsionando en una oportunidad. Al examen físico se constata taquicárdico e hiporreactivo. No se aprecian signos neurológicos focales. Se solicita hemoglucotest que resulta normal y electrocardiograma que demuestra una taquicardia ventricular polimorfa. La alteración hidroelectrolítica que con mayor probabilidad es responsable del cuadro descrito, es:

- a) Hipocalcemia
- b) Hipercalcemia
- c) Hipokalemia
- d) Hiperkalemia
- e) Hiponatremia

15) La persistencia del ductus arterioso, luego del nacimiento, puede tratarse farmacológicamente con:

- a) Adenosina
- b) Prostaglandinas
- c) Furosemida
- d) Indometacina
- e) Digoxina

16) Un niño de 13 años presenta 2 síncope en relación al esfuerzo. Al examen físico se ausculta un soplo sistólico, que aumenta con la maniobra de Valsalva. El diagnóstico más probable es:

- a) Insuficiencia mitral
- b) Estenosis mitral
- c) Estenosis pulmonar
- d) Coartación aórtica
- e) Miocardiopatía hipertrófica

17) Un lactante de 2 semanas, asintomático, presenta un soplo cardíaco holosistólico IV/VI, que se ausculta en todo el precordio izquierdo. El diagnóstico más probable es:

- a) Atresia tricuspídea
- b) Comunicación interauricular tipo ostium secundum
- c) Comunicación interventricular
- d) Tronco arterioso
- e) Foramen oval permeable

18) Un niño de 3 meses presenta mal incremento ponderal e infecciones respiratorias a repetición. La madre refiere que se cansa rápidamente al mamar. Al examen físico destacan crépitos pulmonares bibasales y soplo cardíaco sistólico. Presenta además desaturación arterial hasta 85%, que revierte al aportar oxígeno. El diagnóstico más probable es:

- a) Cardiopatía congénita con cortocircuito de derecha a izquierda
- b) Cardiopatía congénita con cortocircuito de izquierda a derecha
- c) Cardiopatía congénita obstructiva izquierda
- d) Cardiopatía congénita con mezcla total
- e) Transposición de grandes arterias

19) El fármaco de elección para convertir una taquicardia paroxística supraventricular, hemodinámicamente estable, que no responde a maniobras vagales, es:

- a) Amiodarona
- b) Digoxina
- c) Adenosina
- d) Propanolol
- e) Nifedipino

20) ¿Cuál de las siguientes características NO corresponde a un soplo funcional?

- a) Sistólico
- b) Intensidad III/VI
- c) Tonalidad musical
- d) Presencia de frémito
- e) Eyectivo

Prueba 7

1) Un paciente de 67 años, con antecedentes de hipertensión arterial en tratamiento con nifedipino, consulta por dolor retroesternal opresivo, intenso e irradiado al cuello y a la mandíbula, de 30 minutos de duración, asociado a sudoración. Al examen físico se constata FC: 100x' regular, PA: 160/100 mmHg y se ausculta un ritmo cardíaco regular en 3 tiempos, con presencia de un cuarto ruido (R4), sin soplos. La conducta inmediata debe ser:

- a) Solicitar angioTAC de tórax
- b) Solicitar coronariografía de urgencia
- c) Realizar trombolisis endovenosa
- d) Solicitar ecocardiograma
- e) Solicitar electrocardiograma

2) Una paciente de 59 años, cursando el segundo día de un infarto agudo al miocardio de la pared anterolateral, manejado con trombolisis con estreptoquinasa, presenta súbitamente pérdida de conciencia. Al examen físico se aprecia pulso débil, a 125x', regular, PA: 50/20mmHg y se observan las yugulares marcadamente ingurgitadas. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Taquicardia ventricular
- b) Flutter auricular
- c) Rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo
- d) Rotura del músculo papilar
- e) Tromboembolismo pulmonar masivo

3) Un paciente de 63 años, con antecedente de un infarto agudo al miocardio hace 5 años, consulta por palpitations intensas, asociadas a disnea y desorientación. Se aprecia pálido, sudoroso y soporoso, con pulso de 180x', regular y presión arterial de 80/60 mmHg. Se instala monitor electrocardiográfico, que muestra una taquicardia regular con QRS ancho. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar maniobras vagales
- b) Solicitar electrocardiograma de 12 derivaciones
- c) Administrar adenosina endovenosa
- d) Administrar amiodarona endovenosa
- e) Realizar cardioversión eléctrica

4) ¿Qué paciente NO tiene indicación de anticoagulación a permanencia?

- a) Paciente de 17 años con válvula mitral protésica, mecánica
- b) Paciente de 70 años con cardiopatía coronaria, hipertensión arterial y fibrilación auricular crónica, en tratamiento con digoxina y atenolol
- c) Paciente de 65 años con fibrilación auricular crónica, que sufrió un infarto de arteria cerebral media izquierda hace 1 mes
- d) Paciente de 35 años, con fibrilación auricular idiopática, que aqueja palpitations frecuentes
- e) Paciente de 60 años, diabético e hipertenso, con fibrilación auricular crónica, manejada con amiodarona, que ha logrado mantenerlo en ritmo sinusal

5) ¿Qué examen está más indicado para seguir la evolución del derrame pericárdico en un paciente con una pericarditis aguda viral?

- a) Electrocardiograma
- b) Ecocardiograma
- c) Pericardiocentesis
- d) Radiografía de tórax
- e) Auscultación cardíaca

6) Un lactante de 2 meses de edad ha presentado un mal incremento ponderal y varias infecciones respiratorias. Al examen físico se ausculta un soplo cardíaco continuo, más intenso durante la sístole y no presenta cianosis. El diagnóstico más probable es:

- a) Soplo inocente
- b) Comunicación interventricular
- c) Comunicación interauricular
- d) Ductus arterioso persistente
- e) Coartación aórtica

7) Un paciente de 70 años consulta por angina de pecho, al caminar 2 cuadras. Además ha sufrido 2 síncope durante el esfuerzo físico y presenta ortopnea. Al examen físico se aprecia pulso de baja amplitud y se ausculta un soplo sistólico. El diagnóstico más probable es:

- a) Miocardiopatía hipertrófica obstructiva
- b) Estenosis aórtica
- c) Insuficiencia aórtica
- d) Insuficiencia mitral
- e) Insuficiencia cardíaca por cardiopatía coronaria

8) Un paciente de 36 años consulta por disnea de medianos esfuerzos, asociados a edema de extremidades inferiores de un mes de evolución y que ha aumentado en el último tiempo. Refiere que se ahoga en la noche, por lo que debe dormir semisentado. Al examen físico se constata desplazamiento del choque de la punta y se auscultan crépitos pulmonares bibasales. El electrocardiograma muestra signos de hipertrofia ventricular izquierda. El diagnóstico más probable es:

- a) Insuficiencia mitral
- b) Miocardiopatía hipertrófica
- c) Miocardiopatía dilatada
- d) Enfermedad de Kawasaki
- e) Insuficiencia aórtica

9) Un paciente de 67 años, con antecedente de una estenosis mitral, ingresa al servicio de urgencia comprometido de consciencia, hipotenso, taquicárdico y febril. Al examen físico está pálido y sudoroso, con FC: 120x', PA: 60/40 mmHg, t°: 40,2°C. Se ausculta un soplo cardíaco intenso y se observan petequias en las extremidades inferiores. El monitoreo electrocardiográfico muestra una taquicardia sinusal. Se inicia oxígeno, se instalan vías venosas periféricas y se monitoriza invasivamente con un catéter de Swan-Ganz, obteniéndose los siguientes resultados: PVC: 4 mmHg, PAP: 20/4 mmHg, PCP: 6mmHg. La medida más adecuada para el manejo del shock es:

- a) Administrar suero fisiológico endovenoso
- b) Iniciar dopamina por bomba de infusión continua
- c) Iniciar noradrenalina en infusión continua
- d) Administrar adrenalina intramuscular
- e) Realizar cardioversión eléctrica

10) El diagnóstico de la angina estable se fundamenta en:

- a) La historia clínica
- b) El examen físico
- c) El test de esfuerzo
- d) La coronariografía
- e) El ecocardiograma

11) Un paciente de 65 años de edad, con antecedente de hipertensión arterial consulta por dolor torácico intenso de inicio súbito, transfixiante. Al examen físico sólo destaca PA: 180/110 mmHg. El electrocardiograma muestra alteraciones inespecíficas de la repolarización y la radiografía de tórax muestra un ensanchamiento mediastínico. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar coronariografía de urgencia
- b) Iniciar anticoagulación con heparina
- c) Administrar aspirina, oxígeno y nitroglicerina
- d) Solicitar angioTAC de tórax de urgencia
- e) Iniciar nitroprusiato endovenoso

12) Un paciente con antecedente de claudicación intermitente, consulta por dolor intenso de la pantorrilla izquierda, de inicio súbito hace 2 horas. Al examen se aprecia palidez y ausencia de pulso de la extremidad. La conducta inicial más adecuada es:

- a) Anticoagular con heparina y solicitar angiografía de EEII
- b) Indicar reposo absoluto con la extremidad colgando de la cama
- c) Solicitar pletismografía de volumen (PVR)
- d) Solicitar eco-doppler de extremidades inferiores
- e) Instalar un filtro de vena cava inferior

13) Un paciente de 65 años consulta por dolor de la extremidad inferior izquierda de algunas horas de evolución. Al examen físico se aprecia edema blando de dicha extremidad, asociado a dolor a la palpación de las masas musculares, sin otras alteraciones. Los pulsos pedios y poplíteos son normales. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar AINES y controlar en 48 horas
- b) Solicitar electrocardiograma
- c) Solicitar ecodoppler de extremidades inferiores
- d) Solicitar angiografía de extremidades inferiores
- e) Solicitar pletismografía de volumen de extremidades inferiores (PVR)

14) ¿Qué examen es más adecuado para determinar el pronóstico de una insuficiencia cardíaca secundaria a una cardiopatía coronaria?

- a) Holter de presión arterial
- b) Electrocardiograma
- c) Coronariografía
- d) Test de esfuerzo
- e) Ecocardiograma

15) ¿Cuál de las siguientes patología producirá un aumento de la intensidad del componente pulmonar del segundo ruido cardíaco?

- a) Estenosis pulmonar
- b) Insuficiencia pulmonar
- c) Estenosis tricuspídea
- d) Insuficiencia tricuspídea
- e) Hipertensión pulmonar

16) Un paciente de 76 años, hipertenso, en tratamiento con atenolol e hidroclorotiazida, presenta varios síncope en la última media hora. Al examen físico destaca FC: 30 lpm, con R1 de intensidad variable. El diagnóstico más probable es:

- a) Bloqueo aurículoventricular completo
- b) Enfermedad del nodo sinusal
- c) Bradicardia sinusal
- d) Infarto de ventrículo derecho
- e) Hiperkalemia severa

17) Un paciente de 64 años, portador de una insuficiencia cardíaca congestiva, secundaria a una cardiopatía hipertensiva, en tratamiento con enalapril y furosemida en dosis altas, presenta aumento de la disnea y ortopnea basales. El examen físico y el estudio inicial descartan patologías agudas. ¿Qué conducta es más adecuada para el manejo de este paciente?

- a) Agregar una tiazida
- b) Suspender la furosemida
- c) Iniciar betabloqueadores
- d) Reemplazar el enalapril por un antagonista del receptor de angiotensina II
- e) Iniciar un antiagregante plaquetario

18) Un paciente de 56 años, fumador, sufre una hemiplejía derecha de instalación súbita, que dura cerca de 15 minutos, cediendo de manera inmediata. El TAC de cerebro resulta normal. Al examen físico se ausculta un soplo cervical izquierdo. ¿Qué examen es el más adecuado para proseguir el estudio etiológico?

- a) Ecografía doppler de arterias carótidas
- b) Angiografía de arterias carótidas
- c) Angioresonancia magnética nuclear de cuello y cerebro
- d) Electroencefalograma
- e) Ecocardiograma transesofágico

19) ¿Qué situación debería hacer sospechar una hipertensión arterial secundaria a una estenosis de arteria renal?

- a) Presencia de hipokalemia
- b) Elevación de la creatinina plasmática
- c) Buena respuesta al tratamiento con espironolactona

- d) Estrechamiento de los cruces arteriovenosos en el fondo de ojo
- e) Signos de hipertrofia ventricular izquierda en el electrocardiograma

20) ¿Qué tratamiento antibiótico es más adecuado para una endocarditis aguda, cuyo hemocultivo se encuentra pendiente?

- a) Cloxacilina + ampicilina + metronidazol
- b) Ceftriaxona + metronidazol
- c) Ciprofloxacino + clindamicina + penicilina
- d) Gentamicina + cloxacilina + ampicilina
- e) Ampicilina + clindamicina + ceftriaxona

Prueba 8

1) Un paciente de 24 años presenta angina de pecho, relacionada con el ejercicio, asociado a síncope de esfuerzos y disnea paroxística nocturna. Al examen físico se ausculta un ritmo regular en 3 tonos con presencia de un R4, **sin soplos y escasos crépitos pulmonares bibasales. La radiografía de tórax muestra silueta cardíaca normal, con pulmones congestivos y el electrocardiograma muestra signos de hipertrofia ventricular izquierda. El diagnóstico más probable es:**

- a) Válvula aórtica bicúspide
- b) Insuficiencia aórtica
- c) Coartación aórtica
- d) Miocardiopatía hipertrófica
- e) Síndrome de Brugada

2) Un paciente de 57 años, con antecedente de hipertensión arterial, consulta por palpitaciones de una hora de evolución. Al examen físico se constata FC: 154x', regular y PA: 130/80 mmHg. Se solicita electrocardiograma que muestra una taquicardia regular a QRS angosto, con presencia de "ondas de serrucho" en las derivaciones DII, DIII y AVF. El diagnóstico más probable es:

- a) Fibrilación auricular
- b) Flutter auricular
- c) Taquicardia sinusal
- d) Taquicardia paroxística supraventricular
- e) Taquicardia ventricular

3) ¿Cuál de los siguientes casos clínicos es más concordante con una úlcera arterial?

- a) Úlcera sobre el maleólo medial, dolorosa, de borde irregular
- b) Úlcera sobre el maleólo lateral, indolora, de borde regular
- c) Úlcera sobre el maleólo medial, indolora, de borde regular
- d) Úlcera sobre el maleólo lateral, dolorosa, de borde irregular
- e) Úlcera sobre el maleólo medial, dolorosa, de borde regular

4) Un paciente de 60 años presenta astenia, asociada a edema de extremidades inferiores, de algunas semanas de evolución. Al examen físico se ausculta un soplo cardíaco holosistólico, se palpa hepatomegalia y se observa una onda "v" gigante en el pulso venoso. El diagnóstico más probable es:

- a) Pericarditis constrictiva
- b) Estenosis tricuspídea
- c) Insuficiencia mitral
- d) Estenosis mitral
- e) Insuficiencia tricuspídea

5) Una paciente presenta un electrocardiograma con el complejo QRS ancho, asociado a un acortamiento del segmento PR y presencia de una onda delta. Esta paciente tendrá alto riesgo de:

- a) Muerte súbita
- b) Fibrilación auricular
- c) Infarto cardíaco
- d) Bloqueo A-V de tercer grado
- e) Taquicardia paroxística supraventricular

6) Un paciente de 67 años, cardiópata coronario, diagnosticado de insuficiencia cardíaca congestiva en CF II, en tratamiento con aspirina, enalapril, furosemida y atorvastatina, consulta por leve empeoramiento de su disnea basal, la que actualmente es de pequeños esfuerzos. Se solicita radiografía de tórax que muestra cardiomegalia, hilios pulmonares prominentes y redistribución de los vasos pulmonares hacia los ápices, sin presencia de edema pulmonar. El electrocardiograma, así como el hemograma y las CK plasmáticas descartan patologías agudas. La conducta más adecuada es:

- a) Reemplazar el enalapril por losartán
- b) Reemplazar la furosemida por hidroclorotiazida
- c) Iniciar digoxina
- d) Iniciar betabloqueantes
- e) Iniciar amiodarona

7) Un paciente de 80 años de edad se realiza una ecografía abdominal, como parte de sus exámenes de rutina, que muestra la presencia de un aneurisma aórtico infrarrenal de 5,0 cm de diámetro. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución, controlando con ecografías periódicas
- b) Solicitar angiografía
- c) Hospitalizar y administrar antihipertensivos endovenosos
- d) Anticoagular con heparina
- e) Derivar para resolución quirúrgica

8) Un paciente de 67 años, diabético e hipertenso, consulta por dolor torácico opresivo, intenso, por lo que se realiza un electrocardiograma que muestra supradesnivel del segmento ST en las derivaciones V1 a V4. Recibe aspirina, oxígeno y nitroglicerina y se inicia el protocolo de trombolisis endovenosa con estreptoquinasa. Treinta minutos después el dolor disminuye considerablemente, al igual que el supradesnivel del ST. Además en los controles seriados de CKmb se constata una anticipación en alcanzar el peak. Usted debe sospechar:

- a) Que la trombolisis fue exitosa
- b) Un infarto de ventrículo derecho
- c) Una perforación del tabique interventricular
- d) Una disección aórtica
- e) La formación de un aneurisma cardíaco

9) La “danza arterial” es característica de:

- a) Estenosis aórtica
- b) Insuficiencia aórtica
- c) Transposición de grandes vasos
- d) Tetralogía de Fallot
- e) Miocardiopatía hipertrófica obstructiva

10) ¿Cuál de las siguientes alternativas es una contraindicación para el uso de IECAs?

- a) Hiperkalemia
- b) Clearance de creatinina de 50 ml/min
- c) Diabetes mellitus
- d) Asma
- e) Insuficiencia cardíaca en capacidad funcional IV

11) Un paciente de 56 años consulta por palpitaciones intensas y malestar general. Al examen físico presenta FC: 170x', irregular y PA: 110/60 mmHg. El electrocardiograma demuestra una taquicardia irregular con algunos complejos QRS anchos alternados con otros complejos QRS angostos y además se aprecia ausencia de onda P. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar amiodarona e.v.
- b) Administrar adrenalina e.v.
- c) Administrar adenosina e.v.
- d) Administrar verapamilo e.v.
- e) Administrar digitálicos e.v. (lanatósido C)

12) Un paciente de 46 años, portador una resistencia a la proteína C, presenta de manera súbita dolor torácico, disnea y luego pérdida de consciencia. Al examen físico está taquicárdico a 120x' e hipotenso, con presión arterial de 70/40 mmHg. El electrocardiograma muestra una taquicardia sinusal, con onda S profunda en DI y una onda Q, asociada a inversión de la onda T en DIII. Se realiza una ecocardiografía de urgencia que muestra una importante elevación de la presión de la arteria pulmonar. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar coronariografía de urgencia
- b) Realizar angiografía pulmonar de urgencia y trombolisis
- c) Solicitar Angio-TAC de tórax
- d) Administrar suero fisiológico
- e) Administrar aspirina, oxígeno, nitroglicerina y morfina y solicitar troponinas plasmáticas

13) Un paciente de 27 años recibe una puñalada en el tórax, evolucionando con malestar general y síncope. Al examen físico está soporoso, taquicárdico a 150lpm con presión arterial de 60/30 mmHg y yugulares ingurgitadas. Se auscultan ruidos cardíacos muy apagados y el examen pulmonar es normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Disección aórtica
- b) Hemomediastino
- c) Shock hipovolémico
- d) Taquicardia ventricular
- e) Taponamiento cardíaco

14) Un recién nacido presenta cianosis que no responde a oxígeno al 100%, asociada a un soplo sistólico eyectivo intenso, mayor en el segundo espacio intercostal izquierdo. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Comunicación interauricular
- b) Comunicación interventricular
- c) Ductus arterioso persistente
- d) Tetralogía de Fallot
- e) Transposición de grandes vasos

15) Un paciente de 67 años, diabético e hipertenso, portador de una ACxFA crónica, en tratamiento con atenolol, digoxina y anticoagulación oral con warfarina, debe someterse a una cirugía electiva por una hernia inguinal. La conducta más adecuada es:

- a) Mantener la warfarina y realizar la cirugía bajo anticoagulación oral
- b) Administrar vitamina K endovenosa, 2 días previos a la cirugía
- c) Administrar plasma fresco congelado el día de la cirugía
- d) Reemplazar la warfarina por heparina algunos días previos a la cirugía y suspender la heparina 6 horas antes de operar
- e) Reemplazar la warfarina por heparina algunos días previos a la cirugía y administrar protamina endovenosa antes de operar

16) ¿Qué orienta más al diagnóstico de una angina estable?

- a) Dolor precordial relacionado con el esfuerzo
- b) Electrocardiograma con supradesnivel del ST
- c) Disnea paroxística nocturna
- d) Antecedente de hipercolesterolemia
- e) Dolor torácico opresivo

17) ¿Qué alteración es más sugerente de una disección aórtica en contexto de un paciente que consulta por dolor torácico?

- a) Infradesnivel del segmento ST
- b) Radiografía de tórax con ensanchamiento mediastínico
- c) Elevación de la mioglobina plasmática
- d) Soplo sistólico eyectivo
- e) Tercer ruido

18) Un paciente es encontrado inconsciente por su esposa. Usted lo evalúa y constata ausencia de pulso y de respiración. Se inicia masaje cardíaco y se instala monitor electrocardiográfico que muestra una fibrilación ventricular. Luego de 5 ciclos de masaje continua sin pulso. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar intubación orotraqueal y ventilación a presión positiva, continuando con el masaje cardíaco
- b) Realizar desfibrilación eléctrica y continuar el masaje cardíaco
- c) Administrar adrenalina y continuar el masaje cardíaco
- d) Administrar amiodarona endovenosa y continuar el masaje cardíaco
- e) Realizar desfibrilación eléctrica, administrar adrenalina y amiodarona endovenosa y continuar el masaje cardíaco

19) Identifique la asociación FALSA entre la patología y su semiología

- a) Miocardiopatía hipertrófica obstructiva – Soplo mesosistólico, que aumenta con la maniobra de Valsalva
- b) Miocardiopatía dilatada – Desplazamiento del choque de la punta
- c) Estenosis aórtica – Soplo holosistólico, con aumento de la intensidad del R2

- d) Estenosis mitral – Soplo diastólico, con refuerzo presistólico
- e) Estenosis pulmonar – Soplo sistólico que aumenta con la inspiración

20) Un hombre de 47 años, asintomático, obeso, cuyo padre y madre son hipertensos, acude a control médico, donde se le controla presión arterial de 164/100 mmHg. Se realizan varios controles de presión arterial en días diferentes, constándose cifras tensionales cercanas a 160/100 mmHg. Su examen físico es normal y trae hemograma, pruebas hepáticas, creatinina plasmática, sodio, potasio y glicemia de ayuno, todos normales. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar dieta hiposódica y ejercicios, controlando en 3 meses
- b) Iniciar espironolactona
- c) Iniciar enalapril
- d) Solicitar metanefrinas urinarias
- e) Solicitar aldosterona plasmática, actividad de renina plasmática y angiografía de arterias renales

Prueba 9

1) Un paciente de 50 años, diabético, consulta en la sala de urgencia por dolor retroesternal, de 2 horas de evolución, opresivo, de intensidad 9/10, asociado a disnea y sensación de muerte inminente. Al examen físico está sudoroso, con FC: 100x', PA: 120/90 mmHg, RR2T, sin soplos. Se realiza un electrocardiograma que muestra un supradesnivel del segmento ST en las derivaciones DII, DIII y AVF. Se administra oxígeno, aspirina y nitroglicerina. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar ecocardiografía de urgencia
- b) Mantener hospitalizado hasta resolución del cuadro y solicitar test de esfuerzo al alta
- c) Iniciar protocolo de trombolisis endovenosa
- d) Anticoagular con heparina
- e) Solicitar angio-TAC de tórax

2) Ingresa un paciente con una fibrilación auricular rápida a 150 lpm, desorientado, disneico, sudoroso, con PA: 80/60 mmHg, La conducta más adecuada es:

- a) Administrar suero fisiológico
- b) Administrar amiodarona endovenosa, 150 mg en bolo
- c) Administrar adrenalina 1mg endovenoso
- d) Administrar amiodarona endovenosa, 150 mg en infusión continua
- e) Realizar cardioversión eléctrica inmediata

3) Un paciente de 30 años consulta por un cuadro de 3 meses de evolución, progresivo, de disnea de esfuerzo, ortopnea, disnea paroxística nocturna y edema de extremidades inferiores. Al examen físico sólo destaca un desplazamiento del choque de la punta cardíaca al quinto espacio intercostal, a la altura de la línea axilar anterior, razón por la cual usted sospecha una miocardiopatía dilatada. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar un ecocardiograma
- b) Solicitar un electrocardiograma
- c) Solicitar un test de esfuerzo
- d) Solicitar una coronariografía
- e) Solicitar troponinas plasmáticas

4) La causa más frecuente de insuficiencia cardíaca crónica es:

- a) Cardiopatía coronaria
- b) Hipertensión arterial
- c) Valvulopatías
- d) Miocardiopatías
- e) Cardiopatías congénitas

5) Una mujer consulta por palpitaciones intensas, de inicio súbito. Al examen físico está en buenas condiciones generales, con FC: 180x' y PA: 110/70. Se realiza un electrocardiograma que muestra una taquicardia regular a QRS angosto. Se realizan maniobras vagales, sin lograr resultados. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar cardioversión eléctrica
- b) Administrar propafenona
- c) Administrar amiodarona
- d) Administrar adenosina
- e) Administrar bloqueadores de los canales de calcio

6) El dímero D es un examen que sirve para:

- a) Enfrentar un paciente con sospecha de TEP masivo
- b) Confirmar la sospecha clínica de TEP en pacientes con síntomas de TVP
- c) Confirmar la presencia de un TEP en pacientes con baja probabilidad de tenerlo
- d) Descartar la presencia de un TEP en pacientes de alto riesgo de tenerlo
- e) Descartar la presencia de un TEP en pacientes de bajo riesgo de tenerlo

7) Un paciente de 67 años, consulta por un cuadro clínico compatible con una angina crónica, por lo que se realiza un test de esfuerzo que muestra signos electrocardiográficos de isquemia anterolateral ante el esfuerzo. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar aspirina ante la aparición del dolor
- b) Indicar nitroglicerina sublingual ante la aparición del dolor
- c) Solicitar ecocardiografía simple
- d) Solicitar ecocardiografía de esfuerzo, con aceleración con dobutamina
- e) Solicitar coronariografía

8) Un paciente de 67 años presenta dolor en la pantorrilla izquierda, que aparece al caminar 3 cuerdas y que cede con el reposo. Es diabético, fumador e hipertenso, en tratamiento con enalapril, metformina y aspirina. El examen físico muestra disminución de los pulsos pedio y tibial posterior de la extremidad inferior izquierda. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar ejercicios y mejorar sus el control de sus factores de riesgo cardiovascular
- b) Indicar anticoagulación a permanencia y mejorar sus el control de sus factores de riesgo cardiovascular
- c) Solicitar una ecografía doppler de extremidades inferiores
- d) Solicitar una angiografía de extremidades inferiores
- e) Derivar para resolución quirúrgica

9) Un paciente de 70 años, sin antecedentes de importancia, presenta un síncope de 2 minutos de duración. Al examen físico se encuentra en buenas condiciones generales. Se solicita un electrocardiograma que demuestra un bloqueo AV de segundo grado, de tipo Mobitz II, asociado a bloqueo completo de rama derecha. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar atropina S.O.S
- b) Solicitar ecocardiografía
- c) Indicar amiodarona
- d) Instalar marcapasos definitivo
- e) Observar evolución

10) El primer fármaco que debe administrarse ante una hiperkalemia severa, con compromiso electrocardiográfico es:

- a) Suero fisiológico
- b) Sulfato de magnesio
- c) Gluconato de calcio
- d) Insulina cristalina + glucosa
- e) Salbutamol nebulizado

11) Un paciente de 67 años, con antecedente de hipertensión arterial, tabaquismo y un infarto cardíaco hace 4 años, se realiza un electrocardiograma que muestra extrasístoles ventriculares frecuentes. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Solicitar test de esfuerzo
- c) Solicitar coronariografía
- d) Iniciar amiodarona oral
- e) Iniciar betabloqueantes orales

12) Un paciente de 18 años consulta por dolor torácico de 6 horas de evolución, que se acentúa con la inspiración y que disminuye al inclinarse hacia adelante. Se solicita un electrocardiograma que muestra supradesnivel del segmento ST en todas las derivaciones precordiales. El tratamiento más importante para la patología descrita es:

- a) Antiagregantes plaquetarios
- b) Antiinflamatorios no esteroideos
- c) Corticoides orales
- d) Anticoagulantes
- e) Quirúrgico

13) Un paciente diabético de 50 años de edad, es diagnosticado de hipertensión arterial mediante un Holter de presión arterial. Se indica dieta hiposódica y se controla 3 meses después, constatándose presiones arteriales cercanas a 140/90 mmHg. La conducta más adecuada es:

- a) Mantener indicaciones y controlar en 3 meses
- b) Indicar ejercicio aeróbico
- c) Iniciar hidroclorotiazida
- d) Iniciar enalapril
- e) Iniciar atenolol

14) ¿Qué fármacos mejoran los síntomas, SIN aumentan la sobrevida en los paciente con insuficiencia cardíaca crónica?

- a) Diuréticos y betabloqueantes
- b) Hidralazina e isosorbide
- c) Digitálicos e inhibidores del receptor de angiotensina II
- d) Espironolactona e inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina
- e) Diuréticos y digitálicos

15) Un paciente de 67 años, hipertenso, con antecedente de estenosis mitral, es diagnosticado de fibrilación auricular paroxística, mediante la clínica y un estudio electrocardiográfico. Refiere palpitaciones frecuentes y molestas. El tratamiento de elección para el manejo de este paciente es:

- a) Atenolol + acenocumarol
- b) Amiodarona + acenocumarol
- c) Amiodarona
- d) Digoxina
- e) Atenolol

16) ¿Cuál de los siguientes microorganismos es una causa frecuente de endocarditis bacteriana subaguda?

- a) Streptococcus pyogenes
- b) Streptococcus pneumoniae
- c) Staphylococcus epidermidis
- d) Streptococcus viridans
- e) Streptococcus agalactiae

17) Son causas de alargamiento del segmento QT, EXCEPTO:

- a) Hiponatremia
- b) Hipokalemia
- c) Hipomagnesemia
- d) Hipocalcemia
- e) Bradicardia

18) ¿Qué examen es el más adecuado para confirmar la sospecha clínica de una rotura de músculo papilar, durante un síndrome coronario agudo?

- a) Electrocardiograma
- b) Ecocardiografía
- c) Tomografía axial computada, con contraste
- d) Ventriculografía
- e) Resonancia magnética nuclear

19) Un paciente de 30 años, previamente sano, presenta dolor de la pierna izquierda, de inicio súbito, asociado a edema de la extremidad. Al examen físico se constata dolor a la palpación de las masas musculares y signo de Homan positivo. Se confirma el diagnóstico de trombosis venosa profunda, mediante es estudio correspondiente. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar aspirina oral
- b) Administrar heparina endovenosa
- c) Instalar filtro de vena cava inferior
- d) Realizar trombolisis con fibrinolíticos endovenosos
- e) Resolver quirúrgicamente

20) Un paciente es picado por una abeja, evolucionando con malestar general, tos y aparición de placas pseudopapulares generalizadas. Al examen físico presenta taquicardia, PA: 90/50 mmHg y se ausculta estridor inspiratorio. La medida más importante es:

- a) Adrenalina intramuscular
- b) Intubación orotraqueal
- c) Suero fisiológico endovenoso
- d) Nebulización con broncodilatadores
- e) Hidrocortisona endovenosa

Prueba 10

1) Un paciente de 67 años, con antecedentes de hipertensión arterial en tratamiento con nifedipino, consulta por dolor retroesternal opresivo, intenso e irradiado al cuello y a la mandíbula, de 30 minutos de duración, asociado a sudoración. Al examen físico se constata FC: 100x' regular, PA: 160/100 mmHg y se ausculta un ritmo cardíaco regular en 3 tiempos, con presencia de un cuarto ruido (R4), sin soplos. Se solicita Electrocardiograma que muestra supradesnivel del segmento ST en las derivaciones DI, V5 y V6. La conducta inmediata debe ser:

- a) Iniciar aspirina, oxígeno, nitroglicerina, morfina y anticoagular con heparina
- b) Iniciar aspirina, oxígeno, nitroglicerina, morfina y solicitar test de esfuerzo una vez resuelto el cuadro
- c) Iniciar aspirina, oxígeno, nitroglicerina, morfina y realizar trombolisis endovenosa
- d) Iniciar aspirina, oxígeno, nitroglicerina, morfina y solicitar ecocardiograma
- e) Realizar coronariografía de urgencia, sin necesidad de administrar fármacos

2) Una paciente de 59 años, cursando el segundo día de un infarto agudo al miocardio de la pared anteroseptal, presenta marcado empeoramiento del estado general, evolucionando con palidez y disnea. Al examen físico se aprecia pulso a 115x', regular, PA: 100/70mmHg, se ausculta un soplo cardíaco holosistólico y se escuchan crépitos pulmonares bilaterales. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Disección aórtica
- b) Formación de aneurisma cardíaco
- c) Rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo
- d) Rotura del músculo papilar
- e) Tromboembolismo pulmonar masivo

3) Un paciente de 23 años, sin antecedentes importantes, consulta por palpitaciones intensas, asociadas a dolor precordial. Se aprecia disneico, vigil, pálido con pulso de 190x', regular y presión arterial de 105/70 mmHg. Se solicita electrocardiograma, que muestra una taquicardia regular con QRS ancho. El diagnóstico más probable es:

- a) Fibrilación auricular
- b) Fibrilación ventricular
- c) Taquicardia paroxística supraventricular
- d) Taquicardia ventricular
- e) Flutter auricular

4) ¿Qué paciente NO tiene indicación de anticoagulación a permanencia?

- a) Paciente de 87 años con recambio de la válvula mitral, con prótesis biológica
- b) Paciente de 70 años con cardiopatía coronaria, hipertensión arterial y fibrilación auricular crónica, en tratamiento con digoxina y atenolol
- c) Paciente de 65 años con fibrilación auricular crónica, que sufrió un infarto de arteria cerebral media izquierda hace 1 mes
- d) Paciente de 75 años, con estenosis mitral y fibrilación auricular
- e) Paciente de 60 años, diabético e hipertenso, con fibrilación auricular crónica, manejada con amiodarona, que ha logrado mantenerlo en ritmo sinusal

5) Un paciente de 36 años consulta por un cuadro de 2 meses de evolución de astenia. Al examen físico se aprecia edema de extremidades inferiores, hepatomegalia y se observa un pulso venoso con colapso "y" prominente. ¿Qué examen está mejor indicado para evaluar a este paciente?

- a) Electrocardiograma
- b) Ecocardiograma
- c) Pericardiocentesis
- d) Radiografía de tórax
- e) Test de esfuerzo

6) Un lactante de 2 meses de edad ha presentado un mal incremento ponderal y varias infecciones respiratorias. Al examen físico se ausculta un soplo cardíaco mesosistólico, con desdoblamiento fijo del segundo ruido. Satura 82% con FiO₂ ambiental, aumentando hasta 96% con oxígeno al 30%. El diagnóstico más probable es:

- a) Tetralogía de Fallot
- b) Comunicación interventricular
- c) Comunicación interauricular
- d) Ductus arterioso persistente
- e) Coartación aórtica

7) Un paciente de 70 años consulta por disnea de esfuerzos y ortopnea. Al examen físico se aprecia pulso de gran amplitud y se ausculta un soplo diastólico. El diagnóstico más probable es:

- a) Miocardiopatía hipertrófica obstructiva
- b) Estenosis aórtica
- c) Insuficiencia aórtica
- d) Insuficiencia mitral
- e) Insuficiencia cardíaca por cardiopatía coronaria

8) Un paciente de 36 años ha presentado 2 síncope en relación al ejercicio y además presenta disnea de esfuerzos y ortopnea de algunas semanas de evolución. Al examen cardíaco se ausculta un soplo sistólico eyectivo que aumenta con la maniobra de Valsalva y al examen pulmonar se auscultan crépitos pulmonares bibasales. El electrocardiograma muestra ondas T invertidas en las derivaciones precordiales. El diagnóstico más probable es:

- a) Insuficiencia mitral
- b) Miocardiopatía hipertrófica
- c) Miocardiopatía dilatada
- d) Estenosis aórtica
- e) Insuficiencia aórtica

9) Un paciente de 67 años, con antecedente de una estenosis mitral, ingresa al servicio de urgencia comprometido de consciencia, hipotenso, taicárdico y febril. Al examen físico está pálido y sudoroso, con FC: 120x', PA: 60/40 mmHg, t°: 40,2°C. Se ausculta un soplo cardíaco intenso y se observan petequias en las extremidades inferiores. El monitoreo electrocardiográfico muestra una taquicardia sinusal. Se instalan vías venosas periféricas y se monitoriza invasivamente con un catéter de Swan-Ganz, obteniéndose los siguientes resultados: PVC: 15 mmHg, PAP: 45/22 mmHg, PCP: 22mmHg. La medida MENOS adecuada para el manejo de este paciente es:

- a) Administrar suero fisiológico endovenoso
- b) Iniciar dobutamina por bomba de infusión continua
- c) Solicitar ecocardiograma
- d) Solicitar hemocultivos
- e) Administrar oxígeno

10) Un paciente de 66 años, diabético e hipertenso, presenta en algunas ocasiones dolor precordial opresivo, que aparece al caminar 1 cuadra y que cede luego de algunos minutos de reposo. El electrocardiograma es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar ejercicios y mejorar el control de sus factores de riesgo cardiovascular
- b) Indicar nitroglicerina sublingual S.O.S
- c) Solicitar test de esfuerzo
- d) Indicar anticoagulación a permanencia
- e) Solicitar ecocardiograma

11) Un paciente de 65 años de edad, con antecedente de hipertensión arterial consulta por dolor torácico intenso de inicio súbito. Al examen físico destaca PA: 180/110 mmHg y la auscultación cardíaca demuestra un soplo diastólico. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar coronariografía de urgencia
- b) Iniciar anticoagulación con heparina
- c) Solicitar ecocardiograma transtorácico
- d) Solicitar angioTAC de tórax de urgencia
- e) Administrar captopril oral

12) Un paciente con antecedente de claudicación intermitente, consulta porque el dolor se ha hecho de reposo en la última semana. Al examen físico se aprecia pierna con llene capilar presente y con marcada disminución del pulso pedio. La conducta inicial más adecuada es:

- a) Anticoagular con heparina y solicitar angiografía de EEII
- b) Indicar reposo absoluto con la extremidad colgando de la cama
- c) Solicitar pletismografía de volumen (PVR)
- d) Solicitar eco-doppler de extremidades inferiores
- e) Indicar aspirina, estatinas y ejercicios

13) Un paciente de 65 años consulta por dolor de la extremidad inferior izquierda de algunas horas de evolución. Al examen físico se aprecia edema blando de dicha extremidad, asociado a dolor a la palpación de las masas musculares, sin otras alteraciones. Los pulsos pedios y poplíteos son normales. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar AINES y controlar en 48 horas
- b) Solicitar electrocardiograma
- c) Solicitar ecodoppler de extremidades inferiores
- d) Solicitar angiografía de extremidades inferiores
- e) Solicitar pletismografía de volumen de extremidades inferiores (PVR)

14) ¿Qué examen es más adecuado para determinar el pronóstico de una insuficiencia cardíaca secundaria a una cardiopatía hipertensiva?

- a) Holter de presión arterial
- b) Electrocardiograma
- c) Coronariografía
- d) Test de esfuerzo
- e) Ecocardiograma

15) ¿Cuál de las siguientes asociaciones es INCORRECTA?

- a) Insuficiencia mitral – Disminución de la intensidad del primer ruido cardíaco
- b) Fibrilación auricular – Onda “a” gigante
- c) Disfunción sistólica – tercer ruido (R3)
- d) Insuficiencia tricuspídea – Onda “v” gigante en el pulso venoso
- e) Hipertensión pulmonar – Aumento de intensidad del segundo ruido cardíaco

16) Un paciente de 76 años, hipertenso, en tratamiento con atenolol e hidroclorotiazida, presenta varios síncope en la última media hora, evolucionando luego con compromiso de conciencia. Al examen físico destaca está pálido, frío, sudoroso, con FC: 30 lpm, y PA: 70/30 mmHg. A la auscultación cardíaca se constata R1 de intensidad variable. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar adrenalina endovenosa
- b) Instalar marcapasos externo transitorio
- c) Administrar sulfato de magnesio endovenoso
- d) Realizar cardioversión eléctrica
- e) Administrar amiodarona endovenosa

17) Un paciente de 64 años, portador de una insuficiencia cardíaca congestiva, secundaria a una cardiopatía hipertensiva, en tratamiento con dosis altas de enalapril, carvedilol y furosemida, presenta varias lipotimias en el mes. Fuera de eso, refiere estar en buen control de su patología, con escasos síntomas y buena tolerancia a la actividad física. El examen físico y el estudio inicial descartan patologías agudas, constatándose FC: 65x', PA: 100/60 mmHg y examen cardiopulmonar normal. ¿Qué conducta es más adecuada para el manejo de este paciente?

- a) Reemplazar el enalapril por losartán
- b) Disminuir la dosis de furosemida
- c) Reemplazar el carvedilol por propanolol
- d) Iniciar espirolactona
- e) Suspender el carvedilol

18) ¿Cuál es la conducta más adecuada ante un paciente diagnosticado de infarto de ventrículo derecho?

- a) Iniciar morfina, oxígeno, aspirina y nitroglicerina y realizar coronariografía
- b) Iniciar morfina, oxígeno, aspirina, nitroglicerina y furosemida
- c) Administrar suero fisiológico, oxígeno y aspirina y realizar coronariografía
- d) Administrar suero fisiológico, oxígeno, furosemida y nitroglicerina y realizar coronariografía
- e) Administrar oxígeno, aspirina, furosemida y realizar trombolisis endovenosa

19) La causa más frecuente de hipertensión arterial secundaria es:

- a) Renovascular
- b) Nefropatías médicas
- c) Hiperaldosteronismo primario
- d) Feocromocitoma
- e) Farmacológica

20) Un hombre de 20 años, con antecedente de una válvula aórtica bicúspide, con estenosis leve debe realizarse un procedimiento dental invasivo. ¿Qué medida está indicada previa al procedimiento como profilaxis para endocarditis infecciosa?

- a) Administrar ciprofloxacino + clindamicina oral
- b) Administrar cloxacilina oral
- c) Administrar ceftriaxona endovenosa
- d) Administrar gentamicina + cloxacilina + ampicilina endovenosa
- e) Administrar amoxicilina oral

Prueba 11

1) Un paciente de 69 años presenta una cardiopatía coronaria, en tratamiento con aspirina, furosemida, y enalapril, manteniéndose en capacidad funcional III, presentando disnea de pequeños esfuerzos. ¿Qué tratamiento adicional sería más importante para éste paciente?

- a) Amiodarona
- b) Anticoagulación con cumarínicos
- c) Carvedilol
- d) Losartán
- e) Digoxina

2) Un paciente de 70 años, hipertenso y diabético, en tratamiento con dieta, consulta por dolor precordial opresivo, de intensidad 8/10, de 1 hora de evolución, irradiado al cuello y a ambos brazos. Al examen físico está sudoroso, presenta FC; 96x', PA: 150/90 mmHg, ritmo cardíaco regular en 3 tonos, sin soplos, con presencia de un R4 y examen pulmonar normal. Se solicita un electrocardiograma y una radiografía de tórax, resultando ambos normales. La conducta más adecuada es:

- a) Hospitalizar, administrar aspirina y nitroglicerina oral, oxígeno y solicitar electrocardiogramas y troponinas plasmáticas seriadas
- b) Enviar a domicilio con AINEs y solicitar test de esfuerzo
- c) Enviar a domicilio con iECAs y ácido acetilsalicílico y solicitar ecocardiografía
- d) Iniciar anticoagulación con heparina, controlando con TTPA seriados
- e) Solicitar angioTAC de tórax de urgencia

3) Un paciente de 60 años, con antecedente de un infarto hace 3 años, bien tolerado, consulta por disnea y palpitaciones de instalación bruscas. Al examen físico presenta FC: 180 x', con PA: 90/60 mmHg, El monitor electrocardiográfico muestra complejos QRS de 0,20 segundos. El diagnóstico más probable es:

- a) Fibrilación auricular
- b) Taquicardia paroxística ventricular
- c) Infarto agudo al miocardio
- d) Taquicardia ventricular
- e) Flutter auricular con aberrancia

4) Un paciente de 40 años consulta por disnea de esfuerzos progresiva, que inició hace 4 meses y que actualmente es de pequeños esfuerzos. Además refiere ortopnea de 2 almohadas. Al examen físico se aprecia desplazamiento del choque de la punta, edema de extremidades inferiores, un soplo holosistólico. El electrocardiograma muestra signos de hipertrofia ventricular izquierda. El diagnóstico más probable es:

- a) Estenosis mitral
- b) Insuficiencia aórtica
- c) Miocardiopatía hipertrófica
- d) Pericarditis constrictiva
- e) Miocardiopatía dilatada

5) Identifique la asociación CORRECTA entre la cardiopatía congénita y su presentación clínica:

- a) Ductus arterioso persistente – soplo sistólico eyectivo, con desdoblamiento fijo del segundo ruido
- b) Comunicación interventricular – soplo sistólico con cianosis persistente
- c) Comunicación interauricular – soplo diastólico que aumenta con la inspiración
- d) Tetralogía de Fallot – cianosis persistente asociado a soplo sistólico
- e) Trasposición de grandes vasos – Infecciones respiratoria a repetición e insuficiencia cardíaca progresiva durante el primer mes de vida

6) Un paciente diabético, de 58 años, en tratamiento con metformina, presenta varias tomas de presión arterial cercanas a 146/94 mmHg. Se indica dieta hiposódica y ejercicios aeróbicos, controlándose en 3 meses, constatándose presiones arteriales cercanas a 140/90 mmHg. La conducta más adecuada es:

- a) Insistir en una mejor adherencia a la dieta y ejercicios y controlar en un mes
- b) Iniciar un diurético tiazídico
- c) Iniciar un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina

- d) Iniciar un bloqueador del calcio
- e) Iniciar un betabloqueante

7) Un paciente de 56 años presenta dolor torácico muy intenso, de inicio súbito, transfixiante, irradiado al dorso. Al examen físico se constata ausencia del pulso radial izquierdo, sin otras alteraciones. El electrocardiograma resulta normal. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar AINEs y enviar a domicilio
- b) Administrar oxígeno, nitroglicerina, morfina y aspirina y solicitar enzimas cardíacas
- c) Solicitar angioTAC de tórax de urgencia
- d) Solicitar ecocardiografía transtorácica
- e) Solicitar radiografía de tórax AP y lateral

8) Un paciente de 68 años, hipertenso, consulta por dolor de la extremidad inferior izquierda, que inició hace 4 horas. Al examen físico se observa aumento de volumen y edema blando de la pierna izquierda, asociada a dolor con la palpación de las masas musculares. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar anticoagulación con heparina y solicitar angiografía de la extremidad inferior izquierda
- b) Solicitar ecografía doppler de la extremidad inferior izquierda
- c) Solicitar pletismografía de volumen de las extremidades inferiores
- d) Indicar un programa de ejercicios de marcha e iniciar aspirina y una estatina
- e) Solicitar dímero D plasmático

9) Una paciente de 70 años, diabética e hipertenso, es diagnosticada de una fibrilación auricular crónica, con frecuencias cardíacas cercanas a 120 x'. ¿Qué tratamiento es más adecuado para el manejo de esta paciente?

- a) Propanolol + acenocumarol
- b) Losartán + amiodarona
- c) Amiodarona + aspirina
- d) Aspirina + digoxina
- e) Acenocumarol + verapamilo

10) La causa más frecuente de insuficiencia cardíaca en Chile es:

- a) Hipertensiva
- b) Coronaria
- c) Valvulopatías
- d) Miocardiopatías
- e) Idiopática

11) Un paciente de 68 años, cursando una neumonía severa, presenta pérdida de consciencia. Al examen físico se constata ausencia de respiración y de pulso. Se inicia masaje cardíaco y ventilación con ambú y se instala monitor electrocardiográfico, que demuestra asistolia. Se reevalúa a los 2 minutos, persistiendo sin cambios. La conducta más adecuada es:

- a) Proseguir con el masaje cardíaco y las ventilaciones con ambú, sin medidas adicionales
- b) Realizar intubación orotraqueal y mantener el masaje y las ventilaciones
- c) Realizar desfibrilación eléctrica y mantener el masaje y las ventilaciones
- d) Administrar adrenalina endovenosa y proseguir con el masaje y las ventilaciones
- e) Suspender las maniobras de resucitación

12) Un hombre de 68 años presenta pérdida súbita de conciencia recuperándose completamente luego de 2 minutos. Al examen físico se constata FC: 48x', irregular, con PA. 100/66 mmHg, sin otras alteraciones. El diagnóstico más probable es:

- a) Síncope vasovagal
- b) Tromboembolismo pulmonar
- c) Hipotensión ortostática
- d) Síncope cardiogénico
- e) Taponamiento cardíaco

13) Un paciente asintomático, se realiza un electrocardiograma, que muestra FC: 90x' y complejos QRS anchos, con presencia de una onda S profunda en V1 y V2 y con onda R alta en V5 y V6. El diagnóstico más probable es:

- a) Bloqueo completo de rama derecha
- b) Bloqueo aurículo-ventricular completo
- c) Bloqueo completo de rama izquierda

- d) Taquicardia paroxística ventricular con aberrancia
- e) Taquicardia ventricular

14) Un paciente de 28 años consulta por dolor torácico con tope inspiratorio, que inició hace 6 horas, que disminuye al inclinarse hacia adelante y apoyar las rodillas contra el pecho. El examen físico es normal. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Costocondritis
- b) Derrame pericárdico
- c) Disección aórtica
- d) Pericarditis aguda
- e) Tromboembolismo pulmonar

15) Un paciente cursando un infarto agudo al miocardio de pared anteroseptal, tratado con trombolisis endovenosa, presenta marcada disnea al segundo día, que inicia súbitamente. Al examen físico destaca un soplo holosistólico que antes no tenía. La conducta diagnóstica más adecuada es:

- a) Solicitar un nuevo electrocardiograma
- b) Solicitar un ecocardiograma
- c) Solicitar un angio-TAC de tórax
- d) Solicitar una cintigrafía con talio
- e) Solicitar una coronariografía

16) Un paciente de 85 años presenta síncope en relación al ejercicio, asociados a angina de pecho, ortopnea y disnea paroxística nocturna. Al examen físico se ausculta un soplo eyectivo y se palpa el pulso de baja amplitud. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Cardiopatía coronaria
- b) Esteosis aórtica
- c) Insuficiencia aórtica
- d) Enfermedad del nodo sinusal
- e) Miocardiopatía hipertrófica obstructiva

17) Un paciente cursando con una endocarditis aguda grave por Staphylococcus aureus, en tratamiento con cloxacilina + gentamicina endovenosa, presenta marcada hipotensión. Se monitoriza con catéter de Swan Ganz, que muestra PVC: 20 mmHg, PCP: 24 mmHg, PA: 70/38 mmHg. El diagnóstico más probable es:

- a) Shock cardiogénico
- b) Shock hipovolémico
- c) Shock séptico
- d) Shock anafiláctico
- e) Shock neurogénico

18) Un paciente presenta un aneurisma aórtico abdominal de 3,5 cm de diámetro, en tratamiento con aspirina. Se solicita un perfil lipídico, que muestra triglicéridos: 540 mg/dl, colesterol LDL: 130 mg/dl, colesterol HDL: 30 mg/dl. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar dieta baja en grasas saturadas y controlar en 3 meses
- b) Iniciar dieta baja en azúcares refinados y controlar en 3 meses
- c) Iniciar una estatina y dieta baja en grasas saturadas
- d) Iniciar un fibrato y dieta baja en azúcares refinados
- e) Iniciar dieta baja en grasas saturadas y glúcidos refinados, más una asociación entre un fibrato y una estatina

19) ¿Cuál de las siguientes es una indicación de cirugía en una endocarditis bacteriana?

- a) Endocarditis por estafilococo áureo
- b) Absceso perivalvular
- c) Presencia de vegetaciones valvulares
- d) Antecedente de estenosis mitral
- e) Asociación a catéter intravascular

20) Un paciente de 26 años recibe una puñalada en el pecho, evolucionando con compromiso de conciencia. Al examen está hipotenso, con las yugulares ingurgitadas y ruidos cardíacos apagados, sin alteraciones en el examen pulmonar. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar pericardiocentesis de urgencia
- b) Realizar punción del segundo espacio intercostal

- c) Solicitar un angioTAC de urgencia
d) Realizar toracotomía de urgencia
e) Solicitar radiografía de tórax de urgencia

CARDIOLOGÍA RESPUESTAS

Prueba 1	17 E	12 B	8 C	7 E	7 C
1 A	18 A	13 D	9 C	8 A	8 B
2 C	19 C	14 E	10 C	9 B	9 A
3 C	20 B	15 B	11 C	10 A	10 C
4 D		16 D	12 D	11 A	11 D
5 C	Prueba 3	17 E	13 B	12 B	12 C
6 C	1 B	18 E	14 A	13 E	13 C
7 A	2 D	19 E	15 D	14 D	14 E
8 D	3 C	20 E	16 E	15 D	15 B
9 B	4 C		17 C	16 A	16 B
10 B	5 D	Prueba 5	18 B	17 B	17 B
11 D	6 B	1 D	19 C	18 B	18 C
12 B	7 B	2 D	20 D	19 C	19 A
13 C	8 A	3 C		20 C	20 E
14 C	9 C	4 C	Prueba 7	Prueba 9	Prueba 11
15 C	10 C	5 C	1 D	1 C	1 C
16 B	11 C	6 C	2 C	2 E	2 A
17 C	12 B	7 C	3 E	3 A	3 D
18 E	13 C	8 D	4 D	4 A	4 E
19 E	14 A	9 A	5 B	5 D	5 D
20 B	15 A	10 B	6 D	6 E	6 C
	16 E	11 D	7 B	7 E	7 C
Prueba 2	17 C	12 A	8 C	8 A	8 B
1 D	18 D	13 E	9 A	9 D	9 A
2 D	19 E	14 D	10 A	10 C	10 B
3 E	20 C	15 C	11 D	11 D	11 D
4 A		16 C	12 A	12 B	12 D
5 B	Prueba 4	17 C	13 C	13 D	13 C
6 C	1 A	18 A	14 E	14 E	14 D
7 D	2 C	19 D	15 E	15 B	15 B
8 C	3 C	20 C	16 A	16 D	16 B
9 D	4 B		17 C	17 A	17 A
10 B	5 C	Prueba 6	18 A	18 B	18 D
11 E	6 D	1 D	19 A	19 B	19 B
12 B	7 A	2 B	20 D	20 A	20 A
13 E	8 C	3 D	Prueba 8	Prueba 10	
14 D	9 B	4 D	1 D	1 C	
15 D	10 E	5 A	2 B	2 D	
16 C	11 B	6 E	3 D	3 D	
		7 C	4 E	4 A	
			5 E	5 B	
			6 D	6 C	

II) RESPIRATORIO PRUEBAS

Prueba 1 (GASTROENTEROLOGÍA + RESPIRATORIO)

1) Un paciente de 40 años se realiza análisis de sangre, como control de su obesidad y dislipidemia, que trata con atorvastatina. Destacan GOT:135, GPT:124, Fosfatasas alcalinas, bilirrubina, GGT y protrombinemia normales. Al examen físico destaca IMC:32 y sensibilidad a la palpación del hipocondrio derecho, sin otras alteraciones. Bebe una copa de vino con el almuerzo y niega otros hábitos tóxicos. El diagnóstico más probable es:

- a) Hepatitis autoinmune
- b) Hepatitis crónica por VHB
- c) Esteatohepatitis no alcohólica
- d) Hepatitis por fármacos
- e) Síndrome de Gilbert

2) En Chile, las principales causas de daño hepático crónico son:

- a) Alcohólica y NASH
- b) Alcohólica e idiopática
- c) VHC y VHB
- d) Alcohólica y VHC
- e) Alcohólica y VHB

3) Paciente cirrótico de larga evolución que acude a Urgencias por aumento del perímetro abdominal y dolor abdominal difuso. La paracentesis diagnóstica da salida a un líquido con 600 células/mm3 con 80% de polimorfonucleares y 0,795 de proteínas/dl. ¿Cuál de estas medidas es la más adecuada en esta situación?:

- a) Solicitar evaluación por cirujano.
- b) Realizar paracentesis evacuadora, asociada a antibióticos endovenosos.
- c) Iniciar Cefotaximo, sin evacuar la ascitis
- d) Administrar lactulosa, a fin de lograr 2 a 3 deposiciones diarias
- e) Administrar cristaloides endovenosos, asociados a terlipresina

4) Niño de 5 años, que ingiere 13 gramos de paracetamol por error. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar carbón activado y monitorización cardíaca
- b) Realizar lavado gástrico y administrar bicarbonato endovenoso
- c) Realizar diálisis de urgencia
- d) Indicar N-acetilcisteína, según niveles plasmáticos de paracetamol
- e) Tranquilizar a la madre y explicarle los signos de alarma para reconsultar

5) Paciente de 29 años con datos clínicos y serológicos de hepatitis crónica, con siguientes los datos analíticos: GOT y GPT dos veces por encima del límite alto de la normalidad, bilirrubina 0,2 mg/dL; serología virus de la hepatitis B: HBsAg (-), HBsAc (+), HBcAc (+). Anticuerpos anti virus C (+); AMA (-); ANCA (-); ANA (-). ¿Cuál es, entre las siguientes, la causa más probable de la hepatitis crónica?

- a) Hepatitis B
- b) Hepatitis C
- c) Hepatitis B y C
- d) NASH
- e) Hepatitis Autoinmune

6) Un paciente cirrótico de 59 años, se realiza endoscopia digestiva alta, que revela várices esofágicas grandes, con signos rojos. No refiere hemorragias digestivas previas. La conducta más adecuada es:

- a) Ligadura de las várices
- b) Iniciar propranolol
- c) Recomendar la instalación de un TIPS
- d) Ligar las várices, asociando un betabloqueador a permanencia
- e) Indicar furosemina y espironolactona

7) Un niño de 8 años consulta por cuadro de compromiso del estado general y luego ictericia, asociada a acolia y coluria. Entre sus exámenes destaca IgM positiva anti-VHA, diagnosticándose hepatitis A. ¿Cuál de las siguientes situaciones daría un peor pronóstico?

- a) Transaminasas mayor a 1500
- b) Protrombinemia de 45%
- c) Confusión mental
- d) Aparición de ascitis clínica
- e) Positividad de anticuerpos IgG Anticore VHB

8) Mujer de 39 años, consulta por astenia y adinamia de 4 meses de evolución, al que se le ha agregado prurito en las últimas semanas. En su analítica sanguínea destaca elevación de fosfatasa alcalina por 5 veces el nivel normal y discreta elevación de la bilirrubina, con transaminasas normales. El cuadro clínico descrito y la prueba diagnóstica que debe solicitarse corresponden respectivamente a:

- a) Colangitis esclerosante primaria y anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo
- b) Colangitis esclerosante primaria y colangiografía
- c) Cáncer de páncreas y Colangiografía
- d) Colédocolitiasis y CPRE
- e) Cirrosis biliar primaria y anticuerpos antimitocondriales

9) Paciente de 18 años consulta por ictericia fluctuante, especialmente cuando duerme poco y cuando consume bebidas alcohólicas. No ha presentado acolia, coluria ni otros síntomas. El examen físico muestra escleras con tinte subictérico, sin otras alteraciones. Las pruebas hepáticas resultan normales, excepto por hipernilirrubinemia de 2,2 mg/dl, de predominio indirecto. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar ecografía hepática y biliar
- b) Solicitar hemograma, con frotis y prueba de Coombs directa
- c) Realizar control de nuevas pruebas hepáticas, luego de 1 mes sin consumo de alcohol
- d) Tranquilizar al paciente y explicarle que su condición no traerá mayores problemas
- e) Solicitar colangiografía

10) Paciente cirrótico de 48 años, bebedor excesivo activo, consulta por fiebre de hasta 37.6 °C, intenso compromiso del estado general, dolor abdominal alto, vómitos profusos, diarrea fugaz y coluria. Al examen: ictericia marcada, decaimiento, bradipsiquia, dolor en abdomen superior, hepatomegalia sensible y ascitis mínima.

Laboratorio: Bilirrubina 7 mg/dl, transaminasa pirúvica 110 U, transaminasa oxalacética 180 U, gammaglutamiltranspeptidasa 600 U y 12.000 leucocitos/mm³ en el hemograma. El diagnóstico más probable es:

- a) Trombosis de la vena porta
- b) Hepatocarcinoma con necrosis central
- c) Peritonitis bacteriana espontánea.
- d) Hepatitis viral
- e) Hepatitis alcohólica

Preguntas Enfermedades respiratorias (primera parte)

11) La primera causa de Neumonía en el recién nacido es:

- a) Neumococo
- b) Virus respiratorio sincicial
- c) Estreptococo agalactiae
- d) Bacilos gram negativos
- e) Mycoplasma pneumoniae

12) Paciente de 20 años, consulta por dolor torácico de inicio súbito, con tope inspiratorio, asociado a disnea leve. El examen físico sólo demuestra una leve asimetría en la intensidad del murmullo pulmonar entre ambos hemicampos pulmonares. El diagnóstico más probable y la conducta a seguir son respectivamente:

- a) Tromboembolismo pulmonar y solicitar angioTAC de tórax
- b) Neumonía y administrar antibióticos

- c) Neumotórax hipertensivo e instalar toracostomía
- d) Neumotórax espontáneo y solicitar radiografía de tórax
- e) Tromboembolismo pulmonar e iniciar anticoagulación

13) Una paciente de 24 años presenta desde algún tiempo diarrea con emisión de moco y sangre, y dolor abdominal, sin que existan antecedentes epidemiológicos de interés. ¿Qué diagnóstico sería, entre los siguientes, el más probable y qué exploración realizaría para confirmarlo?:

- a) Diverticulosis y TAC de abdomen y pelvis
- b) Angiodisplasia del colon y colonoscopia
- c) Enfermedad inflamatoria intestinal y colonoscopia
- d) Divertículo de Meckel y gammagrafía con ⁹⁹Tc pertechnetato
- e) Pólipo colorectal y rectoscopia

14) Ante una mujer de 60 años con antecedentes de un cuadro de malnutrición en la infancia, que presenta una diarrea crónica a lo largo de 4 años con esteatorrea, anemia ferropénica y adelgazamiento progresivo, la causa más probable de su diarrea es:

- a) Enfermedad celíaca
- b) Enfermedad de Crohn
- c) Colitis ulcerosa
- d) Cáncer de Colon
- e) Pancreatitis crónica

15) Mujer de 75 años, hipertensa, con hipercolesterolemia, que hace 2 años fue estudiada por cuadro de diarrea, con colonoscopia, que resultó normal. Acude al servicio de urgencia por cuadro de dolor abdominal de 4 horas de evolución, mayor en hemiabdomen izquierdo, asociados a sudoración y emisión de sangre franca por el ano. La exploración física destaca abdomen doloroso, con leve distensión. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Cáncer de colon
- b) Enfermedad inflamatoria intestinal
- c) Disentería por Shigella
- d) Colitis pseudomembranosa
- e) Colitis isquémica

16) Paciente de 30 años, portador de úlcera gástrica por uso de AINEs, consulta por exacerbación de sus síntomas dolorosos. Desde hace 3 horas el dolor se hace mucho más intenso, irradiándose a dorso y se asocia a hipotensión. Al examen físico destaca abdomen en tabla, muy doloroso, con Blumber (+) y abolición de los ruidos intestinales. ¿Qué examen debe solicitarse como primera aproximación diagnóstica?

- a) Ecografía abdominal
- b) TAC de abdomen y pelvis
- c) Endoscopia digestiva alta de urgencia
- d) Radiografía de abdomen de pie
- e) Colangiografía

17) Paciente de sexo femenino, de 45 años, inicia dolor en Hipocondrio derecho, muy intenso, asociado a fiebre de un día de evolución. La analítica sanguínea muestra Hcto: 42%, G. Blancos: 15.200, GOT: 55, GPT: 48, Bili: 1,7, amilasa normal. La ecografía abdominal muestra vesícula biliar distendida con paredes engrosadas, barro biliar y cálculo de 12 mm de diámetro, impactado en el bacinete. El tratamiento de elección es:

- a) Colectomía laparoscópica de urgencia
- b) Tratamiento antibiótico y colectomía en frío en 10 días
- c) Colangiografía retrógrada endoscópica y descompresión de la vía biliar
- d) Colectomía abierta a la brevedad
- e) Reposición de volumen y antibióticos y evaluación quirúrgica en 3 meses

18) La mejor conducta ante la sospecha clínica de EPOC es:

- a) Iniciar broncodilatadores, asociados a corticoides inhalatorios
- b) Iniciar terapia broncodilatadora con salbutamol e ipratropio
- c) Solicitar radiografía de tórax e iniciar tratamiento según hallazgos
- d) Solicitar espirometría
- e) Indicar oxigenoterapia domiciliaria, asociando broncodilatadores inhalatorios

19) El tratamiento de elección para la infestación intestinal por Giardia lamblia es:

- a) Albendazol
- b) Permetrina
- c) Metronidazol
- d) Ciprofloxacino
- e) Conducta expectante

20) Paciente de 21 años, previamente sano, que inicia bruscamente hace dos días un cuadro de malestar general, osteomalgias, cefalea intensa y sensación febril. Especialmente molestas son la cefalea y las mialgias de los óculomotores. Consulta hoy por persistencia de los síntomas mencionados, a los que se ha agregado ligera odinofagia y tos irritativa. Se comprueba fiebre de 39,5 y el examen segmentario sólo muestra eritema faríngeo, sin exudado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Neumonitis por Hantavirus
- b) Amigdalitis aguda estreptocócica
- c) Neumonía neumocócica
- d) Influenza
- e) Neumonía por Mycoplasma

Prueba 2

1) Un paciente de 68 años, sin antecedentes de importancia, consulta por cuadro de tos, con expectoración mucopurulenta, asociado a fiebre hasta 39°C y malestar. Al examen se aprecia en buenas condiciones generales, con FC: 90x', PA: 110/60, FR: 18 rpm, t°: 38°C, SatO2: 95% a FiO2 ambiental. La auscultación pulmonar muestra crépitos en la base derecha. Se solicita radiografía de tórax que muestra una zona de condensación en el lóbulo inferior derecho. El tratamiento de elección es:

- a) Amoxicilina
- b) Claritromicina
- c) Ceftriaxona
- d) Amoxicilina + ácido clavulánico
- e) Clindamicina

2) Un paciente de 61 años, con antecedente de EPOC, en tratamiento con corticoides y broncodilatadores inhalados presenta aumento de su disnea basal, asociado a fiebre y expectoración abundante. Al examen se aprecia orientado, taquipneico, con FR: 27x', FC: 91x', PA: 140/100 mmHg, SatO2: 80% a FiO2 ambiental. Se ausculta disminución del murmullo pulmonar, sibilancias intensas y estertores bilaterales. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar salbutamol y corticoides inhalados, oxígeno a bajas dosis e iniciar antibióticos de amplio espectro
- b) Realizar nebulización con salbutamol, administrando oxígeno a bajas dosis, sin necesidad de corticoides ni de antibióticos
- c) Administrar oxígeno en alta concentración, realizar nebulización con corticoides e iniciar antibióticos orales
- d) Administrar oxígeno al 24%, realizar nebulización con salbutamol, administrar corticoides sistémicos e iniciar antibióticos de amplio espectro endovenosos
- e) Administrar oxígeno a 2 litros por minuto, realizar nebulización con corticoides y broncodilatadores de corta acción e iniciar antibióticos endovenosos

3) Un paciente de 30 años, no fumador, con antecedente de neumonía por adenovirus, hace varios años, presenta tos diaria, con abundante expectoración, de algunos años de evolución. La expectoración es mayor en las mañanas y aumenta con el decúbito. En algunas ocasiones ha presentado hemoptisis. El examen pulmonar no aporta mayor información. ¿Qué examen es el mejor para hacer el diagnóstico?

- a) Radiografía simple de tórax
- b) TAC de tórax
- c) Fibrobroncoscopia
- d) Biopsia pulmonar
- e) Baciloscopías

4) Un paciente de 30 años presenta tos con el ejercicio y en varias ocasiones también presenta disnea, asociada a respiración sibilante. Presenta además tos nocturna frecuente y suele hacer crisis obstructivas durante las infecciones virales. En el examen físico se aprecia en buenas condiciones y destaca sólo una leve prolongación del tiempo de espiración. Se solicita una espirometría que confirma la presencia de asma bronquial. El tratamiento más adecuado para este paciente es:

- a) Salbutamol en caso de síntomas
- b) Salmeterol en caso de síntomas y corticoides inhalados según horario
- c) Salbutamol en caso de síntomas y corticoides inhalados, con salmeterol, según horario
- d) Budesonida en caso de síntomas y salbutamol según horario
- e) Salbutamol y salmeterol en caso de síntomas y corticoides orales según horario

5) Un paciente de 72 años, fumador, presenta tos con expectoración mucosa, desde hace 4 meses, asociado a disnea de esfuerzos. En su examen físico destacan uñas en vidrio de reloj. El examen cardiopulmonar es normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Derrame pleural
- b) Cáncer bronquial
- c) Bronquiectasias
- d) Tuberculosis pulmonar
- e) Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

6) Una paciente de 52 años, fumador, presenta disnea de esfuerzos progresiva, de 6 meses de evolución. Al examen físico se auscultan crépitos bilaterales. La radiografía de tórax muestra un patrón en panal de abejas en ambas bases. El diagnóstico más importante es:

- a) EPOC
- b) Fibrosis pulmonar
- c) Edema pulmonar
- d) Neumoconiosis
- e) Neumonía por mycoplasma

7) Un paciente de 20 años ingresa por una neumonía, complicada con un derrame pleural paraneumónico. Al examen físico está en buenas condiciones, eupneico, con signos vitales normales. El examen pulmonar es compatible con un derrame pleural pequeño. Se solicitan gases de sangre arterial con los siguientes valores: PaO₂: 38 mmHg, PaCO₂: 47 mmHg, HCO₃: 25 mEq/l, pH: 7,39. El diagnóstico más probable es:

- a) Insuficiencia respiratoria global severa
- b) Insuficiencia respiratoria parcial, con alcalosis respiratoria
- c) Acidosis respiratoria, con alcalosis metabólica
- d) Insuficiencia respiratoria grave, con acidosis metabólica y alcalosis respiratoria
- e) Gases venosos

8) El efecto adverso más frecuente del tratamiento antituberculoso es:

- a) Alergia
- b) Alteraciones hepáticas
- c) Anemia
- d) Daño renal
- e) Alteraciones visuales

9) Los niños con fibrosis quística suelen contraer neumonías causadas por:

- a) Mycoplasma pneumoniae
- b) Legionella pneumoniae
- c) Streptococcus pneumoniae
- d) Pseudomonas aeruginosa
- e) Streptococcus pyogenes

10) Un recién nacido de 30 semanas de edad gestacional inicia un cuadro de dificultad respiratoria grave a los pocos minutos de vida, con taquipnea marcada, y caída importante de la saturación arterial, que requiere altas concentraciones de oxígeno para alcanzar el 90%. El diagnóstico más probable es:

- a) Taquipnea transitoria
- b) Cardiopatía congénita
- c) Circulación fetal persistente
- d) Síndrome aspirativo meconial
- e) Enfermedad de membrana hialina

11) Un paciente consulta por un cuadro de tos, con expectoración, fiebre y dolor tipo puntada de costado en el hemitórax izquierdo. La radiografía de tórax demuestra un derrame pleural moderado, asociado a una zona de relleno alveolar en el lóbulo inferior izquierdo. Se realiza punción del líquido que demuestra células 740 por mm³, con 86% de polimorfonucleares, LDH: 220 UI/l, proteínas: 4,4 mg/dl, ADA: 28 UI/l, lactato: 3,3 mg/dl y pH: 7,28. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar biopsias pleurales por punción percutánea
- b) Instalar tubo pleural e iniciar antibióticos endovenosos
- c) Administrar antibióticos intrapleurales
- d) Iniciar tratamiento antituberculoso
- e) Iniciar antibióticos endovenosos y evacuar el derrame pleural por toracocentesis

12) Un paciente de 45 años sufre un accidente de tránsito, mientras conducía su vehículo, resultando con un golpe en el tórax contra el manubrio. Evoluciona con dificultad respiratoria. Al examen se aprecia taquipneico, bien perfundido, con presión arterial y frecuencia cardíaca normales. La auscultación cardíaca es normal y el examen pulmonar sólo demuestra crépitos escasos difusos. El diagnóstico más probable es:

- a) Contusión pulmonar
- b) Hemotórax
- c) Neumotórax
- d) Tórax volante
- e) Crisis de angustia

13) Son causa de distrés respiratorio todas las patologías nombradas a continuación, excepto:

- a) Sepsis severa de origen urinario
- b) Fármacos
- c) Pancreatitis aguda
- d) Infarto extenso de ventrículo izquierdo
- e) Quemaduras extensas

14) Un adolescente de 13 años presenta cuadro de tos, rinorrea, odinofagia de 12 días de evolución. En las últimas 48 horas se produce un aumento de la tos y se agregan malestar general y disnea de esfuerzos. Al examen físico destaca fiebre de 38°C y examen pulmonar con crépitos bibasales, mayores a derecha y sibilancias escasas. El resto del examen no aporta mayor información. Se solicita radiografía de tórax que confirma un patrón alveolointersticial bilateral, mayor en la base derecha. El tratamiento más adecuado es:

- a) Claritromicina
- b) Clindamicina
- c) Amoxicilina
- d) Amoxicilina + ácido clavulánico
- e) Cefalosporina de tercera generación

15) El tratamiento de elección para el absceso pulmonar es:

- a) Cirugía
- b) Amoxicilina + ácido clavulánico oral
- c) Drenaje por punción transtorácica y metronidazol oral
- d) Ceftriaxona endovenosa
- e) Clindamicina endovenosa y drenaje postural

16) ¿Cuál de los siguientes pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica tiene indicación de oxígeno domiciliario a permanencia, para aumentar la sobrevida?

- a) Paciente de 67 años, con síntomas muy marcados, con disnea al caminar 3 metros
- b) Paciente con EPOC estable que presenta gases arteriales con PaO₂: 51 mmHg y PaCO₂: 40 mmHg
- c) Paciente que continúa fumando
- d) Paciente con EPOC estable que presenta poliglobulia, PaO₂: 65 mmHg y PaCO₂: 38 mmHg
- e) Paciente con EPOC estable, con VEF1 correspondiente al 43% del valor teórico esperado

17) Un paciente de 67 años, asintomático, fumador, se realiza una radiografía de tórax, como parte de un conjunto de exámenes de chequeo, exigidos en su trabajo. Se identifica un nódulo pulmonar denso, de 3 centímetros en el lóbulo superior izquierdo, espiculado. No cuenta con radiografías previas. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar nueva radiografía de tórax en 6 meses
- b) Solicitar nueva radiografía de tórax en un mes
- c) Solicitar TAC de tórax, con cortes finos
- d) Realizar biopsia transbronquial, por fibrobroncoscopia
- e) Realizar lobectomía superior izquierda

18) El diagnóstico del síndrome bronquial obstructivo del lactante se diagnostica mediante:

- a) La clínica solamente
- b) La clínica + radiografía de tórax
- c) La clínica + espirometría
- d) La clínica + test de metacolina
- e) La clínica + test cutáneo para alérgenos respiratorios

19) Un paciente de 45 años presenta un cuadro de malestar general, rinorrea acuosa y odinofagia, de 2 días de evolución, al que se le ha agregado tos, con escasa expectoración mucosa. Presenta signos vitales normales, faringe congestiva, sin exudado y examen cardiopulmonar normal. El agente más probable es:

- a) *Mycoplasma pneumoniae*
- b) *Rhinovirus*
- c) *Virus influenza*
- d) *Streptococcus pneumoniae*
- e) *Streptococcus pyogenes*

20) ¿Cuál de las siguientes espirometrías es compatible con el diagnóstico de EPOC?

- a) Basal CVF:105%, VEF1:71%, VEF1/CVF:61%; Post-salbutamol CVF:110%, VEF1:72%, VEF1/CVF:60%
- b) Basal CVF:91%, VEF1:66%, VEF1/CVF:54%; Post-salbutamol CVF:109%, VEF1:94%, VEF1/CVF:74%
- c) Basal CVF:50%, VEF1:66%, VEF1/CVF:86%; Post-salbutamol CVF:51%, VEF1:65%, VEF1/CVF:84%
- d) Basal CVF:88%, VEF1:88%, VEF1/CVF:80%; Post-salbutamol CVF:89%, VEF1:95%, VEF1/CVF:85%
- e) Basal CVF:70%, VEF1:74%, VEF1/CVF:77%; Post-salbutamol CVF:70%, VEF1:74%, VEF1/CVF:76%

Prueba 3

1) Un paciente de 30 años, asmático, en tratamiento con salbutamol, presenta tos frecuente, especialmente en la noche y en el último mes ha presentado 2 crisis de disnea sibilante, una de las cuales requirió atención en el servicio de urgencia. El tratamiento más adecuado para este paciente es:

- a) Salbutamol inhalado y prednisona oral, ambos según horario
- b) Salmeterol inhalado según horario y salbutamol inhalado según síntomas
- c) Salbutamol inhalado según horario y fluticasona inhalada según síntomas
- d) Salmeterol inhalado según horario y fluticasona inhalada según síntomas
- e) Fluticasona inhalada según horario y salbutamol inhalado según síntomas

2) Un niño de 2 años presenta tos de inicio súbito intensa, persistiendo con tos, asociada a expectoración mucopurulenta durante los días subsiguientes. Al examen físico se auscultan estertores y sibilancias localizadas en la base derecha. El diagnóstico más probable es:

- a) Neumonía
- b) Bronconeumonía
- c) Tromboembolismo pulmonar
- d) Coqueluche
- e) Cuerpo extraño bronquial

3) Un paciente de 45 años, sin antecedentes de importancia, presenta un cuadro de tos, con expectoración mucopurulenta de 4 semanas de evolución, asociado a fiebre intermitente, baja de peso y sudoración nocturna. En sus exámenes se aprecia anemia normocítica, con elevación de la VHS y leucocitosis de 11.000 células/mm³. La radiografía de tórax muestra bandas de fibrosis y retracción, asociadas a paquipleuritis en ambos ápices pulmonares. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar espirometría basal y postbroncodilatador
- b) Solicitar fibrobroncoscopia y realizar biopsias bronquiales
- c) Solicitar TAC de tórax
- d) Solicitar baciloscopías de expectoración y cultivo para bacilo de Koch
- e) Iniciar antibióticos endovenosos de amplio espectro

4) Una paciente sufre un accidente de tránsito, evolucionando con disnea, sudoración y lipotimia. Al examen físico presenta FC: 127x', PA: 90/60, FR: 30x', se aprecia equimosis torácica y se ausculta abolición del murmullo pulmonar izquierdo, asociado a matidez del hemitórax izquierdo. El diagnóstico más probable es:

- a) Hemotórax masivo
- b) Contusión pulmonar
- c) Neumotórax a tensión
- d) Tórax volante
- e) Neumotórax abierto

5) Un paciente de 65 años, fumador de 20 cigarrillos al día, ha presentado 4 episodios de neumonía en los últimos 6 meses, que han respondido bien al tratamiento antibiótico, todos ellos localizados en el lóbulo inferior izquierdo. El examen físico no aporta mayor información. El diagnóstico más probable es:

- a) Bronquitis crónica
- b) EPOC
- c) Cáncer bronquial
- d) Bronquiectasias
- e) Fibrosis pulmonar

6) El diagnóstico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) se realiza mediante:

- a) La clínica exclusivamente
- b) La clínica más una radiografía de tórax
- c) La clínica más una espirometría
- d) La clínica más un test de provocación bronquial con metacolina
- e) La clínica más una prueba de difusión de monóxido de carbono

7) Un paciente de 65 años, fumador importante, presenta un nódulo pulmonar de 3 cms, de bordes espiculados, localizado en el lóbulo medio derecho, diagnosticado como hallazgo en una radiografía de tórax que se realizó como parte del control de rutina de su trabajo. El examen físico es normal. La conducta inicial más adecuada es:

- a) Resolver quirúrgicamente
- b) Iniciar quimioterapia y radioterapia
- c) Solicitar biopsia por broncoscopia
- d) Solicitar TAC de tórax
- e) Revisar las radiografías previas

8) Un paciente de 18 años presenta un cuadro de 3 días de evolución, de tos con expectoración mucopurulenta, asociado a fiebre hasta 39°C y calofríos solemnes. En las últimas horas se agrega disnea y marcado malestar. Al examen se aprecia orientado, disneico, con FC: 109x', PA: 120/76 mmHg, FR: 30 rpm, SatO₂: 87% a FiO₂ ambiental, que mejora a 95% con oxígeno. El antibiótico de elección es:

- a) Clindamicina
- b) Amoxicilina
- c) Amoxicilina más ácido clavulánico
- d) Ceftriaxona
- e) Ceftriaxona + claritromicina

9) El tratamiento de primera línea para la rinosinusitis bacteriana aguda es:

- a) Amoxicilina
- b) Levofloxacino
- c) Clindamicina
- d) Claritromicina
- e) Cloxacilina

10) Una paciente con historia de disnea se realiza una espirometría, con los siguientes resultados:

Basal: CFV: 44% del teórico VEF1: 48% del teórico VEF1/CVF: 81%

Postbroncodilatador: CFV: 46% del teórico VEF1: 48% del teórico VEF1/CVF: 80%

De entre los siguientes, ¿qué diagnóstico es compatible con estos resultados?

- a) EPOC
- b) Asma
- c) Bronquiectasias
- d) Fibrosis pulmonar idiopática
- e) Hipertensión pulmonar primaria

11) Un paciente consulta por un cuadro de dolor torácico, tipo puntada, con tope inspiratorio, de una semana de evolución, que se ha intensificado en el último tiempo. El examen físico es compatible con un derrame pleural derecho, que se confirma con una radiografía de tórax. Se realiza toracentesis que da salida a líquido amarillo transparente, con proteínas: 6,1 g/dl, LDH: 180 UI/l, 650 células por mm³, con 86% de mononucleares y ADA: 77 UI/l. La tinción de Gram no visualiza bacterias. El análisis sanguíneo muestra proteínas plasmáticas: 7,5 g/dl y LDH plasmática: 210 UI/l. El diagnóstico más probable es:

- a) Empiema
- b) Derrame paraneumónico simple
- c) Derrame pleural canceroso
- d) Tuberculosis pleural
- e) Insuficiencia cardíaca congestiva

12) Frente a un paciente cursando una neumonía, complicada con un empiema, se debe:

- a) Realizar toracocentesis evacuadora
- b) Instalar un tubo de toracostomía
- c) Aumentar la cobertura del tratamiento antibiótico, contra anaerobios
- d) Aumentar la duración del tratamiento antibiótico a 4 semanas
- e) Administrar antibióticos intrapleurales

13) Un paciente de 50 años, fumador de 4 cigarrillos al día, presenta disnea de esfuerzos progresiva, de dos meses de evolución, que actualmente es de pequeños esfuerzos, asociada a tos ocasional. Al examen se auscultan crépitos intensos bilaterales, especialmente en las bases, con disminución del tamaño de los campos pulmonares. Presenta además hipocratismo digital. El diagnóstico más probable es:

- a) Fibrosis pulmonar idiopática
- b) Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
- c) Bronquitis crónica
- d) Tuberculosis pulmonar
- e) Neumonía atípica

14) Un paciente de 24 años presenta disnea y dolor pleurítico de instalación brusca. Al examen se aprecia adolorido, levemente taquipneico, con FC: 87x', PA: 120/80, FR: 24x', SatO₂: 97% a FiO₂ ambiental. Se ausculta asimetría del murmullo pulmonar y ruidos cardíacos apagados. Se solicita una radiografía de tórax que demuestra un neumotórax izquierdo moderado. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar AINEs, enviar a domicilio y controlar en 24 horas con nueva radiografía
- b) Puncionar el segundo espacio intercostal en la línea media claviclar
- c) Instalar tubo pleural
- d) Solicitar TAC de tórax
- e) Realizar neumonectomía apical izquierda

15) Un paciente de 78 años, con antecedente de EPOC, en control con broncodilatadores y corticoides inhalados, con hábito tabáquico suspendido hace 10 años, inicia cuadro de disnea mayor a la habitual, asociada a un aumento en la expectoración, la que se vuelve mucopurulenta. Al examen físico se constata paciente disneico, orientado, con FC: 100x', PA: 130/70 mmHg, FR: 25x', con tiraje, t°: 38,2°C, SatO₂: 83%. Se observan signos de hiperinsuflación pulmonar y se auscultan sibilancias y estertores difusos. ¿Cuál de las siguientes medidas está MENOS indicada, para el manejo de este paciente?

- a) Administrar oxígeno en alta concentración, por mascarilla de recirculación
- b) Administrar corticoides sistémicos
- c) Realizar nebulización con salbutamol
- d) Administrar ceftriaxona endovenosa
- e) Solicitar gases arteriales

16) Un paciente presenta los siguientes gases de sangre arterial: PaO₂: 88mmHg, PaCO₂: 32 mmHg, HCO₃: 17 mEq/l pH: 7,30. Indique el estado ácido base:

- a) Acidosis metabólica pura
- b) Acidosis respiratoria pura
- c) Acidosis metabólica con alcalosis respiratoria
- d) Acidosis respiratoria con alcalosis metabólica
- e) Acidosis mixta

17) Paciente de 21 años, previamente sano, que inicia bruscamente hace dos días un cuadro de malestar general, osteomalgias, cefalea intensa y sensación febril. Especialmente molestas son la cefalea y las mialgias de los oculomotores. Consulta hoy por persistencia de los síntomas mencionados, a los que se ha agregado ligera odinofagia y tos irritativa. Se comprueba fiebre de 39,5° C y el examen segmentario sólo muestra eritema faríngeo, sin exudado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Neumonitis por Hantavirus
- b) Amigdalitis aguda estreptocócica
- c) Neumonía neumocócica
- d) Gripe
- e) Neumonía por Mycoplasma

18) Un adolescente de 13 años presenta cuadro de tos, rinorrea, odinofagia de 12 días de evolución. En las últimas 48 horas se produce un aumento de la tos y se agregan malestar general y disnea de esfuerzos. Al examen físico destaca fiebre de 38°C y examen pulmonar con crépitos bibasales, mayores a derecha y sibilancias escasas. El resto del examen no aporta mayor información. El diagnóstico más probable es:

- a) Bronquitis aguda
- b) Neumonía neumocócica
- c) Neumonía atípica
- d) Crisis asmática
- e) Tromboembolismo pulmonar

19) Un paciente tuberculoso inicia tratamiento antibiótico, controlándose con baciloscopias mensuales con los siguientes resultados: 1(+), 2(-), 3(-), 4(+), 5(+). La conducta más adecuada es:

- a) Continuar el tratamiento antituberculoso hasta completar 6 meses
- b) Solicitar cultivo de esputo para mycobacterias
- c) Solicitar nueva baciloscopia y decidir manejo según resultado

- d) Retomar el tratamiento antituberculoso de la fase mensual
- e) Derivar a especialista, por falla del tratamiento

20) Un recién nacido de 36 semanas de edad gestacional, nacido por cesárea, inicia taquipnea y aleteo nasal a los pocos minutos del nacimiento. Al examen físico sólo se aprecian algunos crépitos escasos en ambas bases pulmonares. La radiografía de tórax demuestra derrame pleural pequeño bilateral y un leve aumento de la trama intersticial de las bases pulmonares, con hilios prominentes. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad de membrana hialina
- b) Taquipnea transitoria del recién nacido
- c) Displasia broncopulmonar
- d) Síndrome de aspiración meconial
- e) Cardiopatía congénita

Prueba 4

1) Un hombre de 35 años acude a un servicio de urgencias de Alicante por disnea. En la gasometría arterial basal tiene un pH de 7.48. PaO₂ de 59 mm Hg. PaCO₂ de 26 mm Hg y HCO₃ de 26 mEq/l. Tras administrarle oxígeno al 31% la PaO₂ asciende a 75 mmHg. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable?:

- a) Intoxicación por monóxido de carbono.
- b) Enfermedad neuromuscular.
- c) Crisis asmática.
- d) Atelectasia del lóbulo inferior derecho por cuerpo extraño intrabronquial.
- e) Síndrome de distress respiratorio del adulto.

2) Paciente diagnosticado de esclerosis lateral amiotrófica que tiene afectado el diafragma, presentando crónicamente un cuadro de insuficiencia respiratoria. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es correcta?:

- a) La diferencia alveoloarterial de O₂ (PAO₂-PaO₂) suele ser normal.
- b) La pO₂ puede estar en los límites de la normalidad.
- c) La pCO₂ suele ser normal.
- d) El tratamiento de elección es la administración de oxígeno por máscara tipo Venturi.
- e) Lo primero es actuar farmacológicamente por vía endovenosa.

3) Hombre de 70 años con antecedentes de EPOC grave y cor pulmonale crónico que presenta una gasometría arterial con pH 7,45, pO₂ 57 mm de Hg, pCO₂ 35 mm de Hg, HCO₃ 25 mEq/l. ¿Cree que estaría indicado iniciar oxigenoterapia domiciliaria?:

- a) No, porque todavía la pO₂ se mantiene por encima de 55 mmHg.
- b) No, porque empeoraría la insuficiencia respiratoria hipercápnica que presenta.
- c) No, porque empeoraría la insuficiencia cardíaca que probablemente presenta.
- d) Sí, pero únicamente en las exacerbaciones.
- e) Sí, porque aumentaría su esperanza de vida.

4) Mujer de 21 años de edad, que ha comenzado hace tres meses con "pitos" en el pecho y tos especialmente a la noche. Se ha hecho más frecuente y los últimos días no le deja descansar. La exploración muestra una discreta disminución del murmullo vesicular y algunos sibilantes, de forma poco intensa en ambos hemitórax, frecuencia cardíaca 86 pulsaciones por minuto. ¿Cuál será la primera decisión terapéutica?:

- a) Prescribir broncodilatadores B2 estimulantes de corta acción cada cuatro horas.
- b) Prescribir broncodilatadores de larga acción como formoterol asociado a corticoides inhalados.
- c) Indicar antibióticos asociados a broncodilatadores anticolinérgicos.
- d) Prescribir N-acetilcisteína, cada 6 horas asociado a amoxicilina.
- e) Prescribir prednisona por vía oral.

5) Mujer de 35 años en tratamiento con anticonceptivos orales que acude a Urgencias por disnea. A la exploración se detecta disminución del murmullo vesicular en base de hemitórax derecho y T de 37,8° C. El ECG revela taquicardia sinusal y en la Rx de tórax se observa derrame pleural derecho sin condensaciones parenquimatosas. La toracocentesis demuestra líquido serohemorrágico con pH 7,33, proteínas 3,6 g/dl, glucosa 78 mg/dl, LDH 320 U/l, Gram y Ziehl negativos, ANAs negativos y ADA de 7 U/l. ¿Qué tratamiento es más oportuno en este contexto?:

- a) Macrólidos.
- b) Inserción de tubo de tórax.
- c) Dicumarínicos.
- d) Heparina sódica.
- e) Corticoterapia.

6) ¿Cuál, entre las siguientes, es la causa más frecuente de síndrome de la vena cava superior?:

- a) Bocio retroesternal.
- b) Carcinoma papilar de tiroides.
- c) Carcinoma broncogénico.
- d) Teratoma mediastínico.
- e) Timoma maligno.

7) Un paciente de 46 años es diagnosticado de derrame pleural bilateral. En el análisis del líquido extraído mediante punción torácica se aprecia: concentración normal de glucosa, escasos leucocitos, concentración de LDH normal y bajo contenido en proteínas. Señale, considerando estos datos, cuál de los propuestos será el diagnóstico más probable:

- a) Empiema pleural bilateral.
- b) Derrames pleurales asociados a artritis reumatoide.
- c) Derrames pleurales asociados a lupus eritematoso.
- d) Tuberculosis pleuropulmonar bilateral.
- e) Síndrome nefrótico.

8) El tratamiento más eficaz, entre los siguientes, del síndrome de apnea del sueño es, en el momento actual:

- a) Tratamiento conservador con pérdida de peso y uso de analépticos respiratorios.
- b) Oxigenoterapia durante más de 15 horas al día.
- c) Uvulopalatofaringoplastia.
- d) Uso de presión positiva continua en la vía aérea.
- e) Uso de presión negativa continua en la vía aérea.

9) Con propósitos clínicos, la hipoventilación alveolar se identifica en la gasometría arterial por uno de los siguientes trastornos:

- a) Aumento de la PO₂ venosa.
- b) Disminución de la PO₂ arterial.
- c) Aumento de la PCO₂ arterial.
- d) Disminución de la PCO₂ arterial.
- e) Disminución de la PCO₂ venosa y la PCO₂ arterial.

10) ¿Cuál de los siguientes datos NO aparece en el síndrome de insuficiencia (distress) respiratoria aguda del adulto, plenamente establecido e inducido por politraumatismo?:

- a) Presión capilar pulmonar (PCP) de enclavamiento superior a 20 mm Hg.
- b) Infiltrados alveolares difusos en la radiología torácica.
- c) Hipoxemia por aumento del shunt intrapulmonar.
- d) Hipertensión pulmonar.
- e) Disminución de la distensibilidad ("compliance") pulmonar.

11) Una paciente de 47 años, con antecedente de fibrosis pulmonar secundaria al uso de nitrofurantoína, presenta cuadro de fiebre, tos y expectoración mucosa, asociada a disnea y luego desorientación. Al examen físico está disneica, taquicárdica, con extremidades pálidas y frías, su presión arterial es 90/60 mmHg y satura 72% a FiO2 ambiental, aumentando a 88% con oxígeno al 100%. Se solicita radiografía de tórax que demuestra infiltrado intersticial bilateral, mayor en las bases, con imágenes de relleno alveolar en el lóbulo inferior izquierdo y en todo el pulmón derecho. ¿Qué tratamiento antibiótico es el más adecuado para esta paciente?

- a) Levofloxacino
- b) Amoxicilina más ácido clavulánico
- c) Ceftriaxona
- d) Ceftriaxona más vancomicina
- e) Ceftriaxona más claritromicina

12) Un paciente de 30 años, obeso, y fumador, con antecedente de rinitis alérgica en tratamiento con ceterizina, consulta por cuadro de tos seca que aparece después del ejercicio y al estar expuesto al frío. El diagnóstico más probable es:

- a) Bronquitis crónica
- b) Asma
- c) EPOC
- d) Fibrosis pulmonar
- e) Hipertensión pulmonar

13) Un paciente de 70 años diagnosticado de EPOC tabáquico, en tratamiento con salbutamol, refiere que en los últimos meses su disnea basal ha aumentado, por lo que no puede caminar más de 2 cuadras, sin tener que descansar, a pesar de inhalarse cada 4 horas. Actualmente ya no fuma y el examen físico sólo demuestra murmullo pulmonar disminuido, espiración prolongada y aumento del diámetro torácico. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar antibióticos y corticoides orales
- b) Agregar corticoides inhalados
- c) Iniciar corticoides orales
- d) Agregar broncodilatadores de acción larga
- e) Indicar oxigenoterapia domiciliaria

14) Un paciente de 60 años, alcoholico y fumador consulta por un cuadro de baja de peso, fiebre y tos con expectoración purulenta y en ocasiones hemoptoica. Al examen físico presenta murmullo pulmonar simétrico, con abundantes crépitos y estertores bilaterales. El diagnóstico más probable es:

- a) Bronquiectasias
- b) Tuberculosis
- c) Tromboembolismo pulmonar
- d) Neumoconiosis
- e) Cáncer pulmonar

15) ¿Cuál de las siguientes asociaciones, entre el hallazgo en el examen físico y la patología, es INCORRECTA?

- a) Matidez – Neumonía
- b) Respiración soplate – Neumotórax
- c) Egofonía – Derrame pleural
- d) Acropaquias – Cáncer
- e) Crepitaciones – Fibrosis pulmonar

16) Un paciente de 65 años, fumador importante presenta un nódulo pulmonar parahiliar derecho en una radiografía, que no se visualizaba en las radiografías previas. El TAC demuestra la presencia de un nódulo único, de 2 cm de diámetro en el bronquio lobar medio, sin calcificaciones y con bordes irregulares. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar biopsia por punción
- b) Solicitar biopsia por broncoscopía
- c) Realizar tumorectomía
- d) Realizar lobectomía media
- e) Realizar neumonectomía derecha

17) Un paciente cursando una neumonía adquirida en la comunidad inicia tratamiento con amoxicilina, sin embargo persiste febril, luego de 72 horas de tratamiento antibiótico, por lo que se decide solicitar una nueva radiografía que demuestra un derrame pleural derecho, el cual se punciona, dando salida a un líquido compatible con un exudado de predominio polimorfonuclear, con lactato: 8 mMol/dl, pH: 7,1, sin visualización de bacterias a la tinción de Gram. La conducta más adecuada es:

- a) Cambiar el tratamiento antibiótico a amoxicilina más ácido clavulánico
- b) Hospitalizar e iniciar ceftriaxona
- c) Hospitalizar, drenar el líquido mediante toracocentesis y cambiar el tratamiento antibiótico a ceftriaxona endovenosa
- d) Hospitalizar, instalar una toracostomía con trampa de agua y cambiar el tratamiento antibiótico a ceftriaxona endovenosa
- e) Hospitalizar, drenar el líquido mediante toracocentesis y cambiar el tratamiento a ceftriaxona más clindamicina endovenosas

18) Un paciente de 66 años, presenta una fractura de cadera, la que es operada. Al 4° día presenta disnea de instalación súbita y dolor en puntada de costado. El examen físico es inespecífico. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar ecografía Doppler de extremidades inferiores
- b) Solicitar ecocardiograma transesofágico
- c) Solicitar dímero D
- d) Solicitar angio-TAC de tórax
- e) Solicitar radiografía de tórax

19) Respecto a las bronquiectasias es falso que:

- a) Su síntoma más frecuente es la broncorrea
- b) Son una causa muy importante de hemoptisis
- c) Su diagnóstico se realiza preferentemente con una broncoscopia
- d) Cuando están localizadas y son sintomáticas, está indicado el tratamiento quirúrgico
- e) La fibrosis quística y el síndrome del cilio inmóvil son causas de bronquiectasias difusas

20) La fibrosis pulmonar idiopática se presenta espirométricamente como:

- a) Un patrón obstructivo que mejora con broncodilatador
- b) Un patrón obstructivo que no mejora con broncodilatador
- c) Un patrón restrictivo que no mejora con broncodilatador
- d) Un patrón mixto que mejora con broncodilatador
- e) Una espirometría normal

Prueba 5 (RESPIRATORIO EN PEDIATRÍA)

1) Una niña de 4 años de edad presenta cuadro de tos irritativa y fiebre hasta 38,1° de 24 horas de evolución. En las últimas horas la tos se hace más intensas, agregándose disfonía, estridor inspiratorio y finalmente disnea. Al examen físico se observa taquipneica, con retracción intercostal, sin cianosis. La auscultación pulmonar no aporta mayor información. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar oxígeno, nebulizar con adrenalina racémica, administrar corticoides inhalados e iniciar antibióticos
- b) Administrar oxígeno, nebulizar con salbutamol y administrar corticoides inhalados
- c) Administrar oxígeno, nebulizar con adrenalina racémica e iniciar antibióticos orales
- d) Administrar oxígeno, nebulizar con adrenalina racémica e iniciar corticoides orales
- e) Administrar oxígeno, nebulizar con salbutamol e iniciar corticoides endovenosos

2) Un lactante de 4 meses, sin antecedentes de importancia, ni cuadros respiratorios previos, inicia cuadro de tos y dificultad respiratoria. Al examen se observa con cianosis perioral, uso de musculatura accesoria y el examen pulmonar demuestra sibilancias difusas bilaterales. El diagnóstico más probable es:

- a) Bronquiolitis aguda
- b) Bronquitis aguda
- c) Neumonía bacteriana
- d) Displasia broncopulmonar

e) Crisis asmática

3) Un recién nacido de 2 días de vida, es diagnosticado de neumonía. La terapia antibiótica empírica más adecuada es:

- a) Ampicilina sola
- b) Cefotaximo + vancomicina
- c) Ceftriaxona + claritromicina
- d) Gentamicina + clindamicina
- e) Cefotaximo + ampicilina

4) Un recién nacido de término, nacido por cesárea, inicia dificultad respiratoria a los pocos minutos de nacer. Al examen se observa taquipneico, con aleteo nasal, sin cianosis. Logra saturación normal con oxígeno al 24%. La radiografía de tórax muestra hilios prominentes y líquido en las cisuras. El diagnóstico más probable es:

- a) Neumonía neonatal
- b) Cardiopatía congénita, con shunt de izquierda a derecha
- c) Cardiopatía congénita, con shunt de derecha a izquierda
- d) Taquipnea transitoria
- e) Síndrome de aspiración meconial

5) Un niño de 6 años consulta por un cuadro de 7 días de evolución de decaimiento, rinorrea y tos seca, la que luego se hace productiva. En las últimas 48 horas se agrega fiebre hasta 38,5°C, asociada mayor compromiso del estado general y finalmente disnea leve. Al examen físico se observa niño en buenas condiciones generales, eupneico, febril hasta 38°, normotenso, bien perfundido, con frecuencia respiratoria de 20 rpm y saturación de O₂ de 97%. El examen pulmonar presenta murmullo pulmonar presente, con escasos crépitos bibasales, mayores a izquierda. La radiografía de tórax muestra un infiltrado intersticial bilateral, mayor en la base izquierda. El tratamiento antibiótico de elección es:

- a) Penicilina benzatina intramuscular
- b) Amoxicilina oral
- c) Claritromicina oral
- d) Ceftriaxona endovenosa
- e) Clindamicina endovenosa

6) ¿Cuál de las siguientes situaciones puede cursar con mayor probabilidad con una insuficiencia respiratoria global?

- a) Crisis asmática
- b) Neumonía neumocócica
- c) Intoxicación con jarabe para la tos
- d) Cardiopatía congénita cianótica
- e) Displasia bronquiopulmonar

7) La etiología más frecuente del síndrome bronquial obstructivo recurrente del lactante es:

- a) Hiperreactividad bronquial secundaria a infección por virus respiratorio sincicial, exacerbada por nuevas infecciones virales
- b) Hiperreactividad bronquial secundaria a exposición a alérgenos respiratorios, exacerbada por infecciones virales
- c) Alteraciones anatómicas de las vías respiratorias pequeñas, asociadas a disminución de la producción de surfactante
- d) Alteraciones en el clearance de secreciones respiratorias, por parte del epitelio ciliado
- e) Infecciones reiteradas por virus respiratorio sincicial

8) Un paciente de 6 años, consulta por cuadro de 3 días de evolución de odinofagia leve y tos irritativa, la que luego se hace productiva, con expectoración mucosa abundante. AL examen físico se observa paciente en buenas condiciones generales, sin dificultad respiratoria. La auscultación pulmonar demuestra esterores bilaterales difusos, que se movilizan con la tos. Se solicita radiografía de tórax, la que resulta normal. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar tratamiento sintomático, sin necesidad de antibióticos ni corticoides
- b) Iniciar antibióticos orales, mucolíticos y antipiréticos
- c) Iniciar antibióticos y corticoides endovenosos
- d) Iniciar broncodilatadores inhalados, asociados a corticoides inhalados

e) Iniciar broncodilatadores inhalados, asociados a corticoides orales y antibióticos orales

9) Un paciente de 7 años, presenta tos con el ejercicio y en algunas ocasiones, también respiración sibilante. El examen físico es normal, al igual que el PEF (flujo espiratorio máximo). La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio sin necesidad de mayor estudio
- b) Solicitar radiografía de tórax y decidir manejo según hallazgos
- c) Solicitar test cutáneo para alérgenos respiratorios
- d) Solicitar test de provocación bronquial con metacolina
- e) Iniciar broncodilatadores y corticoides inhalados

10) La causa más frecuente de estridor congénito de tipo inspiratorio es:

- a) Laringomalacia
- b) Hemangioma subglótico
- c) Parálisis vocal unilateral
- d) Traqueomalacia
- e) Membrana faríngea

11) Un niño de 2 años inicia cuadro de tos intensa, de inicio súbito, persistiendo luego con tos, la que se hace rápidamente productiva. Al examen físico se ve de buen aspecto y la auscultación pulmonar demuestra sibilancias en la base derecha. El diagnóstico más probable es:

- a) Neumonía
- b) Bronconeumonía
- c) Bronquitis aguda
- d) Coqueluche
- e) Cuerpo extraño bronquial

12) Un recién nacido pretérmino de 33 semanas, presenta dificultad respiratoria, quejido, aleteo nasal y retracción intercostal y subcostal. Al examen físico se observa taquipneico, con cianosis perioral, la que mejora parcialmente con la administración de oxígeno. La auscultación cardiopulmonar sólo demuestra crepitaciones bibasales. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad de membrana hialina
- b) Taquipnea transitoria
- c) Neumonía neonatal
- d) Ductus arterioso persistente
- e) Síndrome de aspiración meconial

13) Un niño de 4 años presenta cuadro catarral, seguido de tos seca, la que se hace muy intensa, con accesos de tos recurrentes, seguidos de gallito inspiratorio. Se sospecha infección por Bordetella pertussis, la que se confirma con una inmunofluorescencia directa de expectoración. Su hermano de 3 años, vive con él, tiene sus vacunas al día y se encuentra asintomático. La conducta más adecuada para ambos niños es:

- a) Indicar eritromicina por 14 días al paciente y por 7 días a su hermano
- b) Indicar eritromicina por 14 días al paciente y sólo una dosis a su hermano
- c) Indicar eritromicina por 14 días exclusivamente al paciente y observar al hermano
- d) Indicar amoxicilina más ácido clavulánico por 10 días exclusivamente al paciente y observar al hermano
- e) Indicar amoxicilina más ácido clavulánico por 14 días al paciente y sólo una dosis a su hermano

14) Un paciente 4 años, con sus vacunas al día, estuvo en contacto con un paciente diagnosticado recientemente de tuberculosis bacilífera. Se solicita radiografía de tórax que resulta normal y PPD que resulta negativo

- a) Observar evolución, sin necesidad de nuevos exámenes ni tratamientos
- b) Iniciar quimioprofilaxis primaria con isoniazida
- c) Indicar nueva vacunación con BCG y observar evolución
- d) Solicitar baciloscopías de expectoración mensuales, por 6 meses y decidir conducta según resultados
- e) Solicitar nuevas radiografías de tórax y PPD mesualmente, por 6 meses y decidir conducta según resultados

15) Un lactante de 11 meses, inicia cuadro de fiebre hasta 38,5°C e irritabilidad, sin otros síntomas. Al examen físico se ve de buen aspecto y sólo destaca faringe eritematosa, congestiva, con exudado amigdalino blanquecino, adherente, bilateral, asociado a algunas adenopatías cervicales. El diagnóstico más probable es:

- a) Infección respiratoria alta viral
- b) Amigdalitis estreptocócica
- c) Mononucleosis infecciosa
- d) Herpangina
- e) Difteria

16) El tratamiento farmacológico del asma persistente leve es:

- a) Beta agonistas de acción corta inhalados, previos a la actividad física o en caso de síntomas, sin necesidad de usar corticoides
- b) Corticoides inhalados según horario y beta agonistas de acción corta según síntomas
- c) Corticoides inhalados según horario y beta agonistas de acción larga según síntomas
- d) Corticoides inhalados y beta agonistas de acción larga según horario, más beta agonistas de acción corta según síntomas
- e) Corticoides orales en dosis bajas y beta agonistas de acción corta según síntomas

17) Niño de 3 años, ha presentado 3 episodios de otitis media aguda en los últimos 6 meses. Consulta por nuevo episodio de otalgia y otorrea escasa a derecha. A la otoscopia se observa tímpano derecho eritematoso y abombado, con salida de pus. El tratamiento antibiótico de elección, para este nuevo episodio de otitis media aguda es:

- a) Amoxicilina
- b) Cefadroxilo
- c) Amoxicilina más ácido clavulánico
- d) Azitromicina
- e) Ciprofloxacino

18) La gravedad de una crisis bronquial obstructiva está determinada principalmente por:

- a) La gasometría arterial
- b) La radiografía de tórax
- c) El agente etiológico
- d) La edad del paciente
- e) La clínica

19) Un paciente asmático de 10 años, en tratamiento con broncodilatadores y corticoides inhalados, de uso irregular, consulta por tos seca, asociada a respiración sibilante y disnea de reposo. Al examen se observa disneico, con cianosis labial, frecuencia respiratoria de 32 rpm, asociado a tiraje y retracción subcostal. La auscultación pulmonar muestra espiración prolongada y sibilancias inspiratorias y espiratorias intensas y difusas. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar una nebulización con salbutamol y enviar a domicilio con indicación de cumplir el tratamiento previo, sin necesidad de nuevos controles
- b) Realizar 3 inhalaciones con salbutamol, asociado a ipratropio, separadas por 10 minutos, administrar corticoides sistémicos y enviar a domicilio con tratamiento antibiótico oral
- c) Iniciar oxígeno, realizar 3 nebulizaciones con salbutamol, separadas por 20 minutos, administrar corticoides sistémicos y reevaluar en 1 hora
- d) Hospitalizar, iniciar oxígeno y broncodilatadores nebulizados, administrar corticoides endovenosos, indicar kinesioterapia y observar por 24 horas
- e) Intubar, iniciar ventilación mecánica, broncodilatadores inhalados, corticoides y antibióticos sistémicos.

20) Los gérmenes que con mayor frecuencia están involucrados en las infecciones respiratorias bajas, de los pacientes con fibrosis quística son:

- a) Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa
- b) Streptococcus pneumoniae y Mycoplasma
- c) Streptococcus pneumoniae y Anaerobios
- d) Staphylococcus aureus y Anaerobios
- e) Streptococcus pyogenes y Streptococcus agalactiae

Prueba 6

1) Una paciente de 50 años, diagnosticada de fibrosis pulmonar consulta por fiebre y tos productiva. Al examen físico se encuentra en buenas condiciones, con pulso 87x' regular, presión arterial: 120/80 mmHg, frecuencia respiratoria: 17x', temperatura axilar: 38, 5°C y saturación arterial de oxígeno: 94%. Al examen pulmonar se auscultan crépitos bilaterales. Se solicita radiografía de tórax que demuestra una zona de relleno alveolar en el lóbulo inferior izquierdo. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar amoxicilina oral
- b) Iniciar amoxicilina más ácido clavulánico oral y controlar de forma ambulatoria
- c) Hospitalizar e iniciar ceftriaxona endovenosa
- d) Hospitalizar en UCI e iniciar una asociación entre un macrólido y una cefalosporina de tercera generación
- e) Hospitalizar en UCI e iniciar una asociación entre una quinolona y una cefalosporina de tercera generación

2) ¿Cuál de los siguientes pacientes diagnosticados de EPOC tiene indicación de recibir oxígeno domiciliario para aumentar su sobrevivencia?

- a) Paciente con EPOC estable con PaO₂: 64 mmHg y PaCO₂: 36 mmHg
- b) Paciente con EPOC estable que continúa fumando con PaO₂: 59 mmHg y PaCO₂: 33 mmHg
- c) Paciente con EPOC descompensado por una neumonía, con PaO₂: 54 mmHg y PaCO₂: 46 mmHg
- d) Paciente con EPOC descompensado por abandono de tratamiento, con PaO₂: 64 mmHg y PaCO₂: 50 mmHg
- e) Paciente con EPOC estable, con PaO₂: 56 mmHg y PaCO₂: 47 mmHg y hematocrito: 60%

3) Un recién nacido de 37 semanas de edad gestacional, presenta un cuadro de taquipnea y aleteo nasal luego de nacer. Al examen se auscultan escasos crépitos en ambas bases pulmonares y la radiografía de tórax muestra hilios pulmonares prominentes y escaso derrame en los ángulos costofrénicos. El diagnóstico más probable es:

- a) Taquipnea transitoria
- b) Enfermedad de membrana hialina
- c) Síndrome de aspiración meconial
- d) Cardiopatía congénita cianótica
- e) Cardiopatía congénita acianótica

4) Se realiza una toracocentesis a un paciente diagnosticado de derrame pleural, obteniéndose LDH pleural: 180 UI/l, Proteínas pleurales: 4,5 g/dl, células: 1.200 x mm³, polimorfonucleares: 85%, mononucleares: 15%, lactato: 3 mmol/l, pH: 7,36. Además se midió la LDH plasmática: 210 UI/l y las proteínas plasmáticas: 6,4 g/dl. El diagnóstico más probable es:

- a) Insuficiencia cardíaca
- b) Cáncer
- c) Tuberculosis
- d) Empiema
- e) Derrame paraneumónico simple

5) El tratamiento de primera línea de una sinusitis bacteriana aguda es:

- a) Amoxicilina
- b) Clindamicina
- c) Cloxacilina
- d) Amoxicilina + ácido clavulánico
- e) Levofloxacino

6) Un paciente de 17 años consulta por dolor torácico de inicio súbito, con top inspiratorio. Al examen físico está en buenas condiciones, con signos vitales normales y se aprecia clara disminución del murmullo pulmonar izquierdo. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar dímero D
- b) Solicitar radiografía de tórax
- c) Solicitar AngioTAC de tórax
- d) Solicitar TAC de Tórax
- e) Realizar punción del segundo espacio intercostal

7) Un paciente de 65 años, fumador de una cajetilla al día, consulta por disnea de un mes de evolución, progresiva, asociada a expectoración mucosa. Al examen físico se aprecian uñas en vidrio de reloj y el examen pulmonar es normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Tuberculosis
- b) Cáncer pulmonar
- c) Fibrosis pulmonar
- d) Bronquiectasias
- e) Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

8) Un paciente es diagnosticado de tuberculosis pulmonar, por lo que inicia tratamiento antituberculoso con rifampicina, isoniacida, pirazinamida y etambutol durante 2 meses y luego sólo con rifampicina e isoniacida. Se controlan baciloscopías mensuales, obteniéndose los siguientes resultados: Mes 1: positiva, Mes 2: negativa, Mes 3: positiva. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar cultivo de Koch y ajustar el tratamiento antibiótico según el antibiograma
- b) Mantener el tratamiento con Isoniacida y rifampicina e iniciar pirazinamida
- c) Retomar el tratamiento inicial con Isoniacida, rifampicina, pirazinamida y etambutol
- d) Derivar a especialista para tratamiento con 5 fármacos antituberculosos
- e) Mantener el tratamiento con isoniacida y rifampicina, controlando con resultado del cultivo y nueva baciloscopía en un mes

9) Son causa de Distress respiratorio del adulto, EXCEPTO:

- a) Tromboembolismo pulmonar
- b) Sepsis
- c) Quemaduras
- d) Infarto agudo al miocardio
- e) Neumonía

10) Un paciente de 68 con antecedente de EPOC tabáquico, presenta importante aumento de su disnea. Se inicia oxígeno al 28%, evolucionando con deterioro de su función respiratoria. Al examen está vigil, orientado, con cianosis facial y uso de musculatura accesorio. Se solicitan gases arteriales que muestran PaO₂: 49 mmHg, PaCO₂: 66 mmHg, pH: 7,27 mmHg y HCO₃: 30 mmHg. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar oxígeno por mascarilla de recirculación al 100% y realizar nebulizaciones con salbutamol
- b) Suspender el oxígeno
- c) Realizar nebulizaciones con salbutamol por 3 veces
- d) Administrar corticoides endovenosos
- e) Instalar apoyo ventilatorio no invasivo (Bi-PAP)

11) Un paciente presenta tos y disnea en relación al ejercicio y a las infecciones respiratorias. Además presenta síntomas sin un desencadenante claro, con una mayor frecuencia en primavera. Se solicita una radiografía de tórax que resulta normal y un test de metacolina que demuestra hiperreactividad bronquial. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar prick test
- b) Indicar inhalaciones con salbutamol cada 6 horas
- c) Indicar inhalaciones con salbutamol cada 6 horas y corticoides inhalados en caso de síntomas
- d) Indicar inhalaciones con budesonida cada 12 horas y salbutamol inhalado en caso de síntomas
- e) Indicar antihistamínicos orales

12) Una paciente de 45 años consulta por un cuadro de dolor abdominal, siendo diagnosticada de apendicitis aguda y manejada de manera quirúrgica. Al segundo día presenta disnea de inicio súbito, asociada a fiebre, dolor torácico con tope inspiratorio y expectoración rosada. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar dímero D
- b) Solicitar radiografías de tórax seriadas
- c) Solicitar radiografía de tórax AP y lateral, baciloscopías y cultivo de expectoración
- d) Solicitar angio-TAC
- e) Iniciar antibióticos endovenosos

13) Un paciente de 10 años consulta por fiebre hasta 38,5°C, con odinofagia, asociada a coriza y tos. Al examen se aprecia eritema y edema faríngeo, con aumento de volumen y eritema de ambas amígdalas palatinas. El examen pulmonar es normal. El agente etiológico más probable es:

- a) Streptococcus pyogenes
- b) Streptococcus pneumoniae
- c) Anaerobios
- d) Virus de Epstein Barr
- e) Rinovirus

14) Un paciente consulta por fiebre y tos con expectoración purulenta de mal olor. El examen físico no aporta mayor información y se solicita una radiografía de tórax que muestra una lesión radiopaca redonda, con un nivel hidroaéreo en su interior en el lóbulo inferior derecho. El tratamiento de elección es:

- a) Drenaje postural + clindamicina
- b) Drenaje postural + ceftriaxona
- c) Drenaje por punción + ceftriaxona
- d) Drenaje por punción + clindamicina
- e) Drenaje transbronquial + Ceftriaxona + cloxacilina + metronidazol

15) Un paciente de 23 años presenta broncorrea crónica, mayor en las mañanas y ha presentado neumonías en varias oportunidades. Se realiza un TAC de cortes finos que demuestra bronquiectasias localizadas en el lóbulo inferior derecho. La conducta más adecuada es:

- a) Derivar para resolución quirúrgica
- b) Indicar antibióticos y broncodilatadores
- c) Indicar broncodilatadores y corticoides inhalados
- d) Indicar mucolíticos y corticoides orales
- e) Indicar antibióticos y corticoides orales

16) Un niño de 3 años presenta un cuadro de fiebre y tos, seguido de disnea, con respiración ruidosa, por lo que su madre decide llevarlo a la urgencia, cediendo los síntomas en el trayecto de manera significativa. El diagnóstico más probable es:

- a) Bronquiolitis
- b) Aspiración de cuerpo extraño
- c) Laringitis obstructiva
- d) Neumotórax
- e) Laringomalacia

17) ¿Qué tratamiento indicaría a un paciente con trastorno de la deglución que presenta una neumonía?

- a) Amoxicilina
- b) Ceftriaxona
- c) Ceftriaxona + clindamicina
- d) Levofloxacino + cloxacilina
- e) Claritromicina

18) Una paciente de 50 años, fumadora de 1 a 5 cigarrillos diarios, consulta por disnea de esfuerzos de 3 meses de evolución, que ha ido progresando, presentándose actualmente al caminar una cuadra. Al examen físico se auscultan campos pulmonares pequeños, con crepitaciones intensas, bilaterales, mayores en las bases. El diagnóstico más probable es:

- a) Derrame pleural
- b) Tuberculosis
- c) EPOC
- d) Fibrosis pulmonar
- e) Hipertensión pulmonar

19) ¿Cuál de los siguientes patrones espirométricos es compatible con un asma bronquial?

- a) CVF: 85% del teórico; VEF1: 56% del teórico; VEF1/CVF: 42%, sin mejoría con salbutamol
- b) CVF: 62% del teórico; VEF1: 60% del teórico; VEF1/CVF: 83%, con mejoría con salbutamol
- c) CVF: 105% del teórico; VEF1: 96% del teórico; VEF1/CVF: 79%, sin mejoría con salbutamol

- d) CVF: 110% del teórico; VEF1: 60% del teórico; VEF1/CVF: 58%, con mejoría con salbutamol
- e) CVF: 51% del teórico; VEF1: 51% del teórico; VEF1/CVF: 80%, sin mejoría con salbutamol

20) Se obtienen los siguientes gases arteriales PaO₂: 80mmHg, PaCO₂: 31mmHg, pH: 7.33, HCO₃: 16 mmol/l. ¿A qué estado ácido base corresponden?

- a) Acidosis respiratoria
- b) Acidosis metabólica
- c) Acidosis respiratoria con alcalosis respiratoria
- d) Acidosis metabólica con alcalosis metabólica
- e) Acidosis mixta

Prueba 7

1) Un paciente con EPOC descompensado recibe nebulizaciones con salbutamol y oxígeno al 40% por mascarilla, evolucionando con sopor profundo. El diagnóstico más probable es:

- a) Hipoxemia severa
- b) Hipercarbica severa
- c) Alcalosis respiratoria severa
- d) Acidosis metabólica severa
- e) Alcalosis metabólica severa

2) Un paciente de 60 años, fumador importante, consulta por disnea de esfuerzos moderados. Al examen físico se aprecia aumento del diámetro anteroposterior del tórax, ruidos cardíacos apagados y murmullo pulmonar disminuido globalmente, con algunas sibilancias escasas bilaterales. Se solicita radiografía de tórax que muestra aplanamiento del diafragma. Además de dejar de fumar, la conducta más adecuada es:

- a) Solicitar test de metacolina
- b) Solicitar espirometría
- c) Solicitar TAC de tórax
- d) Iniciar corticoides inhalados según horario, asociados a salbutamol inhalado según síntomas
- e) Iniciar corticoides orales, asociados a salbutamol inhalado según síntomas

3) ¿Qué examen es útil para confirmar el diagnóstico de asma bronquial?

- a) PEF
- b) Prick test
- c) Radiografía de tórax
- d) Biopsia bronquial
- e) Test de provocación con metacolina

4) Un paciente asmático, en tratamiento con salbutamol y fluticasona, consulta por disnea. Al examen físico presenta FC: 100x', PA: 120/80 mmHg, FR: 27x', SatO₂: 92% a FiO₂ ambiental, se auscultan sibilancias espiratorias bilaterales y se observa retracción intercostal, sin cianosis. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar nebulizaciones con salbutamol y salmeterol
- b) Realizar nebulizaciones con salbutamol
- c) Realizar nebulizaciones con salbutamol y administrar corticoides sistémicos
- d) Realizar nebulizaciones con salmeterol y budesonida
- e) Realizar nebulizaciones con adrenalina racémica y budesonida y administrar corticoides sistémicos

5) Un paciente de 15 años consulta por un cuadro de 10 días de evolución de odinofagia, tos y rinorrea, al que en los últimos días se le agrega malestar general, fiebre hasta 38,6°C y disnea de esfuerzos. Al examen pulmonar se constatan crepitaciones y sibilancias bilaterales, mayores en la base derecha. El agente etiológico más probable es:

- a) Neumococo
- b) Mycoplasma
- c) Virus influenza
- d) Anaerobios
- e) Adenovirus

6) Un paciente de 67 años en tratamiento antituberculoso, secundaria a una tuberculosis pulmonar bacilífera, presenta las siguientes baciloscopías mensuales: Mes 1 (+), Mes 2 (-), Mes 3 (-), Mes 4 (+), Mes 5 (+). Actualmente recibe rifampicina e isoniazida dos veces a la semana. La conducta más adecuada es:

- a) Mantener el tratamiento y controlar con nueva baciloscopía en un mes
- b) Retomar el tratamiento con Rifampicina, isoniazida, pirazinamida y etambutol
- c) Solicitar radiografía de tórax y PPD
- d) Solicitar cultivo de Koch con antibiograma
- e) Derivar a especialista por fracaso del tratamiento

7) ¿Qué patología es más probable en un paciente con un derrame pleural tipo exudado, de predominio mononuclear?

- a) Cáncer
- b) Empiema
- c) Síndrome nefrótico
- d) Quilotórax
- e) Derrame paraneumónico simple

8) Una paciente de 67 años presenta dolor en la pierna izquierda, de 2 días de evolución, que luego es seguido de dolor torácico y disnea de inicio súbito, asociado a síncope. Al examen físico presenta FC: 114x' y PA: 80/40 mmHg y saturación arterial de oxígeno: 84%, con crépitos en la base izquierda, en la auscultación pulmonar. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar dímero D
- b) Solicitar radiografías de tórax seriadas
- c) Solicitar TAC de tórax sin contraste
- d) Solicitar angioTAC de tórax
- e) Realizar angiografía pulmonar de urgencia

9) Un paciente de 45 años sufre accidente de tránsito, con golpe en el pecho, contra el manubrio del automóvil que conducía. Evoluciona con disnea y dolor. Al examen físico presenta taquipnea y se auscultan crepitaciones bilaterales, mayores en el campo pulmonar izquierdo. La radiografía de tórax muestra fracturas costales de rasgo único en 3 costillas izquierdas y se observan zonas de relleno alveolar en el pulmón izquierdo. El diagnóstico más probable es:

- a) Edema pulmonar
- b) Contusión pulmonar
- c) Tórax volante
- d) Atelectasia masiva
- e) Laceración traqueobronquial

10) Un paciente de 58 años, con antecedente de silicosis pulmonar, consulta por un cuadro de malestar general, tos con expectoración mucopurulenta y fiebre. Al examen físico está en buenas condiciones generales, con signos vitales normales y se auscultan crepitaciones bilaterales, mayores en la base izquierda. Se solicita una radiografía de tórax que muestra alteraciones pulmonares bilaterales, consistentes con su patología de base, más una zona de condensación en el lóbulo inferior izquierdo. La conducta más adecuada es:

- a) Hospitalizar en UCI, con apoyo ventilatorio e iniciar tratamiento antibiótico con claritromicina + ceftriaxona
- b) Hospitalizar en sala e iniciar tratamiento antibiótico con ceftriaxona
- c) Hospitalizar en sala e iniciar tratamiento con ceftriaxona + clindamicina
- d) Indicar amoxicilina más ácido clavulánico oral, y controlar en 48 horas de manera ambulatoria
- e) Indicar amoxicilina oral por 7 días

11) La conducta más adecuada frente a la sospecha clínica de un neumotórax a tensión es:

- a) Confirmar con radiografía de tórax
- b) Instalar un tubo pleural
- c) Puncionar el segundo espacio intercostal
- d) Iniciar ventilación a presión positiva
- e) Realizar intubación orotraqueal

12) Un niño de 2 años es traído por un cuadro de fiebre, tos y dificultad respiratoria, constatándose una respiración ruidosa, con estridor inspiratorio, sin otras alteraciones en el examen pulmonar. La conducta más adecuada es:

- a) Nebulizar con salbutamol
- b) Nebulizar con adrenalina racémica
- c) Administrar corticoides inhalados y nebulizar adrenalina racémica
- d) Administrar corticoides inhalados y nebulizar salbutamol
- e) Nebulizar con adrenalina racémica y administrar corticoides sistémicos

13) Un paciente de 59 años, fumador, consulta por disnea de esfuerzos, que aparece al caminar una cuadra. Al examen físico se auscultan crepitaciones gruesas bilaterales y murmullo pulmonar simétrico, pero disminuido en ambas bases. Además se constata saturación arterial de oxígeno de reposo de 96%, pero que cae a 87% con el ejercicio. La radiografía de tórax muestra campos pulmonares de tamaño disminuido, con un patrón intersticial, mayor en las bases. El diagnóstico más probable es:

- a) Sarcoidosis
- b) Tuberculosis
- c) EPOC
- d) Fibrosis pulmonar
- e) Bronquiectasias

14) Un paciente presenta los siguientes gases de sangre arterial: PaO₂: 80 mmHg, PaCO₂: 30 mmHg, pH: 7,33, HCO₃: 15,4 mmol/l. El diagnóstico ácido base es:

- a) Acidosis metabólica
- b) Acidosis respiratoria
- c) Acidosis mixta
- d) Acidosis metabólica con alcalosis respiratoria
- e) Acidosis respiratoria con alcalosis metabólica

15) Una paciente de 67 años, portadora de una insuficiencia cardíaca crónica, consulta por mayor disnea de la habitual. Se realiza una radiografía de tórax que demuestra un derrame pleural izquierdo moderado, el que se punciona, obteniéndose un líquido amarillo, transparente, con proteínas 2,1 g/dl, LDH: 50 UI/l, células: 130 x mm³, con 85% de mononucleares y 15% de polimorfonucleares. Las proteínas plasmáticas son 6,3 g/dl y la LDH plasmática es 150 UI/l. La conducta más adecuada es

- a) Solicitar pH y lactato del líquido
- b) Manejar la insuficiencia cardíaca
- c) Solicitar biopsias pleurales
- d) Solicitar baciloscopias y adenosindeaminasa (ADA) de líquido pleural
- e) Instalar tubo pleural

16) Un paciente de 67 años presenta un accidente vascular encefálico, manejado adecuadamente, pero que evoluciona con dificultades para deglutir. Dos semanas después inicia cuadro de tos, fiebre y expectoración mucopurulenta. Al examen físico presenta FC: 100x', t°: 39,0°C, PA: 110/70 mmHg, SatO₂: 89%, se auscultan crepitaciones en la base pulmonar derecha. Se solicita una radiografía de tórax que muestra un foco de condensación en el lóbulo inferior derecho. ¿Qué tratamiento antibiótico es el más adecuado?

- a) Ceftriaxona + metronidazol
- b) Amoxicilina
- c) Amoxicilina + ácido clavulánico
- d) Cefotaximo
- e) Levofloxacino

17) ¿Cuál de las siguientes patologías NO es causa de distrés respiratorio del adulto?

- a) TEP
- b) Insuficiencia cardíaca descompensada
- c) Trauma torácico
- d) Neumonía
- e) Quemaduras

18) Un paciente sufre una caída de altura, resultando con golpe en el tórax. Al examen físico se muestra disneico, adolorido, con presión arterial y frecuencia cardíaca normales. El examen pulmonar constata disminución del murmullo pulmonar en la base izquierda, con matidez a la percusión. El diagnóstico más probable es:

- a) Tórax volante
- b) Neumotórax
- c) Distrés respiratorio
- d) Hemotórax
- e) Contusión pulmonar

19) Un paciente de 29 años, con antecedente de una neumonía por adenovirus en la infancia, presenta un cuadro de varios años de evolución, de broncorrea mucosa, mayor en las mañanas, que en algunas ocasiones se vuelve mucopurulenta. Ha presentado varias infecciones respiratorias bajas y en oportunidades también ha presentado hemoptisis. El examen con mejor rendimiento para el diagnóstico es:

- a) Biopsia pulmonar
- b) TAC de cortes finos
- c) Radiografía de tórax
- d) Baciloscopías de expectoración + cultivo de Koch
- e) PPD

20) Un lactante de 7 meses de edad, previamente sano, es traído por su madre por un cuadro de fiebre, tos y dificultad respiratoria. Al examen físico está en buenas condiciones, algo taquipneico, sin uso de musculatura accesoria ni cianosis. En el examen pulmonar se auscultan sibilancias escasas bilaterales. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar salbutamol inhalado y enviar a domicilio con salbutamol en caso de síntomas
- b) Administrar salbutamol inhalado y corticoides sistémicos y enviar a domicilio con corticoides inhalados según horario y salbutamol inhalado en caso de síntomas
- c) Administrar salbutamol inhalado, corticoides sistémicos y reevaluar en 4 a 6 horas
- d) Administrar salbutamol inhalado, corticoides sistémicos, iniciar antibióticos orales y reevaluar en 4 a 6 horas
- e) Hospitalizar e iniciar nebulizaciones con salbutamol, corticoides sistémicos y antibióticos endovenosos

Prueba 8

1) En un paciente con EPOC estable, ¿qué criterio es el más adecuado para determinar la severidad?

- a) Respuesta a corticoides inhalados
- b) Respuesta a broncodilatadores
- c) Relación VEF1/CVF
- d) VEF1
- e) Gases en sangre arterial

2) Un paciente de 45 años, diabético, consulta por cuadro de fiebre, tos con expectoración mucopurulenta y malestar general, asociado a disnea. Al examen físico se aprecia taquipneico a 30 rpm, con FC:110x', saturación arterial de oxígeno: 88% y el examen pulmonar demuestra crépitos y respiración sopiante en el ápice derecho. La radiografía de tórax demuestra un foco de condensación neumónica del lóbulo superior derecho. La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio con amoxicilina oral
- b) Enviar a domicilio con amoxicilina + ácido clavulánico y controlar ambulatoriamente
- c) Hospitalizar en sala con oxígeno y administrar ceftriaxona endovenosa
- d) Hospitalizar en sala con oxígeno y administrar ceftriaxona + clindamicina por vía endovenosa
- e) Hospitalizar en la UCI con oxígeno y apoyo ventilatorio e iniciar ceftriaxona + claritromicina

3) ¿Cuál de las siguientes acciones es MENOS recomendable para el manejo de un paciente con EPOC descompensado y saturación arterial de 70%?

- a) Administrar antibióticos endovenosos
- b) Administrar corticoides sistémicos
- c) Realizar nebulizaciones con salbutamol
- d) Administrar oxígeno por mascarilla de recirculación, para mantener saturaciones arteriales mayor a 90%
- e) Solicitar gases en sangre arterial

4) Interprete los siguientes resultados de gases arteriales: PaO₂: 57 mmHg, PaCO₂: 62 mmHg, pH: 7,0 HCO₃: 15 mEq/l.

- a) Insuficiencia respiratoria parcial con acidosis respiratoria
- b) Insuficiencia respiratoria parcial con acidosis metabólica
- c) Insuficiencia respiratoria global con acidosis mixta
- d) Insuficiencia respiratoria global con acidosis respiratoria
- e) Insuficiencia respiratoria global con acidosis metabólica

5) Un paciente de 30 años, obeso, consulta por tos que aparece en la noche y en relación al frío. Además refiere que su tolerancia al ejercicio ha disminuido y que suele toser y tener respiración ruidosa luego de hacer deporte. La radiografía de tórax resulta normal, al igual que el examen físico. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar TAC de tórax
- b) Solicitar test cutáneo
- c) Solicitar test de provocación con metacolina
- d) Solicitar IgE total
- e) Iniciar antihistamínicos orales

6) ¿Cuál de las siguientes espirometrías es más sugerente de una fibrosis pulmonar?

- | | | | |
|---------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| a) Basal | VEF1: 96% del teórico | CVF: 85% del teórico | VEF1/CVF: 106% |
| Postbroncodilatador | VEF1: 100% del teórico | CVF: 87% del teórico | VEF1/CVF: 105% |
| b) Basal | VEF1: 48% del teórico | CVF: 50% del teórico | VEF1/CVF: 78% |
| Postbroncodilatador | VEF1: 49% del teórico | CVF: 52% del teórico | VEF1/CVF: 78% |
| c) Basal | VEF1: 39% del teórico | CVF: 92% del teórico | VEF1/CVF: 40% |
| Postbroncodilatador | VEF1: 70% del teórico | CVF: 96% del teórico | VEF1/CVF: 72% |
| d) Basal | VEF1: 45% del teórico | CVF: 85% del teórico | VEF1/CVF: 51% |
| Postbroncodilatador | VEF1: 45% del teórico | CVF: 84% del teórico | VEF1/CVF: 52% |
| e) Basal | VEF1: 80% del teórico | CVF: 85% del teórico | VEF1/CVF: 81% |
| Postbroncodilatador | VEF1: 102% del teórico | CVF: 90% del teórico | VEF1/CVF: 85% |

7) Usted recibe a una paciente de 35 años, sin antecedentes mórbidos, cuyo marido fue recientemente diagnosticado de tuberculosis pulmonar bacilífera. Ella está asintomática y su examen físico es normal, evidenciándose las cicatrices de 2 vacunas BCG en el brazo izquierdo. Se solicita una radiografía de tórax que resulta normal y un PPD que resulta 20mm a las 48 horas. La conducta más adecuada es:

- a) Tranquilizar a la paciente y explicarle que no requiere de exámenes ni medicamentos adicionales
- b) Solicitar baciloscopías de expectoración y cultivo de Koch
- c) Solicitar nuevo PPD en 3-4 semanas
- d) Iniciar profilaxis con isoniazida
- e) Iniciar tratamiento antituberculoso con 4 fármacos

8) Un niño de 3 años, sin antecedentes de importancia, presenta un cuadro de tos y fiebre hasta 38,7° C, seguido de dificultad respiratoria y respiración ruidosa. Al examen físico tose con frecuencia y se escucha estridor inspiratorio. El agente etiológico más probable es:

- a) Virus respiratorio sincicial
- b) Virus parainfluenza
- c) Haemophilus influenzae
- d) Mycoplasma pneumoniae
- e) Streptococcus pneumoniae

9) Un paciente, diagnosticado de derrame pleural, se realiza toracocentesis diagnóstica, obteniéndose un líquido amarillo, transparente, con proteínas de 2,1 g/dl, LDH: 90 UI/l, células: 60 x mm³, con 80% mononucleares, pH: 7,4 y lactato: 3 mmol/l. Las proteínas plasmáticas son 6,4 g/dl y la LDH plasmática es 190 UI/l. El diagnóstico más probable es:

- a) Tuberculosis
- b) Cáncer
- c) Empiema
- d) Derrame paraneumónico simple
- e) Insuficiencia cardíaca

10) Un paciente de 25 años, delgado, consulta por dolor torácico con tope inspiratorio, confirmándose mediante una radiografía de tórax, la presencia de un neumotórax espontáneo que ocupa el 30% del hemitórax derecho. La conducta más adecuada es:

- a) Instalar tubo pleural
- b) Puncionar el segundo espacio intercostal
- c) Observar evolución
- d) Realizar sellamiento pleural
- e) Realizar videotoracoscopia

11) EL tratamiento de elección de la otitis media aguda es:

- a) Observación
- b) Penicilina benzatina intramuscular
- c) Amoxicilina oral
- d) Claritromicina oral
- e) Amoxicilina más ácido clavulánico

12) El distrés respiratorio del adulto se debe a:

- a) Un aumento en la presión hidrostática capilar
- b) Un aumento de la presión de enclavamiento pulmonar
- c) Una disminución de la presión oncótica capilar
- d) Un aumento de la presión oncótica intersticial
- e) Un aumento de la permeabilidad capilar

13) Un niño de 4 años presenta tos y disnea de inicio súbito, que luego cede considerablemente. Al examen se aprecia asimetría del murmullo pulmonar y se auscultan sibilancias en la base pulmonar derecha. El diagnóstico más probable es:

- a) Laringitis obstructiva
- b) Neumotórax
- c) Cuerpo extraño bronquial
- d) Crisis asmática

e) Atelectasia

14) El hemograma en el hanta se caracteriza por:

- a) Anemia, leucocitopenia y trombocitopenia
- b) Anemia, leucocitopenia y trombocitosis
- c) Hemoconcentración, leucocitosis y trombocitopenia
- d) Hemoconcentración, leucocitopenia y trombocitosis
- e) Anemia, leucocitosis y trombocitopenia

15) Un paciente de 65 años, fumador, consulta por tos con expectoración mucosa de 2 semanas de evolución. Se realiza radiografía de tórax que muestra un nódulo pulmonar en el ápice izquierdo de 3 cm de diámetro y de bordes regulares. No tiene radiografías previas. La conducta inicial más adecuada es:

- a) Solicitar nueva radiografía en un mes
- b) Solicitar TAC de tórax
- c) Solicitar citología de expectoración
- d) Solicitar biopsia por broncoscopia
- e) Realizar resección quirúrgica

16) Un paciente de 45 años, fumador de 6 cigarrillos al día, consulta por fiebre y tos con expectoración hemoptoica, de 3 semanas de evolución. Se solicita radiografía de tórax que muestra bandas de retracción en los ápices pulmonares y signos de paquipleuritis. El diagnóstico más probable es:

- a) Cáncer
- b) Bronquiectasias
- c) Tuberculosis
- d) Fibrosis pulmonar
- e) Aspergilosis

17) Un paciente de 40 años consulta por un cuadro de malestar general y fiebre hasta 40,7°C, asociado a tos, odinofagia, cefalea y mialgias intensas. El examen pulmonar es normal y la faringe se aprecia eritematosa, sin exudado. El diagnóstico más probable es:

- a) Hanta
- b) Sinusitis aguda
- c) Influenza
- d) Neumonía neumocócica
- e) Faringitis estreptocócica

18) Un paciente de 50 años, cursando un cuadro neumónico, se realiza una radiografía de tórax que muestra una zona de relleno alveolar en el lóbulo medio derecho, asociado a un derrame pleural moderado, el que es puncionado, obteniéndose un exudado pleural, de predominio polimorfonuclear y pH de 7,0. La conducta más adecuada es:

- a) Drenar el derrame mediante toracocentesis e iniciar tratamiento antibiótico endovenoso
- b) Iniciar tratamiento antibiótico endovenoso
- c) Solicitar baciloscopías pleurales y de expectoración
- d) Iniciar antibióticos intrapleurales y endovenosos
- e) Instalar toracostomía con trampa de agua e iniciar tratamiento antibiótico endovenoso

19) Un paciente de 25 años consulta por un cuadro de 15 días de evolución de tos y odinofagia, al que se ha agregado en los últimos días fiebre hasta 38,5°C, malestar general y disnea de esfuerzos. Al examen físico se auscultan crepitaciones escasas y sibilancias bilaterales. Se solicita radiografía de tórax que muestra un infiltrado alveolar e intersticial, bilateral, mayor en el lóbulo inferior izquierdo. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar amoxicilina
- b) Iniciar amoxicilina más ácido clavulánico
- c) Iniciar ceftriaxona
- d) Iniciar claritromicina
- e) Iniciar clindamicina

20) Un paciente de 67 años, con antecedente de cáncer de próstata en tratamiento con hormonoterapia, consulta por dolor torácico de inicio súbito, asociado a disnea y tos con expectoración hemoptoica. El examen pulmonar es inespecífico, al igual que la radiografía de tórax. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar test de esfuerzo
- b) Solicitar angio-TAC de tórax
- c) Realizar nebulizaciones con salbutamol y administrar analgésicos
- d) Iniciar moxifloxacino
- e) Solicitar TAC de tórax de cortes finos

Prueba 9

1) Un paciente presenta un derrame pleural izquierdo, el que es puncionado, dando salida a un líquido amarillo, transparente, con proteínas: 5, 1 g/dl, LDH: 380 UI/l, células: 800 por mm³, mononucleares: 90%. Las proteínas plasmáticas resultan 7 g/dl y la LDH plasmática, 455 UI/L. El diagnóstico más probable es:

- a) Tuberculosis pleural
- b) Síndrome nefrótico
- c) Empiema
- d) Derrame pleural para neumónico simple
- e) Insuficiencia cardíaca

2) Un paciente con un accidente vascular reciente presenta un cuadro de fiebre y tos con expectoración purulenta, de 2 días de evolución, que ha ido empeorando. Al examen físico está muy decaído, taquipneico, satura 91% a FiO₂ ambiental y se auscultan crépitos pulmonares en la base derecha. Se solicita una radiografía de tórax que demuestra una zona de relleno alveolar en el lóbulo inferior derecho. El tratamiento más adecuado es:

- a) Amoxicilina oral
- b) Metronidazol endovenoso
- c) Ceftriaxona endovenosa
- d) Azitromicina oral
- e) Ceftriaxona + clindamicina endovenosa

3) ¿Qué alteración es MENOS probable de encontrar en un paciente con EPOC?

- a) Disminución de la relación VEF1/CVF en la espirometría
- b) Disminución de la difusión de monóxido de carbono, en las pruebas de difusión
- c) Aumento del hematocrito
- d) Disminución de la capacidad pulmonar total
- e) Aumento de la presión de la arteria pulmonar

4) Un paciente de 8 años asmático, en tratamiento con salbutamol SOS, consulta porque presenta tos nocturna de manera frecuente y disnea luego de hacer ejercicios. El examen físico no aporta mayor información y el PEF resulta normal. La conducta más adecuada es:

- a) Agregar corticoides orales
- b) Agregar broncodilatadores de larga acción
- c) Agregar corticoides inhalados
- d) Reemplazar el salbutamol por salmeterol
- e) Reemplazar el salbutamol por ipratropio

5) Un paciente de 30 años consulta por expectoración mucosa abundante, de varios años de evolución, que es mayor en las mañanas y que en oportunidades se vuelve purulenta, respondiendo al uso de antibióticos orales. Además refiere que presentó hemoptisis en una oportunidad. El examen físico muestra uñas en virio de reloj, con algunas crepitaciones difusas en ambos campos pulmonares y la radiografía de tórax es inespecífica. El diagnóstico más probable es:

- a) Tuberculosis
- b) Cáncer de pulmón
- c) Fibrosis pulmonar
- d) Fibrosis quística
- e) Bronquiectasias

6) Un paciente de 18 años consulta por dolor torácico tipo puntada, con tope inspiratorio, que inició hace 4 horas y que se asoció a disnea. Al examen físico está en buenas condiciones, con signos vitales normales y se ausculta asimetría en el murmullo pulmonar. El diagnóstico más probable es:

- a) Cuerpo extraño
- b) Tromboembolismo pulmonar
- c) Neumotórax
- d) Neumonía
- e) Derrame pleural

7) Un paciente sufre una caída de altura, golpeándose el pecho contra unos fierros. Evoluciona con dolor y disnea y al examen físico se encuentra taquipneico, con PA: 120/80 mmHg, FC: 90x', saturación de O₂: 95% y se constata matidez y disminución del murmullo pulmonar en la base pulmonar derecha. Se solicita una radiografía de tórax que confirma la presencia de un derrame pleural derecho de tamaño moderado y fractura del ángulo de la 6ta y 7ma costillas derechas. La conducta más adecuada es:

- a) Puncionar el derrame y solicitar estudio de líquido pleural
- b) Instalar tubo pleural
- c) Solicitar angio-TAC de tórax
- d) Resolver quirúrgicamente de inmediato
- e) Realizar intubación y ventilación a presión positiva

8) Un paciente de 35 años presenta un cuadro de malestar general, fiebre alta, con calofríos, mialgias intensas y tos seca, que duró cerca de 3 días, respondiendo parcialmente al uso de ibuprofeno y que luego fue mejorando hasta sentirse bien al 6° día. Sin embargo evoluciona nuevamente con malestar general, tos productiva, fiebre y disnea, auscultándose crépito pulmonares difusos y bilaterales. Se solicita una radiografía de tórax que muestra múltiples imágenes de condensación bilaterales, con presencia de múltiples imágenes compatibles con abscesos pulmonares. El agente etiológico más probable es:

- a) Mycobacterium tuberculosis
- b) Pseudomona aureginosa
- c) Bacterias anaerobias
- d) Streptococcus pneumoniae
- e) Staphylococcus aureus

9) Un paciente es diagnosticado de tuberculosis pulmonar, mediante una baciloscopia, por lo que inicia el el tratamiento antituberculoso con rifampicina, isoniazida, pirazinamida y etambutol por 2 meses y luego sólo con rifampicina e isoniazida. Se controla con baciloscopías mensuales resultando así: Primer mes: (+); Segundo mes (-); Tercer mes: (+); cuarto mes (+). La conducta más adecuada es:

- a) Mantener el tratamiento antituberculoso, controlando con nueva baciloscopia en un mes
- b) Solicitar PPD y radiografía de tórax
- c) Derivar al especialista, por fracaso del tratamiento
- d) Solicitar PCR para bacilo de Koch en secreción
- e) Reiniciar el tratamiento con rifampicina, isoniazida, etambutol y pirazinamida

10) Un paciente consulta por fiebre, dolor tipo puntada de costado y tos con expectoración purulenta de 2 días de evolución. Se solicita una radiografía de tórax que muestra un foco de condensación neumónico en el lóbulo inferior izquierdo, asociado a un derrame pleural, el que se punciona, dando salida a un líquido turbio, con características de exudado, con abundantes células de predominio polimorfonuclear y pH: 7,0. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar antibióticos orales
- b) Iniciar antibióticos endovenosos e instalar tubo pleural
- c) Iniciar antibióticos endovenosos y realizar drenaje del derrame pleural, mediante una toracocentesis
- d) Iniciar antibióticos endovenosos e intrapleurales
- e) Iniciar antibióticos endovenosos y solicitar adenosindeaminasa pleural, más biopsias pleurales percutáneas

11) Un paciente presenta una sinusitis aguda de 10 días de evolución. ¿Qué antibiótico le parece más adecuado como tratamiento inicial?

- a) Amoxicilina
- b) Amoxicilina + ácido clavulánico
- c) Moxifloxacino
- d) Clindamicina
- e) Cefadroxilo

12) Un recién nacido de término, con antecedente de sufrimiento fetal agudo, presenta dificultad respiratoria desde el nacimiento. Al examen físico se auscultan sibilancias bilaterales y múltiples crepitaciones gruesas difusas. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad de membrana hialina
- b) Taquipnea transitoria
- c) Síndrome de aspiración meconial
- d) Bronquiolitis aguda

e) Neumonía neonatal

13) Un paciente fumador de 20 paquetes año, consulta por tos y disnea. Se solicita una radiografía que visualiza un nódulo pulmonar de 4 cm en la zona parahiliar izquierda, que no estaba presente en radiografías previas hace 3 años. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar nueva radiografía de tórax en 6 meses
- b) Solicitar TAC de tórax
- c) Solicitar biopsia por punción percutánea
- d) Solicitar endoscopia digestiva alta y colonoscopia en busca de un tumor primario
- e) Resolver quirúrgicamente

14) Un paciente de 50 años presenta disnea progresiva de pequeños esfuerzos. Al examen físico se auscultan crépitos bibasales gruesos y campos pulmonares de pequeño tamaño. Se solicita una radiografía de tórax que muestra un patrón intersticial en ambas bases pulmonares, en “panal de abeja”. ¿Qué alteración es MÁS probable de encontrar en este paciente?:

- a) Relación VEF1/CVF disminuida
- b) Caída de la saturación arterial de oxígeno con el ejercicio
- c) Diferencia alveolo arterial de oxígeno normal
- d) Leucocitosis
- e) Hiperreactividad bronquial en el test de metacolina

15) Un paciente presenta una fractura de pierna izquierda, la que es reducida y estabilizada mediante osteosíntesis. Al segundo día postquirúrgico presenta disnea súbita, con síncope a repetición y el examen físico muestra PA: 80/50 mmHg, FC: 110 x', FR: 33x' y saturación arterial de O₂: 84%. El examen pulmonar y la radiografía de tórax no aportan mayor información. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar dímero D
- b) Solicitar Angio-TAC de tórax
- c) Realizar punción del segundo espacio intercostal
- d) Realizar intubación y ventilación a presión positiva
- e) Realizar angiografía pulmonar

16) El tratamiento del distrés respiratorio suele ser:

- a) Diuréticos endovenosos y oxígeno en altas concentraciones por mascarilla de recirculación
- b) Vasodilatadores endovenosos y oxígeno en altas concentraciones por mascarilla de recirculación
- c) Anticoagulantes endovenosos y oxígeno en altas concentraciones por mascarilla de recirculación
- d) Oxígeno en altas concentraciones por mascarilla de recirculación
- e) Ventilación mecánica a presión positiva y oxigenoterapia

17) Paciente de 35 años de edad, que es traído a urgencias tras haber sufrido accidente de coche. No llevaba puesto cinturón de seguridad. Presenta traumatismo torácico, producido contra el volante, así como lesiones faciales diversas y hemoptisis. En la exploración presenta crepitación del tejido subcutáneo en hemitórax derecho y en la radiografía de tórax se observa neumotórax derecho, enfisema subcutáneo y neumomediastino. Se coloca sonda en hemitórax derecho, observando fuga de aire masiva, siendo imposible expandir el pulmón por completo. El diagnóstico más probable es:

- a) Contusión pulmonar
- b) Lesión traqueobronquial
- c) Neumotórax valvular
- d) Neumotórax abierto no identificado
- e) Mala colocación de la sonda torácica

18) Un niño de 5 años, presenta hace pocos segundos agitación psicomotora, llevándose las manos al cuello, con imposibilidad de llorar o hablar, asociado a cianosis, mientras comía almendras. La conducta más adecuada es:

- a) Abrir la boca y tratar de retirar cualquier tipo de cuerpo extraño
- b) Realizar insuflaciones boca a boca
- c) Realizar maniobra de Heimlich
- d) Realizar insuflaciones boca a nariz-boca
- e) Dar golpes en la espalda

19) Identifique la asociación INCORRECTA entre la patología y su agente causal

- a) Bronquiolitis – Virus sincicial
- b) Laringitis obstructiva – Virus parainfluenza
- c) Sinusitis bacteriana – Neumococo
- d) Neumonía neonatal – Streptococcus pneumoniae
- e) Neumonía atípica – Mycoplasma pneumoniae

20) Un paciente asmático, consulta por disnea. Al examen físico se aprecia de buen aspecto, orientado, con FR: 23x', FC: 80x', PA: 120/80 mmHg, sin uso de musculatura accesoria ni cianosis. Se auscultan sibilancias espiratorias, sin otras alteraciones. Se solicitan gases arteriales, resultando PaO2: 40 mmHg, PaCO2: 47 mmHg, HCO3: 24 mEq/l, pH: 7,4. El diagnóstico más probable es:

- a) Crisis asmática grave con insuficiencia respiratoria global
- b) Crisis asmática grave con insuficiencia respiratoria parcial
- c) Crisis asmática moderada con insuficiencia respiratoria e hipoventilación
- d) Crisis asmática leve con hipoventilación
- e) Crisis asmática leve con toma de gases venosos

Prueba 10:

Ver CARDIOLOGÍA, Prueba 5

RESPIRATORIO RESPUESTAS

Prueba 1	10 E	Prueba 4	10 A	Prueba 7	13 C
1 C	11 E	1 C	11 E	1 B	14 C
2 D	12 A	2 A	12 A	2 B	15 B
3 C	13 D	3 E	13 A	3 E	16 C
4 D	14 A	4 B	14 B	4 C	17 C
5 B	15 E	5 D	15 A	5 B	18 E
6 B	16 B	6 C	16 B	6 E	19 D
7 C	17 C	7 E	17 A	7 A	20 B
8 E	18 A	8 D	18 E	8 E	
9 D	19 B	9 C	19 C	9 B	Prueba 9
10 E	20 A	10 A	20 A	10 D	1 A
11 C		11 E		11 C	2 E
12 D	Prueba 3	12 B	Prueba 6	12 E	3 D
13 C	1 E	13 D	1 B	13 D	4 C
14 A	2 E	14 B	2 E	14 A	5 E
15 E	3 D	15 B	3 A	15 B	6 C
16 D	4 A	16 B	4 E	16 A	7 B
17 A	5 C	17 D	5 A	17 B	8 E
18 D	6 C	18 D	6 B	18 D	9 C
19 C	7 E	19 C	7 B	19 B	10 B
20 D	8 D	20 C	8 E	20 A	11 A
	9 A		9 D	Prueba 8	12 C
	10 D	Prueba 5	10 E	1 D	13 B
Prueba 2	11 D	1 D	11 D	2 C	14 B
1 D	12 B	2 A	12 D	3 D	15 E*
2 D	13 A	3 E	13 E	4 C	16 E
3 B	14 C	4 D	14 A	5 C	17 B
4 C	15 A	5 C	15 A	6 B	18 C
5 B	16 A	6 C	16 C	7 D	19 D
6 B	17 D	7 A	17 C	8 B	20 E
7 E	18 C	8 A	18 D	9 E	
8 B	19 E	9 D	19 D	10 A	
9 D	20 B		20 B	11 C	
				12 E	

III) GASTROENTEROLOGÍA PRUEBAS

Prueba 1

1) Un paciente de 24 años consulta por dolor epigástrico recurrente, de características urentes. Usted solicita una endoscopia digestiva alta que demuestra una úlcera duodenal activa, sin estigmas de sangrado reciente. El test de ureasa resulta positivo. La medida terapéutica de primera línea es:

- a) Omeprazol en dos dosis diarias, a permanencia.
- b) Tratamiento de erradicación de *H. pylori* por 7 a 10 días.
- c) Dieta estricta, evitando grasas, condimentos e irritantes y control endoscópico cada 3 meses.
- d) Inhibidores H2 diarios, asociados a antiácidos, según síntomas.
- e) Prohibir el uso de AINEs y asociar un inhibidor de la bomba de protones en dosis única diaria.

2) Cuatro horas después de acudir a un banquete, 25 personas inician súbitamente un cuadro de náuseas, vómitos y dolores abdominales. ¿Cuál de los siguientes agentes es el causante más probable de estos síntomas?

- a) *Clostridium botulinum*.
- b) *Salmonella*
- c) *Escherichia coli* enterotoxigénica
- d) *Estafilococo Aureo*
- e) *Shigella*

3) ¿Cuál de los siguientes cereales puede ser tomado libremente por los pacientes con enfermedad celíaca?:

- a) Cebada.
- b) Centeno
- c) Trigo
- d) Arroz
- e) Avena

4) Una paciente de 54 años en tratamiento con levofloxacino por neumonía adquirida en la comunidad, inicia dolor abdominal y diarrea acuosa. La conducta inicial más adecuada es:

- a) Suspender el levofloxacino e iniciar amoxicilina más Ac. clavulánico
- b) Agregar metronidazol al tratamiento antibiótico
- c) Solicitar toxinas de *Clostridium difficile* en heces
- d) Solicita colonoscopia y manejar según hallazgos
- e) Tranquilizar a la paciente y explicarle que es normal presentar diarrea al usar antibióticos de amplio espectro

5) La causa más frecuente de la pancreatitis aguda es:

- a) Hipertrigliceridemia
- b) Transgresión alimentaria
- c) Litiasis biliar
- d) Ingesta alcohólica
- e) Idiopática

6) Paciente de 67 años, fumador, refiere disfagia lórica de 3 meses de evolución, asociado a baja de peso de 7 kg. El examen físico no aporta mayor información. El diagnóstico más probable es:

- a) Acalasia esofágica
- b) Divertículo de Zenker
- c) Cáncer incipiente de esófago
- d) Estenosis esofágica secundaria a RGE
- e) Cáncer esofágico avanzado

7) Mujer de 78 años, hipertensa y portadora de fibrilación auricular crónica, presenta dolor abdominal muy intenso, permanente, de inicio brusco, asociado a náuseas. Al examen físico se palpa abdomen blando, sin signos de irritación peritoneal y RHA aumentados. El diagnóstico más probable es:

- a) Pancreatitis aguda
- b) Colangitis aguda
- c) Embolia mesentérica
- d) Perforación de úlcera péptica

e) Absceso hepático

8) En un paciente con metástasis pulmonares, pero sin afectación hepática, por un carcinoma de origen intestinal. ¿Cuál es la localización más probable del primario?:

- a) Recto
- b) Colon sigmoide
- c) Colon ascendente
- d) Intestino delgado
- e) Estómago

9) El factor pronóstico más importante en el cáncer gástrico es:

- a) El tipo histológico del tumor
- b) El tamaño del tumor
- c) La presencia de adenopatías metastásicas
- d) El grado de invasión transmural del tumor
- e) La presencia de anemia

10) Paciente de 30 años, consulta por vómitos y diarrea acuosa de 2 días de evolución, asociado a dolor abdominal y compromiso del estado general. Al examen se aprecia hidratado, con t° axilar: 37,5° C, FC:83 lpm y PA: 130/80. La conducta más adecuada a seguir es:

- a) Reposición de líquidos por vía oral
- b) Hidratación endovenosa, asociado a ceftriaxona
- c) Antidiarreicos y antiespasmódicos
- d) Hidratación, antibióticos y antidiarreicos orales
- e) Ciprofloxacino 500 mg cada 12 horas por 7 días, asociado a sales de rehidratación oral, según plan A.

11) Paciente de 45 años, con epigastralgia recurrente, especialmente postprandial, que en algunas ocasiones asciende hasta el tórax. Se realiza endoscopia alta que demuestra gastritis antral crónica. Refiere regurgitación ocasional, sin otras molestias. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar pHmetría de 24 horas y actuar según resultado
- b) Realizar tratamiento erradicador de H. pylori
- c) Iniciar medidas generales antirreflujo, asociando tratamiento con omeprazol a dosis estándar
- d) Diagnosticar Dispepsia funcional, educar e iniciar medidas generales
- e) Solicitar ecografía abdominal y actuar según hallazgos

12) Mujer de 33 años, con dolor abdominal abdominal, mayor en fosa iliaca izquierda, de años de evolución, asociado a distensión abdominal y deposiciones frecuentes, de consistencia disminuida, con mucosidad. El diagnóstico más probable es:

- a) Diarrea de origen viral
- b) Síndrome de intestino irritable
- c) Enfermedad celíaca
- d) Colitis ulcerosa
- e) Amebiasis intestinal

13) Una paciente de 24 años presenta desde algún tiempo diarrea con emisión de moco y sangre, y dolor abdominal, sin que existan antecedentes epidemiológicos de interés. ¿Qué diagnóstico sería, entre los siguientes, el más probable y qué exploración realizaría para confirmarlo?:

- a) Diverticulosis y TAC de abdomen y pelvis
- b) Angiodisplasia del colon y colonoscopia
- c) Enfermedad inflamatoria intestinal y colonoscopia
- d) Divertículo de Meckel y gammagrafía con 99Tc pertechnetato
- e) Pólipo colorectal y rectoscopia

14) Ante una mujer de 60 años con antecedentes de un cuadro de malnutrición en la infancia, que presenta una diarrea crónica a lo largo de 4 años con esteatorrea, anemia ferropénica y adelgazamiento progresivo, la causa más probable de su diarrea es:

- a) Enfermedad celíaca
- b) Enfermedad de Crohn
- c) Colitis ulcerosa
- d) Cáncer de Colon
- e) Pancreatitis crónica

15) Mujer de 75 años, hipertensa, con hipercolesterolemia, que hace 2 años fue estudiada por cuadro de diarrea, con colonoscopia, que resultó normal. Acude al servicio de urgencia por cuadro de dolor abdominal de 4 horas de evolución, mayor en hemiabdomen izquierdo, asociados a sudoración y emisión de sangre franca por el ano. La exploración física destaca abdomen doloroso, con leve distensión. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Cáncer de colon
- b) Enfermedad inflamatoria intestinal
- c) Disentería por Shigella
- d) Colitis pseudomembranosa
- e) Colitis isquémica

16) Paciente de 30 años, portador de úlcera gástrica por uso de AINEs, consulta por exacerbación de sus síntomas dolorosos. Desde hace 3 horas el dolor se hace mucho más intenso, irradiándose a dorso y se asocia a hipotensión. Al examen físico destaca abdomen en tabla, muy doloroso, con Blumber (+) y abolición de los ruidos intestinales. ¿Qué examen debe solicitarse como primera aproximación diagnóstica?

- a) Ecografía abdominal
- b) TAC de abdomen y pelvis
- c) Endoscopia digestiva alta de urgencia
- d) Radiografía de abdomen de pie
- e) Colangiografía

17) Paciente de sexo femenino, de 45 años, inicia dolor en Hipocondrio derecho, muy intenso, asociado a fiebre de un día de evolución. La analítica sanguínea muestra Hcto: 42%, G. Blancos: 15.200, GOT: 55, GPT: 48, Bili: 1,7, amilasa normal. La ecografía abdominal muestra vesícula biliar distendida con paredes engrosadas, barro biliar y cálculo de 12 mm de diámetro, impactado en el bacinete. El tratamiento de elección es:

- a) Colectomía laparoscópica de urgencia
- b) Tratamiento antibiótico y colectomía en frío en 10 días
- c) Colangiografía retrógrada endoscópica y descompresión de la vía biliar
- d) Colectomía abierta a la brevedad
- e) Reposición de volumen y antibióticos y evaluación quirúrgica en 3 meses

18) Paciente de 50 años, con cirrosis hepática por alcohol, presenta episodio de hematemesis y melena, asociado a ortostatismo. Al examen en decúbito, destaca FC:101 lpm, PA:110/65 mmHg y conjuntivas pálidas. La medida terapéutica inicial más importante es:

- a) Administrar omeprazol endovenoso
- b) Transfusión de 2 unidades de glóbulos rojos, luego de tomar hematocrito
- c) Endoscopia de urgencia y ligadura de várices esofágicas
- d) Terlipresina endovenosa y sonda de Sengstaken
- e) Reposición de volumen con cristaloides por vía periférica

19) El tratamiento de elección para la infestación intestinal por Giardia lamblia es:

- a) Albendazol
- b) Permetrina
- c) Metronidazol
- d) Ciprofloxacino
- e) Conducta expectante

20) ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a un tratamiento de primera línea para erradicar H. Pylori?

- a) Amoxicilina, claritromicina y omeprazol
- b) Bismuto coloidal, tetraciclina y metronidazol
- c) Bismuto coloidal, tetraciclina, metronidazol y omeprazol
- d) Famotidina, claritromicina y omeprazol
- e) Omeprazol, bismuto coloidal y amoxicilina

Prueba 2

1) Un paciente de 44 años presenta dolor abdominal epigástrico intenso, constante, de 24 horas de evolución, asociado a vómitos alimentarios en varias oportunidades. Se aprecia muy adolorido, sudoroso, taquicárdico, con tendencia a la hipotensión. Se observa un área de equimosis periumbilical. El abdomen es blando, doloroso a la palpación, con signos de irritación peritoneal y disminución marcada de los ruidos hidroaéreos. El diagnóstico más probable es:

- a) Embolia mesentérica
- b) Trombosis de vena mesentérica
- c) Estallido hepático
- d) Perforación de úlcera péptica
- e) Pancreatitis aguda

2) Un paciente consulta por dolor epigástrico fluctuante, de carácter urente, que suele ser más intenso en los períodos de ayunas. El examen físico es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar tratamiento con omeprazol
- b) Realizar erradicación de *Helicobacter pylori*
- c) Solicitar pH-metría esofágica
- d) Solicitar endoscopia digestiva alta
- e) Realizar educación y controlar en un mes

3) Un paciente consulta por diarrea de 4 semanas de evolución, asociado a baja de peso. Refiere que en otras oportunidades ha presentado cuadros similares. Refiere que sus deposiciones son abundantes, con gotas de grasa. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar colonoscopia
- b) Solicitar test de Sudán en deposiciones
- c) Iniciar dieta sin gluten
- d) Solicitar test de D-xilosa
- e) Solicitar endoscopia digestiva alta

4) Un paciente de 32 años presenta cuadro de diarrea, de 24 horas de evolución, asociada a dolor abdominal tipo cólico y fiebre hasta 38°C. Su esposa tiene síntomas similares, pero menos intensos. Al examen se aprecia en buenas condiciones generales, con signos vitales normales, hidratado. El abdomen se palpa blando, depresible, con aumento de los ruidos hidroaéreos. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar sales de rehidratación oral y antibióticos
- b) Indicar ingesta de líquidos abundantes y antiespasmódicos en caso de dolor
- c) Indicar ingesta abundante de líquidos e iniciar antidiarreicos, antiespasmódicos y antibióticos
- d) Indicar hidratación oral, antidiarreicos y antiespasmódicos en caso de dolor
- e) Indicar hidratación oral y solicitar coprocultivo

5) Una paciente consulta por cuadro de dolor en hipocondrio derecho intenso, asociado a vómitos alimentarios en 4 oportunidades. Se encuentra en buenas condiciones, y en su examen físico destaca dolor al palpar la zona, sin irritación peritoneal. Se solicita ecografía abdominal que demuestra vesícula biliar con paredes edematosas y de grosor aumentado y barro biliar, con visualización de un cálculo de 2 cm, impactado en el bacinete. La amilasa y pruebas hepáticas son normales. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar analgésicos y realizar colecistectomía laparoscópica bajo cobertura antibiótica, de inmediato
- b) Iniciar antibióticos endovenosos de amplio espectro y programar colecistectomía para 15 días más
- c) Administrar suero fisiológico, antibióticos y antiespasmódicos y solicitar colangiopancreatografía retrógrada endoscópica
- d) Iniciar analgésicos endovenosos e indicar régimen cero
- e) Iniciar antiespasmódicos y AINEs e indicar régimen estricto sin grasas

6) ¿Cuál de las siguientes medidas aconsejaría a un paciente con reflujo gastroesofágico?

- a) Evitar usar hipnóticos
- b) Beber agua antes de dormir
- c) Erradicar *Helicobacter pylori*, si es que lo porta
- d) Inclinar la cama, de modo que los pies quede más altos que la cabeza
- e) Beber moderadas cantidades de alcohol junto con las comidas

7) Un paciente de 35 años presenta dolor abdominal y vómitos. En sus exámenes destaca una elevación importante de la lipasa plasmática. La ecografía abdominal y las pruebas hepáticas son normales. Está en buenas condiciones pero adolorido. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar régimen cero e iniciar analgesia e hidratación endovenosa
- b) Iniciar AINEs y antibióticos de amplio espectro, con régimen hídrico
- c) Indicar régimen cero y solicitar colangiografía retrógrada
- d) Solicitar resonancia magnética nuclear de abdomen y pelvis
- e) Resolver quirúrgicamente

8) Respecto a los divertículos esofágicos es FALSO que:

- a) El divertículo de Zenker se produce por un mecanismo de pulsión
- b) Los divertículos distales suelen tratarse con resección del divertículo más esfinterotomía esofágica inferior
- c) Se diagnostican mediante endoscopia
- d) Se presentan con disfagia, regurgitación no ácida y en algunas ocasiones aspiración
- e) Los divertículos del cuerpo esofágico suelen ser asintomáticos

9) ¿Qué alimento puede consumir libremente un paciente con enfermedad celíaca?

- a) Embutidos
- b) Arroz
- c) Galletas
- d) Tortas
- e) Cerveza

10) Una paciente de 24 años presenta dolor abdominal y diarrea de 4 meses de evolución. En el último tiempo ha empeorado, siendo muy frecuente y volviéndose disenterica. Refiere además sensación febril y baja de peso de 5 Kg, desde que iniciaron los síntomas. Al examen físico está pálida, con un abdomen blando y depresible, sensible de manera difusa, sin signos de irritación peritoneal. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar colonoscopia
- b) Iniciar ciprofloxacino oral
- c) Iniciar metronidazol oral
- d) Iniciar corticoides orales
- e) Solicitar parasitológico de deposiciones y coprocultivo

11) Una paciente de 30 años presenta un cuadro de diarrea de larga data, asociada a distensión y malestar abdominal. Las deposiciones son blandas de color normal, con mucosidad, pero sin sangre ni alimentos sin digerir. Refiere que ha subido 3 Kg de peso en el último año. El examen físico no aporta mayor información. El diagnóstico más probable es:

- a) Colitis viral
- b) Colitis bacteriana
- c) Enfermedad celíaca
- d) Colitis ulcerosa
- e) Colopatía funcional

12) El objetivo del tratamiento erradicador de Helicobacter pylori, en los pacientes con úlcera péptica, es:

- a) Acelerar la cicatrización
- b) Disminuir el riesgo de cáncer gástrico
- c) Disminuir las recurrencias de la úlcera
- d) Prevenir las hemorragias
- e) Paliar los síntomas

13) Un paciente de 33 años inicia cuadro de disfagia, de localización baja, con síntomas intermitentes y que se relacionan tanto con la ingesta de líquidos, como de sólidos. En algunas oportunidades presenta regurgitación no ácida. El examen físico es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar endoscopia digestiva alta
- b) Solicitar manometría esofágica
- c) Solicitar pH-metría esofágica de 24 horas
- d) Iniciar tratamiento con omeprazol
- e) Solicitar radiografías baritadas

14) Un paciente con cirrosis hepática por consumo de alcohol, presenta hematemesis, seguida de ortostatismo. Al examen físico se aprecia pálido, con FC: 88x', PA: 110/70, T°: 36,4°C, abdomen blando depresible, con ascitis clínica moderada. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar cristaloides y omeprazol endovenosos
- b) Reponer la volemia con suero fisiológico y realizar transfusión de glóbulos rojos
- c) Administrar coloides endovenosos y solicitar endoscopia digestiva alta
- d) Administrar suero fisiológico y terlipresina por vía endovenosa y solicitar endoscopia digestiva alta
- e) Administrar cristaloides y glóbulos rojos y solicitar hemograma y endoscopia digestiva alta

15) Un paciente de 55 años, previamente sano, presenta constipación desde hace 3 semanas, con deposiciones pequeñas que en un par de ocasiones han mostrado estrías de sangre. No refiere otros síntomas y el examen físico es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar test de sangre oculta en deposiciones
- b) Solicitar ecografía abdominal
- c) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
- d) Solicitar colonoscopia
- e) Iniciar dieta rica en fibra y controlar en 7 días

16) La complicación más frecuente del cáncer de colon es:

- a) Hemorragia digestiva
- b) Perforación
- c) Fístulas
- d) Obstrucción
- e) Infección

17) Un paciente de 60 años, sin antecedentes de importancia, presenta cuadro de vómitos postprandiales abundantes, que suceden algunos minutos después de ingerir alimentos. Refiere que los síntomas iniciaron hace 4 meses, pero que se han vuelto cada vez más intensos, vomitando incluso luego de ingerir pequeñas cantidades de alimentos. El diagnóstico más probable es:

- a) Pancreatitis crónica
- b) Cáncer esofágico
- c) Cáncer gástrico
- d) Gastritis crónica atrófica
- e) Divertículos esofágicos

18) Una mujer de 66 años presenta un cuadro de dolor abdominal constante e intenso en la fosa ilíaca izquierda, de 7 horas de evolución. Al examen tiene un abdomen blando depresible, doloroso, con signos de Blumberg en la zona. Le mejor alternativa para evaluar a esta paciente es:

- a) Hemograma y PCR
- b) Ecografía abdominal
- c) TAC
- d) Colonoscopia
- e) Explorar quirúrgicamente

19) La causa más frecuente de hemorragia digestiva baja es:

- a) Angiodisplasias
- b) Cáncer de colon
- c) Enfermedad diverticular
- d) Pólipos de colon
- e) Colitis isquémica

20) Un paciente de 45 años, con antecedente de colecistectomía hace 5 años, consulta por un cuadro de dolor abdominal intenso, tipo cólico, asociado a vómitos alimentarios y distensión abdominal. Al examen físico se aprecia en buenas condiciones generales, con abdomen doloroso difuso y aumento de la intensidad de los ruidos hidroaéreos, sin signos peritoneales. El diagnóstico más probable es:

- a) Pancreatitis aguda
- b) Coledocolitiasis residual
- c) Colitis isquémica
- d) Obstrucción intestinal por bridas
- e) Gastroenteritis aguda

Prueba 3

1) ¿Cuál de las siguientes alternativas es compatible con un paciente con infección crónica por el virus de la hepatitis B?

- a) VHBsAg (-), Inmunoglobulinas Anti-VHBs totales (-), IgM anticore (-), Inmunoglobulinas anticore totales (+)
- b) VHBsAg (+), Inmunoglobulinas Anti-VHBs totales (-), IgM anticore (+), Inmunoglobulinas anticore totales (+)
- c) VHBsAg (-), Inmunoglobulinas Anti-VHBs totales (+), IgM anticore (-), Inmunoglobulinas anticore totales (+)
- d) VHBsAg (+), Inmunoglobulinas Anti-VHBs totales (-), IgM anticore (-), Inmunoglobulinas anticore totales (+)
- e) VHBsAg (-), Inmunoglobulinas Anti-VHBs totales (+), IgM anticore (-), Inmunoglobulinas anticore totales (-)

2) ¿Cuál de las siguientes alteraciones supone una mayor gravedad en un paciente con hepatitis aguda por virus A?

- a) Transaminasas sobre 2000 UI/L
- b) Tiempo de protrombina prolongado
- c) Bilirrubina sobre 5 mg/dl
- d) Dolor abdominal
- e) Acolia

3) Una paciente de 33 años asintomática presenta elevación de las transaminasas en exámenes de chequeo, con GOT: 80 UI/l y GPT: 92 UI/l. La bilirrubina, GGT y fosfatasas alcalinas son normales. Presenta ferritina de 360 ng/ml (VN: 50-150 ng/ml). Al examen físico destaca hepatomegalia de 3 cm bajo el reborde costal y obesidad moderada a severa. La ecografía abdominal demuestra aumento de la ecogenicidad hepática. El diagnóstico más probable es:

- a) Hemocromatosis
- b) Hepatitis viral
- c) Esteatohepatitis no alcohólica
- d) Hepatitis autoinmune
- e) Cirrosis hepática

4) Un paciente presenta una erisipela en la pierna derecha. El tratamiento de elección es:

- a) Cloxacilina
- b) Ceftriaxona
- c) Gentamicina
- d) Imipenem
- e) Levofloxacin

5) Un paciente cirrótico por consumo de alcohol ingresa por desorientación y fiebre. Al examen se constata ascitis moderada, ictericia y asterixis. Se decide realizar paracentesis diagnóstica, que da salida a líquido amarillo, transparente, con recuento celular de 490 células por mm³, con 90% polimorfonuclear. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar evaluación por cirujano.
- b) Realizar paracentesis evacuadora, asociada a antibióticos endovenosos.
- c) Iniciar Cefotaximo, sin evacuar la ascitis
- d) Administrar lactulosa, a fin de lograr 2 a 3 deposiciones diarias
- e) Administrar cristaloides endovenosos, asociados a terlipresina

6) ¿Cuál de las siguientes asociaciones entre la patología y cuadro clínico es INCORRECTA?

- a) Mujer de 45 años con astenia, prurito, elevación marcada de las fosfatasas alcalinas y discreto de la GGT y bilirrubina – Cirrosis biliar primaria
- b) Mujer de 40 años con un patrón colestásico en las pruebas hepáticas y anticuerpos antimitocondriales positivos (AMA) – Cirrosis biliar primaria
- c) Mujer de 50 años, previamente sana, con elevación cónica de las transaminasas, serologías virales negativas y positividad de los anticuerpos anti-músculo liso – Hepatitis autoinmune
- d) Hombre de 50 años, con antecedentes de enfermedad de Cröhn, con elevación de la bilirrubina, GGT y fosfatasas alcalinas y AMA negativos – colangitis esclerosante primaria
- e) Mujer de 40 años con astenia e ictericia, que presenta un patrón hepatítico en las pruebas hepáticas y positividad de los anticuerpos antinucleares – Colangitis esclerosante primaria

7) El tratamiento de la ascitis a tensión, en un paciente con asterixis, en el que se ha descartado la presencia de peritonitis bacteriana espontánea es:

- a) Espironolactona + furosemida en dosis altas
- b) Hemodiálisis
- c) Paracentesis evacuadora más reposición de albúmina
- d) Vasoconstrictores endovenosos (noradrenalina)
- e) Instalación de un TIPS

8) Un paciente de 55 años, con daño hepático crónico por consumo de alcohol, se realiza endoscopia como examen de control, que demuestra presencia de várices esofágicas grandes, con signos rojos. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar terlipresina
- b) Instalar un TIPS
- c) Iniciar propranolol
- d) Realizar ligadura de várices
- e) Iniciar octeotride

9) Paciente cirrótico de 48 años, bebedor excesivo activo, consulta por fiebre de hasta 37.6°C, intenso compromiso del estado general, dolor abdominal alto, vómitos profusos, diarrea fugaz y coluria. Al examen: ictericia marcada, decaimiento, bradipsiquia, dolor en abdomen superior, hepatomegalia sensible y ascitis mínima.

Laboratorio: Bilirrubina 7 mg/dl, transaminasa pirúvica 110 U, transaminasa oxalacética 250 U, gammaglutamiltranspeptidasa 600 U y 12.000 leucocitos/mm³ en el hemograma. El diagnóstico más probable es:

- a) Trombosis de la vena porta
- b) Hepatocarcinoma con necrosis central
- c) Peritonitis bacteriana espontánea.
- d) Hepatitis viral
- e) Hepatitis alcohólica

10) Un paciente de 58 años presenta al mismo tiempo una neumonía neumocócica y una infección urinaria por Escherichia coli sensible. ¿Qué tratamiento antibiótico sería más recomendable?

- a) Ciprofloxacino
- b) Ceftriaxona
- c) Metronidazol
- d) Moxifloxacino
- e) Gentamicina

11) El tratamiento de elección de las infecciones por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina es:

- a) Ceftriaxona
- b) Clindamicina
- c) Cefazolina
- d) Vancomicina
- e) Flucloxacilina

12) Un paciente de 30 años, asintomático, presenta en su analítica general niveles plasmáticos de bilirrubina de 2,1 mg/dl, de predominio no conjugado, con transaminasas, GGT y FA normales. El examen físico sólo destaca tinte subictérico de piel y escleras. La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio, explicando el carácter benigno de su condición
- b) Solicitar serologías virales
- c) Solicitar ANA, AMA, ANCA y ASMA
- d) Solicitar ecografía abdominal
- e) Prohibir el consumo de alcohol y controlar con nuevas pruebas hepáticas en 3 meses

13) Un paciente cirrótico por virus B, es traído por sus familiares, ya que presenta desorientación y bradipsiquia, sin otros síntomas. Refieren que habría presentado algunos episodios similares. Al examen se observa inatento, icterico, con asterixis, sin signos focales. Se aprecia ascitis moderada, la que se punciona. El tacto rectal es normal. Se solicitan exámenes entre los que destacan hemograma y sedimento de orina normal, trasaminasas normales, bilirrubina 3,1 y elevación del amonio. La paracentesis diagnóstica descarta una peritonitis bacteriana. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar lactulosa
- b) Solicitar punción lumbar
- c) Iniciar antipsicóticos típicos
- d) Enviar a domicilio con régimen hídrico y controlar en 48 horas
- e) Iniciar corticoides orales

14) Un paciente con cirrosis hepática por consumo de alcohol, presenta hematemesis, seguida de ortostatismo. Al examen físico se aprecia pálido, con FC: 88x', PA: 110/70, T°: 36,4°C, abdomen blando depresible, con ascitis clínica moderada. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar cristaloides y omeprazol endovenosos
- b) Reponer la volemia con suero fisiológico y realizar transfusión de glóbulos rojos
- c) Administrar coloides endovenosos y solicitar endoscopia digestiva alta
- d) Administrar suero fisiológico y terlipresina por vía endovenosa y solicitar endoscopia digestiva alta
- e) Administrar cristaloides y glóbulos rojos y solicitar hemograma y endoscopia digestiva alta

15) Un paciente de 65 años, con antecedente de leucemia linfática crónica, inicia un cuadro caracterizado por dolor abdominal, náuseas, vómitos, orinas oscuras e ictericia. El examen físico no aporta mayor información. Se solicitan pruebas hepáticas que demuestran GOT: 40UI/L, GPT:44UI/L, GGT: 35UI/L, FA: 98UI/L, Bilirrubina total: 4,3 mg/dl, Bilirrubina directa 0,7 mg/dl, LDH: 980 UI/L. El diagnóstico más probable es:

- a) Hepatitis aguda por virus A
- b) Hepatitis autoinmune
- c) Síndrome de Gilbert
- d) Hemólisis
- e) Colédocolitiasis

16) El hepatocarcinoma se asocia a cirrosis hepática de distintas etiologías. ¿Qué marcador serológico se suele elevar en los pacientes con este tipo de tumor?

- a) Ca 19.9
- b) Ca 125
- c) Alfégeno carcinoembrionario
- d) Alfafetoproteína
- e) Ferritina decarboxilada

17) Un paciente con leucemia se realiza quimioterapia, evolucionando con una marcada neutropenia. Al 5 día post-quimioterapia presenta fiebre hasta 39°C. Usted sabe que la mayoría de las infecciones bacterianas en los pacientes neutropénicos febriles es causada por Pseudomona aureginosa y que de manera empírica debe ser tratado con doble cobertura para esta bacteria. ¿Qué combinación de antibióticos es más adecuada?

- a) Ceftriaxona + gentamicina
- b) Piperacilina + vancomicina
- c) Ciprofloxacino + metronidazol
- d) Levofloxacino + clindamicina
- e) Ceftazidina + ampicacina

18) Un paciente de realiza ecografía abdominal, como parte del estudio de un cuadro de dolor abdominal crónico. Se observa una lesión hepática redondeada, de 2 cm, hiperecogénica, homogénea, sin bordes y con refuerzo posterior, localizada en el lóbulo derecho. La conducta más adecuada, respecto a este hallazgo, es:

- a) Observar
- b) Iniciar albendazol
- c) Solicitar TAC abdominal con contraste
- d) Realizar punción bajo ecografía
- e) Realizar resección quirúrgica de la lesión

19) ¿Cuál de los siguientes es un mejor marcador de consumo de alcohol?

- a) Bilirrubina
- b) Hematocrito
- c) Gamaglutamil transferasa (GGT)
- d) Transaminasa pirúvica (GPT)
- e) Acetaldehído

20) ¿Cuál de los siguientes antibióticos es preferible en el tratamiento de una infección urinaria baja afebril?

- a) Cloxacilina
- b) Cefadroxilo
- c) Amoxicilina más ácido clavulánico
- d) Clindamicina
- e) Metronidazol

Prueba 4

1) Un paciente de 24 años presenta un cuadro de dolor abdominal y deposiciones diarreicas de 6 semanas de evolución, que en algunas ocasiones han sido sanguinolentas. Refiere que ha bajado 4 kg de peso desde el inicio de los síntomas y presenta sensación febril ocasional. En esos días además presentó un absceso perianal que fue drenado quirúrgicamente. El diagnóstico más probable es:

- a) Colitis viral
- b) Colitis bacteriana
- c) Colitis por parásitos
- d) Colitis ulcerosa
- e) Enfermedad de Cröhn

2) Un paciente en tratamiento con ibuprofeno por artrosis, inicia de manera brusca lipotimias, con marcado ortostatismo. En una ocasión además presenta deposiciones negras de muy mal olor. Al examen físico se observa pálido y el tacto rectal demuestra melena. La primera medida a realizar es:

- a) Realizar endoscopia digestiva alta
- b) Administrar omeprazol endovenoso
- c) Realizar transfusión de glóbulos rojos
- d) Solicitar hemograma
- e) Administrar cristaloides endovenosos

3) Un paciente de 66 años presenta un cuadro de constipación marcada de 3 días de evolución, sin poder presentar deposiciones, asociado a dolor abdominal. Luego presenta deposiciones diarreicas explosivas en una oportunidad. Refiere además historia de palidez y molestias abdominales de 1 mes de evolución. El examen físico muestra un paciente pálido, con abdomen blando, depresible y el tacto rectal demuestra una ampolla rectal sin deposiciones, sin hallar otras alteraciones. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Vólvulo de colon sigmoides
- b) Cáncer de colon
- c) Obstrucción intestinal por bridas
- d) Síndrome de Ogilvie
- e) Diverticulitis

4) Un paciente de 30 años, previamente sano, presenta dolor epigástrico intenso, constante, irradiado al dorso y acompañado de vómitos alimentarios en varias oportunidades. Presenta FC: 97x', t°: 36,9°C, PA: 120/80 mmHg. El examen abdominal demuestra dolor a la palpación epigástrica, ruidos hidroaéreos presentes y ausencia de signos de irritación peritoneal. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar analgésicos y solicitar radiografía simple de abdomen y pelvis
- b) Administrar suero fisiológico, analgésicos y antibióticos endovenosos
- c) Administrar analgesia y solicitar ecografía abdominal, hemograma y lipasa plasmática
- d) Administrar analgesia y solicitar un TAC de abdomen y pelvis
- e) Realizar laparotomía exploradora

5) Un paciente cursa con una hepatitis aguda por virus B. ¿Cómo esperarías encontrar los marcadores virales?

- a) Antígeno VHBs(+), anticuerpos anti-VHBs(-), IgM anticore(+)
- b) Antígeno VHBs(+), anticuerpos anti-VHBs(+), IgM anticore(-)
- c) Antígeno VHBs(-), anticuerpos anti-VHBs(+), IgM anticore(+)
- d) Antígeno VHBs(+), anticuerpos anti-VHBs(-), IgM anticore(-)
- e) Antígeno VHBs(-), anticuerpos anti-VHBs(-), IgM anticore(+)

6) ¿Cuál es el tratamiento de elección para la ascitis moderada, no complicada, en un paciente cirrótico por consumo de alcohol?

- a) Dieta
- b) Espironolactona y furosemina
- c) Albúmina endovenosa
- d) Paracentesis periódicas
- e) Instalación de un TIPS (Shunt portosistémico)

7) Un paciente celíaco puede consumir libremente todo lo que se nombra a continuación, EXCEPTO:

- a) Ensalada de frutas
- b) Miel de abeja
- c) Atún enlatado
- d) Cereal de maíz
- e) Pan de centeno

8) Un paciente de 23 años consulta por epigastralgia de larga data, que aparece especialmente después de comer. El examen físico es normal. Se solicita endoscopia digestiva alta que demuestra una esofagitis distal lineal, compatible con reflujo gastroesofágico. La conducta más adecuada, de entre las siguientes, es:

- a) Iniciar omeprazol
- b) Realizar tratamiento erradicador para *Helicobacter pylori*
- c) Solicitar pH-metría esofágica de 24 horas
- d) Solicitar manometría esofágica
- e) Diagnosticar dispepsia funcional y realizar educación

9) La causa más frecuente de elevación persistente de las transaminasas en Chile es:

- a) Alcohol
- b) Hepatitis B
- c) Hepatitis C
- d) Esteatosis hepática
- e) Autoinmune

10) ¿Cuál de las siguientes historias clínicas es más compatible con el cuadro clínico característico de la cirrosis biliar primaria?

- a) Mujer de 40 años, con astenia y prurito, con elevación marcada de las fosfatasa alcalinas y discreta de la bilirrubina
- b) Hombre de 60 años, con ictericia y presencia de ANCA
- c) Mujer de 60 años, con antecedente de vitiligo, con elevación persistente de transaminasas, sin hábitos tóxicos y con serología viral negativa
- d) Mujer de 30 años con ictericia fluctuante, de predominio indirecto y elevación de la GGT y fosfatasa alcalinas, con GOT y GPT normales
- e) Hombre de 60 años con ictericia, coluria y acolia, asociado a baja de peso

11) El síntoma preponderante en la acalasia esofágica es:

- a) Regurgitación de alimentos ácidos
- b) Disfagia lórica de instalación progresiva
- c) Dolor retroesternal durante la deglución
- d) Dificultad para tragar líquidos y sólidos, de curso fluctuante
- e) Sensación de cuerpo extraño, de localización esofágica alta

12) Un paciente de 60 años, sin antecedentes de importancia, presenta cuadro de vómitos postprandiales abundantes, que suceden algunos minutos después de ingerir alimentos. Refiere que los síntomas iniciaron hace 4 meses, pero que se han vuelto cada vez más intensos, vomitando incluso luego de ingerir pequeñas cantidades de alimentos. El diagnóstico más probable es:

- a) Pancreatitis crónica
- b) Cáncer esofágico
- c) Cáncer gástrico
- d) Gastritis crónica atrófica
- e) Divertículos esofágicos

13) Un paciente cirrótico por consumo de alcohol ingresa por desorientación y fiebre. Al examen se constata ascitis moderada, ictericia y asterixis. Se decide realizar paracentesis diagnóstica, que da salida a líquido amarillo, transparente, con recuento celular de 490 células por mm³, con 90% polimorfonuclear. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar evaluación por cirujano.
- b) Realizar paracentesis evacuadora, asociada a antibióticos endovenosos.
- c) Iniciar Cefotaximo, sin evacuar la ascitis
- d) Administrar lactulosa, a fin de lograr 2 a 3 deposiciones diarias
- e) Administrar cristaloides endovenosos, asociados a terlipresina

14) Un paciente de 30 años, consulta por un cuadro de algunos años de evolución, de dolor abdominal tipo cólico, intermitente, asociado a distensión abdominal. Refiere tránsito intestinal lento, con deposiciones duras, cada 4 a 5 días. En el último tiempo los síntomas se han vuelto más frecuentes, lo que lo tiene intranquilo. El examen físico resulta normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Obstrucción intestinal
- b) Enfermedad celíaca
- c) Síndrome de intestino irritable
- d) Colitis ulcerosa
- e) Cáncer de colon

15) Un niño de 2 años presenta diarrea acuosa abundante, de 3 días de evolución, con cerca de 12 deposiciones diarias. También presentó fiebre hasta 38°C durante los primeros días. En las últimas horas se agrega irritabilidad importante. Al examen físico presenta signos vitales normales, llora sin lágrimas y toma líquidos ávidamente. La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio con rehidratación oral según plan A
- b) Solicitar coprocultivo y Elisa para rotavirus en heces y reponer volumen por sonda nasointestinal
- c) Indicar sales de rehidratación oral, 100 cc/Kg, a tomar en 4 horas y reevaluar
- d) Indicar sales de rehidratación, luego de cada deposición y antibióticos por vía oral
- e) Administrar bolo de suero fisiológico endovenoso

16) Un paciente inicia diarrea acuosa y dolor abdominal cólico, 2 días después de completar un tratamiento antibiótico con amoxicilina, debido a una neumonía adquirida en la comunidad. Se solicitan toxinas de Clostridium difficile en heces, las que resultan positivas. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar coprocultivo y decidir manejo según resultado
- b) Iniciar metronidazol oral
- c) Iniciar clindamicina oral
- d) Reiniciar la amoxicilina, agregando ácido clavulánico
- e) Iniciar rehidratación oral, sin necesidad de iniciar antibióticos

17) Un paciente presenta pirosis frecuente, luego de comer, especialmente cuando come antes de ir a dormir. También refiere regurgitación ácida de alimentos, varias veces por semana. El examen físico es normal. La conducta más adecuada es;

- a) Indicar medidas generales antireflujo e iniciar un inhibidor de la bomba de protones
- b) Solicitar una Ph-metría esofágica
- c) Prohibir el consumo de los alimentos que le producen los síntomas y controlar en 4 semanas
- d) Solicitar endoscopia digestiva alta
- e) Solicitar manometría esofágica e iniciar bloqueadores H₂

18) Un paciente de 60 años presenta emisión de deposiciones mezcladas con sangre en dos ocasiones en el mismo día, sin embargo las deposiciones se normalizan en los días siguientes. No ha presentado otros síntomas y el examen físico no aporta mayor información. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar prueba de hemorragias ocultas
- b) Realizar colonoscopia
- c) Solicitar antígeno carcinoembrionario
- d) Solicitar ecografía abdominal
- e) Observar y controlar en un mes

19) El tratamiento de la úlcera duodenal no complicada suele ser:

- a) Omeprazol a permanencia
- b) Antibióticos e inhibidores de la bomba de protones por 10 días
- c) Antiinflamatorios no esteroideos
- d) Inyectoterapia endoscópica
- e) Quirúrgico

20) El factor pronóstico más importante en el cáncer gástrico es:

- a) El tipo histológico del tumor
- b) El tamaño del tumor
- c) La presencia de adenopatías metastásicas
- d) El grado de invasión transmural del tumor
- e) La presencia de anemia

Prueba 5 (GASTROENTEROLOGÍA + NEFROLOGÍA)

1) Un paciente de 62 años, con antecedente de cirrosis hepática por consumo de alcohol, de larga data, en tratamiento con dosis altas de furosemida y espironolactona. Consulta por aumento del perímetro abdominal, asociado a disnea. Al examen se observa ascitis a tensión. Se realiza paracentesis diagnóstica, que da salida a líquido citrino, cuyo análisis demuestra proteínas: 1,7g/dl y glóbulos blancos: 50 por mm³, con 80% de polimorfonucleares. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar diuréticos de asa por vía endovenosa
- b) Iniciar cefalosporinas de tercera generación por vía endovenosa, sin drenar el líquido ascítico
- c) Instalar un TIPS
- d) Drenar el líquido ascítico, con reposición de albúmina
- e) Drenar el líquido ascítico, bajo cobertura antibiótica, con cefalosporinas de tercera generación

2) La insuficiencia renal aguda prerrenal se caracteriza por:

- a) Sodio urinario elevado y osmolaridad urinaria elevada
- b) Sodio urinario elevado y osmolaridad urinaria disminuida
- c) Sodio urinario disminuido y osmolaridad urinaria elevada
- d) Sodio urinario disminuido y osmolaridad urinaria disminuida
- e) Sodio urinario disminuido y osmolaridad urinaria normal

3) Un paciente con antecedente de daño hepático crónico por hepatitis viral crónica presenta hematemesis, asociada a ortostatismo. Al examen físico se encuentra taquicárdico con presión arterial de 100/60 mmHg. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar omeprazol endovenoso y terlipresina y realizar endoscopia digestiva algunos días después de estabilizar al paciente
- b) Solicitar hematocrito y decidir transfusión según resultado
- c) Administrar cristaloides endovenosos y realizar endoscopia digestiva alta de urgencia
- d) Administrar cristaloides y betabloqueantes por vía endovenosa
- e) Realizar transfusión de glóbulos rojos y solicitar endoscopia digestiva alta

4) ¿Cuál de las siguientes opciones no es un efecto adverso de los diuréticos de asa?

- a) Hiponatremia
- b) Hipokalemia
- c) Hipercalemia
- d) Hiperglicemia
- e) Dislipidemia

5) La etiología más común del hígado graso es:

- a) Consumo de alcohol
- b) Resistencia a la insulina
- c) Viral
- d) Dieta rica en grasas
- e) Herencia autosómica dominante

6) Un paciente de 48 años, diabético tipo 2, tratado con metformina y glibenclamida, presenta presión arterial cercana a 165/100 en tres mediciones distintas. El examen físico no aporta mayor información y sus exámenes previos de función renal y electrocardiograma son normales. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar dieta hiposódica y ejercicios y controlar en 3 meses
- b) Iniciar dieta, ejercicios y un diurético tiazídico
- c) Indicar dieta, ejercicios y un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina
- d) Indicar dieta, ejercicios, un antagonista del calcio y una estatina
- e) Solicitar ecografía doppler renal, aldosteronemia, actividad de renina plasmática y metanefrinas urinarias

7) Un paciente de 26 años consulta por dispepsia de algunas semanas de evolución, sin otros síntomas. Las molestias suelen ser mayores después de comer. Se realiza ecografía digestiva alta que demuestra esofagitis grado 2, mayor en el esófago distal, sin alteraciones gástricas ni duodenales. La biopsia sólo muestra signos inflamatorios. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar pHmetría de 24 horas
- b) Resolver quirúrgicamente
- c) Iniciar antiácidos luego de cada comida y realizar nueva endoscopia digestiva en un mes
- d) Iniciar omeprazol a dosis estándar
- e) Indicar tratamiento de erradicación de *Helicobacter pylori*

8) ¿Qué antibióticos indicaría para el tratamiento de una pielonefritis aguda de manejo ambulatorio?

- a) Nitrofurantoína o ciprofloxacino
- b) Ciprofloxacino o cefadroxilo
- c) Cefadroxilo o gentamicina
- d) Nitrofurantoína, ciprofloxacino o cefadroxilo
- e) Gentamicina, nitrofurantoína o amoxicilina más ácido clavulánico

9) Un paciente de 45 años consulta por dolor abdominal intenso, asociado a vómitos. Al examen físico se observa en buenas condiciones generales, hidratado y bien perfundido, con actitud de dolor. El abdomen es blando y depresible, pero muy doloroso, especialmente a la palpación epigástrica. Se solicitan exámenes que demuestran, hematocrito: 39%, blancos: 15.000, plaquetas: 250.000, VHS: 60 mm/h, bilirrubina: 1,5, mg/dl, GOT: 40, GPT: 44, fosfatasas alcalinas: 160, amilasa: 456, lipasa: 551, sodio: 133, cloro: 100, potasio: 4,3, BUN: 26 y creatinina: 1,2. La ecografía abdominal sólo demuestra colelitiasis múltiple, con 4 cálculos de tamaño menor a 6mm. La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio con régimen liviano y antibióticos orales de amplio espectro
- b) Enviar a domicilio con régimen hídrico y analgésicos orales
- c) Hospitalizar, indicar régimen cero, hidratación endovenosa y analgesia
- d) Hospitalizar, hidratar por vía endovenosa e iniciar antibióticos de amplio espectro y analgésico
- e) Resolver quirúrgicamente de inmediato

10) Un paciente de 58 años, diabético tipo 2, de larga data, mal controlado, consulta por aparición de edema generalizado y orinas espumosas. Al examen se observa edema facial, de extremidades inferiores y moderada ascitis. Se solicitan exámenes donde destaca hematocrito: 35%, blancos: 6.700, plaquetas: 204.000, creatinina: 1,1, BUN: 20, albuminemia: 2,0, bilirrubina: 0,6 y transaminasas normales. Los exámenes de orina demuestran proteinuria de 24 horas de 5 g/24 horas, sin hematuria.

El diagnóstico más probable es:

- a) Nefrosis lipóidea
- b) Insuficiencia renal crónica
- c) Nefropatía membranosa
- d) Síndrome hepatorenal
- e) Glomeruloesclerosis focal y segmentaria

11) La resección del íleon distal produce malabsorción de:

- a) Vitamina B12 y ácidos biliares
- b) Hierro y calcio
- c) Grasas y polipéptidos
- d) Vitaminas hidrosolubles
- e) Polisacáridos

12) ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a los gases esperables en un paciente con pérdidas de bicarbonato por diarrea?

- a) pH: 7,26; pCO₂: 27 mmHg; HCO₃: 13 mEq/l
- b) pH: 7,40; pCO₂: 40 mmHg; HCO₃: 24 mEq/l
- c) pH: 7,16; pCO₂: 67 mmHg; HCO₃: 26 mEq/l
- d) pH: 7,32; pCO₂: 63 mmHg; HCO₃: 29 mEq/l
- e) pH: 7,46; pCO₂: 48 mmHg; HCO₃: 32 mEq/l

13) Un paciente de 69 años, con antecedente de artrosis de caderas, en tratamiento con paracetamol e ibuprofeno, consulta por un cuadro de deposiciones negras de olor intenso. Al examen físico se observa en buenas condiciones generales, con signos vitales normales. El tacto rectal demuestra melena. El diagnóstico más probable es:

- a) Úlcera péptica
- b) Mallory Vice
- c) Cáncer gástrico
- d) Várices esofágicas
- e) Gastritis crónica

14) ¿Cuál de las siguientes alteraciones aparece más precozmente en la evolución de la insuficiencia renal crónica?

- a) Elevación de la paratohormona
- b) Acidosis
- c) Hiperkalemia
- d) Frotos pericárdicos
- e) Hipocalcemia

15) Una paciente de 25 años, presenta diarrea intermitente, desde hace 3 meses, asociado a distensión abdominal y dolor abdominal tipo cólico. Las deposiciones son blandas, con mucosidad, sin esteatorrea ni sangre. En el examen físico se observa en buenas condiciones generales, con signos vitales normales y destaca un abdomen blando, sensible mayor en hipogastrio, sin irritación peritoneal, con ruidos hidroaéreos presentes. La causa más probable de la diarrea es:

- a) Viral
- b) Bacteriana
- c) Enfermedad inflamatoria intestinal
- d) Enfermedad celíaca
- e) Funcional

16) Un paciente con antecedente de insuficiencia renal crónica en etapa predialítica presenta en sus exámenes Na:130mEq/l, K:4,7mEq/l, Cl:99mEq/l. Se encuentra en buenas condiciones y su examen físico es normal. El tratamiento más adecuado para su hiponatremia es:

- a) Restricción de agua libre
- b) Aumentar la ingesta de sodio
- c) Agregar un diurético de asa
- d) Administrar suero hipertónico por vía endovenosa
- e) Hemodiálisis

17) ¿Qué examen más adecuado para confirmar la sospecha clínica de colecistitis aguda?

- a) Ecografía abdominal
- b) TAC de abdomen con contraste
- c) Colangiografía retrógrada endoscópica
- d) Pruebas hepáticas
- e) Laparoscopia exploradora

18) El tratamiento de la hipertensión arterial crónica en un paciente insuficiente renal crónico, consiste fundamentalmente en:

- a) Fármacos inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona
- b) Inhibidores de canales de calcio
- c) Dieta hiposódica y ejercicios
- d) Manejo de la volemia con restricción hidrosalina y diuréticos
- e) Dieta hiposódica y betabloqueantes

19) Una paciente de 45 años, deportista, sin hábitos tóxicos ni patologías previas, presenta astenia, por lo que se realiza exámenes generales, en donde destaca una elevación de las transaminasas por 4 veces el valor normal. El hemograma, pruebas de función renal, glicemia, perfil lipídico y el resto de las pruebas hepáticas son normales. Se solicitan exámenes adicionales que muestran IgM anti-VHA(-), Antígeno de superficie VHB(-), anticuerpos anti-HBs(+), IgM anticore(-), anticuerpos anti-VHC(-), ANA(-), ANCA(-), ASMA(+). El diagnóstico más probable es:

- a) Hepatitis viral
- b) Cirrosis biliar primaria
- c) Colangitis esclerosante primaria
- d) Hepatitis autoinmune
- e) Esteatohepatitis no alcohólica

20) Un paciente de 55 años fumador importante, con historia de baja de peso y tos, presenta astenia, seguida de desorientación y luego compromiso cuantitativo de conciencia. Al examen físico se observa bien perfundido, en sopor profundo, sin signos focales. Se realiza hemoglucotest que resulta 130. Se solicitan exámenes que demuestran sodio: 144, potasio: 4,9, cloro: 105, creatinina: 2,1, BUN: 44, fósforo: 4,7, calcio: 15,2, albúmina: 4,2. La conducta inicial más adecuada es:

- a) Realizar ABC e iniciar suero fisiológico endovenoso
- b) Realizar ABC y administrar una tiazida
- c) Realizar ABC y solicitar un TAC de cerebro
- d) Realizar ABC y realizar hemodiálisis de urgencia
- e) Realizar ABC y administrar un bifosfonato endovenoso

21) Escoja la asociación INCORRECTA entre cuadro clínico y patología causante de dolor abdominal agudo.

- a) Dolor abdominal, asociado a vómitos, ictericia y coluria – colédocolitiasis
- b) Dolor abdominal de inicio súbito muy intenso, con abdomen blando, depresible y sin irritación peritoneal – embolia mesentérica
- c) Dolor epigástrico en puñalada, con abdomen en tabla – úlcera péptica perforada
- d) Dolor abdominal intenso, tipo cólico, con abolición de los ruidos hidroaéreos – obstrucción intestinal
- e) Dolor en fosa iliaca derecha, con signo de Blumberg – apendicitis aguda

Prueba 6 (GASTROENTEROLOGÍA + HEMATO-ONCOLOGÍA)

1) El diagnóstico de la anemia hemolítica se realiza gracias a cinco signos biológicos característicos: elevación de los reticulocitos, hiperregeneración eritroblástica, hiperbilirrubinemia no conjugada, incremento de la lacticodeshidrogenasa sérica (LDH) y descenso de la haptoglobina. ¿Cuáles de estos signos biológicos pueden observarse también en las pérdidas de sangre por hemorragia?:

- a) Descenso de la haptoglobina e hiperregeneración eritroblástica.
- b) Elevación de LDH y bilirrubina no conjugada.
- c) Hiperregeneración eritroblástica y elevación de la cifra de reticulocitos.
- d) Elevación de la bilirrubina no conjugada y descenso de la haptoglobina.
- e) Descenso de la haptoglobina y elevación de la LDH.

2) Una de estas causas produce anemia megaloblástica. Señálela:

- a) Carcinoma de páncreas.
- b) Gastrectomía total.
- c) Síndrome de Zollinger-Ellison.
- d) Colitis ulcerosa.
- e) Deficiencia de aporte de hierro.

3) En una poliglobulia, todos los datos siguientes concuerdan con una policitemia vera, EXCEPTO uno. Señálelo:

- a) Aumento de la masa de hematíes.
- b) Esplenomegalia.
- c) Leucocitosis y trombocitosis.
- d) Eritropoyetina sérica alta.
- e) Saturación arterial de oxígeno normal.

4) En un paciente de 65 años con lumbalgia, anemia (Hb: 8 g/dL), elevación importante de la VSG (120 mm/1ª hora), hipercalcemia y componente monoclonal IgG-kappa de 6 g/dL en el proteinograma, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?:

- a) Es importante descartar una hernia discal mediante resonancia magnética nuclear.
- b) La macroglobulinemia de Waldenström es un diagnóstico muy probable.
- c) El examen morfológico de la médula ósea es fundamental para el diagnóstico.
- d) La determinación del antígeno prostático específico (PSA) es fundamental para el diagnóstico.
- e) Hay que iniciar ya tratamiento con calcitonina y calcio.

5) ¿Cuál es la segunda línea de tratamiento en un paciente de 55 años, sin antecedentes de interés, diagnosticado de púrpura trombocitopénica idiopática crónica, que no responde a esteroides tras 3 meses de terapia?:

- a) Azatioprina.
- b) Danazol.
- c) Inmunoglobulinas i.v. a altas dosis.
- d) Vincristina.
- e) Esplenectomía.

6) Respecto a la aspirina es verdadero que frecuentemente:

- a) Alarga el tiempo de sangría
- b) Alarga el tiempo de tromboplastina parcial activado
- c) Acorta el tiempo de protrombina
- d) Produce trombocitopenia
- e) Produce trombocitosis

7) Identifique la asociación INCORRECTA entre el factor pronóstico más importante y la patología maligna:

- a) Cáncer de mama – Compromiso linfático de la axila
- b) Cáncer de estómago – Invasión transmural
- c) Cáncer de esófago – Invasión transmural
- d) Sarcoma de partes blandas – Compromiso de ganglios linfáticos
- e) Melanoma – Profundidad de la invasión cutánea

8) ¿Cuál de las siguientes alteraciones es compatible con anemia ferropénica?

- a) Transferrina plasmática alta
- b) Volumen corpuscular medio aumentado
- c) Trombocitopenia
- d) Aumento de los reticulocitos
- e) Ferritina plasmática alta

9) Un paciente consulta por un cuadro de 3 semanas de evolución de fiebre intermitente, astenia y sudoración. Además refiere haber notado aumento de volumen axilar. Al examen físico sólo se palpan varias adenopatías axilares izquierdas, la más grande de cerca de 4 cm de diámetro, indoloras y sin signos inflamatorios. El diagnóstico más probable es:

- a) Leucemia linfática crónica
- b) Leucemia mieloide crónica
- c) Leucemia aguda
- d) Linfoma
- e) Enfermedad por arañazo de gato

10) Una paciente consulta por aumento de volumen cervical. Al examen físico se palpa un nódulo de 2 cm en la línea media anterior por sobre el esternón y que asciende con la deglución. La TSH resulta normal y la ecografía constata un nódulo tiroideo de consistencia sólida, con microcalcificaciones. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar TAC de cuello
- b) Solicitar cintigrama con yodo radiactivo
- c) Solicitar tiroglobulina plasmática
- d) Solicitar biopsia por punción con aguja fina
- e) Realizar tiroidectomía total

11) Un paciente de 32 años exhibe una historia de disfagia, de varios años de evolución, que ha progresado en las últimas semanas hasta tener dificultades, no diarias, para ingerir líquidos. Describe también episodios aislados de regurgitación no ácida de alimentos y ha tenido, al año pasado, dos episodios de neumonía. La exploración que más probablemente hará el diagnóstico correcto será:

- a) Endoscopia digestiva alta.
- b) Radiología esofagográfica con bario.
- c) Estudio de vaciamiento esofágico con radioisótopos.
- d) Manometría esofágica.
- e) pHmetría de 24 horas.

12) En relación a un paciente diagnosticado de una úlcera duodenal no complicada mediante endoscopia, señalar la respuesta FALSA:

- a) Se debe investigar si está infectado por *Helicobacter pylori* y en caso positivo trata la infección.
- b) Si se trata la infección por *Helicobacter pylori* una vez confirmada la erradicación es recomendable mantener un tratamiento con antisecretores gástricos a dosis bajas para evitar una recidiva ulcerosa.
- c) Durante la endoscopia no es necesario biopsiar sus bordes para descartar malignidad.
- d) El riesgo de recidiva ulcerosa si se logra la erradicación de *Helicobacter pylori* es menor de 20%.
- e) Las pruebas serológicas son poco fiables para confirmar la erradicación de *Helicobacter pylori*.

13) En una radiografía de abdomen en supino se ve el ligamento falciforme. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

- a) Ascitis.
- b) Perforación intestinal.
- c) Peritonitis.
- d) Oclusión intestinal.
- e) Ileo paralítico.

14) Un enfermo de 45 años sufre una elevación de los niveles sanguíneos de fosfatasa alcalina hasta 3 veces la cifra normal. ¿Qué prueba diagnóstica le recomendaría a continuación para aclarar el origen de su alteración enzimática?:

- a) Ecografía hepatobiliar.
- b) Radiografía de cráneo.
- c) Colangiografía endoscópica retrógrada.
- d) Radiografía de huesos largos.
- e) Determinación de gamma glutamil transpeptidasa.

15) En un paciente con transaminasas elevadas y un cociente GOT/GPT superior a dos, ¿cuál sería el diagnóstico más probable?:

- a) Hígado de estasis.
- b) Hepatitis vírica aguda.
- c) Hepatitis granulomatosa.
- d) Hepatitis alcohólica.
- e) Hepatitis tóxica.

16) Respecto a la colitis ulcerosa es verdadero que:

- a) Siempre afecta el recto
- b) Puede comprometer el intestino delgado
- c) El tratamiento quirúrgico no suele ser de ayuda en esta patología
- d) Suele comprometer transmuralmente el colon y se caracteriza por presentar espacios de mucosa sin compromiso, entre las zonas afectadas
- e) El tabaco es un factor de riesgo para su desarrollo

17) ¿Qué afirmación es FALSA?

- a) La poliposis adenomatosa familiar (PAF) se caracteriza por presentar más de 100 pólipos en el colon
- b) La PAF debe ser controlada periódicamente con colonoscopías, ya que en cerca de la mitad de los pacientes se desarrolla cáncer de colon
- c) El cáncer de colon hereditario no polipósico (HNPCC) se asocia a cáncer de endometrio
- d) El HNPCC se asocia a cáncer de vejiga
- e) El HNPCC puede presentar pólipos de colon, pero éstos son mucho menos abundantes que en la poliposis adenomatosa familiar

18) Una mujer en estudio por elevación de las transaminasas se realiza serología para hepatitis virales y presenta VHBs-Ag (-), VHBs-Ac (+), VHBc-Ac IgM (-), VHBc-Ac IgG (+), VHC-Ac totales (-), VHA IgM (-). Se realizan las mismas prueba a su marido y resultan todas negativas. ¿Cuál es la conducta más adecuada para el marido?

- a) Indicar uso de preservativo durante las relaciones sexuales
- b) Indicar la administración de inmunoglobulina hiperinmune contra el VHB
- c) Solicitar PCR para VHC
- d) Solicitar PCR para VHB
- e) Tranquilizarlo y explicarle que tanto él como su esposa están libres de hepatitis virales

19) Un paciente cirrótico presenta ascitis, ictericia, asterixis moderada, elevación del amonio y pensamiento incoherente. Se descarta la presencia de peritonitis bacteriana y los parámetros inflamatorios resultan normales, sin embargo las cifras de amonio (NH₄⁺) plasmático están elevadas. El tratamiento de la situación descrita es:

- a) Implantación de un TIPS
- b) Paracentesis evacuadora
- c) Lactulosa oral
- d) Antibióticos endovenosos
- e) Antipsicóticos

20) El hígado graso se diagnostica preferentemente mediante:

- a) La clínica
- b) El perfil lipídico
- c) La ecografía abdominal
- d) Las pruebas hepáticas
- e) La biopsia hepática

Prueba 7

1) Un paciente de 35 años inicia un cuadro diarreico una semana después de utilizar amoxicilina por una amigdalitis. Se solicitan toxinas de Clostridium difficile A y B en las heces, resultando positivas.

La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar ciprofloxacino oral
- b) Iniciar clindamicina oral
- c) Iniciar vancomicina oral
- d) Iniciar metronidazol oral
- e) Iniciar cotrimoxazol oral

2) Un paciente de 43 años, consulta por dolor abdominal epigástrico, muy intenso, de 8 horas de evolución, que se inició luego de una ingesta de alimentos y alcohol. Al examen físico está adolorido, FC: 103x', PA: 130/85 mmHg, con abdomen blando, depresible, muy doloroso a la palpación epigástrica. Se solicita una ecografía abdominal que muestra hígado, vesícula biliar y vía biliar normales, sin poder visualizar el páncreas. Además se solicita hemograma que muestra leucocitosis de 17.000 x mm3. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar radiografía abdominal de pie
- b) Iniciar analgésicos y antibióticos orales
- c) Solicitar lipasa plasmática y TAC de abdomen y pelvis con contraste
- d) Solicitar TAC de abdomen y pelvis sin contraste
- e) Resolver quirúrgicamente

3) Un paciente de 35 años presenta una hemorragia digestiva alta, la que es manejado con administración de cristaloides y omeprazol endovenoso. Se realiza una endoscopia digestiva alta, constatándose la presencia de una úlcera duodenal, la que es tratada mediante inyectoterapia endoscópica, evolucionando satisfactoriamente. Además se constata test de ureasa (+). ¿Cuál es la conducta más adecuada para prevenir nuevas hemorragias?

- a) Iniciar propanolol oral a permanencia
- b) Indicar uso de omeprazol a permanencia
- c) Indicar omeprazol y antibióticos orales, erradicando Helicobacter pylori
- d) Prohibir el consumo de AINEs
- e) Realizar resección quirúrgica del sitio de la úlcera

4) La primera causa de hemorragia digestiva baja masiva es de origen diverticular. ¿Cuál es la conducta más adecuada ante un paciente que presenta una hemorragia digestiva baja masiva, con rectorragia activa?

- a) Administración de cristaloides endovenosos y realización de colonoscopia de urgencia
- b) Administración de cristaloides endovenosos y realización de colonoscopia diferida, tras preparación de colon
- c) Administración de cristaloides endovenosos y realización de angiografía mesentérica
- d) Administración de suero fisiológico y realización de TAC de abdomen y pelvis
- e) Administración de suero fisiológico y realización de hemicolectomía derecha

5) La angina mesentérica se manifiesta clínicamente como:

- a) Dolor abdominal postprandial
- b) Dolor abdominal de ayuno
- c) Dolor abdominal en relación al ejercicio
- d) Dolor abdominal muy intenso, de inicio súbito, sin signos de irritación peritoneal
- e) Hematoquezia

6) Un paciente de 17 años consulta por un cuadro de un mes de evolución de dolor abdominal, pujo y diarrea frecuente, que en algunas oportunidades ha sido sanguinolenta. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad celíaca
- b) Colitis bacteriana
- c) Colitis viral
- d) Poliposis hereditaria
- e) Enfermedad inflamatoria intestinal

7) Indique la asociación INCORRECTA entre el examen y la patología:

- a) Test de Sudán (+) – Síndrome de malabsorción
- b) Test de D-xilosa con eliminación urinaria normal – Malabsorción por déficit pancreático exocrino
- c) Biopsia duodenal con acortamiento de las criptas y alargamiento de las vellosidades – Enfermedad celíaca
- d) Anticuerpos anti-trasglutaminasa (+) – Enfermedad celíaca
- e) Aumento de CO₂ radiactivo en aire espirado, en prueba de xilosa marcada radiactivamente – Sobrecrecimiento bacteriano

8) Un paciente de 59 años presenta pirosis y regurgitación ácida desde hace varios años, por lo que toma omeprazol 20 mg al día, con cierta regularidad. En el último tiempo refiere que los síntomas son más intensos y que lo despiertan por la noche a pesar del omeprazol. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar pH-metría de 24 horas
- b) Solicitar endoscopia digestiva alta
- c) Solicitar manometría esofágica
- d) Aumentar la dosis de omeprazol
- e) Agregar famotidina

9) Un paciente de 50 años se realiza una ecografía abdominal como parte del estudio de un cuadro de hematuria, identificándose un tumor hepático de 3 cm de diámetro, redondeado, de límites regulares, de aspecto hiperecogénico de manera homogénea y con refuerzo posterior. El diagnóstico más probable es:

- a) Quiste hepático simple
- b) Quiste hidatídico
- c) Hemangioma hepático
- d) Metástasis hepática
- e) Hepatocarcinoma

10) Un paciente presenta positividad del antígeno de superficie para VHB y negatividad de los anticuerpos IgM anti-core. Es verdadero que:

- a) Probablemente se trate de un falso positivo
- b) Presenta una hepatitis B aguda
- c) Presenta una hepatitis B crónica
- d) Fue vacunado contra la hepatitis B
- e) Presentó hepatitis B en el pasado, remitiendo completamente, sin evolucionar a la cronicidad

11) Un paciente de 62 años, alcohólico, con cirrosis hepática y várices esofágicas, consulta por hematemesis. ¿Qué hallazgo indicaría una mayor gravedad?

- a) Presión arterial 80/40 mmHg
- b) Ascitis
- c) Hematocrito 30%
- d) Ictericia
- e) Melena

12) El cáncer de colon suele operarse incluso en estadios avanzados, ya que en caso contrario se complica frecuentemente con:

- a) Obstrucción
- b) Perforación
- c) Sepsis
- d) Hemorragia digestiva
- e) Trombosis mesentérica

13) Un paciente de 67 años presenta, desde hace 3 meses, vómitos explosivos luego de comer, que han ido volviéndose cada vez más frecuentes, objetivándose una baja de peso de 12 kilogramos en dos meses. El diagnóstico más probable es:

- a) Divertículo esofágico
- b) Cáncer de esófago
- c) Cáncer gástrico
- d) Acalasia esofágica
- e) Úlcera gástrica

14) Un paciente de 53 años consulta por dolor epigástrico intenso y vómitos alimentarios de 10 horas de evolución, asociado a fiebre intermitente hasta 37,5°C y coluria. Al examen físico está en buenas condiciones generales, con signos vitales normales, escleras subictéricas y dolor a la palpación epigástrica, sin signos de irritación peritoneal. Se solicita ecografía abdominal que muestra vía biliar de 8 mm de diámetro, sin otras alteraciones. El diagnóstico más probable es:

- a) Cólico biliar simple
- b) Colecistitis aguda
- c) Colédocolitiasis
- d) Hepatitis aguda
- e) Pancreatitis aguda

15) Un paciente de 35 años, obeso, sin hábitos tóxicos, se realiza pruebas hepáticas que muestran una elevación de las transaminasas de 1,5 veces el normal. La ecografía abdominal muestra un aumento de la ecogenicidad del hígado. El diagnóstico más probable es:

- a) Hepatitis viral crónica
- b) Hepatitis autoinmune
- c) Hígado graso
- d) Cirrosis
- e) Hemocromatosis

16) Una mujer de 47 años consulta por astenia de un mes de evolución. Trae pruebas hepáticas con elevación de la fosfatasa alcalina y además presenta positividad de los anticuerpos antimitocondriales. El diagnóstico más probable es:

- a) Hepatitis autoinmune
- b) Colangitis esclerosante primaria
- c) Cirrosis biliar primaria
- d) Atresia biliar
- e) Amiloidosis

17) Un niño de 3 años presenta un cuadro diarreico de un día de evolución, asociado a irritabilidad y fiebre de hasta 38,2°C. Al examen presenta FC y PA normales para la edad, constatándose mucosas secas y llanto sin lágrimas. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar bolo de suero fisiológico 20 cc/kg y reevaluar
- b) Indicar sales de rehidratación oral 50cc/Kg, a tomar en 4 horas y reevaluar
- c) Indicar sales de rehidratación oral 100cc después de cada deposición diarreica
- d) Indicar sales de rehidratación oral y antibióticos orales
- e) Indicar sales de rehidratación oral y antiespasmódicos orales

18) ¿Qué examen es más adecuado para el estudio de un paciente en que se sospecha una diverticulitis aguda?

- a) TAC de abdomen y pelvis
- b) Enema baritado
- c) Colonoscopia
- d) Ecografía abdominal
- e) Laparotomía exploradora

19) Un paciente de 56 años, cirrótico, secundario a una infección crónica por VHC, consulta por aumento del perímetro abdominal. Se constata presencia de ascitis moderada y se realiza paracentesis diagnóstica que muestra un líquido peritoneal transparente, con 100 células por mm³, de predominio polimorfonuclear y proteínas en una concentración de 2,0 g/dl. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar dieta hiposódica y una asociación de furosemina y espironolactona
- b) Indicar dieta hiposódica e hidroclorotizida
- c) Realizar paracentesis evacuadora con reposición de albúmina
- d) Iniciar cefotaxima endovenoso
- e) Derivar para instalación de TIPS

20) Un paciente de 31 años consulta por dolor abdominal y diarrea intermitente de varios meses de evolución, asociado a mucosidad en las heces y distensión abdominal frecuente. El examen físico es normal. La etiología más probable es:

- a) Infección bacteriana
- b) Infección parasitaria
- c) Infección viral
- d) Enfermedad inflamatoria intestinal
- e) Funcional

Prueba 8

1) Un paciente de 56 años consulta por dolor epigástrico intenso, asociado a vómitos alimentarios. Al examen físico sus signos vitales están normales y presenta dolor a la palpación epigástrica. En sus exámenes de laboratorio destaca leucocitosis de 15.700 x mm³, bilirrubina: 1,5 mg/dl, GOT: 102 UI/l, GPT: 88 UI/l y lipasa: 367 UI/l. La ecografía abdominal resulta normal. La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio con régimen liviano y analgésicos orales
- b) Hospitalizar, indicar régimen cero y administrar cristaloides y AINES endovenosos
- c) Hospitalizar, iniciar antibióticos, cristaloides y analgésicos orales
- d) Enviar a domicilio con régimen liviano y antibióticos orales
- e) Hospitalizar y resolver de manera quirúrgica de inmediato

2) ¿Qué examen es más adecuado para confirmar un síndrome de malaabsorción intestinal en un paciente con pancreatitis crónica?

- a) Endoscopia digestiva alta
- b) Colonoscopia
- c) Test de Sudán
- d) Anticuerpos antiendomiso
- e) Niveles plasmáticos de lipasa

3) Un paciente de 65 años consulta por dolor abdominal de 5 horas de evolución, mayor en la fosa iliaca izquierda. Al examen presenta t°: 37,7°C, FC: 86x', PA: 120/80 y en el examen abdominal destaca dolor a la palpación, especialmente en la fosa ilíaca izquierda, con cierto grado de resistencia muscular localizada. El examen de elección para evaluar a este paciente es:

- a) Colonoscopia
- b) Tomografía axial computada
- c) Ecografía
- d) Enema baritado
- e) Exploración quirúrgica

4) Un paciente consulta por ictericia, constándose elevación marcada de las transaminasas. Se solicitan pruebas de serología viral que demuestran VHA-Ac IgM(-), VHA-Ac IgG (+), VHBs-Ag(+), VHBs-Ac(-), VHBcore-Ac IgM(+), VHBcore-Ac IgG(-), VHC-Ac totales(+). El diagnóstico más probable es:

- a) Hepatitis B
- b) Hepatitis C
- c) Hepatitis A y B
- d) Hepatitis B y C
- e) Hepatitis A, B y C

5) Las primeras causas de obstrucción de intestino delgado y de colon son respectivamente:

- a) Bridas y hernias
- b) Hernias y cáncer
- c) Hernias y vólvulo
- d) Bridas y cáncer
- e) Bridas y vólvulo

6) Un paciente con epigastralgia crónica se realiza una endoscopia digestiva alta, que muestra una úlcera duodenal, sin estigmas de sangrado. La biopsia gástrica demuestra una gastritis crónica atrófica y presencia de *Helicobacter pylori*. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Indicar omeprazol a permanencia
- c) Solicitar test de ureasa
- d) Erradicar *Helicobacter pylori*
- e) Resolver quirúrgicamente

7) Un niño de 5 años presenta desde hace 2 días fiebre hasta 39,4°C, dolor abdominal tipo cólico y diarrea con sangre y mucosidad. El agente etiológico más probable es:

- a) Rotavirus
- b) Enterovirus
- c) Salmonella
- d) Shigella
- e) Escherichia coli enteropatógena

8) Un paciente de 67 años presenta hematoquezia abundante en una oportunidad, asociada a malestar general. Al examen físico está pálido, con FC: 105x', PA: 100/60 mmHg y el tacto rectal demuestra sangre fresca. La primera medida a realizar es:

- a) Administrar suero fisiológico
- b) Administrar terlipresina
- c) Solicitar hemograma
- d) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
- e) Realizar colonoscopia de urgencia

9) Un paciente consulta por dolor abdominal, fiebre y vómitos de 12 horas de evolución, constatándose mediante una ecografía, una vesícula biliar distendida, con paredes edematosas de 8 mm de diámetro con presencia de barro biliar y un cálculo de 15 mm de diámetro, impactado en el bacinete. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar analgésicos y observar evolución
- b) Indicar analgésicos y realizar colecistectomía laparoscópica electiva, una vez resuelto el cuadro
- c) Indicar antibióticos y analgésicos y realizar colecistectomía laparoscópica electiva, una vez resuelto el cuadro
- d) Realizar colangiopancreatografía retrógrada endoscópica de urgencia
- e) Realizar colecistectomía laparoscópica de urgencia

10) Un paciente de 64 años consulta por malestar abdominal y constipación de 2 meses de evolución, que en último tiempo han empeorado. Al examen físico no se detectan alteraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Solicitar ecografía abdominal
- c) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
- d) Solicitar test de sangre oculta en deposiciones
- e) Solicitar colonoscopia

11) Un niño es diagnosticado de hepatitis A. ¿Qué examen es el más adecuado para definir la gravedad del cuadro?

- a) Transaminasa oxalacética (GOT)
- b) Gamaglutamil transferasa (GGT)
- c) Tiempo de protrombina
- d) Albúmina plasmática
- e) Biopsia hepática

12) Un hombre de 22 años consulta por dolor abdominal, asociado a diarrea de 4 meses de evolución, que en oportunidades es sanguinolenta. Además refiere fiebre ocasional y ha presentado 2 abscesos perianales en el último tiempo. El diagnóstico más probable es:

- a) Amebiasis
- b) Enfermedad de Crohn
- c) Shigellosis
- d) Colitis ulcerosa
- e) Poliposis adenomatosa familiar

13) Un paciente de 20 años consulta por ardor epigástrico, que asciende por el tórax y que suele presentarse después de algunas comidas. Además refiere regurgitación ácida frecuente de alimentos. El examen físico es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar endoscopia digestiva alta
- b) Solicitar pH-metría de 24 horas
- c) Iniciar medidas antirreflujo e indicar omeprazol
- d) Realizar erradicación de H. pylori

e) Solicitar manometría esofágica

14) Un paciente de 57 años, cirrótico por VHC, consulta por aumento del perímetro abdominal. Al examen físico se constata t°: 38,0°C, asterixis, telangiectasias faciales, palma hepática y matidez abdominal desplazable. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar antibióticos endovenosos
- b) Realizar paracentesis evacuadora
- c) Realizar paracentesis diagnóstica
- d) Iniciar diuréticos
- e) Iniciar propranolol

15) ¿Cuál de las siguientes alternativas es MENOS concordante con un síndrome de intestino irritable?

- a) Síntomas nocturnos
- b) Deposiciones caprinas
- c) Deposiciones con mucosidad
- d) Distensión abdominal y flatulencia
- e) Alza de peso de 3 Kg en 3 meses

16) Un paciente de 60 años, asintomático, se realiza una ecografía abdominal, que demuestra la presencia de dos lesiones hepáticas anecogénicas, redondas, de 30 y 21 mm respectivamente, bien definidas, sin pared ni tabiques y con refuerzo acústico posterior. El diagnóstico más probable es:

- a) Quistes simples
- b) Quistes hidatídicos
- c) Hemangiomas
- d) Metástasis
- e) Hepatocarcinomas

17) Los anticuerpos anti-músculo liso son característicos de:

- a) Enfermedad celíaca
- b) Enfermedad de Cröhn
- c) Colangitis esclerosante primaria
- d) Cirrosis biliar primaria
- e) Hepatitis autoinmune

18) Un lactante de 8 meses de edad presenta diarrea acuosa, abundante, de 2 días de evolución, asociada a fiebre hasta 38,2°C. Al examen físico se aprecia en buenas condiciones generales, con signos vitales normales, mucosas hidratadas y turgencia cutánea normal. La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio, indicando abundantes líquidos, como jugos y bebidas gaseosas
- b) Indicar sales de rehidratación oral después de cada deposición diarreica
- c) Administrar sales de rehidratación oral 50 a 100 cc/Kg en 4 a 6 horas y reevaluar
- d) Enviar a domicilio con sales de rehidratación oral y antibióticos
- e) Enviar a domicilio con sales de rehidratación oral y antidiarreicos

19) Un paciente de 66 años, con antecedente de daño hepático por consumo crónico de alcohol, se realiza una endoscopia digestiva alta que muestra várices esofágicas medianas. No ha presentado hemorragias digestivas y actualmente no consume alcohol. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Iniciar betabloqueo no selectivo
- c) Iniciar atenolol
- d) Instalar un TIPS
- e) Realizar ligadura de várices

20) Un paciente de 30 años presenta dificultad para tragar, de localización baja, especialmente de los líquidos, que algunos días es más intensa y en otros se manifiesta menos. En algunas ocasiones presenta regurgitación no ácida de alimentos. El examen físico no aporta mayor información. El diagnóstico más probable es:

- a) Reflujo gastroesofágico
- b) Divertículo esofágico
- c) Cáncer de esófago
- d) Esófago de Barret
- e) Acalasia esofágica

Prueba 9

1) Un recién nacido de 15 días de vida presenta hematemesis en una oportunidad. El examen físico no muestra alteraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio e indicar control en caso de recurrencia o aparición de signos de alarma
- b) Administrar suero fisiológico y solicitar endoscopia digestiva alta de urgencia
- c) Solicitar test de Apt
- d) Instalar una sonda nasogástrica, indicar régimen cero e iniciar suero fisiológico y antibióticos
- e) Solicitar ecografía abdominal

2) Un paciente de 57 años, alcohólico, de larga data, presenta dolor abdominal recurrente, localizado en el epigastrio y que aparece especialmente después de comer. Refiere además deposiciones esteatorreicas y baja de peso. El diagnóstico más probable es:

- a) Hepatitis alcohólica
- b) Úlcera gastroduodenal
- c) Enfermedad celíaca
- d) Pancreatitis crónica
- e) Cáncer gástrico

3) Un paciente de 54 años, cirrótico de causa desconocida, es traído por sus familiares debido a un cuadro de compromiso de conciencia. Al examen físico está desorientado, con ascitis moderada, y asterixis, sin focalidad neurológica. La paracentesis diagnóstica descarta PBE y se solicita hemograma, urocultivo y TAC de cerebro que resultan normales, sin embargo se constata elevación de la amonemia plasmática. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar antibióticos endovenosos
- b) Realizar paracentesis evacuadora
- c) Iniciar lactulosa oral
- d) Indicar la instalación de un TIPS
- e) Iniciar corticoides

4) Una mujer de 25 años consulta por dolor abdominal y diarrea de 4 semanas de evolución, que en los últimos días se ha vuelto sanguinolenta. Al examen físico presenta palidez y escaso dolor a la palpación abdominal, sin signos de irritación peritoneal y con ruidos hidroaéreos presentes. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad celíaca
- b) Colitis ulcerosa
- c) Amebiasis intestinal
- d) Shigellosis
- e) Colitis viral

5) La causa más frecuente de hemorragia digestiva baja es:

- a) Enfermedad diverticular
- b) Cáncer de colon
- c) Angiodisplasia
- d) Hemorroides externos
- e) Enfermedad inflamatoria intestinal

6) Un paciente de 57 años consulta por constipación de un año de evolución, que se ha vuelto más intensa en los últimos días. Trae además un hemograma con hematocrito: 27% y VCM: 72 fl. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar hierro oral y controlar en 6 meses
- b) Solicitar test de detección de sangre oculta en deposiciones
- c) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
- d) Iniciar un laxante
- e) Solicitar colonoscopia

7) Un paciente de 45 años consulta por dolor epigástrico intenso, de un día de evolución, asociado a vómitos alimentarios en varias oportunidades e ictericia. Al examen físico hay dolor a la palpación epigástrica, sin irritación peritoneal. Los exámenes de sangre demuestran hematocrito:45%, glóbulos blancos:15.700 x mm³, bilirrubina total:5,4mg/dl, bilirrubina directa:3,7mg/dl, GOT:37U/l, GPT:34U/l, GGT:237 U/l, fosfatasas alcalinas:334 U/l, albúmina plasmática:4,3 g/dl, protrombina:100%, lipasa: 45 U/l. La ecografía abdominal demuestra dilatación de la vía biliar intrahepática y extrahepáticas, con vesícula biliar normal. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar régimen cero e iniciar analgesia e hidratación endovenosa
- b) Solicitar IgM para virus de la hepatitis A
- c) Realizar colangiografía retrógrada endoscópica
- d) Iniciar antibióticos y cristaloides endovenosos
- e) Solicitar TAC de abdomen y pelvis

8) Un paciente de 70 años consulta por dolor abdominal tipo cólico, intenso, asociado a vómitos alimentarios e imposibilidad de eliminar gases. Al examen físico presenta distensión abdominal y dolor difuso a la palpación, asociado a aumento de los ruidos hidroaéreos. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar colonoscopia
- b) Solicitar ecografía abdominal
- c) Solicitar tomografía axial computada
- d) Indicar hidratación oral y antibióticos
- e) Resolver quirúrgicamente de inmediato

9) Una mujer de 79 años consulta por dolor abdominal bajo, asociado a fiebre hasta 38,2°C. Al examen físico hay dolor a la palpación abdominal, especialmente en la fosa ilíaca izquierda. Se deben tomar las siguientes medidas, EXCEPTO

- a) Iniciar analgésicos
- b) Realizar una colonoscopia
- c) Iniciar antibióticos
- d) Indicar régimen hídrico
- e) Solicitar un hemograma

10) Un paciente insuficiente renal crónico, debe iniciar hemodiálisis 3 veces a la semana, por lo que se solicitan pruebas para virus de hepatitis, obteniéndose los siguientes resultados: VHBsIgG(+), VHBs Ag(-), VHBc IgM(-), VHBc IgG(+), VHC IgG(+), VHC IgM(-). El diagnóstico más probable es:

- a) Hepatitis B crónica
- b) Hepatitis B aguda
- c) Hepatitis B y C
- d) Hepatitis C
- e) Sano

11) Un paciente de 34 años consulta por ardor epigástrico, que asciende por el tórax, que aparece varias veces al día. Se realiza una endoscopia digestiva alta que muestra una esofagitis distal moderada, de distribución lineal. El test de ureasa resulta positivo. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar medidas antirreflujo e iniciar omeprazol
- b) Realizar erradicación de Helicobacter pylori
- c) Solicitar pH-metría de 24 horas
- d) Solicitar manometría esofágica
- e) Iniciar famotidina y realizar nueva endoscopia digestiva en 3 meses

12) Un paciente de 65 años se realiza una ecografía abdominal, visualizándose una lesión hepática de 5 cm de diámetro, de aspecto sólido. En sus exámenes destaca elevación marcada de la alfafetoproteína. El diagnóstico más probable es:

- a) Metástasis de cáncer de colon
- b) Hepatocarcinoma
- c) Quiste simple
- d) Quiste hidatídico
- e) Hemangioma

13) Una paciente presenta una pielonefritis aguda, por lo que es tratada con ciprofloxacino, sin embargo evoluciona con diarrea acuosa y dolor abdominal, que se inicia 5 días después de haber iniciado el tratamiento antibiótico. La conducta más adecuada es:

- a) Suspender el ciprofloxacino
- b) Cambiar el ciprofloxacino por cefadroxilo
- c) Solicitar toxinas de *Clostridium difficile* en deposiciones
- d) Iniciar vancomicina oral
- e) Indicar hidratación oral y observar evolución

14) Una paciente de 40 años consulta por astenia de 2 meses de evolución. Se solicitan exámenes generales, entre los que destacan pruebas hepáticas con fosfatasas alcalinas de 340 UI/l, GGT: 158 UI/l, bilirrubina: 2,5 mg/dl, GOT: 12 UI/l, GPT: 22 UI/l. El diagnóstico más probable es:

- a) Hepatitis autoinmune
- b) Colangitis esclerosante primaria
- c) Infiltración hepática tumoral
- d) Cirrosis biliar primaria
- e) Hígado graso

15) ¿Cuál de las siguientes alteraciones es MENOS concordante con un síndrome de intestino irritable?

- a) Pujo y tenesmo
- b) Dolor que disminuye con la evacuación
- c) Deposiciones caprinas
- d) Distensión abdominal
- e) Mucosidad en las deposiciones

16) Un paciente de 55 años, cirrótico, por consumo de alcohol, consulta por fiebre, malestar general y dolor abdominal. En sus exámenes destaca GOT: 352 UI/l, GPT: 149 UI/l, GGT: 359 UI/l, FA: 120 UI/l, bilirrubina: 3,6 mg/dl, de predominio directo. El diagnóstico más probable es:

- a) Absceso hepático
- b) Hígado graso agudo
- c) Hepatitis aguda viral
- d) Hepatitis alcohólica
- e) Peritonitis bacteriana espontánea

17) La etiología más frecuente de la úlcera duodenal es:

- a) Consumo de AINES
- b) *Helicobacter pylori*
- c) Gastrinoma
- d) Cáncer
- e) Autoinmune

18) Un hombre de 71 años, previamente sano, consulta por malestar general y baja de peso de 15 kilogramos en 4 meses. Al examen se aprecia pálido, se palpan adenopatías supraclaviculares y se aprecia ascitis moderada. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Carcinoma hepatocelular
- b) Cáncer de colon
- c) Cáncer gástrico
- d) Cáncer de esófago
- e) Cáncer de páncreas

19) Un paciente de 55 años consulta por disfagia de localización alta, asociado a halitosis, de varios meses de evolución. Refiere que en ocasiones presenta regurgitación de grandes cantidades de alimento sin digerir y además ha presentado 2 neumonías aspirativas en el último año. ¿Qué examen es más adecuado para continuar el estudio?

- a) Endoscopia digestiva alta
- b) Radiografías baritadas
- c) Manometría esofágica
- d) Tomografía axial computada
- e) pH-metría esofágica

20) ¿Qué alteración indica una mayor gravedad en una hepatitis A?

- a) Ascitis
- b) GOT mayor a 5.000 UI/l
- c) Protrombina: 40%
- d) Desorientación
- e) Dolor en hipocondrio derecho

Prueba 10

1) Un paciente de 23 años consulta por dolor abdominal y diarrea de 3 meses de evolución, que en ocasiones se asocia a fiebre y artralgias. Al examen físico se aprecia abdomen blando, sensible especialmente en el cuadrante inferior derecho. Se solicita una tomografía axial computarizada, que muestra presencia de edema en la pared del íleon distal y de algunas zonas del colon izquierdo. El diagnóstico más probable es:

- a) Diarrea funcional
- b) Enterocolitis viral
- c) Enterocolitis bacteriana
- d) Enterocolitis parasitaria
- e) Enfermedad de Cröhn

2) ¿Qué hallazgo o antecedente es MENOS orientador a un trastorno digestivo funcional?

- a) Pujo y tenesmo
- b) Distensión abdominal
- c) Dolor abdominal tipo cólico
- d) Constipación
- e) Diarrea

3) Un paciente celíaco, en tratamiento con dieta, consulta por persistencia de la esteatorrea. ¿Cuál de los siguientes alimentos podría ser el causante de esto?

- a) Arroz
- b) Vino
- c) Bebidas cola
- d) Embutidos
- e) Naranjas

4) Un paciente de 13 años, sin hábitos tóxicos, ni uso de medicamentos y que vive en una comunidad rural, consulta por un cuadro de una semana de evolución, que inició como fiebre hasta 38,4°C y decaimiento. Hace dos días notó que la orina empezó a volverse más oscura y que su piel y ojos empezaron a tomar un tinte amarillento. Se solicitan pruebas hepáticas que demuestran GOT: 1.560 UI/l, GPT: 1.389 UI/l, GGT: 120 UI/l, FA: 288 UI/l, bilirrubina total: 6,4 mg/dl, bilirrubina directa: 5,6 mg/dl. ¿Qué examen le parece más adecuado para determinar el diagnóstico etiológico de este cuadro?

- a) AMA, ANCA, ASMA y ANA
- b) Anticuerpos totales contra VHC
- c) IgM VHA y antígeno de superficie VHB
- d) Biopsia hepática
- e) Ecografía abdominal

5) ¿Cuál es la presentación más habitual de la cirrosis biliar primaria?

- a) Astenia más elevación de las fosfatasas alcalinas
- b) Ictericia más positividad de los anticuerpos antinucleares
- c) Dolor abdominal, ictericia y elevación de las transaminasas
- d) Dolor abdominal y elevación de la GGT
- e) Ictericia y hepatomegalia

6) Un paciente cirrótico consulta por dolor abdominal y aumento del perímetro abdominal. Al examen físico se aprecia icterico, con fiebre, presencia de ascitis moderada y desorientación. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar antibióticos
- b) Iniciar diuréticos
- c) Solicitar paracentesis diagnóstica
- d) Solicitar pruebas hepáticas
- e) Realizar paracentesis evacuadora

7) Un paciente de 60 años consulta por disfagia alta, asociada a halitosis y regurgitación ocasional de gran cantidad de alimento, no ácido, algunas horas después de haber comido. Al examen físico no se aprecian alteraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Iniciar omeprazol oral
- c) Solicitar endoscopia digestiva alta
- d) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
- e) Solicitar radiografías baritadas

8) ¿Cuál es el tratamiento de primera línea para la erradicación del H. pylori?

- a) Omeprazol + claritromicina + ciprofloxacino
- b) Omeprazol + metronidazol + cefadroxilo
- c) Omeprazol + amoxicilina + ciprofloxacino
- d) Omeprazol + claritromicina + amoxicilina
- e) Omeprazol + metronidazol + ciprofloxacino

9) Un paciente de 30 años consulta por dolor epigástrico urente, que aparece frecuentemente, especialmente en ocasiones cuando está nervioso, sin clara relación con los alimentos. El examen físico no presenta alteraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar omeprazol
- b) Observar evolución
- c) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
- d) Solicitar endoscopia digestiva alta
- e) Solicitar ecografía abdominal

10) El tratamiento de elección de la pancreatitis aguda es:

- a) Régimen cero, hidratación endovenosa y analgésicos parenterales
- b) Régimen cero, antibióticos, analgésicos y cristaloides endovenosos
- c) Régimen cero, analgésicos, corticoides y cristaloides endovenosos
- d) Régimen hídrico, analgésicos y antibióticos orales
- e) Régimen hídrico, analgésicos y corticoides orales

11) ¿Cuál es el diagnóstico más probable ante una paciente de 80 años con un cuadro de un día de evolución de dolor abdominal, vómitos, fiebre alta, confusión e ictericia marcada?

- a) Hepatitis aguda
- b) Colangitis aguda
- c) Colecistitis aguda
- d) Pankreatitis aguda
- e) Hemólisis aguda

12) Un paciente colecistectomizado presenta un cuadro de 5 horas de evolución de dolor abdominal intenso, tipo cólico, asociado a vómitos alimentarios. Al examen físico se constata aumento de los ruidos hidroaéreos y distensión abdominal marcada. El diagnóstico más probable es:

- a) Embolia mesentérica
- b) Colitis isquémica
- c) Pankreatitis aguda
- d) Gastroenteritis aguda
- e) Obstrucción intestinal

13) Un paciente se realiza una colonoscopia, como parte del estudio de una anemia ferropénica, que visualiza un pólipo de 2 cm de diámetro en el colon descendente, sin otras alteraciones. Se extrae el pólipo durante el procedimiento. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
- b) Solicitar estudio anatomopatológico del pólipo
- c) Solicitar nueva colonoscopia en un año
- d) Solicitar nueva colonoscopia en 3 años
- e) Observar evolución

14) Un paciente de 60 años refiere constipación de un año de evolución, asociado a dolor abdominal intermitente, que han aumentado de intensidad en el último mes. El examen físico no presenta alteraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
- b) Aumentar la ingesta de líquidos y fibra vegetal y controlar en 1 mes
- c) Iniciar trimebutino e indicar dieta liviana
- d) Solicitar ecografía abdominal
- e) Solicitar colonoscopia

15) ¿Qué marcador suele estar elevado en el cáncer de páncreas?

- a) Ca 19.9
- b) Ca 125
- c) Alfafetoproteína
- d) Antígeno carcinoembrionario
- e) Gamaglutamil transferasa

16) Un paciente de 69 años consulta por hematoquezia abundante. Al examen físico está en buenas condiciones, con signos vitales normales y sin otras alteraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar cristaloides y solicitar colonoscopia de urgencia sin preparación de colon
- b) Administrar glóbulos rojos endovenosos y solicitar angiografía mesentérica
- c) Administrar globulos rojos y solicitar colonoscopia de urgencia
- d) Administrar suero fisiológico y solicitar TAC de abdomen y pelvis
- e) Administrar suero fisiológico y solicitar colonoscopia, previa preparación de colon

17) La disfagia ilógica es característica de:

- a) La acalasia esofágica
- b) El cáncer de esófago
- c) Los divertículos esofágicos
- d) El reflujo gastroesofágico
- e) El esófago de Barret

18) Un paciente con test de Sudán positivo, presenta disminución marcada de la excreción urinaria de D-xilosa en la prueba de D-xilosa oral. ¿Qué diagnóstico es el más probable?

- a) Enfermedad celíaca
- b) Déficit de enzimas pancreáticas
- c) Sobrecrecimiento bacteriano
- d) Intolerancia a la lactosa
- e) Resección de íleon distal

19) Un paciente de 20 años consulta por fiebre alta, asociada a diarrea disintérica, de un día de evolución. Al examen físico está decaído, con dolor abdominal tipo cólico, signos vitales normales y sin deshidratación. La conducta más adecuada es:

- a) Aumentar la ingesta de líquidos e iniciar ciprofloxacino oral
- b) Aumentar la ingesta de líquidos e iniciar metronidazol oral
- c) Aumentar la ingesta de líquidos e iniciar gentamicina endovenosa
- d) Aumentar la ingesta de líquidos e iniciar clindamicina oral
- e) Aumentar la ingesta de líquidos e iniciar clindamicina endovenosa

20) Un paciente de 23 años consulta por pirosis y regurgitación ácida frecuente. Refiere además que despierta con disfonía y que ésta va cediendo a medida que pasa el día. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar pH-metría esofágica de 24 horas
- b) Realizar erradicación de H. pylori
- c) Solicitar manometría esofágica
- d) Solicitar endoscopia digestiva alta
- e) Iniciar medidas generales antirreflujo y omeprazol en dosis única diaria

Prueba 11:

Ver RESPIRATORIO Prueba 1
GASTROENTEROLOGÍA RESPUESTAS

Prueba 1	14 D	7 E	21 D	15 C	9 B
1 B	15 D	8 A		16 C	10 D
2 D	16 D	9 D	Prueba 6	17 B	11 A
3 D	17 C	10 A	1 C	18 A	12 B
4 C	18 C	11 D	2 B	19 A	13 C
5 C	19 C	12 C	3 D	20 E	14 D
6 E	20 D	13 C	4 C		15 A
7 C		14 C	5 E	Prueba 8	16 D
8 A		15 C	6 A	1 B	17 B
9 D	Prueba 3	16 B	7 D	2 C	18 C
10 A	1 D	17 A	8 A	3 B	19 B
11 C	2 B	18 B	9 D	4 D	20 D
12 B	3 C	19 B	10 D	5 D	
13 C	4 A	20 D	11 D	6 D	Prueba10
14 A	5 C		12 B	7 D	1 E
15 E	6 E	Prueba 5	13 B	8 A	2 A
16 D	7 C	1 D	14 E	9 E	3 D
17 A	8 C	2 C	15 D	10 E	4 C
18 E	9 E	3 C	16 A	11 C	5 A
19 C	10 B	4 C	17 B	12 B	6 C
20 A	11 D	5 B	18 E	13 C	7 E
	12 A	6 C	19 C	14 C	8 D
Prueba 2	13 A	7 D	20 C	15 A	9 D
1 E	14 D	8 B		16 A	10 A
2 D	15 D	9 C	Prueba 7	17 E	11 B
3 B	16 D	10 C	1 D	18 B	12 E
4 B	17 E	11 A	2 C	19 B	13 B
5 A	18 A	12 A	3 C	20 E	14 E
6 A	19 C	13 A	4 A		15 A
7 A	20 B	14 A	5 A	Prueba 9	16 E
8 C		15 E	6 E	1 C	17 A
9 B	Prueba 4	16 A	7 C	2 D	18 A
10 A	1 E	17 A	8 B	3 C	19 A
11 E	2 E	18 D	9 C	4 B	20 E
12 C	3 B	19 D	10 C	5 A	
13 B	4 C	20 A	11 A	6 E	
	5 A		12 A	7 C	
	6 B		13 C	8 C	
			14 C		

IV) NEFROLOGÍA PRUEBAS

Prueba 1 (NEFROLOGÍA + UROLOGÍA)

1) Mujer de 64 años, ingresa por cuadro de hemorragia digestiva por úlcera gástrica. Inicialmente presenta hipotensión y oliguria. En sus exámenes destaca Crea:3,4 y BUN:80. Se administra volumen con suero fisiológico y se realiza tratamiento endoscópico de la úlcera, con buen resultado. Se mantiene con presión arterial cercana a 110/70. Al 3er día reinicia buenas diuresis, cercanas a 4000cc/día, sin embargo persiste con crea:3,3. La causa más probable de su alteración de la función renal es:

- a) Hipovolemia con compromiso prerrenal
- b) Necrosis tubular aguda
- c) Nefropatía diabética
- d) válvula aórtica bicúspide
- e) coartación aórtica

2) Paciente de 67 años, con IRC secundaria a DM2. Consulta por astenia y disnea de esfuerzos que antes no tenía. En el examen físico destaca palidez de piel y mucosas y examen cardiopulmonar normal. El hemograma demuestra Hcto:25%; VCM:82; HCM:32; leucocitos y plaquetas normales. La cinética de hierro resulta normal. El tratamiento más adecuado es:

- a) Sulfato de hierro oral
- b) Transfusiones periódicas de glóbulos rojos
- c) Eritropoyetina subcutánea
- d) Vitamina B12 y hierro, por vía parenteral
- e) Vitamina B12 y hierro, por vía oral

3) Paciente con mieloma múltiple, evoluciona con poliuria, deshidratación y compromiso de conciencia. En la analítica sanguínea destaca Calcemia:16mEq/l. La primera medida a tomar es:

- a) Administrar magnesio endovenoso
- b) Administrar suero fisiológico
- c) Administrar bifosfonatos endovenosos
- d) Administrar furosemida endovenosa
- e) Administrar corticoides endovenosos

4) Un escolar de 5 años es traído por su madre, ya que presenta edema de párpados. Al examen se aprecia paciente normotenso, FC:100x', con edema facial, escrotal y de extremidades. Los exámenes de orina muestran proteinuria (++++); gotas de grasa(+), sin hematuria. Usted solicita proteinuria de 24 horas que muestra proteinuria en rango nefrótico. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar C3, C4, ANA, creatinina e iniciar tratamiento corticoidal
- b) Indicar restricción de sodio y agua e indicar un diurético
- c) Realizar electroforesis de proteínas en orina
- d) Explicar a la madre el carácter benigno del cuadro e indicar control S.O.S.
- e) Solicitar biopsia renal

5) Paciente diabético de 45 años, con control irregular de sus glicemias con metformina. Su presión arterial es normal. En sus exámenes de control destaca creatinina:0,8; BUN:12; albuminuria:100mg/24h. La conducta más adecuada, además de mejorar el control de sus glicemias, es:

- a) Agregar enalapril al tratamiento
- b) Suspender hipoglicemiantes orales e iniciar insulina
- c) Iniciar prednisona
- d) Sospechar glomerulopatía membranosa y realizar control de proteinuria cada 3 meses
- e) Realizar biopsia renal

6) El examen de elección para diferenciar entre una insuficiencia renal aguda y una insuficiencia renal crónica es:

- a) Producto calcio-fósforo
- b) Hemograma
- c) Orina completa
- d) Ecografía renal
- e) Proteinuria de 24 horas

7) Un paciente de 30 años, ingresa por compromiso de conciencia. Los gases arteriales muestran los siguientes resultados: pH:7.28; pO₂:106; pCO₂:12; HCO₃:14. El diagnóstico ácido base es:

- a) Acidosis respiratoria y acidosis metabólica
- b) Acidosis metabólica aislada
- c) Acidosis metabólica y alcalosis respiratoria
- d) Acidosis respiratoria y alcalosis metabólica
- e) Acidosis respiratoria aislada

8) Joven de 15 años, con cuadro de 2 días de evolución de odinofagia, fiebre leve y rinorrea. Presenta varios episodios de hematuria indolora. El examen físico resulta normal. La analítica demuestra hemograma, función renal y hepática normales. El sedimento de orina muestra eritrocitos dismórficos abundantes. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad de cambios mínimos (nefrosis lipoídea)
- b) Glomerulopatía membranosa
- c) Glomerulonefritis rápidamente progresiva
- d) Enfermedad de Berger
- e) Glomerulonefritis aguda postestreptocócica

9) De entre las siguientes alternativas, el mejor examen para determinar el origen prerrenal de una insuficiencia renal aguda es:

- a) El examen físico
- b) La relación entre BUN y creatinina
- c) El clearance de creatinina de 24 horas
- d) La fracción excretada de sodio
- e) La orina completa

10) La causa más frecuente de insuficiencia renal crónica, en Chile, es:

- a) Hipertensión arterial
- b) Diabetes mellitus
- c) Nefropatía tubulointersticial
- d) Glomerulonefritis
- e) Pielonefritis a repetición

Preguntas Urología

11) Paciente fumadora de 65 años de edad, consulta por hematuria indolora, sin otros síntomas. El sedimento de orina muestra más de 100 eritrocitos por campo, sin dismorfia y la ecografía resulta normal. El diagnóstico más probable y el examen para confirmarlo son respectivamente:

- a) Urolitiasis y radiografía simple de abdomen
- b) Infección urinaria baja y urocultivo
- c) Cistitis intersticial y cistoscopia
- d) Cáncer de vejiga y cistoscopia
- e) Uretritis gonocócica oligosintomática y cultivo de Thayer-Martin

12) Mujer de 60 años, consulta porque hace 2 semanas inicia escapes de pequeñas cantidades de orina cuando tose o se ríe y cuando levanta objetos muy pesados. Últimamente ésto le causa vergüenza. La primera aproximación diagnóstica debe ser solicitar:

- a) Sedimento de orina y urocultivo
- b) Uretrocistomanometría
- c) Ecografía renal y vesical
- d) Papanicolau
- e) Estradiol, FSH y LH

13) Paciente de 26 años consulta por compromiso del estado general, asociado a dolor y aparición de lesiones cutáneas en el pene. Refiere tener relaciones sexuales con distintas mujeres, sin protección. Al examen se constata paciente febril hasta 38,5°C, con adenopatías inguinales bilaterales, dolorosas. En el glande y cuerpo del pene, se aprecian múltiples úlceras confluentes, dolorosas. El diagnóstico más probable es:

- a) Chancro sifilítico
- b) Chancroide
- c) Gonorrea
- d) Linfogranuloma venéreo

e) Herpes genital

14) El examen de mayor rendimiento para confirmar la sospecha de urolitiasis es:

- a) Sedimento de orina
- b) Radiografía renal
- c) Ecografía renal y vesical
- d) PielotAC
- e) Pielografía de eliminación, con contraste endovenoso

15) Paciente de 20 años, sufre accidente de tránsito, evoluciona con anuria de 6 horas de evolución, a pesar de deseos intensos de orinar. Presión arterial y pulso normales. Al examen se observa salida de sangre fresca por uretra. La medida inicial a seguir es:

- a) Instalar sonda Foley
- b) Solicitar uretrocistografía retrógrada
- c) Administrar suero fisiológico hasta alcanzar diuresis
- d) Solicitar un nuevo ECG
- e) Evaluar respuesta a cambios de estilo de vida y aspirina, en 1 mes

16) Paciente de 57 años, sin antecedentes de importancia. En control de salud se pesquisa APE: 5,4 ng/ml. El tacto rectal es compatible con hiperplasia benigna de la próstata grado 2. No presenta síntomas urinarios. La conducta más adecuada es:

- a) Mantener control de APE y tacto rectal anual, sin tomar ninguna medida adicional
- b) Realizar nuevo control de APE en 3 meses
- c) Iniciar tamsulosina
- d) Realizar biopsia prostática transrectal
- e) Realizar resección transuretral del adenoma prostático

17) Paciente de 86 años, con cáncer de próstata, diagnosticada por biopsia y APE mayor de 100 ng/ml, en contexto de dolor lumbar de difícil manejo. La cintigrafía ósea es compatible con numerosas metastasis lumbares. El tratamiento más adecuado es:

- a) Prostatectomía radical más linfadenectomía pélvica
- b) Hormonoterapia
- c) Quimioterapia y radioterapia
- d) Cirugía radical más quimioterapia postoperatoria
- e) Tratamiento paliativo con analgesia y manejo de complicaciones

18) Paciente de 25 años, consulta por haber notado aumento de volumen testicular derecho. La ecografía testicular muestra tumor de aspecto sólido en testículo derecho. La conducta inicial más adecuada es:

- a) Control ecográfico en 6 meses
- b) Realizar biopsia por punción del tumor
- c) Realizar tumorectomía y biopsia
- d) Solicitar marcadores tumorales (AFP, HCG y LDH) y decidir cirugía según resultados
- e) Realizar orquiectomía derecha, por vía inguinal, independientemente del resultado de los marcadores tumorales.

19) Niño de 3 meses, en el examen de rutina no se palpa el testículo derecho. Al examinarlo es posible palparlo en relación a la salida del conducto inguinal y se puede descender fácilmente hasta el escroto, sin embargo vuelve al conducto inguinal al soltarlo. ¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor la conducta que debe tomarse?

- a) Tranquilizar a la madre e indicarle que esta condición no tiene ninguna repercusión negativa sobre el lactante.
- b) Solicitar ecografía inguinal y testicular
- c) Realizar orquidopexia quirúrgica al cumplir 18 meses
- d) Realizar orquidopexia inmediata
- e) Realizar orquiectomía para evitar el riesgo de cáncer de testículo

20) Paciente embarazada de 35 semanas, inicia compromiso del estado general, fiebre hasta 38°C y disuria dolorosa. Al examen físico se observa paciente en buenas condiciones generales, normotensa, con FC:90x', puño percusión (+). El sedimento de orina muestra leucocituria y el urocultivo resulta positivo para E. coli multisensible. El antibiótico de elección para el tratamiento de esta condición, por vía oral, es.

- a) Amoxicilina
- b) Ciprofloxacino
- c) Gentamicina
- d) Cefadroxilo
- e) Nitrofurantoína

Prueba 2 (NEFROLOGÍA + UROLOGÍA)

1) Paciente de 57 años, sin antecedentes de importancia. En control de salud se pesquisa APE: 5,4 ng/ml. El tacto rectal es compatible con hiperplasia benigna de la próstata grado 2. No presenta síntomas urinarios. La conducta más adecuada es:

- a) Mantener control de APE y tacto rectal anual, sin tomar ninguna medida adicional
- b) Realizar nuevo control de APE en 3 meses
- c) Iniciar tamsulosina
- d) Realizar biopsia prostática transrectal
- e) Realizar resección trasuretral del adenoma prostático

2) Un paciente de 30 años presenta aumento de volumen testicular, de consistencia aumentada. Al examen físico se palpa una tumoración en relación al testículo derecho, de cerca de 3 cm de diámetro. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar ecografía testicular
- b) Solicitar alfa-fetoproteína y subunidad beta de gonadotropina coriónica humana
- c) Realizar biopsia por punción con aguja gruesa
- d) Realizar tumorectomía
- e) Realizar orquiectomía radical

3) Un paciente cursando una obstrucción intestinal, recientemente operada presenta oliguria y creatinina de 2,5 mg/dl. Se constata K⁺ urinario: 25 mEq/l, Na⁺ urinario: 8 mEq/l, Cl⁻ urinario: 13 mEq/l, con sedimento de orina normal. La patología que mejor explica la elevación de la creatinina es:

- a) Insuficiencia renal aguda prerenal
- b) Necrosis tubular aguda
- c) Nefritis intersticial
- d) Pielonefritis aguda
- e) Insuficiencia renal aguda postrenal

4) Un paciente de 45 años es hospitalizado para realización de una colecistectomía laparoscópica electiva, debida a una coledolitiasis sintomática. En el postoperatorio presenta retención urinaria, por lo que se instala una sonda Foley. Algunas horas después el paciente presenta importante dolor en relación a la sonda. Al examen físico se aprecia el glande aumentado de tamaño, edematoso y doloroso a la palpación, con el prepucio retraído. El diagnóstico más probable es:

- a) Balanopostitis aguda
- b) Infección urinaria baja
- c) Parafimosis
- d) Uretritis por sonda
- e) Trombosis de la vena testicular

5) Un hombre de 58 años, diabético tipo 2, en tratamiento con glibenclamida, más metformina desde hace varios años, presenta edema facial y de extremidades inferiores, asociado a orinas espumosas. El examen físico no aporta mayor información. Se solicitan exámenes que constatan un clearance de creatinina de 70 ml/min, BUN: 23 mg/dl, proteinuria de 24 horas de 5,1 gramos, sedimento de orina sin alteraciones y albuminemia de 2,2 g/dl. El diagnóstico más probable es:

- a) Nefropatía membranosa
- b) Glomeruloesclerosis difusa
- c) Nefrosis lipoídea
- d) Insuficiencia renal terminal
- e) Nefritis intersticial

6) Una paciente de 30 años se realiza una ecografía abdominal como parte del estudio de un cuadro crónico de dolor abdominal, con examen físico normal, probablemente secundario a una colopatía funcional. En dicha ecografía se identifican 2 quistes renales izquierdos, de 2 y 4 cm cada uno. La conducta más adecuada, respecto a este hallazgo, es:

- a) Enviar a domicilio, sin necesidad de mayor estudio ni tratamiento
- b) Controlar con ecografías periódicas
- c) Solicitar estudio genético para descartar enfermedad renal poliquística del adulto
- d) Solicitar TAC abdominal
- e) Resolver quirúrgicamente

7) Un hombre de 68 años presenta aumento de volumen indoloro del testículo derecho. Al examen físico se aprecia el escroto aumentado de tamaño, con prueba de transiluminación positiva. El diagnóstico más probable es:

- a) Cáncer testicular
- b) Hernia inguinoescrotal
- c) Varicocele
- d) Torsión testicular
- e) Hidrocele

8) ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para evitar el hiperparatiroidismo secundario a la insuficiencia renal crónica, en un paciente con clearance de creatinina de 40 ml/min y producto calcio fósforo de 45?

- a) Dieta baja en calcio y baja en fósforo
- b) Calcitonina
- c) Carbonato de calcio oral
- d) Diuréticos de asa
- e) Diuréticos tiazídicos

9) La alternativa que más orienta a una glomerulonefritis aguda postestreptocócica, en un niño que cursa con un síndrome nefrítico, es:

- a) Anticuerpos antinucleares
- b) Elevación de la creatinina
- c) Cultivo faringeo positivo para Streptococcus pyogenes
- d) Hipocomplementemia transitoria
- e) Cilindros hemáticos

10) Un paciente presenta fasciculaciones en varios grupos musculares, asociados a hiperreflexia. La alteración hidroelectrolítica más probable es:

- a) Hipocalcemia
- b) Hipokalemia
- c) Hipomagnesemia
- d) Hipercalcemia
- e) Hiperkalemia

11) El examen de mayor rendimiento para confirmar la sospecha de urolitiasis es:

- a) Sedimento de orina
- b) Radiografía renal
- c) Ecografía renal y vesical
- d) PielotAC
- e) Pielografía de eliminación, con contraste endovenoso

12) La conducta más adecuada ante un paciente de 10 años, cursando con un síndrome nefrótico impuro, asociado a hipertensión y hematuria es:

- a) Iniciar con corticoides orales
- b) Administrar pulsos endovenosos de metilprednisolona
- c) Iniciar inmunosupresores, asociados a corticoides endovenosos
- d) Iniciar una asociación de corticoides, inmunosupresores y antibióticos, con cobertura para estreptococo beta hemolítico del grupo A
- e) Derivar para realización de una biopsia renal

13) ¿Cuál de los siguientes cuadros clínicos es más sugerente de una incontinencia urinaria de esfuerzos?

- a) Mujer de 70 años, demenciada, que presenta escapes de grandes cantidades de orina 3 o 4 veces al día, razón por la cual debe usar pañales
- b) Mujer de 20 años con escape continuo de orina en pequeñas cantidades, lo que la obliga a ocupar protectores
- c) Mujer de 50 años que en algunas ocasiones siente deseos incontrolables de orinar, por lo que no alcanza a ir al baño, orinándose antes
- d) Mujer de 55 años con escape de pequeñas cantidades de orina, al realizar tareas donde requiere hacer mucha fuerza y al toser
- e) Mujer de 60 años con grandes escapes de orina en algunas ocasiones, especialmente cuando se ríe

14) Las causas más frecuentes de insuficiencia renal crónica, en niños y adultos, son respectivamente:

- a) Prerenal y prerrenal
- b) Malformaciones nefrourológicas e hipertensión
- c) Glomerulonefritis y diabetes
- d) Malformaciones nefrourológicas y diabetes
- e) Glomerulonefritis e hipertensión arterial

15) ¿Cuál de las siguientes no es una indicación de hemodiálisis de urgencia?

- a) Hiponatremia grave, que no responde al tratamiento médico
- b) Hiperkalemia grave, que no responde al tratamiento médico
- c) Pericarditis urémica
- d) Edema pulmonar que no responde al tratamiento médico
- e) Acidosis grave, que no responde al tratamiento médico

16) El diagnóstico de la uretritis gonocócica se realiza preferentemente con:

- a) Cultivo de secreción uretral en hombres y la clínica en mujeres
- b) Tinción de Gram de secreción uretral en mujeres y la clínica en hombres
- c) Cultivo de secreción uretral en mujeres y tinción de Gram de secreción uretral en hombres
- d) Cultivo de secreción uretral en hombres y tinción de Gram de secreción uretral en mujeres
- e) La clínica en ambos sexos

17) Un hombre de 60 años consulta por disuria de esfuerzos, con disminución del calibre miccional, nicturia y goteo terminal. El examen físico no aporta mayor información. El diagnóstico más probable es:

- a) Cáncer de próstata
- b) Estenosis uretral
- c) Hiperplasia benigna de la próstata
- d) Infección del tracto urinario
- e) Uretritis por clamidia

18) La causa más frecuente de hipercalcemia en pacientes hospitalizados es:

- a) Hiperparatiroidismo primario
- b) Uso de furosemda
- c) Insuficiencia renal aguda prerrenal
- d) Insuficiencia renal crónica
- e) Cáncer

19) Un paciente de 20 años presenta presiones arteriales elevadas en varias tomas, realizadas en días distintos. El examen físico es normal. Se solicitan hemograma, creatinina plasmática, BUN, sedimento de orina, electrolitos plasmáticos, índice de aldosterona / actividad de renina plasmática y metanefrinas urinarias, identificándose sólo hipokalemia de 2,8 mEq/l, con normalidad de todos los otros parámetros. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Hipertensión arterial esencial
- b) Hipertensión arterial renovascular
- c) Hiperaldosteronismo primario
- d) Síndrome de secreción inadecuada de ADH
- e) Enfermedad de Berger

20) Una niña de 2 años presenta un cuadro de 2 días de evolución de disuria y orinas de mal olor. El examen físico resulta normal. Se solicita urocultivo por sondeo que resulta positivo para E. coli multisensible, con 30.000 unidades formadoras de colonias. La conducta más adecuada es:

- a) Observar, sin necesidad de mayor estudio a menos que recurran o progresen los síntomas
- b) Observar evolución y controlar nuevo urocultivo en 7 días o en caso de fiebre
- c) Iniciar nitrofurantoína oral y controlar con urocultivo en 7 días
- d) Iniciar ceftriaxona endovenosa, controlar con urocultivos y solicitar cintigrafía renal estática
- e) Iniciar cefadroxilo oral, controlar con urocultivos, y una vez resuelto el cuadro, solicitar ecografía renovesical y uretrocistografía retrógrada endoscópica

Prueba 3

1) El mejor examen para diferenciar una insuficiencia renal aguda, de una insuficiencia renal crónica es:

- a) Clearance de creatinina
- b) Relación BUN/creatinina plasmática
- c) Fracción excretada de sodio
- d) Ecografía renal
- e) Parathormona plasmática

2) ¿Qué hallazgo es MENOS probable de encontrar en un paciente con una glomerulonefritis aguda postestreptocócica?

- a) Hipocomplementemia
- b) Hipertensión arterial
- c) Elevación de la creatinina
- d) Cilindros eritrocitarios
- e) Lipiduria

3) Paciente de 67 años, con IRC secundaria a DM2. Consulta por astenia y disnea de esfuerzos que antes no tenía. En el examen físico destaca palidez de piel y mucosas y examen cardiopulmonar normal. El hemograma demuestra Hcto:25%; VCM:82; HCM:32; leucocitos y plaquetas normales. La cinética de hierro resulta normal. El tratamiento más adecuado es:

- a) Sulfato de hierro oral
- b) Transfusiones periódicas de glóbulos rojos
- c) Eritropoyetina subcutánea
- d) Vitamina B12 y hierro, por vía parenteral
- e) Vitamina B12 y hierro, por vía oral

4) Una paciente de 45 años presenta un cuadro de disuria, orinas turbias y fiebre hasta 39°C. Al examen físico está febril, en buenas condiciones, con puño percusión positiva a derecha. Se solicita sedimento de orina que demuestra piocituria y bacteriuria y urocultivo que resulta positivo para E. coli multisensible. El tratamiento de elección es:

- a) Cefadroxilo
- b) Ampicilina
- c) Gentamicina
- d) Nitrofurantoína
- e) Metronidazol

5) ¿Qué alteración es más probable de ser pesquisada en un paciente pediátrico cursando con un síndrome nefrótico por cambios mínimos (nefrosis lipoídea)?

- a) Hipertensión arterial
- b) Hiperlipidemia
- c) Hematuria dismórfica
- d) Hematuria no dismórfica
- e) Hiperproteinemia

6) Una paciente cursando un cuadro diarreico intenso, evoluciona con oliguria y aumento de las pruebas de función renal, con sodio urinario muy disminuido. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome hemolítico urémico
- b) Insuficiencia renal aguda de origen prerrenal
- c) Necrosis tubular aguda
- d) Insuficiencia renal aguda tubulointersticial
- e) Glomerulonefritis aguda postinfecciosa

7) Un paciente de 33 años presenta polidipsia y poliuria de algunos meses de evolución. Actualmente orina cerca de 8 litros al día. Se solicita glicemia que resulta normal. Se realiza test de la sed que demuestra osmolaridades plasmáticas y urinarias basales disminuidas y que se normalizan luego de la privación de agua. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome de secreción inadecuada de ADH
- b) Diabetes insípida nefrogénica
- c) Polidipsia primaria
- d) Diabetes insípida central
- e) Uso de diuréticos

8) Un paciente afectado de cáncer pulmonar, comienza con un cuadro de constipación de 7 días de evolución, al que hace 2 días se le agrega poliuria, y desde hace algunas horas también se agrega desorientación. Al examen físico se aprecia con deshidratación moderada, en sopor profundo, sin alteraciones neurológicas focales. Los signos vitales son normales, al igual que el hemoglucotest. ¿Qué alteración electrolítica es más probable en este paciente?

- a) Hipernatremia
- b) Hiperkalemia
- c) Hipercalcemia
- d) Hiponatremia
- e) Hipocalcemia

9) Un paciente sufre una caída de altura, resultando con fractura expuesta de ambas piernas, con importante hemorragia. Ingresa al hospital donde recibe cristaloides, AINEs y antibióticos endovenosos y luego se reducen las fracturas en pabellón. Evoluciona con oliguria y elevación de la creatinina hasta 3,8 mg/dl. Se mantiene con suero fisiológico, logrando presiones arteriales cercanas a 110/70. Dos días después reinicia diuresis normales, sin embargo la creatinina plasmática se eleva a 4,2 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

- a) Insuficiencia renal prerrenal
- b) Nefritis por AINEs
- c) Necrosis tubular aguda
- d) Insuficiencia renal secundaria a rabdomiolisis
- e) Trombosis de vena renal

10) ¿Cuál de las siguientes opciones es causa frecuente de hiponatremia?

- a) Diabetes insípida
- b) Hipertiroidismo
- c) Uso de furosemida
- d) Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética
- e) Síndrome nefrótico

11) Un paciente diabético tipo 2, en tratamiento con metformina y glibenclamida se realiza exámenes de control que demuestran creatininemia: 0,7 mg/dl, BUN: 8 mg/dl, clearance de creatinina 95 ml/min, proteinuria de 24 horas: 140 mg y albuminuria de 24 horas: 50 mg. Sus exámenes anteriores presentaban valores similares. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar hemoglobina glicosilada
- b) Mantener el tratamiento y controlar en 3 meses
- c) Iniciar insulinoaterapia
- d) Solicitar ecografía renal
- e) Iniciar enalapril

12) Joven de 15 años, con cuadro de 2 días de evolución de odinofagia, fiebre leve y rinorrea. Presenta varios episodios de hematuria indolora. El examen físico resulta normal. La analítica demuestra hemograma, función renal y hepática normales. El sedimento de orina muestra eritrocitos dismórficos abundantes. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad de cambios mínimos (nefrosis lipoídea)
- b) Glomerulopatía membranosa
- c) Glomerulonefritis rápidamente progresiva
- d) Enfermedad de Berger
- e) Glomerulonefritis aguda postestreptocócica

13) Una paciente de 19 años cursando con pielonefritis aguda por *Proteus mirabilis* sensible, inicia tratamiento con ciprofloxacino oral. Al tercer día de estar usando el antibiótico persiste febril y muy decaída. La conducta más adecuada es:

- a) Cambiar el ciprofloxacino por ceftriaxona endovenosa
- b) Solicitar nuevo urocultivo
- c) Mantener el tratamiento con ciprofloxacino y reevaluar en 48 horas
- d) Solicitar cintigrafía renal y vesical
- e) Solicitar ecografía renal

14) Las causas más frecuentes de insuficiencia renal crónica, en niños y adultos, son respectivamente:

- a) Prerenal y prerrenal
- b) Malformaciones nefrourológicas e hipertensión
- c) Glomerulonefritis y diabetes
- d) Malformaciones nefrourológicas y diabetes
- e) Glomerulonefritis e hipertensión arterial

15) El síndrome hemolítico urémico, suele presentarse luego de infecciones intestinales por algunas cepas de *Escherichia coli* enterohemorrágicas y algunas otras enterobacterias. Clínicamente se presenta con:

- a) Edema, orinas espumosas y hematuria
- b) Hipertensión arterial, edema y hematuria
- c) Hematuria, hipertensión arterial y petequias
- d) Edema, petequias y orinas espumosas
- e) Oliguria, palidez y edema

16) La insuficiencia renal crónica produce alteraciones de la homeostasis del calcio y el fósforo, las que se caracterizan por:

- a) Calcio aumentado, fósforo bajo y paratohormona elevada
- b) Calcio disminuido, fósforo disminuido y paratohormona elevada
- c) Calcio bajo, fósforo aumentado y paratohormona disminuida
- d) Calcio disminuido, fósforo alto y paratohormona elevada
- e) Calcio aumentado, fósforo aumentado y paratohormona disminuida

17) ¿Cuál de las siguientes es una indicación de hemodiálisis de urgencia en un paciente con insuficiencia renal?

- a) Anemia severa
- b) Pericarditis urémica
- c) Hipocalcemia que no responde al tratamiento médico
- d) Hipocalcemia que no responde al tratamiento médico
- e) Hipernatremia severa con compromiso de consciencia

18) Un paciente de 67 años presenta insuficiencia renal secundaria a uso de estreptomicina, varios años atrás, con clearance de creatinina actual de 23 ml/min. Ha presentado cifras de presión arterial elevada en varias oportunidades. ¿Cuál es el tratamiento de elección para su hipertensión arterial?

- a) Dieta hiposódica, hipocalórica y ejercicios
- b) IECA más diuréticos
- c) Bloqueadores de calcio
- d) Restricción hidrosalina y diuréticos
- e) Hemodiálisis

19) Un paciente de 35 años, previamente sano y asintomático, presenta en un perfil bioquímico, realizado como chequeo, una calcemia de 11,7 mg/l (VN: 8,5 a 10,5 mg/dl). El examen físico no aporta mayor información. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar furosemida
- b) Solicitar electrocardiograma y pruebas de función renal
- c) Solicitar niveles plasmáticos de paratohormona
- d) Indicar una dieta baja en calcio y controlar con nueva calcemia en 3 meses
- e) Indicar una dieta rica en calcio y controlar con nueva calcemia en 1 mes

20) Un niño de 6 años inicia un cuadro caracterizado por orinas espumosas y edema generalizado. El examen físico no aporta mayor información. En sus exámenes se constata proteinuria de 2,5 g/24h, sin otras alteraciones urinarias, hipoalbuminemia de 2,2 g/dl. El BUN, creatinina y complemento resultan normales y los ANCA y ANA, negativos. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar AINEs
- b) Solicitar biopsia renal
- c) Iniciar corticoides endovenosos y ciclofosfamida
- d) Iniciar IECAs
- e) Iniciar corticoides orales

Prueba 4 (NEFROLOGÍA + UROLOGÍA)

1) ¿De cuál de los siguientes cuadros es característica la aparición de cilindros hemáticos en el sedimento urinario?:

- a) Necrosis tubular aguda.
- b) Lesión a cualquier nivel de las vías urinarias.
- c) Daño glomerular severo.
- d) Daño tubular.
- e) Cualquier lesión de la nefrona.

2) En un paciente con insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo secundario, el tratamiento inicial de su hiperparatiroidismo debe incluir:

- a) Aumento de la ingesta de fósforo.
- b) Restricción del aporte de vitamina D.
- c) Paratiroidectomía total.
- d) Restricción de fósforo en la dieta.
- e) Restricción de la ingesta de calcio.

3) Un enfermo de 20 años acude al hospital por cefalea y orinas oscuras. Se le observa TA de 200/120 mmHg, edema en pies, hematuria macroscópica, urea 140 mg/dl, creatinina 3,4 mg/dl y proteinuria de 2 g/24 horas. Tiene muy probablemente:

- a) Síndrome nefrótico.
- b) Hipertensión vasculo-renal.
- c) Glomerulonefritis membranosa.
- d) Síndrome nefrítico agudo.
- e) Pielonefritis aguda.

4) En un varón de 10 años con un síndrome nefrótico, hematuria macroscópica e hipertensión y que presenta valores muy bajos de la fracción C3 de la cadena del complemento, el diagnóstico más probable es de:

- a) Glomerulonefritis mesangiocapilar.
- b) Glomerulonefritis membranosa.
- c) Hialinosis segmentaria y focal.
- d) Síndrome nefrótico de cambios mínimos.
- e) Nefropatía IgA.

5) Una mujer de 38 años, diagnosticada hace 15 de diabetes, tiene como única complicación conocida una retinopatía. ¿Qué prueba le realizaría para predecir la aparición de nefropatía diabética?:

- a) Proteinuria de 24 horas.
- b) Sedimento urinario.
- c) Creatinina sérica.
- d) Excreción fraccional de sodio.
- e) Microalbuminuria.

6) ¿Cuál de los siguientes hallazgos clínicos constituye un criterio de exclusión en el diagnóstico de cistitis intersticial?:

- a) Capacidad vesical menor de 100 c.c.
- b) Sintomatología miccional rebelde al tratamiento antibiótico.
- c) Urgencia miccional.
- d) Duración de los síntomas miccionales más de año y medio.
- e) Ausencia de polaquiuria nocturna.

7) En el caso de un paciente con hiperplasia prostática benigna, ¿cuál, entre las siguientes circunstancias, NO establece por sí misma indicación de cirugía?:

- a) Hematuria severa recurrente.
- b) Retención urinaria que requiere sondaje vesical permanente.
- c) Infecciones de orina de repetición.
- d) Nicturia de dos veces.
- e) Residuo postmiccional mayor de 200 cc.

8) ¿Cuál es el tratamiento de elección de la hipercalcemia idiopática?:

- a) Furosemida.
- b) Restricción de calcio en la dieta.
- c) Hidroclorotiazida.
- d) Calcitonina.
- e) Vitamina D3.

9) ¿Cuál es el tratamiento de un tumor único urotelial de vejiga que no sobrepasa la lámina propia?:

- a) Radioterapia externa.
- b) Cistectomía radical.
- c) Quimioterapia sistémica.
- d) Resección transuretral.
- e) Cistectomía parcial.

10) En un urocultivo obtenido con micción espontánea se considera como bacteriuria significativa el aislamiento de:

- a) 100 colonias/ml.
- b) 1.000 colonias/ml.
- c) 10.000 colonias/ml.
- d) 50.000 colonias/ml.
- e) 100.000 colonias/ml.

11) Un paciente de 6 años presenta un síndrome nefrótico puro, habiéndose realizado un adecuado estudio de laboratorio. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Iniciar antihipertensivos
- c) Iniciar corticoides
- d) Iniciar hemodiálisis

e) Realizar biopsia renal

12) ¿Qué alteración NO suele presentarse en la insuficiencia renal aguda de tipo prerenal?

- a) Sodio urinario menor a 10 mEq/l
- b) Elevación de la creatinemia
- c) Fracción excretada de sodio menor a 1%
- d) Disminución de la concentración urinaria de nitrógeno
- e) Aumento de la renina plasmática

13) Un paciente con insuficiencia renal crónica presenta síndrome anémico, con Hb: 9,2 g/dl y perfil de hierro normal. Esta condición se trata con:

- a) Transfusiones
- b) Vitamina B12
- c) Vitamina B1
- d) Hierro
- e) Eritropoyetina

14) La hipertensión renovascular se caracteriza por todo lo siguiente, EXCEPTO:

- a) Normalidad del índice aldosterona / actividad de renina plasmática
- b) La enfermedad ateromatosa de las arterias renales es la causa más frecuente en el adulto mayor
- c) La displasia fibromuscular de las arterias renales es la causa más frecuente en los jóvenes
- d) Su tratamiento suele ser con una asociación de diuréticos y inhibidores de la angiotensina II
- e) Suele acompañarse de hipokalemia

15) Un diabético tipo 2 es diagnosticado de hipertensión arterial, por lo que se decide iniciar un iECA. ¿Cuál de las siguientes es una contraindicación de este fármaco?

- a) Hiperkalemia
- b) hemoglobina glicosilada de 8%
- c) Clearance de creatinina de 60 ml/min
- d) Uso concomitante de glibenclamida
- e) Uso concomitante de insulina

16) Un paciente de 30 años presenta un tumor testicular derecho, de consistencia sólida. Se solicita ecografía testicular que confirma el carácter sólido del tumor, por lo que se realiza una orquiectomía radical, cuya biopsia demuestra la presencia de un carcinoma embrionario. Los marcadores tumorales pre y postquirúrgicos son negativos y el TAC de abdomen y pelvis NO visualiza adenopatías retroperitoneales. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar quimioterapia combinada
- b) Realizar radioterapia retroperitoneal
- c) Iniciar hormonoterapia
- d) Realizar linfadenectomía lumboaórtica (LALA modificada)
- e) Solicitar TAC de cerebro

17) El reflujo vesicoureteral leve del lactante suele tratarse con:

- a) Observación bajo profilaxis antibiótica
- b) Instalación de catéter doble jota
- c) Cateterismo limpio, con Sonda nelaton
- d) Diuréticos de asa
- e) Cirugía

18) La uretrorragia es característica de:

- a) Uretritis
- b) Sección uretral
- c) Trauma vesical
- d) Cáncer vesical
- e) Estenosis uretral

19) Un hombre de 26 años presenta hematuria en algunas oportunidades, además ha presentado infecciones urinarias en repetidas ocasiones y en el examen físico se palpa una tumoración abdominal a cada lado. El diagnóstico más probable es:

- a) Cáncer de células renales
- b) Tumor de Wilms
- c) Estenosis pieloureteral
- d) Reflujo vesicoureteral
- e) Riñón poliquístico

20) ¿Cuál de las siguientes asociaciones es INCORRECTA?

- a) Hiperkalemia – Debilidad
- b) Hipokalemia – Debilidad
- c) Hipercalcemia – Tetania
- d) Hipocalcemia – Arritmias
- e) Hiponatremia – compromiso de conciencia

21) Todas estas medidas terapéuticas son aconsejables en el síndrome nefrótico, EXCEPTO:

- a) Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina para disminuir la proteinuria.
- b) Diuréticos del asa para conseguir una disminución del edema de forma eficaz.
- c) Tratamiento anticoagulante de larga duración en el caso de que exista trombosis de la vena renal.
- d) Dietahipoproteica.
- e) Infusión de albúmina intravenosa en situaciones de anasarca refractario.

Prueba 5 (NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA)

1) La primera causa de insuficiencia renal crónica en los niños es:

- a) Hipertensión arterial
- b) Glomerulonefritis aguda
- c) Diabetes mellitus
- d) Malformaciones congénitas
- e) Síndrome hemolítico urémico

2) El examen de elección para diferenciar una insuficiencia renal aguda prerrenal, de una necrosis tubular aguda es:

- a) El clearance de creatinina
- b) La relación BUN/creatinina
- c) El hemograma
- d) La fracción excretada de sodio
- e) El sedimento de orina

3) La conducta más adecuada ante un paciente de 10 años, cursando con un síndrome nefrótico impuro, asociado a hipertensión y hematuria es:

- a) Iniciar con corticoides orales
- b) Administrar pulsos endovenosos de metilprednisolona
- c) Iniciar inmunosupresores, asociados a corticoides endovenosos
- d) Iniciar una asociación de corticoides, inmunosupresores y antibióticos, con cobertura para estreptococo beta hemolítico del grupo A
- e) Derivar para realización de una biopsia renal

4) Un paciente 4 años, ingresa en sopor profundo, luego de una intoxicación accidental con altas dosis de aspirina. Se solicitan gases arteriales con el siguiente resultado:

pH: 7.28 pO₂: 106 mmHg. pCO₂: 12 mmHg. HCO₃: 14 mEq/l.

El diagnóstico ácido base es:

- a) Acidosis respiratoria aislada
- b) Acidosis metabólica aislada
- c) Acidosis respiratoria con alcalosis metabólica
- d) Acidosis metabólica con alcalosis respiratoria
- e) Acidosis metabólica y respiratoria

5)Cuál de las siguientes alternativas representa mejor la clínica del síndrome nefrítico:

- a) Edema, hematuria dismórfica y rápida elevación de la creatinina
- b) Hipertensión arterial, lipiduria y proteinuria
- c) Proteinuria, hematuria dismórfica y orinas espumosas
- d) Edema, hipertensión arterial y hematuria dismórfica
- e) Orina espumosa, hematuria dismórfica y proteinuria

6) Un niño de 7 años, con retraso estatura-ponderal, presenta signos radiológicos de raquitismo y ecográficos de nefrocalcinosis. Los análisis demuestran acidosis metabólica con pH inferior a 7,32 y bicarbonato plasmático inferior a 17 mEq/l. El pH de la orina es siempre superior a 5,5. Presenta además hipercalcemia, hipocitruria y discreta disminución de la resorción del fósforo. No se detecta glucosuria ni aminoaciduria. El diagnóstico más probable es:

- a) Acidosis tubular renal tipo I
- b) Acidosis tubular renal tipo II
- c) Hiperparatiroidismo primario
- d) Insuficiencia renal crónica, con hiperparatiroidismo secundario
- e) Enfermedad poliquística del niño

7) El recuento de colonias necesario para diagnosticar una infección urinaria, por medio de un urocultivo, cuya muestra fue obtenida por punción vesical, es:

- a) 1
- b) 100
- c) 1.000
- d) 10.000
- e) 100.000

8) La causa más frecuente de insuficiencia renal aguda, en los niños es:

- a) Prerenal
- b) Necrosis tubular aguda
- c) Glomerulonefritis aguda
- d) Infección del tracto urinario
- e) Síndrome hemolítico urémico

9) El principal problema de la agenesia renal bilateral congénita es:

- a) Su asociación con cardiopatías congénitas
- b) La necesidad de hemodiálisis a permanencia
- c) Su asociación a defectos del tubo neural
- d) La necesidad de trasplante renal, dentro del primer mes de vida
- e) La incompatibilidad con la vida, dada por hipoplasia pulmonar

10) Una madre trae a su hijo de 4 años, porque continúa orinándose en la cama mientras duerme. Durante el día presenta continencia normal y el desarrollo psicomotor es adecuado para su edad. El diagnóstico más probable es:

- a) Infección urinaria
- b) Malformación congénita urogenital
- c) Enuresis primaria
- d) Hiposecreción de ADH
- e) Sano

11) La conducta más adecuada ante un paciente de 3 meses de edad, cuyo testículo izquierdo es imposible de palpar, es.

- a) Tranquilizar a la madre e indicarle que esta condición no tiene ninguna repercusión negativa sobre el lactante
- b) Solicitar ecografía inguinal y testicular
- c) Realizar orquidopexia quirúrgica al cumplir 18 meses
- d) Realizar orquidopexia inmediata
- e) Realizar laparoscopia abdominal

12) Un niño de 6 años es traído por edema facial y escrotal, asociado a orinas espumosas. Al examen físico se corrobora dicho edema. Se solicitan exámenes que demuestran proteinuria de 4,6 g/24h, lipiduria, sin hematuria. La creatinina, BUN, hemograma, C3 y C4 son normales. El diagnóstico más probable es:

- a) Nefrosis lipoídea
- b) Glomerulonefritis postestreptocócica
- c) Glomeruloesclerosis focal y segmentaria
- d) Glomerulopatía membranosa
- e) Glomerulonefritis mesangiocapilar

13) Una niña de 2 años de edad sufre un episodio de pielonefritis aguda, por Escherichia coli multisensible. La conducta más adecuada para esta paciente es:

- a) Iniciar tratamiento y luego profilaxis antibiótica con ciprofloxacino, sin necesidad de mayor estudio
- b) Iniciar tratamiento y luego profilaxis antibiótica con cefadroxilo, sin necesidad de mayor estudio
- c) Iniciar tratamiento y luego profilaxis antibiótica con cefadroxilo y solicitar ecografía abdominal y uretrocistografía miccional
- d) Iniciar tratamiento con nitrofurantoína y solicitar urocultivos mensuales seriados
- e) Iniciar tratamiento con ciprofloxacino y solicitar urocultivos mensuales seriados

14) Un paciente 4 años, cursando un cuadro disentérico, evoluciona con palidez y oligoanuria. Al examen se aprecia hidratado, con leve edema palpebral. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Síndrome nefrítico postinfeccioso
- b) Síndrome hemolítico urémico
- c) Insuficiencia renal aguda prerrenal
- d) Sepsis por bacterias Gram negativas
- e) Síndrome nefrótico

15) La primera medida que debe tomarse ante una hiperkalemia grave, que cursa con bradicardia, es:

- a) Realizar hemodiálisis de urgencia
- b) Administrar insulina y glucosa endovenosa
- c) Iniciar beta agonistas por nebulización
- d) Administrar gluconato de calcio endovenoso
- e) Administrar suero fisiológico por vía periférica

16) Joven de 15 años, con cuadro de dos días de evolución, de odinofagia, fiebre leve y rinorrea. Presenta varios episodios de hematuria indolora. El examen físico resulta normal. La analítica demuestra hemograma, función renal y hepática normales. El sedimento de orina muestra eritrocitos dismórficos abundantes. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad de cambios mínimos (nefrosis lipoídea)
- b) Glomerulopatía membranosa
- c) Glomerulonefritis rápidamente progresiva
- d) Enfermedad de Berger
- e) Glomerulonefritis aguda postestreptocócica

17) Un recién nacido de 24 horas de vida, con un peso de 2.500 g. Presenta signos de irritabilidad, apnea, arritmia cardíaca y finalmente convulsiones. El diagnóstico más probable es:

- a) Hipercalcemia
- b) Hipocalcemia
- c) Hiponatremia
- d) Hiperkalemia
- e) Hipokalemia

18) Un niño de 11 años presenta hematuria dismórfica, asociado a artralgias y aparición de lesiones eritematosas, palpables, que no blanquean a la compresión, en ambas extremidades. En una ocasión presenta además hematoquezia. El diagnóstico más probable es:

- a) Púrpura de Schönlein-Henoch
- b) Granulomatosis de Wegener
- c) Síndrome hemolítico urémico
- d) Tumor de Wilms
- e) Sepsis diseminada de foco urinario inicial

19) El riñón poliquístico del niño es un trastorno:

- a) Autosómico dominante
- b) Autosómico recesivo
- c) Ligado al cromosoma X
- d) De herencia mitocondrial
- e) No hereditario

20) Un niño de un año de edad, cursando infección respiratoria alta, con buena evolución, presenta presión arterial de 120/80 mmHg en 3 mediciones distintas. La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio sin necesidad de nuevos controles de presión arterial
- b) Enviar a domicilio y realizar pesquisa de hipertensión arterial cada 6 meses
- c) Iniciar dieta hiposódica
- d) Iniciar tratamiento antihipertensivo con iECA
- e) Iniciar estudio en busca de una causa de hipertensión arterial secundaria

Prueba 6 (NEFROLOGÍA + UROLOGÍA)

1) Un niño de 6 años presenta aumento de volumen facial. Al examen físico están en buenas condiciones generales, con frecuencia cardíaca y presión arterial normales. Se visualiza edema de extremidades inferiores, escroto y cara, sin otras alteraciones. En sus exámenes de laboratorio, presenta una creatininemia normal, proteinuria de 2,8 g en 24 horas, sedimento de orina con visualización de gotas de grasa, sin hematuria, albuminemia: 2,3 g/dl, ANA negativo y complemento normal. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar diuréticos
- b) Derivar para realizar biopsia renal
- c) Iniciar corticoides orales
- d) Iniciar corticoides endovenosos, más ciclofosfamida
- e) Observar evolución

2) Un paciente de 75 años, consulta porque le detectaron la presión arterial elevada a 160/110 mmHg. Se toman varias mediciones de presión arterial, obteniendo varias cifras cercanas a 160/100. Previo a esto sus presiones arteriales habían resultado normales. Se solicita creatinina: 1,0 mg/dl, Hcto: 41%, blancos: 7.000 x mm³, plaquetas: 370.000 x mm³, VHS: 20 mm/h, sodio plasmático: 140 mEq/l, Cloro plasmático: 102 mEq/l, potasio plasmático: 3,0 mEq/l. El diagnóstico más probable es:

- a) Hipertensión renovascular
- b) Feocromocitoma
- c) Hipertensión arterial esencial
- d) Nefropatía médica
- e) Sano

3) Un paciente sufre una caída de un caballo, resultando con una herida en la pierna izquierda, que sangra de manera abundante, antes de ser adecuadamente tratada. Evoluciona con oliguria y malestar general, por lo que recibe 2 litros de suero fisiológico por vía endovenosa. Al día siguiente mejora parcialmente la diuresis, pero se controla creatinina plasmática de 3,3 mg/dl. En sus exámenes de orina destaca sodio urinario de 5 mEq/l, potasio urinario de 20 mEq/l y osmolaridad urinaria alta. El diagnóstico más probable es:

- a) Insuficiencia renal aguda prerrenal
- b) Necrosis tubular aguda
- c) Glomerulonefritis aguda
- d) Insuficiencia renal aguda secundaria a rabdomiolisis
- e) Insuficiencia renal aguda secundaria a hemólisis

4) El tratamiento de la necrosis tubular aguda habitualmente consiste en:

- a) Corticoides
- b) Reposición de volumen
- c) Diuréticos
- d) Antihipertensivos
- e) Alcalinización de la orina

5) Un paciente de 34 años, portador del virus de la inmunodeficiencia humana, presenta un síndrome nefrótico, con proteinuria de 5 g/24 horas, sedimento de orina con 8-10 hematíes por campo y albuminemia de 2,5 g/dl. Sus niveles de complemento, así como su función renal son normales. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad de Berger
- b) Glomerulopatía por cambio mínimos
- c) Nefropatía extramembranosa
- d) Glomerulonefritis mesangiocapilar
- e) Lupus sistémico

6) Una mujer de 20 años presenta hematuria, asociada a edema de extremidades inferiores. Al examen físico se aprecia algo pálida, con FC: 77x', PA: 170/110 mmHg y edema marcado en las extremidades inferiores y en los párpados. Se solicitan exámenes que demuestran sedimento de orina con eritrocitos dismórficos abundantes y cilindros eritrocitarios, proteinuria 1,5 g/24h, creatinina plasmática: 1,1 mg/dl, BUN: 20 mg/dl, complemento disminuido. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome nefrítico
- b) Síndrome nefrótico impuro
- c) Síndrome nefrótico puro
- d) Glomerulonefritis aguda rápidamente progresiva
- e) Síndrome hemolítico urémico

7) El mejor examen para diferenciar una insuficiencia renal crónica de una insuficiencia renal aguda es:

- a) Clearance de creatinina
- b) Calcemia y niveles plasmáticos de paratohormona
- c) Fracción excretada de sodio
- d) Ecografía
- e) Relación BUN/crea

8) Un paciente de 67 años, con diagnóstico de cáncer de pulmón, presenta compromiso de conciencia. Al examen físico se aprecian signos de enclavamiento transtentorial y el TAC de cerebro demuestra edema cerebral y herniación del uncus del lóbulo temporal derecho. ¿Qué alteración es más probable?

- a) Hipocalcemia
- b) Hipercalcemia
- c) Hiponatremia
- d) Hipernatremia
- e) Hiperkalemia

9) Un paciente de 60 años, asintomático, diabético en tratamiento con metformina, se realiza exámenes de control, que muestran una proteinuria de 24 horas de 200 mg y una albuminuria de 24 horas de 10 mg. La creatinina plasmática resulta 0,6 mg/dl. Su examen físico es normal y sus exámenes anteriores habían mostrado valores similares. La conducta más adecuada es:

- a) Mantener el tratamiento y controlar en 3 meses
- b) Iniciar un IECA
- c) Iniciar un diurético
- d) Solicitar índice proteinuria/creatininuria
- e) Iniciar insulina

10) ¿Qué alteración, de entre las enumeradas, aparece más tardíamente en un paciente con insuficiencia renal crónica?

- a) Anemia
- b) Elevación de la paratohormona
- c) Acidosis metabólica
- d) Elevación del nitrógeno ureico urinario
- e) Disminución de la calcemia

Preguntas Urología

11) Un paciente de 30 años consulta por aumento de volumen testicular derecho. Al examen físico se palpa un tumor testicular derecho de cerca de 4 cm de diámetro. Se solicita una ecografía testicular que confirma el carácter sólido del tumor. Se solicita gonadotropina coriónica y alfa-fetoproteína, que resultan negativas. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
- b) Solicitar biopsia por punción
- c) Realizar tumorectomía
- d) Realizar orquiectomía radical
- e) Observar evolución

12) ¿Cuál de las siguientes alternativas NO es una indicación de cirugía en una uropatía obstructiva por hiperplasia benigna de la próstata?

- a) Elevación del antígeno prostático
- b) Infecciones urinarias a repetición
- c) Litiasis vesical
- d) Retención urinaria aguda
- e) Hematuria recurrente

13) Un paciente de 80 años, diabético e hipertenso, se realiza un tacto rectal que muestra un nódulo en el lóbulo prostático izquierdo, de 1 cm. No presenta síntomas, y además se mide el antígeno prostático específico, el que resulta 5,1 ng/dl. Por lo anterior, se indica una biopsia transrectal, que muestra un adenocarcinoma de próstata de grado moderado de diferenciación. El estudio complementario no visualiza invasión de otros órganos ni metástasis. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar hormonoterapia
- b) Realizar prostatectomía radical
- c) Indicar quimioterapia
- d) Realizar resección transuretral
- e) Observar evolución

14) Un paciente sufre una caída de altura, con un golpe en la zona lumbar. Evoluciona con dolor y hematuria importante. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar clearance de creatinina
- b) Solicitar sedimento de orina
- c) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
- d) Solicitar uretrocistografía retrógrada endoscópica
- e) Realizar cistoscopia

15) Un paciente de 64 años de edad, presenta hematuria en una oportunidad, por lo que se realiza una ecografía que muestra un tumor renal sólido de 6 cm en el riñón derecho. La tomografía axial computada no visualiza adenopatías. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar nefrectomía parcial
- b) Realizar nefrectomía radical
- c) Realizar biopsia por punción con aguja gruesa
- d) Realizar tumorectomía más quimioterapia
- e) Realizar tumorectomía más radioterapia

16) El tratamiento de la uretritis no gonocócica es:

- a) Ciprofloxacino oral por una vez
- b) Ceftriaxona intramuscular por una vez
- c) Metronidazol oral
- d) Doxiciclina oral
- e) Penicilina benzatina intramuscular

17) Una mujer de 60 años consulta por escapes de pequeñas cantidades de orina, desde hace 2 semanas, en relación a esfuerzos y cuando tose. El examen físico es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar perfil uretral
- b) Solicitar cistomanometría
- c) Solicitar orina completa y urocultivo
- d) Iniciar anticolinérgicos
- e) Resolver quirúrgicamente con un TVT

18) ¿Qué examen es el más adecuado para el estudio de un paciente con un cólico renal?

- a) Radiografía
- b) Ecografía
- c) TAC sin contraste
- d) Resonancia magnética nuclear
- e) TAC con contraste

19) Un hombre de 20 años consulta por aumento dolor recurrente en el testículo izquierdo. Al examen físico se aprecia aumento de volumen escrotal, blando, en consistencia de bolsa de gusanos, que aumenta al ponerse de pie. El diagnóstico más probable es:

- a) Hidrocele
- b) Varicocele
- c) Epididimitis
- d) Cáncer testicular
- e) Torsión testicular

20) ¿Cómo debe hacerse el screening para cáncer de próstata en un paciente cuyo padre murió de cáncer de próstata?

- a) Tacto rectal y APE desde los 40 años
- b) Tacto rectal y APE desde los 50 años
- c) APE desde los 50 años
- d) Tacto rectal desde los 40 años y APE desde los 50 años
- e) Tacto rectal desde los 50 años y APE desde los 40 años

Prueba 7 (NEFROLOGÍA + UROLOGÍA)

1) La hematuria dismórfica es característica de:

- a) Nefrosis lipoídea
- b) Nefropatía membranosa
- c) Glomerulonefritis aguda
- d) Glomeruloesclerosis focal y segmentaria
- e) Síndrome hemolítico urémico

2) Un niño de 5 años presenta diarrea aguda, de 2 días de evolución. Evoluciona con oliguria, edema palperal, hipertensión arterial. Se solicitan exámenes que muestran Hcto: 35%, blancos: 12.500 xmm³, plaquetas: 90.000 x mm³, creatinina: 5,1 mg/dl, BUN: 70 mg/dl, Na: 130 mEq/l, K: 5,5 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

- a) Crioglobulinemia
- b) Glomerulonefritis postinfecciosa
- c) Insuficiencia renal aguda prerrenal
- d) Necrosis tubular aguda
- e) Síndrome hemolítico urémico

3) ¿Cuál de los siguientes cuadros clínicos es más sugerente de una hipocalcemia?

- a) Constipación, poliuria, astenia y acortamiento del segmento QT
- b) Poliuria, desorientación, taquicardia y parestesias
- c) Debilidad, espasmos musculares, hiperreflexia y arritmias
- d) Ensanchamiento del complejo QRS, ondas T picudas y debilidad muscular
- e) Tetraparesia, arreflexia y disminución del tono muscular

4) La primera causa de insuficiencia renal aguda en la edad pediátrica es:

- a) Malformaciones nefrourológicas
- b) Glomerulonefritis aguda
- c) Síndrome hemolítico urémico
- d) Necrosis tubular aguda
- e) Prerenal

5) Un paciente de 25 años presenta niveles de presión arterial cercanos a 160/100 mmHg en promedio. En sus exámenes generales se aprecia creatinina: 1,0 mg/dl, Na: 140 mEq/l, K: 3,0 mEq/l, Cl: 104 mEq/l. El examen físico no muestra alteraciones. El diagnóstico más probable es:

- a) Hipertensión renovascular
- b) Hipertensión esencial
- c) Feocromocitoma
- d) Glomerulopatía médica
- e) Pseudohipertensión (hipertensión del delantal blanco)

6) Una paciente de 25 años presenta hematuria, hipertensión y elevación de la creatinina plasmática. Se solicita complemento que resulta marcadamente disminuido. El diagnóstico más probable es:

- a) Glomerulonefritis por IgA
- b) Glomerulopatía membranosa
- c) Lupus
- d) Glomerulonefritis paucimune
- e) Glomerulopatía por cambio mínimos

7) ¿Cuál de las siguientes medidas es MENOS importante para evitar la progresión de la insuficiencia renal crónica?

- a) Evitar el uso de AINES
- b) Mantener la diuresis con diuréticos
- c) Manejar las dislipidemias con estatinas
- d) Iniciar inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina
- e) Manejar la hipertensión arterial y la diabetes

8) El síndrome nefrótico puro se caracteriza por todo lo siguiente EXCEPTO:

- a) Orinas espumosas
- b) Dislipidemia
- c) Hipertensión arterial
- d) Edema
- e) Hipoalbuminemia

9) ¿Cuál de las siguientes asociaciones entre el diurético y su efecto sobre los electrolitos es CORRECTA?

- a) Furosemida – aumento de los niveles plasmáticos de potasio
- b) Hidroclorotiazida – aumento de los niveles plasmáticos de calcio
- c) Espironolactona – disminución de los niveles plasmáticos de potasio
- d) Espironolactona – aumento de los niveles plasmáticos de sodio
- e) Triamterene – disminución de los niveles plasmáticos de potasio

10) Una paciente presenta un accidente automovilístico, resultando con hemorragia importante. Evoluciona con oliguria y elevación de la creatinina. Se inicia suero fisiológico, con reinicio de la diuresis, a 4.000 cc/día. Al tercer día se solicitan exámenes que muestran creatinina plasmática: 4,4 mg/dl. BUN: 65 mg/dl, Na plasmático: 132 mEq/l, Na urinario: 30 mEq/l, sedimento urinario: cilindros granulados. El diagnóstico más importante es:

- a) Insuficiencia renal aguda prerrenal
- b) Necrosis tubular aguda
- c) Nefritis intersticial
- d) Insuficiencia renal por rhabdomiolisis
- e) Trauma renal

Preguntas Urología

11) Un hombre de 30 años presenta un tumor testicular derecho, de 2 cm de diámetro, que en la ecografía se aprecia de consistencia sólida. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar biopsia por punción con aguja fina
- b) Controlar con nueva ecografía en 3 meses
- c) Solicitar niveles plasmáticos de alfafetoproteína y de gonadotropina coriónica y decidir la conducta según los niveles plasmáticos
- d) Realizar orquiectomía radical
- e) Realizar tumorectomía y solicitar biopsia de la pieza quirúrgica

12) Una paciente de 65 años presenta un tumor renal de 5 cm de diámetro, de carácter sólido en la ecografía. Se solicita un TAC que muestra un tumor renal compatible con un carcinoma de células renales y que no visualiza compromiso de los vasos renales ni adenopatías. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar nefrectomía radical
- b) Realizar tumorectomía
- c) Realizar nefrectomía radical y quimioterapia postquirúrgica
- d) Realizar tumorectomía y quimioterapia postquirúrgica
- e) Realizar nefrectomía radical y radioterapia postquirúrgica

13) Un paciente de 50 años se realiza una ecografía abdominal, como parte del estudio de un cuadro de dolor abdominal, que muestra un quiste renal simple de 6 cm de diámetro en el riñón derecho. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar drenaje por punción
- b) Realizar resección quirúrgica
- c) Observar evolución
- d) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
- e) Realizar marsupialización quirúrgica

14) Un paciente de 35 años consulta por aparición de lesiones polipoideas, rugosas en el surco balanoprepucial, indoloras. El agente causal más probable es:

- a) Virus herpes simple
- b) Chlamydia trachomatis
- c) Virus papiloma humano
- d) Neisseria gonorrhoeae
- e) Treponema pallidum

15) Una paciente de 68 años presenta hematuria en 4 ocasiones sin otros síntomas. Se solicita un sedimento de orina que muestra más de 100 GR por campo, sin dismorfia y un urocultivo que resulta negativo. Se solicita ecografía renal y vesical que resulta normal. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar ANA, ANCA y complemento
- b) Solicitar cistoscopia
- c) Solicitar pielografía de eliminación
- d) Solicitar baciloscopias de orina
- e) Observar evolución

16) Un paciente de 57 años se realiza un APE que resulta 6,8 mg/dl. No presenta síntomas y el tacto rectal es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar ecografía prostática y vesical
- b) Solicitar biopsia prostática transrectal
- c) Controlar en 1 año con APE y tacto rectal
- d) Solicitar urodinamia
- e) Realizar resección transuretral

17) Un paciente de 20 años ha presentado hematuria en varias oportunidades. Además refiere infecciones urinarias recurrentes y en sus exámenes de laboratorio se constata elevación de la creatinina plasmática. Al examen físico se palpa una masa abdominal en relación a cada riñón. El diagnóstico más probable es:

- a) Tumor de Wilms
- b) Cáncer de células renales
- c) Hidroureteronefrosis
- d) Cálculos renales coraliformes
- e) Riñón poliquístico

18) Un adolescente de 15 años presenta dolor testicular izquierdo de inicio súbito, intenso, asociado a aumento de volumen. No presenta otros síntomas ni presenta antecedentes médicos de importancia. El diagnóstico más probable es:

- a) Orquiepididimitis
- b) Cáncer testicular
- c) Hidrocele
- d) Varicocele
- e) Torsión testicular

19) A un niño de 1 año no se le palpa el testículo izquierdo. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar ecografía inguinoescrotal
- b) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
- c) Solicitar cariograma
- d) Realizar laparotomía exploradora
- e) Solicitar niveles plasmáticos de testosterona

20) ¿Cuál de las siguientes alternativas NO es una indicación de cirugía en un paciente con hiperplasia benigna de la próstata?

- a) Hematuria
- b) Nódulo prostático al tacto rectal
- c) Infección urinaria
- d) Insuficiencia renal postrenal
- e) Litiasis vesical

Prueba 8 (NEFROLOGÍA + UROLOGÍA)

Preguntas Nefrología

1) Un paciente de 67 años, hipertenso y portador de una insuficiencia renal crónica, usuario de Losartán, presenta marcado malestar del estado general, constatándose una hiperkalemia grave, con compromiso del ritmo cardíaco. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar suero fisiológico y diuréticos de asa endovenosos
- b) Realizar hemodiálisis de urgencia
- c) Administrar gluconato de calcio e iniciar insulina más suero glucosado por vía endovenosa
- d) Administrar sulfato de magnesio endovenoso e iniciar nebulizaciones con salbutamol
- e) Iniciar insulina cristalina en suero glucosado y realizar nebulizaciones con salbutamol

2) Un paciente con insuficiencia renal crónica, secundaria a hipertensión arterial, presenta palidez, constatándose hematocrito de 27%, con hemoglobina de 9 g/dl y VCM: 90 ft. Se solicita clearance de creatinina que resulta 45ml/min y perfil de hierro que muestra ferremia, transferrina y ferritina normales. El tratamiento más adecuado es:

- a) Iniciar hemodiálisis
- b) Iniciar vitamina B12 y folatos
- c) Iniciar hierro oral
- d) Iniciar hierro endovenoso
- e) Iniciar eritropoyetina subcutánea

3) Un paciente de 58 años, diabético tipo 2, consulta por orinas espumosas y edema facial y de extremidades inferiores. Al examen físico presenta signos vitales normales y edema generalizado. Se solicita clearance de creatinina que resulta 78 ml/min, proteinuria de 24 horas de 5 gramos, sedimento de orina con cilindros hialinos, sin otras alteraciones, albuminemia plasmática de 2,6 g/dl y perfil lipídico, que demuestra hipercolesterolemia LDL. El diagnóstico más probable es:

- a) Nefropatía por cambio mínimos
- b) Nefropatía diabética
- c) Glomerulonefritis mesangiocapilar
- d) Glomerulopatía membranosa
- e) Glomerulonefritis por depósitos de IgA

4) Una paciente con antecedente de enfermedad celíaca, presenta debilidad y espasmos musculares generalizados. Al examen físico se aprecia hiperreflexia y signo de Chovstek. El diagnóstico más probable es:

- a) Hiponatremia
- b) Hipokalemia
- c) Hipocalcemia
- d) Hipomagnesemia
- e) Hipofosfemia

5) Un hombre de 45 años presenta presión arterial cercana a 150/90 mmHg en varias tomas, realizadas en días distintos. Al examen físico presenta IMC: 31, sin otras alteraciones. Se constata hemograma normal, natremia: 140 mEq/l, potasemia: 4,2 mEq/l, cloremia: 100 mEq/l, creatininemia: 0,7 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

- a) Hipertensión arterial esencial
- b) Hipertensión renovascular
- c) Hiperaldosteronismo primario
- d) Nefropatía médica
- e) Feocromocitoma

6) Un paciente de 6 años, cursando una diarrea aguda severa, evoluciona con deshidratación importante, presentando oliguria marcada. Recibe hidratación con suero fisiológico, reanudando diuresis de alto volumen, sin embargo presenta creatinina persistentemente elevada hasta 4,7 mg/dl.

El diagnóstico más probable es:

- a) Nefritis intersticial
- b) Síndrome hemolítico urémico
- c) Insuficiencia renal aguda prerrenal
- d) Glomerulonefritis postinfecciosa
- e) Necrosis tubular aguda

7) Un paciente de 25 años, diagnosticado de granulomatosis de Wegener, evoluciona con anuria, malestar general, edema de extremidades inferiores y luego desorientación. Al examen físico se aprecia sopor superficial, asterixis, hipertensión arterial y frotos pericárdicos. El TAC de cerebro resulta normal y la creatinina plasmática resulta 6,3 mg/dl, con BUN: 110 mg/dl. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar corticoides, asociados a ciclofosfamida y administrar furosemida endovenosa
- b) Administrar corticoides, asociados a ciclofosfamida y administrar nitroprusiato endovenoso
- c) Administrar corticoides, asociados a ciclofosfamida y realizar hemodiálisis de urgencia
- d) Administrar corticoides, asociados a ciclofosfamida e iniciar sulfato de magnesio endovenoso
- e) Administrar corticoides, asociados a ciclofosfamida y observar evolución

8) El tratamiento del hiperparatiroidismo secundario a la insuficiencia renal se basa en:

- a) La paratiroidectomía
- b) El aumento de la ingesta de calcio y de fósforo
- c) El aumento de la ingesta de calcio y disminución de la ingesta de fósforo
- d) La disminución de la ingesta de calcio y aumento de la ingesta de fósforo
- e) La disminución de la ingesta de calcio y fósforo

9) Es característico de la insuficiencia renal aguda prerrenal:

- a) La disminución de la fracción excretada de sodio
- b) La disminución de la osmolaridad urinaria
- c) La disminución del nitrógeno ureico urinario
- d) El aumento de la concentración urinaria de sodio
- e) La disminución de la relación BUN / creatininemia

10) El diagnóstico más probable frente a un niño de 6 años que cursa con hematuria dismórfica, hipertensión arterial y edema palpebral, asociado a creatinina plasmática de 1,2 mg/dl y disminución del complemento es:

- a) Nefrosis lipoídea
- b) Glomerulonefritis aguda postestreptocócica
- c) Enfermedad de Berger
- d) Glomerulonefritis pauciinmune
- e) Glomeruloesclerosis focal y segmentaria

11) La conducta más adecuada para el manejo de un niño de 7 años cursando un síndrome nefrótico puro es:

- a) Observar evolución
- b) Iniciar diuréticos
- c) Iniciar IECAs
- d) Iniciar corticoides
- e) Derivar para realización de biopsia renal

Preguntas Urología

12) Un hombre de 36 años consulta por disuria y fiebre, asociadas a lesiones en el pene. Al examen físico se constata t°: 38,9°C, adenopatías inguinales bilaterales y se observan múltiples úlceras en el glande, dolorosas, de fondo blanquecino. El diagnóstico más probable es:

- a) Linfogranuloma venéreo
- b) Herpes genital
- c) Sífilis primaria
- d) Chancroide genital
- e) Balanouretritis gonocócica

13) Un paciente de 24 años nota aumento de volumen testicular. Al examen físico se palpa un tumor testicular izquierdo de cerca de 2 cm de diámetro. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar marcadores tumorales
- b) Observar evolución
- c) Solicitar ecografía testicular
- d) Solicitar biopsia por punción
- e) Realizar orquiectomía radical

14) La incontinencia urinaria de urgencia se caracteriza por todo lo siguiente, EXCEPTO:

- a) Escapes de pequeñas cantidades de orinal
- b) Contracciones no inhibidas del detrusor en la cistomanometría
- c) Respuesta al tratamiento con anticolinérgicos
- d) Presentarse principalmente en pacientes de sexo femenino
- e) Ser simulada por otras patologías, como infecciones urinarias o cáncer de vejiga

15) Un paciente de 60 años, monorroño de nacimiento, se realiza un TAC de abdomen y pelvis, visualizándose un tumor renal sólido de 2 cm de diámetro en el polo superior de su único riñón, sin visualización de adenopatías ni de compromiso la vena renal. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Nefrectomía parcial
- c) Realizar nefrectomía radical
- d) Realizar nefrectomía parcial y radioterapia postoperatoria
- e) Realizar nefrectomía radical y quimioterapia postquirúrgica

16) Un paciente presenta un tumor testicular, el que es removido por una orquiectomía radical, comprobándose histológicamente un teratoma maligno. El TAC de tórax, abdomen y pelvis no visualiza adenopatías sospechosas ni metástasis a distancia. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar quimioterapia
- b) Realizar linfadenectomía lumboaórtica
- c) Realizar radioterapia retroperitoneal
- d) Iniciar hormonoterapia con testosterona
- e) Iniciar hormonoterapia con análogos de GnRH

17) Un paciente con antecedente de hiperplasia benigna de la próstata, en tratamiento con tamsulosina, consulta por imposibilidad de orinar, de 6 horas de evolución, asociado a intenso dolor abdominal. Al examen físico se palpa globo vesical. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar cistostomía suprapúbica
- b) Drenar con sonda Nelaton
- c) Instalar sonda Foley a permanencia
- d) Indicar sondeo vesical intermitente
- e) Administrar anticolinérgicos endovenosos

18) Un paciente de 55 años consulta por disminución del calibre miccional, asociado a disuria de esfuerzo, nicturia de 2 veces y latencia de 30 segundos antes de empezar a orinar. El diagnóstico más probable es:

- a) Hiperplasia benigna de la próstata
- b) Cáncer de próstata
- c) Cistitis intersticial
- d) Estenosis pieloureteral
- e) Ureterocele

19) Un paciente de 45 años consulta por dolor lumbar derecho intenso, irradiado a los genitales, asociado a agitación psicomotora y vómitos. Se solicita pielotAC de abdomen y pelvis, que muestra un cálculo cálcico de 2,1 cm de diámetro en relación al tercio medio del uréter derecho y se inicia analgesia y antieméticos, logrando remisión parcial. La conducta más adecuada para el manejo de este paciente es:

- a) Resolver quirúrgicamente
- b) Realizar litotripsia extracorpórea
- c) Iniciar alcalinización de la orina
- d) Iniciar acidificación de la orina
- e) Aumentar la ingesta de líquidos y observar evolución

20) Un hombre de 65 años, presenta hematuria recurrente desde hace 5 días, sin otros síntomas. El examen físico no presenta alteraciones y los exámenes de orina demuestran hematuria de más de 100 glóbulos rojos por campo, sin dismorfia, sin otras alteraciones y con hemocultivos negativos. La conducta inicial más adecuada es:

- a) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
- b) Solicitar ecografía renal y vesical
- c) Solicitar uretrocistografía retrógrada
- d) Solicitar cistoscopia
- e) Solicitar pielografía de eliminación endovenosa

Prueba 9

1) Un paciente de 30 años sufre un shock séptico, el que es manejado oportunamente con drogas vasoactivas y volumen, sin embargo evoluciona con elevación persistente de la creatinina plasmática. En sus exámenes destaca un sodio urinario de 30 mEq/l y cilindros granulosos en el sedimento de orina. El diagnóstico más probable es:

- a) Necrosis tubular aguda
- b) Insuficiencia renal aguda prerrenal
- c) Sépsis renal
- d) Glomerulonefritis aguda postinfecciosa
- e) Glomerulonefritis aguda rápidamente progresiva

2) ¿Cuál de las siguientes alteraciones es MENOS probable de encontrar en un síndrome nefrótico por cambios mínimos?

- a) Hematuria
- b) Hipercolesterolemia
- c) Infecciones neumocócicas
- d) Hipoalbuminemia
- e) Anasarca

3) Un paciente de 68 años, diabético e insuficiente renal crónico de larga data, ha presentado una lenta caída en su volumen de micción, con una diuresis actual de cerca de 200cc al día. ¿Qué examen le parece más adecuado para decidir el inicio de terapia dialítica?

- a) Albuminuria de 24 horas
- b) Fracción excretada de sodio
- c) Sedimento de orina
- d) Ecografía abdominal
- e) Clearance de creatinina

4) Un niño de 2 años, cursando una disentería aguda febril, evoluciona con oliguria marcada, edema de extremidades inferiores y hematuria. Al examen físico se aprecia pálido, decaído, con hipertensión arterial y edema de cara y extremidades inferiores. El diagnóstico más probable es:

- a) Insuficiencia renal aguda prerrenal
- b) Glomerulonefritis aguda
- c) Síndrome nefrótico impuro
- d) Síndrome nefrítico
- e) Síndrome hemolítico-urémico

5) Un paciente insuficiente renal crónico, diabético e hipertenso, en tratamiento con dieta y enalapril, consulta por síncope. Al examen físico se constata frecuencia cardíaca de 40x'. El electrocardiograma muestra prolongación del intervalo PR, con un pequeño infradesnivel del segmento ST y ondas T picudas. El diagnóstico más probable es:

- a) Hipocalcemia
- b) Hipercalcemia
- c) Hipomagnesemia
- d) Hiperkalemia
- e) Hipokalemia

6) Una paciente de 20 años consulta por disuria y fiebre hasta 39°C. Al examen físico está decaída, febril, con PA: 120/80 mmHg, FC: 85x', orientada e hidratada. Presenta puño-percusión (+). Se solicita sedimento de orina que muestra abundantes leucocitos y presencia de bacterias. El urocultivo está pendiente. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar tratamiento sintomático, hasta obtener el resultado del urocultivo
- b) Iniciar nitrofurantoína y controlar en 48 horas con el urocultivo
- c) Iniciar ciprofloxacino y controlar en 48 horas con el urocultivo
- d) Iniciar cefadroxilo y controlar en 10 días con nuevo urocultivo
- e) Iniciar amoxicilina y controlar en 10 días con nuevo urocultivo

7) Un paciente de 6 años presenta una amigdalitis, tratada con amoxicilina. Diez días después consulta por hematuria. Al examen físico se aprecia hipertenso, con edema de extremidades inferiores. ¿Qué alteración es más compatible con una glomerulonefritis aguda postestreptocócica?

- a) Caída de la fracción excretada de sodio
- b) Cilindros eritrocitarios
- c) Complemento normal
- d) Proteinuria de 24 horas de 2 gramos por metro cuadrado de superficie corporal
- e) Elevación de los anticuerpos antinucleares

8) ¿Cuál es la primera alteración detectable en la nefropatía diabética, y que marca su inicio?

- a) Aumento de la creatinina plasmática
- b) Elevación de la paratohormona plasmática
- c) Aumento de la relación BUN/Creatininemia
- d) Microalbuminuria
- e) Glucosuria

9) Interprete los siguientes gases venosos: pH: 7,0; Bic: 5 mmol/l, PO₂: 20 mmHg, BE: -25

- a) Acidosis metabólica
- b) Acidosis respiratoria
- c) Acidosis respiratoria con alcalosis metabólica
- d) Acidosis metabólica con alcalosis respiratoria
- e) Error en la toma de muestra

10) Un paciente de 17 años es diagnosticado de hipertensión arterial. En sus exámenes destaca hipokalemia. ¿Qué diagnóstico debe sospechar en primer lugar?

- a) Hipoaldosteronismo
- b) Glomerulopatía médica
- c) Feocromocitoma
- d) Hipertensión renovascular
- e) Hipertensión esencial

11) La asociación de masa renal bilateral, insuficiencia renal, hematuria e infecciones urinarias recurrentes debe hacer sospechar el diagnóstico de:

- a) Tumor de Wilms
- b) Tumor de células renales
- c) Hidroureteronefrosis
- d) Riñón poliquístico
- e) Amiloidosis

12) Una niña de 3 años ha presentado 3 episodios de pielonefritis aguda en los últimos 3 meses. Cuenta con ecografía renal y vesical y con uretrocistografía miccional seriada, ambas normales. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar profilaxis antibiótica con cefadroxilo y controlar con urocultivos seriados
- b) Controlar con urocultivos seriados, sin necesidad de profilaxis antibiótica
- c) Solicitar cintigrafía renal y decidir conducta según resultados
- d) Iniciar profilaxis antibiótica con nitrofurantoína e controlar con ecografías renales y urocultivos seriados
- e) Iniciar profilaxis antibiótica con nitrofurantoína e controlar con cintigrafías renales y urocultivos seriados

13) ¿Cuál de los siguientes antibióticos debe ser ajustado por función renal?

- a) Cloxacilina
- b) Ceftriaxona
- c) Clindamicina
- d) Eritromicina
- e) Vancomicina

14) Un paciente de 65 años, hospitalizado por un TEC severo, con hematoma subdural que debió ser drenado quirúrgicamente, presenta en sus exámenes creatinina plasmática: 0,6 mg/dl, Na: 130 mEq/l, K: 3,9 mEq/l, Cl: 99 mEq/l, Ca: 9,0 mg/dl, albúmina: 4,2 g/dl y sedimento de orina normal. Se recupera de buena forma y su examen físico no demuestra alteraciones. La causa más probable de sus alteraciones electrolíticas es:

- a) Síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética
- b) Hiponatremia ficticia
- c) Hipopituitarismo
- d) Hipoaldosteronismo
- e) Iatrogénica, por reposición de volumen con cristaloides

15) ¿Qué medidas son las más adecuadas para proteger la función renal en un paciente que será sometido a un examen radiológico que requiere medio de contraste endovenoso?

- a) Administrar suero fisiológico y N-acetil-cisteína
- b) Administrar suero fisiológico y acidificar la sangre
- c) Administrar suero fisiológico y alcalinizar la sangre
- d) Acidificar la sangre y administrar N-acetil-cisteína
- e) Alcalinizar la sangre y administrar N-acetil-cisteína

16) Las causas más probables de insuficiencia renal aguda y de insuficiencia renal crónica son respectivamente:

- a) Prerenal y nefropatía diabética
- b) Prerenal e hipertensión arterial
- c) Necrosis tubular aguda e hipertensión arterial
- d) Prerenal y secundaria al uso de nefrotóxicos
- e) Necrosis tubular aguda y diabetes

17) Respecto a la anemia en la insuficiencia renal crónica es verdadero que:

- a) Suele aparecer en etapas tardías de la enfermedad, con clearance menores a 15 ml/min
- b) La anemia ferropénica severa debe ser tratada con aportes endovenosos de hierro
- c) Debe tratarse con eritropoyetina subcutánea cuando el hematocrito está por debajo de 30%
- d) Se diagnostica con una hemoglobina sanguínea menor a 11 g/dl
- e) Habitualmente se encuentran elevados los reticulocitos

18) La osteodistrofia renal se caracteriza por:

- a) Asociarse a hipofosfemia
- b) Responder al aumento de la ingesta de fósforo
- c) Asociarse a aumento de la hormona paratiroidea plasmática
- d) Responder a la disminución de la ingesta de calcio
- e) Aparecer sólo en etapas muy avanzadas de la IRC, con clearance menores a 30 ml/min

19) Un paciente de 25 años consulta por un cuadro de 5 días de malestar general, fiebre, hematuria y malestar general. Al examen físico está hipertenso, con edema de extremidades inferiores. En sus exámenes presenta creatininemia: 5,6 mg/dl, K: 5,5 mEq/l, Na: 134 mEq/l, complemento normal y sedimento de orina con abundantes eritrocitos dismórficos. El diagnóstico más probable es:

- a) Lupus
- b) Enfermedad de Berger
- c) Vaculitis de vaso pequeño
- d) Glomerulonefritis postinfecciosa
- e) Síndrome hemolítico urémico

20) ¿Cuál es el examen más importante ante un paciente en el que se sospecha una insuficiencia renal de origen postrrenal?

- a) Uretrocistografía miccional
- b) Cintigrafía renal dinámica
- c) Cintigrafía renal estática
- d) Ecografía abdominal
- e) Tomografía axial computada de abdomen y pelvis

NEFROLOGÍA RESPUESTAS

Prueba 1	11 D	1 C	10 E	Prueba 7	12 B
1 B	12 E	2 D	11 B	1 C	13 C
2 C	13 D	3 D	12 A	2 E	14 A
3 B	14 D	4 A	13 C	3 C	15 B
4 A	15 A	5 E	14 B	4 E	16 B
5 A	16 C	6 E	15 D	5 A	17 C
6 D	17 C	7 D	16 D	6 C	18 A
7 C	18 E	8 C	17 B	7 B	19 B
8 D	19 B	9 D	18 A	8 C	20 B
9 D	20 E	10 E	19 B	9 B	
10 B		11 C	20 E	10 B	Prueba 9
11 D	Prueba 3	12 D		11 D	1 A
12 A	1 D	13 E	Prueba 6	12 A	2 A
13 E	2 E	14 D	1 C	13 C	3 E
14 D	3 C	15 A	2 A	14 C	4 E
15 B	4 A	16 D	3 A	15 B	5 D
16 D	5 B	17 A	4 B	16 B	6 C
17 B	6 B	18 B	5 C	17 E	7 B
18 E	7 C	19 E	6 A	18 E	8 D
19 A	8 C	20 C	7 D	19 A	9 A
20 D	9 C	21 D	8 C	20 B	10 D
	10 D		9 A		11 D
Prueba 2	11 E	Prueba 5	10 C	Prueba 8	12 A
1 D	12 D	1 D	11 D	1 C	13 E
2 A	13 E	2 D	12 A	2 E	14 A
3 A	14 D	3 E	13 E	3 D	15 A
4 C	15 E	4 D	14 C	4 C	16 A
5 A	16 D	5 D	15 B	5 A	17 BC
6 A	17 B	6 A	16 D	6 E	18 C
7 E	18 D	7 A	17 C	7 C	19 C
8 C	19 C	8 A	18 C	8 C	20 D
9 D	20 E	9 E	19 B	9 A	
10 A	Prueba 4		20 A	10 B	
				11 D	

V) NEUROLOGÍA PRUEBAS

Prueba 1

1) Paciente de 55 años, que luego de un accidente de tránsito presenta intenso dolor lumbar, que se irradia por el muslo y pierna derecha. Al examen se aprecia debilidad para extender los ortejos y abducir el muslo de la extremidad inferior derecha. Los reflejos son normales. La raíz nerviosa comprometida es:

- a) L3
- b) L4
- c) L5
- d) S1
- e) S2

2) Paciente de 75 años, sufre caída de 2 peldaños de la escalera, golpeándose la cabeza contra el suelo. No pierde la conciencia. Al examen se aprecia en Glasgow 15, sin signos neurológicos focales. Se observa pequeño hematoma de 1 cm en zona parietal derecha del cuero cabelludo. La conducta inicial más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio con analgésicos orales
- b) Hospitalizar y observar evolución por 12 horas, sin necesidad de realizar imágenes
- c) Solicitar radiografía de cráneo AP y lateral y decidir manejo según hallazgos
- d) Solicitar tomografía de cerebro, con ventana ósea, sin uso de medio de contraste
- e) Solicitar resonancia magnética nuclear, con contraste endovenoso

3) Hombre de 33 años, consulta por intenso dolor periorcular izquierdo de algunos minutos de evolución. Habría presentado síntomas similares el día anterior. Al examen se aprecia epifora, miosis y rinorrea ipsilaterales al dolor, sin otros síntomas. El diagnóstico más probable es:

- a) Neuralgia del trigémino
- b) Neuralgia de Arnold
- c) Cefalea en racimo
- d) Sd. de Claude Bernard Horner
- e) Migraña con aura

4) Un niño de 13 meses de edad presenta fiebre hasta 39,2°C y una convulsión tónico-clónica de un minuto de duración. Al examen se aprecia un lactante en buenas condiciones, sin signos neurológicos focales. En el examen segmentario sólo destaca faringe eritematosa y congestiva. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar electroencefalograma y decidir si se iniciará tratamiento anticonvulsivante según hallazgos
- b) Iniciar terapia anticonvulsivante inmediatamente
- c) Hospitalizar, realizar exámenes de sangre y punción lumbar y decidir conducta, según resultados
- d) Explicar a la madre el carácter benigno de este acontecimiento y no realizar exámenes
- e) Solicitar resonancia magnética de cerebro

5) Paciente de 65 años sin antecedentes mórbidos. Hace 4 meses con conducta más apática y fallas reiteradas en la memoria. Los familiares se muestran muy preocupados y refieren que además ha presentado caídas en múltiples ocasiones y también incontinencia urinaria. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad de Alzheimer inicial
- b) AVE a repetición
- c) Demencia por cuerpos de Lewy
- d) Demencia frontotemporal
- e) Hidrocefalia normotensiva

6) El tratamiento farmacológico de elección, para el delirium es actualmente:

- a) Antipsicóticos típicos
- b) Antipsicóticos atípicos
- c) Anticonvulsivantes
- d) Inhibidores de la acetilcolinesterasa
- e) Antidepresivos

7) Una paciente hipertenso de 64 años de edad ingresa al servicio de urgencia de su hospital, por presentar hemiplejía faciobraquiocrural izquierda, de 65 minutos de evolución. Al examen físico se constata dicha hemiplejía, con abolición de reflejos izquierdos. Se realiza TAC de cerebro sin contraste, que es informado como normal. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar TAC de cerebro con contraste
- b) Administrar ácido acetil-salicílico oral
- c) Realizar control estricto de presión arterial y glicemia, de modo de mantenerlas en rango normal
- d) Solicitar angiografía cerebral
- e) Administrar fibrinolítico endovenoso

8) Paciente hipertensa de 52 años, consulta por haber presentado hemiparesia faciobraquiocrural izquierda y dificultad para hablar, de 60 minutos de duración y que cedió espontánea y completamente. El examen físico, el ECG y la RMN de cerebro resultaron normales. La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio con aspirina, sin necesidad de mayor estudio
- b) Iniciar anticoagulación con cumarínicos
- c) Explicar carácter benigno del cuadro, sin necesidad de mayor estudio
- d) Solicitar ecografía-doppler carotídea, ecocardiograma y Holter de arritmias
- e) Solicitar nueva resonancia magnética de cerebro en 30 días

9) Paciente de 35 años, con historia de cefalea crónica de 10 años de evolución, que trata con paracetamol y ergotamina. Refiere que en las últimas semanas la cefalea se ha hecho mucho más frecuente, por lo que debe usar dichos analgésicos varias veces al día, logrando sólo alivio transitorio. La causa más probable de su cuadro actual es:

- a) Exacerbación de migraña sin aura
- b) Cefalea por ergotamínicos
- c) Proceso expansivo intracraneano
- d) Cefalea tensional sobreagregada
- e) Hipertensión arterial secundaria

10) Paciente de 50 años, consulta por temblor de extremidades superiores de 4 años de evolución, mayor a derecha, que ha ido en lento incremento. Al examen se aprecia paciente con temblor de ambas manos, que se acentúa al intentar tomar un objeto. También presenta temblor de la cabeza. Camina sin problemas y el resto del examen físico no aporta mayor información. El diagnóstico más probable es:

- a) Corea de Huntington
- b) Síndrome cerebeloso
- c) Temblor esencial
- d) Enfermedad de Parkinson
- e) Esclerosis múltiple

11) Paciente de 48 años, consulta por dolor intenso, recurrente, de segundos de duración, en mejilla derecha, que se gatilla con frecuencia al tocarse la cara o al masticar. El examen físico demuestra pupilas isocóricas, movilidad ocular y facial normal, reflejos fotomotores y corneales normales, con sensibilidad conservada en ambas mejillas. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar RMN de cerebro y base de cráneo
- b) Iniciar tratamiento con triptanes
- c) Iniciar tratamiento con carbamazepina
- d) Iniciar paracetamol, asociado a AINEs
- e) Realizar electromiografía

12) Mujer de 33 años, consulta por astenia y diplopía, de 2 semanas de evolución, fluctuantes. Al examen se observa ptosis izquierda y ligero estrabismo divergente, que ella refiere no haber tenido previamente. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome de Guillan Barré
- b) Miastenia gravis
- c) Tumor hipofisiario
- d) Encefalopatía de Wernicke
- e) Síndrome de Claude Bernard Horner

13) ¿Cuál de las siguientes situaciones orienta mejor a un síndrome de apnea obstructiva del sueño?

- a) Hombre obeso con poliglobulia
- b) Obesa y roncadora, con insomnio de difícil manejo
- c) Roncador, con gran hipersomnia diurna
- d) Obeso, hipertenso y roncador
- e) Roncador con desaturación arterial diurna y nocturna

14) Paciente de 65 años, consulta por dolor lumbar irradiado por la cara posterior del muslo y pierna derecha, hasta el 5° orjejo. Ha presentado síntomas similares en 3 ocasiones previas. Al examen físico destaca abolición del reflejo aquiliano derecho y dificultad para caminar en punta de pies. La causa más probable de su cuadro actual es:

- a) Hernia del núcleo pulposos L5-S1
- b) Cáncer metastásico
- c) Raquiestenosis
- d) Fractura vertebral L5
- e) Artrosis de articulación interfaccetaria vertebral

15) Paciente de 33 años consulta por cefalea de 1 año de evolución, de carácter opresivo, de localización temporo-occipital, irradiada al cuello y que suele ser más intensa en las tardes. El examen físico sólo demuestra leve sensibilidad a la palpación de los músculos cervicales posteriores. El diagnóstico más probable es:

- a) Neuralgia de Arnold
- b) Migraña con aura
- c) Migraña sin aura
- d) Cefalea tensional
- e) Fibromialgia

16) Paciente de 35 años, sin patologías ni historia de cefaleas previas. Consulta por cefalea muy intensa, de inicio súbito, asociada a vómitos, de 1 hora de evolución. Al examen se encuentra afebril, sin focalidad neurológica. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar analgésicos endovenosos y enviar a domicilio con analgesia oral
- b) Solicitar resonancia magnética nuclear de cerebro, de manera ambulatoria e indicar control con neurólogo
- c) Solicitar TAC de cerebro sin contraste de manera urgente y administrar analgésicos endovenosos
- d) Administrar analgésicos y antibióticos endovenosos y solicitar punción lumbar
- e) Administrar analgésicos, manitol, nimodipino y corticoides endovenosos y solicitar TAC de cerebro con contraste

17) ¿Cuál de los siguientes hallazgos en el examen físico orientan más a una parálisis facial periférica derecha?

- a) Mantener la capacidad de arrugar la frente y cerrar el ojo derecho
- b) Compromiso de músculos masticatorios derechos
- c) Presencia de hemiparesia braquiocrural derecha
- d) Presencia de hemihipoestesia facial derecha
- e) Parálisis facial derecha con compromiso armónico de frente, ojo, boca y mentón

18) Un hombre de 35 años, sin patología previa, presenta cuadro caracterizado por movimientos repetitivos involuntarios de la mano derecha, seguidos de desviación de la mirada a derecha y convulsión tónico clónica de 3 minutos de duración. Niega uso de fármacos y drogas. Al examen físico se aprecia un paciente en buenas condiciones, sin alteraciones en el examen neurológico. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar carbamazepina y solicitar RMN de cerebro
- b) Iniciar fenitoína, sin necesidad de realizar exámenes
- c) Solicitar electroencefalograma y decidir manejo según el resultado
- d) Solicitar TAC de cerebro, sin contraste
- e) Enviar a domicilio, sin necesidad de mayor estudio y reconsultar sólo en caso de repetirse el cuadro

19) Mujer de 64 años que consulta por clínica progresiva en los últimos 4 meses de debilidad en ambas piernas. En la exploración se objetiva una paraparesia, mayor a derecha, con atrofia de cuádriceps, asociados a hiperreflexia y algunas fasciculaciones. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad desmielinizante
- b) Espondilosis lumbar
- c) Esclerosis lateral amiotrófica
- d) Polineuropatía
- e) Miastenia gravis

20) Paciente de 80 años, cursando cuadro de fiebre alta y cefalea, con signos meníngicos positivos. Se realiza punción lumbar con salida de líquido turbio, con 3000 leucocitos por mm³, 92% PMN y glucosa de 14 mg/dl. La tinción de Gram muestra cocáceas Gram positivas, dispuestas en pares y cadenas cortas. El agente etiológico más probable es:

- a) Neumococo
- b) Haemophilus
- c) Meningococo
- d) Listeria
- e) Staphylococcus aureus

Prueba 2

1) Un paciente de 15 años presenta parestesias y debilidad de las cuatro extremidades, de 48 horas de evolución, que han ido en aumento. Al examen físico se aprecia abolición de los reflejos osteotendíneos e hipotonía. El diagnóstico más probable es:

- a) Polirradiculoneuropatía desmielinizante (Síndrome de Guillain Barré)
- b) Compresión medular
- c) Miastenia gravis
- d) Infarto lacunar de troncoencéfalo
- e) Infarto cerebeloso

2) Existen numerosos medicamentos que sirven para prevenir la ocurrencia de ataques de migraña. Uno de estos medicamentos es:

- a) Indometacina
- b) Propanolol
- c) Ergotamina
- d) Verapamilo
- e) Tramadol

3) Un paciente de 5 años presenta cefalea y fiebre. Al examen físico se aprecia en buenas condiciones, con signos vitales normales, sin signos neurológicos focales, pero presenta signos meníngicos esbozados, razón por la cual decide realizar una punción lumbar con el siguiente análisis de líquido cefalorraquídeo: Células: 250 x mm³, con 88% de mononucleares, proteínas: 50 mg/ml (VN: 15-30), glucosa: 70 mg/dl (VN: mayor a 40). La tinción de Gram no muestra bacterias. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar aciclovir endovenoso
- b) Iniciar medicamentos antituberculosos y corticoides e.v.
- c) Iniciar ceftriaxona + vancomicina por vía endovenosa, asociadas a dexametasona
- d) Solicitar TAC de cerebro sin contraste
- e) Enviar a domicilio con tratamiento sintomático, indicando reconsulta ante signos de alarma

4) Un paciente de 62 años, hipertenso de larga data, mal controlado, presenta desde hace 3 horas, un cuadro de instalación rápida de hemiplejía y anestesia derechas. Al examen físico está desorientado, con dificultad para hablar y con ausencia de respuesta sensitiva y motora en el hemicuerpo derecho. Se solicita una tomografía computada de cerebro, que demuestra un hematoma intracerebral izquierdo de 3 cm, ¿Cuál de las siguientes indicaciones es MENOS aconsejable?

- a) Controlar frecuentemente con hemoglucotest y agregar insulina de modo de mantener la glicemia dentro de rangos normales
- b) Controlar frecuentemente los signos vitales, administrando captopril, de modo de mantener la presión arterial dentro de rangos normales
- c) Evitar la hipertermia con medidas físicas y farmacológicas
- d) Indicar régimen cero
- e) Administrar oxígeno por naricera, a 2 litros por minuto

5) Un paciente consulta por diplopía. Al examen físico presenta estrabismo divergente y ptosis derecha. Es capaz de mirar normalmente a la derecha, sin embargo al mirar a la izquierda, el ojo izquierdo lo hace normalmente, mientras que el ojo derecho se queda en la línea media. Lo mismo sucede al mirar hacia arriba y hacia abajo. El nervio comprometido es:

- a) Tercer nervio craneal derecho
- b) Cuarto nervio craneal izquierdo
- c) Sexto nervio craneal derecho
- d) Tercer nervio craneal izquierdo
- e) Sexto nervio craneal izquierdo

6) Un paciente consulta en el servicio de urgencias, por dolor periorbital muy intenso, asociado a rinorrea, epifora y miosis ipsilateral. El dolor suele presentarse diariamente durante la tarde, desde hace 2 días, durando algunos minutos. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar amitriptilina
- b) Solicitar resonancia magnética cerebral
- c) Administrar AINEs más corticoides endovenoso
- d) Administrar sumatriptán subcutáneo y oxígeno al 100%
- e) Solicitar radiografía de tórax, en busca de un tumor pulmonar

7) Un paciente presenta disminución de la sensibilidad de las zonas distales de las extremidades, especialmente de la vibratoria. No presenta alteraciones motoras. El diagnóstico más probable es:

- a) Mononeuritis múltiple
- b) Polineuropatía
- c) Síndrome de arteria espinal posterior
- d) Síndrome de arteria espinal anterior
- e) Síndrome de Guillain Barre

8) Mujer de 33 años, consulta por astenia y diplopía, de 2 semanas de evolución, fluctuantes. Al examen se observa ptosis izquierda y ligero estrabismo divergente, que ella refiere no haber tenido previamente. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome de Guillain Barré
- b) Miastenia gravis
- c) Tumor hipofisiario
- d) Encefalopatía de Wernicke
- e) Síndrome de Claude Bernard Horner

9) Un niño de 1 año presenta un cuadro de odinofagia y fiebre alta, hasta 39,5°C, presentando una convulsión tónico clónica de 2 minutos de duración, autolimitada. Al examen físico se encuentra en buenas condiciones generales, con pulso y presión arterial normales, con examen neurológico y cardiopulmonar sin alteraciones, destacando sólo eritema y edema faríngeo. La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio con antipiréticos
- b) Solicitar electroencefalograma
- c) Solicitar estudio de líquido cefalorraquídeo, PCR y hemograma
- d) Administrar anticonvulsivantes endovenosos y solicitar resonancia magnética nuclear de cerebro
- e) Iniciar ácido valproico a permanencia

10) Un paciente de 70 años, hospitalizado por una neumonía adquirida en la comunidad, ATS III, presenta un cuadro de agitación psicomotora, con alucinaciones visuales e ideas paranoides, refiriendo que las enfermeras lo quieren matar. Al examen físico no presenta signos focales y se aprecia inatento y desorientado. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad de Alzheimer
- b) AVE isquémico
- c) Síndrome confusional agudo
- d) Esquizofrenia
- e) Epilepsia del lóbulo temporal

11) La compresión de la cauda equina se manifiesta clínicamente como:

- a) Pérdida del control de esfínteres, impotencia sexual y anestesia en silla de montar
- b) Afectación motora asimétrica de las extremidades inferiores, sin compromiso sensitivo
- c) Afectación sensitiva de las cuatro extremidades, sin compromiso motor
- d) Compromiso asimétrico de las raíces nerviosas, que inervan las extremidades inferiores, con afectación sensitiva y motora
- e) Compromiso simétrico de extremidades inferiores, con afectación motora y de la sensibilidad termalgésica, respetando la sensibilidad táctil, vibratoria y propioceptiva

12) Un paciente de 30 años presenta movimientos involuntarios de la mano derecha, de 20 segundos de duración, seguidos de dolor epigástrico y desconexión del medio, que dura cerca de 1 minuto. El diagnóstico más probable es:

- a) Crisis tónico clónica
- b) Epilepsia mioclónica
- c) Crisis parcial simple
- d) Crisis parcial compleja
- e) Crisis de ausencia

13) ¿Cuál de los siguientes cuadros clínicos es más sugerente de una hemorragia subaracnoidea por rotura de un aneurisma?

- a) Cefalea opresiva occipital, con dolor a la palpación de los músculos cervicales posteriores
- b) Cefalea de inicio súbito, con intensidad 10/10, asociada a vómitos
- c) Cefalea intensa, pulsátil, frontal, asociada a fotopsias
- d) Cefalea de rápida instalación, asociada a hemiparesia derecha y abolición de los reflejos osteotendíneos derechos
- e) Cefalea progresiva, mayor con el decúbito, asociado a vómitos y edema de papila

14) Un paciente de 67 años presenta alteraciones de la memoria reciente, asociada torpeza motora y alucinaciones visuales, de cerca de un año de evolución, que han ido en aumento. Se inicia risperidona en bajas dosis, evolucionando con marcado empeoramiento de sus síntomas. El diagnóstico más probable es:

- a) Demencia frontotemporal
- b) Demencia por cuerpos de Lewy
- c) Hidrocefalia normotensiva
- d) Demencia senil
- e) Delirium

15) Un paciente presenta dificultad para caminar y vértigo de inicio súbito. Al examen físico se aprecia dismetría de las extremidades, marcha atáxica, con aumento de la base de sustentación y nistagmo bilateral, multidireccional. El diagnóstico más probable es:

- a) Accidente vascular isquémico de troncoencéfalo
- b) Accidente vascular encefálico de arteria cerebral media derecha
- c) Accidente vascular encefálico de arterias cerebrales posteriores
- d) Hemorragia cerebelosa
- e) Parálisis vestibular

16) Un paciente presenta hemiparesia derecha de instalación brusca, que luego de un día comienza a mejorar, hasta ser casi imperceptible al quinto día de evolución. El diagnóstico más probable es:

- a) Accidente isquémico transitorio
- b) Parálisis de Todd
- c) Esclerosis múltiple
- d) Infarto lacunar
- e) AVE isquémico, con transformación hemorrágica

17) Un paciente de 40 años presenta debilidad muscular, dificultad para caminar y para coordinar algunos movimientos. Al examen físico se observa atrofia de las masas musculares de las extremidades inferiores, mayor a derecha, con hiperreflexia bilateral, asimétrica y fasciculaciones. No presenta alteraciones sensitivas. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome de cauda equina
- b) Esclerosis lateral amiotrófica
- c) Síndrome piramidal
- d) Síndrome extrapiramidal
- e) Miastenia gravis

18) Un paciente de 50 años presenta cefalea progresiva, desde hace un par de semanas, que suele ser mayor en la mañana. A esto se le ha agregado hipoestesia en la extremidad superior izquierda y presentó una convulsión tónico clónica en una oportunidad. El diagnóstico más probable es:

- a) Encefalitis herpética
- b) Pseudotumor cerebral
- c) Accidente vascular con compromiso de los núcleos de la base
- d) Tumor cerebral
- e) Esclerosis múltiple

19) Un paciente de 33 años presenta dolor tipo neurálgico, recurrente e intenso, en la zona cervical alta, posterior izquierda. Suele desencadenarse al tocar la zona. Usted sospecha una neuralgia de Arnold. El tratamiento más adecuado es:

- a) Tramadol
- b) Ketoprofeno
- c) Carbamazepina
- d) Diazepam
- e) Clorpromazina

20) Un paciente de 61 años presenta temblor de la mano izquierda, principalmente de reposo, como si contara monedas y que desaparece al tomar objetos o al realizar otros movimientos con esa extremidad. Camina con pasos cortos y presenta disminución de la expresión facial, del parpadeo y del braceo. El diagnóstico más probable es:

- a) Temblor esencial
- b) Síndrome cerebeloso
- c) Enfermedad de Parkinson
- d) Esclerosis lateral amiotrófica
- e) Síndrome piramidal

Prueba 3

1) La presentación clínica más frecuente del síndrome de Guillain Barré es:

- a) Paraparesia espática, con compromiso respiratorio
- b) Tetraparesia flácida, fluctuante, con marcado compromiso de los párpados y oculomotores
- c) Tetraparesia flácida, febril, con signos menígeos esbozados
- d) Tetraparesia con hipotonía y arreflexia, con compromiso de los nervios faciales
- e) Tetraparesia progresiva, con ausencia de compromiso sensitivo

2) Un paciente sufre un trauma lumbar, al caer de altura, presentando incontinencia urinaria. Al examen destaca anestesia en silla de montar de la zona perineal. La movilidad y sensibilidad de las extremidades inferiores son normales. El sitio más probable de la lesión es:

- a) Asta anterior de la médula
- b) Haz corticoespinal
- c) Haz espinotalámico
- d) Cauda equina
- e) Cono medular

3) La causa más frecuente de accidentes vasculares de tipo hemorrágico, es:

- a) Angiopatía amiloidea
- b) Hipertensión arterial
- c) Aneurismas de arterias cerebrales
- d) Embolias cardíacas
- e) Traumatismos encefalocraneano

4) Un paciente de 26 años refiere cefalea recurrente, muy intensa y molesta, que compromete la zona retroocular, parietal y frontal y es de carácter pulsátil. Refiere que los cuadros se hacen más frecuentes cuando presenta sobrecarga de trabajo y cuando presenta el dolor, éste es exacerbado por los ruidos intensos y por la luz. El diagnóstico más probable es:

- a) Migraña
- b) Cefalea tensional
- c) Neuralgia del trigémino
- d) Cefalea en racimo
- e) Hipertensión endocraneana

5) Respecto al delirium es FALSO que:

- a) Suele acompañarse de ideas paranoides
- b) Junto con tratar la causa, se deben administrar antipsicóticos típicos en dosis bajas
- c) La agitación se trata con benzodiazepinas
- d) Lo más característico es la afectación de la atención
- e) El paciente debe usar sus lentes y audífonos, si los usa

6) Un paciente de 67 años sufre una caída a nivel, al resbalarse en el piso húmedo, resultando con un golpe en la zona occipital, con una pequeña herida de 1 cm, que sangra inicialmente, de forma autolimitada. Al examen físico se encuentra en buenas condiciones generales, con signos vitales normales, al igual que el examen neurológico completo. La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio con analgésicos orales
- b) Solicitar radiografía de cráneo
- c) Solicitar TAC de cerebro y cráneo, sin contraste
- d) Solicitar RMN de cerebro
- e) Hospitalizar, con analgésicos endovenosos y antibióticos profilácticos

7) ¿Cuál de las siguientes asociaciones entre características clínicas y patología es INCORRECTA?

- a) Desinhibición y conductas desadaptativas – Demencia frontotemporal
- b) Caídas frecuentes e incontinencia urinaria – Hidrocefalia normotensiva
- c) Empeoramiento de los síntomas con antipsicóticos – Demencia por cuerpos de Lewy
- d) Asociación a hemiparesia – Demencia vascular
- e) Alucinaciones visuales – Demencia senil

8) ¿Cuál de las siguientes alteraciones es MENOS probable de encontrar en un paciente con esclerosis lateral amiotrófica?

- a) Fasciculaciones
- b) Atrofia muscular
- c) Hiperreflexia
- d) Hipoestesia
- e) Disfagia

9) Un paciente de 67 años, hipertenso y diabético presenta de forma súbita una hemiparesia derecha, asociada a afasia, de 30 minutos de duración. Se solicita TAC de cerebro que descarta hemorragias. Es manejado adecuadamente, con medidas de neuroprotección y afortunadamente, los síntomas inician una recuperación espontánea antes de comenzar el protocolo de trombolisis. Al segundo día está en excelentes condiciones, sin déficit neurológico ni otras alteraciones del examen físico. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar TAC de cerebro control
- b) Solicitar electroencefalograma
- c) Solicitar Holter de arritmias, ecocardiograma y eco-doppler carotideo
- d) Iniciar aspirina
- e) Iniciar anticoagulación oral a permanencia

10) Un paciente de 45 años presenta cefalea holocránea, de inicio súbito, muy intensa, asociada vómitos. No refiere historia de cefaleas previas y la intensidad del dolor es 10/10. El examen físico, incluyendo el fondo de ojo es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar paracetamol oral
- b) Administrar oxígeno al 100% y triptanes subcutáneos
- c) Administrar AINEs endovenosos
- d) Iniciar analgesia endovenosa y solicitar punción lumbar
- e) Solicitar TAC de cerebro y administrar analgésicos endovenosos

11) ¿Cuál de los siguientes medicamentos produce parkinsonismo por drogas con más frecuencia?

- a) Clozapina
- b) Risperidona
- c) Carbamacepina
- d) Ergotamina
- e) Amitriptilina

12) Un paciente presenta de forma brusca imposibilidad para evocar palabras. No es capaz de nombrar objetos, sólo puede decir algunas palabras cortas, con mucha dificultad, sin embargo repite con mayor facilidad. Presenta sólo mínima dificultad de la comprensión. El resto del examen físico no aporta mayor información. El diagnóstico más probable es:

- a) Infarto silviano derecho
- b) Accidente isquémico frontal izquierdo
- c) Infarto postrolándico izquierdo
- d) Isquemia aguda de troncoencéfalo
- e) Infarto cerebeloso

13) Existen tratamientos profilácticos para la migraña, que disminuyen la frecuencia y la intensidad de los episodios de jaqueca. Todos los medicamentos enumerados a continuación pueden ser usados como tratamiento profiláctico, EXCEPTO:

- a) Sumatriptán
- b) Propanolol
- c) Ácido valproico
- d) Flunarizina
- e) Amitriptilina

14) Un paciente presenta una hemianopsia homónima derecha de baja congruencia. La lesión se localizará probablemente en:

- a) El nervio óptico derecho
- b) La cintilla óptica derecha
- c) El lóbulo occipital izquierdo
- d) El lóbulo occipital derecho
- e) La cintilla óptica izquierda

15) Un paciente presenta ptosis derecha, asociada a miosis ipsilateral. No presenta alteraciones en la agudeza visual, ni en la oculomotilidad. El diagnóstico más probable es:

- a) Compresión del tercer nervio craneal derecho
- b) Afectación metabólica del tercer nervio craneal derecho
- c) Afectación del nervio facial derecho
- d) Neuralgia secundaria del trigémino

e) Síndrome de Claude Bernard Horner

16) Además del ABC, lo primero que debe hacer frente a un paciente que ingresa convulsionando, es:

- a) Administrar lorazepam endovenoso
- b) Poner una gasa en la boca del paciente, para evitar que se muerda la lengua
- c) Solicitar una resonancia magnética nuclear
- d) Administrar fenitoína por sonda nasogástrica
- e) Administrar diazepam intramuscular

17) Un paciente de 68 años presenta debilidad progresiva de la mano izquierda, de 7 días de evolución. Refiere además cefalea matinal, asociada a vómitos y presentó una convulsión tónicoclónica en una oportunidad. El diagnóstico más probable es:

- a) Accidente vascular encefálico lacunar
- b) Hipertensión endocraneana idiopática
- c) Accidente vascular encefálico de tipo hemorrágico
- d) Hematoma subdural crónico
- e) Tumor cerebral

18) La sección medular completa a nivel de C5 produce:

- a) Hipotensión, bradicardia y tetraplejía, asociada a anestesia de las 4 extremidades
- b) Hipertensión, taquicardia y paraplejía, asociada a anestesia de las extremidades inferiores
- c) Hipotensión, taquicardia y paraplejía, asociada a anestesia de las extremidades inferiores
- d) Hipertensión, bradicardia y tetraplejía, asociada a anestesia de las 4 extremidades
- e) Hipotensión, taquicardia y tetraplejía, asociada a anestesia de las extremidades inferiores

19) Los agentes etiológicos más frecuentes de las meningoencefalitis virales y las meningitis bacterianas agudas, son respectivamente:

- a) Virus herpes y meningococo
- b) Virus herpes y neumococo
- c) Enterovirus y neumococo
- d) Enterovirus y meningococo
- e) Enterovirus y estafilococo aureo

20) Identifique la asociación correcta entre raíz nerviosa afectada y cuadro clínico:

- a) C5 – Afectación de la sensibilidad del pulgar
- b) C7 – Afectación del reflejo bicipital
- c) L5 – Afectación del reflejo aquiliano
- d) L4 – Afectación del reflejo rotuliano
- e) S1 – Afectación de la sensibilidad de la piel sobre el maléolo interno

Prueba 4 (NEUROLOGÍA + SALUD PÚBLICA)

1) ¿Cuál de los siguientes hallazgos clínicos NO apoyaría el diagnóstico de polineuropatía en un paciente con debilidad progresiva en miembros inferiores?:

- a) Fasciculaciones.
- b) Atrofia muscular.
- c) Signo de Babinski.
- d) Hipo o arreflexia.
- e) Hipotonía.

2) Una mujer de 60 años con antecedentes de jaqueca e HTA en tratamiento, acude al servicio de urgencias por haber sufrido una cefalea intensa instaurada de manera brusca tras haber realizado un esfuerzo físico. En la exploración se aprecia fotofobia, rigidez de nuca y una tensión arterial elevada, siendo normal el resto de la exploración neurológica. El diagnóstico más probable es:

- a) Hematoma cerebral intraparenquimatoso hipertensivo.
- b) Tumor cerebral.
- c) Crisis de jaqueca.
- d) Rotura de aneurisma sacular intracraneal.
- e) Cefalea producida por una subida de la TA.

3) ¿Cuál de los siguientes hallazgos es muy frecuente en la enfermedad de Parkinson idiopática?:

- a) Demencia al inicio
- b) Mioclonías.
- c) Blefaroespasmos.
- d) Retrocollis.
- e) Pérdida de movimientos asociados en la marcha.

4) Enfermo de 76 años que acude a la consulta por pérdida de fuerza, fundamentalmente proximal, en miembros superiores. La exploración neurológica evidencia pérdida de fuerza, atrofia y fasciculaciones en varios grupos musculares de miembros superiores, así como discreta pérdida de fuerza en los músculos tibiales anteriores. Los reflejos osteotendinosos son vivos y simétricos y la sensibilidad es normal. El estudio electrofisiológico demuestra signos de denervación en múltiples músculos con conducción nerviosa sensitiva normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Esclerosis lateral amiotrófica.
- b) Síndrome miasténico tipo Eaton-Lambert.
- c) Miopatía tirotóxica con fasciculaciones.
- d) Espondilosis cervical.
- e) Atrofia muscular espinal de comienzo tardío.

5) Una paciente de 22 años consulta por presentar desde una semana antes ptosis palpebral izquierda, sin dolor, con diplopía en la mirada lateral izquierda. En la exploración física se comprueba la existencia de una ptosis izquierda, una paresia de la abducción del ojo izquierdo, con unas pupilas isocóricas y normorreactivas de la luz. ¿Qué enfermedad es más probable que padezca la paciente?:

- a) Una neuritis óptica izquierda en relación con Esclerosis Múltiple.
- b) Un síndrome de Horner.
- c) Una Miastenia gravis.
- d) Una parálisis del III par izquierdo.
- e) Una miopatía hipertiroides con afectación de la musculatura extraocular.

6) ¿Cuál de los siguientes medicamentos es útil para prevenir la recurrencia de jaquecas?

- a) Paracetamol
- b) Vitamina C
- c) Ergotamina
- d) Sumatriptán
- e) Flunarizina

7) Un paciente presenta de manera súbita hemiparesia izquierda, asociada a compromiso de los pares craneales V, VI y VII derechos. ¿A qué nivel se encuentra la lesión?

- a) Corteza cerebral
- b) Cápsula interna
- c) Tálamo
- d) Troncoencéfalo
- e) Nervios

8) Un paciente de 34 años sufre un accidente de tránsito, con traumatismo cervical y sección medular a la altura de C5. ¿Qué alteración sería MENOS probable de encontrar?

- a) Parálisis diafragmática
- b) Incontinencia urinaria
- c) Tetraplejia
- d) Anestesia de las 4 extremidades
- e) Hipotensión arterial

9) Un paciente de 68 años presenta un cuadro de meses de evolución de olvidos frecuentes y conversaciones repetitivas, al que se le ha agregado en las últimas semanas dificultad para realizar sus actividades cotidianas, como salir a comprar o llamar por teléfono. El examen neurológico no presenta alteraciones motoras ni sensitivas. El diagnóstico más probable es:

- a) Demencia senil
- b) Delirium
- c) Demencia por cuerpos de Lewy
- d) Depresión
- e) Demencia vascular

10) Un niño de 10 años presenta un cuadro de movimientos involuntarios de la extremidad inferior izquierda, que luego se extienden a la extremidad superior izquierda, siendo seguidos de lenguaje incoherente y finalmente una convulsión tónico-clónica. ¿Qué etiología es la más probable entre las planteadas a continuación?

- a) Epilepsia tónicoclónica
- b) Epilepsia mioclónica
- c) Lesión focal
- d) Encefalitis viral
- e) Crisis convulsiva farmacológica

11) Está usted evaluando una prueba diagnóstica y finalmente se encuentra en la siguiente tabla:

Enfermedad	SÍ	NO
Prueba Positiva	80	100
Prueba Negativa	20	800

A partir de ella y redondeando decimales, señale cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- a) El valor predictivo positivo es del 56% y el valor predictivo negativo del 13%.
- b) El valor predictivo positivo es del 44% y el valor predictivo negativo del 98%.
- c) El valor predictivo positivo es del 80% y el valor predictivo negativo del 90%.
- d) El valor predictivo positivo es del 80% y el valor predictivo negativo del 11%.
- e) El valor predictivo positivo es del 10% y el valor predictivo negativo del 20%.

12) Suponga que en un ensayo clínico hay diferencias entre los grupos en algunos factores pronósticos. ¿Afecta esto a la interpretación de los resultados?:

- a) No, gracias a la asignación aleatoria ("randomización").
- b) Haría necesario utilizar alguna técnica estadística que permita tener en cuenta las diferencias entre ellos en los factores pronósticos.
- c) Invalida el estudio, ya que la asignación aleatoria no ha conseguido su objetivo de obtener grupos homogéneos.
- d) Invalida el estudio, ya que el número de pacientes incluidos es insuficiente para obtener grupos homogéneos.
- e) Indica la necesidad de reanudar la inclusión de pacientes en el estudio, hasta conseguir equilibrar el pronóstico de los grupos.

13) Uno de los principales inconvenientes de los estudios de casos y controles es:

- a) Que a menudo requieren muestras de gran tamaño.
- b) Su mayor susceptibilidad a incurrir en sesgos respecto a otros estudios epidemiológicos.
- c) Que no son adecuados para estudiar enfermedades raras.
- d) Que suelen ser caros y de larga duración.
- e) Que no permiten determinar la odds ratio.

14) Un niño de 5 años pesa 20 kg. Según las tablas de Tanner-Whitehouse, este valor corresponde aproximadamente al percentil 75 de la distribución del peso en niños de dicha edad. ¿Qué significa esta expresión?:

- a) El 75% de los niños de 5 años pesan aproximadamente 20 kg.
- b) El niño pesa un 75% más que el promedio de los niños de su edad.
- c) El 75% de los niños de 5 años pesan menos de 20 kg.
- d) El niño tiene un peso que es un 75% superior a la mediana del peso de los niños de su edad.
- e) El 75% de los niños de 5 años pesan, como mínimo, 20 kg.

15) Suponga que en la fase de diseño se calcula que para tener suficiente poder estadístico en el estudio de cierta intervención terapéutica mediante un ensayo clínico es necesario incluir 100 sujetos. Sin embargo el ensayo se realiza con sólo 50 pacientes y el resultado es estadísticamente significativo ($P < 0,001$). Suponga que en todo lo demás el estudio parece correcto. En vista del pequeño número de pacientes incluidos, ¿son creíbles los resultados?:

- a) No, ya que en los ensayos demasiado pequeños los errores sistemáticos son inevitables.
- b) No, ya que hay muchas posibilidades de que las diferencias encontradas sean un resultado falso positivo.
- c) Sí, ya que una vez alcanzado un resultado concluyente no importa lo probable o improbable que fuese el llegar a él antes de hacer el estudio.
- d) No, ya que la probabilidad de encontrar diferencias, si éstas existen, es baja cuando el estudio es pequeño.
- e) Sí, siempre y cuando estos resultados se utilicen exclusivamente para unirlos a los de otros estudios

pequeños sobre la misma cuestión y hacer un meta-análisis o una revisión.

16) Un estudio compara dos tratamientos antibióticos (fármaco A y fármaco B), para las neumonías ATS III. Se administra cada antibiótico a 100 pacientes distintos y se ve la tasa de mejoría. El fármaco A presenta una tasa de mejoría de 98% y el fármaco B de 90%, sin embargo el tratamiento completo con el fármaco A cuesta \$100.000 y con el fármaco B cuesta \$20.000. Se calcula el dinero adicional que hay que invertir, al utilizar el fármaco A, en lugar del fármaco B, para que un paciente adicional mejore. ¿A qué tipo de estudio corresponde?

- a) Costo-eficacia
- b) Costo-utilidad
- c) Costo-beneficio
- d) Minimización de costos
- e) Efectividad

17) Para determinar la relevancia de una enfermedad infecciosa grave conviene ocupar:

- a) Mortalidad general
- b) Mortalidad específica
- c) Incidencia
- d) Prevalencia
- e) Tasa de ataque

18) Se calcula el IMC de 80 pacientes diabéticos y de 150 pacientes sanos. ¿Qué prueba estadística es la más adecuada para determinar si existen diferencias significativas entre ambos grupos?

- a) t de Student
- b) Chi cuadrado
- c) r de Pearson
- d) Análisis de Varianza
- e) Riesgo atribuible

19) El ISP tiene como una de sus funciones:

- a) Realizar autopsias de fallecimientos traumáticos y suicidios
- b) Fiscalizar a las ISAPRES
- c) Controlar el correcto funcionamiento de los laboratorios públicos y privados
- d) Administrar los recursos de la salud pública
- e) Entregar el aporte per cápita

20) Un hospital tiene un índice mensual de ocupación de camas del 90%. Esto quiere decir que:

- a) Se ocupa el 90% de los días-cama disponibles en el mes
- b) Hay días en que el hospital no tiene camas disponibles
- c) El hospital siempre tiene algunas camas disponibles
- d) durante el mes hay un 10% de camas que no fueron utilizadas
- e) Los pacientes tienen una alta rotación

Prueba 5 (NEUROLOGÍA + HEMATOONCOLOGÍA)

1) La hemisección medular a nivel torácico se caracteriza por:

- a) Imposibilidad de mover la extremidad contralateral, ausencia de sensibilidad termalgésica ipsilateral y ausencia de sensibilidad táctil y vibratoria contralateral
- b) Imposibilidad de mover la extremidad ipsilateral, ausencia de sensibilidad termalgésica contralateral y ausencia de sensibilidad táctil y vibratoria ipsilateral
- c) Imposibilidad de mover la extremidad ipsilateral, ausencia de sensibilidad termalgésica ipsilateral y ausencia de sensibilidad táctil y vibratoria contralateral
- d) Imposibilidad de mover la extremidad contralateral, ausencia de sensibilidad termalgésica ipsilateral y ausencia de sensibilidad táctil y vibratoria ipsilateral
- e) Imposibilidad de mover la extremidad ipsilateral, ausencia de sensibilidad termalgésica contralateral y ausencia de sensibilidad táctil y vibratoria contralateral

2) La trombofilia congénita más frecuente es:

- a) Factor V de Leiden
- b) Déficit de antitrombina III
- c) Déficit de proteína C
- d) Déficit de proteína S

e) Hiperhomocisteinemia

3) Un paciente de 78 años presenta un cuadro caracterizado por hemiparesia y hemihipoestesia derechas, asociadas a desorientación de 2 horas de evolución. Al examen físico se observa paciente en Glasgow 13, eupneico, con presión arterial 180/110 mmHg, FC: 110 lpm y con las alteraciones descritas previamente. El hemoglucotest resulta 200 mg/dl. La conducta inicial más adecuada es:

- a) Anticoagular con heparina
- b) Administrar captopril oral
- c) Solicitar electrocardiograma
- d) Administrar aspirina
- e) Solicitar TAC de cerebro

4) ¿Cuál de los siguientes medicamentos NO es útil como tratamiento profiláctico de jaqueca?

- a) Ergotamina
- b) Flunarizina
- c) Propanolol
- d) Ácido valproico
- e) Amitriptilina

5) La causa más frecuente de muerte por cáncer, en la población masculina chilena, es:

- a) Cáncer de vesícula biliar
- b) Cáncer de estómago
- c) Cáncer de pulmón
- d) Cáncer de próstata
- e) Cáncer de origen hematológico

6) Un paciente de 61 años presenta temblor de la mano derecha, que se presenta en reposo, con frecuencia de 3 hertzios y que desaparece al tomar objetos o realizar otros movimientos. Camina con pasos cortos y muestra clara disminución del braceo. El diagnóstico más probable es:

- a) Temblor esencial
- b) Síndrome cerebeloso
- c) Enfermedad de Parkinson
- d) Esclerosis lateral amiotrófica
- e) Síndrome piramidal

7) Un paciente de 50 años se realiza una ecografía abdominal como parte del estudio de un cuadro de dolor abdominal, visualizándose un tumor renal izquierdo, sólido, de 5 cm de diámetro mayor. La conducta más adecuada es:

- a) Controlar con nueva ecografía en 3 meses
- b) Solicitar resonancia magnética nuclear
- c) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
- d) Solicitar biopsia con aguja gruesa
- e) Realizar nefrectomía radical

8) Un paciente de 52 años, con antecedente de hipertensión y diabetes, sufre un episodio caracterizado por movimientos involuntarios de la extremidad inferior derecha, seguido luego de chupeteo y lenguaje incoherente, que dura cerca de 15 minutos. Luego se recupera completamente, recordando sólo hasta el momento de los movimientos de la mano. El diagnóstico más probable es:

- a) Accidente isquémico transitorio
- b) Crisis parcial
- c) Crisis parcial compleja
- d) Crisis generalizada
- e) Crisis parcial, secundariamente generalizada

9) Un hombre de 66 años, consulta por astenia. El examen físico demuestra palidez moderada y se palpan adenopatías pequeñas generalizadas. El hemograma presenta hematocrito: 27%, Hb: 8,8, blancos: 36.000, linfocitos: 88%, neutrófilos: 7%, monocitos: 1%, basófilos: 0%, eosinófilos: 0%, plaquetas: 85.000. El diagnóstico más probable es:

- a) Linfoma
- b) Leucemia mieloide crónica
- c) Leucemia linfática crónica
- d) Mieloma
- e) Mononucleosis infecciosa

10) Un paciente de 65 años, sin patologías ni hábitos de importancia, presenta cuadro de astenia, por lo que se realiza hemograma que demuestra Hcto: 30%, Hb: 10 g/d, VCM: 106, HCM: 35, blancos: 4.100, plaquetas: 100.000. Se sospecha déficit de vitamina B12, por lo que se inician aportes intramusculares, asociados a folatos endovenosos, sin lograr respuesta luego de varias semanas de tratamiento. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Aplasia medular
- b) Mielodisplasia
- c) Leucemia mieloide crónica
- d) Anemia de enfermedades crónicas
- e) Déficit de hierro

11) Una adolescente de 17 años de edad presenta desde la infancia, tendencia a la epistaxis y gingivorragia. También presenta petequias y equimosis recurrentes. Sus reglas son abundantes y suele sangrar más de lo normal luego de procedimientos dentales. El examen físico no aporta más información. El examen que con mayor probabilidad se encontrará alterado es:

- a) Recuento de plaquetas
- b) Tiempo de protrombina
- c) Tiempo de tromboplastina parcial activada
- d) Tiempo de sangría
- e) Fibrinogenemia

12) ¿Cuál de las siguientes asociaciones entre la estructura anatómica y síntoma que aparece al dañarse, es correcta?

- a) Fascículo longitudinal medial - imposibilidad de mirar hacia lateral
- b) Asta anterior de la médula - hipoestesia
- c) Vermix cerebeloso - nistagmo multidireccional
- d) Ganglio estrellado - midriasis
- e) Nervio facial - ptosis

13) Un paciente de 55 años sufre un episodio caracterizado por desviación de la comisura labial derecha y dificultad para mover la mano ipsilateral, de 2 horas de duración y que se recupera completamente. Al momento del examen se encuentra asintomática y su examen físico es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio iniciando aspirina y una estatina
- b) Realizar trombolisis endovenosa
- c) Realizar angiografía carotídea y decidir manejo según hallazgos
- d) Hospitalizar, anticoagular con heparina y solicitar ecodoppler carotídeo
- e) Hospitalizar, iniciar medidas de neuroprotección, solicitar una neuroimagen y realizar estudio de fuente embólica

14) Un paciente de 65 años presenta astenia y palidez de varias semanas de evolución. Al examen físico se observa pálido, delgado, con varias adenopatías pequeñas, no dolorosas, en cuello, axilas e ingles. No presenta otras alteraciones. Se realiza exámenes de sangre entre los que destaca un hemograma, con hematocrito de 26%, hemoglobina de 8,7 g/dl, blancos: 32.600, linfocitos: 90%, neutrófilos: 9%, segmentados: 9%, baciliformes: 1%, promielocitos: 0%, blastos: 0%, monocitos: 0%, plaquetas: 76.000. El diagnóstico más probable es:

- a) Leucemia linfática aguda
- b) Leucemia linfática crónica
- c) Linfoma de Hodking
- d) Linfoma no Hodking de alto grado
- e) Mielofibrosis

15) ¿Cuál de los siguientes hallazgos es más orientador a una alteración de la hemostasia primaria?

- a) Alargamiento del TTPA
- b) Equimosis
- c) Antecedentes familiares de hemorragias
- d) Petequias
- e) Hemartrosis

16) La disminución de la sensibilidad de la zona distal de las extremidades, especialmente del componente vibratorio y termalgésico, es característica de:

- a) Mononeuritis múltiple
- b) Polineuropatía
- c) Poliradiculopatía desmielinizante
- d) Daño de la vía espinotalámica de la médula
- e) Daño de los cordones posteriores de la médula

17) El factor pronóstico más importante en un sarcoma de partes blandas es:

- a) Tamaño del tumor
- b) Tipo histológico
- c) Presencia de adenopatías
- d) Invasión microvascular
- e) Grado de diferenciación histológica

18) Un paciente de 34 años presenta accidente de tránsito, con golpe en la cabeza. Inicialmente evoluciona bien, sin embargo 30 minutos después evoluciona con cefalea intensa y luego compromiso de conciencia de instalación relativamente rápida, hasta caer en Glasgow 6. Al examen físico destaca anisocoria, con midriasis derecha. La explicación más probable es:

- a) Hemorragia subaracnoidea, con compromiso del tercer nervio craneal
- b) Hematoma intraparenquimatoso, con herniación del cíngulo
- c) Hematoma extradural, con herniación de las amígdalas cerebelosas
- d) Hematoma epidural, con herniación del uncus temporal
- e) Hematoma subdural, con compresión del troncoencéfalo

19) La anemia por hemorragias agudas se diferencia de la anemia por hemorragias crónicas en que la primera:

- a) No se beneficia de transfusiones de glóbulos rojos
- b) Tiene un índice reticulocitario elevado
- c) Presenta aumento de la transferrina plasmática
- d) Es mejor tolerada
- e) Presenta esquistocitos en el frotis sanguíneo

20) Una mujer de 67 años, con antecedente de fibrilación auricular, presenta hemianopsia homónima izquierda de inicio súbito, con alta congruencia. ¿Cuál es el sitio más probable de la embolia?

- a) Arteria vertebral izquierda
- b) Arteria basilar
- c) Arteria cerebral media izquierda
- d) Arteria cerebral posterior derecha
- e) Arteria cerebral anterior derecha

Prueba 6 (NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA)

1) Un paciente de 8 años consulta por cuadro de debilidad de las 4 extremidades y dolor en extremidades inferiores. Al examen se constata tetraparesia, con abolición de reflejos osteotendíneos y disminución del tono muscular. El diagnóstico más probable es:

- a) Miелitis transversa
- b) Miastenia gravis
- c) Síndrome de Guillan-Barré
- d) Déficit de vitamina B12
- e) Intoxicación por anticolinérgicos

2)Cuál de las siguientes opciones corresponde a una asociación INCORRECTA entre un reflejo arcaico y su edad de desaparición?

- a) Preensión plantar – 3 meses
- b) Preensión palmar – 3 meses
- c) Moro – 6 meses
- d) Marcha automática – 3 meses
- e) Búsqueda – 3 meses

3) Un niño de 3 años presenta cuadro de odinofagia, fiebre alta y tos irritativa escasa. Presenta convulsión tónico clónica en una oportunidad, de 2 minutos de duración. Habría presentado otra convulsión febril hace 1 año. Al examen físico se aprecia en buenas condiciones generales, en Glasgow 15, sin focalidad neurológica ni signos meníngicos. La faringe se observa eritematosa, sin exudado. La conducta más adecuada es:

- a) Hospitalizar, iniciar antibióticos y realizar punción lumbar
- b) Enviar a domicilio, indicando paracetamol durante los cuadros febriles, sin necesidad de anticonvulsivantes
- c) Iniciar ácido valproico y solicitar resonancia magnética nuclear
- d) Enviar a domicilio, indicando antipiréticos y diazepam durante las alzas térmicas
- e) Solicitar electroencefalograma y decidir manejo según hallazgos

4) El examen de elección para evaluar a un niño que sufre una convulsión tónico clónica autolimitada y cuyo examen físico es normal, es:

- a) Electroencefalograma
- b) TAC de cerebro sin contraste
- c) Resonancia magnética nuclear de cerebro
- d) Electromiografía
- e) Creatinfosfokinasa plasmática

5) Un niño de 2 años, consulta por cuadro de cefalea y fiebre hasta 38,7°C, asociado a estrabismo divergente. Al examen físico se constata parálisis del tercer nervio craneal derecho y signos meníngicos esbozados, por lo que se decide realizar punción lumbar que demuestra un líquido cefalorraquídeo con proteínas aumentadas, glucosa disminuida y pleocitosis, con 86% de mononucleares. El diagnóstico más probable es:

- a) Meningitis viral
- b) Meningitis tuberculosa
- c) Meningitis bacteriana aguda
- d) Encefalitis herpética
- e) Absceso cerebral

6) La triada de cefalea, vómitos y papiledema, es característica de:

- a) Hidrocefalia
- b) Meningitis viral
- c) Glaucoma congénito
- d) Hipertensión endocraneana
- e) Migraña

7) Un niño de 5 años inicia cefalea progresiva, asociada a caídas frecuentes y luego dificultad para caminar, de 2 semanas de evolución. La cefalea suele ser mayor en las mañanas y ha aumentado considerablemente en los últimos días. Al examen físico se corrobora ataxia de la marcha y dismetría de extremidades, mayor a derecha. El diagnóstico más probable es:

- a) Poliomiелitis
- b) Tumor del sistema nervioso central
- c) Epilepsia focal
- d) Accidente vascular cerebral
- e) Pseudotumor cerebral

8) Los 3 hitos del desarrollo psicomotor, que el lactante logra normalmente al cumplir el año de edad, son:

- a) Gatea, usa las primeras palabras y pasa objetos de una mano a otra
- b) Camina sin apoyo, pasa objetos de una mano a otra y dice sus primeras palabras
- c) Caminar sin apoyo, uso de la pinza madura entre pulgar e índice, y uso de las primeras palabras
- d) Uso de las primeras palabras, continencia urinaria diurna y caminar con apoyo
- e) Caminar sin apoyo, formación de las primeras frases y continencia urinaria diurna

9) La fontanela anterior se cierra normalmente entre:

- a) Los 3 y 6 meses de edad
- b) Los 6 y los 9 meses de edad
- c) Los 9 y los 18 meses de edad
- d) Los 12 y los 24 meses de edad
- e) Los 24 y los 36 meses de edad

10) Un niño de 3 años sufre caída a nivel mientras jugaba, golpeándose la cabeza contra un árbol y evolucionando con aparición de aumento de volumen en la zona del golpe. No perdió la conciencia ni presentó vómitos. Al examen se observa en buenas condiciones generales, en Glasgow 15, sin focalidad neurológica. Se observa un hematoma de 3,5 cm en la zona frontal. La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio con indicación de reconsultar en caso de aparición de signos de alarma
- b) Observar hospitalizado por 24 horas sin necesidad de realizar imágenes
- c) Solicitar radiografía de cráneo y decidir manejo según hallazgos
- d) Solicitar TAC de cerebro y de cráneo, sin medio de contraste y decidir manejo según resultados
- e) Realizar punción del hematoma e iniciar analgesia endovenosa

11) La causa más frecuente de macrocefalia es:

- a) Hidrocefalia
- b) Meningitis
- c) Infecciones congénitas
- d) Constitucional
- e) Postraumática

12) Una niña de 5 años es traída por su madre, ya que presenta cefalea, fiebre hasta 38,5°C y vómitos. Al examen físico destaca rigidez de nuca esbozada, sin otros hallazgos de importancia. Se solicita punción lumbar que da salida a líquido claro, con 100 células, con 85% mononuclear y 15% polimorfonuclear, la glucosa del LCR es normal y las proteínas están levemente aumentadas. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar paracetamol oral
- b) Iniciar cefadroxilo oral y analgésicos orales
- c) Iniciar ceftriaxona endovenosa, asociada a dexametasona endovenosa
- d) Iniciar vancomicina endovenosa, sin necesidad de corticoides
- e) Iniciar corticoides orales

13) Un niño de 8 años, con antecedentes de epilepsia tónicoclónica, en tratamiento con ácido valproico, es traído al servicio de urgencia, donde usted trabaja, ya que se encuentra convulsionando hace 10 minutos. El fármaco de elección para controlar la crisis convulsiva es:

- a) Lorazepam intravenoso
- b) Fenitoína por sonda nasogástrica
- c) Fenobarbital intramuscular
- d) Flumazenil intravenoso
- e) Diazepam intramuscular

14) Un niño sufre un accidente en bicicleta, con golpe en la cabeza. Inicialmente en buenas condiciones generales, sin embargo 40 minutos después inicia cefalea importante y luego compromiso de conciencia. Convulsiona en una oportunidad. El diagnóstico más probable es:

- a) Concusión
- b) Hematoma subdural
- c) Hemorragia subaracnoidea
- d) Hematoma epidural
- e) Fractura de base de cráneo

15) Un niño de 18 meses aún no camina, y presenta también retraso de otras habilidades motoras, sin embargo dice varias palabras y parece comprender lo que su madre le dice. No ha presentado empeoramiento de su condición ni ha perdido los hitos del desarrollo motor que ha ido logrando. Al examen físico destaca espasticidad de ambas extremidades inferiores, mayor a derecha, sin otros hallazgos de importancia. El diagnóstico más probable es:

- a) Tumor cerebral
- b) Poliomiелitis por vacuna
- c) Parálisis cerebral
- d) Distrofia muscular de Duchenne
- e) Polineuropatía metabólica

16) Un niño de 6 años es traído por su madre, ya que ha presentado un mal rendimiento escolar. Los profesores dicen que es difícil de manejar, ya que se distrae fácilmente y le cuesta quedarse quieto. Tiene buena relación con sus compañeros, aunque en algunas ocasiones pelea con ellos. El examen físico no aporta mayor información. El diagnóstico más probable es:

- a) Autismo
- b) Déficit atencional
- c) Trastorno oposicionista desafiante
- d) Depresión infantil
- e) Síndrome de Asperger

17) ¿Cuál de las siguientes opciones es una indicación para realizar una punción lumbar en un paciente que presentó una convulsión febril?

- a) Temperatura mayor a 40°C
- b) Causa de la fiebre identificable
- c) Crisis convulsiva generalizada
- d) Aspecto tóxico
- e) La punción lumbar debe realizarse en todo paciente que presenta una convulsión febril

18) Un recién nacido de término, de 2 días de vida, con antecedente de sufrimiento fetal agudo durante el parto, presenta una crisis convulsiva. Al examen físico se aprecia levemente hipotónico, sin signos focales, sin otros hallazgos de importancia. El diagnóstico más probable es:

- a) Poliglobulia neonatal
- b) Encefalopatía hipóxico isquémica
- c) Hipoglicemia
- d) Hemorragia periventricular
- e) TORCH

19) Un niño de 6 años, con diagnóstico de meningitis bacteriana aguda, presenta una tinción de Gram de líquido cefalorraquídeo que identifica cocáceas Gram positivos aisladas y en diplos. El agente etiológico más probable es:

- a) Neisseria meningitidis
- b) Streptococcus pyogenes
- c) Haemophilus influenzae
- d) Listeria monocytogenes
- e) Streptococcus pneumoniae

20) Un joven de 14 años, previamente sano, presenta en la primera hora de la mañana brúscas sacudidas bilaterales desde hace seis meses, ocasionales, más frecuentes luego de estudiar hasta tarde la noche previa. Su hermano de 12 años también ha tenido saltitos al despertar. Ahora consulta por un episodio único de brúscas pérdida del conocimiento, seguida de convulsión tónico clónica recuperada en 15 a 20 minutos.

El diagnóstico más probable es:

- a) Epilepsia mioclónica
- b) Epilepsia parcial motora
- c) Crisis convulsiva única
- d) Epilepsia parcial benigna
- e) Epilepsia focal, secundaria

Prueba 7

1) Un paciente de 67 años, hipertenso, presenta de manera súbita imposibilidad para hablar, asociado a hemiparesia derecha. Usted lo recibe 30 minutos después en el servicio de urgencia. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar anticoagulación con heparina
- b) Realizar trombolisis endovenosa
- c) Administrar aspirina, oxígeno y atorvastatina
- d) Solicitar TAC de cerebro sin contraste
- e) Realizar ecografía-Doppler de arterias carótidas

2) En el síndrome de Guillain Barré se puede encontrar todo lo siguiente EXCEPTO:

- a) Hipoestesia de extremidades inferiores
- b) Espasticidad
- c) Arreflexia
- d) Parálisis facial
- e) Insuficiencia respiratoria

3) Un paciente de 57 años consulta por debilidad de las extremidades inferiores, progresiva, de varios días de evolución. Al examen físico se aprecia paresia de ambas extremidades inferiores, mayor a izquierda, con signos de atrofia muscular y fasciculaciones, asociados a reflejos osteotendíneos aumentados, sin alteraciones en la sensibilidad. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome de arteria espinal anterior
- b) Polineuropatía
- c) Mononeuritis múltiple
- d) Miastenia gravis
- e) Esclerosis lateral amiotrófica

4) Un niño de 6 años sufre una caída en bicicleta, golpeándose la cabeza. Presenta signos vitales normales, examen neurológico normal y se visualiza un hematoma de 3 cm de diámetro, en el cuero cabelludo de la zona frontal, con una pequeña herida por abrasión. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Solicitar TAC de cerebro sin contraste
- c) Solicitar TAC de cerebro con contraste
- d) Solicitar radiografía de cráneo
- e) Solicitar resonancia magnética nuclear

5) ¿Cuál es la conducta más adecuada para controlar a un paciente que está convulsionando?

- a) Administrar diazepam e.v.
- b) Administrar fenitoína e.v.
- c) Administrar fenobarbital e.v.
- d) Administrar ácido valproico e.v.
- e) Administrar lorazepam e.v.

6) Una mujer embarazada consulta por cefalea y fiebre. Al examen físico destaca signo de Brudzinsky, por lo que se realiza una punción lumbar, que muestra un líquido cefalorraquídeo, compatible con una meningitis bacteriana aguda, sin poder identificar el agente en la tinción de Gram. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar cefazolina + vancomicina + corticoides endovenosos
- b) Administrar ceftriaxona + metronidazol + corticoides endovenosos
- c) Administrar ceftriaxona + ampicilina + corticoides endovenosos
- d) Administrar cefotaximo + gentamicina + metronidazol + corticoides endovenosos
- e) Administrar cefotaximo + gentamicina + corticoides endovenosos

7) ¿Cuál de las siguientes asociaciones entre patología y presentación clínica es INCORRECTA?

- a) Embolia de arteria cerebral anterior – Hemiparesia de predominio crural
- b) Embolia de arteria cerebral media – Afasia
- c) Embolia de arteria cerebral posterior – Amaurosis
- d) Infarto de troncoencéfalo – Síndrome alterno
- e) Infarto lacunar de la cápsula interna – Hemiparesia pura

8) Un hombre de 67 años presenta un cuadro de varios meses de evolución de fallas de la memoria, asociado a ideas paranoides, caídas frecuentes y movimientos involuntarios de las extremidades superiores. Los familiares refieren que en ocasiones es agresivo y presenta alucinaciones visuales. El diagnóstico más probable es:

- a) Hidrocefalia normotensiva
- b) Enfermedad de Alzheimer
- c) Glioblastoma multiforme
- d) Demencia por cuerpos de Lewy
- e) Delirium

9) Un paciente de 34 años presenta cefalea holocránea muy intensa, de inicio súbito, hace 60 minutos. Refiere que es muy raro que presente cefalea y su examen físico, incluyendo un adecuado examen neurológico, es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar AINEs y corticoides endovenosos
- b) Administrar sumatriptán subcutáneo
- c) Enviar a domicilio con analgésicos orales, indicando control en caso de aparición de signos de alarma
- d) Solicitar resonancia magnética nuclear de cerebro
- e) Solicitar TAC de cerebro, sin contraste

10) La asociación entre ptosis y miosis es característica de:

- a) Parálisis del nervio oculomotor
- b) Parálisis del nervio troclear
- c) Parálisis del nervio abducens
- d) Miastenia gravis
- e) Síndrome de Claude Bernard Horner

11) Un paciente de 67 años consulta por temblor de las extremidades superiores, que aumenta al adoptar alguna postura. Refiere que su madre presentó un cuadro similar. La marcha y la coordinación motora son normales y no presenta focalidad en el examen neurológico. El tratamiento de la patología descrita es:

- a) Antidepresivos tricíclicos
- b) Agonistas dopaminérgicos
- c) Betabloqueo
- d) Antipsicóticos
- e) Anticonvulsivantes

12) Un paciente de 55 años consulta por dolor en la mitad de la frente y la mejilla derechas, muy intenso, de segundos de duración, que se presenta varias veces al día, desde hace algunos días. Refiere que el dolor suele gatillarse al tocarse la cara. El examen físico y neurológico no presenta alteraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar AINEs
- b) Iniciar sumatriptán
- c) Iniciar flunarizina
- d) Iniciar corticoides
- e) Iniciar carbamazepina

13) Identifique la asociación CORRECTA entre la raíz nerviosa y la función que desempeña:

- a) C5 – Sensibilidad cara interna del brazo
- b) C6 – Flexión del codo
- c) C7 – Reflejo bicipital
- d) T5 – Sensibilidad periumbilical
- e) S1 – Sensibilidad de la zona inguinal

14) Un paciente de 45 años refiere cefalea de localización temporo-occipital, opresiva, recurrente, de varios años de evolución, pero que se ha vuelto más intensa y frecuente en las últimas semanas. Al examen físico sólo se detecta sensibilidad a la palpación de los músculos cervicales posteriores. EL diagnóstico más probable es:

- a) Cefalea tensional
- b) Migraña
- c) Cefalea en racimo
- d) Neuralgia de Arnold
- e) Fibromialgia

15) Un paciente presenta vértigo, asociado a vómitos y dificultad para caminar, ya que se cae. Al examen físico se aprecia nistagmo vertical, con fase rápida hacia arriba. El diagnóstico más probable es:

- a) Vértigo postural paroxístico benigno
- b) Neurinoma del acústico
- c) Neuronitis vestibular
- d) Vértigo central
- e) Enfermedad de Meniere

16) Un hombre de 80 años presenta cefalea, fiebre y desorientación. Al examen físico destaca rigidez de nuca marcada. Se solicita TAC de cerebro, que descarta hipertensión endocraneana y se realiza punción lumbar que da salida a un líquido turbio, con proteínas 1.050 mg/dl, glucosa de 20 mg/dl y 900 células por mm³, con 90% de linfocitos. EL diagnóstico más probable es:

- a) Meningitis bacteriana aguda
- b) Meningitis viral por enterovirus
- c) Meningitis herpética
- d) Meningitis tuberculosa
- e) Encefalitis por priones

17) ¿Cuál de los siguientes fármacos es útil como tratamiento profiláctico de la migraña?

- a) Flunarizina
- b) Ergotamina
- c) Sumatriptán
- d) Clozapina
- e) Fluoxetina

18) Un paciente presenta parálisis facial derecha, con compromiso de toda la cara, incluyendo la frente y asociada a hiperacusia y disgeusia. El diagnóstico más probable es:

- a) Parálisis facial periférica
- b) Infarto de la protuberancia anular
- c) Esclerosis múltiple
- d) Infarto del cuerpo estriado
- e) Accidente vascular encefálico frontoparietal isquémico

19) Identifique la asociación INCORRECTA entre la parasomnia y las características:

- a) Pesadilla – Ocurren en el sueño REM
- b) Terror nocturno – El paciente recuerda el episodio
- c) Apnea obstructiva del sueño – Se caracteriza por hipersomnia y sueño “poco reparador”
- d) Sonambulismo – Ocurre en el sueño NO REM
- e) Síndrome de piernas inquietas – Se caracteriza por disestesias y movimientos de las extremidades inferiores

20) El daño del fascículo longitudinal medial (oftalmoplejia internuclear) se caracteriza por:

- a) Imposibilidad de mirar a lateral
- b) Imposibilidad de mirar a medial
- c) Imposibilidad de mirar a inferior
- d) Imposibilidad de mirar a superior
- e) Imposibilidad de mantener la mirada fija

Prueba 8

1) Una paciente de 55 años, asintomática, presenta de manera súbita hemiparesia derecha, de predominio braquial, que dura cerca de 30 minutos, recuperándose completamente. Al examen físico no se detectan alteraciones y la resonancia magnética de cerebro resulta normal. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar electroencefalograma
- b) Solicitar ecocardiograma, ecografía doppler de arterias carótidas y Holter de arritmias
- c) Realizar anticoagulación con heparina
- d) Solicitar angiografía carotídea
- e) Indicar aspirina y observar evolución

2) ¿Cuál de los siguientes NO es un síndrome lacunar?

- a) Afasia – hemiparesia
- b) Hemiparesia pura
- c) Hemihipoestesia pura
- d) Disartria – mano torpe
- e) Hemiparesia – ataxia

3) Un niño de 3 años presenta una crisis convulsiva tónico clónica, en relación a un alza térmica hasta 39,6°C. Al examen físico está en buenas condiciones, con presión y pulso normal, faringe eritematosa, sin signos neurológicos focales. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar antipiréticos en relación a las alzas térmica, sin necesidad de anticonvulsivantes ni de estudio adicional
- b) Indicar paracetamol y diazepam durante las alzas térmicas
- c) Solicitar electroencefalograma
- d) Solicitar hemograma, hemocultivo, exámenes de orina y estudio de líquido cefalorraquídeo
- e) Solicitar resonancia magnética nuclear e iniciar carbamazepina

4) Una paciente de 18 años presenta astenia de una semana de evolución, fluctuantes, asociada a visión doble en algunas oportunidades. Al examen físico se aprecia ptosis palpebral bilateral, mayor a derecha. El diagnóstico más probable es:

- a) Esclerosis múltiple
- b) Esclerosis lateral amiotrófica
- c) Síndrome de Guillain Barré
- d) Miastenia Gravis
- e) Tumor cerebral

5) La lesión del tercer nervio craneal, producirá todo lo siguiente, EXCEPTO:

- a) Imposibilidad de mirar hacia medial
- b) Ptosis
- c) Imposibilidad de mirar hacia arriba
- d) Miosis
- e) Imposibilidad de mirar hacia abajo

6) Un paciente de 34 años consulta por cefaleas recurrentes, de varios años de evolución de carácter pulsátil, de localización frontoparietal y que suele ser muy intensa, agravándose con los ruidos y con la luz. Las crisis se presentan 3 a 4 veces al mes. El examen físico es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar AINES durante las crisis y ergotamina entre ellas, como tratamiento profiláctico
- b) Indicar flunarizina durante las crisis y amitriptilina entre ellas, como tratamiento profiláctico
- c) Indicar AINES durante las crisis y ácido valproico entre ellas, como tratamiento profiláctico
- d) Indicar ergotamínicos durante las crisis y ácido propanolol entre ellas, como tratamiento profiláctico
- e) Solicitar TAC de cerebro

7) Identifique la asociación INCORRECTA entre la raíz nerviosa y el reflejo osteotendíneo:

- a) C6 – bicipital
- b) C7 – tricipital
- c) C8 – estilorrado
- d) L3 – rotuliano
- e) S1 – aquiliano

8) El síndrome de arteria espinal anterior se caracteriza por:

- a) Compromiso motor de extremidades inferiores, sin alteraciones sensitivas
- b) Compromiso sensitivo de extremidades inferiores, sin alteraciones motoras
- c) Compromiso motor de las extremidades inferiores, con compromiso de la sensibilidad termalgésica
- d) Compromiso motor de las extremidades inferiores, con compromiso de la sensibilidad táctil fina y propioceptiva
- e) Incontinencia urinaria, asociada a anestesia en "silla de montar"

9) Un paciente de 60 años presenta un cambio en su personalidad, con actitud desinhibida, lenguaje grosero de alto contenido sexual, labilidad emocional y falta de sensibilidad en las relaciones interpersonales. Al examen físico está vigil, sin signos focales en el examen neurológico. El diagnóstico más probable es:

- a) Demencia por cuerpos de Lewy
- b) Demencia frontotemporal
- c) Enfermedad de Alzheimer
- d) Manía aguda
- e) Hidrocefalia normotensiva

10) Una paciente de 56 años presenta cefalea matinal, asociada a vómitos, que inicio hace 2 semanas y que se ha vuelto cada vez más intensa, asociándose a torpeza y debilidad para mover la mano derecha. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Jaqueca con aura
- b) Tumor cerebral
- c) Esclerosis múltiple
- d) Accidente vascular encefálico
- e) Hidrocefalia normotensiva

11) Un paciente de 45 años sufre cefalea muy intensa, de inicio súbito, asociada a vómitos alimentarios. Al examen físico destaca rigidez de nuca esbozada, sin signos focales. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar punción lumbar
- b) Solicitar resonancia magnética nuclear de cerebro
- c) Solicitar TAC de cerebro sin contraste
- d) Solicitar Angio-TAC de cerebro
- e) Administrar analgésicos endovenos y observar evolución

12) Un paciente presenta debilidad de las extremidades inferiores. Al examen físico se aprecia paraparesia, mayor a derecha, con hiperreflexia, hipertonía y signo de Babinsky bilateral, sin signos de atrofia muscular. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome piramidal
- b) Síndrome extrapiramidal
- c) Polineuropatía
- d) Esclerosis lateral amiotrófica
- e) Síndrome cerebeloso

13) El atrapamiento del nervio cubital se caracteriza por:

- a) Parestesias y dificultad a la extensión del codo, con hipoestesia sobre el epicóndilo medial
- b) Parestesias y dificultad a la flexión del codo, con hipoestesia sobre el epicóndilo lateral
- c) Parestesias y disminución de la sensibilidad de los dedos 1°, 2° y 3°
- d) Disminución en la sensibilidad y debilidad a la flexión de los dedos 4° y 5°
- e) Dificultad a la extensión de los dedos 3°, 4° y 5°, con anestesia en su cara dorsal

14) El temblor de la enfermedad de Parkinson se caracteriza por:

- a) Ser postural
- b) Asociarse a aumento del pestañeo
- c) Ser de intención
- d) Presentarse en reposo y ceder con realizar movimientos
- e) Asociarse a una marcha con aumento de la base de sustentación y pasos largos

15) Un paciente sufre una lesión en la cintilla óptica derecha. ¿Qué alteración esperaría encontrar en la campimetría?

- a) Hemianopsia bitemporal
- b) Hemianopsia homónima derecha
- c) Cuadrantopsia homónima izquierda
- d) Amaurosis derecha
- e) Amaurosis izquierda

16) Un paciente de 34 años consulta por dolor periocular izquierdo muy intenso, asociado a ptosis, epífora y rinorrea ipsilaterales. El diagnóstico más probable es:

- a) Neuralgia primaria del trigémino
- b) Neuralgia secundaria del trigémino
- c) Cefalea en racimo (cluster)
- d) Infarto de troco cerebral
- e) Glaucoma agudo

17) ¿Cuál de las siguientes alteraciones en MENOS probable de encontrar en un vértigo periférico?

- a) Dismetría
- b) Nistagmo horizontal
- c) Vómitos
- d) Hipoacusia
- e) Alteración de la prueba calórica

18) El antibiótico tratamiento de la meningitis bacteriana aguda, a germen desconocido, en un niño de 5 años, es:

- a) Penicilina + metronidazol
- b) Cefotaximo + ampicilina
- c) Ceftriaxona + vancomicina
- d) Cefotaximo + claritromicina
- e) Ceftriaxona sola

19) ¿Cuál de las siguientes alteraciones puede aparecer en una parálisis facial de Bell?

- a) Parálisis que respeta los movimientos de la frente y el músculo orbicular del ojo
- b) Hipoestesia facial
- c) Hemiparesia braquial
- d) Estrabismo
- e) Alteración en la percepción del gusto

20) Una mujer de 78 años, sin antecedentes de importancia, presenta desde hace 3 días desorientación y falsos reconocimientos de sus familiares. Se levanta en la noche y sale de su casa en dos oportunidades, siendo traída de vuelta por sus vecinos. Probablemente presenta:

- a) Un accidente vascular encefálico
- b) Una demencia inicial por enfermedad de Alzheimer
- c) Una demencia por cuerpos de Lewy
- d) Un estatus epiléptico no convulsivo
- e) Una infección o problema metabólico

Prueba 9

1) Un paciente de 64 años, hipertenso, presenta de manera súbita, imposibilidad de mover la pierna derecha, asociada a dificultad y torpeza para mover la mano ipsilateral e incontinencia urinaria. Al examen físico se constata hemiparesia derecha, con afectación completa de la extremidad inferior (M0) y sólo parcial de la superior (M3). El diagnóstico más probable es:

- a) Accidente vascular encefálico de arteria cerebral anterior
- b) Accidente vascular encefálico de arteria cerebral media
- c) Accidente vascular encefálico de arteria cerebral posterior
- d) Accidente vascular encefálico de arteria basilar
- e) Accidente vascular encefálico de arteria vertebral

2) Una mujer de 68 años presenta un cuadro de 12 meses de evolución de problemas de memoria, ideas paranoides y alucinaciones visuales. Presenta además caídas frecuentes y temblor de la mano izquierda. Los síntomas son fluctuantes, pero muestran una tendencia a empeorar. El diagnóstico más probable es:

- a) Demencia por cuerpos de Lewy
- b) Enfermedad de Alzheimer
- c) Delirium
- d) Demencia frontotemporal
- e) Hidrocefalia normotensiva

3) Un paciente de 72 años presenta temblor de las extremidades superiores, mayor a la izquierda. El temblor aparece en el reposo y desaparece al tomar un objeto o al adoptar alguna posición. Se constata además disminución de la frecuencia del pestañeo. El diagnóstico más probable es:

- a) Temblor esencial
- b) Enfermedad de Parkinson
- c) Síndrome cerebeloso
- d) Síndrome piramidal
- e) Envejecimiento normal

4) Un paciente presenta marcha inestable, con aumento de la superficie de sustentación, asociada a dismetría e imposibilidad de realizar movimientos alternantes. ¿Qué patología es más concordante con el cuadro descrito?

- a) Accidente vascular encefálico lacunar
- b) Hemorragia cerebelosa
- c) Accidente vascular talámico
- d) Síndrome piramidal
- e) Síndrome extrapiramidal

5) Una mujer de 28 años presenta debilidad de curso fluctuante, asociado a astenia. Al examen físico se aprecia ptosis bilateral, mayor a derecha. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome de Claude Bernard Horner
- b) Esclerosis múltiple
- c) Mononeuritis múltiple
- d) Síndrome de Guillain Barré
- e) Miastenia Gravis

6) Un paciente de 65 años presenta hipoestesia de las 4 extremidades, de distribución distal, que afecta principalmente la sensibilidad térmica y dolorosa. El diagnóstico más probable es:

- a) Polirradiculoneuritis desmielinizante
- b) Síndrome de arteria espinal posterior
- c) Mononeuritis múltiple
- d) Polineuropatía
- e) Mielitis transversa

7) El primer fármaco que debe administrarse a un paciente es estatus epiléptico es:

- a) Fenitoína
- b) Ácido valproico
- c) Lorazepam
- d) Fenobarbital
- e) Propofol

8) Un paciente de 36 años presenta un cuadro de 2 semanas de evolución, progresivo, de cefalea holocránea, que es mayor al despertar y que se asocia a vómitos y paresia de la mano izquierda. El diagnóstico más probable es:

- a) Accidente vascular encefálico
- b) Migraña
- c) Cefalea cluster
- d) Pseudotumor cerebral
- e) Tumor cerebral

9) Identifique la asociación INCORRECTA entre la patología y las manifestaciones clínicas:

- a) Parálisis del tercer nervio craneal izquierdo – Midriasis izquierda
- b) Daño del fascículo longitudinal medial – Imposibilidad de mirar a medial
- c) Parálisis del cuarto par craneal izquierdo – Imposibilidad de mirar hacia inferonasal con el ojo izquierdo
- d) Parálisis del sexto par craneal izquierdo – Imposibilidad de mirar hacia la izquierda con el ojo izquierdo
- e) Parálisis del nervio oculomotor izquierdo – Imposibilidad de cerrar el ojo izquierdo

10) El síndrome confusional agudo se manifiesta clínicamente como:

- a) Inatención y compromiso de conciencia cualitativo o cuantitativo, de inicio agudo y curso fluctuante
- b) Pérdida de la memoria de corto y largo plazo, asociado a compromiso de conciencia de inicio agudo
- c) Desorientación y alucinaciones auditivas de inicio agudo
- d) Agitación psicomotora y alucinaciones visuales, sin compromiso de conciencia, de inicio agudo
- e) Ideas paranoides, fallas en la memoria de largo plazo y compromiso de conciencia de inicio agudo

11) Las meningitis virales suelen ser de curso benigno y autolimitado. El agente más frecuente es:

- a) Virus herpes simple
- b) Virus influenza
- c) Enterovirus
- d) Adenovirus
- e) Virus varicela-zóster

12) Un paciente de 35 años, consulta por cefalea muy intensa, de 1 hora de evolución, que inició de manera súbita y que presentó vómitos. Refiere que rara vez presenta dolor de cabeza y que nunca había sido tan intenso. El examen neurológico es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar AINES endovenos y enviar a domicilio
- b) Solicitar TAC de cerebro sin contraste
- c) Enviar a domicilio, indicando paracetamol y AINES orales
- d) Realizar punción lumbar
- e) Solicitar resonancia magnética nuclear

13) El temblor esencial suele tratarse con:

- a) Fluoxetina
- b) Propanolol
- c) Carbamacepina
- d) Ácido valproico
- e) Flunarizina

14) El nistagmo multidireccional es característico de:

- a) La parálisis vestibular súbita
- b) La enfermedad de Meniere
- c) El vértigo postural paroxístico benigno
- d) La neuritis vestibular
- e) Los vértigos de origen central

15) ¿Cuál de las siguientes alteraciones NO suele presentarse en la parálisis facial periférica idiopática?

- a) Hipoestesia malar
- b) Imposibilidad de levantar la ceja
- c) Hiperacusia
- d) Disgeusia
- e) Desviación de la comisura labial

16) La hemisección medular izquierda, a la altura de T10, se presentará clínicamente como:

- a) Incontinencia urinaria y anestesia en silla de montar
- b) Parálisis de la extremidad inferior izquierda y anestesia total de la extremidad inferior derecha
- c) Parálisis y ausencia de sensibilidad termalgésica en la extremidad inferior derecha y ausencia de sensibilidad vibratoria y táctil fina de la extremidad inferior izquierda
- d) Parálisis y ausencia de sensibilidad termalgésica en la extremidad inferior izquierda y ausencia de sensibilidad vibratoria y táctil fina de la extremidad inferior derecha
- e) Parálisis y ausencia de sensibilidad vibratoria y fina en la extremidad inferior izquierda y ausencia de sensibilidad termalgésica en la extremidad inferior derecha

17) Una mujer de 40 años, con antecedente de una hemiparesia derecha, consulta por imposibilidad de ver con el ojo izquierdo, que se instaló en 8 horas. Actualmente presenta amaurosis izquierda total, asociada a un defecto pupilar aferente. El diagnóstico más probable es:

- a) Apoplejía hipofisiaria
- b) Esclerosis lateral amiotrófica
- c) Esclerosis múltiple
- d) Tumor cerebral
- e) Accidente vascular encefálico

18) Un hombre de 75 años consulta por fiebre, cefalea y compromiso del estado general de 1 días de evolución, a lo que se le agregó una convulsión tónico-clónica. Se solicita un TAC de cerebro que no muestra lesiones focales ni signos de hipertensión endocraneana y se realiza una punción lumbar que da salida a un líquido turbio, con 2.500 células por mm³, con 87% de polimorfonucleares y glucosa baja. La tinción de Gram no visualiza bacterias y el cultivo está pendiente. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar tratamiento sintomático
- b) Iniciar aciclovir endovenoso
- c) Iniciar tratamiento antituberculoso, asociado a corticoides endovenosos
- d) Iniciar ceftriaxona + vancomicina + corticoides endovenosos
- e) Iniciar ceftriaxona + ampicilina + corticoides endovenosos

19) Un paciente de 50 años presenta dolor en la mejilla derecha, en ramalazo, recurrente, muy intenso, de algunos segundos de duración, que se gatilla al tocar la zona o bien espontáneamente. El examen físico, incluyendo un adecuado examen neurológico es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar triptanes subcutáneos y oxígeno al 100%
- b) Indicar AINEs orales
- c) Indicar bloqueadores de los canales de calcio
- d) Iniciar analgésico opiáceos orales
- e) Iniciar amitriptilina oral

20) ¿Cuál de las siguientes medidas es MENOS adecuada para el manejo de un paciente que cursa con un accidente vascular encefálico de tipo hemorrágico?

- a) Mantener la temperatura corporal dentro de rangos normales
- b) Mantener la presión arterial dentro de rangos normales
- c) Mantener la glicemia dentro de rangos normales
- d) Administrar oxígeno
- e) Indicar régimen cero

Prueba 10

1) Un paciente de 64 años, hipertenso, presenta de manera súbita, imposibilidad de mover la pierna derecha, asociada a dificultad y torpeza para mover la mano ipsilateral e incontinencia urinaria. Al examen físico se constata hemiparesia derecha, con afectación completa de la extremidad inferior (M0) y sólo parcial de la superior (M3). El diagnóstico más probable es:

- a) Accidente vascular encefálico de arteria cerebral anterior
- b) Accidente vascular encefálico de arteria cerebral media
- c) Accidente vascular encefálico de arteria cerebral posterior
- d) Accidente vascular encefálico de arteria basilar
- e) Accidente vascular encefálico de arteria vertebral

2) Una mujer de 68 años presenta un cuadro de 12 meses de evolución de problemas de memoria, ideas paranoides y alucinaciones visuales. Presenta además caídas frecuentes y temblor de la mano izquierda. Los síntomas son fluctuantes, pero muestran una tendencia a empeorar. El diagnóstico más probable es:

- a) Demencia por cuerpos de Lewy
- b) Enfermedad de Alzheimer
- c) Delirium
- d) Demencia frontotemporal
- e) Hidrocefalia normotensiva

3) Un paciente de 72 años presenta temblor de las extremidades superiores, mayor a la izquierda. El temblor aparece en el reposo y desaparece al tomar un objeto o al adoptar alguna posición. Se constata además disminución de la frecuencia del pestañeo. El diagnóstico más probable es:

- a) Temblor esencial
- b) Enfermedad de Parkinson
- c) Síndrome cerebeloso
- d) Síndrome piramidal
- e) Envejecimiento normal

4) Un paciente presenta marcha inestable, con aumento de la superficie de sustentación, asociada a dismetría e imposibilidad de realizar movimientos alternantes. ¿Qué patología es más concordante con el cuadro descrito?

- a) Accidente vascular encefálico lacunar
- b) Hemorragia cerebelosa
- c) Accidente vascular talámico
- d) Síndrome piramidal
- e) Síndrome extrapiramidal

5) Una mujer de 28 años presenta debilidad de curso fluctuante, asociado a astenia. Al examen físico se aprecia ptosis bilateral, mayor a derecha. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome de Claude Bernard Horner
- b) Esclerosis múltiple
- c) Mononeuritis múltiple
- d) Síndrome de Guillain Barré
- e) Miastenia Gravis

6) Un paciente de 65 años presenta hipoestesia de las 4 extremidades, de distribución distal, que afecta principalmente la sensibilidad térmica y dolorosa. El diagnóstico más probable es:

- a) Polirradiculoneuritis desmielinizante
- b) Síndrome de arteria espinal posterior
- c) Mononeuritis múltiple
- d) Polineuropatía
- e) Mielitis transversa

7) El primer fármaco que debe administrarse a un paciente es estatus epiléptico es:

- a) Fenitoína
- b) Ácido valproico
- c) Lorazepam
- d) Fenobarbital
- e) Propofol

8) Un paciente de 36 años presenta un cuadro de 2 semanas de evolución, progresivo, de cefalea holocránea, que es mayor al despertar y que se asocia a vómitos y paresia de la mano izquierda. El diagnóstico más probable es:

- a) Accidente vascular encefálico
- b) Migraña
- c) Cefalea cluster
- d) Pseudotumor cerebral
- e) Tumor cerebral

9) Identifique la asociación INCORRECTA entre la patología y las manifestaciones clínicas:

- a) Parálisis del tercer nervio craneal izquierdo – Midriasis izquierda
- b) Daño del fascículo longitudinal medial – Imposibilidad de mirar a medial
- c) Parálisis del cuarto par craneal izquierdo – Imposibilidad de mirar hacia inferonasal con el ojo izquierdo
- d) Parálisis del sexto par craneal izquierdo – Imposibilidad de mirar hacia la izquierda con el ojo izquierdo
- e) Parálisis del nervio oculomotor izquierdo – Imposibilidad de cerrar el ojo izquierdo

10) El síndrome confusional agudo se manifiesta clínicamente como:

- a) Inatención y compromiso de conciencia cualitativo o cuantitativo, de inicio agudo y curso fluctuante
- b) Pérdida de la memoria de corto y largo plazo, asociado a compromiso de conciencia de inicio agudo
- c) Desorientación y alucinaciones auditivas de inicio agudo
- d) Agitación psicomotora y alucinaciones visuales, sin compromiso de conciencia, de inicio agudo
- e) Ideas paranoides, fallas en la memoria de largo plazo y compromiso de conciencia de inicio agudo

11) Las meningitis virales suelen ser de curso benigno y autolimitado. El agente más frecuente es:

- a) Virus herpes simple
- b) Virus influenza
- c) Enterovirus
- d) Adenovirus
- e) Virus varicela-zóster

12) Un paciente de 35 años, consulta por cefalea muy intensa, de 1 hora de evolución, que inició de manera súbita y que presentó vómitos. Refiere que rara vez presenta dolor de cabeza y que nunca había sido tan intenso. El examen neurológico es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar AINES endovenos y enviar a domicilio
- b) Solicitar TAC de cerebro sin contraste
- c) Enviar a domicilio, indicando paracetamol y AINES orales
- d) Realizar punción lumbar
- e) Solicitar resonancia magnética nuclear

13) El temblor esencial suele tratarse con:

- a) Fluoxetina
- b) Propanolol
- c) Carbamacepina
- d) Ácido valproico
- e) Flunarizina

14) El nistagmo multidireccional es característico de:

- a) La parálisis vestibular súbita
- b) La enfermedad de Meniere
- c) El vértigo postural paroxístico benigno
- d) La neuritis vestibular
- e) Los vértigos de origen central

15) ¿Cuál de las siguientes alteraciones NO suele presentarse en la parálisis facial periférica idiopática?

- a) Hipoestesia malar
- b) Imposibilidad de levantar la ceja
- c) Hiperacusia
- d) Disgeusia
- e) Desviación de la comisura labial

16) La hemisección medular izquierda, a la altura de T10, se presentará clínicamente como:

- a) Incontinencia urinaria y anestesia en silla de montar
- b) Parálisis de la extremidad inferior izquierda y anestesia total de la extremidad inferior derecha
- c) Parálisis y ausencia de sensibilidad termalgésica en la extremidad inferior derecha y ausencia de sensibilidad vibratoria y táctil fina de la extremidad inferior izquierda
- d) Parálisis y ausencia de sensibilidad termalgésica en la extremidad inferior izquierda y ausencia de sensibilidad vibratoria y táctil fina de la extremidad inferior derecha
- e) Parálisis y ausencia de sensibilidad vibratoria y fina en la extremidad inferior izquierda y ausencia de sensibilidad termalgésica en la extremidad inferior derecha

17) Una mujer de 40 años, con antecedente de una hemiparesia derecha, consulta por imposibilidad de ver con el ojo izquierdo, que se instaló en 8 horas. Actualmente presenta amaurosis izquierda total, asociada a un defecto pupilar aferente. El diagnóstico más probable es:

- a) Apoplejía hipofisiaria
- b) Esclerosis lateral amiotrófica
- c) Esclerosis múltiple
- d) Tumor cerebral
- e) Accidente vascular encefálico

18) Un hombre de 75 años consulta por fiebre, cefalea y compromiso del estado general de 1 días de evolución, a lo que se le agregó una convulsión tónico-clónica. Se solicita un TAC de cerebro que no muestra lesiones focales ni signos de hipertensión endocraneana y se realiza una punción lumbar que da salida a un líquido turbio, con 2.500 células por mm³, con 87% de polimorfonucleares y glucosa baja. La tinción de Gram no visualiza bacterias y el cultivo está pendiente. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar tratamiento sintomático
- b) Iniciar aciclovir endovenoso
- c) Iniciar tratamiento antituberculoso, asociado a corticoides endovenosos
- d) Iniciar ceftriaxona + vancomicina + corticoides endovenosos
- e) Iniciar ceftriaxona + ampicilina + corticoides endovenosos

19) Un paciente de 50 años presenta dolor en la mejilla derecha, en ramalazo, recurrente, muy intenso, de algunos segundos de duración, que se gatilla al tocar la zona o bien espontáneamente. El examen físico, incluyendo un adecuado examen neurológico es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar triptanes subcutáneos y oxígeno al 100%
- b) Indicar AINEs orales
- c) Indicar bloqueadores de los canales de calcio
- d) Iniciar analgésico opiáceos orales
- e) Iniciar amitriptilina oral

20) ¿Cuál de las siguientes medidas es MENOS adecuada para el manejo de un paciente que cursa con un accidente vascular encefálico de tipo hemorrágico?

- a) Mantener la temperatura corporal dentro de rangos normales
- b) Mantener la presión arterial dentro de rangos normales
- c) Mantener la glicemia dentro de rangos normales
- d) Administrar oxígeno
- e) Indicar régimen cero

NEUROLOGÍA RESPUESTAS

Prueba 1	15 D	7 D		15 D	9 E
1 C	16 D	8 A	Prueba 6	16 D	10 A
2 D	17 B	9 A	1 C	17 A	11 C
3 C	18 D	10 C	2 A	18 A	12 B
4 D	19 C	11 B	3 D	19 B	13 B
5 E	20 C	12 B	4 A	20 B	14 E
6 A		13 B	5 B		15 A
7 E		14 C	6 D	Prueba 8	16 E
8 D	Prueba 3	15 C	7 B	1 B	17 C
9 B	1 D	16 A	8 C	2 A	18 E
10 C	2 E	17 C	9 C	3 A	19 E
11 C	3 B	18 A	10 A	4 D	20 B
12 B	4 A	19 C	11 D	5 D	
13 C	5 C	20 A	12 A	6 C	Prueba 10
14 A	6 C		13 A	7 C	1 A
15 D	7 E		14 D	8 C	2 A
16 C	8 D	Prueba 5	15 C	9 B	3 B
17 E	9 C	1 B	16 B	10 B	4 B
18 A	10 E	2 A	17 D	11 C	5 E
19 C	11 B	3 E	18 B	12 A	6 D
20 A	12 B	4 A	19 E	13 D	7 C
	13 A	5 B	20 A	14 D	8 E
	14 E	6 C		15 C	9 E
Prueba 2	15 E	7 C	Prueba 7	16 C	10 A
1 A	16 A	8 C	1 D	17 A	11 C
2 B	17 E	9 C	2 B	18 C	12 B
3 E	18 A	10 B	3 E	19 E	13 B
4 B	19 C	11 D	4 A	20 E	14 E
5 A	20 D	12 C	5 E		15 A
6 D		13 E	6 C	Prueba 9	16 E
7 B		14 B	7 C	1 A	17 C
8 B	Prueba 4	15 D	8 D	2 A	18 E
9 A	1 C	16 B	9 E	3 B	19 E
10 C	2 D	17 E	10 E	4 B	20 B
11 D	3 E	18 D	11 C	5 E	
12 D	4 A	19 B	12 E	6 D	
13 B	5 C	20 D	13 B	7 C	
14 B	6 E		14 A	8 E	

VI) ENDOCRINOLOGÍA, DIABETES Y NUTRICIÓN PRUEBAS

Prueba 1

1) Hombre de 22 años, consulta por infertilidad. Al examen físico destacan testículos de tamaño pequeño. La testosterona plasmática está disminuida y la FSH aumentada. El espermiograma demuestra azoospermia. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome de Klinefelter
- b) Disgenesia gonadal primaria
- c) Hipopituitarismo
- d) Hipogonadismo hipogonadotrópico
- e) Orquitis atrófica idiopática

2) Paciente diabético de 57 años, cursando síndrome nefrótico, secundario a nefropatía membranosa. En sus exámenes destaca hipercolesterolemia, albúmina:2,1 mg/dl, creatinina:1,1 mg/dl, Ca:7,3 mg/dl, con sodio, potasio y cloro normales. La causa más probable de su hipocalcemia es:

- a) Pérdidas renales de calcio
- b) Hipocalcemia por insuficiencia renal crónica
- c) Hipocalcemia ficticia
- d) Hipovitaminosis D
- e) Hipocalcemia por diuréticos

3) Mujer de 38 años, puérpera hace 6 meses. Durante el parto presentó importante hemorragia, secundaria a inercia uterina. Desde el comienzo presentó agalactia, por lo que debió alimentar exclusivamente con fórmula a su hijo. A pesar de lo anterior, persiste en amenorrea y se ha agregado astenia y adinamia importante. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome de Sheehan
- b) Apoplejía apofisiaria
- c) Tiroiditis postparto
- d) Hiperprolactinemia
- e) Hipogonadismo hipergonadotrófico

4) Mujer de 18 años, consulta por reglas irregulares, las que presenta cada 2 a 3 meses. Al examen se aprecia obesa, con hirsutismo leve, acné y piel grasa. La causa más probable de su alteración menstrual es:

- a) Hipogonadismo hipergonadotrópico
- b) Hipotiroidismo
- c) Síndrome de ovario poliquístico
- d) Hiperplasia suprarrenal
- e) Tumor productor de andrógenos

5) Mujer de 40 años, hipertensa, con obesidad de disposición troncular, estrías abdominales y moderado hirsutismo. Usted sospecha un síndrome de Cushing. La conducta más adecuada a seguir es:

- a) Administrar hidrocortisona endovenosa
- b) Solicitar cortisol plasmático basal
- c) Solicitar cortisol libre urinario de 24 horas
- d) Medir cortisol plasmático basal y tras estimulación con ACTH
- e) Solicitar resonancia magnética nuclear de hipófisis

6) Mujer de 52 años que consulta por temblor, nerviosismo, pérdida de peso e intolerancia al calor desde hace 2 meses. Al examen: exoftalmo mayor a derecha, retracción palpebral bilateral, mixedema pretibial y bocio difuso, no doloroso. La TSH se encuentra suprimida. El diagnóstico más probable es:

- a) Hipertiroidismo por adenoma tóxico
- b) Enfermedad de Basedow-Graves
- c) Hipertiroidismo facticio
- d) Tiroiditis subaguda
- e) Bocio multinodular tóxico

7) La alteración lipídica, asociada con mayor frecuencia al hipotiroidismo es:

- a) Hipertrigliceridemia
- b) HDL bajo
- c) Hipercolesterolemia
- d) LDL pequeñas y densas
- e) LDL oxidada

8) Paciente de 30 años, con nódulo tiroideo de consistencia pétrea, en el lóbulo derecho. Se estudia con ecografía que demuestra tumor sólido de 19mm. La TSH resulta normal y la punción con aguja fina demuestra citología compatible con carcinoma papilar de tiroides. La conducta inicial más adecuada es:

- a) Realizar biopsia con aguja gruesa
- b) Realizar hemitiroidectomía derecha
- c) Realizar tiroidectomía total
- d) Administrar yodo radiactivo
- e) Iniciar levotiroxina y realizar control ecográfico en 30 días

9) Mujer de 33 años, consulta por astenia y adinamia de algunas semanas de evolución. Al examen físico destaca hiperpigmentación de manos, facial y de mucosa oral. En sus exámenes destaca K: 5,5 mEq/l; Na: 132 mEq/l; Cl: 98 mEq/l. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Tumor productor de ACTH ectópica
- b) Insuficiencia suprarrenal crónica, secundaria
- c) Enfermedad de Cushing
- d) Hiperaldosteronismo primario
- e) Insuficiencia suprarrenal primaria

10) Un paciente de 50 años, hipertenso, asintomático. En un perfil bioquímico, realizado como chequeo médico, se constata hipercalcemia de 16 mg/dl, hiperfosfatemia y fosfatasas alcalinas elevadas. El diagnóstico más probable es:

- a) Hiperparatiroidismo primario
- b) Hipercalcemia maligna
- c) Hipervitaminosis D
- d) Cáncer medular de tiroides
- e) Hipercalcemia por fármacos

Preguntas Diabetología y Nutrición

11) Paciente hipertenso y diabético, con control irregular. Consulta porque en la mañana pierde en cuestión de minutos, la visión del ojo izquierdo. Al examen: amaurosis izquierda, oculomotilidad normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Edema macular
- b) Retinopatía diabética no proliferativa
- c) Retinopatía diabética proliferativa
- d) Hemorragia vítrea
- e) Trobosis de la vena central de la retina

12) ¿Qué modificación recomendaría en el tratamiento de un paciente diabético tratado con insulina NPH matinal. Presenta buen control glicémico durante el día, confirmado mediante hemoglucotest, sin embargo presenta glicemias de ayuno cercanas a 300 mg/dl. La conducta terapéutica más adecuada es:

- a) Agregar insulina cristalina durante la mañana
- b) Aumentar la dosis matinal de insulina NPH
- c) Agregar insulina NPH nocturna
- d) Agregar insulina cristalina nocturna
- e) Agregar colación durante la mañana

13) El examen de elección para evaluar la respuesta al tratamiento de un hipotiroidismo, secundario a tiroiditis de Hashimoto, es:

- a) TSH
- b) T4 libre
- c) T4 y T3
- d) Anticuerpos anti-TPO
- e) El examen clínico

14) Alcohólico de 55 años. Refiere epistaxis frecuentes y dolor en la cadera izquierda. Al examen se aprecia un paciente delgado, con equimosis en piernas, petequias en manos, muslos y pies. También presenta gingivitis hemorrágica. Al movilizar la cadera izquierda presenta gran dolor. El cuadro descrito se correlaciona mejor con la deficiencia de la siguiente vitamina:

- a) A
- b) B1
- c) B6
- d) C
- e) K

15) El mejor examen para evaluar el control glicémico de un paciente diabético es:

- a) Glicemia de ayuno
- b) Microalbuminuria
- c) Test de tolerancia a la glucosa
- d) HbA1c
- e) Fondo de ojo

16) Mujer de 25 años, con sobrepeso, cursando embarazo de 8 semanas. En sus exámenes de control se constata glicemia de ayuno de 109 mg/dl. La conducta más adecuada es:

- a) Continuar control de embarazo, sin necesidad de tomar ninguna medida adicional
- b) Solicitar nueva glicemia de ayuno
- c) Solicitar test de tolerancia a la glucosa
- d) Iniciar ejercicio, dieta y metformina
- e) Iniciar insulina

17) Niño de 4 años. En control de niño sano se constata peso: +2,3 DS, talla: + 1,4 DS, IPT: + 1,5 DS . El diagnóstico nutricional es:

- a) Eutrofia
- b) Sobrepeso
- c) Obesidad
- d) Desnutrición
- e) Talla baja

18) Paciente de 45 años, se realiza perfil lipídico, como chequeo médico, con el siguiente resultado: HDL:34, LDL:210, Triglicéridos:580. La conducta terapéutica inicial debe ser:

- a) Dieta más ejercicio y control en 3 meses
- b) Iniciar una estatina
- c) Iniciar un fibrato
- d) Indicar una asociación entre una estatina y un fibrato
- e) Iniciar ácido nicotínico

19) La alteración neurológica, que se presenta con mayor frecuencia en pacientes diabéticos, es:

- a) Mononeuropatía múltiple
- b) Compromiso de pares craneales oculomotores
- c) Debilidad y atrofia muscular proximal
- d) Compromiso sensitivo distal y simétrico
- e) Compromiso motor distal

20) Hombre de 21 años, diabético tipo 1, normopeso, bien controlado con insulina en esquema intensificado. Comienza a tener crisis de mareo y sudoración al final de la mañana. La hemoglobina glicosilada es normal. La conducta más adecuada, de entre las siguientes, es:

- a) Aumentar dosis de insulina NPH de la tarde
- b) Disminuir insulina NPH matinal
- c) Indicar colación en la mañana
- d) Aumentar insulina cristalina nocturna
- e) Disminuir insulina cristalina nocturna

Prueba 2

1) Un paciente de 45 años, obeso, consulta por palpitaciones, polidefecación y marcado nerviosismo. En su examen físico presenta piel fina y húmeda y retracción palpebral bilateral, sin exoftalmo. Su tiroides se palpa normal. Se solicita TSH que resulta suprimida, T4 elevada y tiroglobulina casi indetectable. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad de Hashimoto
- b) Enfermedad de Basedow Graves
- c) Tiroiditis de Quervern
- d) Hipertiroidismo por consumo de tiroxina exógena
- e) Adenoma tóxico

2) Una paciente de 33 años presenta un cuadro de astenia, debilidad muscular y náuseas. En su examen físico destaca hiperpigmentación de la cara y melano plaquias en la cavidad oral. El examen de elección para aclarar el diagnóstico es:

- a) Cortisol libre urinario de 24 horas
- b) Cortisol y ACTH basales
- c) Cortisol post-Dexametsona
- d) Cortisol basal y post-ACTH
- e) Cortisol matinal y nocturno

3) La enfermedad de Cushing presenta las siguientes alteraciones, EXCEPTO:

- a) Atrofia muscular
- b) Estrías violáceas
- c) Osteoporosis
- d) Hipoglicemia
- e) Hipertensión arterial

4) La hiperprolactinemia en hombres se manifiesta frecuentemente como:

- a) Ginecomastia aislada
- b) Galactorrea aislada
- c) Impotencia sexual y disminución de la libido
- d) Astenia y vómitos
- e) Ginecomastia y galactorrea

5) Una paciente de 33 años presenta un nódulo tiroideo de 1,5 cm, que en la ecografía se aprecia de aspecto sólido, sin adenopatías. No presenta otros síntomas y tiene TSH normal. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar levotiroxina
- b) Realizar biopsia por punción con aguja fina
- c) Solicitar cintigrafía tiroidea con yodo radiactivo
- d) Realizar biopsia quirúrgica
- e) Controlar con nueva ecografía en 3 meses

6) Una paciente de 40 años, presenta amenorrea de 4 meses de evolución. No presenta otros síntomas y cuenta con una prueba de embarazo negativa, prolactina normal, TSH normal y con una prueba de progesterona positiva. El diagnóstico más probable es:

- a) Amenorrea de origen uterino
- b) Hipogonadismo hipogonadotrópico (hipotálamo-hipofisario)
- c) Hipogonadismo hipergonadotrópico (ovárico)
- d) Climaterio
- e) Anovulación

7) El tratamiento inicial de elección de la enfermedad de Basedow Graves es:

- a) Levotiroxina oral más betabloqueantes
- b) Yodo radiactivo
- c) Corticoides orales y beta-bloqueantes
- d) Propiltiouracilo más beta-bloqueantes
- e) Beta-agonistas y levotiroxina

8) Un paciente presenta hipercalcemia de 11 mg/dl, con elevación de la fosfatemia y de las fosfatasas alcalinas. El diagnóstico más probable es:

- a) Hiperparatiroidismo primario
- b) Hiperparatiroidismo secundario
- c) Hipercalcemia maligna
- d) Hipercalciuria primaria
- e) Hipervitaminosis D

9) El mejor examen para controlar la respuesta al tratamiento de un paciente con hipotiroidismo, es:

- a) Examen físico
- b) TSH plasmática
- c) T4 plasmática
- d) T3 plasmática
- e) Tiroglobulina plasmática

10) Un paciente de 66 años, hospitalizado por un trauma encéfalo craneano moderado, evoluciona con compromiso de conciencia, sin signos focales. Su hemoglucotest es normal. Se solicita un TAC de cerebro, que descarta hemorragias. En sus exámenes destaca hiponatremia de 120 mEq/l. El diagnóstico más probable es:

- a) Insuficiencia suprarrenal aguda
- b) Secreción inadecuada de hormona antidiurética
- c) Sección del tallo hipofisiario
- d) Hiperaldosteronismo primario
- e) Hipoaldosteronismo

11) Una paciente lúpica en tratamiento con prednisona desde hace un año, suspende el tratamiento, evolucionando con compromiso del estado general, dolor abdominal y vómitos. Al examen físico presenta presión arterial de 78/40 mmHg y FC: 104x' con extremidades frías y sudorosas. No presenta alteraciones cutáneas ni a la auscultación cardiopulmonar y su hemoglucotest es de 68. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar suero glucosado e insulina endovenosa
- b) Administrar suero fisiológico e hidrocortisona endovenosa y solicitar electrolitos plasmáticos
- c) Administrar suero fisiológico e insulina endovenosa
- d) Administrar suero glucosado, con 2 gramos de NaCl y 1 gramo de KCl, por vía venosa periférica
- e) Administrar suero glucosado y dexametasona por vía endovenosa

12) ¿Qué tipo de alteración es más probable encontrar en un tumor hipofisiario compresivo?

- a) Hemianopsia nasal derecha
- b) Cuadrantopsia heterónima bitemporal
- c) Cuadrantopsia heterónima binasal
- d) Amaurosis derecha
- e) Hemoanopsia homónima derecha

13) ¿En qué condición es preferible solicitar T4 libre en lugar de T4 corriente?

- a) Tiroiditis subaguda
- b) Tiroiditis de hashimoto
- c) Hipotiroidismo congénito
- d) Uso de anticonceptivos orales
- e) Insuficiencia cardíaca

14) ¿Cuál de los siguientes casos es más sugerente de una tiroiditis subaguda de Quervern?

- a) Hombre de 35 años con bocio difuso, de consistencia aumentada y síntomas de hipotiroidismo
- b) Mujer de 59 años con tiroides de tamaño normal, pero consistencia dura, de manera difusa
- c) Mujer con bocio difuso, exoftalmo, mixedema pretibial y síntomas de hipertiroidismo
- d) Hombre de 55 años, con bocio nodular, asociado a poliadenopatías cervicales
- e) Mujer de 30 años con dolor cervical y otalgia, asociado a bocio doloroso a la palpación

15) Ante un paciente con síndrome poliúrico, quien presenta glicemia y creatinina normal, ¿Qué examen se debe solicitar para lograr un adecuado diagnóstico?

- a) Electrolitos urinarios y plasmáticos basales y luego de privación de agua
- b) TAC de silla turca
- c) ADH plasmática
- d) Prueba de respuesta a la ADH
- e) Sedimento de orina

16) Una paciente de 45 años nota cambios en sus facciones desde hace 3 años. Además refiere que su lengua ha crecido, por lo que le es más difícil hablar y que su talla de calzado ha aumentado de 37 a 40 en este tiempo. Al examen físico se observan rasgos faciales toscos, con macroglosia y aumento del tamaño de manos y pies. Además en sus exámenes destaca glicemia de 150 mg/dl en 2 tomas distintas. Además de iniciar tratamiento para su diabetes, se debe:

- a) Solicitar somatomedinas plasmáticas (IGF-1)
- b) Realizar estudio para hipercortisolismo
- c) Solicitar GH basal
- d) Solicitar GH post-insulina post-ejercicio
- e) Solicitar TSH y T4

17) Los bochornos perimenopáusicos se caracterizan por calor y eritema facial y de la mitad superior del tronco, de algunos segundos o minutos de duración, evanescentes. El tratamiento más efectivo para evitarlos es:

- a) Bloqueadores de calcio
- b) Calcio más vitamina D
- c) Estrógenos orales
- d) Antidepresivos inhibidores de la recaptura de serotonina
- e) Benzodiacepinas

18) El síndrome de compresión del tallo hipofisiario generalmente es causado por tumores y presenta las siguientes alteraciones, EXCEPTO:

- a) Hipotiroidismo
- b) Insuficiencia suprarrenal
- c) Hipogonadismo
- d) Prolactinemia disminuida
- e) Hormona de crecimiento disminuida

19) Una mujer de 18 años, presenta oligomenorrea, acné e hirsutismo. Al examen físico se aprecia además que es obesa y que presenta acantosis nigricans. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome de ovario poliquístico
- b) Hiperplasia suprarrenal congénita
- c) Diabetes mellitus
- d) Síndrome de Cushing
- e) Hipotiroidismo

20) Un niño de 15 años, presenta escaso desarrollo puberal, a pesar de tener una estatura normal. Al examen físico NO se aprecia vello púbico y se palpan testículos de pequeño tamaño. Se solicitan exámenes que demuestran disminución de la testosterona, con aumento de las gonadotropinas. El diagnóstico más probable es:

- a) Hiperplasia suprarrenal congénita
- b) Orquitis urleana
- c) Disgenesia gonadal primaria
- d) Síndrome de resistencia periférica a los andrógenos
- e) Síndrome de Klinefelter

Prueba 3 (DIABETES, NUTRICIÓN y MIR 2006)

1) Un paciente de 42 años de edad consulta por molestias faríngeas y cierta afonía de dos meses de evolución. No es fumador ni tiene una profesión en que deba forzar la voz. Una exploración laríngea revela un ligero edema de las cuerdas vocales y un ligero eritema de la región interarritenoidea. Interrogado el paciente no refiere pirosis ni regurgitación ácida. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?:

- a) La presencia de mínimas lesiones laríngeas indican que muy probablemente el paciente tenga también lesiones de esofagitis y por tanto hay que indicar una endoscopia digestiva alta.
- b) En ausencia de síntomas de broncoaspiración (tos y sibilancias), las molestias laríngeas no pueden ser atribuidas a enfermedad por reflujo gastroesofágico.
- c) La ausencia de síntomas de reflujo (pirosis y regurgitación) no descarta la enfermedad por reflujo.
- d) Puede averiguarse si la causa de los síntomas es una enfermedad por reflujo gastroesofágico con una prueba corta administrando ranitidina 150 mg al día durante dos semanas. La ausencia de mejoría sintomática descarta el reflujo como causa de los síntomas laríngeos.
- e) Si un tránsito esófago-gástrico con bario muestra hernia hiatal, es altamente probable que los síntomas laríngeos sean debidos a reflujo gastroesofágico.

2) Una paciente de 42 años ingresó hace 6 días con un cuadro de pancreatitis aguda de origen biliar. La mala evolución obliga a determinar si presenta necrosis pancreática. ¿Qué prueba diagnóstica solicitaría?:

- a) Ecografía abdominal con contraste endovenoso.
- b) Colangio – Resonancia magnética.
- c) Radiografía simple de abdomen.
- d) Colangio pancreatografía retrograda endoscópica.
- e) Tomografía computorizada con contraste endovenoso.

3) Paciente de 22 años, fumador de ½ paquete al día y diagnosticado de soplo cardíaco en la adolescencia. Acude al hospital por dolor torácico y disnea. En la auscultación se detecta un soplo sistólico en mesocardio que aumenta con la maniobra de valsalva. En el ECG está en fibrilación auricular rápida, tiene signos de crecimiento ventricular izquierdo y ondas q en DI y aVL. La Rx de tórax demuestra la existencia de insuficiencia cardíaca y silueta normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

- a) Estenosis aórtica congénita.
- b) Infarto lateral alto
- c) Miocardiopatía dilatada
- d) Angina inestable.
- e) Miocardiopatía hipertrófica obstructiva.

4) Una mujer de 55 años, fumadora durante años, consulta por síntomas derivados de un síndrome de vena cava superior. En la Rx de tórax hay marcado ensanchamiento mediastínico. ¿Cuál es la patología a más frecuente?:

- a) Carcinoma microcítico pulmonar.
- b) Carcinoma químico.
- c) Enfermedad de Hodgkin.
- d) Linfoma folicular.
- e) Carcinoma tiroideo anaplásico.

5) Un hombre de 30 años acude a su consulta por presentar debilidad muscular y diplopia fluctuantes, de un mes de evolución, que usted objetiva con la exploración física. ¿Cuál de las siguientes pruebas NO le parecería oportuno solicitar?:

- a) Electromiografía de fibra muscular aislada.
- b) Electromiografía con estimulación repetitiva.
- c) Estudio de función autonómica.
- d) Determinación de anticuerpos anti-receptor de acetilcolina.
- e) TAC torácico.

6) Todas las siguientes son manifestaciones de la espondilitis anquilosante (anquilopoyética) EXCEPTO:

- a) Dolor lumbar y rigidez de más de 3 meses que mejora con el ejercicio pero no con el reposo.
- b) Sacroileitis radiológica bilateral.
- c) Uveítis aguda anterior.
- d) Insuficiencia aórtica.
- e) Vasculitis de pequeños vasos

7) Un enfermo de 50 años, diabético conocido desde hace 30 años, sin retinopatía proliferativa ni alteraciones urinarias conocidas, presenta edemas de instauración rápida, proteinuria nefrótica y microhematuria. El aclaramiento de creatinina es de 120 ml/min. El complemento es normal y no se detectan anticuerpos. El cuadro se ha mantenido estable en los últimos seis meses. El diagnóstico sería:

- a) Nefropatía diabética.
- b) Nefropatía mesangial IgA.
- c) Glomerulonefritis membranoproliferativa.
- d) Nefropatía membranosa.
- e) Glomerulonefritis proliferativa extracapilar.

8) Una mujer de 68 años con antecedentes de AC-VA isquémico derecho, cardiopatía isquémica (angina crónica estable), hipertensión arterial bien controlada y diabetes mellitus tipo 2, consulta por un episodio de AIT (ataque isquémico transitorio). En la tomografía axial computarizada no se observan cambios en la imagen cerebral previa y en el electrocardiograma se confirma la existencia de una fibrilación auricular, con respuesta ventricular normal, cuya reversión a ritmo sinusal, tanto eléctrica como farmacológica, había fracasado previamente. En la ecografía se observa la existencia de una aurícula izquierda aumentada de tamaño. Los días antes del último episodio seguía tratamiento con aspirina (150 mg diarios). ¿Cuál sería su consejo terapéutico?:

- a) Iniciaría tratamiento con acenocumarol como terapia inicial o tras el empleo de heparina de bajo peso molecular.
- b) Sustituiría la aspirina por clopidogrel.
- c) Añadiría clopidogrel a la aspirina
- d) Duplicaría la dosis de aspirina.
- e) Antes de retirar la aspirina intentaría una nueva reversión farmacológica

9) Paciente de 45 años que desde hace 1 mes presenta debilidad a nivel de cintura escapular y pelviana. En la piel se objetiva edema palpebral y coloración eritematoviolácea periorbitaria y lesiones eritematodescamativas sobre prominencias ósea de dorso de manos. El diagnóstico sería:

- a) Lupus eritematoso sistémico.
- b) Artritis reumatoide.
- c) Dermatomiositis.
- d) Eritema polimorfo.
- e) Esclerodermia.

10) En las pacientes con anorexia nerviosa que llevan más de un año con amenorrea es necesario practicar:

- a) Una densitometría ósea.
- b) Una determinación de niveles séricos de cortisol.
- c) Una determinación de los niveles de prolactina.
- d) Un electroencefalograma.
- e) Un test de supresión con dexametasona.

11) Una niña de 6 años, diagnosticada de coartación de aorta consulta por talla baja. En la exploración física se observa talla en Percentil 3 para su edad y *pterygium coli*. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable y que exploración realizaría para confirmarlo?:

- a) Déficit de GH y determinación de IGF-1 sérica.
- b) Síndrome de Turner y cariotipo.
- c) Hipocondroplasia y radiografías de esqueleto óseo completo.
- d) Hipotiroidismo y determinación de TSH y T4 séricas.
- e) Disgenesia gonadal pura y cariotipo.

12) Un estudio en el que se seleccionan sujetos libres de enfermedad que son clasificados según el nivel de exposición a posibles factores de riesgo y son seguidos para observar la incidencia de enfermedad a lo largo del tiempo es un:

- a) Estudio de casos y controles.
- b) Ensayo clínico.
- c) Estudio de una serie de casos.
- d) Estudio transversal.
- e) Estudio de cohortes.

13) En un análisis de evaluación económica, los costes derivados de las horas/días de trabajo perdidos por absentismo laboral se denominan:

- a) Costes médicos directos.
- b) Costes no-médicos directos.
- c) Costes indirectos.
- d) Costes intangibles.
- e) Costes sociales.

14) Un recién nacido puede experimentar sintomatología transitoria de la enfermedad materna si la madre padece cualquiera de las siguientes patologías EXCEPTO:

- a) Miastenia gravis.
- b) Hipertiroidismo primario.
- c) Pénfigo vulgar.
- d) Herpes gestacional.
- e) Enfermedad celiaca.

15) Mujer de raza blanca, de 48 años, que manifiesta en los últimos tres años, cinco crisis de vértigos rotatorios de entre una y tres horas de duración, con náuseas y vómitos, sudor frío, plenitud de oído. Nistagmo. Acúfenos en el oído izquierdo que preceden a las crisis vertiginosas. Hipoacusia del oído izquierdo que se confirma con la audiometría de tipo neurosensorial con mayor pérdida en las frecuencias graves. A la exploración por micro-otoscopia, se aprecian conductos auditivos externos y tímpanos normales. La Resonancia Magnética cerebral con contraste es normal. ¿Qué diagnóstico considera más acertado?:

- a) Neuronitis vestibular izquierda.
- b) Vértigo Postural Paroxístico Benigno.
- c) Neurinoma Vestibular izquierdo.
- d) Enfermedad de Menière.
- e) Otosclerosis.

16) ¿Cuál de los siguientes pacientes NO tiene diagnóstico de diabetes mellitus?

- a) Niño de 5 años con poliuria, polidipsia y baja de peso, que presenta glicemia de 450 mg/dl
- b) Embarazada que se realiza test de tolerancia la glucosa, de 75 g, con glicemia basal de 101 mg/dl y a las 2 horas de 167 mg/dl
- c) Hombre de 75 años, obeso, con infecciones balanoprepuciales recurrentes, se realiza test de tolerancia oral con 75 gramos de glucosa, presentando glicemia basal de 150 mg/dl y a las 2 horas de 270 mg/dl
- d) Hombre de 45 años, con 2 glicemias postprandiales cercanas a 150 mg/dl
- e) Mujer de 40 años, asintomática, con glicemia de ayuno de 133 mg/dl, la que se repite a los 5 días con valor de 140 mg/dl. Sin embargo se indica dieta y a los 3 meses presenta glicemias normales.

17) ¿Qué alteración es menos probable de encontrar en un niño con cetoacidosis diabética?

- a) Respiraciones profundas
- b) Deshidratación
- c) Dolor abdominal y vómitos
- d) Hipertensión arterial
- e) "Olor a manzana"

18) ¿Qué asociación entre déficit de vitamina y cuadro clínico es incorrecta?

- a) Déficit de vitamina B1 – Confusión, ataxia y estrabismo
- b) Déficit de vitamina B2 – Ceguera nocturna
- c) Déficit de vitamina B12 – Pseudodemencia y anemia macrocítica
- d) Déficit de vitamina A – Piel seca y alopecia
- e) Déficit de vitamina C – Petequias y gingivitis hemorrágica

19) Un paciente diabético tipo 2, está en tratamiento con insulina NPH matinal y nocturna, más refuerzos con insulina cristalina en las 3 comidas principales: desayuno, almuerzo y cena. Está asintomático, sin embargo presenta hemoglucotest de ayuno, cercanos a 180 mg/dl. La hemoglobina glicosilada es de 8%. El examen físico no aporta mayor información. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar metformina
- b) Iniciar glibenclamida
- c) Aumentar la insulina NPH matinal
- d) Aumentar la insulina NPH nocturna
- e) Aumentar la insulina cristalina del desayuno

20) Un paciente obeso de 45 años, asintomático, presenta los siguientes niveles de lípidos: Colesterol total: 340 mg/dl, LDL: 194 mg/dl, HDL: 32 mg/dl, Triglicéridos: 570 mg/dl. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar dieta y ejercicios y controlar en 3 meses
- b) Iniciar una estatina
- c) Iniciar un fibrato
- d) Iniciar una asociación entre una estatina y un fibrato
- e) Iniciar una asociación entre ácido nicotínico, una estatina y un fibrato

Prueba 4

1) Una paciente de 45 años consulta por cuadro de astenia, desconcentración, constipación e intolerancia al frío. Al examen físico se constata un bocio difuso de tamaño moderado. Se solicita TSH que resulta en 26 UI/l. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad de Basedow Graves
- b) Tiroiditis subaguda
- c) Tiroiditis de Hashimoto
- d) Cáncer de tiroides
- e) Adenoma tóxico

2) El hiperparatiroidismo primario se presenta clásicamente como:

- a) Osteoporosis acelerada, asociada a hipercalcemia e hipercalcemia
- b) Constipación crónica, asociada a hipercalcemia e hiperfosfemia
- c) Astenia y debilidad muscular, asociado a hipocalcemia e hiperfosfemia
- d) Contracturas musculares e hiperreflexia, asociado a hipercalcemia e hipocalciuria
- e) Hipercalcemia, hipocalciuria e hipofosfemia

3) El síndrome metabólico se asocia a todas las condiciones siguientes, EXCEPTO

- a) Síndrome de ovario poliquístico
- b) Elevación del colesterol LDL
- c) Elevación de los triglicéridos
- d) Resistencia a la insulina
- e) Hipertensión arterial

4) Una paciente de 65 años, hospitalizado con antecedente de cáncer pulmonar, inicia compromiso de conciencia. En el examen físico está en sopor profundo, sin focalidad neurológica, con pulso de 86 latidos por minuto, presión arterial de 150/100 mmHg y satura 98% a FiO2 ambiental. Se solicitan exámenes que demuestran glicemia: 137 mg/dl, Na: 119 mEq/l, Cl: 94 mEq/l, K: 4,8 mEq/l, Ca: 10,1 mg/dl, Crea: 1,1 mg/dl, BUN: 22 mg/dl, pruebas hepáticas normales, hemograma normal y TAC de cerebro sin lesiones. El diagnóstico más probable es:

- a) Insuficiencia suprarrenal aguda
- b) Encefalopatía por hipercalcemia
- c) Diabetes insípida
- d) Síndrome de secreción ectópica de ACTH
- e) Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética

5) Un paciente diabético tipo 2, de 66 años, en tratamiento con glibenclamida y metformina, inicia un cuadro de astenia y poliuria de 2 días de evolución, seguido de compromiso de conciencia. Al examen físico está deshidratado, con FC: 105x', PA: 90/60, en sopor profundo, sin focalidad neurológica ni alteraciones cardiopulmonares. Se solicita hemoglucotest que resulta "Hi". La conducta más adecuada es:

- a) Administrar suero fisiológico e hidrocortisona endovenosa y solicitar electrolitos plasmáticos, pruebas de función renal, gases arteriales y hemograma
- b) Administrar suero fisiológico e insulina endovenosa y solicitar electrolitos plasmáticos, pruebas de función renal, gases venosos, hemograma y exámenes de orina, controlando frecuentemente
- c) Administrar insulina subcutánea, suero fisiológico, antibióticos de amplio espectro y bicarbonato endovenoso
- d) Administrar suero fisiológico + 2g de KCl, insulina y bicarbonato endovenoso y reevaluar
- e) Administrar suero fisiológico, hidrocortisona, insulina y bicarbonato endovenoso y solicitar exámenes generales, que incluyan electrolitos plasmáticos

6) La causa más frecuente de hipercalcemia en los pacientes ambulatorios es:

- a) Cáncer
- b) Hiperparatiroidismo primario
- c) Hipercalcemia ficticia
- d) Hipercalcemia farmacológica
- e) hipervitaminosis D

7) Una paciente de 33 años presenta amenorrea de 4 meses de evolución, sin otros síntomas. El examen físico y ginecológico no presenta alteraciones. Se realiza test de embarazo que resulta negativo. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar anticonceptivos orales
- b) Solicitar prueba de estrógenos más progesterona
- c) Solicitar test de tolerancia a la glucosa con insulinemia basal y post carga de glucosa
- d) Solicitar TSH, prolactinemia y prueba de progesterona
- e) Mantener en observación y controlar en 3 meses

8) Un paciente de 55 años, diabético tipo 2 en tratamiento con glibenclamida y metformina, presenta hemoglobina glicosilada de 9,5%, creatinina plasmática de 2,5 mg/dl y proteinuria de 24 horas de 500 mg. La conducta más adecuada es:

- a) Aumentar la dosis de glibenclamida
- b) Aumentar la dosis de metformina
- c) Iniciar insulina
- d) Iniciar hemodiálisis
- e) Hacer énfasis en el seguimiento de la dieta y correcto uso de los hipoglicemiantes orales y controlar con nuevos exámenes en 3 meses

9) Un paciente con desnutrición calórico-proteica por cáncer gástrico inicia nutrición parenteral evolucionando con ataxia de la marcha, diplopía y desorientación. Al examen físico destaca estrabismo convergente, con parálisis del VI nervio craneal izquierdo. La causa más probable es:

- a) Hipofosfemia
- b) Hipoglicemia
- c) Déficit de vitamina B12
- d) Déficit de vitamina B1
- e) Hipomagnesemia

10) Un paciente de 34 años, sin antecedentes de importancia presenta cuadro de astenia, alza de peso y debilidad muscular. Al examen físico se aprecia obesidad centripeta, con turgor, brazos delgados y estrías abdominales de color violáceo. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar RMN de silla turca
- b) Solicitar cortisol plasmático basal y post-ACTH
- c) Solicitar TAC de abdomen y pelvis, con cortes finos a la altura de las glándulas suprarrenales
- d) Solicitar cortisol urinario de 24 horas
- e) Solicitar cortisol y ACTH plasmáticos basales

11) Un paciente de 36 años consulta por aumento de volumen cervical, sin otros síntomas. Al examen se aprecia un nódulo tiroideo derecho de 2,5 cm de consistencia dura, que se moviliza con la deglución y que se asocia a una adenopatía cervical ipsilateral, de consistencia aumentada. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar calcitonina, PTH y calcemia
- b) Solicitar TAC de cuello
- c) Solicitar ecografía cervical
- d) Solicitar biopsia excisional del nódulo
- e) Solicitar cintigrafía tiroidea con yodo radiactivo

12) ¿Qué alteración retinal se asocia a mayor riesgo de ceguera en un paciente diabético?

- a) Exudados céreos
- b) Microaneurismas
- c) Microinfartos
- d) Vasos de neoformación
- e) Microhemorragias

13) Niño de 4 años. En control de niño sano se constata peso: +2,5 DS, talla: + 2,1 DS, IPT: + 1,5 DS. El diagnóstico nutricional es:

- a) Eutrofia
- b) Sobrepeso
- c) Obesidad
- d) Desnutrición
- e) Talla baja

14) Un paciente diabético de larga data, en tratamiento irregular con insulina NPH, consulta por una lesión en el talón derecho, dolorosa. Al examen está en buenas condiciones, con signos vitales normales y se observa una úlcera de 2 cm de diámetro, con halo eritematoso de 1,5 cm y escaso exudado purulento. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar ceftriaxona más vancomicina y solicitar hemocultivos y cultivo de la lesión
- b) Iniciar doxacilina más claritromicina y solicitar radiografía de pie
- c) Iniciar ciprofloxacino más gentamicina y solicitar cultivo de la lesión
- d) Iniciar cefazolina más metronidazol y solicitar radiografía de pie
- e) Iniciar clindamicina más penicilina y solicitar cultivo de la lesión

15) El mejor examen para evaluar el control glicémico de un paciente diabético es:

- a) Glicemia de ayuno
- b) Microalbuminuria
- c) Test de tolerancia a la glucosa
- d) HbA1c
- e) Fondo de ojo

16) ¿Qué alteraciones son específicas de la enfermedad de Basedow Graves?

- a) TSH suprimida, con T4 libre normal
- b) Retracción palpebral y polidefecación
- c) Baja de peso y sudoración
- d) Exoftalmo y mixedema pretibial
- e) Bocio difuso y positividad de los anticuerpos anti peroxidasa tiroidea

17) ¿Qué alteración visual esperaría encontrar en un paciente con un tumor hipofisiario que comprime el quiasma óptico?

- a) Hemianopsia homónima derecha
- b) Cuadrantopsia heterónima bitemporal
- c) Hemianopsia heterónima binasal
- d) Amaurosis izquierda
- e) Diplopia

18) Una paciente de 28 años, con IMC: 32, presenta cuadros de temblor, sudoración y palpitaciones que aparecen 3 a 4 horas después de ingerir algunos alimentos. En una oportunidad se controló un hemoglucotest con valor de 50 mg/dl. La etiología de la patología descrita es:

- a) Tumoral
- b) Resistencia a la insulina
- c) Autoinmune
- d) Psicógena
- e) Hereditaria, autosómica dominante

19) ¿Cuál de las siguientes alteraciones NO suele encontrarse en un paciente con insuficiencia suprarrenal primaria?

- a) Hiperpigmentación
- b) Hipotensión
- c) Hipoglicemia
- d) Hiponatremia
- e) Hipokalemia

20) Un paciente de 60 años, diabético e hipertenso, en tratamiento con enalapril, aspirina y metformina, se realiza un perfil lipídico, con los siguientes resultados colesterol total: 240 mg/dl, LDL: 138 mg/dl, HDL: 38 mg/dl y triglicéridos: 320 mg/dl. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar dieta y ejercicios y controlar en 1 mes con nuevo perfil lipídico
- b) Iniciar una estatina
- c) Iniciar un fibrato
- d) Iniciar una asociación entre fibrato y estatina
- e) Iniciar insulina

Prueba 5

1) Varón de 45 años, gran fumador, sin antecedentes previos de enfermedad, diagnosticado dos meses antes de problema pulmonar no precisado. Ingresa de urgencias por deterioro progresivo, durante las dos últimas semanas, de sus funciones cognitivas. La familia niega traumatismo previo. La exploración muestra normotensión arterial y ausencia de edemas. Datos de laboratorio: Na⁺ plasmático 120 mEq/l, osmolaridad plasmática 245 mOsm/kg, glucemia normal, urea 20 mg/dl. Orina: 250 mOsm/kg, Na⁺ 35 mEq/l. ¿Cuál de los siguientes cuadros es el más probable?:

- a) Insuficiencia suprarrenal crónica.
- b) Diabetes insípida central.
- c) Polidipsia compulsiva.
- d) Síndrome de secreción inadecuado de hormona antidiurética (SIADH).
- e) Reajuste del osmostato.

2) Previamente a la administración de I 131, para destruir tejido tiroideo residual, tras una tiroidectomía por cáncer folicular de tiroides ¿Qué debemos hacer?:

- a) Suspender el tratamiento con hormona tiroidea para elevar los niveles plasmáticos de la TSH.
- b) Aumentar la dosis de hormona tiroidea para disminuir los niveles de TSH.
- c) Administrar solución de Lugol. 3 semanas antes.
- d) Medir tiroglobulina para fijar dosis de I 131.
- e) No variar la dosis de hormona tiroidea, para evitar que la TSH varíe.

3) Un varón de 75 años, que vive solo, es traído a urgencias del hospital en coma. Presenta palidez, hinchazón de cara, pies y manos e hipotonía y arreflexia generalizadas con ausencia de focalidad neurológica. Su tensión arterial es de 80/50 mmHg; el pulso de 56 lpm; la temperatura rectal de 34°C. Las determinaciones de laboratorio muestran: hemoglobina 11 g/dl; leucocitos 5.300/mm³ con fórmula normal; glucosa 61 mg/dl; BUN 20 mg/dl; creatinina 1,3 mg/dl; sodio 129 mEq/l; potasio 4,7 mEq/l; pH 7,37, PaCO₂ 49 mmHg, PaO₂ 65 mmHg. Una TC cerebral y una radiografía de tórax son normales. ¿Cuál debe ser la medida terapéutica más urgente?:

- a) Solución salina hipertónica.
- b) Corticoides y glucosa hipertónica.
- c) Hormonas tiroideas y ventilación mecánica.
- d) Hormonas tiroideas y corticoides.
- e) Calentamiento y corticoides.

4) El hipotiroidismo puede provocar todas las siguientes manifestaciones neurológicas EXCEPTO:

- a) Demencia.
- b) Ataxia cerebelosa.
- c) Debilidad muscular proximal.
- d) Síndrome del túnel del carpo bilateral.
- e) Corea.

5) Una mujer de 41 años con obesidad troncular, hipertensión e intolerancia a la glucosa, presenta una excreción urinaria de cortisol sérico a dosis elevadas de dexametasona y ACTH sérico no detectable.

La prueba de localización de esta lesión más adecuada es:

- a) RMN de hipófisis.
- b) TAC torácico.
- c) TAC abdominal.
- d) Ecografía suprarrenal.
- e) Broncoscopia.

6) ¿Cuál de los siguientes fármacos está CONTRAINDICADO durante el embarazo de la mujer diabética?:

- a) Derivado de hierro por vía oral.
- b) Insulina de acción rápida.
- c) Insulina de acción intermedia.
- d) Insulina de acción ultralenta.
- e) Sulfonilureas.

7) En las dietas de los pacientes diabéticos se debe aconsejar fundamentalmente:

- a) Mantener los hidratos de carbono de absorción rápida y suprimir los de absorción lenta.
- b) Restringir tanto los hidratos de carbono de absorción rápida como los de absorción lenta.
- c) Reducir los hidratos de carbono de absorción rápida y mantener los de absorción lenta.
- d) Suprimir los alimentos con alto contenido en sacarosa y glucosa y restringir los alimentos ricos en fibra.
- e) Utilizar alimentos especiales para diabéticos.

8) Hombre de 60 años de edad, remitido por triglicéridos de 620 mg/dl, colesterol total de 220 mg/dl. No es obeso, fuma diez cigarrillos diarios y se toma dos vasos de vino con las comidas y tres copas de coñac diarios. ¿Cuál debe ser la primera medida para reducir su trigliceridemia?:

- a) Dejar el tabaco por completo.
- b) Suspender el alcohol por completo.
- c) Prescribir un fibrato.
- d) Dar una estatina.
- e) Suspender por completo el consumo de aceites y productos de pastelería, añadiendo además dosis moderadas de una resina.

9) Paciente de 40 años, fumador de 40 cigarrillos/día, al que en un reconocimiento rutinario analítico en su empresa se le objetivan unas cifras de colesterol de 280 mg/dl y una cifra de triglicéridos de 300 mg/dl. ¿Cuál será la actitud correcta?:

- a) Iniciar tratamiento inmediato con una estatina.
- b) Iniciar tratamiento con una resina fijadora de ácidos biliares.
- c) Recomendar primero medidas dietéticas, no sobrepasar 20 cigarrillos/día y repetir analítica en 3 meses.
- d) Recomendar medidas dietéticas y abandono del hábito tabáquico y realizar un nuevo control posterior.
- e) Iniciar tratamiento con probucol.

10) En la bioquímica sanguínea practicada a una paciente de 47 años, vista en un centro de atención primaria por padecer molestias en la columna lumbar y astenia, aparece una calcemia elevada. ¿Cuál es la causa más probable de dicha alteración?:

- a) Hiperparatiroidismo primario.
- b) Sarcoidosis.
- c) Metástasis óseas de una afección maligna.
- d) Mieloma múltiple.
- e) Enfermedad de Paget con inmovilización.

11) Una mujer de 40 años presenta astenia y adinamia, asociada a debilidad muscular y náuseas. Al examen físico se aprecia hiperpigmentación cutánea. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar cortisol plasmático y ACTH basales
- b) Solicitar cortisol libre urinario
- c) Solicitar cortisol basal y post-dexametasona
- d) Solicitar cortisol basal y post-ACTH
- e) Solicitar ACTH y CRH basales

12) Una mujer consulta por aparición de un nódulo cervical de lento crecimiento. Al examen físico se palpa un nódulo de consistencia aumentada, de 2 cm de diámetro, ubicado en la línea media del triángulo anterior del cuello, que se eleva con la deglución. Además se palpa una adenopatía de consistencia dura. La TSH es normal. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Quiste del conducto tirogloso
- b) Quiste coloídeo
- c) Adenoma tóxico
- d) Cáncer folicular de tiroides
- e) Cáncer papilar de tiroides

13) Una mujer de 45 años consulta por dolor cervical, nerviosismo y temblor de extremidades inferiores. Al examen físico se palpa un bocio difuso, doloroso y se aprecia un fino temblor de extremidades superiores. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad de Basedow graves
- b) Bocio multinodular tóxico
- c) Tiroiditis de Hashimoto
- d) Tiroiditis subaguda
- e) Cáncer medular de tiroides

14) ¿Qué alteración es más probable de encontrar en un paciente con síndrome de Klinefelter?

- a) Disminución de los niveles plasmáticos de gonadotropinas
- b) Disminución del tamaño testicular
- c) Aumento de los niveles plasmáticos de testosterona
- d) Talla baja
- e) Ginecomastia

15) La presentación más frecuente de las crisis adrenales (insuficiencia suprarrenal aguda) es:

- a) Hipotensión arterial, hiponatremia, hiperkalemia e hiperglicemia
- b) Hipotensión arterial, hipernatremia, hipokalemia e hipoglicemia
- c) Hipertensión arterial, hipernatremia, hiperkalemia e hiperglicemia
- d) Hipertensión arterial, hiponatremia, hiperkalemia e hipoglicemia
- e) Hipotensión arterial, hiponatremia, hiperkalemia e hipoglicemia

16) Un paciente de 48 años consulta por astenia, poliuria y dolores óseos. Al examen físico no se aprecian alteraciones. Se solicitan exámenes generales que demuestran una calcemia de 12,7 mg/dl, con PTH baja, albúmina 3,6 g/dl y elevación de la fosfemia. El diagnóstico más probable es:

- a) Hiperparatiroidismo primario
- b) Insuficiencia renal
- c) Hipercalcemia ficticia
- d) Cáncer
- e) Cáncer medular de tiroides

17) Un paciente de 47 años, diagnosticado de hipotiroidismo en tratamiento con levotiroxina 100 ug/d, se realiza control de TSH que resulta 10,3 UI/l (VN: 0,4 – 4 UI/l). La conducta más adecuada es:

- a) Suspender el tratamiento con levotiroxina
- b) Mantener el tratamiento con levotiroxina en la misma dosis
- c) Agregar propiltiouracilo
- d) Aumentar la dosis de levotiroxina
- e) Disminuir la dosis de levotiroxina

18) Una paciente de 47 años consulta por amenorrea y galactorrea. Se solicita test de embarazo que resulta negativa. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar niveles plasmáticos de dopamina
- b) Solicitar niveles plasmáticos de LH y FSH
- c) Solicitar niveles plasmáticos de estrógenos y progesterona
- d) Solicitar niveles plasmáticos de prolactina
- e) Solicitar RMN de silla turca

19) ¿Qué tipo de alteraciones visuales producen los macroadenomas hipofisarios?

- a) Diplopía
- b) Disminución de la agudeza visual
- c) Hemianopsias o cuadrantopsias homónimas
- d) Defectos del campo visual bitemporales
- e) Defectos del campo visual binasales

20) ¿Cuál de las siguientes asociaciones entre patología y tratamiento de primera línea es INCORRECTA?

- a) Enfermedad de Basedow graves – Propiltiouracilo
- b) Tiroiditis de Quervain – AINEs y betabloqueo
- c) Enfermedad de Hashimoto – Levotiroxina
- d) Adenoma tóxico – Cirugía
- e) Cáncer folicular de tiroides – Tiroidectomía total

Prueba 6 (DIABETES y NUTRICIÓN + REUMATOLOGÍA)

1) Un hombre de 69 años, sin antecedentes médicos de interés, presenta una monoartritis aguda de rodilla. La radiografía simple de rodilla muestra calcificación de ambos meniscos, ¿Cuál de las siguientes exploraciones complementarias hay que solicitar en primer lugar para establecer la etiología de la artritis?:

- a) Determinación de ácido úrico en sangre.
- b) Artroscopia de rodilla.
- c) Examen del líquido sinovial con microscopio de luz polarizada.
- d) Resonancia magnética nuclear de la rodilla.
- e) Determinación de factor reumatoide en sangre.

2) En relación con las vasculitis sistémicas, señale cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA:

- a) La poliarteritis nodosa (PAN) clásica, cursa con frecuencia con glomerulonefritis y capilaritis pulmonar.
- b) La presencia de anticuerpos anti-citoplasma de los neutrófilos con patrón perinuclear es mucho más frecuente en la poliarteritis microscópica que en la PAN clásica.
- c) El tratamiento más eficaz para la granulomatosis de Wegener consiste en la administración conjunta de ciclofosfamida y glucocorticoides.
- d) La presencia de asma bronquial grave y eosinofilia periférica son características de la granulomatosis alérgica de Churg-Strauss.
- e) Es frecuente la asociación de manifestaciones propias de varios síndromes de vasculitis en un mismo paciente.

3) Hombre de 30 años, que presenta un cuadro clínico de 10 meses de evolución consistente en dolor lumbar continuo, que le despierta por la noche, y que se acompaña de rigidez matutina de tres horas de duración. ¿Cuál sería el tratamiento de primera elección?:

- a) Diazepam oral.
- b) Dexametasona intramuscular.
- c) Indometacina oral.
- d) Metamizol intramuscular.
- e) Sales de oro intramuscular.

4) El porcentaje de hemoglobina glicosilada, si se determina correctamente, ofrece una estimación del control diabético, aproximadamente, durante:

- a) El mes anterior.
- b) Los 3 meses anteriores.
- c) Los 5 meses anteriores.
- d) Los 7 meses anteriores.
- e) Los 9 meses anteriores.

5) Un paciente de 35 años lleva padeciendo artralgias en las articulaciones metacarpofalángicas (MCF), muñecas y tobillos cuatro meses. Posteriormente desarrolla artritis en MCF, interfalángicas proximales de manos, metatarsofalángicas, muñecas y tobillos, acompañadas de rigidez matutina de más de 3 horas de duración. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

- a) Artrosis generalizada.
- b) Reumatismo poliarticular agudo (fiebre reumática).
- c) Gota poliarticular.
- d) Artritis reumatoide.
- e) Enfermedad de Whipple.

6) Paciente de 58 años remitido a la consulta por objetivarse, en una analítica rutinaria, una cifra de ácido úrico de 9 mg/dL (normal en hombres hasta 7 por el método de la uricasa), siendo el resto de la analítica, incluida función renal, normal. No refiere antecedentes personales de interés, excepto que es fumador de medio paquete de tabaco al día. No bebe alcohol ni ha padecido episodios de litiasis renal, no dolores articulares. La exploración física es normal y la TA de 120/70 mmHg. ¿Qué actitud terapéutica, de las siguientes, es la más indicada?:

- a) Iniciar tratamiento con alopurinol.
- b) Iniciar tratamiento con alopurinol y colchicina.
- c) Iniciar tratamiento con fármacos uricosúricos.
- d) Iniciar tratamiento con fármacos uricosúricos y colchicina.
- e) No realizar tratamiento alguno.

7) Una paciente de 55 años comienza con disnea progresiva y edema en las extremidades inferiores. Diez años antes había sido diagnosticada de esclerosis sistémica (ES) debido a la presencia de fenómeno de Raynaud, esclerodermia localizada y la detección de anticuerpos anticentrómero en sangre. Estaba controlada con 7,5 mg de prednisona diarios y cremas vasodilatadoras aplicadas en manos. En su evaluación en el momento de la disnea, la gasometría arterial demostraba hipoxia y en la radiografía de tórax no se veía ninguna afectación parenquimatosa. ¿Cuál es la causa más probable del cuadro actual de esta paciente?:

- a) Insuficiencia respiratoria restrictiva muscular.
- b) Endocarditis de Libman Sachs de la tricúspide.
- c) Insuficiencia cardíaca congestiva secundaria a la miocardiopatía de la E.S.
- d) Hipertensión pulmonar.
- e) Tromboembolismo pulmonar de repetición.

8) Un muchacho de 12 años acude al hospital con disminución del apetito, aumento de la sed, micción frecuente y pérdida de peso durante las últimas tres semanas. En las últimas 24 horas aparece letárgico. Los análisis muestran una natremia de 147 mEq/l, una potasemia de 5,4 mEq/l, un cloro de 112 mEq/l, un bicarbonato de 6 mEq/l, una glucosa de 536 mg/dl, una urea de 54 mg/dl, una creatinina de 2 mg/dl y un pH de 7,18. La cetonuria es positiva. ¿Cuál de las siguientes es la medida más adecuada para comenzar el tratamiento de este paciente?:

- a) Hidratación con salino hipotónico, 10 U. de insulina subcutánea y bicarbonato.
- b) Hidratación con salino isotónico y perfusión i.v. de insulina.
- c) Hidratación con salino isotónico, perfusión de insulina i.v. y bicarbonato.
- d) Hidratación con salino hipotónico, perfusión de insulina i.v. y bicarbonato.
- e) Hidratación con salino hipotónico y 10 U. de insulina subcutánea.

9) ¿Qué modificación recomendaría en el tratamiento de un paciente diabético tratado con insulina cristalina antes de desayuno y comida, y con mezcla de cristalina y NPH antes de la cena, si presentase hipoglucemias repetidas a las 7 horas a.m.?:

- a) Disminuir la dosis de insulina cristalina antes del desayuno.
- b) Disminuir la dosis de insulina cristalina antes de la cena.
- c) Disminuir la dosis de insulina NPH antes de la cena.
- d) Aumentar la ingesta de calorías en el desayuno y la cena.
- e) Adelantar la hora del desayuno.

10) Enferma de 36 años con antecedentes de esplenectomía por trombocitopenia a los 22 años y cuatro abortos, el último seguido de un cuadro de trombosis venosa profunda. Desde hace unas 8 semanas presenta un cuadro de artralgias generalizadas, astenia, abultamientos ganglionares y fiebre. ¿Cuál de las siguientes pruebas de laboratorio cree de mayor utilidad para llegar al diagnóstico?:

- a) Factor reumatoide y anticuerpos antinucleares (ANA).
- b) Anticuerpos antinucleares (ANA) y anticardiolipina.
- c) Factor reumatoide y anticuerpo enfermedad de Lyme.
- d) Anticuerpo anti-ADN nativo y anti-Ro (SSA).
- e) Anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo (ANCA) y antihistonas.

11) Una paciente de 67 años presenta astenia y debilidad de las extremidades superiores, de predominio proximal, asociada a claudicación mandibular, cefalea frecuente y fiebre ocasional. En sus exámenes generales destaca anemia con marcada elevación de la VHS. El diagnóstico más probable es:

- a) Granulomatosis de Wegener
- b) Lupus sistémico
- c) Poliangeítis microscópica
- d) Arteritis de células gigantes
- e) Polimiositis

12) ¿Cuál de las siguientes alteraciones es más probable de encontrar en un líquido articular de un paciente cursando con una artritis séptica?

- a) Predominio linfocitario
- b) Filancia disminuida
- c) Celularidad baja
- d) Glucosa aumentada
- e) Proteínas dismiuidas

13) ¿Qué alteración NO es característica del lupus eritematoso sistémico?

- a) Deterioro de la función renal
- b) Leucocitosis
- c) Úlceras orales
- d) Positividad de los anticuerpos antinucleares y de los anticuerpos anti-DNA de doble hebra
- e) Disminución del complemento

14) Un paciente con antecedente de psoriasis presenta artritis de la rodilla izquierda y del tobillo derecho, asociado a dactilitis del 2° y 3° orjejos izquierdos. El resto del examen físico no aporta mayor información. El diagnóstico más probable es:

- a) Artritis psoriática
- b) Síndrome de Reiter
- c) Esclerodermia
- d) Dermatomiositis
- e) Artritis por cristales

15) ¿Cuál de las siguientes alteraciones es menos probable de encontrar en un paciente con artritis reumatoide?

- a) Nódulos reumatoídeos
- b) Derrame pleural
- c) Nefritis
- d) Anemia
- e) Miocarditis

16) Los anticuerpos antihistonas son característicos de:

- a) Esclerodermia
- b) Psicosis lúpica
- c) Lupus cutáneo subagudo
- d) Dermatomiositis
- e) Lupus por drogas

17) El síndrome metabólico o síndrome X, se caracteriza por todo lo siguiente excepto:

- a) Obesidad
- b) Resistencia a la insulina
- c) Hipercolesterolemia
- d) Hipertensión arterial
- e) Hipertrigliceridemia

18) ¿Cuál de las siguientes es una contraindicación de la insulina?

- a) Insuficiencia renal
- b) Hipertensión arterial no controlada
- c) Hemoglobina glicosilada mayor a 10%
- d) Desnutrición calórica
- e) Ninguna de las anteriores

19) ¿Cuál de los siguientes hallazgos NO se observa en el fondo de ojo de la retinopatía diabética?

- a) Disminución de los cruces arteriovenosos
- b) Vasos de neoformación
- c) Exudados algodonosos
- d) Exudados céreos
- e) Microhemorragias

20) ¿Qué tratamiento está indicado ante la aparición de microalbuminuria persistente en un paciente con diabetes mellitus tipo 2?

- a) Insulina
- b) Dieta hipoproteica
- c) Dieta hiperproteica
- d) iECAs
- e) Atorvastatina

Prueba 7 (ENDOCRINOLOGÍA + PREGUNTAS PÁGINA EUNACOM)

1) En un paciente hospitalizado por infarto miocárdico, la aparición de un tercer ruido sugiere:

- a) Ruptura del septum interauricular
- b) Embolia pulmonar asociada
- c) Insuficiencia cardíaca inminente
- d) Edema pulmonar agudo
- e) Reinfarto

2) Para confirmar la sospecha clínica de enfermedad de Addison debe solicitarse:

- a) Cortisol y ACTH basales
- b) Cortisol libre urinario de 24 horas
- c) Prueba de supresión con dexametasona
- d) Curva de cortisol circadiano
- e) Cortisol plasmático basal y post ACTH

3) Paciente de 38 años, en tratamiento antibiótico por neumonía adquirida en la comunidad, con buena respuesta inicial. Al quinto día de tratamiento, consulta por reaparición de la fiebre y dolor tipo puntada de costado al mismo lado de la neumonía.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Absceso pulmonar
- b) Resistencia antibiótica
- c) Embolia pulmonar
- d) Reacción adversa a medicamentos
- e) Derrame pleural

4) ¿Cuál de los siguientes enunciados se correlaciona mejor con el cuadro clínico de la tiroiditis subaguda?

- a) Mujer de 55 años con bocio difuso, no doloroso y síntomas leves de hipotiroidismo
- b) Mujer de 39 años con bocio doloroso, uninodular, asociado a síntomas de hipertiroidismo leve y cintigrafía con yodo radiactivo que demuestra nódulo caliente
- c) Mujer de 30 años con otalgia y bocio difuso, doloroso, asociado a síntomas leves de hipertiroidismo
- d) Mujer de 35 años con temblor, sudoración y retracción palpebral, asociado a bocio difuso, no doloroso
- e) Mujer de 51 años con bocio multinodular de tamaño moderado, asociado a constipación e intolerancia al frío

5) ¿Cuál es el agente etiológico más probable en la artritis séptica de rodilla, con presencia de cocáceas Gram (-) intracelulares y cultivo negativo del líquido articular?

- a) Anaerobios
- b) Chlamydia trachomatis
- c) Neisseria gonorrhoeae
- d) Streptococcus agalactiae
- e) Staphylococcus aureus

6) ¿Cuál de los siguientes exámenes es más adecuado para iniciar el estudio de un nódulo tiroideo sospechoso de cáncer, en un paciente con TSH normal?

- a) Ecografía de cuello
- b) Cintigrafía con yodo radiactivo
- c) Anticuerpos anti-TPO y anti-tiroglobulina
- d) T4 libre
- e) T3 y T4

7) Cuando un paciente debuta con un episodio maníaco, el diagnóstico es:

- a) Ciclotimia
- b) Manía unipolar
- c) Trastorno esquizomaniaco
- d) Depresión unipolar mixta
- e) Trastorno bipolar

8) Una mujer de 60 años se realiza densitometría ósea como examen de rutina, que demuestra los siguientes resultados: score Z: -1 DE; score T: -2,1 DE. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar ejercicios, son necesidad de medicamentos
- b) Indicar ejercicios, calcio y vitamina D
- c) Indicar ejercicios, calcio y bifosfonatos
- d) Indicar ejercicios, calcio, vitamina D y bifosfonatos
- e) Indicar ejercicios, calcio, vitamina D, estrógenos y bifosfonatos

9) Se aplica una encuesta de hábito alimentario a pacientes operados de cáncer de colon y operados de otras patologías, para probar la hipótesis de que la carne roja ahumada aumenta el riesgo de desarrollar este cáncer.

¿A qué tipo de diseño corresponde esta investigación?

- a) Ensayo clínico controlado
- b) Estudio de prevalencia
- c) Estudio cuasi experimental
- d) Estudio de casos y controles
- e) Estudio ecológico

10) Varón de 45 años, gran fumador, sin antecedentes previos de enfermedad, diagnosticado dos meses antes de problema pulmonar no precisado. Ingres a urgencias por deterioro progresivo, durante las dos últimas semanas, de sus funciones cognitivas. La familia niega traumatismo previo. La exploración muestra normotensión arterial y ausencia de edemas. Datos de laboratorio: Na⁺ plasmático 120 mEq/l, osmolaridad plasmática 245 mOsm/kg, glucemia normal, urea 20 mg/dl. Orina: 250 mOsm/kg, Na⁺ 35 mEq/l. ¿Cuál de los siguientes cuadros es el más probable?

- a) Insuficiencia suprarrenal crónica
- b) Diabetes insípida central
- c) Polidipsia compulsiva
- d) Síndrome de secreción inadecuado de hormona antidiurética
- e) Diabetes insípida nefrogénica

11) Una paciente de 34 años consulta por compromiso del estado general, vómitos y malestar abdominal. Refiere además cuadro previo de 2 meses de evolución de astenia y adinamia. Al examen se aprecia paciente en regulares condiciones generales, hipotenso hasta 80/40, sin otros hallazgos. En sus exámenes de laboratorio destaca glicemia: 58, Na⁺: 131, K⁺: 5,8. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Enfermedad de Addison
- b) Síndrome de Cushing
- c) Hiperaldosteronismo primario
- d) Insuficiencia renal
- e) Hipoglicemia reactiva

12) El minimental test de Folstein es un instrumento que se utiliza para evaluar la:

- a) Funcionalidad
- b) Cognición
- c) Memoria reciente
- d) Afectividad
- e) Atención

13) La enfermedad de Basedow-Graves, a diferencia de otras causas de hipertiroidismo, presenta:

- a) Retracción palpebral
- b) TSH suprimida
- c) Diarrea
- d) T4 elevada
- e) Mixedema pretibial

14) Una mujer de 75 años consulta por incontinencia urinaria de esfuerzo, progresiva, de varios años de evolución, que en los últimos meses le impiden realizar actividades sociales. La paciente es autovalente, no ingiere medicamentos, tiene un Mini Mental State (MMS) normal. El examen físico y los exámenes básicos de laboratorio son normales.

¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado?

- a) Entrenamiento vesical
- b) Imipramina
- c) Terazocina
- d) Oxibutinina
- e) Tratamiento quirúrgico

15) Hombre de 23 años, con antecedentes de dolor lumbar insidioso de 3 meses de evolución, acompañado de rigidez lumbar matinal. Además presenta talalgia al caminar desde hace 15 días. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable?

- a) Artritis reumatoidea
- b) Espondiloartrosis
- c) Pelviespondilopatía seronegativa
- d) Raquiestenosis
- e) Lumbago mecánico

16) Una paciente de 33 años consulta por intolerancia al frío y astenia. Al examen físico se palpa tiroides levemente aumentada de tamaño y de consistencia ligeramente aumentada, sin nódulos. Se solicitan exámenes donde destaca TSH: 15,2 (VN: 0,4 - 4,0). El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad de Basedow Graves
- b) Tiroiditis de Hashimoto
- c) Adenoma tóxico
- d) Tiroiditis subaguda
- e) Déficit de yodo

17) La asociación de hipercalcemia, hipofosfemia y osteoporosis acelerada es característica:

- a) Hiperparatiroidismo secundario
- b) Hipercalcemia maligna
- c) Hipervitaminosis D
- d) Hiperparatiroidismo primario
- e) Déficit de vitamina D

18) La recomendación más apropiada en un paciente anciano que sufre una caída por hipotensión ortostática es:

- a) Indicar vasoconstrictores
- b) Aumentar la ingesta de líquidos
- c) Usar medias elásticas
- d) Ácido acetilsalicílico 100 mg/día
- e) Aumentar la ingesta de sal

19) La hiperprolactinemia en hombres se manifiesta frecuentemente como:

- a) Ginecomastia aislada
- b) Galactorrea aislada
- c) Impotencia sexual y disminución de la libido
- d) Astenia y vómitos
- e) Ginecomastia y galactorrea

20) Hombre de 60 años que al examen físico presenta palidez y esplenomegalia de 7 cms bajo el reborde costal, sin adenopatías.

El hemograma muestra anemia leve normocítica normocrómica, leucocitosis de 70.000/ mm³, con gran desviación a izquierda, sin blastos y plaquetas de 450.000/mm³.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Síndrome linfoproliferativo crónico
- b) Leucemia de células velludas
- c) Mielofibrosis primaria
- d) Trombocitosis esencial
- e) Leucemia mieloide crónica

Prueba 8 (DIABETES Y NUTRICIÓN + REUMATOLOGÍA + TRAUMATOLOGÍA)

1) Un paciente de 34 años, consulta por dolor en el cuello, dorso y extremidad superior derecha, que apareció luego de levantar y mover algunos muebles. Al examen presenta disminución del reflejo bicipital e hipoestesia en el pulgar derecho. ¿Qué raíz nerviosa es la afectada?

- a) C5
- b) C6
- c) C7
- d) C8
- e) T1

2) Una paciente anoréxica es hospitalizada por deterioro del estado general y debilidad, reiniciándose alimentación por sonda nasogástrica. Evoluciona con confusión, diplopía y descoordinación de los movimientos. Al examen físico sólo destaca estrabismo divergente, por compromiso del nervio oculomotor derecho. El déficit que con mayor probabilidad es responsable de este cuadro es:

- a) Cianocobalamina (vitamina B12)
- b) Zinc
- c) Fósforo
- d) Tiamina (vitamina B1)
- e) Magnesio

3) Son factores de riesgo para luxación congénita de la cadera, EXCEPTO:

- a) Sexo femenino
- b) Prematurez
- c) Síndrome de Down
- d) Presentación podálica
- e) Antecedentes familiares de displasia de cadera

4) Un paciente de 70 años consulta por dolor muy intenso en la rodilla izquierda, asociada a aumento de volumen, calor local y eritema. Al examen físico presenta derrame articular y signos inflamatorios en dicha articulación. Se realiza una radiografía de rodilla, que muestra una línea de calcificación a nivel del cartílago articular. La artrocentesis da salida a un líquido turbio, de filancia disminuida, con cerca de 10.000 células, con 90% de polimorfonucleares. La microscopía en el microscopio de campo oscuro observa múltiples cristales con birrefringencia de elongación positiva. La tinción de Gram no muestra bacterias. La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio con paracetamol oral y una dieta pobre en calcio
- b) Iniciar AINEs y alopurinol oral
- c) Solicitar niveles plasmáticos de ácido úrico, calcemia y paratohormona y decidir manejo según resultados
- d) Iniciar AINEs endovenosos y reposo
- e) Iniciar antibióticos endovenosos y realizar drenaje articular

5) Un paciente de 71 años, con antecedentes conocidos presenta un cuadro de tos con expectoración, fiebre y luego desorientación, seguido de compromiso cuantitativo de conciencia. Al examen físico se aprecia en sopor profundo, deshidratado, con FC: 128x', PA: 74/38 mmHg, FR: 18x', sin signos neurológicos focales. Se realiza hemoglucotest que resulta Hi (por sobre el rango máximo de medición). El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome hiperglicémico hiperosmolar
- b) Cetoacidosis diabética
- c) Edema cerebral
- d) Shock séptico
- e) Hiperglicemia facticia

6) Un paciente de 78 años, con antecedente de hipertensión, diabetes y demencia inicial por enfermedad de Alzheimer, sufre una caída a nivel, resultando con imposibilidad para caminar e intenso dolor. Al examen se aprecia extremidad inferior derecha en posición impúdica, con imposibilidad de flexar la cadera. Se solicitan radiografías de caderas que demuestran una fractura de la región intertrocanterica, con importante desplazamiento (Tronzo IV). Una vez estabilizado el paciente, la conducta más adecuada es:

- a) Inmovilizar con yeso pelvipedio
- b) Realizar osteosíntesis con placa y tornillos
- c) Realizar osteosíntesis con DHS (dynamic hip screw)
- d) Instalar prótesis parcial de cadera
- e) Instalar prótesis total de cadera

7) Un paciente de 27 años presenta un cuadro de dolor lumbar crónico, mayor en reposo, asociado a rigidez matinal. En alguna ocasión presentó artritis de la rodilla derecha. Se solicita radiografía de articulaciones sacroiliacas que demuestran signos de sacroileítis bilateral y de algún grado de calcificación de los ligamentos longitudinales anterior y posterior. El tratamiento de elección de la patología descrita es:

- a) Corticoesteroides y kinesioterapia
- b) Metotrexato y ciclosporina
- c) Antiinflamatorios no esteroideos y ejercicios
- d) Metotrexato y ejercicios
- e) Ciclofosfamida y corticoides

8) Un paciente de 56 años sufre inversión forzada del pie izquierdo, evolucionando con importante dolor. Al examen se observa edema y equimosis en relación a la zona inframaleolar derecha, con dolor importante a la palpación de dicha zona y a la mayoría de los movimientos del tobillo. La movilidad, sensibilidad y llenado capilar distales son normales. La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio indicando reposo y analgesia oral
- b) Solicitar radiografías de tobillo
- c) Solicitar TAC de tobillo
- d) Inmovilizar con una bota ortopédica
- e) Inmovilizar con bota corta de yeso, abierta

9) Un paciente de 25 años cae de un tercer piso, golpeándose contra el suelo. Al examen se observa muy adolorido, consciente, orientado y respira espontáneamente, sin apremio respiratorio. Al examen presenta frecuencia cardíaca de 124 lpm, presión arterial: 80/40 mmHg, frecuencia respiratoria: 20 rpm. Presenta una fractura en la pierna derecha, con una herida de 4 cm, con exposición ósea y sangrado profuso. También se observan varias heridas abrasivas en la extremidad superior izquierda y en la cara, sin sangrado activo. Se instala collar cervical. La conducta inicial más adecuada es:

- a) Aplicar torniquete en el muslo derecho y reponer volumen con suero glucosalino endovenoso
- b) Realizar compresión sobre la herida de la pierna y administrar suero fisiológico por vía venosa periférica
- c) Realizar examen físico y neurológico completo
- d) Realizar intubación orotraqueal y administrar oxígeno
- e) Instalar un catéter venoso central

10) La retinopatía diabética puede causar ceguera mediante dos mecanismos, que son respectivamente:

- a) Microinfartos retinales y hemorragia vítrea
- b) Exudados céreos perimaculares y hemorragia vítrea
- c) Vasos de neoformación retinales y microaneurismas
- d) Edema macular y microinfartos retinales
- e) Exudados céreos perimaculares y microaneurismas

11) ¿Cuál de las siguientes asociaciones entre patología y expresión clínica es INCORRECTA?

- a) Fractura subcapital de húmero – equimosis en la cara interna del brazo
- b) Fractura de escafoides – dolor en la tabaquera anatómica
- c) Fractura de cúpula radial – imposibilidad de pronosupinar el antebrazo
- d) Luxación posterior de cadera – posición púdica
- e) Luxación anterior de hombro – signo de la tecla de piano

12) ¿Cuál de las siguientes asociaciones entre marcadores inmunológicos y patología es correcta?

- a) Anticuerpos anti-ribonucleoproteína – Dermatomiositis
- b) Anticuerpos anti-proteína P – Actividad lúpica
- c) Anticuerpos anti-histona – Enfermedad de Sjörgren
- d) Anticuerpos anticentrómero – Esclerodermia
- e) Anticuerpos antinucleares, patrón citoplasmático – Poliangeítis microscópica

13) La complicación más habitual de la fractura del cuello del astrágalo es:

- a) Lesión de la arteria tibial posterior
- b) Necrosis avascular
- c) Síndrome compartimental del pie
- d) Consolidación viciosa
- e) Osteomielitis

14) Un paciente de 25 años presenta una quemadura grado B en la extremidad inferior derecha, evolucionando con una respuesta inflamatoria importante, por lo que se inician medidas de soporte. Al séptimo día de evolución inicia edemas de extremidades inferiores. Se solicitan exámenes en donde destaca una prealbúmina muy baja. Al examen presenta un índice de masa corporal de 27. El diagnóstico nutricional es:

- a) Desnutrición calórico-proteica
- b) Sobrepeso con desnutrición proteica
- c) Sobrepeso sin desnutrición proteica
- d) Obesidad con desnutrición proteica
- e) Obesidad sin desnutrición proteica

15) Un hombre de 29 años sufre una lesión traumática del hombro izquierdo, presentando una luxación anterior de hombro, la que es tratada ortopédicamente con buena evolución. En una segunda instancia presenta otra luxación anterior de hombro izquierdo, en relación a un traumatismo de poca energía, la que es reducida adecuadamente. La conducta más adecuada es:

- a) Inmovilizar con cabestrillo simple
- b) Inmovilizar con cabestrillo bloqueado
- c) Inmovilizar con vendaje en ocho
- d) Inmovilizar con yeso escápulo braquial
- e) Realizar reparación quirúrgica

16) Una paciente de 58 años, de origen rural, tiene una historia de larga data de dolores articulares, especialmente en las manos, que han ido limitando sus actividades de manera progresiva. Los síntomas son fluctuantes, con períodos de mayor actividad. Al examen se observa desviación de los dedos hacia cubital, con deformaciones en cuello de cisne y en dedos de sastre (Boutonniere). No se aprecian signos inflamatorios. El diagnóstico más probable es:

- a) Artritis psoriática
- b) Gota tofácea
- c) Artritis reumatoide
- d) Artrosis
- e) Espondilitis anquilosante

17) Una paciente de 67 años consulta por dolor de la rodilla izquierda de 3 semanas de evolución, que aparece especialmente durante la marcha. Al examen presenta signos de derrame articular moderado, sin eritema ni aumento de la temperatura local. La movilidad es completa, pero dolorosa, especialmente en la flexión extrema y se palpa crepitación articular. Los signos de cajones y bostezos son negativos. El diagnóstico más probable es:

- a) Condrocalcinosis
- b) Artrosis
- c) Espondiloartropatía seronegativa
- d) Artritis reumatoidea
- e) Meniscopatía crónica

18) Un paciente de 66 años consulta por astenia y cefalea. Refiere además que en algunas ocasiones debe descansar mientras mastica, ya que presenta dolor de los músculos masticatorios. Le sucede algo similar al usar las extremidades superiores, ya que “se le cansan los hombros”. Al examen presenta dolor a la palpación del cuero cabelludo. En sus exámenes destaca un hemograma con hematocrito: 33%, VCM: 90, HCM: 32, hemoglobina: 11, blancos: 6.900, con recuento diferencial normal, plaquetas: 342.000, VHS: 96. El diagnóstico más probable es:

- a) Lupus eritematoso sistémico
- b) Poliangeítis microscópica
- c) Arteritis de células gigantes
- d) Granulomatosis de Wegener
- e) Panarteritis nodosa

19) Un paciente sufre una fractura de húmero, con lesión del nervio radial. ¿Cuál de los siguientes signos es más probable de encontrar en el examen físico de este paciente?

- a) Imposibilidad para flexionar la muñeca
- b) Imposibilidad para extender la muñeca
- c) Anestesia de los pulpejos del índice y dedo medio
- d) Anestesia de los pulpejos del meñique y anular
- e) Anestesia de la palma de la mano

20) Un paciente diabético tipo 2, en tratamiento con insulina en esquema intensificado presenta resumen de autocontroles con hemoglucotest, con los siguientes promedios: HGT ayuno:102; postdesayuno:120; prealmuerzo:198; postalmuerzo:144; precena:286 y postcena:133. No ha presentado síntomas de hipoglicemia y la hemoglobina glicosilada es 8,4%. La conducta más adecuada es:

- a) Aumentar la insulina NPH matinal
- b) Aumentar la insulina NPH vespertina
- c) Aumentar la insulina cristalina predesayuno
- d) Aumentar la insulina cristalina prealmuerzo
- e) Mantener el esquema sin modificaciones

21) Paciente diabético tipo 2, de 48 años, en tratamiento con glibenclamida, presenta temblor, asociado a mareos y luego presenta disminución del estado de conciencia. Se controla HGT: 34. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar glucagón subcutáneo y glucosa endovenosa por una vez y luego indicar glucosa oral en su domicilio
- b) Administrar glucosa oral y suspender glibenclamida
- c) Administrar glucosa endovenosa en bolo, hospitalizar y mantener con glucosa endovenosa en infusión
- d) Cambiar glibenclamida por metformina y administrar bolo de glucosa endovenosa
- e) Suspender glibenclamida e iniciar insulino terapia una vez resuelto el cuadro con glucosa oral

Prueba 9 (ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA)

1) Un recién nacido presenta un resultado positivo en la prueba de screening para hipotiroidismo congénito, con sangre de talón. Se solicita confirmación con TSH sérica, la que resulta elevada. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar levotiroxina
- b) Solicitar nueva TSH en 1 mes y decidir conducta según resultado
- c) Solicitar anticuerpos antitiroideos y T4 libre y decidir conducta según resultados
- d) Solicitar TRH, T4 y T3 y decidir manejo según resultados
- e) Iniciar suplemento de yodo, con lugol oral y solicitar nueva TSH y T4 en 15 días

2) La adrenarquia se caracteriza por:

- a) Aparición de vello púbico
- b) Aumento de la velocidad de crecimiento
- c) Inicio de la fertilidad
- d) Olor axilar adulto
- e) Pigmentación cutánea

3) El primer signo de desarrollo puberal en niñas es:

- a) Botón mamario
- b) Vello púbico
- c) Pigmentación de labios vaginales
- d) Pigmentación de areola
- e) Olor axilar

4) El primer signo de desarrollo puberal en varones es:

- a) Vello púbico
- b) Crecimiento peneano
- c) Crecimiento testicular
- d) Cambio de la voz
- e) Olor axilar

5) Se considera pubertad precoz el inicio del desarrollo puberal antes de:

- a) Los 6 años en los niños y los 7 años en las niñas
- b) Los 9 años en los niños y las niñas
- c) Los 9 años en los niños y los 8 años en las niñas
- d) Los 8 años en los niños y los 7 años en las niñas
- e) Los 8 años en los niños y los 9 años en las niñas

6) Un joven de 14 años llega a su consultorio con la madre, porque están preocupados por sus mamas. El niño está bien desarrollado y con sobrepeso; tiene vello axilar y pubiano, y el desarrollo peneano y el crecimiento testicular están apropiados para la edad (etapa Tanner III). Sus mamas están aumentadas simétricamente de tamaño; el tejido mamario mide 4 cm. de diámetro a derecha y 6 cm a izquierda, con grosor de 0.5 cm. No hay inflamación ni flujo. El diagnóstico más probable es:

- a) Ginecomastia puberal benigna
- b) Ginecomastia secundaria a fumar marihuana
- c) Síndrome de Klinefelter
- d) Tumor adenocortical
- e) Hiperplasia suprarrenal congénita

7) Un niño de 10 años, diabético tipo 1, en tratamiento con insulina en esquema intensivo, presenta cuadro de sudoración, temblor y actitud agresiva, seguida luego de inconciencia. El diagnóstico más probable es:

- a) Accidente vascular encefálico
- b) Cetoacidosis diabética
- c) Coma hiperglicémico hiperosmolar
- d) Hipoglicemia
- e) Encefalitis herpética

8) Ante la sospecha clínica de síndrome de Turner se debe tomar la siguiente conducta:

- a) Solicitar gonadotrofinas, estrógenos y progesteronas
- b) Iniciar anticonceptivos orales
- c) Realizar ecografía ginecológica
- d) Solicitar cariograma
- e) Solicitar prueba de progesterona

9) Una niña de 7 años es la más baja de su curso. Al revisar su curva de crecimiento se observa que se encuentra el percentil 2 y que se ha mantenido en el mismo carril desde los 2 años de edad. Su madre mide 1,50 metros y su padre, 1,61 metros. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome de Turner
- b) Talla baja familiar
- c) Retraso constitucional del crecimiento
- d) Pubertad precoz
- e) Déficit de GH

10) Un niño tiene estatura bajo el percentil 3, velocidad de crecimiento normal y edad cronológica mayor a la edad ósea. El diagnóstico más probable es:

- a) Retraso constitucional del crecimiento
- b) Talla baja familiar
- c) Déficit de GH
- d) Acondroplasia
- e) Hipopituitarismo secundario

11) ¿Qué examen debe solicitarse para confirmar el diagnóstico de hiperplasia suprarrenal congénita?

- a) Tomografía axial computada de abdomen
- b) Cortisol libre urinario de 24 horas
- c) Cortisol plasmático basal y post ACTH
- d) Androstenediona y Dihidroepiandrosterona
- e) 17-hidroxiprogesterona

12) Una recién nacida de 4 días de vida presenta metrorragia escasa. El examen físico no aporta mayor información. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución, sin necesidad de mayor estudio
- b) Realizar ecografía abdominopélvica
- c) Solicitar estradiol y progesterona
- d) Solicitar hemograma, con recuento de plaquetas y tiempos de coagulación
- e) Solicitar cortisol plasmático basal

13) Un niño de 7 años presenta retraso del crecimiento, debilidad, astenia y cefalea. Al examen neurológico destaca defecto del campo visual bitemporal, asimétrico. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad de Cushing
- b) Enfermedad de Addison
- c) Craneofaringioma
- d) Diabetes insípida
- e) Hiperprolactinemia

14) Un niño de 5 años, cursando una infección diseminada por Neisseria meningitidis, presenta shock refractario al tratamiento antibiótico y a la reposición hídrica con suero fisiológico. Se inician drogas vasoactivas con respuesta parcial. Entre sus exámenes destacan K+: 5,5, Na+: 130, Cl-: 93, HGT: 45. La sospecha diagnóstica debe abarcar:

- a) Insuficiencia suprarrenal
- b) Hipertiroidismo
- c) Diabetes insípida
- d) Hipotiroidismo
- e) Síndrome de Cushing

15) Un niño de 9 años presenta un cuadro de baja de peso, poliuria y astenia de 1 mes de evolución. El examen físico no aporta mayor información. Se solicita glicemia de ayuno que resulta 260 mg/dl. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Solicitar test de tolerancia a la glucosa oral
- b) Solicitar nueva glicemia de ayuno
- c) Indicar dieta y ejercicio y controlar en 1 mes
- d) Iniciar medidas generales, asociado a hipoglicemiantes orales
- e) Iniciar insulina

16) La hormona que más incide en el crecimiento fetal intrauterino es:

- a) GH
- b) Insulina
- c) Tiroxina
- d) Lactógeno placentario
- e) Somatomedina

17) El síndrome de Klinefelter se presenta como:

- a) Hipogonadismo hipogonadotrópico, con testículos pequeños
- b) Hipogonadismo hipogonadotrópico, con testículos grandes
- c) Hipogonadismo hipergonadotrópico, con testículos pequeños
- d) Hipogonadismo hipergonadotrópico, con testículos grandes
- e) Hipergonadismo hipogonadotrópico, con testículos grandes

18) La información más útil, al evaluar un niño que consulta por talla baja, la entrega:

- a) La edad ósea
- b) Los niveles plasmáticos de GH
- c) El índice talla/edad
- d) Los niveles plasmáticos de testosterona, LH y FSH
- e) La curva de crecimiento

19) Una adolescente de 17 años consulta porque aún no inicia sus menstruaciones. No tienen antecedentes patológicos ni otros síntomas. Al examen físico se observa desarrollo puberal normal, al igual que el examen ginecológico. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar anticonceptivos orales
- b) Solicitar cariógrama, TSH, prolactina, estradiol y progesterona plasmática
- c) Solicitar prueba de progesterona
- d) Solicitar ecografía transvaginal
- e) Solicitar niveles de LH y FSH

20) La causa más frecuente de hipotiroidismo congénito es:

- a) Hipopituitarismo
- b) Alteraciones de la conversión periférica de T4 en T3
- c) Disgenesia tiroidea
- d) Déficit de yodo
- e) Tiroiditis crónica

Prueba 10 (NUTRICIÓN PEDIÁTRICA)

ENDOCRINOLOGÍA, DIABETES Y NUTRICIÓN RESPUESTAS

1) En el preescolar, el diagnóstico de obesidad se realiza cuando:

- a) El peso es al menos 2 desviaciones estándar mayor que el promedio para su edad
- b) El peso es al menos 2 desviaciones estándar mayor que el promedio para su talla
- c) El peso es al menos 3 desviaciones estándar mayor que el promedio para su edad
- d) El peso es al menos 3 desviaciones estándar mayor que el promedio para su talla
- e) El peso es al menos el doble que el promedio para su edad

2) ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una alternativa válida para la alimentación de un recién nacido, que no recibe pecho materno?

- a) Leche purita al 7,5%, más azúcar al 2,5%, más aceite al 1,5%
- b) Leche purita al 7,5%, más azúcar al 2,5%, más cereal al 3%
- c) Leche purita al 7,5%, más azúcar al 5%, más cereal al 1,5%
- d) Leche purita al 10%, más azúcar al 2,5%, más aceite al 1,5%
- e) Leche purita al 10%, más azúcar al 5%, más cereal al 3%

3) Un lactante de 5 meses, alimentado exclusivamente con pecho materno presenta un peso 30% mayor del normal para su edad y talla. La conducta más adecuada es:

- a) Suspender la lactancia materna, iniciar fórmula en cantidades menores e introducir alimentos sólidos
- b) Mantener la lactancia materna, pero disminuir la frecuencia de las mamadas
- c) Mantener la lactancia materna, pero disminuir la duración de las mamadas
- d) Ordenar la lactancia materna, de modo de ofrecer el pecho 4 veces al día y agregar una comida, tipo sopa puré
- e) Tranquilizar a la madre y explicarle que su hijo está eutrófico, sin tomar ninguna medida en especial

4) ¿Cuál de los siguientes parásitos puede simular un síndrome de malabsorción intestinal?

- a) Ascaris lumbricoides
- b) Oxiuros
- c) Entamoeba histolítica
- d) Balantidium coli
- e) Giardia lamblia

5) Una madre trae a su hija de 5 años, porque es la más baja de su curso. No presenta otros síntomas y tiene un buen rendimiento escolar. Sus padres son de estatura más bien baja. Al medirla se constata que su talla está en el percentil 2, para su edad. La conducta inicial más adecuada es:

- a) Solicitar radiografía de carpo, para determinar la edad ósea
- b) Solicitar cariograma
- c) Solicitar niveles de 17-hidroxiprogesterona, estradiol, TSH, glicemia y anticuerpos antitransglutaminasa
- d) Evaluar la curva de crecimiento, con los registros previos de peso y talla
- e) Tranquilizar a la madre y explicarle que la talla de su hija es normal

6) Durante el primer año de vida, habitualmente se suplementa la alimentación con todo lo siguiente, EXCEPTO:

- a) Vitamina A
- b) Vitamina B1
- c) Vitamina C
- d) Vitamina D
- e) Hierro

7) El tratamiento de la obesidad en el niño está orientado a:

- a) Lograr que coma frutas y verduras, sin ingesta de carbohidratos refinados
- b) Lograr que su curva de peso se mantenga en el mismo carril
- c) Eliminar las grasas de la dieta
- d) Bajar de peso, hasta alcanzar el peso normal
- e) Establecer hábitos saludables de alimentación y actividad física

8) Un lactante de 10 meses presenta deposiciones líquidas 4 a 5 veces al día, sin vómitos ni fiebre, desde hace tres días. Se alimenta bien con lactancia artificial más almuerzo y comida con postre. Al examen físico se encuentra afebril, con buen estado general, sin signos de deshidratación, con el abdomen distendido, ruidos hidroaéreos aumentados y bazuqueo.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Hidratar por vía oral por 4 horas y luego continuar con su misma alimentación
- b) Administrar sales de hidratación oral después de cada deposición y eliminar los residuos de la dieta
- c) Reemplazar leche actual por leche modificada sin lactosa
- d) Hidratar por vía oral por 4 horas y luego continuar con leche modificada sin lactosa
- e) Diluir la leche y eliminar los residuos de la dieta

9) Las medidas más importantes, para prevenir el síndrome de realimentación en un paciente crítico muy desnutrido, son:

- a) Reiniciar la alimentación oral progresivamente, con alimentos sin potasio
- b) Iniciar la alimentación oral, indicando además un suero glucosado al 5% de mantención, para evitar las hipoglicemias
- c) Reiniciar la alimentación por una sonda nasointestinal, usando una bomba de infusión continua
- d) Reanudar la alimentación progresivamente, por vía oral, iniciando con cantidades pequeñas y suplementar con vitaminas y minerales
- e) Reanudar la alimentación por vía parenteral e iniciar la vía oral una vez que se haya logrado estabilizar al paciente

10) Se recomienda no darle miel de abeja a los lactantes menores de un año. ¿Cuál es la justificación para esta indicación?

- a) Es fuente de alergias en los lactantes menores
- b) No se absorben los disacáridos de la miel a esta edad y provoca diarrea osmótica
- c) Produce cólicos y malestar abdominal en los lactantes menores
- d) Existe riesgo de botulismo en los lactantes menores
- e) Provoca enteropatía perdedora de proteínas y de glóbulos rojos, la que puede ser grave

11) ¿Cuál de las siguientes no constituye una ventaja de la leche materna?

- a) Aporta cantidades óptimas de hierro al recién nacido
- b) Permite un mejor desarrollo del sistema inmune del recién nacido
- c) Disminuye el riesgo de diarreas en el lactante
- d) Tiene una osmolaridad óptima para el tubo digestivo del recién nacido
- e) Disminuye el riesgo de muerte súbita del lactante

12) ¿Cuál de las siguientes alternativas NO corresponde a una contraindicación para la lactancia materna exclusiva?

- a) Galactosemia
- b) Infección materna por VIH
- c) Consumo materno de cocaína
- d) Infección materna por hepatitis B
- e) Uso materno de antineoplásicos

13) Una niña de 7 años de edad, con mal incremento ponderal, presenta además diarrea crónica, esteatorreica. Se realiza test de Sudan en deposiciones, que resulta positivo y se solicitan anticuerpos antiendomisio, lo que resultan positivos a títulos altos. ¿Cuál de los siguientes alimentos puede ser ingerido sin problemas, por este paciente?

- a) Avena
- b) Maíz
- c) Centeno
- d) Trigo
- e) Cebada

14) ¿Cuál de las siguientes vitaminas se absorbe normalmente en un paciente con alteración de la producción de ácidos biliares?

- a) A
- b) E
- c) C
- d) D
- e) K

15) Un lactante de 11 meses, sin suplementación vitamínica, es traído por su madre porque presenta epistaxis frecuente y llora con facilidad. Al examen físico se aprecian petequias en manos, muslos y piernas, gingivitis hemorrágica, caderas flectadas y llora al movilizar la cadera izquierda. El cuadro descrito se correlaciona mejor con el déficit de la siguiente vitamina:

- a) A
- b) B1
- c) C
- d) B6
- e) K

16) Al cumplir un año de edad un niño debe alimentarse preferentemente con:

- a) Tres mamaderas de 250 ml, más dos comidas con postre
- b) Dos mamaderas de 250 ml, más tres comidas con postre
- c) Tres mamaderas de 400 ml, más dos comidas con postre
- d) Dos mamaderas de 400 ml, más tres comidas con postre
- e) Lactancia materna a libre demanda, más 3 comidas con postre

17) Un lactante de 10 meses, alimentado con fórmula y sopa puré de carnes con vegetales, es traído por su madre, ya que lo encuentra obeso. Sus mediciones antropométricas son: índice peso/edad: +2,3 DS, índice talla/edad: +1,2 DS, índice peso/talla: +1,8 DS. El diagnóstico nutricional es:

- a) Desnutrición
- b) Eutrofia
- c) Sobrepeso
- d) Obesidad
- e) Obesidad mórbida

18) Un niño de 9 años, previamente sano y eutrófico, presenta detención del crecimiento y baja de peso, a pesar de mantener un apetito normal. Refiere además que toma mucha agua y va frecuentemente a orinar. En el último tiempo se ha agregado astenia. El examen físico no aporta mayor información. El diagnóstico más probable, de entre los siguientes, es:

- a) Síndrome de malabsorción intestinal
- b) Insuficiencia suprarrenal
- c) Leucemia
- d) Anorexia nervosa
- e) Diabetes mellitus 1

19) Los exámenes de laboratorio más adecuados para determinar la presencia de una desnutrición proteica y para determinar la cantidad de proteínas que se deben consumir diariamente para su tratamiento, son respectivamente:

- a) Albúmina plasmática y proteinuria de 24 horas
- b) Albúmina plasmática y calorimetría indirecta
- c) Prealbúmina plasmática y calorimetría indirecta
- d) Prealbúmina plasmática y nitrógeno urinario total
- e) Perfil lipídico y creatinina plasmática

20) ¿Cuál de las siguientes opciones, corresponde a un alimento que NO debe ofrecerse a un niño de 6 meses de edad?

- a) Pollo
- b) Sandía
- c) Vacuno
- d) Brócoli
- e) Atún

Prueba 11

1) Un paciente de 67 años, diabético en tratamiento con metformina, consulta por dolor en las extremidades inferiores, de carácter urente, que apareció hace 3 meses y que se ha vuelto cada vez más frecuente y más intenso. Al examen físico se aprecia atrofia muscular de cuádriceps y gastrocnemios, sin alteraciones en la sensibilidad. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar AINES y aumentar la dosis de metformina
- b) Agregar glibenclamida e iniciar gabapentina
- c) Iniciar insulino terapia y un antidepresivo tricíclico
- d) Solicitar test de tolerancia a la glucosa oral e iniciar carbamacepina
- e) Indicar paracetamol en caso de dolor, manteniendo la dosis de metformina

2) Un paciente de 56 años, diabético tipo 1, en tratamiento con insulina en esquema intensificado, con 2 dosis de insulina NPH al día y 3 refuerzos preprandiales con insulina cristalina, tiene los siguientes hemoglucotest promedio:

Pre Desayuno: 98	Post Desayuno: 132
Pre Almuerzo: 158	Post Almuerzo: 168
Pre Cena: 100	Post Cena: 138

La conducta más adecuada es:

- a) Aumentar la insulina NPH matinal
- b) Aumentar la insulina cristalina pre-desayudno
- c) Aumentar la insulina NPH nocturna
- d) Aumentar la insulina cristalina pre-almuerzo
- e) Aumentar la insulina cristalina pre-cena

3) Un paciente de 45 años presenta astenia y náuseas de 3 meses de evolución. Al examen físico destacan melanoplaquias en la mucosa oral y en sus exámenes generales se aprecia hematocrito: 45% blancos: 10.000 x mm³, con 60% de linfocitos, 25% de neutrófilos, 8% de monocitos y 7% de eosinófilos, plaquetas: 220.000 x mm³, glicemia: 60 mg/dl, Na⁺: 132 mEq/l, K⁺: 5,9 mEq/l, creatinina: 0,9 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad de Cushing
- b) Enfermedad de Addison
- c) Secreción ectópica de ACTH
- d) Panhipopituitarismo
- e) Hiperprolactinemia

4) Un paciente de 54 años consulta por astenia, malestar general y cambios en su estructura facial. Además refiere que ha aumentado dos tallas en su calzado. Al examen físico se aprecia macroglosia, labios gruesos y aumento del tamaño de las manos y los pies. ¿Qué examen debe solicitar?

- a) GH basal
- b) GH basal y post-ejercicio
- c) Somatomedina 1
- d) GRH basal
- e) GRH basal y post-ejercicio

5) Una paciente de 20 años consulta por dolor cervical, asociado a nerviosismo y temblor de extremidades superiores. Al examen físico se aprecia bocio difuso moderado, doloroso a la palpación y se solicita una TSH que resulta 0,2 UI/l. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar propiltiouracilo
- b) Iniciar levotiroxina oral
- c) Iniciar AINES y betabloqueantes
- d) Iniciar AINES y propiltiouracilo
- e) Solicitar ecografía cervical

6) Identifique la asociación INCORRECTA entre la patología y la presentación clínica:

- a) Hashimoto – Bocio difuso, asociado a hipotiroidismo
- b) Tiroiditis de Riedel – Bocio difuso, de consistencia aumentada
- c) Basedow graves – Bocio difuso con síntomas de hipertiroidismo
- d) Adenoma tóxico – Bocio nodular con auscultación de soplo tiroideo
- e) Cáncer papilar – Bocio nodular, asociado a adenopatía cervical

7) La enfermedad de Basedow Graves se caracteriza por:

- a) Presencia de anticuerpos anti-peroxidasa tiroidea
- b) Bajos niveles plasmáticos de tiroglobulina
- c) Exoftalmo
- d) Baja captación de yodo en la cintigrafía tiroidea
- e) Mixedema generalizado

8) La compresión del tallo hipofisiario presenta todo lo siguiente, EXCEPTO:

- a) Prolactina baja
- b) Hipotiroidismo
- c) Diabetes insípida
- d) Insuficiencia suprarrenal
- e) Hipogonadismo

9) Un paciente hipotiroideo está en tratamiento con 125 ug de levotiroxina al día, desde hace 3 meses. Se solicita nueva TSH que resulta 8,2 UI/l. La conducta más adecuada es:

- a) Disminuir la dosis de levotiroxina
- b) Mantener el tratamiento
- c) Aumentar la dosis de levotiroxina
- d) Solicitar T4 libre
- e) Solicitar cintigrafía tiroidea con yodo radiactivo

10) Un paciente de 33 años presenta poliuria y polidipsia, asociado a nicturia de 5 o 6 veces. El examen físico es normal, al igual que la glicemia de ayuno. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar furosemida
- b) Iniciar hidroclorotiazida
- c) Iniciar desmopresina intranasal
- d) Solicitar sodio y osmolaridades plasmática y urinaria basales y luego de privación de agua
- e) Solicitar niveles plasmáticos de hormona antidiurética

11) ¿Qué dieta debe seguir un paciente hipercolesterolémico?

- a) Hipocalórica
- b) Baja en colesterol y lecitina
- c) Baja en ácidos grasos saturados
- d) Baja en triglicéridos poliinsaturados
- e) Baja en hidratos de carbono refinados

12) Un paciente de 67 años, hipertenso y diabético, en tratamiento con enalapril y metformina, se realiza un perfil lipídico que muestra colesterol total: 272 mg/dl, LDL: 170 mg/dl, HDL: 39 mg/dl, triglicéridos: 315 mg/dl. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar un fibrato
- b) Iniciar una estatina
- c) Iniciar ácido nicotínico
- d) Indicar dieta y ejercicio y controlar en 3 meses, sin necesidad de iniciar nuevos fármacos
- e) Iniciar insulina

13) Un paciente diabético de 70 años, en tratamiento con metformina y glibenclamida presenta episodio de temblor, palpitaciones y sudoración, seguidos de lenguaje incoherente y sopor profundo. Se realiza un hemoglucotest que resulta 39 mg/dl. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar glucosa por vía endovenosa hasta normalizar la glicemia y bajar la dosis de metformina
- b) Administrar glucosa por vía endovenosa hasta normalizar la glicemia y bajar la dosis de glibenclamida
- c) Administrar glucosa por vía endovenosa hasta normalizar la glicemia y mantener con suero glucosado en infusión continua, controlando hemoglucotest de manera periódica
- d) Administrar glucosa por vía endovenosa hasta normalizar la glicemia y luego suspender los hipoglicemiantes orales
- e) Administrar glucosa por vía oral e indicar una colación

14) Un paciente de 60 años presenta calcemia: 11,2 mg/dl, fósforo: 4,0 mg/dl, albúmina: 6,0 g/dl y fosfatasa alcalina normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Hipercalcemia maligna
- b) Hipercalcemia ficticia
- c) Hipervitaminosis D
- d) Hiperparatiroidismo primario
- e) Hiperparatiroidismo secundario

15) ¿Cuál de las siguientes alteraciones es MENOS probable en una mujer luego de la menopausia?

- a) Disminución de la densidad ósea
- b) Disminución de los niveles plasmáticos de estrógenos
- c) Disminución de los niveles plasmáticos de progesterona
- d) Disminución de los niveles plasmáticos de gonadotropinas
- e) Disminución de la masa muscular

16) La ceguera nocturna es característica del déficit de:

- a) Vitamina A
- b) Vitamina B1
- c) Vitamina C
- d) Vitamina D
- e) Vitamina E

17) Un paciente obeso, asintomático, se realiza un test de tolerancia a la glucosa, que muestra glicemia basal de 120 mg/dl y glicemia 2 horas post sobrecarga, con 75 gramos de glucosa, de 210 mg/dl. La hemoglobina glicosilada resulta normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Resistencia a la insulina
- b) Diabetes mellitus 2
- c) Intolerancia a la glucosa
- d) Síndrome metabólico
- e) Glicemia de ayuno alterada

18) Una paciente de 45 años se palpa un nódulo tiroideo de 2,1 cm. Se solicita una TSH que resulta 6,5UI/l y una ecografía que constata el carácter sólido-quístico del nódulo, con presencia de microcalcificaciones. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar cintigrafía tiroidea con yodo radiactivo
- b) Solicitar punción por aguja fina
- c) Solicitar TAC de cuello
- d) Solicitar calcitonina plasmática
- e) Realizar tumorectomía y biopsia

19) Un paciente de 56 años, gastrectomizado, por un cáncer gástrico incipiente, consulta por astenia y palidez, constatándose anemia, trombopenia y leucopenia, con macrocitosis e hipersegmentación del núcleo de los neutrófilos en el frotis. El diagnóstico más probable es:

- a) Déficit de vitamina B1
- b) Déficit de vitamina B2
- c) Déficit de vitamina B6
- d) Déficit de vitamina B9
- e) Déficit de vitamina B12

20) Una paciente de 34 años consulta por amenorrea y problemas de visión. Al examen físico destaca cuadrantopsia bitemporal superior. El diagnóstico más probable es:

- a) Tumor hipofisiario
- b) Hiperprolactinemia
- c) Síndrome de Sheehan
- d) Apoplejía hipofisiaria
- e) Síndrome de silla turca vacía

Prueba 12 (DIABETES, NUTRICIÓN y REUMATOLOGÍA)

Preguntas Diabetes y Nutrición

1) Un paciente de 57 años, diabético tipo 2, en tratamiento con dieta y metformina en dosis máxima desde hace 6 meses, sin daño a órgano blanco, presenta hemoglobina glicosilada de 8% y varios hemoglucotest sobre los niveles óptimos. La conducta más adecuada es:

- a) Mantener el tratamiento y controlar en 3 meses
- b) Solicitar test de tolerancia a la glucosa oral
- c) Agregar glibenclamida oral al tratamiento
- d) Iniciar insulina cristalina junto con las comidas
- e) Iniciar insulina NPH en dos dosis diarias

2) Un paciente alcohólico ingresa al servicio de urgencia producto de una caída, con probable fractura de cadera. Se inicia analgesia e hidratación con suero glucosalino, evolucionando con desorientación y visión doble. Al examen físico se aprecia parálisis del sexto par derecho. El tratamiento del cuadro descrito consiste en:

- a) Glucosa endovenosa al 30%
- b) Insulina cristalina
- c) Cianocobalamina endovenosa
- d) Niacina endovenosa
- e) Tiamina endovenosa

3) La hemorragia vítrea se caracteriza por:

- a) Acompañarse de dolor
- b) Ser frecuente en la retinopatía diabética NO proliferativa
- c) Producir desaparición del rojo pupilar
- d) Acompañarse de ojo rojo de tipo profundo
- e) Presentarse bilateralmente

4) Un niño de 7 años, obeso, presenta baja de peso, asociado a astenia, polidipsia y poliuria. Se solicita una glicemia de ayuno que resulta 230 mg/dl. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar insulina en esquema intensificado
- b) Iniciar dieta ejercicios y metformina
- c) Iniciar dieta ejercicios y glibenclamida
- d) Solicitar test de tolerancia a la glucosa oral
- e) Indicar dieta y ejercicio y controlar en 2 semanas

5) Un paciente diabético, usuario de metformina y glibenclamida es encontrado inconsciente por su hijo. Es traído a la urgencia, donde se constata FC: 100x', PA: 110/60 mmHg y HGT: 30 mg/dl. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar glucosa oral
- b) Administrar glucagón
- c) Administrar glucosa endovenosa en bolo y controlar HGT periódicos, indicando el alta al normalizar la glicemia
- d) Administrar glucosa endovenosa y potasio endovenoso, controlando HGT periódicos, indicando el alta al normalizar la glicemia
- e) Hospitalizar, administrar glucosa endovenosa en alta concentración y luego mantener con suero glucosado en infusión continua, controlando con HGT periódicos

6) Es efecto adverso frecuente de las estatinas:

- a) Mialgias
- b) Anemia
- c) Hipotiroidismo
- d) Acidosis láctica
- e) Hipoglicemia

7) Un paciente adulto presenta las siguientes medidas antropométricas talla: 150cm y peso: 60Kg. El diagnóstico nutricional es:

- a) Desnutrición
- b) Eutrofia
- c) Sobrepeso
- d) Obesidad
- e) Obesidad mórbida

Preguntas Reumatología

8) Un paciente de 43 años es diagnosticada de artritis reumatoide. El tratamiento de primera línea es:

- a) Indometacina
- b) Metotrexato
- c) Prednisona
- d) Ciclofosfamida
- e) Paracetamol

9) Un hombre de 67 años consulta por dolor intenso en la rodilla izquierda, de algunas horas de duración. No ha sufrido traumatismos y al examen se aprecia aumento de volumen, eritema y aumento de la temperatura local de la articulación. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar hemograma, factor reumatoideo, ANA y ANCA
- b) Iniciar AINEs
- c) Iniciar AINEs y alopurinol
- d) Realizar punción articular y solicitar estudio de líquido sinovial
- e) Iniciar antibióticos endovenosos y derivar a drenaje articular quirúrgico

10) El examen más adecuado para iniciar el estudio de un hombro doloroso es:

- a) Radiografía anteroposterior y axial de hombro
- b) Radiografía anteroposterior bilateral comparativa
- c) Tomografía axial computada
- d) Resonancia magnética nuclear
- e) Ecotomografía

11) Una paciente de 24 años consulta por astenia, artralgiyas y fiebre ocasional. Trae un hemograma en el que destaca linfopenia y proteinuria. El diagnóstico más probable es:

- a) Granulomatosis de Wegener
- b) Poliangeítis microscópica
- c) Panarteritis nodosa
- d) Arteritis de células gigantes
- e) Lupus eritematoso sistémico

12) Un hombre de 66 años consulta por astenia, cefalea y fiebre ocasional. Refiere que en ocasiones presenta claudicación mandibular durante la masticación. El examen físico no aporta mayor información y entre sus exámenes trae un hemograma con Hematocrito: 29%, VCM: 90 fl, HCM: 30 pg, blancos: 8.500 x mm³, plaquetas: 380.000 x mm³, VHS: 96 mm/h. El diagnóstico más probable es:

- a) Arteritis de Takayasu
- b) Pelviespondilopatía seronegativa
- c) Arteritis de células gigantes
- d) Lupus
- e) Poliangeítis microscópica

13) Una paciente presenta dolor lumbar intenso de inicio súbito, irradiado a la extremidad inferior izquierda, recorriendo la cara lateral del muslo, la piel sobre la rótula y la cara medial de la pierna, hasta el maléolo medial. Al examen presenta debilidad a la extensión de la pierna y a la dorsiflexión del pie. El reflejo rotuliano se encuentra disminuido. La raíz afectada es:

- a) L3
- b) L4
- c) L5
- d) S1
- e) S2

14) Un paciente de 65 años consulta por dolor de la rodilla izquierda de algunos meses de evolución, que aparece con la marcha y cede con el reposo. En el último tiempo el dolor se ha hecho más intenso, limitando sus actividades habituales. Al examen físico no se observan signos inflamatorios y la radiografía de rodilla muestra disminución del espacio articular y esclerosis ósea subcondral. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar resonancia magnética nuclear
- b) Iniciar paracetamol oral
- c) Iniciar prednisona oral
- d) Iniciar AINEs endovenosos
- e) Iniciar AINEs y colchicina

15) ¿Qué medida es MENOS importante para prevenir la recurrencia de artritis por ácido úrico?

- a) Iniciar alopurinol
- b) Iniciar hidroclorotiazida
- c) Iniciar probenecid
- d) Disminuir la ingesta de alcohol
- e) Disminuir la ingesta de carnes rojas

16) Un paciente de 23 años consulta por dolor lumbar de 3 semanas de evolución, asociado a rigidez matinal, mayores en la mañana y que cede con la actividad física. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Raquiestenosis
- b) Artritis reumatoide
- c) Espondilosis degenerativa
- d) Espondilitis anquilosante
- e) Lumbago mecánico

17) ¿Qué marcador suele alterarse con mayor frecuencia en la dermatomiositis?

- a) Complemento
- b) Factor reumatoideo
- c) Velocidad de sedimentación hemática
- d) Anticuerpos antinucleares
- e) Creatinfosfoquinasa

18) Una paciente de 36 años consulta por artralgiyas de manos de algunos meses de evolución, asociados a rigidez matinal de 1 hora aproximadamente. Al examen físico se aprecia aumento de volumen y signos inflamatorios en la mayoría de las articulaciones interfalángicas proximales y metacarpofalángicas de ambas manos. El diagnóstico más probable es:

- a) Artrosis
- b) Artritis reumatoide
- c) Artritis psoriática
- d) Lupus sistémico
- e) Esclerodermia

19) Los anticuerpos anti-ribonucleoproteína (Anti-RNP) se asocian a:

- a) Esclerodermia
- b) Dermatomiositis
- c) Enfermedad mixta del tejido conectivo
- d) Lupus por drogas
- e) Síndrome de Sjögren

20) Un paciente de 67 años consulta por artralgiyas y fiebre de 3 días de evolución, asociados a hematuria y oliguria importante. En sus exámenes generales se aprecia hematuria dismórfica, elevación de la creatinina hasta 3,5 mg/dl, anticuerpos antinucleares negativos y anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos positivos en patrón perinuclear. El diagnóstico más probable es:

- a) Poliangeítis microscópica
- b) Panarteritis nodosa
- c) Vasculitis granulomatosa de Wegener
- d) Vasculitis alérgica de Churg-Strauss
- e) Arteritis de la temporal

Prueba 13

1) Una mujer de 23 años consulta por palpitations frecuentes, asociados a diarrea e intolerancia al calor. Al examen físico se constata un bocio difuso, asociado a exoftalmo y retracción palpebral bilateral, con temblor fino de las extremidades superiores. El diagnóstico más probable es:

- a) Tiroiditis de Quervern
- b) Adenoma tóxico
- c) Tiroiditis de Hashimoto
- d) Enfermedad de Basedow Graves
- e) Bocio multinodular tóxico

2) Un paciente de 45 años consulta por astenia y debilidad muscular, asociado a aumento de peso. Al examen físico se aprecia obesidad de disposición centrípeta, con atrofia muscular en las extremidades y estrías abdominales de color oscuro. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar cortisol basal y post-ACTH
- b) Solicitar cortisol y ACTH basales
- c) Solicitar ACTH basal y post-dexametasona
- d) Solicitar cortisol libre urinario de 24 horas
- e) Iniciar cortisol oral

3) Un paciente de 25 años, asintomático, se realiza un perfil bioquímico, que muestra una hipercalcemia de 11,5 mg/dl, con albúmina de 3,5 g/dl. El examen físico es normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Insuficiencia renal
- b) Hipercalcemia maligna
- c) Hiperparatiroidismo primario
- d) Hipercalcemia ficticia
- e) Hipevitaminosis D

4) Una mujer de 25 años puérpera hace 3 meses, con antecedente de una inercia uterina, con hemorragia importante, consulta porque no produjo leche y aún así se mantiene en amenorrea. Además presenta astenia, náuseas y debilidad. El examen físico no aporta mayor información. El diagnóstico más probable es:

- a) Hiperprolactinemia
- b) Hipotiroidismo
- c) Panhipopituitarismo
- d) Síndrome de Cushing
- e) Enfermedad de Addison

5) Un paciente con síndrome polidipsico-poliúrico se realiza glicemia basal que resulta normal. Se realiza test de la sed que muestra: Na⁺ plasmático basal: 136 mEq/l; Na⁺ plasmático post-privación de agua: 143 mEq/l (VN Na⁺ plasmático: 136-144 mEq/l); Sodio urinario basal disminuido y sodio urinario post-privación de agua normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Diabetes insípida
- b) Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética
- c) Polidipsia psicógena
- d) Insuficiencia renal
- e) Insuficiencia suprarrenal

6) Una mujer de 34 años consulta por aumento de volumen cervical. Al examen físico se palpa un nódulo cervical de 2 cm de diámetro, en la línea media anterior, supraesternal, que asciende con la deglución. Se TSH que resulta normal y una ecografía cervical que confirma un nódulo tiroideo sólido quístico, de 2 cm, con microcalcificaciones. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar cintigrafía tiroidea
- b) Solicitar anticuerpos anti-TPO
- c) Realizar tumorectomía y biopsia
- d) Realizar tiroidectomía total
- e) Realizar biopsia por aguja fina

7) ¿Cuál(es) fármaco(s) es(son) una causa frecuente de hiperprolactinemia?

- a) Antipsicóticos
- b) Levodopa
- c) Enalapril
- d) Atorvastatina
- e) Anticonceptivos orales

8) ¿Cuál de las siguientes alteraciones en MENOS probable de encontrar en un paciente con enfermedad de Addison?

- a) Hiponatremia
- b) Hipokalemia
- c) Hiperpigmentación
- d) Dolor abdominal
- e) Hipoglicemia

9) La causa más frecuente de bocio es:

- a) Tiroiditis Hashimoto
- b) Enfermedad de Basedow Graves
- c) Adenoma tiroideo
- d) Tiroiditis subaguda
- e) Cáncer de tiroides

10) Una mujer de 55 años se realiza una densitometría ósea que muestra un T-score de -2,3 DS y un Z-score de -1 DS. El diagnóstico más probable es:

- a) Sano
- b) Osteopenia
- c) Osteoporosis primaria
- d) Osteoporosis secundaria
- e) Osteopetrosis

11) Un paciente de 54 años, sin patología previa, sufre un accidente de tránsito, con un TEC severo, que debió ser manejado quirúrgicamente. En sus exámenes de sangre destaca un sodio plasmático de 126 mEq/l. ¿Cuál es la causa más probable de esta alteración?

- a) Diabetes insípida central
- b) Hiponatremia ficticia
- c) Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética
- d) Insuficiencia suprarrenal
- e) Panhipopituitarismo

12) Una paciente de 20 años consulta por dolor cervical, asociada a nerviosismo. Al examen físico se palpa bocio doloroso a la palpación, sin adenopatías. EL diagnóstico más probable es:

- a) Tiroiditis bacteriana aguda
- b) Tiroiditis de Hashimoto
- c) Tiroiditis subaguda de Quervein
- d) Tiroiditis de Riedel
- e) Enfermedad de Basedow Graves

13) La asociación entre diabetes tipo 1, hipotiroidismo e insuficiencia suprarrenal primaria, es diagnóstica de:

- a) Hipopituitarismo
- b) Sección del tallo hipofisiario
- c) Neoplasia endocrina múltiple tipo 1
- d) Neoplasia endocrina múltiple tipo 2
- e) Síndrome poliglandular

14) Un adolescente de 17 años presenta retraso en el desarrollo puberal. Mide 1,80 m y pesa 72Kg, presenta escaso vello puberal y sus testículos son de pequeño tamaño y consistencia firme. Se solicita testosterona plasmática, que resulta baja y gonadotropinas, que resultan elevadas. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar una radiografía de mano, para estimar la edad ósea
- b) Solicitar un cariograma
- c) Iniciar análogos de GnRH
- d) Solicitar prolactina
- e) Solicitar somatomedinas

15) Una paciente de 29 años presenta amenorrea de 4 meses de evolución. Se solicita prueba de embarazo, que resulta negativa, TSH y prolactina que resultan normales y prueba de progesterona, que resulta positiva. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más concordante con los hallazgos descritos?

- a) Falla hipotalámica
- b) Falla ovárica prematura
- c) Síndrome de ovario poliquístico
- d) Hipogonadismo hipogonadotrópico
- e) Sinequias uterinas (Síndrome de Asherman)

16) Un paciente presenta hipercalcemia e hipofosfemia, asociadas a litiasis renal y osteoporosis. El diagnóstico más probable es:

- a) Insuficiencia renal crónica
- b) Hiperparatiroidismo primario
- c) Hiperparatiroidismo secundario
- d) Hipercalcemia maligna
- e) Hipervitaminosis D

17) Un paciente diagnosticado de hipertiroidismo, se realiza una cintigrafía tiroidea, que muestra un nódulo caliente, compatible con un adenoma tóxico. El tratamiento más adecuado para esta patología es:

- a) Cirugía
- b) Yodo radiactivo
- c) Propiltiouracilo
- d) Betabloqueo
- e) Levotiroxina en dosis bajas

18) Un paciente hipotiroideo está en tratamiento con levotiroxina 100ug al día. Se solicita una TSH que resulta 10,6 U/I. La conducta más adecuada es:

- a) Disminuir la dosis de eutirox
- b) Aumentar la dosis de eutirox
- c) Mantener la dosis de eutirox
- d) Solicitar T4
- e) Solicitar anticuerpos anti-TPO

19) Un niño de 5 años es traído por su madre, ya que es el más bajo de su curso. Está asintomático y al examen físico no se aprecian alteraciones. La conducta inicial más adecuada es:

- a) Solicitar cariograma
- b) Solicitar testosterona basal y 17-hidroxiprogesterona
- c) Solicitar edad ósea
- d) Revisar la curva de crecimiento
- e) Tranquilizar a la madre y explicarle que su hijo es completamente normal

20) La causa más frecuente de hipotiroidismo es:

- a) Autoinmune
- b) Hipofisiaria
- c) Secundaria a fármacos
- d) Genética
- e) Déficit de consumo de yodo

Prueba 14

1) Un paciente de 65 años, diabético tipo 2, de larga data, con tratamiento irregular con metformina y glibenclamida consulta por dolor intenso de la extremidad inferior izquierda, de tipo neurálgico, que recorre el dermatoma L4. Al examen físico se observa enflaquecido, con disminución de la sensibilidad distal y sin alteraciones motoras. La hemoglobina glicosilada resulta 9,9%. La conducta más adecuada es:

- a) Reforzar el tratamiento con hipoglicemiantes orales y controlar en 3 meses
- b) Suspender la glibenclamida y agregar insulina NPH nocturna
- c) Indicar zapatos adecuados y revisión diaria de los pies y regularizar el tratamiento con hipoglicemiantes orales
- d) Indicar un plan de ejercicios, reforzar la adhesión al tratamiento y controlar en 7 días
- e) Hospitalizar, iniciar insulino terapia y clomipramina oral

2) Un paciente de 65 años diabético tipo 2, en tratamiento con metformina presenta un hemoglucotest de ayuno “hi”. Refiere estar orinando más seguido de lo normal, sin otros síntomas. El examen físico resulta normal y su glicemia venosa resulta 544 mg/dl. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar orina completa y urocultivo e iniciar glibenclamida
- b) Solicitar orina completa y urocultivo, indicar régimen hídrico y controlar en 24 horas
- c) Solicitar orina completa y urocultivo y administrar suero fisiológico hasta normalizar la glicemia
- d) Solicitar orina completa y urocultivo e indicar insulina NPH en dosis matinal y nocturna
- e) Solicitar orina completa y urocultivo y hospitalizar para manejo con insulina

3) Un paciente de 24 años diabético tipo 1, en tratamiento con insulina en esquema intensificado, consulta por malestar general, desorientación y vómitos. Al examen físico está polipneico, sudoroso, con FC: 110x', PA: 100/60 mmHg. Se solicita glicemia que resulta 350 mg/dl, pH sanguíneo: 7,1, cetonas urinarias +++ , Na⁺ plasmático: 138 mEq/l, K⁺ plasmático: 4,3 mEq/l y Cl⁻ plasmático: 99 mEq/l. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar suero fisiológico e insulina cristalina por vía endovenosa
- b) Administrar suero fisiológico, insulina cristalina y potasio por vía endovenosa
- c) Administrar suero fisiológico, insulina cristalina, potasio y bicarbonato por vía endovenosa
- d) Administrar suero glucosado, insulina cristalina y potasio por vía endovenosa
- e) Administrar suero glucosado, insulina NPH, potasio y bicarbonato por vía endovenosa

4) Un paciente diabético en tratamiento con glibenclamida y metformina presenta un cuadro de ansiedad, temblor, sudoración y luego desorientación y coma. El diagnóstico más probable es:

- a) Cetoacidosis
- b) Síndrome hiperglicémico hiperosmolar
- c) Hipoglicemia
- d) Crisis de pánico
- e) Infarto agudo al miocardio

5) El mejor indicador de un adecuado manejo farmacológico de la diabetes mellitus 2 es:

- a) Glicemia de ayuno
- b) Glicemia post-sobrecarga de glucosa
- c) Hemoglucotest postprandiales
- d) Hemoglobina glicosilada
- e) Examen físico

6) Un paciente diabético tipo 2, diagnosticado hace 10 años, consulta por pérdida súbita de la visión del ojo derecho, sin dolor ni otros síntomas, permaneciendo sólo con escasa visión periférica en la zona temporosuperior del campo visual de dicho ojo. La etiología del cuadro descrito es:

- a) Infarto retinal
- b) Exudados céreos perimaculares
- c) Trombosis de la vena central de la retina
- d) Hemorragia por rotura de vasos de neoformación retinianos
- e) Hemorragia por rotura de microaneurismas

7) Un paciente diabético en tratamiento con insulina en esquema intensificado con 2 dosis de NPH

(matinal y nocturna) y 3 dosis de insulina cristalina (desayuno, almuerzo y cena), presenta los siguientes hemoglucotest promedio:

Pre Desayuno: 93	Post Desayuno: 132
Pre Almuerzo: 158	Post Almuerzo: 168
Pre Cena: 100	Post Cena: 138

La conducta más adecuada es:

- a) Aumentar la insulina NPH nocturna
- b) Aumentar la insulina NPH matinal
- c) Aumentar la insulina cristalina del desayuno
- d) Aumentar la insulina cristalina del almuerzo
- e) Aumentar la insulina cristalina de la cena

8) Un niño de 8 años, obeso, presenta baja de peso de 4 kg, astenia, poliuria y polidipsia. Se solicita glicemia de ayuno que resulta 224 mg/dl. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar test de tolerancia a la glucosa
- b) Solicitar nueva glicemia de ayuno
- c) Indicar dieta y ejercicios y controlar con exámenes generales en 30 días
- d) Indicar dieta y ejercicios e iniciar metformina
- e) Iniciar insulino terapia en esquema intensificado

9) ¿Cuál de los siguientes pacientes NO presenta diagnóstico de diabetes mellitus?

- a) Hombre obeso, con acantosis nigricans, glicemia basal de 120 mg/dl e insulina basal del doble del límite normal
- b) Mujer normopeso, con TTOG de 75 gr de glucosa, con glicemia basal de 105 mg/dl y a las 2 horas de 208 mg/dl
- c) Hombre obeso con glicemias de ayuno tomadas en distintos días de 140 mg/dl y 128 mg/dl
- d) Embarazada con TTOG de 75 gr de glucosa, con glicemia basal de 98 mg/dl y a las 2 horas de 170 mg/dl
- e) Embarazada con 2 glicemias de ayuno cercanas a 110 mg/dl

10) Una paciente embarazada de 28 semanas se realiza un test de tolerancia a la glucosa, siendo diagnosticada de diabetes mellitus gestacional. Se inicia tratamiento con dieta y ejercicio y se controla 14 días después, con los siguientes hemoglucotest promedio:

Pre Desayuno: 93	Post Desayuno: 132
Pre Almuerzo: 104	Post Almuerzo: 144
Pre Cena: 108	Post Cena: 139

La conducta más adecuada es:

- a) Mantener las indicaciones previas
- b) Aumentar los ejercicios y reforzar la dieta
- c) Iniciar metformina
- d) Iniciar glibenclamida
- e) Iniciar insulina

11) Un paciente de 56 años diabético tipo 2, en tratamiento con dieta y ejercicio presenta mala adherencia al tratamiento, evolucionando con daño renal. Su creatinina plasmática es 2,1 mg/dl y su hemoglobina glicosilada es de 8,1%. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar régimen hipoproteico y aumentar el ejercicio
- b) Iniciar metformina
- c) Iniciar glibenclamida
- d) Iniciar metformina + glibenclamida
- e) Iniciar insulina

12) ¿Qué tratamiento antibiótico es más adecuado para el manejo de un paciente con pie diabético?

- a) Penicilina + clindamicina
- b) Ceftriaxona + metronidazol
- c) Ciprofloxacino + gentamicina
- d) Clindamicina + metronidazol
- e) Cefazolina + metronidazol

13) ¿Cuál es el efecto adverso más frecuente de la metformina?

- a) Mala tolerancia gastrointestinal
- b) Artralgias y mialgias
- c) Acidosis láctica
- d) Rabdomiolisis
- e) Hipoglicemias

14) El síndrome metabólico o síndrome X se caracteriza por:

- a) Obesidad, resistencia a la insulina, hipertensión arterial, hipertrigliceridemia y elevación del colesterol LDL
- b) Obesidad, resistencia a la insulina, hipertensión arterial, hipertrigliceridemia y elevación del colesterol HDL
- c) Obesidad, resistencia a la insulina, hipertensión arterial, elevación del colesterol LDL y disminución del colesterol HDL
- d) Obesidad, resistencia a la insulina, hipertensión arterial, hipertrigliceridemia y disminución del colesterol HDL
- e) Obesidad, resistencia a la insulina, hipertensión arterial, elevación del colesterol HDL y disminución del colesterol LDL

15) Las hipoglicemias reactivas suelen suceder algunas horas después de ingerir alimentos. Su etiología suele ser:

- a) La resistencia a la insulina
- b) La presencia de un insulinoma
- c) Tumoral maligna
- d) Farmacológica
- e) La desnutrición

16) En los estados hipercatabólicos suele aumentar:

- a) La prealbúmina plasmática
- b) La proteinuria
- c) El nitrógeno urinario total
- d) El colesterol
- e) La albúmina plasmática

17) Respecto a la encefalopatía de Wernicke es FALSO que:

- a) Debe prevenirse con administración de tiamina endovenosa
- b) Es frecuente en pacientes alcohólicos
- c) Se caracteriza por alucinaciones visuales e ideas paranoides
- d) Suele afectarse la oculomotilidad
- e) Suele desencadenarse tras la realimentación de un paciente desnutrido

18) El diagnóstico de la obesidad se basa en:

- a) La ingesta diaria de calorías
- b) Las medidas antropométricas
- c) La inspección visual
- d) La impedanciometría
- e) El perfil lipídico

19) Cuando los niveles de triglicéridos sobrepasan los 500 mg/dl, existe un alto riesgo de:

- a) Accidente vascular cerebral
- b) Embolia grasa
- c) Infarto miocárdico
- d) Pancreatitis aguda
- e) Esteatohepatitis no alcohólica

20) Un paciente cardiópata coronario y diabético se realiza un perfil lipídico que muestra los siguientes valores: Colesterol total: 204 mg/dl, Colesterol LDL: 120 mg/dl, HDL: 35 mg/dl, triglicéridos: 245 mg/dl.

La conducta más adecuada es:

- a) Indicar dieta baja en grasas saturadas e hidratos de carbono refinados y controlar en 3 meses
- b) Iniciar un fibrato
- c) Iniciar una estatina
- d) Iniciar ácido nicotínico
- e) Iniciar una asociación entre un fibrato y una estatina

Prueba 15

1) Un paciente presenta un nódulo tiroideo derecho, asociado a síntomas de hipertiroidismo. Se solicita TSH que resulta menor a 0,02 UI/L, razón por la cual se realiza una cintigrafía tiroidea con yodo radiactivo que muestra hipercaptación a nivel del nódulo, con ausencia de captación en el resto de la tiroides. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar betabloqueantes y propiltiouracilo
- b) Realizar tumorectomía
- c) Realizar tiroidectomía total
- d) Iniciar levotiroxina en dosis bajas
- e) Administrar yodo radiactivo

2) Una niña de 7 años presenta olor axilar adulto desde hace algunos días. Se puede afirmar que:

- a) Ha iniciado su pubertad de manera precoz
- b) Ha iniciado su pubertad normalmente
- c) Probablemente presentará talla baja
- d) Se debe descartar una hiperplasia suprarrenal congénita
- e) Es normal

3) Una paciente asmática severa, en tratamiento con salbutamol, fluticasona, salmeterol y prednisona presenta fiebre, tos y expectoración purulenta, siendo diagnosticada de neumonía, mediante una radiografía de tórax. Inicia amoxicilina + ácido clavulánico, sin embargo evoluciona con marcado decaimiento, náuseas, vómitos y ortostatismo. Al examen físico presenta FC: 102x', PA: 80/50 mmHg, FR: 16x', SatO2: 96%, t°: 37°C. La conducta más adecuada es:

- a) Hospitalizar, administrar suero fisiológico, iniciar ceftriaxona y solicitar TSH y T4 libre
- b) Hospitalizar, administrar suero fisiológico, iniciar ceftriaxona y solicitar test de supresión larga con dexametasona
- c) Hospitalizar, administrar suero fisiológico, iniciar ceftriaxona y administrar corticoides endovenosos
- d) Hospitalizar, administrar suero fisiológico, iniciar ceftriaxona e iniciar levotiroxina
- e) Hospitalizar, administrar suero fisiológico, iniciar ceftriaxona y solicitar cortisol libre urinario de 24 horas

4) ¿Qué examen es más adecuado para vigilar por posible recurrencia a un paciente operado de cáncer folicular de tiroides hace un año?

- a) Hormona tiroestimulante
- b) Tiroglobulina
- c) Tiroxina
- d) Triyodotironina
- e) Calcitonina

5) La primera causa de hipercalcemia en los pacientes hospitalizados es:

- a) Hipervitaminosis D
- b) Uso de diuréticos de asa
- c) Hiperparatiroidismo primario
- d) Hiperparatiroidismo secundario
- e) Cáncer

6) El hipogonadismo en los hombres suele presentarse como:

- a) Astenia, disminución de la libido e impotencia sexual
- b) Debilidad, ginecomastia y alopecia
- c) Impotencia sexual, ginecomastia y baja de peso
- d) Baja de peso, alopecia y disminución de la libido
- e) Debilidad muscular, bochornos, impotencia sexual y aumento de peso

7) Respecto al carcinoma papilar es FALSO que:

- a) Es el cáncer de tiroides más frecuente
- b) Suele diseminarse por vía hematógena
- c) Responde al tratamiento con yodo radiactivo
- d) Se diagnostica mediante punción con aguja fina
- e) Su pronóstico de supervivencia es mayor al 80%

8) Un paciente consulta por cefalea intensa, vómitos y visión doble que iniciaron súbitamente hace 1

hora. Al examen físico se aprecia estrabismo divergente y hemianopsia heterónima bitemporal. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome de Sheehan
- b) Síndrome de Asherman
- c) Apoplejía hipofisiaria
- d) Síndrome de compresión del tallo hipofisiario
- e) Síndrome de silla turca vacía

9) Indique la asociación INCORRECTA entre la patología y el tratamiento de elección:

- a) Tiroiditis subaguda – AINES
- b) Hiperparatiroidismo primario – bifosfonatos
- c) Enfermedad de Addison – cortisol y fludrocortisona por vía oral
- d) Enfermedad de Cushing – cirugía
- e) Tiroiditis de Hashimoto – levotiroxina

10) Un paciente consulta por palpitaciones y diarrea. Al examen físico se constata retracción palpebral, temblor fino, piel húmeda y caliente, sin alteraciones a la palpación de la glándula tiroides. Se solicita TSH que resulta suprimida y T4 que está aumentada. Los anticuerpos anti-TPO y TRAB resultan negativos, la tiroglobulina plasmática es indetectable y la captación de yodo radiactivo muestra captación menor al 1%. El diagnóstico más probable es:

- a) Tiroiditis de Riedel
- b) Tiroiditis silente
- c) Tiroiditis de Quervein
- d) Struma Ovari
- e) Uso de tiroxina exógena

11) Un paciente diagnosticado de VIH hace 5 años, sin tratamiento antirretroviral, consulta por astenia, debilidad y marcado malestar general. Al examen físico está hipotenso y se visualizan máculas hiperpigmentadas en la cara y en la cavidad oral. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética
- b) Hipotiroidismo
- c) Hipopituitarismo
- d) Insuficiencia suprarrenal
- e) Síndrome de secreción ectópica de ACTH

12) Un niño de 10 años es de los más bajos de su curso. Al revisar su curva de crecimiento de aprecia una velocidad normal de crecimiento y el examen físico no aporta mayor información. Se solicita radiografía de carpo, que es concordante con la edad ósea de un niño de 8 años. El diagnóstico más probable es:

- a) Déficit de GH
- b) Enfermedad celíaca
- c) Talla baja familiar
- d) Retraso puberal
- e) Retraso constitucional del crecimiento

13) La etiología más frecuente del síndrome de ovario poliquístico es:

- a) Adenoma hipofisiario hiperfuncionante
- b) Resistencia a la insulina
- c) Adenoma ovárico hiperfuncionante
- d) Cuerpo lúteo persistente
- e) Hipogonadismo hipergonadotrópico

14) Un paciente de 20 años presenta hipertensión arterial de reciente diagnóstico, con cifras tensionales cercanas a 160/110 mmHg. En sus exámenes generales destaca potasemia de 2,9 mEq/l. Debe sospecharse:

- a) Feocromocitoma
- b) Enfermedad de Addison
- c) Hiperparatiroidismo primario
- d) Hipertensión esencial
- e) Hiperaldosteronismo primario

15) Un paciente con bocio difuso, doloroso a la palpación probablemente padece:

- a) Tiroiditis de Hashimoto
- b) Tiroiditis de Quervain
- c) Tiroiditis de Riedel
- d) Quiste coloideo
- e) Enfermedad de Basedow Graves

16) Un paciente de 35 años consulta por astenia y poliuria. Se solicitan exámenes generales, donde destaca glicemia: 80 mg/dl, calcemia de 12,5 mg/dl, con albuminemia de 3,5g/dl y fosfemia de 2,9 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

- a) Hipercalcemia maligna
- b) Hipercalcemia ficticia
- c) Hiperparatiroidismo primario
- d) Hipercalcemia por uso de diuréticos
- e) Hipervitaminosis D

17) Una mujer de 36 años, previamente sana, consulta por galactorrea y amenorrea de 3 meses. El examen físico no aporta mayor información. Se constata elevación moderada de la prolactina y se solicita una resonancia magnética de silla turca, con visualización de un tumor hipofisiario de 3 mm de diámetro. El tratamiento de elección es:

- a) Agonistas dopaminérgicos
- b) Antagonistas dopaminérgicos
- c) Radioterapia
- d) Cirugía
- e) Anticonceptivos orales

18) Un paciente de 45 años, sin antecedentes de importancia, consulta por debilidad muscular, astenia y aumento de peso. Al examen físico se aprecia obesidad con concentración del tejido adiposo en la cara y en la zona alta de la espalda. También se constata hipertensión arterial y adelgazamiento de las masas musculares de las extremidades. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar niveles plasmáticos de cortisol y de ACTH
- b) Solicitar cortisol basal y post-estimulación con ACTH
- c) Solicitar cortisol basal y resonancia magnética nuclear
- d) Solicitar test de supresión corta con dexametasona
- e) Solicitar 17-hidroxi progesterona

19) En una paciente con síndrome de Sheehan, la prueba de progesterona y la prueba de estrógeno+progesterona, serán respectivamente:

- a) Positiva y positiva
- b) Positiva y negativa
- c) Negativa y positiva
- d) Negativa y negativa
- e) Positiva y no interpretable

20) ¿Qué examen es más adecuado para determinar el origen central o nefrogénico de una diabetes insípida?

- a) Osmolaridad urinaria basal y postprivación de agua
- b) Prueba de respuesta a desmopresina
- c) Sodio urinario de 24 horas
- d) Niveles plasmáticos de ADH
- e) TAC de silla turca

1) Una paciente de 38 años consulta por astenia, palpitaciones y diarrea, que iniciaron hace cerca de unos meses y que han ido en aumento. Refiere además que se siente muy incómoda en los días calurosos. Al examen físico está taquicárdica, con pulso irregular, normotensa, con piel fina y húmeda. La mirada es expresiva con retracción palpebral y cierto grado de proptosis y se palpa un bocio difuso, no doloroso. ¿Qué alteración es MENOS probable de ser hallada en esta paciente?

- a) TSH suprimida
- b) Presencia de anticuerpos contra el receptor de TSH
- c) Elevación de la tiroxina plasmática
- d) Disminución de la captación tiroidea de yodo
- e) Mixedema pretibial

2) Un paciente consulta por astenia, debilidad muscular y náuseas de varias semanas de evolución. Al examen físico se observan máculas hiperpigmentadas en la boca y en la cara. ¿Qué examen(es) debe(n) ser solicitado(s) ante este cuadro clínico?

- a) Cortisol y ACTH plasmáticos basales
- b) Cortisol plasmático basal y post-dexametasona
- c) Cortisol plasmático basal y post-ACTH
- d) Cortisol plasmático basal y nocturno
- e) Cortisol y ACTH en orina

3) Una paciente de 35 años consulta por astenia, constipación, debilidad y problemas de visión, de lenta evolución. Al examen físico se aprecia disminución del campo visual temporal de ambos ojos. El diagnóstico más probable es:

- a) Apoplejía hipofisiaria
- b) Síndrome de Sheehan
- c) Tumor hipofisiario
- d) Síndrome de la silla turca vacía
- e) Hiperprolactinemia

4) Una paciente de 33 años, esquizofrénica, presenta galactorrea. Refiere ausencia de menstruaciones desde hace 4 meses, por lo que se realiza un test de embarazo, que resulta negativo. El diagnóstico más probable es:

- a) Hipogonadismo hipogonadotrópico
- b) Prolactinoma hipofisiario
- c) Hipogonadismo hipergonadotrópico
- d) Síndrome de ovario poliquístico
- e) Hiperprolactinemia secundaria a fármacos

5) Un paciente consulta por astenia y alza de peso. Al examen físico está hipertenso, se aprecia atrofia muscular y obesidad de disposición centripeta. En sus exámenes destaca glicemia de ayuno: 180 mg/dl, creatinina: 1,0 mg/dl, K: 3,0 mEq/l, Na: 142 mEq/l, Cl: 103 mEq/l. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad de Cushing
- b) Diabetes mellitus 2
- c) Enfermedad de Addison
- d) Acromegalia
- e) Hipotiroidismo

6) Una paciente presenta dolor cervical y malestar general. Al examen físico se palpa bocio doloroso y se solicita TSH que resulta 0,1 UI/l. El diagnóstico más probable es:

- a) Tiroiditis de Hashimoto
- b) Enfermedad de Basedow Graves
- c) Tiroiditis de Quervein
- d) Tiroiditis de Riedel
- e) Bocio multinodular tóxico

7) Un paciente de 26 años, con hipertensión arterial, se realiza exámenes generales, en los que

destaca hipokalemia, por lo que se solicita índice de aldosterona/ARP, el que resulta 60 (VN: menor a 25). EL tratamiento de la patología descrita es:

- a) Cirugía vascular de arterias renales
- b) Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina
- c) Cirugía de las glándulas suprarrenales
- d) Propanolol
- e) Espironolactona

8) Un paciente hipotiroideo, en tratamiento con 75 ug de levotiroxina al día, se controla TSH que resulta 0,2 UI/l. La conducta más adecuada es:

- a) Agregar propiltiouracilo
- b) Mantener el tratamiento
- c) Agregar betabloqueo
- d) Aumentar la dosis de levotiroxina
- e) Disminuir la dosis de levotiroxina

9) Un paciente de 80 años se realiza un perfil bioquímico, en el que se aprecia calcio: 12,0 mEq/l, albúmina: 2,0 g/dl, fósforo: 7 mg/dl y fosfatasa alcalinas: 300 UI/l. El diagnóstico más probable es:

- a) Hipercalcemia maligna
- b) Hipercalcemia ficticia
- c) Hiperparatiroidismo primario
- d) Hiperparatiroidismo secundario
- e) Hipervitaminosis D

10) Un paciente de 50 años consulta por astenia, debilidad muscular, disminución de la libido y disfunción sexual, con pérdida de las erecciones matinales. El examen físico muestra disminución del vello corporal. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad de Cushing
- b) Hipogonadismo
- c) Depresión
- d) Hipotiroidismo
- e) Diabetes mellitus

11) Los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, inadecuadamente tratado, suelen complicarse con:

- a) Depresión
- b) Manía
- c) Delirio
- d) Síntomas disociativos
- e) Síntomas conversivos

12) Una mujer presenta crisis de pánico en una oportunidad, mientras iba sola en un ascensor. Desde entonces ha presentado 4 crisis de pánico, sin poder identificar un desencadenante claro y refiere miedo a que le pase algo durante esas crisis y no reciba ayuda, por lo que evita quedarse sola y salir de su casa. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de pánico
- b) Trastorno de ansiedad generalizada
- c) Trastorno fóbico social
- d) Fobia específica
- e) Trastorno de estrés postraumático.

13) Las obsesiones del TOC se caracterizan por todo lo siguiente, EXCEPTO:

- a) Que el paciente las reconoce como propias de su mente
- b) Producir angustia, la que sólo se disipa al realizar un ritual
- c) Ser frecuentemente ideas de contaminación o duda
- d) Que el paciente las considera como irracionales
- e) Asociarse a alteraciones perceptuales

14) Un paciente consulta por un cuadro crónico de ideas paranoides, alucinaciones visuales y

marcado aplanamiento afectivo. El tratamiento de elección es:

- a) Neurolépticos orales
- b) Neurolépticos de depósito
- c) Antidepresivos
- d) Anticonvulsivantes
- e) Benzodiacepinas

15) Una mujer asegura que Barack Obama está profundamente enamorado de ella y que se lo muestra a través de sus discursos, pero que no ha podido estar con ella, debido a que sus obligaciones como presidente y la CÍA se lo prohíben. Explica que todo comenzó con la visita del presidente estadounidense a Chile hace varios meses. Sus familiares se muestran preocupados, ya que habla frecuentemente de eso y no entienden qué le pasa. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de personalidad histriónica
- b) Trastorno bipolar en fase maníaca
- c) Trastorno delirante
- d) Trastorno de personalidad narcicista
- e) Trastorno disociativo

16) Un paciente consulta por ánimo bajo, anhedonia, aumento de las horas de sueño y subida de peso de 10 Kg en los últimos 3 meses. Refiere que siente muchas ganas de comer cosas dulces, especialmente chocolates, lo que lo ha hecho engordar. El tratamiento más adecuado para este paciente es:

- a) Antidepresivos tricíclicos
- b) Anticonvulsivantes
- c) Antidepresivos inhibidores de la recaptura de serotonina
- d) Antidepresivos inhibidores de la monoaminoxidasa
- e) Antidepresivos inhibidores de la recaptura de serotonina más antipsicóticos atípicos

17) Una paciente de 24 años consulta porque se siente ansiosa y en ocasiones triste. Refiere que es muy insegura, le cuesta expresar desacuerdo y tomar decisiones por sí misma, lo que hace que en ocasiones su marido y su jefe se molesten con ella, lo que le causa mucha angustia. El diagnóstico más probable es:

- a) Distimia
- b) Trastorno adaptativo
- c) Trastorno de personalidad
- d) Trastorno depresivo
- e) Trastorno de ansiedad generalizada

18) ¿Cuál de las siguientes asociaciones es INCORRECTA entre el medicamento y sus efectos adversos?

- a) Ácido valproico – Aumento de peso
- b) Risperidona - Disonía
- c) Haloperidol - Disonía
- d) Escitalopram – Disminución de la libido
- e) Imipramina - Diarrea

19) Usted recibe a un paciente que refiere que tiene pesadillas y recuerdos muy vivos acerca de un incendio que sucedió hace 2 meses en la casa donde él vivía, en el que resultó con algunas quemaduras de segundo grado y perdió gran parte de sus bienes. Refiere que le causa mucha angustia recordarlo y que sólo ver fuego le produce ansiedad, al punto que no es capaz de entrar a la cocina, cuando están cocinando algo. Refiere que le cuesta expresar qué es lo que le pasa, pero que está muy incómodo con la situación. El diagnóstico más probable es:

- a) Fobia específica
- b) Trastorno de angustia
- c) Trastorno de angustia generalizada
- d) Trastorno obsesivo compulsivo
- e) Trastorno por estrés postraumático

20) Un paciente de 25 años consulta por tristeza, anhedonia, insomnio y baja de peso de 5 kg, de un

mes de evolución, asociado a disminución en la concentración e ideas de desesperanza. No es capaz de identificar un desencadenante claro y ha visto afectada su vida laboral. Al ser interrogado, refiere que hace tres años sufrió un cuadro similar, autolimitado, luego de 8 meses y que cinco años atrás sufrió un cuadro que describe con “mucha energía y ganas de hacer cosas, en las que hice varios negocios, sin embargo todos fracasaron. Casi no necesitaba dormir y tuve muchos problemas con mis familiares y amigos”. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar fluoxetina
- b) Iniciar amitriptilina
- c) Derivar a especialista para inicio de neurolépticos
- d) Derivar a especialista para inicio de litio
- e) Administrar haloperidol intramuscular y hospitalizar

Prueba 1	4 A	8 B	10 D	13 C	17 B
1 A	5 C	9 D	11 A	14 A	18 B
2 C	6 E	10 A	12 B	15 E	19 E
3 A	7 D	11 D	13 E	16 B	20 A
4 C	8 A	12 E	14 A	17 C	
5 C	9 C	13 D	15 C	18 E	Prueba 12
6 B	10 A	14 B	16 B	19 C	1 C
7 C	11 B	15 E	17 D	20 C	2 E
8 C	12 E	16 D	18 C		3 C
9 E	13 C	17 D	19 C	Prueba 10	4 A
10 B	14 E	18 D	20 E	1 B	5 E
11 D	15 D	19 D		2 A	6 A
12 C	16 D	20 D	Prueba 8	3 E	7 C
13 A	17 D		1 B	4 E	
14 D	18 B		2 D	5 D	8 B
15 D	19 D		3 B	6 B	9 D
16 B	20 C	Prueba 6	4 D	7 E	10 E
17 B		1 C	5 A	8 B	11 E
18 C	Prueba 4	2 A	6 C	9 D	12 C
19 D	1 C	3 C	7 C	10 D	13 B
20 C	2 A	4 B	8 B	11 A	14 B
	3 B	5 D	9 B	12 D	15 B
Prueba 2	4 E	6 E	10 B	13 B	16 D
1 D	5 B	7 D	11 E	14 C	17 E
2 D	6 B	8 B	12 D	15 C	18 B
3 D	7 D	9 C	13 B	16 A	19 C
4 C	8 C	10 B	14 B	17 C	20 A
5 B	9 D	11 D	15 E	18 E	
6 E	10 D	12 B	16 C	19 D	Prueba 13
7 D	11 C	13 B	17 B	20 E	1 D
8 C	12 D	14 A	18 C		2 D
9 B	13 B	15 C	19 B	Prueba 11	3 C
10 B	14 D	16 E	20 A	1 C	4 C
11 B	15 D	17 C	21 C	2 A	5 C
12 B	16 D	18 E		3 B	6 E
13 D	17 B	19 A	Prueba 9	4 C	7 A
14 E	18 B	20 D	1 A	5 C	8 B
15 A	19 E		2 D	6 D	9 A
16 A	20 B	Prueba 7	3 A	7 C	10 B
17 C		1 C	4 C	8 A	11 C
18 D	Prueba 5	2 E	5 C	9 C	12 C
19 A	1 D	3 E	6 A	10 D	13 E
20 E	2 A	4 C	7 D	11 C	14 B
	3 D	5 C	8 D	12 B	15 C
Prueba 3	4 E	6 A	9 B	13 C	16 B
1 C	5 C	7 E	10 A	14 B	17 B
2 E	6 E	8 B	11 E	15 D	18 B
3 E	7 C	9 D	12 A	16 A	19 D

20 A	13 A	4 B	15 B	4 E	13 E
	14 D				
Prueba 14	15 A	5 E	16 C	5 A	14 A
1 E	16 C	6 A	17 A	6 C	15 C
2 E	17 C	7 B	18 D	7 E	16 D
3 B	18 B	8 C	19 C	8 E	17 C
4 C	19 D	9 B	20 B	9 A	18 E
5 D	20 C	10 E	Prueba 16	10 B	19 E
6 D		11 D	1 D	11 A	20 D
7 B	Prueba 15	12 E	2 C	12 A	
8 E	1 E	13 B	3 C		
9 A	2 E	14 E			
10 E	3 C				
11 E					
12 E					

VII) REUMATOLOGÍA PREGUNTAS

Prueba 1 (REUMATOLOGÍA + SALUD PÚBLICA)

1) ¿A qué tipo de estudio corresponde el siguiente enunciado?: “Se selecciona un grupo de 50 pacientes, afectos de hepatocarcinoma y otro grupo de 100 pacientes, de edad similar, sanos y se comparan la tasas de exposición previa a alcohol”

- a) Caso control
- b) Estudio de prevalencia
- c) Cohortes
- d) Ensayo clínico
- e) Ecológico

2) La mejor estrategia para disminuir el error aleatorio es:

- a) Aleatorizar
- b) Realizar análisis estratificado
- c) Aumentar el tamaño de la muestra
- d) Enmascarar (doble ciego)
- e) Aparear (matching)

3) Calcule el valor predictivo positivo APROXIMADO de una prueba diagnóstica con los siguientes datos:

Sensibilidad: 0,8; Especificidad: 0,9; Prevalencia de enfermedad: 10%

- a) 0,33
- b) 0,50
- c) 0,66
- d) 0,80
- e) 0,90

4) ¿A qué tipo de estudio corresponde el siguiente enunciado?: “Se selecciona una muestra de 5000 pacientes y se les miden los niveles de colesterol y triglicéridos, determinando el número de pacientes con hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia”

- a) Transversal
- b) Ensayo de campo
- c) Ecológico
- d) Cohortes
- e) Intervención comunitaria

5) Se seleccionan 300 pacientes con hipercolesterolemia y se aleatorizan a 3 grupos de 100 pacientes cada uno. El primer grupo recibe atorvastatina, el segundo grupo recibe gemfibrozilo y el tercero recibe una asociación entre gemfibrozilo y atorvastatina. Se comparan los niveles de colesterol luego de 3 meses de tratamiento. La mejor prueba para determinar la significancia estadística es:

- a) La “t” de Student
- b) Chi cuadrado
- c) La “r” de Pearson
- d) Prueba exacta de Fisher
- e) Análisis de varianza

6) El exceso de riesgo de enfermar, en los pacientes sometidos a un factor de riesgo, se denomina:

- a) Odds ratio
- b) Likelihood ratio
- c) Riesgo relativo
- d) Riesgo atribuible
- e) Riesgo atribuible poblacional

7) Un paciente sufre de claudicación intermitente. Se le indican ejercicios diarios. Esta indicación corresponde a una medida de:

- a) Prevención primaria
- b) Prevención secundaria
- c) Prevención terciaria
- d) Protección de salud
- e) Promoción de salud

8) La compra de insumos y la implementación de equipos, por parte de los distintos servicios de

salud, está determinada de la siguiente manera:

- a) Comprar el equipamiento más moderno disponible
- b) Comprarlos de acuerdo a los precios y garantías que ofrecen los proveedores
- c) Renovarlos anualmente para evitar pérdida de garantías y obsolescencia
- d) Externalizar todos los servicios que requieran de equipamiento
- e) Comprar al mismo proveedor, garantizando así compatibilidad técnica

9) La institución encargada de fiscalizar el actuar de las farmacias es:

- a) La central nacional de abastecimiento
- b) El instituto de salud pública
- c) La secretaría regional ministerial
- d) La superintendencia de isapres
- e) El instituto médico legal

10) El índice de ocupación de un hospital está dado por la relación entre:

- a) La duración promedio de las hospitalizaciones y el total de días-cama disponibles
- b) Los pacientes ingresados y el total de camas
- c) Los pacientes dados de alta y el total de camas
- d) Los días-cama ocupados y el total de días-cama disponibles
- e) La duración promedio de las hospitalizaciones y el total de días-cama disponibles

Reumatología

11) Una mujer de 57 años, consulta por artralgias de manos, de larga evolución. Al examen físico se aprecia aumento de volumen de consistencia dura en relación a las articulaciones interfalángicas proximales y distales. El diagnóstico más probable es:

- a) Artritis reumatoide
- b) Artritis gotosa
- c) Artrosis
- d) Espondiloartropatía seronegativa
- e) Esclerodermia sistémica limitada

12) La manifestación extraarticular más frecuente de la artritis reumatoidea es:

- a) Escleritis-epiescleritis
- b) Mononeuritis múltiple
- c) Nódulos reumatoideos
- d) Afectación pleuro-pulmonar
- e) Afectación cardíaco-pericárdica

13) ¿Cuál de las siguientes exámenes permite predecir el grado de actividad lúpica?

- a) Anticuerpos antinucleares
- b) Anticuerpos anti-Ro y anti-La
- c) Anticuerpos anti DNA de una hebra
- d) Factor reumatoideo
- e) Complemento C3 y C4

14) La presentación clínica más habitual de la granulomatosis de Wegener es:

- a) Astenia, fiebre, compromiso de coronarias y arterias mesentéricas
- b) Glomerulonefritis rápidamente progresiva y ANCA positivo en patrón perinuclear
- c) Asma refractario a tratamiento y con posterioridad afectación renal
- d) Rinosinusitis de difícil manejo, asociada a glomerulonefritis rápidamente progresiva y afectación pulmonar
- e) Insuficiencia renal, hematuria, accidentes vasculares encefálicos a repetición y púrpura palpable de extremidades inferiores

15) La causa más frecuente de codo doloroso es:

- a) Artrosis
- b) Tendinitis bicipital
- c) Epicondilitis lateral y medial
- d) Bursitis
- e) Entesitis tricpital

16) Un paciente de 56 años, con antecedente de gota, inicia dolor intenso en la rodilla derecha,

asociado a aumento de volumen y eritema. Al examen físico se aprecia paciente febril hasta 38,4°C, levemente hipertenso, con aumento de volumen, eritema, aumento del calor local y signos de derrame articular, en relación a la rodilla izquierda. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar AINEs, colchicina y alopurinol
- b) Iniciar AINEs y colchicina, sin alopurinol
- c) Iniciar AINEs y realizar infiltración local con corticoides
- d) Iniciar AINEs y solicitar estudio de líquido sinovial
- e) Iniciar cefazolina y AINEs endovenosos y derivar a traumatología, para aseo quirúrgico inmediato

17) Una mujer de 43 años, presenta artralgiyas de manos, asociados a rigidez matinal de 1 hora, de varios años de evolución. Al examen físico se observa deformación en cuello de cisne y en botón de camisa de varios dedos y desviación hacia cubital de los dedos de ambas manos, asociado a artritis de muñecas y de algunas articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales. El diagnóstico más probable es:

- a) Artrosis avanzada
- b) Artritis lúpica no erosiva
- c) Artritis gotosa tofácea
- d) Artritis reumatoidea deformante
- e) Esclerodermia

18) Una mujer de 24 años, consulta por artralgiyas de manos y fiebre ocasional. El examen físico no aporta mayor información y los exámenes de laboratorio arrojan linfopenia y proteinuria. El diagnóstico más probable es:

- a) Arteritis de la temporal
- b) Lupus eritematoso sistémico
- c) Leucemia aguda
- d) Artritis viral
- e) Vasculitis de vaso pequeño

19) La dermatomiositis es una enfermedad autoinmune, que ha sido asociada a la presencia de un cáncer concomitante. Los marcadores inmunológicos más característicos de esta patología son:

- a) Anticuerpos anti centrómero
- b) Anticuerpos anti nucléolo
- c) Anticuerpos anti Jo-1
- d) Anticuerpos anti Ro y anti La
- e) Anticuerpos anti ribonucleoproteína

20) Un paciente de 55 años, consulta por dolor articular. Refiere dolor y aumento de volumen recidivante y migratorio de grandes y pequeñas articulaciones. Al examen físico se aprecia artritis de la rodilla y codo derechos, y de la rodilla, muñeca y tobillo izquierdo. También se observa dactilitis de 3 dedos y 2 orjeos, asociados a pits (picotazos) ungueales. El diagnóstico más probable es:

- a) Artritis psoriática
- b) Espondilitis anquilosante
- c) Enfermedad de Still (Artritis juvenil idiopática)
- d) Artritis reumatoide
- e) Lupus eritematoso sistémico

Prueba 2

1) ¿Cuál de las siguientes asociaciones es INCORRECTA?

- a) Anticuerpos anti-citoplasma de neutrófilos en patrón "C" – Granulomatosis de Wegener
- b) Anticuerpos anti-DNA de doble hebra – Marcador de actividad de Lupus sistémico
- c) Anticuerpos antihistona – Lupus por drogas
- d) Anticuerpos anticentrómero – Dermatomiositis
- e) Anticuerpos anti-RNP – Enfermedad mixta del tejido conectivo

2) Un paciente de 77 años presenta dolor intenso y aumento de volumen en la rodilla derecha, de un

par de horas de evolución. Al examen se observa dolor, eritema y aumento de la temperatura de la articulación. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar radiografía simple de rodilla
- b) Solicitar uricemia, calcemia y niveles plasmáticos de paratohormona
- c) Indicar reposo e iniciar AINEs
- d) Realizar artrocentesis y estudio de líquido sinovial
- e) Administrar corticoides intraarticulares

3) La artritis psoriática se manifiesta con mayor frecuencia como:

- a) Una monoartritis aguda migratoria y recidivante
- b) Una oligoartritis que compromete las articulaciones cuya piel circundante presenta placas psoriáticas
- c) Una oligoartritis asimétrica y migratoria de grandes y pequeñas articulaciones, asociada a dactilitis
- d) Una poliartritis simétrica distal, de pequeñas y grandes articulaciones, asociadas a rigidez matinal de más de 30 minutos de duración
- e) Una poliartritis de pequeñas articulaciones, asimétrica, asociada a compromiso renal

4) Una mujer de 67 años presenta astenia y artralgias de una semana de evolución, asociado a fiebre intermitente. Hace 2 días comienza con marcado decaimiento, oligoanuria y hematuria. Al examen físico sólo se aprecian algunas lesiones eritematosas pequeñas en la piel de las extremidades inferiores. En sus exámenes destaca creatinina de 6,7 mg/dl, proteinuria escasa y hematuria con un 20% de dismorfia. Los ANA resultan negativos y los ANCA resultan positivos en patrón perinuclear. El diagnóstico más probable es:

- a) Panarteritis nodosa
- b) Púrpura de Schoenlein Henoch
- c) Lupus eritematoso sistémico
- d) Poliangeítis microscópica
- e) Granulomatosis de Wegener

5) Un niño de 5 años presenta un cuadro de 2 meses de evolución de artritis de rodillas, muñecas y algunas articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales de las manos, asociado a fiebre ocasional. En sus exámenes presenta función renal normal, anemia discreta, con VCM: 85, leucocitos normales, plaquetas discretamente elevadas. En el perfil de hierro destaca elevación importante de la ferritina. El tratamiento de la patología descrita es:

- a) Corticoides orales
- b) Corticoides más ciclosporina
- c) Metotrexato oral en dosis única semanal
- d) Inmunoglobulina G en altas dosis por vía endovenosa
- e) Antiinflamatorios no esteroideos orales

6) Un paciente de 66 años aqueja dolor en la ingle derecha, especialmente al caminar varias cuerdas. Se solicita radiografía de cadera que demuestra disminución del espacio articular, con algunos osteofitos acetabulares y esclerosis del hueso subcondral. El diagnóstico más probable es:

- a) Pelviespondilopatía seronegativa
- b) Artrosis
- c) Condrocalcinosis
- d) Necrosis avascular de la cabeza femoral
- e) Epifisiolisis femoral

7) ¿Cuál de las siguientes opciones NO es un criterio de lupus eritematoso sistémico?

- a) Fotosensibilidad
- b) Presencia de anticuerpos antinucleares
- c) Trombocitosis
- d) Psicosis
- e) Derrame pericárdico

8) Un paciente presenta dolor en la cara lateral del codo, mayor con la actividad, especialmente con

los movimientos habituales de pronosupinación. Al examen físico presenta dolor a la palpación de la zona, sin otras alteraciones. El diagnóstico más probable es:

- a) Artrosis de codo
- b) Epicondilitis
- c) Epitrocleítis
- d) Tendinitis tricipital
- e) Atrapamiento del nervio cubital

9) Un paciente de 60 años presenta astenia y debilidad muscular, especialmente de los grupos musculares proximales. El examen físico no aporta mayor información. En sus exámenes se constata hematocrito de 38%, leucocitos: 7.400, plaquetas: 370.000 y VHS: 90 mm/h. Presenta además CK normales, ANA(-) y ANCA(-). El diagnóstico más probable es:

- a) Fibromialgia
- b) Dermatomiositis
- c) Polimiositis
- d) Polimialgia reumática
- e) Micropoliangeítis (PAM)

10) ¿Cuál de las siguientes patologías es más frecuente en hombres que en mujeres?

- a) Dermatomiositis
- b) Espondilitis anquilosante
- c) Artritis reumatoide
- d) Artrosis
- e) Lupus eritematoso sistémico

11) Una paciente de 45 años presenta dolor y aumento de volumen de las articulaciones de las manos de un par de meses de evolución. Refiere que despierta con las manos rígidas y que demora entre media hora y una hora en poder movilizarlas normalmente. Al examen físico se observa artritis de una muñeca y de 3 articulaciones interfalángicas proximales en cada mano. El diagnóstico más probable es:

- a) Artritis reumatoide
- b) Lupus eritematoso sistémico
- c) Artrosis
- d) Espondiloartropatía seronegativa
- e) Esclerodermia

12) Seleccione la relación verdadera entre la raíz nerviosa afectada y su manifestación clínica:

- a) C5 – Imposibilidad de extender la muñeca
- b) C6 – Alteración del reflejo tricipital
- c) C7 – Debilidad a la flexión del codo
- d) L4 – Alteración del reflejo rotuliano
- e) S1 – Hipoestesia del primer orjejo

13) La conducta más adecuada, frente a un paciente con artritis aguda por cristales de ácido úrico, es:

- a) Iniciar AINEs endovenosos, colchicina y alopurinol por vía oral
- b) Iniciar AINEs por vía endovenosa e indicar reposo
- c) Iniciar AINEs orales y realizar infiltración local con corticoides
- d) Iniciar corticoides y alopurinol orales
- e) Iniciar AINES, solicitar uricemia, calcemia y decidir manejo según resultados

14) Un niño de 4 años presenta cojera de 1 día de evolución, sin otros síntomas. La madre refiere que no tiene patologías previas ni ha presentado traumatismos. Al examen físico se aprecia en buenas condiciones, con leve dolor a la rotación externa de la cadera izquierda, sin otros hallazgos. El diagnóstico más probable es:

- a) Artritis séptica
- b) Displasia de cadera
- c) Enfermedad de Perthes
- d) Epifisiolisis de la cabeza femoral
- e) Sinovitis transitoria

15) ¿Cuál de las siguientes NO suele ser una manifestación extra articular de la artritis reumatoide?

- a) Derrame pleural
- b) Mononeuritis múltiple
- c) Demencia
- d) Miocarditis
- e) Síndrome de Sjögren secundario

16) Una mujer de 35 años presenta artralgiás de manos y rodillas, asociadas a astenia, desde hace 3 meses. Al examen físico se observan úlceras orales no dolorosas y eritema facial. En sus exámenes generales destaca proteinuria, con hemograma normal. La conducta más adecuada, de entre las siguientes alternativas, es:

- a) Iniciar prednisona y ciclofosfamida por vía oral
- b) Iniciar tratamiento sintomático con AINEs
- c) Solicitar ANCA, factor reumatoideo y HLA-B27
- d) Iniciar alopurinol y prednisona en dosis bajas
- e) Solicitar ANA, anticuerpos anti-DNA de 2 hebras y complemento

17) ¿Cuál de las siguientes manifestaciones clínicas es más frecuente en los pacientes con esclerodermia sistémica limitada?

- a) Artritis de pequeñas articulaciones
- b) Fenómeno de Raynaud
- c) Eritema cutáneo
- d) Fibrosis pulmonar
- e) Insuficiencia renal

18) Un paciente de 33 años es diagnosticado de artritis séptica de cadera izquierda por estudio de líquido sinovial, con visualización de cocáceas Gram positivas dispuestas en racimo. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar cloxacilina oral e indicar uso de muletas, prohibiendo el apoyo de la extremidad
- b) Iniciar ceftriaxona endovenosa e indicar uso de muletas, prohibiendo el apoyo de la extremidad
- c) Iniciar vancomicina endovenosa y realizar aseo quirúrgico de la articulación
- d) Iniciar clindamicina oral y realizar aseo quirúrgico de la articulación
- e) Iniciar cefazolina endovenosa y realizar aseo quirúrgico de la articulación

19) Una paciente de 34 años, sin antecedentes de importancia, presenta dolor lumbar intenso, irradiado a la cara posterior del muslo y pierna derecha, hasta el talón, de 1 día de evolución y que apareció luego de levantar unas cajas de mercadería. El dolor es especialmente intenso con algunos movimientos y cede con el reposo. Al examen físico se aprecia movilidad lumbar limitada por dolor, especialmente a la flexión y signo de Lasegue, sin alteraciones en la sensibilidad ni movilidad distal. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar reposo en cama por 3 días y AINEs por vía intramuscular
- b) Iniciar AINEs por vía oral, e indicar reposo relativo
- c) Iniciar corticoides orales y solicitar electromiografía de extremidades inferiores
- d) Solicitar radiografía de columna lumbar y articulaciones sacroiliacas e iniciar tratamiento sintomático
- e) Solicitar resonancia magnética nuclear e iniciar AINEs por vía oral

20) ¿Cuál de las siguientes alteraciones NO suele encontrarse en la artrosis idiopática?

- a) Mano en ráfaga
- b) Nódulos de Bouchard
- c) Crepitación articular
- d) Derrame articular no inflamatorio
- e) Rigidez matinal de pocos minutos de duración

Prueba 3

1) El fenómeno de Raynaud es característico de la siguiente patología:

- a) Esclerodermia
- b) Dermatomiositis
- c) Síndrome de Sjögren
- d) Artritis reumatoide
- e) Artritis psoriática

2) Una paciente de 40 años presenta dolor en las manos desde hace 3 meses. Refiere marcada rigidez

articular, que dura cerca de una hora. Al examen físico se aprecia artritis de ambas muñecas y de varias articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales, de manera bilateral. El tratamiento de elección de la patología descrita es:

- a) Paracetamol
- b) Prednisona
- c) Ciclofosfamida + corticoides
- d) Alopurinol más AINEs
- e) Metotrexato

3) Un niño de 7 años presenta cojera de 3 semanas de evolución, con mínimo dolor. Al examen físico se aprecia dolor a la abducción máxima de la cadera izquierda, asociado a leve atrofia del cuádriceps izquierdo. El diagnóstico más probable es:

- a) Artritis séptica
- b) Sinovitis transitoria
- c) Epifisiolisis de la cabeza femoral
- d) Enfermedad de Perthes
- e) Síndrome de Osgood Schlatter

4) Un paciente de 65 años presenta astenia y debilidad muscular, especialmente al levantar los brazos y en la musculatura proximal de las extremidades inferiores. También refiere que presenta cefalea frecuente y dolor al masticar por mucho tiempo, lo que lo obliga a comer lento. En sus exámenes destaca anemia normocítica normocrómica, con VHS: 97 mm/h. El diagnóstico más probable es:

- a) Lupus
- b) Polimiositis
- c) Arteritis de células gigantes
- d) Poliangeítis microscópica
- e) Panarteritis nodosa

5) ¿Cuál de las siguientes no es una manifestación extraarticular de la artritis reumatoide?

- a) Glomerulonefritis
- b) Miocarditis
- c) Mononeuritis múltiple
- d) Epiescleritis
- e) Derrame pleural

6) Una paciente de 26 años presenta astenia, febrícula ocasional y baja de peso. En su examen físico sólo se ausculta un soplo carotídeo derecho y una clara asimetría de los pulsos radiales. El diagnóstico más probable es:

- a) Pelviespándiloartropatía con compromiso arterial
- b) Arteritis de células gigantes
- c) Enfermedad de Wegener
- d) Arteritis de Takayasu
- e) Lupus eritematoso sistémico

7) ¿Cuál de las siguientes asociaciones entre marcador inmunológico y patología es correcta?

- a) Hipocomplementemia – Artritis reumatoide
- b) Factor reumatoideo – Espondilitis anquilosante
- c) Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo en patrón citoplasmático – micropoliangeítis (PAM)
- d) Anticuerpos anticentrómero - Dermatomiositis
- e) Anticuerpos anti-ribonucleoproteína – Enfermedad mixta del tejido conectivo

8) La causa más frecuente de codo doloroso es:

- a) Epicondilitis
- b) Esguince
- c) Artrosis
- d) Atrapamiento cubital
- e) Tendinitis tricipital

9) Un paciente de 68 años, diabético e hipertenso, bien controlado, presenta dolor en la cadera

izquierda, desde hace algunos meses, lo que le dificulta la marcha. Al examen físico presenta dolor a la flexión y abducción extremas de la cadera. Se solicita radiografía de cadera que demuestra disminución del espacio articular y un osteofito acetabular. La conducta MÁS adecuada es:

- a) Solicitar anticuerpos antinucleares y factor reumatoideo
- b) Iniciar paracetamol
- c) Iniciar metotrexato
- d) Iniciar prednisona
- e) Iniciar diclofenaco

10) El test de Schirmer positivo es característico de:

- a) Enfermedad de Behcet
- b) Sarcoidosis
- c) Síndrome de CREST
- d) Dermatomiositis
- e) Síndrome de Sjögren

11) Una paciente de 45 años presenta dolor de larga data en el hombro derecho, que aumenta con la actividad y que en los últimos 10 días se ha hecho mucho más intenso, al punto que le impide la movilización. Al examen físico está en buenas condiciones, con signos vitales normales y presenta intenso dolor tanto a la movilización activa, como a la movilización pasiva del hombro, sin signos inflamatorios. El diagnóstico más probable es:

- a) Bursitis
- b) Tendinitis del manguito de rotador
- c) Artrosis
- d) Capsulitis adhesiva
- e) Tendinitis bicipital

12) Una paciente presenta artralgiás, con febrícula ocasional. Se solicita hemograma que demuestra hematocrito: 35%, VCM: 87, HCM: 32, blancos: 3.900, linfocitos: 25%, neutrófilos: 68%, monocitos: 7%, plaquetas: 53.000. El diagnóstico más probable es:

- a) Arteritis de la temporal
- b) Granulomatosis de Wegener
- c) Crioglobulinemia
- d) Lupus eritematoso sistémico
- e) Poliangeítis microscópica

13) ¿Cuál de las siguientes zonas son MENOS frecuentemente afectadas por artrosis?

- a) Muñecas
- b) Articulaciones interfalángicas proximales
- c) Articulaciones interfalángicas distales
- d) Rodillas
- e) Columna vertebral

14) Una paciente de 40 años, con antecedente de colon irritable, presenta fatigabilidad y dolores generalizados. En su examen físico presenta dolor a la palpación de los músculos del cuello, dorso, cara interna de las rodillas y cara lateral de los codos. El diagnóstico más probable es:

- a) Polimiositis
- b) Fibromialgia
- c) Polimialgia reumática
- d) Hipotoroidismo
- e) Lupus

15)Cuál de las siguientes asociaciones, entre marcador inmunológico y patología, es INCORRECTA:

- a) Anticuerpos anti-núcleo – Esclerodermia
- b) Anticuerpos anti-DNA de una hebra – Lupus por drogas
- c) Anticuerpos anti-Ro – Síndrome de Sjögren
- d) Anticuerpos anti-citoplasma de neutrófilo – Arteritis de la temporal
- e) Anticuerpos anti-proteína P – Psicosis lúpica

16) Un hombre de 67 años presenta dolor intenso y aumento de volumen del codo izquierdo, de 1 día

de evolución. Al examen físico se aprecia aumento de volumen, con derrame articular, eritema y aumento de la temperatura local. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar artrocentesis y solicitar estudio de líquido articular
- b) Iniciar AINES y colchicina
- c) Solicitar hemograma y hemocultivos
- d) Solicitar radiografía de codo izquierdo
- e) Solicitar cintigrafía ósea

17) ¿Cuál de las siguientes alteraciones NO suele aparecer en los pacientes con artritis reumatoide?

- a) Mano en ráfaga
- b) Dedos en cuello de cisne
- c) Dedos en sastre
- d) Nódulos de Heberden
- e) Nódulos reumatoideos

18) ¿Qué tratamiento debe indicar ante un paciente de 57 años que cursa actualmente con un ataque de gota, confirmado con el estudio pertinente?

- a) Alopurinol
- b) AINES
- c) Antibióticos y AINES
- d) Alopurinol y AINES
- e) Alopurinol, colchicina y AINES

19) Un paciente de 32 años presenta una rinosinusitis crónica de difícil manejo, asociado a epistaxis frecuente. En el último tiempo se agrega compromiso del estado general, fiebre, hematuria y oliguria. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Púrpura de Schönlein-Henoch
- b) Granulomatosis de Wegener
- c) Vasculitis de Churg-Strauss
- d) Lupus sistémico eritematoso
- e) Panarteritis nodosa

20) Una paciente de 20 años presenta malestar general, caída de cabello y lesiones faciales eritematosas. Al examen físico se aprecia eritema en los pómulos y en el dorso de la nariz y algunas úlceras en el paladar duro y en las mejillas. El diagnóstico más probable es:

- a) Dermatomiositis
- b) Vasculitis de vaso pequeño
- c) Lupus
- d) Enfermedad de Behcet
- e) Esclerodermia

Prueba 4 (REUMATOLOGÍA E INMUNOLOGÍA EN PEDIATRÍA)

1) Una niña de 5 años presenta fiebre intermitente de 3 semanas de evolución, acompañada en algunas oportunidades de un rash eritematoso macular, que compromete el tronco y la zona proximal de las extremidades que desaparece al ceder la fiebre. No presenta otros síntomas. Al examen físico se constata artritis de el tobillo derecho y de la tercera y cuarta articulaciones metacarpofalángica izquierdas. El diagnóstico más probable es:

- a) Lupus infantil
- b) Púrpura de Schoenlein Henoch
- c) Enfermedad de Kawasaki
- d) Artritis juvenil idiopática (Enfermedad de Still)
- e) Poliangeitis microscópica

2) El agente etiológico más frecuente de la artritis séptica en escolares es:

- a) Streptococcus pyogenes
- b) Streptococcus agalactiae
- c) Streptococcus pneumoniae
- d) Staphylococcus aureus
- e) Staphylococcus epidermidis

3) El mejor examen para evaluar el desarrollo de complicaciones y por tanto, el pronóstico de un

paciente con enfermedad de Kawasaki es:

- a) Anticuerpos anti-citoplasma de neutrófilo (ANCA)
- b) Hemograma-VHS
- c) Ecocardiograma
- d) Coronariografía
- e) Orina completa

4) Un lactante de 4 meses, con mal incremento ponderal ha presentado varios cuadros de neumonía y diarreas, de difícil tratamiento. Actualmente cursando síndrome diarreico. Al examen físico destaca presencia de alborracho y candidiasis anogenital. Un hermano falleció tempranamente por neumonía. El diagnóstico más probable es:

- a) Agamaglobulinemia ligada al sexo
- b) Déficit de complemento
- c) Inmunodeficiencia común variable
- d) Inmunodeficiencia combinada severa
- e) Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)

5) Un paciente de 14 años de edad tiene una historia desde la infancia de sinusitis de repetición, giardiasis y bronquitis crónica. Debemos sospechar:

- a) Síndrome de inmunodeficiencia adquirida
- b) Inmunodeficiencia común variable
- c) Alteración de los linfocitos T
- d) Agamaglobulinemia
- e) Agenesia esplénica

6) Un niño de 6 años, con una talla más corta que la que debería corresponder a su edad, aqueja dolores moderados de su cadera derecha y claudicación al correr. A la exploración se aprecia una discreta atrofia del muslo y existe una limitación de los movimientos de rotación interna y abducción. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Sinovitis transitoria de la cadera
- b) Artritis séptica
- c) Displasia de cadera
- d) Enfermedad de Perthes
- e) Epifisiolisis de la cabeza femoral

7) ¿Cuál de las siguientes vacunas puede administrarse a un paciente inmunodeprimido severo?

- a) Varicela
- b) Polio oral
- c) Hepatitis A
- d) Tríplica
- e) BCG

8) Un niño consulta por fiebre de 7 días de evolución, asociado a un rash papuloeritematoso generalizado. En el examen se observa eritema e inyección conjuntival. Los labios y la lengua están enrojecidos y aumentados de volumen. Se palpan 2 adenopatías cervicales anteriores, la mayor de ellas de 2,5 cm. Además se constata edema, eritema y fina descamación en ambos pies. El diagnóstico más probable es:

- a) Leucemia linfoblástica aguda
- b) Sarampión
- c) Escarlatina
- d) Púrpura de Schoenlein Henoch
- e) Enfermedad de Kawasaki

9) ¿Cuál de las siguientes glomerulonefritis NO cursan con hipocomplementemia?

- a) Glomerulonefritis lúpica
- b) Glomerulonefritis postestreptocócica
- c) Enfermedad de Berger
- d) Glomerulonefritis asociada a endocarditis subaguda
- e) Glomerulonefritis mesangiocapilar

10) Un adolescente de 14 años presenta artralgias de rodillas y tobillos, asociadas a un rash

eritematoso palpable en glúteos y piernas. Presenta además hematuria en 3 oportunidades y hematoquezia en una ocasión. El diagnóstico más probable es:

- a) Púrpura trombocitopénico inmune
- b) Púrpura trombocitopénico trombótico
- c) Púrpura de Schoenlein-Henoch
- d) Lupus infantil
- e) Infección por el virus de la inmunodeficiencia humana

11) ¿Cuál de los siguientes virus suelen producir artritis frecuentemente?

- a) Parotiditis y rubeola
- b) Enterovirus y virus herpes 6
- c) Virus varicela zóster y virus hepatitis A
- d) Rubeola y parvovirus B19
- e) Parotiditis y sarampión

12) Un niño de 8 años presenta artralgiyas y artritis de manos y pies, asociada a compromiso del estado general. El examen físico no aporta mayor información. En sus exámenes de laboratorio destaca elevación importante de la ferritina plasmática y elevación moderada de la PCR y VHS. El diagnóstico más probable es:

- a) Artritis por cristales
- b) Hemocromatosis
- c) Artritis viral
- d) Artritis reactiva
- e) Artritis juvenil idiopática

13) Un niño de 6 años sufre accidente en bicicleta, golpeándose el abdomen y resultando con rotura del bazo, por lo que es esplenectomizado. ¿Qué conducta adicional debe tomarse?

- a) Administrar inmunoglobulina genérica endovenosa cada 3 meses
- b) Vacuna antipneumocócica cada 5 años y antigripal anual
- c) Profilaxis antibiótica de endocarditis bacteriana durante procedimientos dentales, gastrointestinales y genitourinarios
- d) Control anual de PPD y profilaxis con isoniazida según resultados
- e) Refuerzo de BCG cada 3 años

14) Usted atiende a un recién nacido de 20 días de vida, nacido por cesárea, que se alimenta con fórmula y que es hijo de madre VIH positivo en terapia antirretroviral, con cargas virales bajas. Se realizó ELISA para VIH que resultó positivo. La conducta más adecuada es

- a) Solicitar nuevo ELISA inmediatamente
- b) Confirmar la infección con Western Blot
- c) Iniciar terapia antirretroviral
- d) Indicar vacunación anti-hepatitis B y BCG inmediatamente
- e) Tranquilizar a la madre y explicarle que con alta probabilidad corresponde a un falso positivo

15) ¿Cuál de las siguientes patologías es causada por autoinmunidad de tipo 1?

- a) Dermatitis herpetiforme
- b) Artritis juvenil idiopática
- c) Glomerulonefritis postestreptocócica
- d) Lupus infantil
- e) Rinitis alérgica

16) La causa más frecuente de artritis en la edad pediátrica es:

- a) Bacteriana
- b) Traumática
- c) Viral
- d) Degenerativa
- e) Autoinmune

17) Un lactante de 13 meses inicia fiebre y decaimiento. La madre refiere que dejó de caminar hace 24

horas. Al examen físico se observa decaído, febril hasta 39,7°C, con presión arterial normal y leve taquicardia. Presenta dolor a la movilización de la cadera izquierda. La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio con cefadroxilo oral y antipiréticos
- b) Iniciar antipiréticos, solicitar hemograma y radiografías de cadera izquierda y decidir manejo según hallazgos
- c) Solicitar hemograma, PCR y hemocultivos y realizar punción articular bajo ecografía
- d) Hospitalizar, solicitar hemograma y hemocultivos e iniciar vancomicina endovenosa
- e) Solicitar RMN de cadera e iniciar cloxacilina endovenosa

18) Un niño de 10 años ha presentado 3 meningitis meningocócicas, con buena respuesta al tratamiento antibiótico. ¿Qué examen estará alterado con mayor probabilidad?

- a) Inmunoglobulina A
- b) Inmunoglobulina G
- c) Subclases de inmunoglobulina G
- d) Subpoblaciones de linfocitos
- e) Complemento

19) ¿Cuál es la utilidad de las vacunas conjugadas?

- a) Permiten desarrollar inmunidad contra antígenos proteicos en menores de 5 años
- b) Permiten desarrollar inmunidad contra antígenos polisacáridos en mayores de 5 años
- c) Permiten desarrollar inmunidad contra antígenos proteicos en menores de 2 años
- d) Permiten desarrollar inmunidad contra antígenos polisacáridos en menores de 2 años
- e) Permiten desarrollar inmunidad en pacientes inmunodeprimidos que tienen contraindicadas las vacunas no conjugadas

20) Un niño de 3 años presenta cojera de 2 días de evolución. No ha presentado otros síntomas. Al examen físico se observa en buenas condiciones generales, afebril, con signos vitales normales. Presenta dolor a la abducción y rotación externa de la cadera derecha, sin otras alteraciones. El diagnóstico más probable es:

- a) Sinovitis transitoria de la cadera
- b) Artritis séptica
- c) Displasia de cadera
- d) Enfermedad de Osgood-Schlatter
- e) Epifisiolisis de la cabeza femoral

1) Un paciente de 70 años consulta por dolor inguinal izquierdo, de larga data, que aparece al caminar y que se ha vuelto más intenso en las últimas semanas, limitando sus actividades habituales. Al examen físico presenta dolor a la movilización de la cadera izquierda, sin signos inflamatorios. Se realiza una radiografía de cadera, que muestra marcada disminución del espacio articular, asociado a esclerosis subcondral y presencia de osteofitos acetabulares. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar factor reumatoideo, anticuerpos antinucleares y anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo.
- b) Iniciar paracetamol oral e indicar ejercicios de fortalecimiento de cuádriceps
- c) Iniciar AINES orales e indicar reposo relativo
- d) Indicar inmovilización con yeso
- e) Indicar kinesioterapia motora y controlar en 3 meses

2) Un paciente de 45 años presenta un cuadro diarreico autolimitado. Diez días después inicia cuadro de dolor lumbar, artritis de rodillas y manos, asociados a ojo rojo profundo y disuria. El diagnóstico más probable es:

- a) Púrpura trombocitopénico trombótico
- b) Síndrome de Reiter
- c) Enfermedad de Behcet
- d) Vasculitis de Wegener
- e) Crioglobulinemia

3) Una paciente de 20 años consulta por fiebre, astenia, artralgias y hematuria. Al examen físico se aprecia artritis de manos, sin otras alteraciones. En sus exámenes generales destaca elevación de la creatinina hasta 2,1 mg/dl y hematuria dismórfica. El diagnóstico más probable es:

- a) Esclerodermia
- b) Crioglobulinemia
- c) Poliangeítis microscópica
- d) Lupus
- e) Artritis reumatoide

4) La asociación de asma, eosinofilia y hematuria dismórfica es característica de:

- a) Granulomatosis de Wegener
- b) Vasculitis de Churg Strauss
- c) Púrpura de Schoenlein-Henoch
- d) Síndrome de Good-Pasture
- e) Panarteritis nodosa

5) ¿Cuál de los siguientes cuadros clínicos es más sugerente de una artritis reumatoide?

- a) Mujer de 45 años con artritis de varias de las articulaciones interfalángicas proximales y metacarpofalángicas de ambas manos, asociadas a rigidez matinal de 2 horas de evolución.
- b) Mujer de 30 años con artritis de rodilla derecha, codo izquierdo y articulaciones interfalángicas proximales, asociadas a nódulos eritematosos palpables en extremidades inferiores
- c) Mujer de 70 años con artritis de las rodillas, caderas y hombros, asociadas a rigidez matinal de 50 minutos
- d) Mujer de 60 años con artralgias crónicas de manos, asociada a rigidez matinal de pocos minutos de duración
- e) Mujer de 55 años con dolores articulares de ambas manos, de varios meses de evolución, asociado a aumento de volumen de consistencia dura en las articulaciones interfalángicas proximales y distales

6) Un paciente de 25 años consulta por dolor lumbar de 4 meses de evolución, que es mayor en la mañana y se asocia a rigidez matinal, cediendo a medida que realiza actividad física. Al examen físico presenta marcada dificultad para flexionar la columna, llegando a tocar sólo las rodillas con las extremidades inferiores extendidas. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar aines y reposo relativo, indicando control en caso de recurrencia
- b) Iniciar analgésicos, relajantes musculares y kinesioterapia
- c) Solicitar radiografía de columna lumbosacra
- d) Solicitar RMN de columna lumbosacra
- e) Iniciar corticoides orales y ejercicios

7) Los pacientes con esclerodermia sistémica limitada (CREST) suelen desarrollar:

- a) Fibrosis pulmonar
- b) Accidentes vasculares encefálicos
- c) Cáncer
- d) Hipertensión pulmonar
- e) Uveítis

8) ¿Cuál de las siguientes asociaciones es CORRECTA entre el marcador inmunológico y la patología?

- a) Anticuerpos anti-RNP - Esclerodermia
- b) Anticuerpos anti-Jo1 - Esclerodemia
- c) Anticuerpos anti-SRP - Dermatomiositis
- d) Anticuerpos anti-Ro – Lupus por drogas
- e) Anticuerpos anti-centrómero - Polimiositis

9) El tratamiento de elección de la artritis reumatoide es:

- a) Paracetamol
- b) AINES
- c) Prednisona
- d) Metotrexato
- e) Prednisona + ciclofosfamida

10) Un hombre de 63 años presenta astenia y debilidad de los hombros, siéndole especialmente difícil realizar actividades como peinarse o mantener los brazos levantados. En sus exámenes destaca hemograma con VHS: 87 mm/h, sin alteraciones en las líneas celulares. El diagnóstico más probable es:

- a) Arteritis de la temporal
- b) Polimialgia reumática
- c) Fibromialgia
- d) Polimiositis
- e) Arteritis de Takayasu

11) Un paciente de 67 años consulta por dolor de la rodilla, de 2 semanas de evolución. Al examen físico se aprecia derrame articular, que se punciona, dando salida a un líquido transparente, amarillento, filante, con 540 células por mm³, de predominio mononuclear, proteínas normales y glucosa normal, sin otras alteraciones. El diagnóstico más probable es:

- a) Artritis tuberculosa
- b) Artritis por cristales
- c) Artritis reumatoide
- d) Artritis séptica
- e) Artrosis

12) ¿Cuál de las siguientes es una manifestación extraarticular de la artritis reumatoide?

- a) Glomerulonefritis
- b) Accidente vascular encefálico
- c) Miocarditis
- d) Neuritis óptica
- e) Pioderma gangrenoso

13) Identifique la asociación CORRECTA entre la patología del codo y la manifestación clínica:

- a) Codo del tenista (epicondilitis) – Dolor a la palpación de la inserción proximal de los músculos flexores del antebrazo
- b) Codo del golfista (epitrocleítis) – Dolor a la palpación de la cara lateral del codo
- c) Tendinitis bicipital – Dolor a la palpación de la cara medial del codo
- d) Tendinitis tricipital – Dolor a la palpación de la zona proximal del olécranon
- e) Atrapamiento cubital – Dolor y debilidad a la flexión de los dedos pulgar, índice y medio

14) Una mujer de 50 años consulta por dolor del hombro derecho, que aumenta con los movimientos.

Refiere además dolor nocturno y al examen físico destaca dolor importante a la abducción contra resistencia del brazo. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio de esta paciente?

- a) Radiografía de hombro AP y axial
- b) Ecografía de hombro
- c) Cintigrafía
- d) Tomografía axial computada de hombro
- e) Resonancia magnéticanuclear de hombro

15) Un paciente de 68 años consulta por dolor intenso de la rodilla izquierda, de 4 horas de evolución, asociado a aumento de volumen. Al examen físico se aprecia enrojecimiento, aumento de la temperatura local y derrame articular, con intenso dolor a la movilización activa y pasiva de la articulación. Se solicita radiografía de rodilla, que muestra una línea de calcificación del cartílago articular y se realiza estudio del líquido sinovial, demostrándose la presencia de abundantes cristales con birrefringencia de elongación positiva. La tinción de Gram no visualiza bacterias. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar drenaje articular y administrar analgésicos y bifosfonatos
- b) Indicar reposo e iniciar analgésicos y bifosfonatos
- c) Indicar reposo e iniciar analgésicos y sulfato de magnesio
- d) Indicar reposo e iniciar analgésicos y antibióticos empíricos
- e) Indicar reposo e iniciar analgésicos

16) Un paciente con lumbociática, presenta irradiación del dolor por la cara posterior del muslo y la pierna, hasta el 5° ortojo, con debilidad para la flexión plantar y disminución del reflejo aquileano. La raíz nerviosa afectada es:

- a) L3
- b) L4
- c) L5
- d) S1
- e) S2

17) Un hombre de 30 años presenta una monoartritis aguda del codo izquierdo, la que se punciona, mostrando un líquido articular inflamatorio, con visualización de abundantes cócáceas Gram positivas. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar drenaje articular y administrar cloxacilina
- b) Iniciar flucloxacilina oral
- c) Realizar drenaje articular y administrar vancomicina
- d) Iniciar AINEs e indicar reposo
- e) Realizar drenaje articular y administrar ceftriaxona

18) ¿Cuál de los siguientes medicamentos está contraindicado en los pacientes con gota?

- a) Hidroclorotiazida
- b) Enalapril
- c) Losartán
- d) Nifedipino
- e) Atenolol

19) Una mujer de 28 años consulta por astenia y fiebre ocasional. En una oportunidad presentó una hemiparesia izquierda de instalación súbita y 20 minutos de duración, que cedió de manera espontánea. Al examen físico se constata disminución del pulso radial derecho. El diagnóstico más probable es:

- a) Arteritis de células gigantes
- b) Lupus
- c) Panarteritis nodosa
- d) Granulomatosis de Wegener
- e) Arteritis de Takayasu

20) ¿En qué patología debe pensar ante un niño de 3 años con claudicación de la marcha de un día de

evolución, por dolor en una cadera, que se ve de buen aspecto y no presenta signos inflamatorios?

- a) Artritis séptica
- b) Displasia de cadera
- c) Enfermedad de Perthes
- d) Sinovitis transitoria
- e) Epifisiolisis de la cabeza femoral

1) Un paciente de 22 años consulta por dolor lumbar de algunas semanas de evolución, asociados a rigidez matinal, que aumenta con el reposo y cede con la actividad física. Se solicita radiografía de zona lumbosacra, que muestra signos de sacroileítis, con calcificación de los ligamentos longitudinales. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar resonancia magnética nuclear de columna lumbar
- b) Indicar ejercicios e iniciar AINEs por vía oral
- c) Iniciar corticoides orales e indicar ejercicios
- d) Indicar reposo e iniciar hidroxycloquina
- e) Resolver de modo quirúrgico

2) Un paciente con antecedente de asma de difícil manejo y eosinofilia, consulta por malestar general, fiebre, artralgias y hematuria. Se solicita sedimento de orina que muestra hematuria dismórfica y clearance de creatinina que resulta 44 ml/min. El diagnóstico más probable es:

- a) Lupus eritematoso sistémico
- b) Esclerodermia sistémica difusa
- c) Panarteritis nodosa
- d) Vasculitis alérgica de Churg-Strauss
- e) Vasculitis granulomatosa de Wegener

3) Una paciente de 65 años se realiza una radiografía lumbar que muestra osteopenia radiológica, por lo que se solicita una densitometría ósea que muestra T-score: -2,1 y un Z-score: -0,9. El diagnóstico más probable es:

- a) Sana
- b) Osteopenia
- c) Osteoporosis postmenopáusica
- d) Osteoporosis secundaria
- e) Enfermedad de Paget

4) Un paciente de 35 años, consulta por dolor cervical intenso, de inicio brusco, irradiado al hombro derecho y que inició en relación a levantar unos sacos de cemento. Al examen físico se aprecia disminución de la sensibilidad en la zona deltoidea derecha y cierta debilidad para abducir el brazo. La raíz más probablemente afectada es:

- a) C5
- b) C6
- c) C7
- d) C8
- e) T1

5) Un niño de 14 años, obeso, consulta por dolor en la ingle izquierda, que aparece al caminar y que ha ido aumentando en los últimos días, obligándolo a cojear. Al examen físico se aprecia dolor a la movilización de la cadera. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Sinovitis transitoria
- b) Necrosis avascular de la cabeza femoral
- c) Enfermedad de Perthes
- d) Artritis séptica
- e) Epifisiolisis de la cabeza femoral

6) Un paciente de 67 años consulta por dolor intenso en la rodilla izquierda, de 2 horas de evolución. Al examen se aprecia aumento de volumen, eritema y aumento de la temperatura local de la rodilla izquierda y la radiografía muestra una línea de calcificación en el cartilago articular. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar AINEs e indicar reposo
- b) Solicitar calcemia y niveles plasmáticos de PTH
- c) Iniciar alopurinol y colchicina
- d) Realizar punción articular y estudio de líquido sinovial
- e) Resolver de manera quirúrgica

7) Una mujer de 19 años consulta por astenia, artralgias y fiebre ocasional. Se visualiza artritis de

manos y se solicitan exámenes generales entre los que destaca un hemograma, con Hcto: 37%, plaquetas: 140.000 x mm³, glóbulos blancos: 5.000 x mm³, neutrófilos: 80%, monocitos: 10% y linfocitos: 10%. El diagnóstico más probable es:

- a) Lupus sistémico
- b) Leucemia
- c) Poliangeítis microscópica
- d) Enfermedad reumática
- e) Artritis reumatoídea

8) Una paciente de 40 años consulta por artralgias de algunas semanas de evolución. Al examen físico se aprecia artritis de la rodilla izquierda, el tobillo derecho y algunas articulaciones metatarsofalángicas, con presencia de dactilitis de 3 ortejos. El diagnóstico más probable es:

- a) Artritis por cristales
- b) Lupus
- c) Artritis psoriática
- d) Artritis reumatoide
- e) Artritis viral

9) Un hombre de 70 años consulta por astenia, fiebre y cefalea de algunas semanas de evolución. Refiere claudicación mandibular y que se cansa, especialmente al levantar los brazos y realizar actividades como peinarse. El diagnóstico más probable es:

- a) Fibromialgia
- b) Polimiositis
- c) Polimialgia reumática
- d) Arteritis de células gigantes
- e) Poliangeítis microscópica

10) Una paciente de 50 años, dueña de casa, consulta por dolor en el hombro derecho, insidioso, que aumenta al realizar actividades como limpiar muebles o trapear el piso y además suele presentarse en la noche. Al examen físico presenta dolor a la abducción contra resistencia del brazo, sin otras alteraciones. El diagnóstico más probable es:

- a) Artritis séptica
- b) Artrosis de hombro
- c) Capsulitis adhesiva
- d) Tendinitis del manguito rotador
- e) Bursitis

11) Una mujer de 60 años consulta por artralgias de las manos de varios meses de evolución, asociadas a rigidez matinal de 10 minutos de duración. Al examen físico se aprecian nódulos de Heberden. El diagnóstico más probable es:

- a) Lupus
- b) Artritis reumatoide
- c) Artrosis
- d) Esclerodermia
- e) Enfermedad mixta del tejido conectivo

12) El lupus inducido por drogas suele presentar:

- a) Anticuerpos anti-DNA de doble hebra
- b) Anticuerpos anti-proteína P
- c) Anticuerpos anti-Ro
- d) Anticuerpos anti-histona
- e) Anticuerpos anti-ribonucleoproteína

13) La arteritis de Takayasu se manifiesta con todo lo siguiente, EXCEPTO:

- a) Glomerulonefritis
- b) Artralgias
- c) Fiebre
- d) Accidente vascular encefálico
- e) Asimetría de los pulsos radiales

14) En un adolescente con síntomas de artritis séptica del tobillo derecho se realiza estudio de líquido

sinovial que muestra un aspecto turbio, poco filante, con células 85.000 x mm³, con 95% de polimorfonucleares y visualización de abundantes cocáceas Gram negativas intracelulares. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar penicilina benzatina
- b) Iniciar flucloxacilina oral
- c) Iniciar cloxacilina endovenosa y realizar drenaje quirúrgico
- d) Iniciar vancomicina endovenosa y realizar drenaje quirúrgico
- e) Iniciar ceftriaxona endovenosa y realizar drenaje quirúrgico

15) Un paciente adulto mayor, con dolor crónico de rodilla se realiza una radiografía que muestra disminución simétrica del espacio articular, asociada a esclerosis ósea subcondral. El diagnóstico más probable es:

- a) Artrosis
- b) Pelviespondiloartropatía
- c) Condrocalcinosis
- d) Gota
- e) Artritis reumatoide

16) Una paciente de 30 años presenta fenómeno de Raynaud intenso y recurrente, asociado a sensación de tirantez de la cara. El diagnóstico más probable es:

- a) Dermatomiositis
- b) Esclerodermia
- c) Enfermedad mixta del tejido conectivo
- d) Síndrome de Sjögren
- e) Lupus cutáneo subagudo

17) Una paciente de 40 años presenta poliartritis crónica de manos, asociada a elevación del factor reumatoideo. La radiografía de manos demuestra artritis con lesiones en sacabocado bilaterales, en varias articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar paracetamol
- b) Iniciar AINEs
- c) Iniciar prednisona
- d) Iniciar metotrexato
- e) Iniciar prednisona + ciclofosfamida

18) ¿Cuál de las siguientes es una manifestación de la artritis reumatoide?

- a) Sacroileítis
- b) Hematuria
- c) Pericarditis
- d) Trombocitopenia
- e) Úlceras orales

19) La fibromialgia se caracteriza por:

- a) Asociarse a anemia
- b) Asociarse a cáncer
- c) Presentar elevación de la VHS
- d) Dolor a la presión de las masas musculares
- e) Presentar positividad de los anticuerpos antinucleares

20) Una paciente presenta eritema violáceo en los párpados superiores, asociado a eritema sobre los hombros y la parte superior del tórax. Además refiere debilidad de las masas musculares proximales.

¿Qué marcado se encontrará alterado con mayor probabilidad?

- a) Anticuerpos anti-citoplasma de neutrófilo
- b) Anticuerpos antinucleares
- c) Factor reumatoideo
- d) Creatinina
- e) Complemento

1) ¿Qué anticuerpo es más sensible para el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico?

- a) Anti-DNA de una hebra
- b) Anti-DNA de dos hebras
- c) Anti-Sm
- d) Anti-nucleares
- e) Anti-citoplasma de neutrófilo

2) ¿Cuál de las siguientes es una complicación frecuente de la espondilitis anquilosante?

- a) Uveítis aguda
- b) Accidente vascular encefálico
- c) Pericarditis
- d) Mononeuritis múltiple
- e) Disfagia

3) Un paciente de 25 años consulta por dolor en la rodilla izquierda, que inició luego de realizar una excursión por la montaña. Al examen físico se aprecia dolor a la palpación de la zona medial del extremo proximal de la tibia, 2 cm bajo la interlínea articular. El diagnóstico más probable es:

- a) Esguince de ligamento colateral medial
- b) Tendinitis de la fascia lata
- c) Síndrome de Osgood-Schlatter
- d) Tendinitis de la pata de ganso
- e) Lesión meniscal medial

4) ¿Cuál de los siguientes corresponde a un signo de alarma en un lumbago agudo?

- a) Inicio súbito
- b) Dolor intenso, que limita las actividades de la vida diaria
- c) Irradiación del dolor por debajo de la rodilla
- d) Antecedente de episodios previos de lumbago agudo
- e) Fiebre sin causa clara

5) ¿Cuál de los siguientes datos clínicos o de laboratorio representa un PEOR pronóstico en una paciente que inicia con un artritis reumatoide?

- a) Mayor edad
- b) Obesidad
- c) Leucocitosis
- d) Anemia
- e) Exantema

6) La asociación de oligoartritis asimétrica, dactilitis y placas cutáneas eritematosas y descamativas es propia de:

- a) Artritis psoriática
- b) Panarteritis nodosa
- c) Crioglobulinemia
- d) Dermatomiositis
- e) Esclerodermia

7) Una paciente consulta por astenia, debilidad muscular y aparición de eritema violeta en los párpados superiores. Se diagnostica una dermatomiositis con los exámenes diagnósticos adecuados. ¿Qué examen(es) debe(n) realizarse dirigidamente?

- a) Colonoscopia, radiografía de tórax y mamografía
- b) Fondo de ojo y ecocardiografía
- c) Coronariografía
- d) Manometría esofágica
- e) Endoscopia digestiva alta y fracción excretada de sodio

8) Un paciente de 43 años presenta artralgiyas de 5 meses de evolución, que han ido en aumento.

Refiere dolor de las manos, las muñecas, los tobillos y las rodillas, que se asocian a marcada rigidez matinal de cerca de 90 minutos de duración. Al examen físico se constata artritis de ambas muñecas de la mayoría de las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales y de la rodilla izquierda. El tratamiento de primera línea es:

- a) Indometacina
- b) Metotrexato
- c) Prednisona
- d) Ciclofosfamida
- e) Paracetamol

9) Un hombre de 67 años consulta por dolor intenso en la rodilla izquierda, de algunas horas de duración. No ha sufrido traumatismos y al examen se aprecia aumento de volumen, eritema y aumento de la temperatura local de la articulación. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar hemograma, factor reumatoideo, ANA y ANCA
- b) Iniciar AINEs
- c) Iniciar AINEs y alopurinol
- d) Realizar punción articular y solicitar estudio de líquido sinovial
- e) Iniciar antibióticos endovenosos y derivar a drenaje articular quirúrgico

10) El examen más adecuado para iniciar el estudio de un hombro doloroso es:

- a) Radiografía anteroposterior y axial de hombro
- b) Radiografía anteroposterior bilateral comparativa
- c) Tomografía axial computada
- d) Resonancia magnética nuclear
- e) Ecotomografía

11) Una paciente de 24 años consulta por astenia, artralgias y fiebre ocasional. Trae un hemograma en el que destaca linfopenia y proteinuria. El diagnóstico más probable es:

- a) Granulomatosis de Wegener
- b) Poliangeítis microscópica
- c) Panarteritis nodosa
- d) Arteritis de células gigantes
- e) Lupus eritematoso sistémico

12) Un hombre de 66 años consulta por astenia, cefalea y fiebre ocasional. Refiere que en ocasiones presenta claudicación mandibular durante la masticación. El examen físico no aporta mayor información y entre sus exámenes trae un hemograma con Hematocrito: 29%, VCM: 90 fl, HCM: 30 pg, blancos: 8.500 x mm³, plaquetas: 380.000 x mm³, VHS: 96 mm/h. El diagnóstico más probable es:

- a) Arteritis de Takayasu
- b) Pelviespondilopatía seronegativa
- c) Arteritis de células gigantes
- d) Lupus
- e) Poliangeítis microscópica

13) Una paciente presenta dolor lumbar intenso de inicio súbito, irradiado a la extremidad inferior izquierda, recorriendo la cara lateral del muslo, la piel sobre la rótula y la cara medial de la pierna, hasta el maléolo medial. Al examen presenta debilidad a la extensión de la pierna y a la dorsiflexión del pie. El reflejo rotuliano se encuentra disminuido. La raíz afectada es:

- a) L3
- b) L4
- c) L5
- d) S1
- e) S2

14) Un paciente de 65 años consulta por dolor de la rodilla izquierda de algunos meses de evolución,

que aparece con la marcha y cede con el reposo. En el último tiempo el dolor se ha hecho más intenso, limitando sus actividades habituales. Al examen físico no se observan signos inflamatorios y la radiografía de rodilla muestra disminución del espacio articular y esclerosis ósea subcondral. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar resonancia magnética nuclear
- b) Iniciar paracetamol oral
- c) Iniciar prednisona oral
- d) Iniciar AINEs endovenosos
- e) Iniciar AINEs y colchicina

15) ¿Qué medida es MENOS importante para prevenir la recurrencia de artritis por ácido úrico?

- a) Iniciar alopurinol
- b) Iniciar diuréticos
- c) Iniciar probenecid
- d) Disminuir la ingesta de alcohol
- e) Disminuir la ingesta de carnes rojas

16) Un paciente de 23 años consulta por dolor lumbar de 3 semanas de evolución, asociado a rigidez matinal, mayores en la mañana y que cede con la actividad física. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Raquiestenosis
- b) Artritis reumatoide
- c) Espondilosis degenerativa
- d) Espondilitis anquilosante
- e) Lumbago mecánico

17) ¿Qué marcador suele alterarse con mayor frecuencia en la dermatomiositis?

- a) Complemento
- b) Factor reumatoideo
- c) Velocidad de sedimentación hemática
- d) Anticuerpos antinucleares
- e) Creatinfosfoquinasa

18) Una paciente de 66 años consulta por artralgiyas de manos de algunos meses de evolución, asociados a rigidez matinal de 20 minutos aproximadamente. Al examen físico se aprecia aumento de volumen de consistencia dura, sin signos inflamatorios en la mayoría de las articulaciones interfalángicas proximales y distales de ambas manos. El diagnóstico más probable es:

- a) Artrosis
- b) Artritis reumatoide
- c) Artritis psoriática
- d) Lupus sistémico
- e) Esclerodermia

19) Los anticuerpos anti-ribonucleoproteína (Anti-RNP) se asocian a:

- a) Esclerodermia
- b) Dermatomiositis
- c) Enfermedad mixta del tejido conectivo
- d) Lupus por drogas
- e) Síndrome de Sjögren

20) Un paciente de 67 años consulta por artralgiyas y fiebre de 3 días de evolución, asociados a hematuria y oliguria importante. En sus exámenes generales se aprecia hematuria dismórfica, elevación de la creatinina hasta 3,5 mg/dl, anticuerpos antinucleares negativos y anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos positivos en patrón perinuclear. El diagnóstico más probable es:

- a) Poliangeítis microscópica
- b) Panarteritis nodosa
- c) Vasculitis granulomatosa de Wegener
- d) Vasculitis alérgica de Churg-Strauss
- e) Arteritis de la temporal

Prueba 8
Ver ENDOCRINOLOGÍA, DIABETES Y NUTRICIÓN, Prueba 6

Prueba 9
Ver ENDOCRINOLOGÍA, DIABETES Y NUTRICIÓN, Prueba 8

Prueba 10
Ver ENDOCRINOLOGÍA, DIABETES Y NUTRICIÓN, Prueba 12

REUMATOLOGÍA RESPUESTAS

Dr. Guillermo Guevara Aliaga

Prueba 1	5 E	9 B	14 E	16 D	20 D
1 A	6 B	10 E	15 E	17 A	Prueba 7
2 C	7 C	11 D	16 B	18 A	1 D
3 B	8 B	12 D	17 C	19 E	2 A
4 A	9 D	13 A	18 E	20 D	3 D
5 E	10 B	14 B	19 D		4 E
6 D	11 A	15 D	20 A	Prueba 6	5 A
7 C	12 D	16 A	Prueba 5	1 B	6 A
8 B	13 B	17 D	1 B	2 D	7 A
9 B	14 E	18 B	2 B	3 B	8 B
10 D	15 C	19 B	3 D	4 A	9 D
11 C	16 E	20 C	4 B	5 E	10 E
12 C	17 B	Prueba 4	5 A	6 D	11 E
13 E	18 E	1 D	6 C	7 A	12 C
14 D	19 B	2 D	7 D	8 C	13 B
15 C	20 A	3 C	8 C	9 D	14 B
16 D		4 D	9 D	10 D	15 B
17 D	Prueba 3	5 B	10 B	11 C	16 D
18 B	1 A	6 D	11 E	12 D	17 D
19 C	2 E	7 C	12 C	13 A	18 A
20 A	3 D	8 E	13 D	14 E	19 C
Prueba 2	4 C	9 C	14 B	15 A	20 A
1 D	5 A	10 C	15 E	16 B	
2 D	6 D	11 D		17 D	
3 C	7 E	12 E		18 C	
4 D	8 A	13 B		19 D	

VIII) INFECTOLOGÍA PRUEBAS

Prueba 1

1) Paciente de 75 años, diabético, con buen control metabólico, consulta por cuadro de tres días de evolución, de tos, con expectoración y fiebre hasta 38,7°C. En el último día se agrega confusión. Al examen físico se aprecia paciente decaído, desorientado, Glasgow 14, PA:120/70, FC:119x', FR:28x', t°:38,9. En la auscultación pulmonar se aprecian crépitos en base derecha. Se constata radiografía de tórax con condensación en lóbulo inferior derecho, sin derrame pleural. Los gases arteriales demuestran PO2:78, PCO2:34, Bic:19, pH:7,35, a FiO2 ambiental. El tratamiento antibiótico de elección es:

- a) Amoxicilina más ácido clavulánico
- b) Claritromicina
- c) Ceftriaxona más claritromicina
- d) Ceftriaxona sola
- e) Ceftazidina más vancomicina

2) Un paciente de 56 años consulta por intenso dolor en rodilla derecha. Al examen se aprecia rodilla derecha eritematosa, caliente y aumentada de volumen. Se realiza artrocentesis, con salida de líquido turbio, poco filante. El estudio citológico demuestra más de 100.000 células, con 90% de polimorfonucleares. La microscopía demuestra cristales escasos de pirofosfato de calcio y la tinción de Gram demuestra cocáceas gran positivas en racimo. El tratamiento de elección es:

- a) Drenaje quirúrgico, asociado a Vancomicina endovenosa
- b) Drenaje quirúrgico, asociado a Cloxacilina endovenosa
- c) Cefazolina endovenosa, en dosis altas
- d) Drenaje quirúrgico y tratamiento antibiótico intraarticular
- e) Cefadroxilo por vía oral

3) Paciente de 3 años, sin vacunaciones previas, es traída por su madre por presentar convulsiones y fiebre. Al examen se aprecia paciente en regulares condiciones generales, febril, hemodinámicamente estable, con signos meníngeos positivos y parálisis del cuarto nervio craneal derecho. Se realiza punción lumbar que da salida a líquido turbio, con 500 células, 86% de mononucleares, proteínas aumentadas y glucosa de un 20% respecto a la glucosa plasmática. La tinción de Gram y tinta china resultan negativas. El diagnóstico más probable es:

- a) Meningitis bacteriana aguda
- b) Meningoencefalitis viral (enterovirus)
- c) Meningitis tuberculosa
- d) Meningococcemia
- e) Panencefalitis esclerosante subaguda

4) Una arsenalera sufre un accidente cortopunzante con un aguja de sutura, durante una cirugía de herniorrafia de un paciente con promiscuidad sexual. No se cuentan con exámenes previos sobre posibilidad de infección por VIH. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar zidovudina oral
- b) Iniciar triterapia antirretroviral inmediatamente
- c) Solicitar serología viral al paciente y a la arsenalera y actuar según resultados, sin iniciar medicamentos
- d) Solicitar serología viral sólo al paciente y actuar según los resultados, sin iniciar medicamentos
- e) No realizar exámenes ni administrar terapia alguna, ya que los accidentes con aguja de sutura son de mínimo riesgo de transmisión de VIH

5) Un paciente de 49 años, consulta por ictericia y compromiso del estado general. Se constata hiperbilirrubinemia de predominio directo y transaminasas elevadas. Se solicita serología de distintos virus causantes de hepatitis, con el siguiente resultado: HBsAg(-), HBsAc(+), HBeAc(+), Ig total antiVHC(-), IgM VHA(-), IgG VHA(+), IgM CMV(+), IgG CMV(-), IgM VCA(+), IgG VCA(-). ¿Cuál es, entre las siguientes, la causa más probable de la hepatitis?:

- a) Infección conjunta por VHA y VHB
- b) Infección conjunta por CMV y VHB
- c) Infección conjunta por VEB y CMV
- d) Infección aislada por VHB
- e) Infección conjunta por VEB y VHA

6) Paciente obeso de 33 años, consulta por dolor en extremidad inferior derecha y fiebre. Al examen se aprecia placa eritematosa, rojo brillante, de 10 cm de diámetro, con bordes bien definidos, indurada y

dolorosa a la palpación. Se observa además un cordón eritematoso, de 1 cm de ancho y 15 cm de largo, que asciende hasta el muslo y se palpan adenopatías inguinales ipsilaterales, dolorosas. El agente etiológico más probable es:

- a) Pseudomona aureginosa
- b) Staphylococcus aureus
- c) Strptococcus pyogenes
- d) Escherichia coli
- e) Haemophilus sp.

7) La complicación más frecuente de la varicela, en un niño de 5 años, es:

- a) Cerebelitis
- b) Neumonía
- c) Sobreinfección de las lesiones por cocáceas Gram positivas
- d) Síndrome de Reye
- e) Rabdomiolisis

8) El tratamiento de elección para la sífilis secundaria es:

- a) Penicilina G endovenosa
- b) Penicilina benzatina intramuscular
- c) Ceftriaxona endovenosa
- d) Eritromicina oral
- e) Ciprofloxacino oral

9) El tratamiento de elección de la pediculosis en los niños escolares es actualmente:

- a) Permetrina al 1%
- b) Permetrina al 5%
- c) Lindano
- d) Vaselina azufrada
- e) Ivermectina

10) El antibiótico de elección para tratar infecciones causadas por Staphylococcus aureus resistente a la cloxacilina es:

- a) Cefazolina
- b) Ceftriaxona
- c) Vancomicina
- d) Clindamicina
- e) Flucloxacilina

11) ¿Cuál de las siguientes vacunas se puede administrar a una paciente embarazada?

- a) Varicela
- b) Sarampión
- c) BCG
- d) Antitetánica
- e) Polio oral

12) Paciente VIH, en tratamiento antirretroviral irregular. Su último recuento de linfocitos CD4(+) fue de 102, hace un año. Actualmente cursando un cuadro de deterioro del estado general, asociado a hemiparesia braquiocrural derecha y a convulsión tónico clónica en 2 ocasiones. Se realiza RMN de cerebro que muestra una lesión subcortical frontal izquierda de 1 cm de diámetro, con captación de contraste en anillo, asociada a 3 lesiones similares, más pequeñas en zona parietal izquierda. El diagnóstico más probable es:

- a) Leucomalacia multifocal progresiva
- b) Toxoplasmosis cerebral
- c) Meningoencefalitis criptocócica
- d) Linfoma cerebral primario
- e) Encefalitis por mycobacterias

13) Paciente de 21 años, es traído por sus familiares por presentar un cuadro de 2 días de evolución de fiebre alta, asociado a compromiso del estado general y cefalea intensa, al que luego se agrega

conducta paranoide y confusión, seguido de convulsión tonicoclónica y disminución cuantitativa de conciencia. El examen físico no aporta mayor información, excepto por dudosa rigidez de nuca. Se realiza TAC de cerebro que muestra lesiones temporales bilaterales. La conducta más adecuada, además de aplicar medidas de soporte, es:

- a) Iniciar cefalosporinas de tercera generación, asociadas a vancomicina
- b) Solicitar punción lumbar con estudio citoquímico de LCR y PCR para herpes simplex y decidir manejo según resultados
- c) Iniciar aciclovir endovenoso inmediatamente y solicitar estudio de LCR, que incluya PCR para virus herpes simplex
- d) Administrar corticoides endovenosos, en altas dosis, asociados a antibióticos de amplio espectro
- e) Iniciar anticoagulación inmediata con heparina, asociando ceftriaxona y ganciclovir

14) Paciente de 45 años, con neumonía tratada con amoxicilina desde hace 5 días. Evoluciona con diarrea. Se solicitan toxinas de clostridium difficile en heces, que resultan positivas. La conducta más apropiada es:

- a) Suspender amoxicilina + clavulánico
- b) Iniciar vancomicina oral
- c) Iniciar metronidazol oral
- d) Iniciar clindamicina oral
- e) Iniciar ceftriaxona endovenosa

15) Adolescente de 15 años, consulta por fiebre, mialgias y exantema muy pruriginosos. Al examen se aprecia paciente febril, en buenas condiciones, con exantema papulo-pustular que compromete cabeza, tronco y extremidades. Se observan costras en cuero cabelludo y escasas vesículas en troco. El diagnóstico más probable es:

- a) Impétigo buloso
- b) Eritema infeccioso
- c) Síndrome pie-mano-boca
- d) Sífilis secundaria
- e) Varicela

16) Paciente de 12 años, consulta por fiebre, odinofagia intensa y compromiso del estado general. Al examen físico destaca faringe muy eritematosa, con exudado amigdalino blanco, adherente y múltiples adenopatías cervicales sensibles. Se inicia amoxicilina oral, evolucionando con exantema macular eritematoso en tronco y extremidades. El diagnóstico más probable es:

- a) Escarlatina
- b) Mononucleosis infecciosa
- c) Leucemia
- d) Primoinfección por citomegalovirus
- e) Herpangina

17) Hombre de 40 años, mapuche, vive en la novena región. Consulta por cuadro de 2 días de evolución de fiebre y mialgias generalizadas, muy intensas, en especial al mover los ojos. No ha presentado otros síntomas y el examen físico no aporta mayor información. Se realiza hemograma que demuestra Hematocrito:38%, Plaquetas:230.000, Blancos:12.100, linfocitos:22%, Neutrófilos:45%, Eosinófilos:27%, Basófilos:1%, Monocitos:5%. El diagnóstico más probable es:

- a) Hidatidosis
- b) Larva migrante visceral
- c) Distomatosis
- d) Triquinosis
- e) Ascariasis

18) El examen de elección ante la sospecha de fiebre tifoidea en un paciente con 10 días de síntomas es:

- a) Hemocultivo
- b) Biopsia de médula ósea
- c) Coprocultivo
- d) IgM e IgG para Salmonella typhi
- e) El examen físico

19) Paciente VIH (+), con bajo recuento de linfocitos CD4, consulta por diarrea acuosa, sin sangre, de 6 semanas de evolución, asociada a baja de peso de 3 kg. El diagnóstico más probable es:

- a) Diarrea por *Cryptosporidium*
- b) Infección por *Isospora belli*
- c) Infección por *Mycobacterium avium* complex
- d) Malabsorción intestinal por VIH
- e) Diarrea por fármacos antirretrovirales

20) Un paciente diagnosticado de leucemia mieloide aguda, recibe quimioterapia, evolucionando al quinto día, con leucopenia, con recuento de neutrófilos menor a 500 cels/mm³. Presenta fiebre hasta 38,7°C, sin otros síntomas. El examen físico y los exámenes radiológicos, de orina y de sangre, no aportan mayor información. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar ceftriaxona más vancomicina
- b) Iniciar ceftazidina más amikacina
- c) Controlar diariamente exámenes de sangre y orina y decidir según resultados
- d) Administrar cotrimoxazol en una dosis diaria, por 3 veces a la semana, hasta que ceda la leucopenia
- e) Iniciar amoxicilina más ciprofloxacino

Prueba 2

1) Un paciente VIH, sin tratamiento antirretroviral, presenta cefalea, asociado a paresia de la extremidad inferior derecha. Presenta una convulsión tónico-clónica en una oportunidad. El examen físico no aporta mayor información. El examen que con mayor probabilidad dará el diagnóstico es:

- a) Tinción de Gram, cultivo y citoquímico de LCR
- b) Tinta china y citoquímico de LCR
- c) TAC de cerebro
- d) Electroencefalograma
- e) Serología para toxoplasma

2) ¿Cuál de las siguientes medidas le parece más adecuada para la prevención del contagio de enfermedades de transmisión sexual, en una mujer sexualmente activa, sin pareja estable?

- a) Uso de anticonceptivos orales
- b) Uso de antibióticos profilácticos
- c) Vacunación contra el virus papiloma
- d) Uso de preservativo durante las relaciones sexuales
- e) Instalación de un dispositivo intrauterino

3) Un paciente de 20 años, cursando con una osteomielitis aguda, evoluciona con fiebre, gran decaimiento, eritrodermia y marcada hipotensión, asociada a taquicardia, que no responde a la administración de suero fisiológico. Los hemocultivos resultan negativos. El diagnóstico más probable es:

- a) Shock séptico
- b) Fasciitis necrotizante
- c) Endocarditis aguda
- d) Infección conjunta de *Estafilococo aureo* y *Streptococo pyogenes*
- e) Shock tóxico estafilocócico

4) Un paciente de 35 años sufre accidente de tránsito, resultando con un traumatismo encéfalo craneano abierto. Se somete a neurocirugía, con buenos resultado, sin embargo a los 4 días, evoluciona con fiebre, cefalea y signos meníngeos, por lo que se realiza punción lumbar y se solicita estudio de líquido cefalorraquídeo, que es compatible con una meningitis bacteriana aguda, sin poder visualizarse bacterias. El tratamiento antibiótico empírico más adecuado es:

- a) Ceftriaxona + penicilina
- b) Ampicilina + cefotaximo
- c) Cefazolina + metronidazol
- d) Ceftazidima + vancomicina
- e) Gentamicina + ampicilina

5) Un niño de 6 años presenta un cuadro de 2 días de evolución de odinofagia y fiebre hasta 38,5°C. Evoluciona luego con un exantema papular, generalizado. Al examen físico se observa faringe

eritematosa, con algunas petequias y exudado amigdalino bilateral, grisáceo. Además presenta una lengua saburral, con demarcación de las papilas y un exantema papular, eritematoso, con algunas petequias lineales en los pliegues cubitales. El agente causal más probable es:

- a) Staphylococcus aureus
- b) Streptococcus pyogenes
- c) Parvovirus B19
- d) Virus herpes 6
- e) Enterovirus

6) Una paciente de 60 años, sin antecedentes de importancia, hospitalizada por una fractura de pelvis, tratada quirúrgicamente, evoluciona al 4to día con fiebre alta y malestar general, a lo que luego se le agrega disnea. Al examen se aprecia febril y decaída, presenta FC: 100x', PA: 110/40 mmHg, MP+ con escasos crépitos bibasales, RR2T con un soplo diastólico intenso. Los pulsos se palpan saltones. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar hemograma, PCR, hemocultivos y ecocardiografía
- b) Solicitar hemograma, PCR y radiografía de tórax
- c) Iniciar ceftriaxona endoveosa
- d) Solicitar cultivo de la punta de los catéteres intravasculares que tenga
- e) Iniciar vancomicina más imipenem por vía endovenosa

7) Un paciente de 50 años, con antecedente de EPOC tabáquico, bien controlado, con uso de broncodilatadores y hábito tabáquico suspendido hace 5 años, presenta un cuadro de tos con expectoración mucopurulenta, asociada a fiebre y dolor tipo puntada de costado izquierdo. No presenta mayor disnea de la habitual. Al examen físico está en buenas condiciones generales, con signos vitales normales y satura 94% a FiO2 ambiental. Tiene un MP(+), con espiración prolongada y se ausculta algunas sibilancias difusas y crepitaciones localizadas en la base pulmonar derecha. Se solicita radiografía de tórax que demuestra una zona de condensación en el lóbulo inferior izquierdo, sin derrame pleural. La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio con amoxicilina oral
- b) Enviar a domicilio con amoxicilina más ácido clavulánico oral
- c) Hospitalizar con ceftriaxona endovenosa
- d) Hospitalizar con ceftriaxona más claritromicina
- e) Solicitar cultivo de expectoración y decidir tratamiento antibiótico según resultado

8) Un niño de 5 años presenta una placa alopecica de 4 cm en el cuero cabelludo. Al examen se observan pelos quebrados en la placa y ligera descamación. El tratamiento más adecuado para la patología descrita es:

- a) Terbinafina tópica
- b) Fluconazol oral
- c) Griseofulvina oral
- d) Permetrina oral
- e) Permetrina tópica

9) La manifestación clínica más frecuente de los pacientes portadores del virus de la inmunodeficiencia humana es:

- a) Neumonía por Pneumocystis jirovecii
- b) Síndrome mononucleósico
- c) Candidiasis mucocutáneas
- d) Adenopatías palpables
- e) Infecciones respiratorias altas a repetición

10) Las lesiones características de la escabiosis son:

- a) Placas eritematosas en tiro al blanco
- b) Pápulas y vesículas en tronco y zona distal de las extremidades
- c) Placas con borde arciforme y tendencia a la curación central
- d) Vesículas perladas y surcos
- e) Pseudopápulas y escoriaciones

11) Un paciente de 5 años presenta un cuadro de 3 días de evolución de fiebre, decaimiento y odinofagia. Al examen físico se observa faringe eritematosa, con exudado amigdalino adherente. Se

palpan varias adenopatías cervicales y presenta esplenomegalia. El diagnóstico más probable es:

- a) Infección por VIH
- b) Mononucleosis infecciosa
- c) Amigdalitis pultácea
- d) Linfoma
- e) Infección por adenovirus

12) ¿Cuál de las siguientes alteraciones es más específica para una sinusitis aguda?

- a) Radiografía de senos paranasales, con velamiento de un seno maxilar
- b) Obstrucción nasal
- c) Descarga posterior
- d) Visualización de salida de pus desde el meato medio
- e) Sensación de presión facial

13) Un niño de 8 años presenta malestar general y odinofagia. Al examen físico se observan vesículas en el paladar blando, algunas ulceradas. Presenta además vesículas en las palmas de las manos. El agente causal es:

- a) Virus varicela zóster
- b) Enterovirus
- c) Parvovirus B19
- d) Virus herpes 8
- e) Virus herpes 6

14) Un paciente de 56 años, proveniente de Temuco, presenta ictericia, dolor abdominal y fiebre. Al examen físico se observa icterico, con el hígado palpable 3 cms bajo el reborde costal, sensible. En el hemograma destaca una eosinofilia de 25%. El diagnóstico más probable es:

- a) Hepatitis A
- b) Leptospirosis
- c) Hidatidosis
- d) Distomatosis
- e) Triquinosis

15) ¿Cuál de las siguientes opciones es un tratamiento válido para una pielonefritis aguda?

- a) Metronidazol
- b) Amoxicilina
- c) Macrodantina
- d) Cefazolina
- e) Clindamicina

16) Una mujer de 26 años, cursando su segundo embarazo, de 29 semanas, presenta fiebre hasta 39° C, asociada a leucorrea. Al examen físico presenta t°: 38,7°, FC: 110x', PA: 120/80. Destaca sensibilidad a la palpación uterina y a la especuloscopia se aprecia que la leucorrea proviene del OCE. El registro fetal muestra FCF: 170x', sin otros signos de SFA. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar corticoides y antibióticos de amplio espectro e interrumpir el embarazo en 48 horas
- b) Iniciar antibióticos de amplio espectro y mantener una conducta expectante
- c) Realizar una amniocentesis de inmediato
- d) Iniciar antibióticos de amplio espectro, por vía endovenosa e interrumpir el embarazo por una vía expedita
- e) Realizar cesárea de urgencia, de inmediato

17) Un paciente presenta elevación persistente de las transaminasas. Se solicitan serologías virales que demuestran: IgM VHA (-), IgG VHA (+), Ags VHB (-), Acs VHB (+), IgM anticore VHB (-), IgG anticore VHB (+), anticuerpos totales anti VHC (+), IgM VCA (-), IgG VCA (-), IgM CMV (-), IgG CMV (-). La etiología más probable de su hepatitis es:

- a) Hepatitis A
- b) Hepatitis A y B
- c) Hepatitis A, B y C
- d) Hepatitis B y C
- e) Hepatitis C

18) Un paciente de 35 años presenta aumento de volumen y dolor de la rodilla izquierda y al examen físico se constata eritema, aumento del calor local y derrame articular. Se realiza artrocentesis que da

salida a un líquido articular turbio, de filancia disminuida, con 90.000 células por mm³, 92% de polimorfonucleares. En la tinción de Gram se visualizan cocáceas Gram negativas intracelulares. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar ceftriaxona endovenosa y realizar drenaje quirúrgico
- b) Administrar cefazolina intraarticular
- c) Iniciar vancomicina endovenosa y realizar drenaje quirúrgico
- d) Iniciar azitromicina oral y drenar el derrame, mediante artrocentesis repetidas
- e) Iniciar cloxacilina endovenosa y realizar drenaje quirúrgico

19) ¿Cuál de las siguientes vacunas puede usarse durante el embarazo?

- a) Varicela
- b) Rubeola
- c) DPT
- d) Polio oral
- e) Antineumocócica

20) Un paciente de 56 años, obeso, presenta fiebre y dolor en la extremidad inferior derecha. Al examen se aprecia una placa eritematosa de 15 cm en la pierna derecha, ligeramente sensible a la palpación, de bordes difíciles de delimitar. La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio con ciprofloxacino más clindamicina por vía oral
- b) Solicitar cultivo de la lesión
- c) Hospitalizar e iniciar cloxacilina endovenosa
- d) Hospitalizar e iniciar ceftriaxona endovenosa
- e) Enviar a domicilio con eritromicina oral

Prueba 3

1) Un paciente con VIH, que no sigue tratamiento antirretroviral, consulta por diarrea. Su último recuento de CD4 fue hace 2 años y en ese momento era de 210 células por mm³. Refiere que está con diarrea desde hace 3 meses, que sus deposiciones son acuosas, sin elementos patológicos. El agente etiológico más probable de su cuadro es:

- a) Criptococo
- b) Criptosporidium
- c) Toxoplasma
- d) Mycobacterium avium complex
- e) Virus de la inmunodeficiencia humana

2) Un paciente portador de una leucemia linfática aguda, consulta por fiebre y malestar general. Al examen físico sólo presenta palidez. Se solicita hemograma que muestra un hematocrito: 27%, blancos: 20.000, con 2% de neutrófilos, 66% de linfocitos y 32% de blastos, plaquetas: 52.000. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar estudio para VIH y realizar exámenes de laboratorio en busca de un foco infeccioso
- b) Iniciar quimioterapia y vancomicina y realizar exámenes de laboratorio en busca de un foco infeccioso
- c) Iniciar cefazolina + metronidazol y realizar exámenes de laboratorio en busca de un foco infeccioso
- d) Iniciar ceftriaxona + ampicilina y realizar exámenes de laboratorio en busca de un foco infeccioso
- e) Iniciar ceftazidina + gentamicina y realizar exámenes de laboratorio en busca de un foco infeccioso

3) Un paciente de 35 años presenta disuria intensa y secreción uretral. Refiere haber tenido relaciones sexuales sin protección. Se solicita un Gram de secreción uretral, que demuestra la presencia de cocáceas Gram negativas intracelulares, por lo que se le administra ceftriaxona 250 mg por vía intramuscular. Dos semanas después reconsulta por persistir con los mismos síntomas. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar urocultivo y sedimento de orina
- b) Iniciar corticoides
- c) Administrar ceftriaxona 1 g por una vez, por vía intramuscular
- d) Administrar ciprofloxacino 500 mg por una vez, por vía oral
- e) Iniciar doxiciclina por 10 días, por vía oral

4) ¿Cuál de las siguientes asociaciones entre microorganismo y patología es FALSA?

- a) Staphylococcus aureus – Celulitis orbitaria

- b) Streptococcus pyogenes – Escarlatina
- c) Streptococcus pyogenes – Erisipela
- d) Staphylococcus aureus – Antrax cutáneo
- e) Staphylococcus aureus – Síndrome de piel escaldada

5) Un paciente de 4 años presenta un cuadro compatible con una meningitis aguda, por lo que se realiza una punción lumbar, que da salida a líquido turbio, con glucosa baja y marcado aumento de la celularidad, de predominio polimorfonuclear. La tinción de Gram demuestra bacilos Gram negativos.

El agente más probable es:

- a) Neumococo
- b) Listeria
- c) Meningococo
- d) Escherichia coli
- e) Leptospira

6) ¿Cuál de las siguientes es una indicación quirúrgica en la endocarditis bacteriana?

- a) Endocarditis sobre estenosis mitral previa
- b) Infección por estafilococo dorado metilino resistente
- c) Presencia de vegetaciones
- d) Insuficiencia cardíaca progresiva
- e) Endocarditis sobre cardiopatía congénita

7) Un paciente cursando su 4 día post accidente vascular encefálico, presenta fiebre y tos con expectoración. Se realiza una radiografía de tórax que muestra una condensación de tipo neumónica en el lóbulo inferior izquierdo. ¿Qué tratamiento es más adecuado?

- a) Cefazolina + clindamicina
- b) Amoxicilina
- c) Levofloxacino
- d) Ceftriaxona + claritromicina
- e) Cefotaximo + metronidazol

8) La onicomicosis se debe tratar preferentemente con:

- a) Terbinafina oral
- b) Griseofulvina oral
- c) Nistatina tópica
- d) Clotrimazol tópico
- e) Anfotericina B endovenosa

9) Cuando un paciente en quien se sospecha infección por VIH, presenta un test de ELISA positivo, éste debe confirmarse con un Western Blot. Esto se debe a que:

- a) El Western Blot permite detectar aquellos pacientes que estaban en el período de ventana
- b) El Western Blot mide directamente las proteínas virales, mientras que el ELISA sólo mide anticuerpos
- c) El ELISA presenta falsos positivos, especialmente por reacción cruzada a otros virus, como el HTLV-1 y el Western Blot los descarta
- d) El ELISA es menos sensible que el Western Blot
- e) El Western Blot es menos sensible que el ELISA

10) Una niña de 5 años es traída por su madre, ya que ella piensa que tiene piojos, porque se rasca la cabeza muy frecuentemente, desde hace un par de semanas. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar lindano tópico
- b) Indicar permetrina tópica al 1%
- c) Indicar corte de cabello
- d) Indicar antihistamínicos y permetrina oral
- e) Revisar el cabello y cuero cabelludo, en busca de liendres y lesiones

11) ¿Cuál es la conducta más adecuada ante un paciente de 4 años que nunca se ha vacunado?

- a) Administrar la vacuna BCG ahora, las vacunas DPT, Hib, VHB y polio oral en un mes y la vacuna trivírica

en 2 meses más

- b) Administrar la vacuna BCG, trivírica, DPT, Hib, VHB y polio oral, todas juntas
- c) Administrar las vacunas trivírica y BCG ahora y las vacunas DPT, Hib, VHB y polio oral en un mes más
- d) Administrar la vacuna DPT solamente
- e) Administrar la vacuna DT y trivírica

12) Un niño de 5 años presenta un cuadro de decaimiento, fiebre escasa, asociado a eritema de ambas mejillas. A los 3 días presenta un exantema macular eritematoso, que compromete el tronco y las zonas proximales de las extremidades, con un patrón reticular. El diagnóstico más probable es:

- a) Rubéola
- b) Exantema inespecífico por enterovirus
- c) Quinta enfermedad
- d) Exantema súbito
- e) Sarampión

13) ¿Cómo se contrae la hidatidosis?

- a) Por consumo de carne de cerdo o cordero, contaminada
- b) Por contacto con deposiciones humanas
- c) Por contacto con deposiciones de perro
- d) Por consumo de berros contaminados
- e) Por consumo de pescado contaminado

14) Una paciente de 38 años, cursando con una pielonefritis por Escherichia coli multisensible inicia tratamiento antibiótico, con adecuada cobertura, sin embargo 5 días después permanece febril, con disuria y dolor lumbar. La conducta más adecuada es:

- a) Cambiar el tratamiento antibiótico por uno de mayor cobertura
- b) Solicitar una tomografía axial computada
- c) Mantener el tratamiento antibiótico y reevaluar en 2 días
- d) Solicitar ecografía
- e) Solicitar nuevo urocultivo y decidir según antibiograma

15) La leucorrea por candida se caracteriza por:

- a) Leucorrea blanquecina, asociada a disuria intensa
- b) Leucorrea amarilla verdosa, asociada a vulva en fresa
- c) Leucorrea blanquecina de mal olor, con sólo escasos signos inflamatorios de la pared vaginal
- d) Leucorrea blanca, grumosa, asociada a prurito vulvar
- e) Leucorrea blanca, grumosa, asociada a cervicitis

16) Respecto a la artritis séptica es FALSO que:

- a) El agente causal más frecuente es el Staphylococcus aureus
- b) Generalmente se manifiesta como una monoartritis aguda
- c) El líquido articular presenta una disminución de su filancia
- d) La punción articular es muy importante para el diagnóstico
- e) El drenaje quirúrgico se reserva para aquellos casos que no responden al tratamiento antibiótico endovenoso

17) Una mujer de 33 años, inmunodeprimida, presenta varias lesiones solevantadas, de menos de 5 mm de diámetro, con una umbilicación central, en tronco, cabeza y extremidades, no dolorosas, ni pruriginosas. El resto del examen físico sólo demuestra candidiasis oral. El diagnóstico más probable es:

- a) Condiloma
- b) Candidiasis cutánea
- c) Prurigo
- d) Molusco contagioso
- e) Angiomatosis basilar (*Bartonella henselae*)

18) Una paciente de 40 años presenta lesiones vulvares rugosas, polipoideas, indoloras, especialmente en los labios mayores y menores. El agente causal más probable es:

- a) Virus Herpes simplex 2
- b) Virus papiloma humano, serotipos 11 y 6
- c) Pox virus
- d) Ureaplasma urealyticum
- e) Chlamydia trachomatis

19) Un paciente de 6 años inicia diarrea, asociada a fiebre, dolor abdominal tipo cólico y decaimiento. Al segundo día la diarrea se vuelve mucosanguinolenta. Al examen físico está decaído, febril, sin deshidratación ni compromiso hemodinámico. La conducta más adecuada es:

- a) Hospitalizar, administrar suero fisiológico e iniciar ceftriaxona endovenosa
- b) Hospitalizar e iniciar ciprofloxacino endovenoso
- c) Enviar a domicilio con hidratación oral, antiespasmódicos y antidiarreicos
- d) Enviar a domicilio con hidratación oral y cotrimoxazol, indicando antiespasmódicos en caso de dolor
- e) Enviar a domicilio con régimen hídrico y solicitar hemograma, hemocultivos y test de detección de rotavirus en deposiciones

20) El tratamiento de elección para la sífilis primaria, en los pacientes alérgicos a la penicilina, es:

- a) Ciprofloxacino
- b) Tetraciclina
- c) Macrólidos
- d) Clindamicina
- e) Sales de mercurio

Prueba 4

1) Una paciente de 35 años, consulta por flujo genital, abundante, de mal olor. A la especuloscopia se observa leucorrea grisácea, de mal olor, con ausencia de signos inflamatorios en las paredes vaginales. El agente etiológico más probable es:

- a) Trichomona vaginalis
- b) Candida albicans
- c) Bacterias anaerobias
- d) Neisseria gonorrhoeae
- e) Escherichia coli

2) Un niño de 5 años presenta un cuadro de decaimiento, fiebre escasa, asociado a eritema de ambas mejillas. A los 3 días presenta un exantema macular eritematoso, que compromete el tronco y las zonas proximales de las extremidades, con un patrón reticular. El diagnóstico más probable es:

- a) Rubéola
- b) Exantema inespecífico por enterovirus
- c) Quinta enfermedad
- d) Exantema súbito
- e) Sarampión

3) Un paciente de 70 años es traído por su familia por un cuadro de decaimiento marcado, asociado a fiebre alta y luego desorientación. En su examen físico se aprecia desorientado, en regulares condiciones, con signos meníngeos positivos. Se realiza una punción lumbar y se solicita estudio de LCR, con 150.000 células por mm³, con 92% de polimorfonucleares, proteínas de 95 mg/dl y glucosa de 20 mg/dl. La conducta más adecuada, además de ofrecer soporte, es:

- a) Realizar tinción de Gram y cultivo de LCR, administrar corticoides endovenosos y decidir tratamiento antibiótico según hallazgos
- b) Iniciar tratamiento empírico con cefazolina, metronidazol y corticoides endovenosos
- c) Iniciar tratamiento empírico con ceftriaxona, ampicilina y corticoides endovenosos
- d) Iniciar tratamiento empírico con cloxacilina, gentamicina y corticoides endovenosos
- e) Iniciar tratamiento empírico con cefotaximo y corticoides endovenosos

4) Un niño de 11 meses presenta irritabilidad y decaimiento, asociados a fiebre hasta 38,2°C. Al examen físico presenta vesículas en el paladar blando, varias de ellas ulceradas, con tendencia a

confluir, asociado a algunas adenopatías cervicales anteriores. El diagnóstico más probable es:

- a) Mononucleosis infecciosa
- b) Amigdalitis pultácea
- c) Primoinfección herpética
- d) Herpangina
- e) Difteria

5) Un paciente de 10 años presenta un cuadro de odinofagia y fiebre hasta 39,5°C. Al examen físico se observa eritema faríngeo asociado a exudado amigdalino blanco adherente. Presenta adenopatías cervicales bilaterales y bazo palpable 2 cm bajo el reborde costal. Se solicita hemograma que muestra leucocitosis de 17.000, con 75% de linfocitos, algunos de ellos atípicos. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar ceftriaxona endovenosa
- b) Iniciar aciclovir oral
- c) Administrar penicilina benzatina intramuscular
- d) Iniciar AINEs y solicitar IgM VCA
- e) Solicitar cultivo faríngeo

6) Un paciente de 44 años presenta varias úlceras confluentes y dolorosas en el glande, asociadas a adenopatías inguinales. El diagnóstico más probable es:

- a) Sífilis primaria
- b) Herpes genital
- c) Linfogranuloma venéreo
- d) Chancroide
- e) Condiloma acuminado

7) Una paciente de 30 años presenta un cuadro de tos con expectoración, asociada a fiebre y disnea, de 3 días de evolución y cuyos síntomas han ido empeorando. Al examen físico se aprecia bastante taquipneica y se auscultan crépitos en la base pulmonar derecha y en la mitad superior del campo pulmonar izquierdo. Se solicita radiografía de tórax que es compatible con una neumonía multilobar, con compromiso de los lóbulos medio e inferior derecho y superior izquierdo. El tratamiento antibiótico más adecuado es:

- a) Amoxicilina
- b) Amoxicilina más ácido clavulánico
- c) Ceftriaxona
- d) Ceftriaxona + levofloxacino
- e) Gentamicina + vancomicina

8) El tratamiento de elección de la onicomicosis es:

- a) Clotrimazol tópico
- b) Terbinafina oral
- c) Fluconazol oral
- d) Terbinafina tópica
- e) Griseofulvina oral

9) Un paciente presenta desde hace 6 semanas tos persistente, con expectoración mucopurulenta, asociados a fiebre intermitente y baja de peso de 4 kilogramos. Al examen físico presenta crepitaciones y estertores en ambos ápices pulmonares. La radiografía de tórax muestra áreas de fibrosis y retracción en los ápices pulmonares. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar ceftriaxona endovenosa
- b) Solicitar tinción de Gram y cultivo de lavado bronquioloalveolar
- c) Iniciar cloxacilina endovenosa
- d) Solicitar baciloscopías y cultivo para mycobacterias
- e) Iniciar clindamicina endovenosa

10) El agente etiológico más frecuente de la artritis séptica en los niños es:

- a) Estafilococo dorado
- b) Estreptococo betahemolítico grupo A
- c) Estreptococo betahemolítico grupo B
- d) Gonococo
- e) Neumococo

11) Un paciente de 47 años, obeso, se realiza una herida en la pierna derecha mientras realizaba deporte. Evoluciona con eritema, dolor y aumento de volumen de la zona. Al examen físico está febril,

con una placa eritematosa de 10 cm de diámetro, con bordes difíciles de definir, asociado a adenopatías inguinales ipsilaterales. El tratamiento más adecuado es:

- a) Cloxacilina
- b) Ceftriaxona
- c) Amoxicilina
- d) Clindamicina
- e) Ciprofloxacino

12) Un paciente de 20 años presenta un cuadro de un día de evolución de fiebre marcada y decaimiento seguido de actitud agresiva y desorientación. Finalmente presenta una convulsión. Al examen físico está febril, soporoso, sin signos focales. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar aciclovir endovenoso y solicitar TAC cerebral y estudio de líquido cefalorraquídeo, que incluya PCR para virus herpes
- b) Realizar punción lumbar y solicitar citoquímico, gram y cultivo de líquido cefalorraquídeo, decidiendo tratamiento según hallazgos
- c) Iniciar antibióticos de amplio espectro por vía endovenosa y solicitar citoquímico, gram y cultivo de líquido cefalorraquídeo
- d) Solicitar TAC de cerebro y decidir manejo según hallazgos
- e) Iniciar corticoides endovenosos, antibióticos de amplio espectro y solicitar resonancia magnética nuclear de cerebro

13) ¿Cuál de los siguientes tratamientos es el más adecuado para una amigdalitis pultácea?

- a) Amoxicilina + ibuprofeno
- b) Ciprofloxacino + diclofenaco
- c) Gentamicina + ibuprofeno
- d) Cefotaximo + ketoprofeno
- e) Metronidazol + paracetamol

14) El tratamiento más adecuado para una infección del tracto urinario febril, cuyo urocultivo está pendiente es:

- a) Nitrofurantoina
- b) Moxifloxacino
- c) Cefradina
- d) Clindamicina
- e) Claritromicina

15) El examen de elección ante la sospecha de fiebre tifoidea, con 10 días de síntomas, es:

- a) Hemocultivo
- b) Biopsia de médula ósea
- c) Coprocultivo
- d) IgM e IgG para Salmonella typhi
- e) El examen físico

16) La sospecha clínica de hepatitis A, se confirma con:

- a) PCR para VHA
- b) Antígeno de superficie y anticuerpos anti-core de tipo IgM
- c) Anticuerpos totales para VHA
- d) IgM para VHA
- e) Pruebas hepáticas

17) Un paciente de 20 años presenta un cuadro de fiebre y decaimiento, con aparición de un exantema vesiculopustular generalizado y pruriginoso, que inició en la cabeza, comprometiendo el cuero cabelludo. Al examen físico se observan algunas lesiones como pústulas y otras como costras. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar IgM para varicela e iniciar tratamiento sintomático
- b) Iniciar aciclovir oral y tratamiento sintomático
- c) Indicar tratamiento sintomático con clorfenamina y paracetamol
- d) Iniciar aspirina y ceterizina
- e) Iniciar corticoides orales

18) Un paciente de 40 años presenta un cuadro clínico compatibles con una meningitis aguda. El análisis citoquímico es compatible con una meningitis bacteriana aguda y la tinción de Gram demuestra

cocáceas gram positivas. El agente más probable es:

- a) Meningococo
- b) Haemophilus
- c) Listeria
- d) Estáfilococo aureo
- e) Neumococo

19) Ante la sospecha clínica de sífilis secundaria se debe:

- a) Solicitar FTA-ABS o MHA TP
- b) Administrar penicilina benzatina intramuscular
- c) Iniciar una cefalosporina de tercera generación
- d) Solicitar VDRL o RPR
- e) Iniciar un macrólido

20) El tratamiento antibiótico de elección para un paciente que presenta una celulitis periorbitaria, sin compromiso de la agudeza visual, oculomotilidad ni de los reflejos oculares, es:

- a) Cefazolina
- b) Piperacilina + tazobactam
- c) Vancomicina
- d) Penicilina
- e) Ceftriaxona

Prueba 5

1) Un paciente de 34 años presenta algorra en la cavidad bucal y refiere haber bajado 4 Kg de peso en los últimos 3 meses. El examen físico no aporta mayor información. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar cultivo para hongos de hisopado bucal e iniciar fluconazol oral
- b) Solicitar ELISA para VIH
- c) Solicitar carga viral para VIH
- d) Solicitar Westernblot para VIH
- e) Solicitar recuento de linfocitos CD4

2) Un niño de 3 años presenta prurito anal importante. La madre visualizó un pequeño gusanito en la zona perianal. El tratamiento de elección es:

- a) Prazicuantel
- b) Metronidazol
- c) Cotrimoxazol
- d) Mebendazol
- e) Benzinidazol

3) ¿Cuál de los siguientes antibióticos puede ser ocupado para tratar infecciones por Staphylococcus aureus sensible a la meticilina, con mejor respuesta?

- a) Cefazolina
- b) Ceftriaxona
- c) Metronidazol
- d) Amoxicilina
- e) Azotromicina

4) Un paciente portador de una leucemia linfática aguda, consulta por fiebre y malestar general. Al examen físico sólo presenta palidez. Se solicita hemograma que muestra un hematocrito: 27%, blancos: 20.000, con 2% de neutrófilos, 66% de linfocitos y 32% de blastos, plaquetas: 52.000. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar estudio para VIH y realizar exámenes de laboratorio en busca de un foco infeccioso
- b) Iniciar quimioterapia y vancomicina y realizar exámenes de laboratorio en busca de un foco infeccioso
- c) Iniciar cefazolina + metronidazol y realizar exámenes de laboratorio en busca de un foco infeccioso
- d) Iniciar ceftriaxona + ampicilina y realizar exámenes de laboratorio en busca de un foco infeccioso
- e) Iniciar ceftazidina + gentamicina y realizar exámenes de laboratorio en busca de un foco infeccioso

5) Un paciente consulta por mialgias generalizadas y fiebre. Al examen físico presenta dolor a la palpación de las masas musculares, sin otros hallazgos de importancia. Se solicita hemograma que

demuestra eosinofilia importante. El diagnóstico más probable es:

- a) Larva migrante visceral
- b) Distomatosis
- c) Hidatidosis
- d) Triquinosis
- e) Cistecercosis

6) Una paciente está hospitalizada hace 10 horas por una neumonía del lóbulo inferior izquierdo, adquirida en la comunidad, ATS III, con fiebre hasta 41,5°C y escasos requerimientos de oxígeno. Su presión arterial es 120/80 mmHg y su pulso es de 100 lpm. Se solicitan tres hemocultivos y se inicia tratamiento con ceftriaxona, de los que uno de ellos resulta positivo para Staphylococcus aureus, mientras que los otros 2 resultan negativos. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar vancomicina y suspender la ceftriaxona
- b) Iniciar cefazolina y suspender la ceftriaxona
- c) Agregar vancomicina al tratamiento con ceftriaxona
- d) Agregar cloxacilina al tratamiento con ceftriaxona
- e) Mantener la ceftriaxona, ya que muy probablemente se trata de contaminación de la muestra

7) Un paciente de 66 años diabético, mal controlado, presenta aumento de volumen y dolor facial de rápida instalación asociado a escasa secreción nasal. Al examen se observa eritema y edema facial, con un área necrótica negruzca en relación a la prominencia malar izquierda. El agente etiológico más probable es:

- a) Pseudomona aureginosa
- b) Neumococo
- c) Staphylococcus aureus
- d) Streptococcus pyogenes
- e) Mucor

8) La distomatosis se contrae debido a:

- a) Relaciones sexuales sin protección
- b) Picaduras de insecto
- c) Ingesta de carnes y lácteos mal cocidos
- d) Ingesta de berros silvestres
- e) Ingesta de alimentos contaminados con fecas

9) El tratamiento de elección de la uretritis por Chlamydia trachomatis es:

- a) Ciprofloxacino
- b) Ceftriaxona
- c) Penicilina
- d) Doxiciclina
- e) Sulfas

10) Un paciente cursando una infección, inicia tratamiento antibiótico endovenoso. Durante la administración del fármaco presenta aparición de lesiones eritematosas, solevantadas en la cara, cuello, hombros, y zona proximal de las extremidades superiores, con prurito. El antibiótico que con mayor probabilidad produjo este cuadro es:

- a) Gentamicina
- b) Cloxacilina
- c) Ampicilina
- d) Clindamicina
- e) Vancomicina

11) Un paciente cursa con fiebre, compromiso del estado general y aparición de un soplo diastólico de intensidad moderado. En el examen físico presenta además algunas Petequias subconjuntivales y en los pulpejos. Los mejores exámenes para el diagnóstico son:

- a) PCR y hemograma
- b) Angio TAC y hemocultivos
- c) Hemocultivos y ecocardiografía transesofágica
- d) Ecocardiografía transtorácica y hemograma
- e) Ventriculografía y ecocardiografía transesofágica

12) Las meningoencefalitis virales suelen ser cuadros benignos y autolimitados. El agente etiológico más frecuente es:

- a) Virus herpes simplex
- b) Virus herpes zóster
- c) Enterovirus
- d) Virus influenza
- e) Adenovirus

13) La vómica es una manifestación de:

- a) Enfermedad de Chagas
- b) Malaria
- c) Hidatidosis
- d) Oxiuriasis
- e) Sarna

14) ¿Qué tratamiento NO aconsejaría a una infección del tracto urinario febril?

- a) Cloxacilina
- b) Ciprofloxacino
- c) Cefotaximo
- d) Gentamicina
- e) Cefazolina

15) Un paciente VIH positivo, con tratamiento antirretroviral intermitente, presenta disminución progresiva de la agudeza visual bilateral, de 7 días de evolución, que actualmente sólo le permite distinguir siluetas. Su último recuento de CD4 se lo realizó hace 7 meses y en ese entonces era de 72 células CD4+ por mm³. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar RMN de cerebro
- b) Realizar fondo de ojo
- c) Iniciar aciclovir
- d) Realizar estudio de líquido cefalorraquídeo
- e) Iniciar corticoides endovenosos

16) Un paciente de 6 años presenta dolor y aumento de volumen cervical. Al examen físico se aprecia una adenopatía cervical anterior izquierda de 3 cm, dolorosa, con escaso eritema en la piel que la recubre. Destaca además caries y enfermedad periodontal generalizadas en la cavidad bucal. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar una dosis de penicilina benzatina intramuscular
- b) Iniciar tratamiento con amoxicilina más ácido clavulánico por vía oral
- c) Hospitalizar e iniciar una cefalosporina de tercera generación por vía endovenosa
- d) Solicitar hemograma, hemocultivos e IgM para Bartonella hensellae
- e) Tomar cultivo por punción con aguja fina

17) La neurocisticercosis se caracteriza por todo lo siguiente EXCEPTO:

- a) Es causada por Taenia solium
- b) Suele ser asintomática
- c) Se contrae por consumir carne de cerdo mal cocida
- d) Los pacientes con neurocisticercosis no transmiten la enfermedad a otras personas
- e) Es una causa rara de epilepsia

18) ¿Qué relación entre antibiótico de elección y bacteria es correcta?

- a) Penicilina – Streptococo beta-hemolítico grupo A
- b) Imipenem – Estafilococo dorado
- c) Vancomicina – Acinetobacter baumannii
- d) Azitromicina – Pseudomonas aeruginosa
- e) Metronidazol – Enterococo

19) ¿Qué antibióticos son más efectivos para tratar infecciones causadas por anaerobios?

- a) Metronidazol y clindamicina
- b) Amoxicilina y levofloxacino
- c) Doxiciclina y penicilina
- d) Cefazolina y gentamicina
- e) Flucloxacilina y tinidazol

20) Un paciente VIH, mal controlado consulta por disfagia. Presenta algarra en la cavidad oral y recuento de CD4 de 140 células x mm³. El diagnóstico más probable es:

- a) Sarcoma de Kaposi esofágico
- b) Esofagitis por criptosporidium
- c) Esofagitis por candida
- d) Esofagitis por citomegalovirus
- e) Esofagitis por virus de la inmunodeficiencia humana

Prueba 6

1) UN paciente de 70 años presenta fiebre alta, cefalea y desorientación. Al examen físico destacan signos meníngeos positivos y fiebre de 39,4°C. El resto del examen no aporta mayor información. Se realiza punción lumbar que da salida a líquido cefalorraquídeo turbio, con 10.000 células, con 94% polimorfonucleares, glucosa de 21 mg/dl y proteínas de 134 mg/dl. La tinción de Gram no muestra bacterias. El tratamiento farmacológico de elección es:

- a) Penicilina + Vancomicina
- b) Ceftriaxona sola
- c) Ceftriaxona + Vancomicina
- d) Cefotaximo + Ampicilina
- e) Cefotaximo + metronidazol

2) Respecto a la neurocisticercosis es FALSO que:

- a) Es causada por el parásito Taenia solium
- b) Se produce por comer carne de cerdo infestada
- c) Suele ser asintomática
- d) Es causa de epilepsia focal
- e) Los neurocisticercos no se reproducen en el huésped que infestan

3) Un paciente de 30 años presenta un cuadro de cefalea, mialgias intensas y fiebre hasta 40,1°C, de 2 días de evolución, al que se ha agregado ligera odinofagia y tos seca. El examen físico se aprecia decaído, bien perfundido, eupneico, con FC: 92 lpm, PA: 120/80 mmHg, FR: 14 rpm y t°:39,6°C. La faringe se observa congestiva y algo eritematosa y la auscultación cardiopulmonar resulta normal. La saturación de oxígeno, por pulsometría es de 97%. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar radiografía de tórax y decidir manejo según hallazgos
- b) Indicar tratamiento sintomático con paracetamol e iniciar oseltamivir oral
- c) Iniciar amoxicilina e ibuprofeno
- d) Solicitar hemograma, VHS, PCR y hemocultivos, decidiendo manejo según resultados
- e) Iniciar un macrólido, asociado a algún AINE, como tratamiento sintomático

4) Un paciente de 37 años, consulta por astenia, fiebre intermitente y aparición de un exantema macular no pruriginoso, generalizado, que compromete las palmas y las plantas. Se solicita RPR que resulta positivo. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar VDRL
- b) Solicitar MHA-TP
- c) Administrar penicilina benzatina intramuscular
- d) Iniciar tratamiento con un macrólido oral
- e) Realizar biopsia de alguna de las lesiones cutáneas

5) Un paciente VIH, sin triterapia, con último recuento de CD4 de 220, hace 12 meses, consulta por cuadro de cefalea y compromiso del estado general. Al examen físico presenta signos meníngeos esbozados, por lo que se solicita punción lumbar, que da salida a líquido claro, con 110 células, 90% mononucleares, con proteínas aumentadas y glucosa baja. El diagnóstico más probable es:

- a) Toxoplasmosis cerebral
- b) Encefalitis por VIH
- c) Meningitis tuberculosa
- d) Criptococosis meníngea
- e) Leucomalacia multifocal progresiva

6) Un paciente de 60 años, consulta por fiebre, compromiso del estado general, disuria dolorosa y de esfuerzo, de inicio hace 2 días. Al examen físico se encuentra febril, bien perfundido, con ausencia de

puño percusión y el tacto rectal resulta muy doloroso. El diagnóstico más probable es:

- a) Prostatitis aguda
- b) Absceso perianal
- c) Uretritis gonocócica
- d) Absceso pelvirrectal
- e) Pielonefritis aguda

7) Un paciente de 16 años presenta una amigdalitis ulceronecrótica (angina de Vincent), por lo que se inicia clindamicina, evolucionando con diarrea y dolor abdominal al sexto día de tratamiento. La conducta más adecuada es:

- a) Mantener el tratamiento con clindamicina y agregar sales de rehidratación oral y antiespasmódicos
- b) Agregar metronidazol al tratamiento con clindamicina
- c) Suspender la clindamicina e iniciar vancomicina
- d) Suspender la clindamicina e iniciar amoxicilina más ácido clavulánico
- e) Solicitar toxinas A y B de Clostridium difficile en deposiciones

8) Un paciente de 45 años consulta por dolor, enrojecimiento y aumento de volumen de la rodilla derecha. Al examen físico se observa derrame articular y signos inflamatorios a nivel de la rodilla. Se realiza punción articular que da salida alíquido purulento, con más de 100.000 células por mm³, con 95% de polimorfonucleares y glucosa baja. La tinción de Gram demuestra cocáceas Gram-negativas al interior de los glóbulos blancos. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar ceftriaxona y realizar drenaje articular quirúrgico
- b) Iniciar cloxacilina y realizar drenaje articular quirúrgico
- c) Iniciar Vancomicina y realizar drenaje articular quirúrgico
- d) Solicitar radiografía de rodilla y decidir manejo según hallazgos
- e) Solicitar cintigrafía ósea y decidir manejo según hallazgos

9) El examen de elección para confirmar la sospecha clínica de fiebre tifoidea es:

- a) Coprocultivo
- b) IgM para Salmonella typhi
- c) Hemocultivo
- d) Reacción de Widal
- e) PCR para Salmonella typhi

10) Un paciente de 57 años, diabético mal controlado, consulta por aumento de volumen y dolor facial de 4 días de evolución, asociado a eritema de la zona nasal y malar bilateral, mayor a derecha. Al examen físico se observa eritema y edema facial, con una zona oscura necrótica, en la zona malar derecha. El ojo derecho presenta una leve proptosis. El diagnóstico más probable es:

- a) Celulitis por pseudomona
- b) Celulitis orbitaria
- c) Fasceítis necrotizante
- d) Mucormicosis
- e) Erisipela

11) Un paciente de 30 años presenta ictericia, fiebre y malestar general. Se solicitan pruebas hepáticas que demuestran una elevación importante de las transaminasas. Se solicitan serologías virales con los siguientes resultados: IgM VHA(+), antígeno VHBs(-), anticuerpos anti-VHBs(+), anticuerpos totales anti-VHBc(+), anticuerpos totales anti-VHC(+), IgM VCA(+), IgM CMV(+), IgG CMV(-). El diagnóstico MENOS probable es:

- a) Hepatitis A
- b) Hepatitis B
- c) Hepatitis C
- d) Hepatitis por CMV
- e) Mononucleosis infecciosa

12) Una paciente obesa, de 57 años, consulta por dolor y aumento de volumen en la extremidad inferior derecha. Al examen se observa una placa eritematosa de 15 cm, de color rojo brillante, de

bordes netos, caliente y sensible a la palpación. El diagnóstico más probable es:

- a) Erisipela
- b) Linfangitis
- c) Celulitis
- d) Ectima
- e) Fasceítis necrotizante

13) El tratamiento antibiótico de elección del absceso cerebral es:

- a) Cefotaximo + clindamicina
- b) Clindamicina sola
- c) Ceftriaxona sola
- d) Ceftriaxona + metronidazol
- e) Ceftazidina + Vancomicina

14) Un paciente VIH, con escaso seguimiento, consulta por disminución rápida de la agudeza visual a lo largo de 7 días, mayor a derecha, sin dolor ni otras molestias. Al examen físico se aprecia agudeza visual de 20/100 a derecha y de 20/50 a izquierda, sin otras alteraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar resonancia magnética nuclear de cerebro
- b) Realizar fondo de ojo
- c) Administrar corticoides endovenosos
- d) Iniciar aciclovir oral
- e) Solicitar IgM para citomegalovirus

15) Una paciente de 34 años consulta por diarrea de 2 días de evolución, asociada a fiebre y dolor abdominal tipo cólico. Las deposiciones presentan pus y sangre. Al examen físico se observa decaído, bien perfundido, febril hasta 38,8°C, con un abdomen blando, sensible difuso, con ruidos hidroaéreos aumentados y sin signos de irritación peritoneal. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar hidratación oral y ciprofloxacino
- b) Iniciar hidratación oral y cefadroxilo
- c) Iniciar hidratación oral y clindamicina
- d) Iniciar hidratación endovenosa y ceftriaxona
- e) Iniciar hidratación oral, sin necesidad de antibióticos

16) Un paciente de 5 años presenta prurito intenso en las manos, pies, genitales y abdomen, respetando la cara y la espalda. Al examen se observan escoriaciones y descamación en las zonas comprometidas. Entre los dedos de las manos se observan algunos surcos y vesículas perladas. El tratamiento de elección es:

- a) Terbinafina tópica
- b) Permetrina tópica
- c) Lindano tópico
- d) Albendazol oral
- e) Corticoides tópicos

17) Un paciente de 45 años, con antecedente de válvula aórtica bicúspide, presenta fiebre y compromiso del estado general de 3 días de evolución. Al examen se ausculta un soplo diastólico III/VI y se observan algunas petequias en las extremidades superiores e inferiores. Se solicita Hemograma que demuestra Hcto: 38%, Hb: 12,6, Blancos: 16.000, neutrófilos: 85%, linfocitos: 11%, monocitos: 4%, plaquetas: 455.000, VHS: 55 mm/h. Los hemocultivos están pendientes y la ecografía demuestra vegetaciones en la válvula aórtica con un grado leve de insuficiencia aórtica. El tratamiento antibiótico empírico de elección es:

- a) Cloxacilina + metronidazol
- b) Ampicilina + gentamicina + cloxacilina
- c) Ceftriaxona + metronidazol
- d) Ertapenem
- e) Penicilina + amikacina

18) Un paciente hospitalizado, cursando una infección intrahospitalaria, inicia tratamiento antibiótico presentando un rash eritematoso maculopapular de rápida instalación, que afecta el cuello, hombros y

la zona dorsal alta, con algunas pequeñas lesiones en la cara interna de los brazos. ¿Cuál de los siguientes fármacos es el causante de este cuadro, con mayor probabilidad?

- a) Gentamicina
- b) Imipenem
- c) Vancomicina
- d) Clindamicina
- e) Metronidazol

19) Un paciente consulta presenta fiebre, compromiso del estado general, meningitis aséptica y conjuntivitis hemorrágica. ¿Qué microorganismo provocaría el cuadro descrito, con mayor probabilidad?

- a) Brucella
- b) Legionella
- c) Mycoplasma
- d) Leptospira
- e) Rickettsia

20) Un paciente cursando una neumonía grave, con insuficiencia respiratoria y necesidad de ventilación mecánica debe ser tratado con:

- a) Ceftriaxona sola
- b) Ceftazidina + vancomicina
- c) Cefotaximo + clindamicina
- d) Vancomicina + ampicilina
- e) Claritromicina + cefalosporina de tercera generación

Prueba 7 (INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA)

1) Las Infecciones del tracto urinario en los niños generalmente deben estudiarse a fin de detectar la presencia de malformaciones que aumentan el riesgo de recurrencia de la infección y de daño renal. ¿Cuál de las siguientes opciones enumera los exámenes que deben solicitarse para cumplir este objetivo?

- a) Ecografía renal y vesical y cintigrafía renal estática
- b) Cintigrafía renal estática y cintigrafía renal dinámica
- c) Uretrocistografía miccional seriada y ecografía renal y vesical
- d) Tomografía de abdomen y pelvis y cintigrafía renal dinámica
- e) Ecografía renal y vesical y cintigrafía renal dinámica

2) El tratamiento empírico de la meningitis bacteriana aguda en niños, cuando se desconoce el agente causal, es:

- a) Ceftriaxona sola
- b) Ceftriaxona más vancomicina
- c) Penicilina más metronidazol
- d) Gentamicina más cefotaximo
- e) Azitromicina sola

3) Una niña de 5 años es traída por su madre, ya que presenta cefalea, fiebre hasta 38,5°C y vómitos. Al examen físico destaca rigidez de nuca esbozada, sin otros hallazgos de importancia. Se solicita punción lumbar que da salida a líquido claro, con 756 células, con 85% mononuclear y 15% polimorfonuclear, la glucosa del LCR es normal y las proteínas están levemente aumentadas. El diagnóstico más probable es:

- a) Meningitis tuberculosa
- b) Meningitis bacteriana aguda
- c) Meningoencefalitis herpética
- d) Meningoencefalitis viral por enterovirus
- e) Absceso cerebral

4) En los niños, la complicación más frecuente de la varicela es:

- a) Cerebelitis postvaricela

- b) Neumonía varicelatoria
- c) Hepatitis viral
- d) Sobreinfección de las lesiones por bacterias Gram positivas
- e) Síndrome de Reye

5) Un niño de 10 meses presenta fiebre alta hasta 40,3°C, asociado a leve decaimiento durante los episodios febriles. Luego de 2 días presenta aparición de exantema papular, eritematoso, generalizado con lesiones pequeñas y dispersas. Paralelamente a la aparición del exantema, desaparece la fiebre y el lactante se observa en buenas condiciones. El agente causal del cuadro descrito es:

- a) Enterovirus
- b) Virus Herpes 6
- c) Virus Epstein Baar
- d) Parvovirus B19
- e) Citomegalovirus

6) Un niño de 6 meses recibe las vacunas correspondientes a su edad, presentando compromiso del estado general, fiebre alta y convulsiones en una oportunidad. ¿Cuál de las vacunas es la causante de este cuadro, con mayor probabilidad?

- a) Difteria
- b) Tétanos
- c) Pertusis
- d) Polio
- e) Hepatitis B

7) El tratamiento antibiótico de elección para la celulitis orbitaria es:

- a) Cefazolina endovenosa
- b) Cloxacilina oral
- c) Ceftriaxona endovenosa
- d) Gentamicina endovenosa
- e) Ciprofloxacino oral

8) Una mujer de 34 años, portadora de una infección crónica por el virus de la hepatitis B, da a luz a un recién nacido de término sin patología aparente. La conducta más adecuada, para con este recién nacido, es:

- a) Iniciar lamivudina y suspender la lactancia materna
- b) Administrar inmunoglobulina hiperinmune anti-VHB e iniciar lamivudina
- c) Administrar inmunoglobulina hiperinmune anti-VHB y la primera dosis de la vacuna anti-hepatitis B
- d) Administrar la primera dosis de la vacuna anti-hepatitis B y suspender la lactancia materna
- e) Vacunar contra la hepatitis B e iniciar lamivudina

9) Respecto a la infección por VIH en el niño es FALSO que:

- a) La vía de contagio más frecuente es la vertical
- b) El curso de la enfermedad suele ser más lento que en los adultos
- c) La manifestación más frecuente es la candidiasis oral
- d) El diagnóstico en los recién nacidos debe hacerse con PCR o carga viral y no con ELISA
- e) A fin de prevenirlo debe suspenderse la lactancia materna si la madre está infectada

10) Una niña de 4 años presenta desde hace 5 días erosiones amarillas, costrosas debajo de las narinas y en las mejillas, el mentón y las extremidades superiores. Por lo demás la niña está bien y no tiene alergias conocidas a medicamentos. ¿Cuál de los siguientes es el tratamiento más indicado?

- a) Cefadroxilo oral
- b) Aciclovir tópico
- c) Coprofloxacino oral
- d) Mupirocina tópica
- e) Ceftriaxona endovenosa

11) Un niño de 8 meses presenta fiebre hasta 38,9°C, sin otros síntomas. Al examen físico se observa en buenas condiciones generales, sin hallazgos patológicos. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar antipiréticos, solicitar hemograma y sedimento de orina y decidir conducta según resultados
- b) Iniciar cefadroxilo oral y antipiréticos, sin necesidad de exámenes
- c) Iniciar antipiréticos y controlar en 48 horas o en caso de empeoramiento, sin necesidad de mayor estudio
- d) Hospitalizar, iniciar antibióticos endovenosos y solicitar hemograma, VHS, sedimento de orina, urocultivo, radiografía de tórax y punción lumbar, decidiendo manejo según resultados
- e) Iniciar antipiréticos y claritromicina, controlando en 48 horas o en caso de empeoramiento

12) Un niño de 13 años consulta por compromiso del estado general y fiebre alta, hasta 40°C, asociado a odinofagia. Al examen destaca faringe eritematosa, con exudado amigdalino blanco adherente. Se palpan varias adenopatías cervicales. Se solicita hemograma que demuestra leucocitosis de 17.000, con 90% de linfocitos, algunos de ellos atípicos. El diagnóstico más probable es:

- a) Herpangina
- b) Faringoamigdalitis estreptocócica
- c) Mononucleosis infecciosa
- d) Infección por VIH
- e) Linfoma

13) Los agentes etiológicos más frecuentes de la sepsis neonatal son:

- a) Streptococcus pyogenes y Staphylococcus aureus
- b) Streptococcus agalactiae y Staphylococcus aureus
- c) Streptococcus agalactiae y Escherichia coli
- d) Streptococcus pneumoniae y Streptococcus agalactiae
- e) Streptococcus pyogenes y Streptococcus pneumoniae

14) ¿Cuál de las siguientes cardiopatías congénitas NO requiere de profilaxis antibiótica de endocarditis bacteriana?

- a) Válvula aórtica bicúspide
- b) Comunicación interauricular tipo ostium secundum
- c) Comunicación interventricular
- d) Coartación de la aorta
- e) Tetralogía de Fallot

15) ¿Cuál es el agente causal de la mayoría de las neumonías del lactante menor de un año?

- a) Neumococo
- b) Haemophilus influenza
- c) Mycoplasma pneumoniae
- d) Adenovirus
- e) Virus respiratorio sincicial

16) ¿Qué vacunas debe recibir un niño a los 18 meses, según el plan nacional de inmunizaciones?

- a) DPT, polio oral y hepatitis B
- b) Sólo DT
- c) Polio oral y DPT
- d) DPT y trivírica
- e) DPT, trivírica y polio oral

17) Niño de 2 años consulta por cuadro de 2 días de evolución de otalgia y otorrea escasa a derecha. A la otoscopia se observa el tímpano derecho eritematoso y abombado, con salida de pus escasa. El tratamiento antibiótico de elección es:

- a) Amoxicilina
- b) Cefadroxilo
- c) Amoxicilina más ácido clavulánico
- d) Azitromicina
- e) Ciprofloxacino

18) Un niño de 7 años presenta un cuadro de rinorrea y tos con escasa expectoración mucosa desde hace 7 días. En las últimas 48 horas aumenta la tos, la que se hace productiva y se agrega fiebre hasta

38,5°C y disnea de grandes esfuerzos. Al examen físico se aprecia en buenas condiciones, sin cianosis ni uso de musculatura accesoria y satura 97% con FiO2 ambiental. Al examen pulmonar se auscultan crepitaciones y sibilancias escasas, mayores en las bases. Se solicita radiografía de tórax que muestra un patrón de relleno alveolo-intersticial, mayor en la base izquierda. El tratamiento antibiótico de elección es:

- a) Claritromicina
- b) Amoxicilina
- c) Ceftriaxona
- d) Vancomicina
- e) Amoxicilina más ácido clavulánico

19) El agente etiológico más frecuente de las infecciones congénitas (TORCH) es:

- a) Virus de la rubeola
- b) Toxoplasma
- c) Citomegalovirus
- d) Virus herpes simplex
- e) Tripanosoma cruzi

20) Un niño de 8 meses presenta diarrea acuosa, explosiva, asociada a fiebre leve. Al examen físico se observa moderadamente deshidratado. El agente causal más probable es:

- a) Rotavirus
- b) Escherichia coli
- c) Enterovirus
- d) Salmonella
- e) Shigella

1) Un niño de 10 años presenta cefalea y fiebre alta, asociados a vómitos en varias oportunidades. Al examen físico se aprecia decaído, con rigidez de nuca esbozada. Se realiza punción lumbar que da salida a líquido cefalorraquídeo con 600 células por mm³, de predominio polimorfonuclear, proteínas de 150 mg/dl y glucosa de 30 mg/dl. No se observan bacterias en el Gram. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar baciloscopías y cultivo de Koch de líquido cefalorraquídeo
- b) Iniciar ceftriaxona más vancomicina endovenosa, asociadas a corticoides
- c) Enviar a domicilio con tratamiento sintomático
- d) Iniciar aciclovir endovenoso y solicitar PCR para virus herpes simplex
- e) Iniciar ceftriaxona más ampicilina endovenosa, asociadas a corticoides

2) Un paciente diagnosticado de infección por el virus de la inmunodeficiencia humana hace 5 años, consulta por cefalea, hipoestesia de la extremidad inferior izquierda y una convulsión tónicoclónica. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Criptococosis
- b) Leucomalacia multifocal progresiva
- c) Encefalitis por VIH
- d) Toxoplasmosis cerebral
- e) Meningitis bacteriana aguda

3) Un niño de 6 años presenta un cuadro de marcado compromiso del estado general, con fiebre hasta 40,5°C, asociado a tos y un exantema macular rojo intenso que inició en la cara y luego se hizo generalizado. Al examen físico se ve muy decaído, con la faringe eritematosa, enantema oral y signos de conjuntivitis bilateral. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Sarampión
- b) Rubeola
- c) Exantema súbito
- d) Eritema infeccioso
- e) Escarlatina

4) Identifique la asociación INCORRECTA entre la parasitosis y la vía de contagio:

- a) Triquinosis – Consumo de carne de cerdo infestada
- b) Distomatosis – Consumo de berros contaminados
- c) Hidatidosis – Consumo de carne de cordero
- d) Teniasis – Consumo de carne infestada con cisticercos
- e) Ascariasis – Ingesta de hortalizas contaminadas con heces

5) Un niño de 6 años consulta por un cuadro de tos de 13 días de evolución, que inicialmente se acompañó de odinofagia y coriza, pero que en los últimos días se ha acompañado de fiebre, malestar general y expectoración mucosa. Al examen físico se ausculta estertores, crépitos y escasas sibilancias bibasales. Se solicita radiografía de tórax que muestra un patrón de relleno alveolointersticial bibasal. Su hermana de 8 años está con síntomas similares. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar amoxicilina
- b) Iniciar amoxicilina más ácido clavulánico
- c) Iniciar macrólidos
- d) Iniciar ceftriaxona
- e) Iniciar osetamivir

6) ¿Cuál de las siguientes alternativas es un tratamiento adecuado para una uretritis gonocócica?

- a) Penicilina benzatina 2,4 millones i.m. por una vez y agregar cobertura para Chlamydia
- b) Ceftriaxona 1 g cada 24 horas por 7 días y agregar cobertura para Chlamydia
- c) Cirpofloxacin 500 mg v.o. por una vez y agregar cobertura para Chlamydia
- d) Rifampicina 600 mg cada 12 horas por 3 días y agregar cobertura para Chlamydia
- e) Doxiciclina 100 mg cada 12 horas por 10 días y agregar cobertura para Chlamydia

7) Un paciente de 70 años consulta por fiebre y aparición de una lesión en el muslo izquierdo. Al examen físico se aprecia una placa eritematosa de bordes definidos, con aumento de la temperatura

local y presencia de varias adenopatías inguinales ipsilaterales. El diagnóstico más probable es:

- a) Celulitis
- b) Erisipela
- c) Fasciitis necrotizante
- d) Ectima
- e) Escarlatina

8) Un paciente de 9 años consulta por malestar general, rinorrea purulenta y sensación de descarga posterior, a lo que se ha agregado eritema periocular izquierdo y aumento de la temperatura local, con agudeza visual normal y movimientos oculares conservados. Al examen físico. Se solicita un TAC de órbita que descarta compromiso orbitario. EL tratamiento de elección es:

- a) Penicilina
- b) Cloxacilina
- c) Ceftriaxona
- d) Vancomicina
- e) Clindamicina

9) El tratamiento de elección de la oxiuriasis es:

- a) Metronidazol
- b) Prazicuantel
- c) Mebendazol
- d) Nifurtimox
- e) Benzinidazol

10) El tratamiento de elección de la onicomicosis suele ser:

- a) Clotrimazol tópico
- b) Terbinafina tópica
- c) Anfotericina B endovenosa
- d) Terbinafina oral
- e) Ketoconazol oral

11) Un paciente de 65 años, con antecedente de estenosis mitral, consulta por fiebre y malestar general marcado. Al examen físico se ausculta un soplo cardíaco con componente sistólico y diastólico sin otras alteraciones y la analítica sanguínea muestra leucocitosis de 17.000 con desviación izquierda, elevación de la PCR, creatinina y de las transaminasas. El diagnóstico más probable es:

- a) Endocarditis bacteriana
- b) Leptospirosis
- c) Brucelosis
- d) Legionelosis
- e) Mononucleosis infecciosa

12) Identifique la asociación INCORRECTA entre la patología y el tratamiento:

- a) Disentería por Shigella flexneri – ciprofloxacino
- b) Disentería amebiana – cotrimoxazol
- c) Diarrea por Clostridium difficile – metronidazol
- d) Diarrea por Campilobacter jejuni – macrólidos
- e) Diarrea por Vibrio cholerae – tetraciclina

13) Una paciente presenta disuria y leucorrea purulenta. A la especuloscopia se observa pared vaginal normal, pero importante compromiso inflamatorio del cuello uterino, con presencia de pus. El diagnóstico más probable es:

- a) Candidiasis
- b) Gonorrea
- c) Vaginitis bacteriana
- d) Tricomoniasis
- e) Infección por Escherichia coli

14) Un paciente con neutropenia febril, sin identificación del foco infeccioso debe ser tratado:

- a) Sintomáticamente
- b) Con una asociación de ceftriaxona y metronidazol

- c) Con una asociación de cefazolina y metronidazol
- d) Con una asociación de gentamicina y ceftazidina
- e) Con una asociación de penicilina y clindamicina

15) Un paciente de 24 años consulta por aparición de eritema, costras y bulas en la cara, que aparecieron dos días después de afeitarse. Al examen físico se aprecian vesículas y bulas de hasta 8 mm de diámetro, que se rompen fácilmente al tocarlas. El diagnóstico más probable y el agente etiológico más probable son respectivamente:

- a) Ectima gangrenoso – Pseudomona aureginosa
- b) Foliculitis de la barba – Staphilococcus aureus
- c) Impétigo común – Streptococcus pyogenes
- d) Impétigo buloso – Staphilococcus aureus
- e) Erisipela – Streptococcus pyogenes

16) Un paciente de 40 años presentó sífilis hace un año, la que fue tratada adecuadamente. Consulta nuevamente por fiebre y malestar general, por lo que se solicita VDRL que resulta negativo y MHA-TP que resulta positivo. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar penicilina benzatina intramuscular
- b) Iniciar ceftriaxona intramuscular
- c) Solicitar RPR
- d) Solicitar FTA-ABS
- e) Descartar la sífilis como diagnóstico y continuar el estudio

17) Un paciente con elevación de las transaminasas, presenta VHBs-Ag (+), VHBs-IgG(-), VHBc-IgM(-), VHBc-IgG(+), VHC-IgM(-), VHC-IgG(-). El diagnóstico más probable es:

- a) Hepatitis B aguda
- b) Hepatitis B crónica
- c) Vacunación previa contra la hepatitis B
- d) Antecedente de hepatitis B recuperada, sin infección actual
- e) Infección conjunta por los virus hepatitis B y C

18) Un paciente con diagnóstico de VIH consulta por disminución de la agudeza visual de 2 días de evolución. Al fondo de ojo se aprecian signos de coriorretinitis hemorrágica bilateral. El agente más probable es:

- a) Toxoplasma
- b) Criptococo
- c) Bacilo de Koch
- d) Citomegalovirus
- e) Mycobacterium avium complex

19) Un paciente de 13 años consulta por adinofagia intensa, asociada a fiebre hasta 39,0°C, de 24 horas de evolución. No presenta otros síntomas y al examen físico se constata eritema faríngeo y aumento de volumen amigdalino, con placas de exudado amigdalino grisáceo bilaterales y algunas petequias en el paladar blando. El agente etiológico más probable es:

- a) Bacterias anaerobias
- b) Estreptococo betahemolítico grupo A
- c) Virus de Epstein Baar
- d) Virus herpes simple
- e) Enterovirus

20) Un paciente de 5 años presenta fiebre hasta 38,4°C, asociado a un exantema pápulo-vesicular pruriginoso, con compromiso de la cabeza, tronco y extremidades. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar paracetamol y antihistamínicos
- b) Iniciar aspirina y antihistamínicos
- c) Iniciar aciclovir y antihistamínicos
- d) Iniciar cloxacilina y antihistamínicos
- e) Iniciar corticoides orales y antihistamínicos

Prueba 9

1) Un paciente de 50 años consulta por dolor y aparición de una lesión en la pierna izquierda. Al examen físico se aprecia una placa eritematosa de 7 cm de diámetro en la pierna izquierda, de bordes difíciles de definir, aumento de la temperatura local y sensibilidad a la palpación. EL tratamiento más adecuado es:

- a) Metronidazol
- b) Gentamicina
- c) Ceftriaxona
- d) Vancomicina
- e) Cloxacilina

2) Una paciente presenta disuria dolorosa, fiebre hasta 39°C y puño percusión positiva. Se solicita urocultivo que demuestra presencia de E. coli con más de 100.000 unidades formadoras de colonias. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar una cefalosporina de primera generación
- b) Iniciar nitrofurantoína
- c) Iniciar eritromicina
- d) Iniciar moxifloxacino
- e) Iniciar clindamicina

3) Una paciente con antecedente de válvula aórtica bicúspide, consulta por fiebre, artralgias y malestar general. Al examen físico destaca un soplo sistólico, que antes no tenía. Los exámenes más adecuado para el estudio diagnóstico son:

- a) Electrocardiograma y hemograma
- b) Hemocultivos y electrocardiograma
- c) Proteína C reactiva y ecocardiografía
- d) Ecocardiografía y hemocultivos
- e) Hemograma y coronariografía

4) Un lactante de 12 meses de edad presenta fiebre alta e irritabilidad, que ceden dando paso a la aparición de un exantema papular generalizado, con algunas lesiones en la cara, tronco y extremidades. El agente etiológico más probable es:

- a) Parvovirus B19
- b) Virus Herpes 6
- c) Enterovirus
- d) Virus de Epstein Baar
- e) Streptococcus pyogenes

5) Un paciente de 17 años consulta por fiebre alta y odinofagia. Al examen físico se palpan varias adenopatías cervicales sensibles e esplenomegalia moderada. La faringe se aprecia eritematosa, con aumento de volumen amigdalino y presencia de exudado blanquecino adherente. El diagnóstico más probable es:

- a) Mononucleosis infecciosa
- b) Síndrome retroviral agudo
- c) Amigdalitis pultácea
- d) Angina de Vincent
- e) Herpangina

6) Un paciente de 30 años consulta por fiebre y presencia de un exantema macular generalizado, con compromiso de palmas y plantas. Se solicita VDRL y FTA-ABS que resultan positivos. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar penicilina benzatina
- b) Iniciar cirpofloxacino
- c) Iniciar doxiciclina
- d) Iniciar metronidazol
- e) Observar evolución

7) Una paciente de 35 años consulta por prurito vulvar y leucorrea. A la especuloscopia se aprecia leucorrea blanquecina, grumosa, con algunos signos inflamatorios de la pared vaginal. EL diagnóstico más probable es:

- a) Vaginosis

- b) Tricomoniasis
- c) Candidiasis
- d) Gonorrea
- e) Infección urinaria

8) Un paciente de 18 años, alérgico a los macrólidos y a los betalactámicos, consulta por un cuadro de odinofagia, tos seca y rinorrea, de 12 días de evolución, que en las últimas 48 horas se han acompañado de malestar general, disnea y fiebra hasta 38,5°C. Se solicita radiografía de tórax que muestra un infiltrado alveolointersticial bilateral difuso, mayor en la base izquierda. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar certrioxona
- b) Iniciar vancomicina
- c) Iniciar clindamicina
- d) Iniciar azitromicina
- e) Iniciar levofloxacino

9) Un paciente de 32 años, portador de una infección crónica por el virus de la inmunodeficiencia adquirida, sin terapia antirretroviral, consulta por disfgia de una semana de evolución, mayor con los alimentos sólidos. Al examen físico sólo se observa algorra. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar ganciclovir
- b) Solicitar ecografía abdominal
- c) Solicitar endoscopia digestiva alta
- d) Solicitar IgM para citomegalovirus
- e) Iniciar ganciclovir oral

10) El examen más adecuado para el diagnóstico de fiebre tifoidea, de 10 días de evolución es:

- a) Serología
- b) Hemocultivo
- c) Coprocultivo
- d) Test de Widal
- e) El examen físico

11) Una niña de 5 años consulta por cefalea y fiebre, asociado a presencia de rigidez nuczal y signo de Brudzinsky, por lo que se realiza punción lumbar, que muestra salida de líquido cefalorraquídeo, con 890 células por mm³, 89% de mononucleares, glucosa: 30 mg/dl, proteínas: 160 mg/dl. El agente etiológico más probable es:

- a) Enterovirus
- b) Virus herpes simple
- c) Neisseria gonorreae
- d) Streptococcus pyogenes
- e) Mycobacterium tuberculosis

12) Un adolescente de 15 años consulta por malestar general, fiebre hasta 38,7°C y aparición de pápulas, vesículas y pústulas pruriginosas y generalizadas. Al examen físico se aprecian dichas lesiones en el cuero cabelludo, cara, tronco y extremidades. El diagnóstico más probable es:

- a) Varicela
- b) Exantema súbito
- c) Prurigo
- d) Quinta enfermedad
- e) Escarlatina

13) Un paciente de 60 años consulta por mialgias generalizadas y fiebre alta, asociadas a presencia de eosinofilia de 17% en el hemograma. El diagnóstico más probable es:

- a) Hidatidosis
- b) Triquinosis
- c) Diatomatosis
- d) Teniasis
- e) Ascariasis

14) Identifique la asociación INCORRECTA entre la patología y el agente etiológico más frecuente:

- a) Folliculitis – Streptococcus pyogenes
- b) Artritis séptica – Staphylococcus aureus

- c) Fascelitis necrotizante – Streptococcus pyogenes
- d) Síndrome de piel escaldada – Staphylococcus aureus
- e) Escarlatina – Streptococcus pyogenes

15) El tratamiento de elección de la pediculosis es:

- a) Lindano
- b) Organofosforados
- c) Permetrina
- d) Albendazol
- e) Retiro manual con peine

16) Un paciente de 18 años presenta malestar general, fiebre e ictericia, asociados a coluria y acolia. Se solicitan pruebas hepáticas, que muestran marcada elevación de las transaminasas, con bilirrubina de 4,5mg/dl, de predominio directo y normalidad de la GGT y las fosfatasa alcalina. Se solicita serología a vitral que muestra: IgG VHA(+), IgM VHA(-), IgM VHB anticore (+), IgG VHB anti-S(-), Ag VHBs (+), IgG anti VHC(-), IgM anti-CMV(-), IgG anti-CMV(+), IgM VCA(-), IgG VCA(+). El diagnóstico más probable es:

- a) Hepatitis A
- b) Hepatitis B
- c) Hepatitis por infección conjunta por VHA y CMV
- d) Hepatitis por infección conjunta por VHA, VHB, CMV y VEB
- e) Hepatitis por infección conjunta por VHB y VEB

17) El tratamiento de elección del absceso pulmonar es:

- a) Clindamicina
- b) Ceftriaxona
- c) Metronidazol
- d) Cloxacilina
- e) Macrólidos

18) Un paciente presenta diarrea disentérica por Shigella flexneri. El tratamiento de elección es:

- a) Hidratación y observación
- b) Hidratación y ciprofloxacino
- c) Hidratación y metronidazol
- d) Hidratación y eritromicina
- e) Hidratación y gentamicina

19) Identifique la asociación CORRECTA entre el antibiótico y su espectro de cobertura:

- a) Clindamicina – Mycoplasma
- b) Cefoperazona – Pseudomona
- c) Penicilina G – estafilococo dorado
- d) Metronidazol – nematelmintos
- e) Levofloxacino – bacterias anaerobias

20) El tratamiento de elección de la meningitis bacteriana aguda del recién nacido es:

- a) Ceftriaxona + vancomicina
- b) Cefotaximo + ampicilina
- c) Cefazolina + metronidazol
- d) Penicilina + gentamicina
- e) Ceftriaxona + ampicilina

Prueba 10

1) Un paciente de 70 años presenta un TEC, que evoluciona con un hematoma subdural, el que debe ser operado con craneotomía y drenaje. Evoluciona con fiebre alta y desorientación, por lo que se realiza una punción lumbar, que da salida a un líquido turbio, con glucosa baja, proteínas elevadas y

más de 1.000 glóbulos blancos por mm³, de predominio polimorfonuclear. El agente etiológico más probable es:

- a) Neumococo
- b) Haemophilus
- c) Listeria
- d) Meningococo
- e) Estafilococo aureo

2) Un paciente de 45 años, consulta por dolor abdominal, diarrea y fiebre alta, asociada a cefalea y malestar general, de 10 días de evolución. Se realiza un hemograma que muestra leucopenia, desviación izquierda y ausencia de eosinófilos y se solicitan hemocultivos, que resultan positivos para Salmonella tify. La conducta MÁS adecuada es iniciar:

- a) Tratamiento sintomático
- b) Ciprofloxacino oral
- c) Metronidazol oral
- d) Cefadroxilo oral
- e) Tetraciclina oral

3) Un niño de 4 años presenta fiebre y malestar general, asociado a aparición de un exantema vesículopustular que compromete la cabeza, tronco y extremidades, sin otras alteraciones. La conducta más adecuada es

- a) Iniciar aspirina
- b) Iniciar paracetamol
- c) Iniciar aciclovir y tratamiento sintomático
- d) Iniciar cloxacilina y tratamiento sintomático
- e) Iniciar ganciclovir y tratamiento sintomático

4) Un niño de 10 años presenta tos con expectoración mucosa, rinorrea y malestar general de 12 días de evolución, a lo que se agrega fiebre hasta 38,7°C y mayor malestar. Al examen físico se auscultan crepitaciones y sibilancias bilaterales. Se solicita una radiografía de tórax, que muestra un patrón intersticial, con engrosamiento bronquial y algunas zonas de relleno alveolar bilateral, mayor en la base izquierda. EL tratamiento más adecuado es:

- a) Sintomático
- b) Amoxicilina
- c) Claritromicina
- d) Ceftriaxona
- e) Clindamicina

5) El tratamiento de la mucormicosis es:

- a) Fluconazol oral
- b) Itraconazol endovenoso
- c) Ketoconazol tópico
- d) Anfotericina B endovenosa + resección quirúrgica
- e) Terbinafina oral + resección quirúrgica

6) Un paciente de 60 años consulta por dolor intenso de la extremidad inferior derecha. Al examen físico se aprecia una placa eritematosa, bien delimitada, con pequeñas áreas violáceas, muy dolorosa a la palpación, de 30 x 20 cm de diámetro en el muslo derecho, con 3 vesículas hemorrágicas. El diagnóstico más probable es:

- a) Erisipela
- b) Celulitis
- c) Linfngitis
- d) Ectima gangrenoso
- e) Fasciitis necrotizante

7) Identifique la asociación INCORRECTA entre la patología y el tratamiento:

- a) Tiña capitis – clotrimazol tópico
- b) Tiña corporis – terbinafina tópica
- c) Onicomycosis – terbinafina oral
- d) Algorra – miconazol tópico

e) Candidiasis esofágica – fluconazol oral

8) El eritema infeccioso o quinta enfermedad se caracteriza por un exantema que compromete las mejillas “en cachetada” y el tronco y las extremidades en disposición reticular. Su agente etiológico es:

- a) Virus herpes 8
- b) Virus herpes 6
- c) Citomegalovirus
- d) Enterovirus
- e) Parvovirus B19

9) El tratamiento del síndrome de piel escaldada suele ser:

- a) Hidratación, manejo de las heridas y ceftriaxona endovenosa
- b) Hidratación, manejo de las heridas y una asociación de penicilina y vancomicina endovenosa
- c) Hidratación, manejo de las heridas, cloxacilina endovenosa y resección quirúrgica del foco infeccioso
- d) Hidratación, manejo de las heridas y una asociación de cloxacilina y clindamicina endovenosa
- e) Hidratación, manejo de las heridas y una asociación de ceftriaxona y gentamicina endovenosa

10) Un paciente de 12 años consulta por odinofagia, fiebre y malestar general. Al examen físico está decaído, con fiebre de 39,2°C, se aprecia levemente ictérico, con varias adenopatías cervicales sensibles y se palpa esplenomegalia. En sus exámenes destaca linfocitosis de 15.000 con 80% de linfocitos, algunos de ellos atípicos y elevación de las transaminasas. ¿Qué examen es el más adecuado para confirmar el diagnóstico?

- a) IgM para leptospira
- b) PCR para virus Epstein Baar
- c) IgM VCA
- d) Elisa para CMV y VEB
- e) Cultivo faríngeo

11) Un paciente de 25 años consulta por disuria y secreción uretral, que inició algunos días después de tener relaciones sexuales sin protección. Se solicita Gram de secreción uretral, que muestra múltiples glóbulos blancos, pero que no visualiza bacterias. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar ciprofloxacino
- b) Indicar doxiciclina
- c) Indicar metronidazol
- d) Administrar ceftriaxona
- e) Administra penicilina benzatina

12) Un paciente consulta porque en sus deposiciones halló un gusano blanco de 15 cm de longitud, cilíndrico. El tratamiento de elección es:

- a) Metronidazol
- b) Clindamicina
- c) Albendazol
- d) Prazicuantel
- e) Nifurtimox

13) Un paciente de 24 años consulta por odinofagia intensa, fiebre y dolor a la movilización cervical, que impide la flexión y extensión. Usted sospecha un absceso retrofaríngeo. ¿Qué examen es el más adecuado para evaluar a este paciente?

- a) Ecografía cervical
- b) TAC de cuello
- c) Resonancia magnética
- d) Cintigrafía
- e) Punción cervical con aguja fina

14) ¿Cuál de los siguientes pacientes debe recibir triterapia antirretroviral?

- a) Paciente con Elisa (+) y Western blot (-) para VIH
- b) Paciente VIH con menos de 500 linfocitos CD4 (+) por mm³
- c) Paciente VIH a finales del segundo trimestre de embarazo, asintomática
- d) Paciente VIH no vacunado contra la tuberculosis

e) Paciente VIH que ha presentado 2 sinusitis y una neumonía por neumococo

15) El tratamiento de la neumonía por *Pneucystis jiroveci* consiste en:

- a) Amoxicilina
- b) Metronidazol
- c) Mebendazol
- d) Azitrmicina
- e) Cotrimoxazol

16) El dengue se caracteriza por todo lo siguiente EXCEPTO:

- a) Se trasmite por picadura de un mosquito
- b) Es causado por plasmodium
- c) Presenta cefalea y mialgias intensas
- d) Suele presentar petequias
- e) Puede contraerse más de una vez

17) Un paciente presenta cefalea intensa, fiebre alta, signos meníngeos, desorientación y agitación psicomotora, seguidas de una convulsión tónicoclónica. El TAC de cerebro muestra lesiones en ambos lóbulos temporales. El diagnóstico más probable es:

- a) Meningitis por criptococo
- b) Meningitis bacteriana aguda
- c) Meningitis tuberculosa
- d) Encefalitis por enterovirus
- e) Encefalitis virus herpes simplex

18) El tratamiento de elección de la sífilis, en los pacientes alérgicos a los betalactámicos es:

- a) Eritromicina
- b) Doxiciclina
- c) Coramfenicol
- d) Gentamicina
- e) Cirpofloxacino

19) Un paciente de 25 años es mordido en la pierna derecha, mientras intentaba separar una pelea de perros callejeros. Al examen físico sólo presenta una pequeña herida de 5 mm, sin embargo se muestra muy preocupado por la posibilidad de contraer rabia. La conducta más adecuada, en este sentido, es:

- a) Iniciar vacunación antirrábica
- b) Administrar suero antirrábico
- c) Solicitar punción lumbar
- d) Solicitar PCR de rabdovirus de la zona de la herida
- e) Tranquilizar al paciente, explicándole que no es necesario realizar estudios ni tratamientos adicionales

20) Identifique la asociación INCORRECTA:

- a) Candidiasis – prurito vulvar
- b) Trichomoniasis – leucorrea verdosa
- c) Clamidia – cervicitis
- d) Vaginosis bacteriana – test de KOH positivo
- e) Gonorrea – marcados signos inflamatorios en la mucosa vulvar

Prueba 11 (INFECTOLOGÍA + HEMATOLOGÍA)

1) Una mujer de 68 años presenta astenia y palidez. Se solicita hemograma que muestra anemia con hematocrito: 30%, Hb: 10 g/dl, VCM: 69 fl, HCM: 27 pg, plaquetas: 468.000 x mm³, blancos: 6.500 x mm³, segmentados: 53%, baciliformes: 3%, linfocitos: 33%, monocitos: 6%, eosinófilos: 3%, basófilos:

2%. Al frotis destaca microcitosis, anisocitosis e hipocromía. El diagnóstico más probable es:

- a) Anemia por enfermedades crónicas
- b) Anemia por déficit de hierro
- c) Mielodisplasia
- d) Trombocitosis esencial
- e) Leucemia mieloide crónica

2) Una mujer de 80 años se realiza un hemograma, que muestra leucocitosis de 40.000 x mm³, con 90% de linfocitos y anemia moderada. Al examen físico no se aprecian alteraciones y en un examen anterior, realizado hace un año, se constata leucocitosis de 30.000 x mm³, también de predominio linfocitario. El diagnóstico más probable es:

- a) Leucocitosis reactiva a infección viral crónica
- b) Leucemia linfática crónica
- c) Mielofibrosis
- d) Reacción leucemoide
- e) Linfoma

3) Una paciente de 69 años presenta anemia, síndrome nefrótico y dolores óseos. Probablemente presentará además:

- a) Hipocalcemia
- b) Hepatomegalia marcada
- c) Leucocitosis
- d) Paraproteinemia monoclonal
- e) Alargamiento del TTPA

4) La anemia por enfermedades crónicas se caracteriza por presentar:

- a) Ferritina disminuida y transferrina elevada
- b) Ferritina aumentada y transferrina disminuida
- c) Ferritina y transferrina aumentadas
- d) Ferritina y transferrina disminuidas
- e) Ferritina y transferrina dentro de rangos normales

5) Las células de ReedStemberg son características de:

- a) Asplenia
- b) Mielofibrosis
- c) Mieloma
- d) Anemia de células falciformes
- e) Linfoma de Hodking

6) Una mujer de 50 años presenta epistaxis y gingivorragia, desde hace 2 semanas. Además refiere equimosis ante pequeños traumatismos y al examen físico se aprecia un rash petequeial, sin otras alteraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar tiempos de coagulación
- b) Solicitar biopsia de médula ósea
- c) Solicitar pruebas de agregación plaquetaria
- d) Solicitar hemograma
- e) Iniciar corticoides orales

7) Un niño de 4 años ha presentado 2 hemartrosis de rodilla y varios episodios de hematomas profundos. Con alta probabilidad presentará:

- a) Alteración del recuento de plaquetas
- b) Alteración de las pruebas de agregación plaquetaria
- c) Alteración de los niveles plasmáticos de fibrinógeno
- d) Alteración del TTPA
- e) Alteración del TP

8) Un paciente de grupo sanguíneo B recibe por error una transfusión de glóbulos rojos AB. ¿Cuál es la probabilidad de que se presente una reacción hemolítica transfusional?

- a) Mayor al 95%
- b) 65%-95%
- c) 35%-65%

- d) 5%-35%
- e) Menor al 5%

9) Un paciente de 50 años, sin antecedentes de importancia, presenta una TVP de extremidad inferior izquierda. Además de los signos de TVP, al examen físico se aprecia piel violácea y se palpa esplenomegalia moderada. En sus exámenes destaca hemograma con hematocrito: 63%, Hb: 21 g/dl, plaquetas: 460.000 x mm³ y blancos: 9.000 x mm³, con fórmula diferencial normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Déficit de antitrombina III
- b) Leucemia mieloide crónica
- c) Leucemia mieloide aguda promielocítica (M3)
- d) Macrobulinemia de Waldestron
- e) Policitemia vera

10) Un paciente debe ser esplenectomizado, producto de un PTI crónico, resistente al tratamiento médico. ¿Qué medida debe ser realizada con anterioridad?

- a) Iniciar anticoagulación con heparina
- b) Solicitar niveles plasmáticos de complemento
- c) Administrar la vacuna antineumocócica
- d) Iniciar profilaxis antibiótica
- e) Solicitar recuento de subpoblación de linfocitos y Elisa para VIH

11) Un paciente de 30 años, portador del VIH, sin infecciones oportunistas, ni uso de triterapia, se realiza un recuento de linfocitos CD4(+), que demuestra 180 linfocitos CD4(+) por mm³. Algunos meses atrás había presentado 220 linfocitos CD4(+) por mm³. Respecto a este paciente el VERDADERO que:

- a) Debe iniciar profilaxis con cotrimoxazol y triterapia antirretroviral
- b) Debe iniciar profilaxis con cotrimoxazol, azitromicina y ganciclovir, sin necesidad de antirretrovirales
- c) Debe iniciar triterapia antirretroviral, sin necesidad de otros antimicrobianos
- d) Debe solicitarse carga viral y decidir conducta en base a los resultados
- e) Debe solicitarse nuevo Western Blot y decidir conducta en base a los resultados

12) Un niño de 6 años presenta un cuadro de fiebre y aparición de un exantema, que inició en las mejillas y que luego se hizo generalizado, comprometiendo el tronco y la zona proximal de las extremidades, en disposición "en encaje". El agente más probable es:

- a) Virus herpes 6
- b) Virus herpes 3
- c) Parvovirus B19
- d) Enterovirus
- e) Virus de la rubeola

13) Son alternativas para el tratamiento de infecciones por anaerobios, EXCEPTO:

- a) Penicilina
- b) Clindamicina
- c) Moxifloxacino
- d) Azitromicina
- e) Metronidazol

14) Un niño de 6 años presenta un cuadro de cefalea, fiebre y malestar general. Al examen físico presenta FC: 100x', PA: 100/60 mmHg y rigidez de nuca, sin signos focales. Se realiza punción lumbar, que da salida a un líquido cefalorraquídeo con 100 células por mm³, con 86% de mononucleares y 14% de polimorfonucleares, proteínas: 60 mg/dl, glucosa: 58 mg/dl y sin visualización de bacterias a la tinción de Gram. El agente más probable es:

- a) Virus herpes
- b) Neumococo
- c) Listeria
- d) Mycobacterium tuberculosis
- e) Enterovirus

15) ¿Qué tratamiento antibiótico indicaría a un adulto mayor postrado, que cursa simultáneamente con una infección urinaria y una neumonía adquirida en la comunidad ATS II, que se niega a ser hospitalizado?

- a) Clindamicina
- b) Claritromicina
- c) Moxifloxacino
- d) Amoxicilina + ácido clavulánico
- e) Cefuroximo

16) El tratamiento de elección de la ascariasis es:

- a) Albendazol
- b) Metronidazol
- c) Nifurtimox
- d) Prazicuantel
- e) Cotrimoxazol

17) ¿Cuál de las siguientes NO es causa de síndrome mononucleósico?

- a) Infección por citomegalovirus
- b) Reactivación de toxoplasmosis, producto de una inmunodeficiencia adquirida (Ej: SIDA)
- c) Uso de anticonvulsivantes
- d) Leucemia aguda
- e) Síndrome retroviral agudo

18) Un paciente de 23 años consulta por tos de 14 días de evolución, que en el último tiempo ha empeorado, agregándose fiebre y disnea. Al examen físico se auscultan sibilancias y crepitaciones bilaterales, mayores en la base derecha. Se solicita una radiografía de tórax que demuestra un patrón de relleno alveolointerstitial bilateral, mayor en la el LID. El tratamiento de elección es:

- a) Amoxicilina
- b) Claritromicina
- c) Ciprofloxacino
- d) Clindamicina
- e) Ceftriaxona

19) El tratamiento de elección del linfogranuloma venéreo es:

- a) Ceftriaxona
- b) Penicilina
- c) Tetraciclina
- d) Sintomático
- e) Ciprofloxacino

20) Identifique la asociación INCORRECTA entre la patología y su tratamiento:

- a) Mucormicosis – anfotericina B endovenosa más debridación quirúrgica
- b) Candidiasis esofágica – fluconazol oral
- c) Tiña capitis – clotrimazol tópico
- d) Onicomycosis – terbinafina oral
- e) Tiña corporis – terbinafina tópica

INFECTOLOGÍA RESPUESTAS

Prueba 1	3 C	5 C	7 C	9 A	11 D
1 D	4 B	6 C	8 B	10 C	12 B
2 B					

13 C	8 A	3 A	19 D	14 D	9 D
14 C	9 C	4 E	20 E	15 D	10 C
15 E	10 E	5 D		16 E	11 B
16 B	11 B	6 E	Prueba 7	17 B	12 C
17 D	12 C	7 E	1 C	18 D	13 B
18 A	13 C	8 D	2 B	19 B	14 C
19 A	14 D	9 D	3 D	20 A	15 E
20 B	15 D	10 E	4 D		16 B
	16 E	11 C	5 B	Prueba 9	17 E
Prueba 2	17 D	12 C	6 C	1 E	18 A
1 C	18 B	13 C	7 C	2 A	19 E
2 D	19 D	14 A	8 C	3 D	20 E
3 E	20 C	15 B	9 B	4 B	
4 D		16 B	10 A	5 A	Prueba 11
5 B	Prueba 4	17 C	11 C	6 A	
6 A	1 C	18 A	12 C	7 C	1 B
7 B	2 C	19 A	13 C	8 E	2 B
8 C	3 C	20 C	14 B	9 C	3 D
9 C	4 D		15 E	10 B	4 B
10 D	5 D	Prueba 6	16 C	11 E	5 E
11 B	6 B	1 D	17 A	12 A	6 D
12 D	7 C	2 B	18 A	13 B	7 D
13 B	8 B	3 B	19 C	14 A	8 A
14 D	9 D	4 B	20 A	15 C	9 E
15 D	10 A	5 D		16 B	10 C
16 D	11 A	6 A	Prueba 8	17 A	11 A
17 E	12 A	7 E	1 B	18 B	12 C
18 A	13 A	8 A	2 D	19 B	13 D
19 E	14 C	9 C	3 A	20 B	14 E
20 C	15 A	10 D	4 C		15 E
	16 D	11 B	5 C	Prueba 10	16 A
Prueba 3	17 B	12 A	6 C	1 E	17 B
1 B	18 E	13 D	7 B	2 B	18 B
2 E	19 D	14 B	8 C	3 B	19 C
3 E	20 E	15 A	9 C	4 C	20 C
4 A		16 B	10 D	5 D	
5 D	Prueba 5	17 B	11 A	6 E	
6 D	1 B	18 C	12 B	7 A	
7 E	2 D		13 B	8 E	

IX) HEMATO-ONCOLOGÍA PRUEBAS

Prueba 1

1) Paciente lúpica consulta por dolor abdominal, fiebre y orinas oscuras de 24 horas de evolución. Al

examen se aprecia ictericia leve. En su analítica destaca hematocrito: 27%, plaquetas: 400.000, blancos: 11.400, bilirrubina de 4 mg/dl, de predominio indirecto, transaminasas normales, LDH:1070.

La(s) prueba(s) diagnóstica(s) para confirmar el diagnóstico es(son):

- a) Biopsia de médula ósea
- b) Frotis de médula ósea
- c) Orina completa y ecografía abdominal
- d) C3, C4 y anticuerpos anti-DNA doble hebra
- e) Frotis sanguíneo y prueba de coombs

2) Paciente de 50 años, consulta por dolor en hipocondrio izquierdo y fiebre recurrente. Al examen destaca esplenomegalia importante. El hemograma muestra Hcto: 39%, Hb: 13mg/dl blancos: 43.000, con 95% de neutrófilos, 24% de baciliformes, 5% de promielocitos y 1% de blastos; recuento de plaquetas: 460.000. El diagnóstico más probable es:

- a) Leucemia mieloide crónica
- b) Leucemia mieloide aguda
- c) Mononucleosis infecciosa
- d) Fiebre tifoidea
- e) Mielodiplasia

3) Paciente de 60 años, consulta por astenia, adinamia e infecciones a repetición. Al examen pálido, con escasas petequias en extremidades superiores. El hemograma muestra Hematocrito: 23%, blancos: 3.000, con fórmula diferencial normal, plaquetas: 45.000. El examen más adecuado para continuar el estudio etiológico es:

- a) Biopsia de médula ósea
- b) Radiografía de calota
- c) Electroforesis de proteínas en sangre y orina
- d) Cinética de hierro y niveles de vitamina B12
- e) Citometría de flujo en sangre periférica

4) Mujer de 68 años, diagnosticada de cáncer pulmonar, consulta por cefalea y tos, de inicio brusco. Al examen se aprecia edema y cianosis de cara y extremidades superiores, con dilatación de las venas faciales. Las medidas iniciales deben ser:

- a) Administrar corticoides endovenosos y solicitar radioterapia de urgencia
- b) Solicitar radiografía de tórax y punción pleural
- c) Administrar broncodilatadores inhalados, oxígeno y antibióticos endovenosos
- d) Iniciar un diurético e indicar restricción hídrica
- e) Realizar cirugía de urgencia

5) Niño de 7 años, consulta por fiebre y baja de peso de 2 semanas de evolución, asociado a dolores óseos. Al examen se aprecia pálido y destacan petequias en extremidades inferiores. Presenta dolor a la palpación y movilización de rodilla izquierda. El diagnóstico más probable es:

- a) Leucemia aguda
- b) Síndrome hemolítico urémico
- c) Artritis séptica de rodilla
- d) Púrpura trombocitopénica aguda
- e) Linfoma de Hodgkin

6) La primera causa de alteración de la hemostasia primaria en mujeres adultas es:

- a) Púrpura trombocitopénica inmune
- b) Uso de anticonceptivos
- c) Enfermedad de Von Willebrand
- d) Uso de anticoagulantes
- e) Uso de antiinflamatorios no esteroideos

7) Niño de 6 años, es traído por su madre, por presentar lesiones en extremidades. Al examen se aprecian petequias generalizadas y algunas equimosis pequeñas en extremidades, sin epistaxis ni otros sangrados mayores. En su analítica destacan recuento de plaquetas de 9.000, Hematocrito de 45% y recuento de blancos de 7.200. La conducta más adecuada a seguir es:

- a) Administrar hidrocortisona endovenosa

- b) Iniciar prednisona oral
- c) Indicar reposo, y control, sin necesidad de administrar medicamentos, explicando a la madre los signos de alarma para reconsultar
- d) Indicar transfusión de plaquetas con urgencia
- e) Administrar inmunoglobulina endovenosa

8) Paciente de 65 años, con dolores óseos, presenta en su analítica creatinina de 2,1, anemia con Hb:9,7 e hipercalcemia de 11,1. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Insuficiencia renal crónica, con hiperparatiroidismo asociado
- b) Anemia de enfermedades crónicas
- c) Mieloma múltiple
- d) Déficit de proteína C
- e) Cáncer de próstata

9) Paciente de 44 años, consulta por aumento de volumen en muslo izquierdo, de 4 meses de evolución, indolora. Al examen se aprecia masa de 20 cms, de consistencia gomosa, lisa en cara interna de muslo izquierdo, adherida a planos profundos. La radiografía muestra aumento de volumen de partes blandas, que erosiona la superficie cortical del fémur. La técnica de imagen más útil, para continuar el estudio es:

- a) Resonancia magnética
- b) Tomografía axial computada
- c) Ecografía de partes blandas
- d) Cintigrafía ósea
- e) Radiografía de tórax

10) Mujer de 35 años, consulta por astenia. Refiere reglas abundantes. Se objetiva anemia microcítica y el perfil de hierro es compatible con anemia ferropénica. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar sulfato de hierro oral, hasta normalizar la ferritina
- b) Realizar endoscopia digestiva alta e iniciar hierro oral
- c) Iniciar anticonceptivos para disminuir la hipermenorrea, son necesidad de aportar hierro
- d) Iniciar sulfato de hierro oral, hasta normalizar la hemoglobina
- e) Administrar hierro oral por 1 mes, sin realizar más exámenes

11) Un lactante de 9 meses es llevado por su madre al policlínico, ya que lo encuentra pálido. El examen físico no aporta mayor información. Se toma hemograma, que demuestra Hematocrito: 26%, Hb: 8,9 g/dl, VCM:80, blancos y plaquetas normales. La causa más probable de su anemia es:

- a) Ferropenia
- b) Anemia fisiológica
- c) Talasemia
- d) Anemia por enfermedades crónicas
- e) Déficit de folatos

12) Mujer de 24 años consulta por fiebre, baja de peso y sudoración nocturna. Al examen presenta poliadenopatías cervicales. El hemograma es normal. La radiografía de tórax muestra mediastino ensanchado. El diagnóstico más probable es:

- a) Infección por Bartonella henselae
- b) Tuberculosis
- c) Linfoma
- d) Leucemia
- e) Timoma

13) El factor pronóstico más importante ante el diagnóstico de melanoma es:

- a) El diámetro de la lesión
- b) El grado de atipias de la células cancerígenas
- c) El índice de Breslow
- d) La presencia de adenopatías comprometidas
- e) La ubicación de la lesión

14) Un paciente de 65 años presenta un tumor de 5 mm de diámetro con bordes perlados ubicado en el ala nasal, de un año de evolución. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

- a) Carcinoma espinocelular
- b) Melanoma
- c) Queratosis seborreica

- d) Carcinoma basocelular
- e) Queratosis actínica

15) La cinética de hierro que más orienta a anemia de enfermedades crónicas es:

- a) Ferremia alta, transferrina baja y ferritina baja
- b) Ferremia alta, transferrina alta y ferritina alta
- c) Ferremia baja, transferrina alta y ferritina baja
- d) Ferremia baja, transferrina baja y ferritina alta
- e) Ferremia baja, transferrina alta y ferritina alta

16) Mujer de 55 años, asintomática, se realiza mamografía como método de screening de cáncer de mama. Es informada como Birrads 3. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar ecografía de mamas
- b) Mantener control mamográfico anual, explicando a la paciente el carácter benigno de los hallazgos
- c) Solicitar biopsia por punción con aguja gruesa a la brevedad
- d) Realizar nueva mamografía en 6 meses
- e) Realizar mastectomía parcial y biopsia

17) Mujer de 35 años se realiza PAP que es informado como “presencia de atipias de alto grado”. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar cono biopsico
- b) Derivar a colposcopia
- c) Solicitar nuevo PAP inmediatamente
- d) Solicitar nuevo PAP en un año
- e) Realizar histerectomía

18) El factor pronóstico más importante del cáncer de boca es:

- a) Tipo histológico del tumor
- b) Tamaño del tumor
- c) Presencia de invasión vascular a la histología
- d) Presencia de adenopatías cervicales comprometidas
- e) Ubicación del tumor primario

19) Paciente de 60 años, consulta por astenia, adinamia y palidez. En sus exámenes destaca Hcto:27%, Blancos:3100, Plaquetas:50.000, GR:2.200.000 cels/mm³. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome mielodisplásico
- b) Leucemia aguda
- c) Aplasia medular
- d) Déficit de vitamina B12
- e) Anemia de enfermedades crónicas

20) Hombre 65 años que comienza hace algunos meses con constipación, que antes no tenía. En la analítica destaca anemia microcítica e hipocroma leve. La conducta más adecuada, de entre las siguientes, es:

- a) Solicitar recuento de reticulocitos y estudio de médula ósea
- b) Solicitar Ecografía abdominal
- c) Solicitar tomografía computada de abdomen y pelvis, con contraste
- d) Administrar hierro oral, sin necesidad de mayor estudio
- e) Solicitar colonoscopia

Prueba 2

1) Un paciente de 60 años consulta por epistaxis frecuentes y gingivorragia de 3 días de evolución. En una oportunidad además presentó hematoquezia. Al examen físico se observan múltiples petequias en las extremidades y en el tronco. No se palpan adenopatías ni esplenomegalia. Se solicita un

hemograma que demuestra: Hcto: 44%, Hb: 14,6 g/dl, Blancos: 7.800 x mm³, Plaquetas: 42.000 x mm³.

La conducta más adecuada es:

- a) Indicar reposo relativo y controlar en 2 semanas con nuevo hemograma
- b) Iniciar prednisona oral
- c) Iniciar aspirina
- d) Iniciar ácido tranexánico
- e) Realizar esplenectomía

2) Las causas más frecuente de anemia en adultos y en niños son respectivamente:

- a) Ferropénica y ferropénica
- b) Ferropénica y genética
- c) Ferropénica y déficit de vitamina B12
- d) Déficit de vitamina B12 y genética
- e) Déficit de vitamina B12 y ferropénica

3) Un paciente de 56 años presenta hematoquezia en una oportunidad. El examen físico no aporta mayor información. Se decide realizar colonoscopia que demuestra un tumor de 4 cm, el que se biopsia, diagnosticándose de un adenocarcinoma tubular de grado moderado. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar resección endoscópica completa del tumor
- b) Solicitar endosonografía
- c) Iniciar quimioterapia
- d) Solicitar TAC de tórax abdomen y pelvis
- e) Solicitar ecografía abdominal

4) Un paciente de 34 años, presenta compromiso del estado general y fiebre intermitente desde hace 2 semanas. Al examen físico se aprecia pálido, con petequias en las extremidades inferiores y en el tronco. Se palpa también esplenomegalia moderada. El diagnóstico más probable es:

- a) Mononucleosis infecciosa
- b) Leucemia mieloide crónica
- c) Leucemia linfática crónica
- d) Leucemia aguda
- e) Linfoma

5) Un paciente de 66 años se realiza exámenes de rutina, que demuestran una anemia moderada, con hematocrito de 28%, mactocítica, con VCM de 105 fl, asociadas a trombocitopenia y leucopenia, ambas leves con 95.000 plaquetas y 3.700 glóbulos blancos por milímetro cúbico de sangre. El examen físico no aporta mayor información. Se inicia tratamiento con hierro, vitamina B12 y folatos por vía oral y se controla un nuevo hemograma a los 60 días, que no muestra cambios significativos respecto al inicial. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar niveles plasmáticos de eritropoyetina
- b) Iniciar eritropoyetina
- c) Solicitar biopsia de médula ósea
- d) Iniciar vitamina B12 y fierro, por vía parenteral
- e) Iniciar corticoides orales

6) La primera causa de muerte en los pacientes con mieloma es:

- a) Trombosis
- b) Infecciones
- c) Hipercalcemia
- d) Hemorragias
- e) Arritmias

7) Una paciente de 30 años presenta un nevo de 7 mm en la pierna derecha, de color heterogéneo, bordes irregulares y forma asimétrica, que ha crecido en el último año. Se decide extirparlo, con mínimo margen y la biopsia concluye que se trata de un melanoma de extensión superficial, con un índice de Breslow de 2,5 mm. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar quimioterapia

- b) Realizar ampliación de los márgenes de 1 cm y administrar radioterapia postoperatoria
- c) Realizar ampliación de los márgenes de 2 cm y solicitar biopsia de ganglio centinela
- d) Iniciar tratamiento paliativo
- e) Solicitar radiografía de tórax, TAC de abdomen y pelvis y biopsia de ganglio centinela

8) El síndrome antifosfolípidos se asocia a todo lo siguiente EXCEPTO:

- a) Acortamiento del TTPA
- b) Trombosis arteriales
- c) Trombosis venosas
- d) Abortos
- e) Lupus eritematosos sistémico

9) Un paciente portador de una trombofilia congénita, presenta un tromboembolismo pulmonar, por lo que se decide anticoagular con heparina y luego con cumarínicos. ¿Qué examen es el más adecuado para ajustar la dosis de cumarínicos que debe ocupar?

- a) Tiempo de sangría
- b) Tiempo de tromboplastina parcial activado
- c) Tiempo de protrombina
- d) Tiempo de trombina
- e) Fibrinogenemia

10) Las tres causas más frecuentes de muerte por cáncer en la población masculina chilena son:

- a) Gástrico, pulmonar y prostático
- b) Gástrico, de colon y páncreático
- c) Gástrico, esofágico y páncreático
- d) Gástrico, pulmonar y de vesícula biliar
- e) Gástrico, de colon y prostático

11) Un paciente de 33 años sufre un accidente de tránsito, resultando con una fractura de húmero, la que se reduce en pabellón, por medio de osteosíntesis con placas y tornillos. En sus exámenes postoperatorios, destaca un hemograma con Hcto: 42%, blancos: 9.300 x mm³ y plaquetas: 470.000 x mm³. La causa más probable de su trombocitosis es:

- a) Embolia grasa
- b) Trombocitosis escencial
- c) Farmacológica
- d) Alérgica
- e) Reactiva

12) Un paciente de 32 años consulta por baja de peso, fiebre y sudoración nocturna de 4 semanas de evolución. Al examen físico se palpan adenopatías axilares derechas, algunas de ellas confluentes, siendo la mayor de cerca de 3 cm. No presenta otras alteraciones en el examen. El diagnóstico más probable es:

- a) Leucemia linfática aguda
- b) Leucemia mieloide crónica
- c) Linfoma
- d) Mononucleosis infecciosa
- e) Adenopatías reactivas

13) El factor pronóstico más importante en el cáncer de mama es:

- a) La estadificación mamográfica de Birrads
- b) La presencia de metástasis a distancia
- c) La presencia de receptores de estrógenos y progesterona en el
- d) El compromiso de los ganglios linfáticos axilares
- e) El tamaño del tumor

14) Un paciente con anemia normocítica normocrómica, se realiza exámenes que demuestran índice reticulocitario bajo, ferritina baja, ferremia baja y transferrina muy elevada. El diagnóstico más probable es:

- a) Mielodisplasia
- b) Anemia de enfermedades crónicas

- c) Anemia ferropénica
- d) Hemocromatosis
- e) Anemia hemolítica

15) ¿Cuál de las siguientes patologías se caracteriza por presentar la mayor magnitud de esplenomegalia?

- a) Mielofibrosis
- b) Leucemia mieloide aguda
- c) Leucemia linfática crónica
- d) Mieloma múltiple
- e) Linfoma de Hodgkin

16) El factor pronóstico más importante en un paciente afectado de un sarcoma de partes blandas es:

- a) Tamaño del tumor primario
- b) Compromiso de ganglios linfáticos
- c) Compromiso de otros órganos, a distancia
- d) Tipo histológico del tumor
- e) Grado de diferenciación histológica del tumor

17) Un niño de 6 años presenta dolores óseos, fiebre y cefalea de varios días de evolución. Se solicitan un hemograma que muestra Hcto: 25%, Hb: 8,1 g/dl, Plaquetas: 32.000 x mm³, Blancos: 65.000 x mm³, con 78% de linfocitos, 12% de neutrófilos y 10% de blastos. El diagnóstico más probable y la conducta más adecuada son respectivamente:

- a) Linfoma y solicitar biopsia de adenopatía
- b) Leucemia linfática aguda y solicitar biopsia de médula
- c) Leucemia mieloide aguda y solicitar cariotipo de células malignas
- d) Leucemia linfática crónica y solicitar biopsia de médula
- e) Leucemia aguda e iniciar quimioterapia

18) Una lactante de 4 meses de edad se realiza hemograma como parte de estudio de una ITU. En ese hemograma destaca una hemoglobina de 10 g/dl. El diagnóstico más probable es:

- a) Anemia ferropénica
- b) Anemia fisiológica
- c) Talasemia
- d) Anemia por déficit de folatos
- e) Anemia por déficit de vitamina B12

19) Los AINEs se han asociado a trastornos de la hemostasia. Éste se produce mediante:

- a) Aumento de los factores de la coagulación
- b) Disminución de las plaquetas circulantes
- c) Hipercoagulabilidad, por activación del factor V
- d) Alteración del funcionamiento plaquetario
- e) Alteración de la hemostasia secundaria, por inactivación del factor V

20) Determine la asociación INCORRECTA entre patología y hallazgo en el frotis sanguíneo:

- a) Asplenia – Cuerpos de Howel Jolly
- b) Mieloma – Dacriocitos
- c) Anemia hemolítica – Aumento de los reticulocitos
- d) Anemia ferropénica – Anisocitosis
- e) Anemia hemolítica – Esquistocitos

Prueba 3

1) Un paciente de 57 años, diabético, hipertenso, con antecedente de una fibrilación auricular crónica, en tratamiento con acenocumarol y betabloqueo, presenta fatigabilidad y palidez. El examen físico no aporta mayor información. Se solicitan exámenes que demuestran un electrocardiograma en fibrilación

n auricular a 64 latidos, por minuto, sin otras alteraciones y un hemograma, con plaquetas y leucocitos normales, pero con hematocrito: 24%, Hemoglobina: 8,1 g/dl, VCM: 69 ft, HCM: 24 pg. El frotis sanguíneo presenta anisocitosis e hipocromía. El diagnóstico más probable es:

- a) Anemia ferropénica
- b) Anemia de enfermedades crónicas
- c) Anemia por déficit de folatos
- d) Anemia por hipotiroidismo
- e) Anemia hemolítica

2) Un paciente de 36 años presenta aumento de volumen inguinal, de 4 meses de evolución, asociado a baja de peso y fiebre recurrente. Al examen físico se aprecia algo pálido y presenta varias adenopatías inguinales derechas, algunas de ellas confluentes, siendo la mayor de casi 4 centímetros. El bazo se palpa de tamaño normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Leucemia linfática aguda
- b) Leucemia linfática crónica
- c) Leucemia mieloide aguda
- d) Linfoma
- e) Adenopatías reactivas

3) Un niño de 10 meses, asintomático, alimentado con leche materna y una comida, presenta anemia con hemoglobina de 9,2 g/dl, sin alteración de las otras series de células sanguíneas. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar biopsia de médula ósea
- b) Solicitar perfil de hierro, niveles de vitamina B12 y folatos
- c) Iniciar tratamiento con hierro oral
- d) Solicitar prueba de Coombs
- e) Solicitar pruebas de screening para talasemias

4) Un paciente de 16 años consulta por fiebre, compromiso del estado general de 7 días de evolución, al que se le agregó dolor faríngeo en las últimas horas. Al examen se encuentra febril, y se aprecia pálido. La faringe está eritematosa, con aumento de volumen amigdalino, mayor a derecha, sin exudado. Se observan varias petequias en el tronco y extremidades y se palpa esplenomegalia moderada. El diagnóstico más probable es:

- a) Mononucleosis infecciosa
- b) Mielodisplasia
- c) Leucemia aguda
- d) Leucemia mieloide crónica
- e) Linfoma

5) Un paciente de 67 años, con antecedente de una limitación crónica del flujo aéreo, producto de una tuberculosis en su juventud, que trata con broncodilatadores, de manera irregular. Actualmente presenta disnea de pequeños esfuerzos. Acude a control con un hemograma que demuestra hematocrito: 60%, hemoglobina: 19,6 g/dl, plaquetas: 440.000 por mm³, blancos: 7.800 por mm³, con fórmula diferencial normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Hemograma normal
- b) Anemia por enfermedades crónicas
- c) Policitemia vera
- d) Trombocitosis esencial
- e) Poliglobulia por hipoxemia.

6) Un niño de 7 años consulta por fiebre, dolores óseos y malestar general. Al examen se observan petequias en las extremidades inferiores, sin otros hallazgos. Se solicita hemograma que demuestra: Hcto: 26%, plaquetas: 36.000, blancos: 2.400, con 90% de linfocitos y 10% de neutrófilos. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar IgM VCA e IgM CMV

- b) Solicitar pruebas de agregación plaquetaria
- c) Solicitar tiempo de sangría, TP y TTPA
- d) Solicitar perfil de hierro e niveles plasmáticos de vitamina B12
- e) Solicitar biopsia de médula ósea

7) El púrpura trombocitopénico inmune se caracteriza por todo lo siguiente EXCEPTO:

- a) Ausencia de esplenomegalia
- b) Petequias
- c) Hemorragias de las mucosas
- d) Alargamiento del tiempo de sangría
- e) Poliadenopatías

8) Una paciente cursando una septicemia por E. coli, en contexto de una pielonefritis complicada, presenta hematoquezia en una oportunidad y aparición de equimosis en las extremidades inferiores. En sus exámenes destacan plaquetas de 40.000 por mm³, alargamiento del TTPA y fibrinogenemia de 80mg/dl. La conducta más adecuada para su trastorno de la hemostasia es:

- a) Anticoagular con heparina endovenosa
- b) Iniciar aspirina
- c) Administrar plasma fresco congelado
- d) Administrar crioprecipitado
- e) Realizar transfusión de plaquetas

9) Un paciente de 67 años consulta por astenia y palidez. Se solicita un cell-dyn que demuestra una anemia moderada, normocítica. Se solicita perfil de hierro que constata una ferremia disminuida, transferrina muy aumentada, con bajo índice de saturación y ferritina muy disminuida. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar endoscopia digestiva alta e iniciar sulfato de hierro por vía oral
- b) Diagnosticar anemia por enfermedades crónicas y solicitar exámenes generales, para determinar la causa
- c) Repetir el perfil de hierro
- d) Iniciar vitamina B12 por vía parenteral
- e) Iniciar hierro oral y controlar con un hemograma en 3 meses

10) Un paciente de 14 años consulta por fiebre y odinofagia de 3 días de evolución. Al examen presenta un tinte subictérico de la piel, se palpan varias adenopatías cervicales, y se aprecia cierto grado de esplenomegalia. Se solicitan un hemograma que demuestra hemtocrítico: 46%, plaquetas: 270.000 x mm³, blancos: 16.700 x mm³, con 78% de linfocitos, algunos de ellos con atipias, correspondientes a aumento del citoplasma. El diagnóstico más probable es:

- a) Leucemia linfática crónica
- b) Leucemia linfoide aguda
- c) Mielodisplasia
- d) Mononucleosis infecciosa
- e) Linfoma de Hodgkin

11) La combinación de anemia, hipercalcemia, elevación de la creatinina y dolores óseos, debe hacer sospechar:

- a) Linfoma
- b) Mieloma
- c) Déficit de vitamina B12
- d) Hipervitaminosis D
- e) Malaabsorción intestinal

12) Un paciente de 20 años presenta tendencia a las equimosis y suele tener sangramiento gingival cuando se cepilla los dientes, desde su niñez. Refiere además que cuando se hace heridas, suelen sangrar por varios minutos. Al examen sólo se observan algunas petequias. ¿Qué examen estará alterado con mayor probabilidad?

- a) Tiempo de protrombina
- b) Tiempo de sangría
- c) Tiempo de tromboplastina parcial activada
- d) Recuento de plaquetas
- e) Fibrinogenemia

13) Un paciente con antecedente de un factor V de Leyden presenta súbitamente disnea y dolor torácico, con tope inspiratorio a derecha. No presenta compromisos hemodinámico ni desaturación importante. Se solicita un angioTAC que es compatible con un tromboembolismo pulmonar derecho. Se decide iniciar anticoagulación con heparina no fraccionada por vía endovenosa. ¿Qué examen debe realizar para controlar un adecuado nivel de anticoagulación?

- a) Tiempo de protrombina (TP) e INR
- b) Tiempo de trombina (TT)
- c) Tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPA)
- d) Tiempo de sangría
- e) No requiere control con exámenes

14) Los linfomas suelen derivarse de las siguientes alteraciones genéticas:

- a) Mutaciones autosómicas dominantes
- b) Mutaciones autosómicas recesivas
- c) Mutaciones ligadas al sexo
- d) Translocaciones cromosómicas
- e) Aneuploidías

15) Un hombre de 66 años, consulta por astenia. El examen físico demuestra palidez moderada y se palpan adenopatías pequeñas generalizadas. El hemograma presenta hematocrito: 27%; Hb: 8,8; blancos: 36.000 por mm³; linfocitos: 88%; neutrófilos: 7%; monocitos: 1%; basófilos: 0%; eosinófilos: 0%; plaquetas: 85.000. El diagnóstico más probable es:

- a) Linfoma
- b) Leucemia mieloide crónica
- c) Leucemia linfática crónica
- d) Mieloma
- e) Mielodisplasia

16) Un paciente de 24 años, con enfermedad celiaca sin un adecuado cumplimiento de la dieta y depresión, en tratamiento antidepresivo, que usa de forma irregular, consulta por marcada astenia y disnea de mínimos esfuerzos. Al examen físico se aprecia muy pálido, taquicárdico, con un pulso amplio. Se ausculta un soplo sistólico eyectivo, de características funcionales. Se solicitan exámenes que son compatibles con una anemia por déficit de vitamina B12, con una hemoglobina actual de 5,8 g/dl. La conducta más adecuada, de entre las siguientes, es:

- a) Enviar a domicilio con vitamina B12 vía oral en dosis altas
- b) Enviar a domicilio, insistiendo en el cumplimiento de la dieta
- c) Hospitalizar y administrar vitamina B12 por vía parenteral
- d) Hospitalizar y transfundir glóbulos rojos
- e) Hospitalizar e indicar dieta alta en folatos, vitamina B12 y hierro, asegurándose de que no ingiera más gluten

17) La anemia hemolítica inmune se caracteriza por:

- a) Hiperbilirrubinemia de predominio directo
- b) Elevación de la haptoglobina
- c) Frotis con dacriocitos
- d) Aumento de los reticulocitos
- e) Cuerpos de Howell-Jolly

18) Paciente de 50 años, consulta por dolor en hipocondrio izquierdo y fiebre recurrente. Al examen destaca esplenomegalia importante. El hemograma muestra Hcto: 39%, Hb: 13mg/dl blancos: 43.000, con 95% de neutrófilos, 24% de baciliformes, 5% de promielocitos y 1% de blastos; recuento de plaquetas: 460.000. El diagnóstico más probable es:

- a) Leucemia mieloide crónica

- b) Leucemia mieloide aguda
- c) Mononucleosis infecciosa
- d) Fiebre tifoidea
- e) Mielodiplasia

19) ¿Cuál de las siguientes anemias no suele ser macrocítica?

- a) Por consumo de alcohol
- b) Por hipotiroidismo
- c) Por mielodisplasias
- d) Por enfermedades crónicas
- e) Por déficit de folatos

20) ¿Cuál de los siguientes cuadros es más sugerente de una hemofilia?

- a) Paciente de sexo masculino y 16 años, que ha sufrido varias hemartrosis de rodillas y otras articulaciones, de manera espontánea
- b) Paciente de sexo masculino y 14 años, que presenta epistaxis frecuentes, asociado a aparición de petequias y equimosis con pequeños golpes.
- c) Paciente de sexo femenino de 13 años, que presenta hematuria y artralgias, asociado a un púrpura de extremidades inferiores y hematoquezia.
- d) Paciente de sexo femenino, de 18 años, que desde su infancia ha presentado tendencia a presentar equimosis, sangra más de lo normal en procedimientos dentales y tiene reglas muy abundantes.
- e) Paciente de sexo masculino, de 5 años, que presenta un púrpura petequeial generalizado, de 3 días de evolución, que empezó una semana después de una infección viral

Prueba 4 (HEMATO-ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA)

1) La primera causa de anemia crónica en los niños menores de 1 año es:

- a) Ferropénica
- b) Enfermedades crónicas
- c) Mutaciones genéticas de la hemoglobina
- d) Déficit de folatos y B12
- e) Hemólisis extravascular

2) La ictericia neonatal que aparece en las primeras 24 horas de vida, se debe con mayor frecuencia a:

- a) Fenómenos fisiológicos
- b) Incompatibilidad de grupo Rh
- c) Incompatibilidad de grupo clásico (ABO)
- d) Infecciones intrauterinas
- e) Hipotiroidismo

3) Un paciente de 5 años, sin antecedentes de importancia presenta cuadro de 3 días de evolución de exantema petequeial, asociado a sangramiento gingival al cepillarse los dientes. La madre refiere que cursó con una infección respiratoria alta, autolimitada, hace 10 días. Al examen físico se aprecia paciente en buenas condiciones, afebril, con un exantema petequeial generalizado. El examen más importante para confirmar la sospecha diagnóstica es:

- a) Hemograma con recuento de plaquetas
- b) Hemocultivos
- c) Pruebas de agregación plaquetaria
- d) Tiempo de sangría
- e) Tiempos de protrombina y de tromboplastina parcial activada

4) La primera causa de muerte en niños con leucemia es:

- a) Infecciones
- b) Hemorragias
- c) Arritmias
- d) Fenómenos trombóticos

e) Edema pulmonar no cardiogénico

5) ¿Cuál de las siguientes opciones NO constituye un factor de riesgo para presentar poliglobulia neonatal?

- a) Prematurez
- b) Hijo de madre diabética
- c) Preclamsia
- d) Retraso del crecimiento intrauterino
- e) Recién nacido postérmino

6) Un niño de 5 años es traído por su madre por cuadro de fiebre y compromiso del estado general de algunas semanas de evolución. El hemograma muestra hematocrito: 27%, hemoglobina: 9,1 mg/dl, plaquetas: 48.000 por mm³, glóbulos blancos: 2.900 por mm³, con 84% de linfocitos, 9% de neutrófilos segmentados, 2% de monocitos, 0% de eosinófilos, 0% de basófilos y 5% de blastos. El diagnóstico más probable es:

- a) Linfoma
- b) Leucemia linfática aguda
- c) Leucemia linfática crónica
- d) Púrpura trombocitopénico trombótico
- e) Sepsis por bacterias Gram negativas

7) ¿Cuál de las siguientes opciones es el tipo más frecuente de inmunodeficiencia en la población pediátrica?

- a) Alteraciones de la inmunidad celular
- b) Alteraciones de la inmunidad humoral (anticuerpos)
- c) Alteraciones de la fagocitosis
- d) Déficit de complemento
- e) Infección por VIH

8) Un lactante de 5 meses diagnosticado de tos convulsiva, presenta leucocitosis importante, hasta 44.000 por mm³, con un 90% de linfocitos. La causa más probable de esta alteración sanguínea es:

- a) Infección viral sobreagregada
- b) Leucemia linfática aguda concomitante
- c) Reacción leucemoide por Bordetella pertusis
- d) Infección previa por VIH
- e) Agamaglobulinemia congénita

9) La medida más efectiva para prevenir la hemólisis fetal por incompatibilidad Rh es:

- a) Administrar inmunoglobulina anti-D a las mujeres Rh(+), sensibilizadas, a las 28 semanas de gestación y luego del parto
- b) Administrar inmunoglobulina anti-D a las mujeres Rh(+), no sensibilizadas, a las 28 semanas de gestación y luego del parto
- c) Administrar inmunoglobulina anti-D a las mujeres Rh(-), sensibilizadas, a las 28 semanas de gestación y luego del parto
- d) Administrar inmunoglobulina anti-D a las mujeres Rh(-), no sensibilizadas, a las 28 semanas de gestación y luego del parto
- e) Administrar inmunoglobulina anti-D al recién nacido Rh(-)

10) Un niño de 3 meses de edad, asintomático, sin antecedentes de importancia, presenta hemoglobina de 10,4 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

- a) Anemia ferropénica
- b) Anemia de enfermedades crónicas
- c) Anemia hemolítica, por incompatibilidad de grupo
- d) Anemia hemolítica, de etiología genética
- e) Anemia fisiológica

11) El cáncer es la segunda causa de muerte en los niños mayores de un año, luego de los accidentes. Los dos grupos más importantes de tumores malignos, causantes de mortalidad en la edad pediátrica son:

- a) Hematológicos y originados en el sistema nervioso central
- b) Hematológicos y originados en el tubo digestivo

- c) Hematológicos y originados en el sistema urogenital
- d) Hematológicos y los sarcomas de partes blandas
- e) Hematológicos y los tumores óseos

12) Un paciente de 12 años, consulta por cuadro de fiebre alta, gran compromiso del estado general, odinofagia intensa. Al examen físico destacan faringe eritematosa, con exudado amigdalino blanco adherente, poliadenopatías cervicales y bazo palpable. En sus exámenes se aprecia hemograma con leucocitosis de 16.000 por mm³, con 80% de linfocitos, 15% de ellos atípicos. El diagnóstico más probable es:

- a) Linfoma de Hodgkin
- b) Linfoma no Hodgkin
- c) Leucemia linfática aguda
- d) Enfermedad por arañazo de gato (Bartonellosis)
- e) Mononucleosis infecciosa

13) Un niño de 6 años con diagnóstico de púrpura trombocitopénico idiopático, sin manifestaciones hemorrágicas graves, presenta un recuento de plaquetas de 45.000 por mm³. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar reposo y observar la evolución, sin necesidad de medicamentos
- b) Iniciar corticoides orales
- c) Administrar inmunoglobulina endovenosa, en altas dosis
- d) Derivar para esplenectomía
- e) Indicar transfusión inmediata de plaquetas

14) Un paciente de 16 años consulta por fiebre, baja de peso y aumento de volumen cervical progresivo de algunos meses de evolución. En algunas ocasiones presenta dolor, especialmente después de tomar alcohol. En el examen físico destacan poliadenopatías cervicales izquierdas, de consistencia aumentada. Se solicita hemograma que resulta normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Linfoma de Hodgkin
- b) Enfermedad por arañazo de gato
- c) Tuberculosis
- d) Leucemia
- e) Infección por citomegalovirus

15) La hemofilia habitualmente corresponde a un trastorno:

- a) Autosómico dominante
- b) Autosómico recesivo
- c) Ligado al cromosoma X
- d) Ligado al cromosoma Y
- e) De herencia mitocondrial

16) Un niño de 7 años consulta por fiebre y compromiso del estado general, de 2 semanas de evolución, asociado a dolores óseos. Al examen destacan petequias en extremidades inferiores y esplenomegalia moderada. El diagnóstico más probable es:

- a) Leucemia mieloide crónica
- b) Leucemia aguda
- c) Púrpura trombocitopénico inmune
- d) Púrpura trombocitopénico trombótico
- e) Anemia de células falciformes

17) ¿Cuándo se inicia habitualmente la suplementación con hierro, en el lactante nacido prematuro, alimentado con lactancia materna exclusiva?

- a) Al alcanzar los 2 kilogramos de peso
- b) Al doblar el peso de nacimiento
- c) Al cumplir los 4 meses de edad
- d) Al cumplir los 6 meses de edad
- e) No requiere suplementación

18) La clínica más característica de la hemofilia es:

- a) Niños con equimosis, hemartrosis y hematomas profundos ante traumas pequeños
- b) Adolescentes con equimosis recurrentes y menstruaciones abundantes
- c) Niños con epistaxis, gingivorragia y petequias a repetición
- d) Niños con petequias, equimosis y tendencia a formar cicatrices hipertróficas, ante traumas menores

e) Niños con equimosis, hematuria y hemorragias digestivas recurrentes

19) ¿Qué tipo de inmunodeficiencia debe sospecharse en primer lugar, ante un paciente que presenta infecciones meningocócicas a repetición?

- a) Déficit de inmunoglobulina A
- b) Déficit de complemento
- c) Alteraciones de la fagocitosis
- d) Alteración de los linfocitos T
- e) Déficit de subclases de IgG

20) Un niño de 9 años de edad presenta desde los primeros años de vida, tendencia a la epistaxis y gingivorragia. También presenta petequias y equimosis recurrentes. El examen físico no aporta más información. El examen que con mayor probabilidad se encontrará alterado es:

- a) Recuento de plaquetas
- b) Tiempo de protrombina
- c) Tiempo de tromboplastina parcial activada
- d) Tiempo de sangría
- e) Fibrinogenemia

Prueba 5

1) Un paciente de 45 años, asintomático, se realiza un hemograma como parte de un chequeo médico, que muestra hematocrito: 45%, Hemoglobina: 15g/dl, VCM: 85 fl, plaquetas: 360.000 x mm³, glóbulos blancos: 37.000 x mm³, linfocitos: 7%, monocitos: 5%, segmentados: 66%, baciliformes: 16%,

promielocitos: 4%, blastos: 2%. Al examen físico se palpa esplenomegalia. El diagnóstico más probable es:

- a) Linfoma
- b) Reacción leucemoide
- c) Leucemia mieloide crónica
- d) Leucemia mieloide aguda
- e) Déficit de vitamina B12

2) El tratamiento del púrpura trombocitopénico crónico, del adulto es:

- a) Corticoides orales
- b) Ácido acetil salicílico
- c) Cumarínicos orales
- d) Esplenectomía
- e) Reposo y observación

3) Un paciente de 20 años consulta por fiebre intermitente y astenia, de 2 semanas de evolución. Al examen físico se palpan 4 adenopatías cervicales izquierdas, de hasta 3 cm de diámetro, sin otras alteraciones. Se solicita una radiografía de tórax que muestra ensanchamiento del mediastino. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad por arañazo de gato
- b) Linfoma
- c) Leucemia
- d) Mononucleosis infecciosa
- e) Tuberculosis

4) Un hombre de 57 años es diagnosticado de anemia ferropénica, mediante un hemograma y un perfil de hierro. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Solicitar colonoscopia e indicar sulfato ferroso, controlando nuevo perfil de hierro en 6 meses
- c) Indicar sulfato ferroso hasta normalizar el hematocrito y la ferremia
- d) Indicar sulfato ferroso por 6 meses sin necesidad de estudio adicional
- e) Indicar sulfato ferroso por 1 mes sin necesidad de estudio adicional

5) El pronóstico de sobrevida de la leucemia linfática aguda de la infancia actualmente es aproximadamente:

- a) 85%
- b) 60%
- c) 30%
- d) 10%
- e) 2%

6) Un paciente con anemia normocítica se realiza un perfil de hierro que muestra ferremia baja, transferrina baja y ferritina elevada. El diagnóstico más probable es:

- a) Anemia hemolítica
- b) Anemia por déficit de folatos
- c) Anemia ferropénica
- d) Anemia por enfermedades crónicas
- e) Talasemia

7) Un lactante de 10 meses, alimentado con leche materna y 2 comidas al día, asintomático, se realiza un hemograma que demuestra anemia leve, con hemoglobina: 9 g/dl y VCM: 80 ft. El diagnóstico más probable es:

- a) Anemia fisiológica
- b) Anemia ferropénica

- c) Talasemia
- d) Microesferocitosis familiar
- e) Anemia de enfermedades crónica

8) La asociación entre dolores óseos, anemia e hipercalcemia es característico de:

- a) Linfoma de Hodgkin
- b) Linfoma no Hodgkin
- c) Mielofibrosis
- d) Leucemia aguda
- e) Mieloma múltiple

9) Un hombre de 68 años consulta por astenia y palidez. Hace 3 meses había sido diagnosticado de anemia por lo que está tomando sulfato ferroso, vitamina B12 y ácido fólico. Su examen físico no presenta otras alteraciones. Se solicita un hemograma que muestra HCM: 31 pg, VCM: 106 pg, hematocrito: 26%, hemoglobina: 9 g/dl, blancos: 3.800 x mm³, plaquetas: 100.000 x mm³. El diagnóstico más probable es:

- a) Leucemia mieloide crónica
- b) Leucemia linfocítica crónica
- c) Mielofibrosis
- d) Mielodisplasia
- e) Aplasia medular

10) El factor pronóstico más importante del melanoma cutáneo es:

- a) Presencia de adenopatías comprometidas
- b) Profundidad de la infiltración cutánea
- c) Grados histológico de diferenciación
- d) Tamaño del tumor
- e) Presencia de ulceración

11) Son factores de mal pronóstico en el cáncer de mama EXCEPTO:

- a) Presencia de adenopatías tumorales en la axila
- b) Presencia de receptores de estrógenos y de progesterona
- c) Tamaño mayor a 5 cm
- d) Mutación BRCA 1
- e) Histología con alto grado de indiferenciación

12) Un paciente de 45 años, consulta por astenia, fiebre y orinas oscuras. Al examen físico se aprecia palidez, por lo que se solicita hemograma que demuestra hematocrito: 23%, hemoglobina: 7,6 g/dl, VCM: 110 ft, blancos: 8.000 x mm³, con fórmula diferencial normal y plaquetas: 169.000 x mm³. El frotis sanguíneo visualiza abundantes reticulocitos y esquistocitos. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar perfil de hierro
- b) Solicitar niveles de vitamina B12 y folatos
- c) Solicitar biopsia de médula ósea
- d) Solicitar pruebas de coagulación
- e) Solicitar prueba de Coombs directo

13) El déficit de antitrombina III se manifiesta como:

- a) Una alteración de la hemostasia primaria
- b) Una alteración de la hemostasia secundaria
- c) Una inmunodeficiencia
- d) Una trombofilia
- e) Una predisposición al desarrollo de leucemias

14) ¿Cuál de las siguientes alteraciones es MENOS compatible el diagnóstico de hemofilia?

- a) Sexo masculino
- b) Gingivorragia
- c) Hematomas profundos
- d) Hemartrosis

e) Alargamiento del TTPA

15) Un paciente de 67 años se realiza un perfil bioquímico que muestra elevación de las proteínas plasmáticas, con albúmina de 3,4 g/dl. Los exámenes generales son normales, al igual que el examen físico. Se solicita una electroforesis de proteínas en plasma, que constata un peak monoclonal de inmunoglobulina G, por lo que se realiza una biopsia de médula ósea que demuestra elevación del número de plasmocitos, compatible con un MGUS. La conducta más adecuada es:

- a) Obsevar evolución
- b) Indicar quimioterapia
- c) Iniciar ácido acetil salicílico
- d) Iniciar hidroxiurea
- e) Realizar trasplante de médula ósea

16) Una paciente de 65 años, fumadora de 1 cajetilla al día, presenta un cuadro de rápida instalación de tos, cefalea y cianosis facial. Al examen físico se aprecia además edema de la cara y las extremidades superiores, con dilatación de las venas superficiales de dichas zonas. La radiografía de tórax muestra ensanchamiento del mediastino y un tumor pulmonar de 5 cm en el lóbulo superior izquierdo. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar suero fisiológico endovenoso
- b) Administrar corticoides endovenosos
- c) Realizar angiografía de urgencia
- d) Anticoagular con heparina
- e) Resolver quirúrgicamente de inmediato

17) El consumo de AINEs clásicamente produce

- a) Alargamiento del tiempo de protrombina
- b) Alargamiento del tiempo de tromboplastina parcial activada
- c) Alargamiento del tiempo de sangría
- d) Disminución del recuento de plaquetas
- e) Aumento del recuento de plaquetas

18) Un niño de 5 años es traído por su madre, ya que desde hace 4 días que ha presentado varias epistaxis y además ha notado aparición de varias lesiones en la piel. Refiere que estuvo resfriado hace 10 días y que mejoró completamente. Al examen físico aprecian petequias generalizadas, sin otras alteraciones. El diagnóstico más probable es:

- a) Leucemia linfática aguda
- b) Enfermedad de Von Willebrand
- c) Púrpura trombocitopénica inmune
- d) Linfoma
- e) Hemofilia

19) Una paciente de 59 años presenta aumento de volumen en el brazo derecho, sin dolor. Al examen físico se aprecia una masa de 15 cm de diámetro de consistencia similar a las masas musculares, sin signos inflamatorios. ¿Qué imagen es más adecuada para la evaluación de este paciente?

- a) Radiografía simple
- b) Ecografía de partes blandas
- c) Tomografía axial computada sin contraste
- d) Tomografía axial computada con contraste
- e) Resonancia magnética nuclear

20) Un paciente, diagnosticado de cáncer pulmonar, presenta un cuadro de poliuria de 3 días, al que se le ha agregado desorientación en las últimas horas. Al examen físico está deshidratado, con sopor profundo, sin focalidad neurológica. El hemoglucotest resulta 180 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome de lisis tumoral

- b) Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética
- c) Embolia tumoral
- d) Hipercalcemia
- e) Síndrome hiperglicémico hiperosmolar

Prueba 6

1) Un paciente de 65 años presenta hemograma con hemoglobina: 9,6 g/dl, VCM: 106, plaquetas: 150.000 x mm³ y blancos: 4.100 x mm³. Le indican vitamina B12 y folatos, los que recibe por 4 meses. Se controla un nuevo hemograma que presenta valores similares. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Mieloma
- b) Leucemia aguda
- c) Mielodisplasia
- d) Anemia por enfermedades crónicas
- e) Talasemia

2) ¿Cuál de los siguientes hemogramas es más característico de una leucemia linfóide crónica?

- a) Hematocrito: 30%, plaquetas: 140.000 x mm³, blancos: 29.000 x mm³, 90% linfocitos, 8% segmentados, 2% monocitos
- b) Hematocrito: 45%, plaquetas: 460.000 x mm³, blancos: 35.000 x mm³, 10% linfocitos, 60% segmentados, 20% baciliformes, 5% mielocitos, 3% blastos, 2% monocitos
- c) Hematocrito: 28%, plaquetas: 120.000 x mm³, blancos: 2.000 x mm³, 80% linfocitos, 20% segmentados
- d) Hematocrito: 35%, plaquetas: 100.000 x mm³, blancos: 18.000 x mm³, 50% linfocitos, 25% segmentados, 25% monocitos
- e) Hematocrito: 40%, plaquetas: 240.000 x mm³, blancos: 16.000 x mm³, 80% linfocitos, 15% segmentados, 5% monocitos

3) Un paciente con anemia moderada, microcítica, se realiza un perfil de hierro que muestra ferritina baja, ferremia baja y transferrina alta. El diagnóstico más probable es:

- a) Anemia ferropénica
- b) Anemia sideroblástica
- c) Anemia por enfermedades crónicas
- d) Talasemia
- e) Microesferocitosis familiar

4) ¿Cuál de las siguientes alteraciones es MENOS compatible con una anemia hemolítica autoinmune?

- a) Prueba de coombs directa positiva
- b) Haptoglobina baja
- c) Hiperbilirrubinemia de predominio indirecto
- d) Reticulocitos bajos
- e) Macrocitosis

5) Un paciente presenta aumento de volumen inguinal, indoloro, asociado a baja de peso y fiebre. Al examen físico se aprecian cinco adenopatías inguinales derechas, de consistencia aumentada, la mayor de ellas de 2,5 cm. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar biopsia de una de las adenopatías
- b) Solicitar biopsia de médula ósea
- c) Solicitar electroforesis de proteínas
- d) Iniciar quimioterapia
- e) Solicitar resonancia magnética nuclear

6) Un adulto mayor presenta dolores óseos, hipercalcemia y anemia. Se debe sospechar:

- a) Linfoma de Hodgkin
- b) Leucemia
- c) Mieloma
- d) Linfoma no Hodgkin
- e) Mieloidosis

7) Un lactante de 4 meses presenta hematocrito 10 g/dl, sin otras alteraciones en el hemograma. El diagnóstico más probable es:

- a) Hemólisis por incompatibilidad de grupo
- b) Talasemia
- c) Anemia ferropénica
- d) Anemia fisiológica
- e) Hipotiroidismo congénito

8) Un niño de 6 años presenta un púrpura trombocitopénico inmune, con un recuento de plaquetas de 30.000 por milímetro cúbico. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar reposo relativo y observar evolución
- b) Indicar reposo relativo e iniciar prednisona
- c) Indicar reposo relativo e iniciar aspirina

- d) Realizar transfusión de plaquetas
- e) Administrar inmunoglobulina endovenosa

9) Un niño de 6 años ha presentado varios hematomas musculares espontáneos y algunas hemartrosis a lo largo de su vida. La madre refiere que con frecuencia presenta equimosis ante traumas menores. Usted esperaría encontrar:

- a) Disminución del recuento de plaquetas
- b) Alargamiento del tiempo de sangría
- c) Alargamiento del TTPA
- d) Disminución del fibrinógeno
- e) Alargamiento del tiempo de protrombina

10) Un paciente consulta por dolor en el hipocondrio izquierdo, asociado a astenia. Al examen físico destaca una marcada esplenomegalia. Se solicita hemograma que muestra VHS: 20 mm/h, hematocrito: 30%, Hb: 9,5 g/dl, blancos: 3.500 x mm³, con 65% de linfocitos, 30% de segmentados y 5% de monocitos, plaquetas: 100.000 x mm³ y visualización de dacriocitos en el frotis. El diagnóstico más probable es:

- a) Mieloma múltiple
- b) Leucemia mieloide aguda
- c) Mielofibrosis
- d) Asplenia
- e) Mielodisplasia

11) Una paciente de 36 años se realiza una mamografía, que es informada como Birrads 0. La conducta más adecuada es:

- a) Repetir mamografía en un año
- b) Repetir mamografía en 6 meses
- c) Repetir mamografía de inmediato
- d) Solicitar ecografía mamaria
- e) Derivar a biopsia estereotáxica

12) Un paciente de 33 años presenta una lesión hiperpigmentada, de rápido crecimiento en el brazo derecho, la que se biopsia de manera excisional, diagnosticándose un melanoma de extensión superficial, con índice de Breslow de 3mm. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar quimioterapia
- b) Ampliar márgenes un centímetro
- c) Ampliar márgenes dos centímetros y realizar biopsia de ganglio centinela
- d) Realizar radioterapia
- e) Realizar quimioterapia + radioterapia

13) El factor pronóstico más importante del cáncer de lengua es:

- a) Tipo histológico
- b) Invasión de los ganglios linfáticos cervicales
- c) Grado de diferenciación histológica
- d) Presencia de metástasis a distancia
- e) Tamaño del tumor

14) Un paciente de 62 años consulta por astenia y baja de peso, asociada a sensación de llene precoz, cuando se alimenta. Al examen físico se observa pálido y se palpan adenopatías supraclaviculares. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar biopsia de una de las adenopatías
- b) Solicitar endoscopia digestiva alta
- c) Solicitar colonoscopia
- d) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
- e) Solicitar ecografía abdominal

15) Un paciente de 64 años presenta hematuria en una oportunidad, corroborada en el sedimento de orina, como no dismórfica. Se solicita ecografía renal y vesical, que visualiza un tumor renal derecho de 6 cm de diámetro y de aspecto sólido. Luego se solicita un TAC de abdomen y pelvis que confirma la presencia del tumor, sin adenopatías sospechosas. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución

- b) Solicitar resonancia magnética nuclear
- c) Realizar tumorectomía
- d) Realizar nefrectomía radical
- e) Realizar nefrectomía radical + Radioterapia postoperatoria

16) La trombofilia congénita más frecuente en Chile es:

- a) Déficit de antitrombina III
- b) Déficit de proteína C
- c) Déficit de proteína S
- d) Resistencia del Factor V a la proteína C
- e) Hiperhomocisteinemia

17) Un paciente portador de un déficit de antitrombina III está en tratamiento con acenocumarol. Se solicita TTPA que resulta normal e INR que resulta 2,8. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar heparina
- b) Aumentar la dosis de acenocumarol
- c) Disminuir la dosis de acenocumarol
- d) Mantener el tratamiento
- e) Suspender el tratamiento anticoagulante y administrar vitamina K

18) Un hombre de 70 años presenta una lesión cutánea en la espalda, indolora, de 1,6 cm de diámetro, solevantada, con una depresión central y borde perlado. El diagnóstico más probable es:

- a) Léntigo maligno
- b) Carcinoma basocelular
- c) Melanoma nodular
- d) Carcinoma espinocelular
- e) Queratosis actínica

19) Una paciente de 40 años se realiza una especuloscopia que resulta normal, tomándose un PAP que es informado como muestra satisfactoria, con presencia de células displásicas de alto grado. La conducta más adecuada es:

- a) Derivar a patología cervical, para realización de colposcopia y biopsia de la lesión
- b) Repetir el PAP en un año
- c) Realizar cono cervical
- d) Repetir el PAP inmediatamente
- e) Repetir el PAP en 3 meses

20) El síndrome de vena cava superior se caracteriza por:

- a) Hipertensión arterial, palidez y dilatación de las venas torácicas y de las extremidades superiores
- b) Tos y edema facial y de extremidades superiores
- c) Dolor torácico intenso, asociado a disnea
- d) Ingurgitación yugular, asociado a hipotensión
- e) Compromiso de conciencia y dolor torácico

Prueba 7

1) Un paciente de 68 años presenta un hemograma con hematocrito: 30%, hemoglobina: 9,8 g/dl, glóbulos rojos: 4,5 millones por mm³, glóbulos blancos: 7.800 por mm³, plaquetas: 460.000 por mm³, con anisocitosis +++ al frotis. El diagnóstico más probable es:

- a) Anemia ferropénica
- b) Anemia por enfermedades crónicas
- c) Anemia megaloblástica
- d) Mielodisplasia
- e) Anemia hemolítica

2) Una paciente de 50 años consulta por fiebre y dolor en el hipocondrio izquierdo. Al examen físico se aprecia esplenomegalia marcada y su hemograma demuestra hematocrito de 45%, plaquetas de 480.000 por mm³, leucocitosis de 35.000 x mm³, con 55% de segmentados, 20% de baciliformes, 10% de mielocitos, 4% de blastos, 2% de eosinófilos, 8% de linfocitos y 1% de monocitos. El diagnóstico más probable es:

- a) Leucemia promielocítica aguda
- b) Reacción leucemoide
- c) Linfoma
- d) Leucemia de células peludas
- e) Leucemia mieloide crónica

3) Respecto a los linfomas de bajo grado, es FALSO que:

- a) La tasa de recaídas después del tratamiento con quimioterapia, suele ser muy baja
- b) Al momento del diagnóstico suelen estar diseminados
- c) Suelen presentar sobrevidas sobre los 10 años
- d) En los adultos mayores, suelen observarse
- e) Se diagnostican mediante biopsias ganglionares

4) Un paciente presenta palidez y astenia. Se solicitan exámenes generales, que muestran anemia con marcada elevación de los reticulocitos. El diagnóstico más probable es:

- a) Anemia hemolítica
- b) Anemia ferropénica
- c) Anemia por déficit de vitamina B12
- d) Anemia por enfermedades crónicas
- e) Talasemia

5) Un paciente de 50 años, con un síndrome purpúrico, es diagnosticado de púrpura trombocitopénico inmune, mediante el estudio correspondiente, con un recuento de plaquetas de 50.000 por mm³. La conducta más adecuada, además de indicar reposo, es:

- a) Observar evolución
- b) Iniciar corticoides orales
- c) Realizar esplenectomía
- d) Realizar transfusión de plaquetas
- e) Iniciar aspirina

6) Un paciente de 67 años se realiza un hemograma y un perfil bioquímico, como parte de un cheque médico, donde se comprueba anemia normocítica normocrómica, elevación de la VHS, hasta 99 mm/h, calcio: 11,7 mg/dl, proteínas totales: 10, 5 g/dl, albúmina: 3,2 g/dl y creatinina: 2,0 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

- a) Linfoma
- b) Leucemia linfática crónica
- c) Mieloma
- d) Leucemia mieloide crónica
- e) Mielofibrosis

7) La anemia ferropénica se caracteriza por presentar

- a) Elevación de la ferritina y de la transferrina
- b) Elevación de la transferrina y disminución de la ferritina
- c) Elevación de la ferritina y disminución de la transferrina
- d) Disminución de la ferritina y de la transferrina

e) Disminución de la ferritina, aumento de la ferremia y disminución de la saturación de la transferrina

8) Un niño de 5 años presenta epistaxis recurrentes y gingivorragia, desde hace 4 días. Al examen físico se aprecian petequias y equimosis generalizadas, sin otras alteraciones. El diagnóstico más probable es:

- a) Hemofilia
- b) Enfermedad de Von Willebrand
- c) Púrpura trombocitoénica inmune
- d) Púrpura trombocitoénica trombótica
- e) Leucemia aguda

9) Un paciente de 65 años, agricultor, consulta por una lesión hiperqueratósica en la frente, áspera al tacto, de 2 cm de diámetro, que en ocasiones sangra, sin tendencia a la curación. El diagnóstico más probable es:

- a) Carcinoma espinocelular
- b) Carcinoma basocelular
- c) Melanoma
- d) Queratosis actínica
- e) Queratosis seborreica

10) Un paciente de 67 años se realiza una colonoscopia, que visualiza un pólipo de 3 cm de diámetro, en el colon sigmoide, el que se biopsia, siendo informado como un adenocarcinoma tubular con grado de diferenciación moderado. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar resección completa del pólipo, por vía transrectal
- b) Solicitar TAC de tórax, abdomen y pelvis
- c) Solicitar ecografía abdominal
- d) Realizar hemicolectomía izquierda
- e) Solicitar resonancia magnética nuclear de abdomen y pelvis

11) Un paciente diabético e hipertenso, portador de una fibrilación auricular crónica, en tratamiento con warfarina y atenolol, se realizan pruebas de coagulación, que muestran TTPA normal e INR: 1,5. La conducta más adecuada es:

- a) Disminuir la dosis de warfarina
- b) Aumentar la dosis de warfarina
- c) Mantener el tratamiento
- d) Solicitar tiempo de sangría
- e) Iniciar aspirina

12) Un paciente diagnosticado de hemofilia A, consulta porque su esposa está embarazada, esperando un bebé de sexo masculino. ¿Cuál es la probabilidad de que este niño padezca de hemofilia?

- a) 0%
- b) 25%
- c) 33%
- d) 50%
- e) 100%

13) Un adolescente de 15 años consulta por fiebre y odinofagia, de 2 días de evolución. Al examen físico se aprecia con ictericia leve, t°: 38,5°C y se palpan múltiples adenopatías cervicales sensibles. La faringe está eritematosa, con aumento de volumen amigdalino y escaso exudado blanquecino. Además es posible palpar el bazo. El diagnóstico más probable es:

- a) Leucemia aguda
- b) Linfoma
- c) Mononucleosis infecciosa
- d) Anemia hemolítica autoinmune
- e) Leucemia linfática crónica

14) El factor pronóstico más importante para un sarcoma de partes blandas y la imagen más adecuada para su evaluación son respectivamente:

- a) Grado de diferenciación histológica y ecografía de partes blandas
- b) Grado de diferenciación histológica y resonancia magnética nuclear
- c) Tamaño del tumor y tomografía axial computada

- d) Tamaño del tumor y resonancia magnética nuclear
- e) Compromiso de ganglios linfáticos y tomografía axial computada

15) Un niño de 5 años presenta fiebre, dolores óseos y aparición de múltiples petequias en el tórax y las extremidades inferiores. Al examen físico se aprecia pálido, con esplenomegalia moderada. El diagnóstico más probable es:

- a) Linfoma de Hodking
- b) Mieloma
- c) Púrpura trombocitopénico inmune
- d) Leucemia linfática aguda
- e) Leucemia linfática crónica

16) Una paciente de 48 años se realiza una mamografía, que es informada como Birrads 2. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar nueva mamografía en un año
- b) Solicitar nueva mamografía en 6 meses
- c) Repetir la mamografía de inmediato
- d) Solicitar ecografía mamaria
- e) Derivar a biopsia mamaria

17) Las primeras causas de muerte por cáncer, en los hombres y mujeres chilenos, son respectivamente:

- a) Cáncer de pulmón y de estómago
- b) Cáncer de pulmón y de vesícula biliar
- c) Cáncer de estómago y de cuello uterino
- d) Cáncer de pulmón y de mama
- e) Cáncer de estómago y de vesícula biliar

18) Un hombre de 65 años presenta palidez, por lo que se solicita un hemograma, que muestra hematocrito: 27%, plaquetas: 87.000 x mm³, blancos: 3.900 x mm³, VCM: 106 ft, HCM: 32 pg, VHS: 32 mm/h. Al frotis sólo destacan plaquetas disminuidas y macrocitos leve. Al examen físico no se detectan otras alteraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar biopsia de médula ósea
- b) Iniciar vitamina 12 y folatos
- c) Iniciar sulfato ferroso
- d) Solicitar niveles plasmáticos de homocisteína
- e) Solicitar prueba de Coombs directo y haptoglobina

19) Un paciente de 25 años consulta por fiebre recurrente y baja de peso, de 5 kilogramos, en los últimos dos meses. Refiere que consultó a un médico, quien le recetó paracetamol y amoxicilina, sin lograr mejoría. Al examen físico se palpan varias adenopatías axilares izquierdas, de hasta 3,5 cm de diámetro, de consistencia firme. El diagnóstico más probable es:

- a) Leucemia mieloides aguda
- b) Leucemia linfática aguda
- c) Leucemia linfática crónica
- d) Linfoma
- e) Enfermedad por arañazo de gato

20) ¿Cuál de los siguientes es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de endometrio?

- a) Hipertensión arterial
- b) Uso de anticonceptivos orales
- c) Multiparidad
- d) Antecedente de legrado uterino
- e) Menopausia precoz

Prueba 8

Ver GASTROENTEROLOGÍA, Prueba 6

Prueba 9

Ver NEUROLOGÍA, Prueba 5

Prueba 10

Ver INFECTOLOGÍA, Prueba 11

HEMATO-ONCOLOGÍA RESPUESTAS

Prueba 1	5 C	9 A	14 A	16 B	20 B
1 E	6 B	10 D	15 C	17 C	Prueba 7
2 A	7 C	11 B	16 B	18 C	1 A
3 A	8 A	12 B	17 B	19 E	2 E
4 A	9 C	13 C	18 A	20 D	3 A
5 A	10 A	14 D	19 B		4 A
6 E	11 E	15 C	20 D	Prueba 6	5 B
7 B	12 C	16 D	Prueba 5	1 C	6 C
8 C	13 D	17 D	1 C	2 A	7 B
9 A	14 C	18 A	2 A	3 A	8 C
10 A	15 A	19 D	3 B	4 D	9 A
11 A	16 E	20 A	4 B	5 A	10 B
12 C	17 B	Prueba 4	5 A	6 C	11 B
13 C	18 B	1 A	6 D	7 D	12 A
14 D	19 D	2 C	7 B	8 A	13 C
15 D	20 B	3 A	8 E	9 C	14 B
16 D		4 A	9 D	10 C	15 D
17 B	Prueba 3	5 A	10 B	11 D	16 A
18 D	1 A	6 B	11 B	12 C	17 E
19 D	2 D	7 B	12 E	13 B	18 A
20 E	3 C	8 C	13 D	14 B	19 D
Prueba 2	4 C	9 D	14 B	15 D	20 A
1 B	5 E	10 E	15 A	16 D	
2 A	6 E	11 A		17 D	
3 D	7 E	12 E		18 B	
4 D	8 C	13 A		19 A	

X) MIX DE PREGUNTAS DE MEDICINA INTERNA

Prueba 1

1) Un paciente de 65 años presenta astenia y debilidad muscular, especialmente al levantar los brazos

y en la musculatura proximal de las extremidades inferiores. También refiere que presenta cefalea frecuente y dolor al masticar por mucho tiempo, lo que lo obliga a comer lento. En sus exámenes destaca anemia normocítica normocrómica, con VHS: 97 mm/h. El diagnóstico más probable es:

- a) Lupus
- b) Polimiositis
- c) Arteritis de células gigantes
- d) Poliangeítis microscópica
- e) Panarteritis nodosa

2) Un hombre de 76 años presenta varios síncope en las últimas horas. Al examen físico está soporoso, hipoperfundido, tiene una frecuencia cardíaca de 34 latidos por minutos y una presión arterial de 86/48 mmHg. Se ausculta un primer ruido cardíaco de intensidad variable. El diagnóstico más probable es:

- a) Bloqueo AV completo
- b) Enfermedad del nodo sinusal
- c) Síncope vasovagal
- d) Síndrome coronario agudo
- e) Fibrilación auricular

3) Un paciente de 50 años, fumador de 4 cigarrillos al día, presenta disnea de esfuerzos progresiva, de dos meses de evolución, que actualmente es de pequeños esfuerzos, asociada a tos ocasional. Al examen se auscultan crépitos intensos bilaterales, especialmente en las bases, con disminución del tamaño de los campos pulmonares. Presenta además hipocratismo digital. El diagnóstico más probable es:

- a) Fibrosis pulmonar idiopática
- b) Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
- c) Bronquitis crónica
- d) Tuberculosis pulmonar
- e) Neumonía atípica

4) Un paciente afectado de cáncer pulmonar, comienza con un cuadro de constipación de 7 días de evolución, al que hace 2 días se le agrega poliuria, y desde hace algunas horas también se agrega desorientación. Al examen físico se aprecia con deshidratación moderada, en sopor profundo, sin alteraciones neurológicas focales. Los signos vitales son normales, al igual que el hemoglucotest. ¿Qué alteración electrolítica es más probable en este paciente?

- a) Hipernatremia
- b) Hiperkalemia
- c) Hipercalcemia
- d) Hiponatremia
- e) Hipocalcemia

5) Un paciente de 55 años, diabético tipo 2 en tratamiento con glibenclamida y metformina, presenta hemoglobina glicosilada de 9,5%, creatinina plasmática de 2,5 mg/dl y proteinuria de 24 horas de 500 mg. La conducta más adecuada es:

- a) Aumentar la dosis de glibenclamida
- b) Aumentar la dosis de metformina
- c) Iniciar insulina
- d) Iniciar hemodiálisis
- e) Hacer énfasis en el seguimiento de la dieta y correcto uso de los hipoglicemiantes orales y controlar con nuevos exámenes en 3 meses

6) ¿Cuál de las siguientes patologías es más frecuente en hombres que en mujeres?

- a) Dermatomiositis
- b) Espondilitis anquilosante
- c) Artritis reumatoide
- d) Artrosis
- e) Lupus eritematoso sistémico

7) Un paciente de 67 años consulta por astenia y palidez. Se solicita un cell-dyn que demuestra una anemia moderada, normocítica. Se solicita perfil de hierro que constata una ferremia disminuida, transferrina muy aumentada, con bajo índice de saturación y ferritina muy disminuida. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar endoscopia digestiva alta e iniciar sulfato de hierro por vía oral

- b) Diagnosticar anemia por enfermedades crónicas y solicitar exámenes generales, para determinar la causa
- c) Repetir el perfil de hierro
- d) Iniciar vitamina B12 por vía parenteral
- e) Iniciar hierro oral y controlar con un hemograma en 3 meses

8) Un paciente de 61 años presenta dolor de la extremidad inferior derecha, de inicio súbito, asociado a parestesis y dificultad progresiva para mover los ortejos de esa extremidad. Al examen físico se aprecia palidez de la pierna derecha, con clara disminución del pulso pedio. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar Ecografía Doppler de extremidades inferiores
- b) Anticoagular con heparina y realizar angiografía femoral de urgencia
- c) Solicitar pletismografía de volumen de extremidades inferiores
- d) Instalar filtro de vena cava inferior
- e) Administrar trombolíticos endovenosos

9) Un paciente de 47 años, obeso, se realiza una herida en la pierna derecha mientras realizaba deporte. Evoluciona con eritema, dolor y aumento de volumen de la zona. Al examen físico está febril, con una placa eritematosa de 10 cm de diámetro, con bordes difíciles de definir, asociado a adenopatías inguinales ipsilaterales. El tratamiento más adecuado es:

- a) Cloxacilina
- b) Ceftriaxona
- c) Amoxicilina
- d) Clindamicina
- e) Ciprofloxacino

10) Un paciente de 30 años presenta tos con el ejercicio y en varias ocasiones también presenta disnea, asociada a respiración sibilante. Presenta además tos nocturna frecuente y suele hacer crisis obstructivas durante las infecciones virales. En el examen físico se aprecia en buenas condiciones y destaca sólo una leve prolongación del tiempo de espiración. Se solicita una espirometría que confirma la presencia de asma bronquial. El tratamiento más adecuado para este paciente es:

- a) Salbutamol en caso de síntomas
- b) Salmeterol en caso de síntomas y corticoides inhalados según horario
- c) Salbutamol en caso de síntomas y corticoides inhalados, con salmeterol, según horario
- d) Budesonida en caso de síntomas y salbutamol según horario
- e) Salbutamol y salmeterol en caso de síntomas y corticoides orales según horario

11) Un paciente de 30 años presenta movimientos involuntarios de la mano derecha, de 20 segundos de duración, seguidos de dolor epigástrico y desconexión del medio, que dura cerca de 1 minuto. El diagnóstico más probable es:

- a) Crisis tónico clónica
- b) Epilepsia mioclónica
- c) Crisis parcial simple
- d) Crisis parcial compleja
- e) Crisis de ausencia

12) Un paciente de 20 años presenta presiones arteriales elevadas en varias tomas, realizadas en días distintos. El examen físico es normal. Se solicitan hemograma, creatinina plasmática, BUN, sedimento de orina, electrolitos plasmáticos, índice de aldosterona / actividad de renina plasmática y metranefrinas urinarias, identificándose sólo hipokalemia de 2,8 mEq/l, con normalidad de todos los otros parámetros. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Hipertensión arterial esencial
- b) Hipertensión arterial renovascular
- c) Hiperaldosteronismo primario
- d) Síndrome de secreción inadecuada de ADH
- e) Enfermedad de Berger

13) Un paciente cursando su 4 día post accidente vascular encefálico, presenta fiebre y tos con expectoración. Se realiza una radiografía de tórax que muestra una condensación de tipo neumónica en el lóbulo inferior izquierdo. ¿Qué tratamiento es más adecuado?

- a) Cefazolina + clindamicina
- b) Amoxicilina

- c) Levofloxacin
- d) Ceftriaxona + claritromicina
- e) Cefotaximo + metronidazol

14) ¿Cuál de las siguientes vacunas se puede administrar a una paciente embarazada?

- a) Varicela
- b) Sarampión
- c) BCG
- d) Antitetánica
- e) Polio oral

15) Paciente de 55 años, que luego de un accidente de tránsito presenta intenso dolor lumbar, que se irradia por el muslo y pierna derecha. Al examen se aprecia debilidad para extender los ortejos y abducir el muslo de la extremidad inferior derecha. Los reflejos son normales. La raíz nerviosa comprometida es:

- a) L3
- b) L4
- c) L5
- d) S1
- e) S2

16) El examen de elección para diferenciar entre una insuficiencia renal aguda y una insuficiencia renal crónica es:

- a) Producto calcio-fósforo
- b) Hemograma
- c) Orina completa
- d) Ecografía renal
- e) Proteinuria de 24 horas

17) Un escolar de 5 años es traído por su madre, ya que presenta edema de párpados. Al examen se aprecia paciente normotenso, FC:100x', con edema facial, escrotal y de extremidades. Los exámenes de orina muestran proteinuria (++++); gotas de grasa(+), sin hematuria. Usted solicita proteinuria de 24 horas que muestra proteinuria en rango nefrótico. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar C3, C4, ANA, creatinina e iniciar tratamiento corticoidal
- b) Indicar restricción de sodio y agua e indicar un diurético
- c) Realizar electroforesis de proteínas en orina
- d) Explicar a la madre el carácter benigno del cuadro e indicar control S.O.S.
- e) Solicitar biopsia renal

18) Paciente de sexo femenino, de 45 años, inicia dolor en Hipocondrio derecho, muy intenso, asociado a fiebre de un día de evolución. La analítica sanguínea muestra Hcto: 42%, G. Blancos: 15.200, GOT: 55, GPT: 48, Bili: 1,7, amilasa normal. La ecografía abdominal muestra vesícula biliar distendida con paredes engrosadas, barro biliar y cálculo de 12 mm de diámetro, impactado en el bacinete. El tratamiento de elección es:

- a) Colectomía laparoscópica de urgencia
- b) Tratamiento antibiótico y colectomía en frío en 10 días
- c) Colangiografía retrógrada endoscópica y descompresión de la vía biliar
- d) Colectomía abierta a la brevedad
- e) Reposición de volumen y antibióticos y evaluación quirúrgica en 3 meses

19) La manifestación extraarticular más frecuente de la artritis reumatoidea es:

- a) Escleritis-epiescleritis
- b) Mononeuritis múltiple
- c) Nódulos reumatoideos
- d) Afectación pleuro-pulmonar
- e) Afectación cardíaco-pericárdica

20) Paciente de 20 años, consulta por dolor torácico de inicio súbito, con tope inspiratorio, asociado a disnea leve. El examen físico sólo demuestra una leve asimetría en la intensidad del murmullo pulmonar entre ambos hemcampos pulmonares. El diagnóstico más probable y la conducta a seguir son respectivamente:

- a) Tromboembolismo pulmonar y solicitar angioTAC de tórax

- b) Neumonía y administrar antibióticos
- c) Neumotórax hipertensivo e instalar toracostomía
- d) Neumotórax espontáneo y solicitar radiografía de tórax
- e) Tromboembolismo pulmonar e iniciar anticoagulación

21) Un paciente de 70 años consulta por dolor muy intenso en la rodilla izquierda, asociada a aumento de volumen, calor local y eritema. Al examen físico presenta derrame articular y signos inflamatorios en dicha articulación. Se realiza una radiografía de rodilla, que muestra una línea de calcificación a nivel del cartilago articular. La artrocentesis da salida a un líquido turbio, de filancia disminuida, con cerca de 10.000 células, con 90% de polimorfonucleares. La microscopía en el microscopio de campo oscuro observa múltiples cristales con birrefringencia de elongación positiva. La tinción de Gram no muestra bacterias. La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio con paracetamol oral y una dieta pobre en calcio
- b) Iniciar AINEs y alopurinol oral
- c) Solicitar niveles plasmáticos de ácido úrico, calcemia y paratohormona y decidir manejo según resultados
- d) Iniciar AINEs endovenosos y reposo
- e) Iniciar antibióticos endovenosos y realizar drenaje articular

22) Un paciente de 26 años consulta por dispepsia de algunas semanas de evolución, sin otros síntomas. Las molestias suelen ser mayores después de comer. Se realiza ecografía digestiva alta que demuestra esofagitis grado 2, mayor en el esófago distal, sin alteraciones gástricas ni duodenales. La biopsia sólo muestra signos inflamatorios. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar pHmetría de 24 horas
- b) Resolver quirúrgicamente
- c) Iniciar antiácidos luego de cada comida y realizar nueva endoscopia digestiva en un mes
- d) Iniciar omeprazol a dosis estándar
- e) Indicar tratamiento de erradicación de *Helicobacter pylori*

23) Una paciente de 33 años consulta por intolerancia al frío y astenia. Al examen físico se palpa tiroides levemente aumentada de tamaño y de consistencia ligeramente aumentada, sin nódulos. Se solicitan exámenes donde destaca TSH: 15,2 (VN: 0,4 - 4,0). El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad de Basedow Graves
- b) Tiroiditis de Hashimoto
- c) Adenoma tóxico
- d) Tiroiditis subaguda
- e) Déficit de yodo

24) La hemisección medular a nivel torácico se caracteriza por:

- a) Imposibilidad de mover la extremidad contralateral, ausencia de sensibilidad termalgésica ipsilateral y ausencia de sensibilidad táctil y vibratoria contralateral
- b) Imposibilidad de mover la extremidad ipsilateral, ausencia de sensibilidad termalgésica contralateral y ausencia de sensibilidad táctil y vibratoria ipsilateral
- c) Imposibilidad de mover la extremidad ipsilateral, ausencia de sensibilidad termalgésica ipsilateral y ausencia de sensibilidad táctil y vibratoria contralateral
- d) Imposibilidad de mover la extremidad contralateral, ausencia de sensibilidad termalgésica ipsilateral y ausencia de sensibilidad táctil y vibratoria ipsilateral
- e) Imposibilidad de mover la extremidad ipsilateral, ausencia de sensibilidad termalgésica contralateral y ausencia de sensibilidad táctil y vibratoria contralateral

25) ¿Cuál de las siguientes patologías se asocia a bajo riesgo de embolia sistémica?

- a) Fibrilación auricular
- b) Estenosis mitral
- c) Infarto anterior y apical
- d) Miocardiopatía dilatada
- e) Insuficiencia aórtica reumática

26) Un paciente presenta disnea de esfuerzos, ortopnea y disnea paroxística nocturna. Al examen físico se observa desplazamiento del choque de la punta cardíaca al quinto espacio intercostal, en la línea axilar anterior, se ausculta un soplo diastólico III/VI en todo el precordio y se palpa el pulso arterial periférico muy amplio (pulso Celler). El diagnóstico más probable es:

- a) Estenosis aórtica

- b) Estenosis mitral
- c) Insuficiencia aórtica
- d) Insuficiencia mitral
- e) Miocardiopatía hipertrófica obstructiva

27) Un hombre de 66 años, consulta por astenia. El examen físico demuestra palidez moderada y se palpan adenopatías pequeñas generalizadas. El hemograma presenta hematocrito: 27%, Hb: 8,8, blancos: 36.000, linfocitos: 88%, neutrófilos: 7%, monocitos: 1%, basófilos: 0%, eosinófilos: 0%, plaquetas: 85.000. El diagnóstico más probable es:

- a) Linfoma
- b) Leucemia mieloide crónica
- c) Leucemia linfática crónica
- d) Mieloma
- e) Mononucleosis infecciosa

28) Carpintero de 62 años, ex fumador de 20 cigarrillos diarios. Consulta por presentar tos crónica con expectoración mucosa y disnea progresiva, actualmente de medianos a pequeños esfuerzos. Examen pulmonar: sibilancias bilaterales escasas y disminución global del murmullo pulmonar. Espirometría: CVF % Teórico: 99 (Basal) 112 (Post Broncodilatador) VEF1 % Teórico: 54 (Basal) 56 (Post Broncodilatador) VEF1/ CVF %: 44 (Basal) 43 (Post Broncodilatador)

¿Cuál de las siguientes indicaciones es la más apropiada?

- a) Broncodilatador en aerosol, expectorantes y profilaxis periódica con antibióticos
- b) Antibióticos y broncodilatadores sólo durante las descompensaciones
- c) Broncodilatadores en aerosol a permanencia
- d) Corticoides por vía inhalatoria a permanencia
- e) Antibióticos y expectorantes sólo durante las descompensaciones

29) Una mujer de 62 años consulta por dolor en fosa ilíaca izquierda. Refiere dos episodios previos similares. Al examen hay sensibilidad en la zona y signos de irritación peritoneal. El diagnóstico más probable es:

- a) infección urinaria
- b) diverticulitis
- c) litiasis renal
- d) proceso inflamatorio pelviano
- e) torsión de tumor ovárico

30) ¿Cuál es el examen más adecuado para el diagnóstico de la infección aguda por el virus de la hepatitis A?

- a) Anticuerpos IgE anti-virus A
- b) Anticuerpos IgM anti-virus A
- c) Anticuerpos IgG anti-virus A
- d) Reacción de polimerasa en cadena para virus A
- e) Anticuerpos IgA anti-virus A

31) A una mujer de 25 años, asintomática se le pesquisa un bocio difuso II de la clasificación OMS en un examen físico de rutina.

¿Con qué examen corresponde iniciar el estudio?

- a) Determinación de TSH ultrasensible
- b) Determinación de T4 libre
- c) Determinación de T3
- d) Ecotomografía tiroidea
- e) Cintigrama tiroideo

32) Las infecciones en pacientes con neutropenia febril son producidas principalmente por:

- a) Bacilos Gram negativos anaerobios facultativos
- b) Anaerobios
- c) Staphylococcus aureus metilino resistentes (SARM)
- d) Aspergillus niger

e) *Streptococcus pneumoniae*

33) Un paciente de 32 años, VIH (+) diagnosticado hace 2 años, ingresa por presentar tos seca, disnea progresiva y fiebre desde hace 10 días. Examen físico: FC: 125/min, temperatura axilar: 38 °C, FR: 24/min, placas blanquecinas en cara interna de mejillas y paladar duro, adenopatías cervicales bilaterales indoloras y examen pulmonar con escasas crepitaciones en ambas bases. La radiografía de tórax muestra sombras retículo-nodulares bilaterales.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Linfoma no-Hodgkin
- b) Tuberculosis ganglionar
- c) Neumonía por *Pneumocystis carinii*
- d) Candidiasis diseminada
- e) Neumonía neumocócica

34) ¿Cuál es el tratamiento inicial de elección del púrpura trombocitopénico inmunológico primario en el adulto?

- a) Inmunosupresores
- b) Esplenectomía
- c) Corticoides
- d) Interferon
- e) Inmunoglobulina

35) Hombre de 67 años, hipertenso y fumador que acude a urgencias por disnea de grandes esfuerzos en el último mes. La auscultación demuestra disminución del murmullo vesicular sin otros hallazgos. La Rx de tórax y el ECG realizados son normales. Los valores en sangre de péptido natriurético tipo B son de 60 pg/ml. (valores normales <100pg/ml.) ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el menos probable?:

- a) Disfunción ventricular sistólica.
- b) Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
- c) Asma.
- d) Hipertensión pulmonar primaria.
- e) Tromboembolismo pulmonar.

36) Hombre de 27 años de edad que desde hace varios meses presenta cuadros de dolor abdominal con aumento del número de deposiciones, de una duración de 6-8 días y que ceden de forma espontánea. Acude al Servicio de Urgencias por un cuadro similar a los previos pero de mayor intensidad, con deposiciones líquidas y rectorragia. Hb 10,4 mg/dl, Hto. 33%, VCN 78 fl, Leucocitos 8200 (83 P), VSG 48, plaquetas 390.000. Urea, iones y bioquímica hepática: normales, PCR 2,1 mg/dl. Fe 37 microgr/dl. Colonoscopia: hiperemia en recto y desde 10 cm úlceras serpinginosas distribuidas por todo el colon, con mucosa normal entre las úlceras. Tránsito intestinal: estenosis a nivel de íleon terminal. ¿Qué cuadro de los que se mencionan a continuación le parece el diagnóstico más probable?:

- a) Colitis ulcerosa.
- b) Colitis por shigelas.
- c) Colitis pseudomembranosa.
- d) Colitis isquémica.
- e) Enfermedad de Crohn.

37) En la esclerosis lateral amiotrófica, la lesión se localiza en:

- a) Corteza entorrinal.
- b) Núcleo Caudado.
- c) Sustancia Negra.
- d) Corteza cerebelosa.
- e) Asta anterior de la médula.

38) Un día en que la presión atmosférica es de 705 mmHg, un paciente de 40 años se presenta en la sala de urgencias con una presión arterial de oxígeno de 37 mmHg, una presión de anhídrido carbónico de 82 mmHg y un pH de 7.22. Calculamos la presión alveolar de oxígeno, que resulta ser 39 mmHg. Entre las causas de insuficiencia respiratoria mencionadas más abajo ¿cuál será la más probable? :

- a) Una embolia de pulmón.
- b) Es una insuficiencia respiratoria crónica re-agudizada en un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).
- c) Tiene una crisis asmática grave.
- d) Una neumonía extensa.
- e) Una sobredosis de morfina.

39) ¿Cuál es, de los siguientes, el más útil y eficaz factor de pronóstico en el cáncer de mama?:

- a) Negatividad de los receptores de estrógenos en las células tumorales.
- b) Presencia de focos de componente intraductal en puntos distantes al tumor.
- c) Invasión de ganglios linfáticos.
- d) Presencia de mutación en el gen BRCA1.
- e) Altos niveles de catepsina D en las células tumorales.

40) ¿Cuál es la definición de intolerancia glucídica o tolerancia a la glucosa alterada?:

- a) Glucemia en ayunas entre 110 y 125 mg/dL.
- b) Glucemia tras sobrecarga oral de glucosa menor de 140 mg/dL.
- c) Glucemia tras sobrecarga oral de glucosa mayor de 200 mg/dL.
- d) Glucemia tras sobrecarga oral de glucosa entre 140 y 199 mg/dL.
- e) Glucemia en ayunas mayor de 125 mg/dL.

41) Un paciente, con antecedente de hipertensión y ACxFA presenta súbitamente dificultades para ver y para caminar. Al examen se constata hemianopsia homónima izquierda, con monoparesia M2, de la extremidad inferior izquierda. El diagnóstico más probable es:

- a) Accidente vascular encefálico isquémico de arteria cerebral anterior
- b) Accidente vascular encefálico isquémico de arteria cerebral media
- c) Accidente vascular encefálico isquémico de arteria cerebral posterior
- d) Accidente vascular encefálico isquémico de arterias penetrantes
- e) Accidente vascular hemorrágico de arterias penetrantes

42) Un paciente diabético, hipertenso, dislipidémico y fumador, en tratamiento con insulina, enalapril, aspirina y atorvastatina, que desde hace 4 meses presenta dolor precordial, que aparece al caminar dos cuadras, lo que le obliga a detenerse, cediendo con el reposo y que dura cerca de 3 minutos. Se solicita un electrocardiograma que resulta normal. La conducta más adecuada es:

- a) Mejorar sus factores de riesgo cardiovascular y controlar en un mes
- b) Mejorar sus factores de riesgo cardiovascular y solicitar un test de esfuerzo
- c) Realizar coronariografía de urgencia
- d) Mejorar sus factores de riesgo cardiovascular y solicitar ecocardiografía
- e) Mejorar sus factores de riesgo cardiovascular e iniciar anticoagulación oral

43) Un niño de 5 años presenta hematuria y aumento de volumen facial. Al examen se constata con hipertensión arterial y con edema facial, escrotal y de extremidades inferiores. Se solicita un sedimento de orina que demuestra leucocituria, con 10 GB x campo y hematuria de 50 GR x campo con 20% de dismorfia. También se observan algunos cilindros eritrocitarios. Se solicitan exámenes de sangre que muestran hemograma normal, creatinina: 0,7 mg/dl, BUN: 8 mg/dl, ANA (-), ANCA (-) y complemento disminuido. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar restricción hidrosalina e iniciar diuréticos y antihipertensivos
- b) Iniciar corticoides orales
- c) Iniciar corticoides e inmunosupresores endovenosos
- d) Derivar a hemodiálisis
- e) Derivar para biopsia renal

44) ¿Cuál de las siguientes patologías NO es un síndrome mieloproliferativo?

- a) Policitemia vera
- b) Mieloptosis
- c) Leucemia mieloide crónica
- d) Mielofibrosis

e) Trombocitosis esencial

45) Un paciente de 67 años, consulta por dolor en el hombro derecho. Al examen se no se observan signos inflamatorios. La movilidad es completa, pero dolorosa, especialmente con los movimientos de rotación extrema. Se solicita radiografía de hombro, que demuestra una disminución del espacio articular, con esclerosis subcondral y presencia de un quiste subcortical. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome del manguito rotador
- b) Bursitis
- c) Artrosis de hombro
- d) Artritis reumatoide
- e) Atrapamiento del tendón largo del biceps

46) Un paciente de 55 años, indigente fumador y alcohólico, con daño hepático crónico y EPOC, presenta un derrame pleural izquierdo, moderado. Se decide realizar toracocentesis, que da salida a líquido amarillo, transparente, con 100 células por mm³, de predominio mononuclear, con LDH: 30 UI/l, proteínas: 1,4 g/dl, lactato: 2 mg/dl, pH: 7,35. La LDH plasmática fue 130 UI/l y las proteínas plasmáticas fueron 6,4 g/dl. El diagnóstico más probable, de entre los siguientes, es:

- a) Tuberculosis pleural
- b) Cáncer pulmonar, con compromiso pleural
- c) Derrame paraneumónico simple
- d) Empiema
- e) Transudado pleural, secundario a cirrosis hepática

47) Un paciente de 46 años, presenta obesidad central, con fascie de luna, turgor, adelgazamiento de la piel, hipertensión arterial, hirsutismo y atrofia muscular. ¿Cuál de las siguientes pruebas es más adecuada para continuar el diagnóstico?

- a) Cortisol basal
- b) Cortisol basal y post-ACTH
- c) Cortisol basal y post-dexametasona
- d) Cortisol y ACTH basales
- e) ACTH basal y post-metilprednisolona

48) Un paciente de 47 años cursando un distrés respiratorio por virus Hanta, se encuentra en la UCI, conectado a un ventilador mecánico. Está muy comprometido y de pronto pierde la consciencia. Al examinarlo usted constata que no tiene pulso, por lo que inicia masaje cardiorespiratorio. Luego de 5 ciclos continúa sin pulso y el monitor muestra una taquicardia ventricular. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar amiodarona endovenosa y continuar el masaje cardíaco
- b) Administrar adrenalina endovenosa y continuar el masaje cardíaco
- c) Administrar atropina endovenosa y continuar el masaje cardíaco
- d) Realizar desfibrilación eléctrica y continuar el masaje cardíaco
- e) Realizar desfibrilación eléctrica, administrar noradrenalina endovenosa y reevaluar

49) La penicilina aún continúa vigente como tratamiento antibiótico para múltiples infecciones. Identifique el microorganismo que NO debe ser tratado con penicilina en la actualidad:

- a) Treponema pallidum
- b) Streptococcus pyogenes
- c) Proteus mirabilis
- d) Neisseria meningitidis
- e) Bacterias anaerobias

50) ¿Cuál de las siguientes es una contraindicación del uso de sales de rehidratación oral, en un paciente con diarrea aguda?

- a) Diarrea disintérica
- b) Distensión abdominal progresiva
- c) Vómitos alimentarios, en 3 oportunidades

- d) Deshidratación moderada
- e) Diarrea por *Escherichia coli* enteroinvasiva

51) ¿Cuál de las siguientes alternativas es MENOS sugerente de un trastorno digestivo funcional?

- a) Inicio a los 30 años
- b) Distensión abdominal
- c) Aumento de peso
- d) Síntomas nocturnos
- e) Deposiciones con mucosidad

52) Un paciente con diarrea aguda, evoluciona con oliguria. Se solicitan exámenes que demuestran una creatinina de 3,2 mg/dl, BUN: 69 mg/dl, Na⁺ plasmático: 136 mEq/l, K⁺ plasmático: 5,3 mEq/l. Además presenta Na⁺ urinario: 5mEq/l y K⁺ urinario: 12mEq/l. El diagnóstico más probable es:

- a) Necrosis tubular aguda
- b) Insuficiencia renal aguda prerrenal
- c) Síndrome hemolítico urémico
- d) Diabetes insípida
- e) Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética

53) ¿Un paciente de 52 años, con daño hepático por alcohol, avanzado, presenta hematemesis por rotura de várices esofágicas. La conducta más adecuada para prevenir nuevos sangramientos es:

- a) Indicar terlipresina a permanencia
- b) Realizar ligadura de várices
- c) Iniciar betabloqueo
- d) Realizar ligadura de várices e iniciar betabloqueo
- e) Instalar un TIPS

54) Las vasculitis alérgica de Churg-Strauss, presenta ANCA positivo, en una proporción moderada de los casos. Clínicamente se manifiesta como:

- a) Asma de difícil manejo, que luego se acompaña de glomerulonefritis
- b) Exantema purpúrico, de extremidades inferiores, con hematuria, artritis y compromiso gastrointestinas, como hematoquezia por ejemplo
- c) Rinosinusitis de difícil manejo, seguida de hemoptisis y glomerulonefritis, con rápido deterioro de la función renal
- d) Cefalea, fiebre, amaurosis fugax, claudicación mandibular, polimialgia reumática y elevación de la VHS
- e) Exantema pseudopapular (ronchas) muy pruriginoso, con lesiones que confluyen hasta formar grandes placas, afectando las mucosas y asociándose a hipotensión arterial

55) Los nódulos tiroideos se caracterizan por:

- a) Palparse en relación al cartílago tiroides
- b) Ser dolorosos a la palpación
- c) Ascender con la deglución
- d) Ser fáciles de movilizar
- e) Ser difíciles de visualizar ecográficamente

56) ¿Cuál de las siguientes alternativas supone una mayor gravedad en un paciente cursando con una neumonía adquirida en la comunidad?

- a) Neumonía por *Klebsiella BLEE*
- b) PaFi de 100
- c) Frecuencia respiratoria de 29 respiraciones por minuto
- d) Derrame pleural asociado
- e) Compromiso de los lóbulos inferior y medio derechos

57) Una paciente de 45 años, portadora de VIH, asintomático, sin triterapia, se realiza exámenes de control que muestran una carga viral de 20.000 copias/ml y linfocitos CD4 de 160 células por mm³. El hemograma, perfil bioquímico, pruebas hepáticas y pruebas de función renal son normales. ¿Cuál de las siguientes conductas es MENOS apropiada para el manejo de este paciente?

- a) Aconsejar el inicio de triterapia antirretroviral

- b) Indicar vacunación contra la influenza
- c) Aconsejar vacunación antineumocócica
- d) Iniciar cotrimoxazol trisemanal, como profilaxis de *Pneumocystis carinii*
- e) Indicar anticonceptivos orales, como método de prevención de embarazo

58) Un lactante de 8 meses presenta palidez. Se solicita hemograma que demuestra anemia con hemoglobina de 9,0 g/dl, VCM: 82 fl, HCM: 29 pg, con anisocitosis y sin compromiso de las plaquetas ni de los glóbulos blancos. El diagnóstico más probable es:

- a) Anemia hemolítica
- b) Anemia ferropénica
- c) Anemia por enfermedades crónicas
- d) Talasemia
- e) Anemia por déficit de vitamina B12 o folatos

59) El síndrome alterno se caracteriza por presentar compromiso somático de un hemicuerpo, asociado a compromiso de nervios craneales contralaterales. La localización más frecuente de una lesión que produzca uno de estos síndromes es:

- a) Cuerpo estriado
- b) Cuerpo calloso
- c) Tálamo
- d) Hipotálamo
- e) Tronco cerebral

60) Una paciente de 25 años presenta fiebre, astenia y dolores músculoarticulares de un mes de evolución. Al examen físico se observan lesiones cutáneas eritematosas en las mejillas, dorso nasal y en los hombros. Se solicitan exámenes generales, donde destaca un hemograma con Hcto: 35%, plaquetas: 80.000, blancos: 4.000, con 80% de neutrófilos, 18% de linfocitos y 2% de monocitos. Presenta además elevación de la creatina plasmática. El diagnóstico más probable es:

- a) Leucemia linfática crónica
- b) Leucemia mieloide aguda
- c) Infección por VIH
- d) Lupus eritematosos sistémico
- e) Mononucleosis infecciosa

61) El síndrome urémico se caracteriza por todo lo siguiente EXCEPTO:

- a) Asterixis
- b) Pericarditis
- c) Hipo o singulto
- d) Fétor urémico
- e) Hipercoagulabilidad

62) Un paciente de 7 años presenta lesiones en las mejillas y cerca de la boca, caracterizadas por pequeñas pápulas, confluentes, con costras amarillentas sobre ellas y también algunas bulas fáciles de romper. Se aprecia en buenas condiciones y el resto del examen físico es normal. El agente etiológico más probable es:

- a) *Streptococcus pyogenes*
- b) *Staphylococcus aureus*
- c) *Streptococcus agalactiae*
- d) *Pseudomona aereginosa*
- e) *Leptospira*

63) ¿Cuál de las siguientes asociaciones entre cuadro clínico y patología es INCORRECTA?

- a) Cefalea temporoccipital, recurrente, opresiva – Cefalea tensional
- b) Cefalea himicránea, pulsátil, recurrente – Jaquaca
- c) Cefalea progresiva, matinal, con signos focales – Tumor cerebral
- d) Dolor neurálgico en la mejilla, muy intenso, de segundos de duración – Cluster
- e) Cefalea muy intensa, de inicio súbito – hemorragia subaracnoidea

64) Una paciente de 30 años, esquizofrénica, en tratamiento con risperidona, presenta amenorrea de 5 meses de evolución, asociado a secreción mamaria láctea. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar niveles plasmáticos de prolactina
- b) Solicitar RMN de silla turca
- c) Solicitar mamografías

- d) Solicitar TSH y prueba de progesterona
- e) Iniciar anticonceptivos orales

65) Un paciente de 67 años, diabético y fumador, consulta por dolor epigástrico intenso, de 4 horas de evolución. Al examen físico se aprecia sudoroso y taquicárdico. El examen abdominal es normal, pero el examen cardíaco demuestra un ritmo de galope por presencia de un cuarto ruido. EL hemoglucotest resulta en 120. Se decide tomar un electrocardiograma, que presenta un supradesnivel en las derivaciones DII, DIII y AVF. Evoluciona luego con marcada hipotensión e ingurgitación yugular. El examen pulmonar es normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Infarto transmural de pared lateral con taponamiento cardíaco, por rotura de la pared libre
- b) Infarto transmural de pared inferior con infarto de ventrículo derecho
- c) Infarto no Q de pared inferior, con rotura del tabique interventricular
- d) Infarto no Q de pared lateral, con formación de pseudoaneurisma ventricular
- e) Infarto transmural de pared inferior, con rotura de músculo papilar

66) Un paciente de 7 años presenta detención del crecimiento. La madre refiere que presenta deposiciones frecuentes, abundantes, de color amarillento, brillantes, en ocasiones con gotas de grasa. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar colonoscopia
- b) Solicitar test de hemorragias ocultas en deposiciones
- c) Solicitar coprocultivo y parasitológico directo
- d) Iniciar dieta sin gluten
- e) Solicitar test de Sudán de deposiciones

67) Un paciente de 47 años, consulta por palpitaciones muy intensas, asociadas a varias lipotimias. Los síntomas iniciaron bruscamente hace 40 minutos. Al examen físico se aprecia FC: 170x', PA: 110/70, con signos de vasoconstricción periférica. Se solicita un electrocardiograma que demuestra una taquicardia regular con QRS ancho, a 175 x'. El diagnóstico más probable es:

- a) Flutter auricular
- b) Taquicardia paroxística supraventricular
- c) Taquicardia ventricular
- d) Enfermedad del nodo sinusal
- e) Bloqueo aurículo-ventricular completo

68) Respecto a los linfomas de bajo grado es verdadero que:

- a) Suelen dar síntomas desde los estadios iniciales
- b) La quimioterapia suele ser curativa
- c) Suelen tener sobrevidas elevadas, cercanas a 10 años
- d) Se diagnostican mediante estudio de médula ósea
- e) Suelen iniciarse en otros órganos diferentes a los ganglios linfáticos, como el bazo y la piel

69) Un paciente de 55 años, fumador, consulta por tos con expectoración verdosa, de 4 semanas de evolución. Al examen físico de auscultan algunos crépitos gruesos difusos. Se solicita radiografía de tórax que demuestra bandas de retracción en ambos ápices pulmonares. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Cáncer pulmonar
- b) Neumonía atípica
- c) Tuberculosis pulmonar
- d) Bronquiectasias
- e) Fibrosis pulmonar

70) Las melanoplaquias son características de:

- a) Hipertiroidismo
- b) Enfermedad de Addison
- c) Hipopituitarismo
- d) Síndrome de Cushing
- e) Hipotiroidismo

Prueba 2

1) Una paciente de 40 años presenta dolor en las manos desde hace 3 meses. Refiere marcada rigidez articular, que dura cerca de una hora. Al examen físico se aprecia artritis de ambas muñecas y de varias articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales, de manera bilateral. El

tratamiento de elección de la patología descrita es:

- a) Paracetamol
- b) Prednisona
- c) Ciclofosfamida + corticoides
- d) Alopurinol más AINEs
- e) Metotrexato

2) Mujer, 60 años, con estenosis mitral severa, inicia bruscamente disnea y palpitaciones. Al examen FC:140x', PA:85/35, MP(+), con crépitos intensos y difusos, RI2T con soplo diastólico IV/VI, mayor en á pex. La conducta inicial más adecuada es:

- a) Administrar amiodarona endovenosa en bolo
- b) Entregar oxígeno a FiO2 elevadas y soporte ventilatorio con Bipap
- c) Reponer fluidos con suero fisiológico
- d) Cardioversión eléctrica inmediata
- e) Administrar furosemida endovenosa, asociada a drogas vasoactivas

3) Un paciente de 18 años presenta un cuadro de 3 días de evolución, de tos con expectoración mucopurulenta, asociado a fiebre hasta 39°C y calofríos solemnes. En las últimas horas se agrega disnea y marcado malestar. Al examen se aprecia orientado, disneico, con FC: 109x', PA: 120/76 mmHg, FR: 30 rpm, SatO2: 87% a FiO2 ambiental, que mejora a 95% con oxígeno. El antibiótico de elección es:

- a) Clindamicina
- b) Amoxicilina
- c) Amoxicilina más ácido clavulánico
- d) Ceftriaxona
- e) Ceftriaxona + claritromicina

4) Las causas más frecuentes de insuficiencia renal crónica, en niños y adultos, son respectivamente:

- a) Prerenal y prerrenal
- b) Malformaciones nefrourológicas e hipertensión
- c) Glomerulonefritis y diabetes
- d) Malformaciones nefrourológicas y diabetes
- e) Glomerulonefritis e hipertensión arterial

5) ¿Qué alteración retinal se asocia a mayor riesgo de ceguera en un paciente diabético?

- a) Exudados céreos
- b) Microaneurismas
- c) Microinfartos
- d) Vasos de neoformación
- e) Microhemorragias

6) El tratamiento de elección de la onicomicosis es:

- a) Clotrimazol tópico
- b) Terbinafina oral
- c) Fluconazol oral
- d) Terbinafina tópica
- e) Griseofulvina oral

7) Un paciente de 77 años presenta dolor intenso y aumento de volumen en la rodilla derecha, de un par de horas de evolución. Al examen se observa dolor, eritema y aumento de la temperatura de la articulación. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar radiografía simple de rodilla
- b) Solicitar uricemia, calcemia y niveles plasmáticos de paratohormona
- c) Indicar reposo e iniciar AINEs
- d) Realizar artrocentesis y estudio de líquido sinovial
- e) Administrar corticoides intraarticulares

8) En el electrocardiograma las extrasístoles auriculares se caracterizan por presentar:

- a) Complejo QRS ancho y presencia de pausa compensatoria
- b) Complejo QRS angosto y ausencia de pausa compensatoria
- c) Complejo QRS ancho y ausencia de pausa compensatoria
- d) Alargamiento del segmento QT y alteraciones de la repolarización

e) Acortamiento del segmento QT sin alteraciones de la repolarización

9) Un paciente de 36 años presenta aumento de volumen inguinal, de 4 meses de evolución, asociado a baja de peso y fiebre recurrente. Al examen físico se aprecia algo pálido y presenta varias adenopatías inguinales derechas, algunas de ellas confluentes, siendo la mayor de casi 4 centímetros. El bazo se palpa de tamaño normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Leucemia linfática aguda
- b) Leucemia linfática crónica
- c) Leucemia mieloide aguda
- d) Linfoma
- e) Adenopatías reactivas

10) El efecto adverso más frecuente del tratamiento antituberculoso es:

- a) Alergia
- b) Alteraciones hepáticas
- c) Anemia
- d) Daño renal
- e) Alteraciones visuales

11) Un paciente de 15 años presenta parestesias y debilidad de las cuatro extremidades, de 48 horas de evolución, que han ido en aumento. Al examen físico se aprecia abolición de los reflejos osteotendinosos e hipotonía. El diagnóstico más probable es:

- a) Polirradiculoneuropatía desmielinizante (Síndrome de Guillain Barré)
- b) Compresión medular
- c) Miastenia gravis
- d) Infarto lacunar de troncoencéfalo
- e) Infarto cerebeloso

12) ¿Cuál de las siguientes no es una indicación de hemodiálisis de urgencia?

- a) Hiponatremia grave, que no responde al tratamiento médico
- b) Hiperkalemia grave, que no responde al tratamiento médico
- c) Pericarditis urémica
- d) Edema pulmonar que no responde al tratamiento médico
- e) Acidosis grave, que no responde al tratamiento médico

13) Un paciente de 35 años presenta disuria intensa y secreción uretral. Refiere haber tenido relaciones sexuales sin protección. Se solicita un Gram de secreción uretral, que demuestra la presencia de cocáceas Gram negativas intracelulares, por lo que se le administra ceftriaxona 250 mg por vía intramuscular. Dos semanas después reconsulta por persistir con los mismos síntomas. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar urocultivo y sedimento de orina
- b) Iniciar corticoides
- c) Administrar ceftriaxona 1 g por una vez, por vía intramuscular
- d) Administrar ciprofloxacino 500 mg por una vez, por vía oral
- e) Iniciar doxiciclina por 10 días, por vía oral

14) Mujer de 64 años, ingresa por cuadro de hemorragia digestiva por úlcera gástrica. Inicialmente presenta hipotensión y oliguria. En sus exámenes destaca Crea:3,4 y BUN:80. Se administra volumen con suero fisiológico y se realiza tratamiento endoscópico de la úlcera, con buen resultado. Se mantiene con presión arterial cercana a 110/70. Al 3er día reinicia buenas diuresis, cercanas a 4000cc/día, sin embargo persiste con crea:3,3. La causa más probable de su alteración de la función renal es:

- a) Hipovolemia con compromiso prerrenal
- b) Necrosis tubular aguda
- c) Nefropatía diabética
- d) Válvula aórtica bicúspide
- e) Coartación aórtica

15) Una paciente hipertensa de 64 años de edad ingresa al servicio de urgencia de su hospital, por presentar hemiplejía faciobraquiocrural izquierda, de 65 minutos de evolución. Al examen físico se constata dicha hemiplejía, con abolición de reflejos izquierdos. Se realiza TAC de cerebro sin contraste, que es informado como normal. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar TAC de cerebro con contraste

- b) Administrar ácido acetil-salicílico oral
- c) Realizar control estricto de presión arterial y glicemia, de modo de mantenerlas en rango normal
- d) Solicitar angiografía cerebral
- e) Administrar fibrinolítico endovenoso

16) El examen de elección ante la sospecha de fiebre tifoidea en un paciente con 10 días de síntomas es:

- a) Hemocultivo
- b) Biopsia de médula ósea
- c) Coprocultivo
- d) IgM e IgG para Salmonella typhi
- e) El examen físico

17) De entre las siguientes alternativas, el mejor examen para determinar el origen prerrenal de una insuficiencia renal aguda es:

- a) El examen físico
- b) La relación entre BUN y creatinina
- c) El clearance de creatinina de 24 horas
- d) La fracción excretada de sodio
- e) La orina completa

18) Un paciente de 24 años consulta por dolor epigástrico recurrente, de características urentes. Usted solicita una endoscopia digestiva alta que demuestra una úlcera duodenal activa, sin estigmas de sangrado reciente. El test de ureasa resulta positivo. La medida terapéutica de primera línea es:

- a) Omeprazol en dos dosis diarias, a permanencia.
- b) Tratamiento de erradicación de H. pylori por 7 a 10 días.
- c) Dieta estricta, evitando grasas, condimentos e irritantes y control endoscópico cada 3 meses.
- d) Inhibidores H2 diarios, asociados a antiácidos, según síntomas.
- e) Prohibir el uso de AINEs y asociar un inhibidor de la bomba de protones en dosis única diaria.

19) La mejor conducta ante la sospecha clínica de EPOC es:

- a) Iniciar broncodilatadores, asociados a corticoides inhalatorios
- b) Iniciar terapia broncodilatadora con salbutamol e ipratropio
- c) Solicitar radiografía de tórax e iniciar tratamiento según hallazgos
- d) Solicitar espirometría
- e) Indicar oxigenoterapia domiciliaria, asociando broncodilatadores inhalatorios

20) La presentación clínica más habitual de la granulomatosis de Wegener es:

- a) Astenia, fiebre, compromiso de coronarias y arterias mesentéricas
- b) Glomerulonefritis rápidamente progresiva y ANCA positivo en patrón perinuclear
- c) Asma refractario a tratamiento y con posterioridad afectación renal
- d) Rinosinusitis de difícil manejo, asociada a glomerulonefritis rápidamente progresiva y afectación pulmonar
- e) Insuficiencia renal, hematuria, accidentes vasculares encefálicos a repetición y púrpura palpable de extremidades inferiores

21) Un paciente de 62 años, con antecedente de cirrosis hepática por consumo de alcohol, de larga data, en tratamiento con dosis altas de furosemida y espironolactona. Consulta por aumento del perímetro abdominal, asociado a disnea. Al examen se observa ascitis a tensión. Se realiza paracentesis diagnóstica, que da salida a líquido citrino, cuyo análisis demuestra proteínas: 1,7g/dl y glóbulos blancos: 50 por mm³, con 80% de polimorfonucleares. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar diuréticos de asa por vía endovenosa
- b) Iniciar cefalosporinas de tercera generación por vía endovenosa, sin drenar el líquido ascítico
- c) Instalar un TIPS
- d) Drenar el líquido ascítico, con reposición de albúmina
- e) Drenar el líquido ascítico, bajo cobertura antibiótica, con cefalosporinas de tercera generación

22) ¿Cuál de las siguientes asociaciones entre marcadores inmunológicos y patología es correcta?

- a) Anticuerpos anti-ribonucleoproteína – Dermatomiositis
- b) Anticuerpos anti-proteína P – Actividad lúpica
- c) Anticuerpos anti-histona – Enfermedad de Sjögren
- d) Anticuerpos anticentrómero – Esclerodermia

e) Anticuerpos antinucleares, patrón citoplasmático – Poliangeítis microscópica

23) ¿Cuál de los siguientes enunciados se correlaciona mejor con el cuadro clínico de la tiroiditis subaguda?

- a) Mujer de 55 años con bocio difuso, no doloroso y síntomas leves de hipotiroidismo
- b) Mujer de 39 años con bocio doloroso, uninodular, asociado a síntomas de hipertiroidismo leve y cintigrafía con yodo radiactivo que demuestra nódulo caliente
- c) Mujer de 30 años con otalgia y bocio difuso, doloroso, asociado a síntomas leves de hipertiroidismo
- d) Mujer de 35 años con temblor, sudoración y retracción palpebral, asociado a bocio difuso, no doloroso
- e) Mujer de 51 años con bocio multinodular de tamaño moderado, asociado a constipación e intolerancia al frío

24) Un paciente de 61 años presenta temblor de la mano derecha, que se presenta en reposo, con frecuencia de 3 hertzios y que desaparece al tomar objetos o realizar otros movimientos. Camina con pasos cortos y muestra clara disminución del braceo. El diagnóstico más probable es:

- a) Temblor esencial
- b) Síndrome cerebeloso
- c) Enfermedad de Parkinson
- d) Esclerosis lateral amiotrófica
- e) Síndrome piramidal

25) ¿Cuál de los siguientes hallazgos es más orientador a una alteración de la hemostasia primaria?

- a) Alargamiento del TTPA
- b) Equimosis
- c) Antecedentes familiares de hemorragias
- d) Petequias
- e) Hemartrosis

26) Un paciente presenta disnea de esfuerzos, ortopnea y disnea paroxística nocturna. Al examen físico se observa desplazamiento del choque de la punta cardíaca al quinto espacio intercostal, en la lí nea axilar anterior, se ausculta un soplo diastólico III/VI en todo el precordio y se palpa el pulso arterial periférico muy amplio (pulso Celler). El diagnóstico más probable es:

- a) Estenosis aórtica
- b) Estenosis mitral
- c) Insuficiencia aórtica
- d) Insuficiencia mitral
- e) Miocardiopatía hipertrófica obstructiva

27) En un paciente con hipertensión arterial esencial grado I, la primera etapa de tratamiento consiste en:

- a) restricción de actividad física.
- b) betabloqueadores.
- c) diuréticos tiazídicos.
- d) régimen hiposódico.
- e) ansiolíticos.

28) Paciente de 18 años consulta por episodios recurrentes de tos, expectoración y en ocasiones respiración sibilante. Actualmente asintomático y con examen físico normal. Flujo espiratorio máximo (PEF) normal.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Indicar broncodilatador por vía inhalatoria
- b) Pedir radiografía de tórax
- c) Pedir prueba de provocación bronquial con metacolina
- d) Solicitar espirometría basal y con broncodilatador
- e) Solicitar test cutáneo

29) Mujer de 28 años, con historia de tres años de diarrea frecuente asociada a intenso dolor abdominal cólico. Ha perdido 10 Kg de peso y al examen se palpa una masa en el cuadrante inferior derecho del abdomen. El diagnóstico más probable es:

- a) adenocarcinoma de colon
- b) Enfermedad de Crohn

- c) colitis ulcerosa
- d) carcinoma de intestino delgado
- e) enfermedad celíaca

30) El diagnóstico de hepatitis aguda por virus B se confirma con la detección serológica de HBsAg y de:

- a) Anti HBc total
- b) Anti HBc IgM
- c) HBe Ag
- d) DNA - VHB
- e) Anti HBs

31) ¿Cuál es el examen de elección para monitorizar el tratamiento del hipotiroidismo primario?

- a) T4
- b) T4 Libre
- c) TSH
- d) T3
- e) Tiroglobulina

32) El aumento de la proteólisis, observada durante el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, se puede cuantificar mediante:

- a) excreción de nitrógeno ureico urinario
- b) aumento del consumo de oxígeno
- c) determinación del cociente respiratorio
- d) determinación de creatinina plasmática
- e) nivel de cuerpos cetónicos en la sangre

33) ¿Cuál de los siguientes es el principal factor de riesgo de endocarditis infecciosa intrahospitalaria?

- a) Uso de dispositivos intravasculares
- b) Hospitalización prolongada
- c) Cirugía mayor
- d) Antecedentes de drogadicción endovenosa
- e) Endocarditis previa

34) Un paciente de 67 años con antecedentes de insuficiencia cardíaca crónica en tratamiento con enalapril, carvedilol, furosemida y espironolactona acude a urgencias por sensación de mareo en las últimas 48 horas. Su tensión arterial es de 85/40 mmHg. En la exploración física no se objetivan signos de congestión. El ECG demuestra un bloqueo de rama izquierda a 65 lpm ya conocido previamente. Los valores de creatinina, hemoglobina e iones son normales ¿cuál de las siguientes actitudes le parece más adecuada?:

- a) Disminuir dosis de carvedilol
- b) Disminuir dosis de furosemida.
- c) Disminuir dosis de enalapril.
- d) Disminuir dosis de espironolactona.
- e) Añadir al tratamiento nitratos transdérmicos.

35) Paciente que acude a Urgencias por dolor abdominal localizado en fosa ilíaca izquierda. La historia clínica sugiere una diverticulitis. ¿Cuál de las siguientes exploraciones NO debe utilizarse para estadificar la gravedad de la enfermedad o evaluar la evolución de la misma?:

- a) Exploración física.
- b) Recuento de leucocitos.
- c) Ecografía abdominal.
- d) TAC con contraste.
- e) Colonoscopia.

36) Mujer de 25 años que acude al Centro de Salud muy alarmada porque al mirarse en el espejo se ha visto la boca torcida. Ese mismo día durante la comida ha notado que los líquidos le resbalaban por la comisura labial. De entre las siguientes, señale la respuesta correcta:

- a) El comienzo súbito nos orienta a una parálisis facial distinta a la de Bell.
- b) La ausencia o disminución del reflejo palpebral es un dato diagnóstico muy específico para diferenciar las

parálisis de origen periférico de las de origen central.

- c) La parálisis facial periférica idiopática no es frecuente que se acompañe de ageusia y de hiperacusia.
- d) La presencia de otros síntomas, como disfagia o diplopía, es compatible con el diagnóstico de parálisis facial periférica idiopática.
- e) En éste, como en todos los casos de parálisis facial, está indicada la realización de un EMG.

37) La anemia de enfermedades crónicas se caracteriza por:

- a) ser macrocítica, hipocrómica y arregenerativa
- b) presentar valores de hemoglobina inferiores a 7.0 grs/dl.
- c) acompañarse de leucocitosis
- d) acompañarse de trombopenia
- e) presentar hiposideremia con ferritina sérica alta

38) Un paciente de 60 años de edad acude a la consulta por habersele descubierto un patrón de tipo intersticial en la radiografía de tórax. Refiere ser fumador de 40 paquetes/año y haber trabajado como montador de tuberías. En la tomografía axial computarizada se observa el mencionado patrón y un engrosamiento pleural. El diagnóstico en que pensará es:

- a) Fibrosis pulmonar.
- b) Neumoconiosis.
- c) Bronquiolitis respiratoria.
- d) Asbestosis.
- e) Silicosis.

39) Un niño de 2 años de edad es traído a Urgencias por petequias generalizadas sin otros signos de diátesis hemorrágica. Refieren catarro de vías altas y fiebre 2 semanas antes pero en la actualidad se encuentra afebril, con buen estado general, y el resto de la exploración es normal. Un hemograma muestra hemoglobina 14 mg/dL, leucocitos 9400/mm³ y plaquetas 34.000/mm³. Los tiempos de protrombina y de tromboplastina parcial activada son normales. Ante este cuadro clínico, una de las siguientes afirmaciones es cierta:

- a) El diagnóstico más probable es el de púrpura trombótica trombocitopénica.
- b) Requiere de transfusión urgente de concentrado de plaquetas.
- c) La evolución más probable es a la recuperación espontánea.
- d) Debe practicarse un TAC craneal para descartar hemorragia intracraneal.
- e) El pronóstico depende de la precocidad del tratamiento.

40) Un paciente de 56 años, diabético e hipertenso, presenta dolor precordial de inicio súbito, intenso, de 2 horas de evolución. El dolor es de carácter opresivo y se irradia al cuello y al brazo izquierdo. AL examen físico está normotenso, con FC: 95x', regular, FR: 14x' y saturación arterial de 98%. Se solicita electrocardiograma que demuestra inversión de la onda T y un infradesnivel del ST de 2 mm en las derivaciones DII, DIII y AVF. ¿Cuál de las siguientes conductas le parece MENOS adecuada?

- a) Administrar oxígeno por naricera
- b) Solicitar hemoglucotest
- c) Solicitar troponinas plasmáticas
- d) Iniciar estreptoquinasa por vía endovenosa
- e) Administrar aspirina 500 mg, por vía oral

41) Un paciente de 28 años presenta dolor lumbar de varias semanas de evolución. El dolor es de predominio matinal y se asocia a rigidez, pero ambos síntomas ceden con el ejercicio. Al examen físico sólo se detecta cierta limitación a la flexión lumbar. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar un AINE y relajantes musculares por 5 días
- b) Indicar reposo relativo y analgésicos
- c) Solicitar RMN de columna lumbar
- d) Solicitar radiografía de columna y pelvis
- e) Solicitar ANA, ANCA y factor reumatoideo

42) En el síndrome de Ovario poliquístico se dan trastornos menstruales asociados a:

- a) Hipotiroidismo.
- b) Obesidad y resistencia insulínica.
- c) Tiroiditis autoinmune.
- d) Hiperfunción suprarrenal.

e) Anemia ferropénica.

43) ¿Qué alteración es MÁS específica de una glomerulonefritis?

- a) Elevación de la creatinina
- b) Proteinuria
- c) Cilindros granulosos
- d) Leucocituria aséptica
- e) Hematuria dismórfica

44) Un paciente de 45 años refiere que despierta con cierto grado de disfonía, la que luego mejora con el transcurso del día. Además refiere regurgitación ácida de alimentos, especialmente después de comer. En algunas ocasiones presenta un ardor retroesternal que asciende hasta el cuello. El examen físico no muestra alteraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar endoscopia digestiva alta
- b) Iniciar omeprazol
- c) Solicitar pH-metría esofágica
- d) Solicitar manometría esofágica
- e) Erradicar *Helicobacter pylori*

45) Un paciente de 57 años, obeso y diabético tipo 2, en tratamiento con dieta desde hace 3 años, presenta glicemias cercanas a 180 mg/dl, tanto en ayunas, como postprandiales. El examen físico es normal y su hemoglobina glicosilada es de 8,5%. La conducta más adecuada es:

- a) Mantener dieta, indicar ejercicios y controlar en 3 meses
- b) Iniciar metformina
- c) Iniciar glibenclamida
- d) Iniciar insulina
- e) Iniciar una asociación entre un hipoglicemiante oral e insulina

46) ¿Cuál de las siguientes asociaciones entre los resultados de gases arteriales y patología es INCORRECTA?

- a) PaO₂: 40 mmHg, PaCO₂: 46 mmHg, Ph: 7,36 Bic: 25 mEq/l – Muestra de sangre venosa
- b) PaO₂: 60 mmHg, PaCO₂: 60 mmHg, Ph: 7,32 Bic: 30 mEq/l – Hipoventilación alveolar
- c) PaO₂: 80 mmHg, PaCO₂: 35 mmHg, Ph: 7,33 Bic: 18 mEq/l – Acidosis metabólica pura
- d) PaO₂: 92 mmHg, PaCO₂: 40 mmHg, Ph: 7,40 Bic: 24 mEq/l – Gases normales
- e) PaO₂: 70 mmHg, PaCO₂: 20 mmHg, Ph: 7,50 Bic: 17 mEq/l – Alcalosis metabólica

47) Los pacientes insuficientes renales, en etapas avanzadas, suelen presentar las siguientes alteraciones, EXCEPTO:

- a) Hipercalcemia
- b) Hiperpotasemia
- c) Anemia
- d) Acidosis
- e) Oliguria

48) Un adolescente de 14 años sufre caída a un río, sumergiéndose en el agua por cerca de 3 minutos, siendo retirado inconsciente. Usted llega al lugar en pocos minutos, en una ambulancia bien equipada, con dispositivos de manejo de vía aérea, oxígeno, drogas vasoactivas monitor electrocardiográfico, con marcapasos externo y desfibrilador. Además cuenta con una enfermera y un auxiliar paramédico, bien entrenados. Al examinar al paciente nota que no respira ni tienen pulso. Inicia masaje cardíaco y ventilaciones con ambú, ayudado por su personal. Al mismo tiempo se instala el monitor electrocardiográfico, constatándose asistolia luego de 5 ciclos de masaje y ventilación. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar masaje cardíaco por 2 minutos más y reevaluar
- b) Realizar desfibrilación eléctrica y continuar el masaje cardiopulmonar
- c) Instalar el marcapasos externo y continuar el masaje cardiopulmonar
- d) Administrar adrenalina y continuar el masaje cardiopulmonar
- e) Suspender la reanimación

49) Un paciente de 4 años presenta diarrea acuosa, con 7 deposiciones diarias, asociada a dolor abdominal tipo cólico y vómitos alimentarios en una oportunidad. Al examen presenta signos vitales normales, para su edad, llora sin lágrimas y se observan los ojos algo hundidos, con mucosa oral seca. El resto del examen físico no aporta mayor información. La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio con sales de rehidratación oral después de cada deposición diarreica
- b) Enviar a domicilio con hidratación oral, antibióticos y antidiarreicos
- c) Administrar sales de rehidratación oral, según plan B y controlar en 4-6 horas
- d) Hospitalizar, iniciar hidratación oral y antibióticos endovenosos
- e) Hospitalizar y administrar suero fisiológico, 20 cc/Kg, por vía endovenosa

50) Un paciente presenta ataxia de la marcha, asociado a temblor de intención (dismetría) y dificultad para realizar movimientos alternantes (adiadococinesia). El diagnóstico más probable es:

- a) Infarto de troncoencéfalo
- b) Enfermedad de Parkinson
- c) Síndrome cerebeloso
- d) Síndrome piramidal
- e) Síndrome extrapiramidal

51) Un paciente de 58 años, fumador importante, presenta dolor torácico que aparece al realizar actividad física y que cede con el reposo. En algunas ocasiones es tan intenso que le obliga a sentarse, cediendo luego de un par de minutos. El examen físico es normal al igual que un electrocardiograma de reposo. ¿Cuál es la causa más probable de su cuadro?

- a) Coronaria
- b) Pulmonar
- c) Pleural
- d) Esofágica
- e) Musculo esquelética

52) Una paciente de 45 años presenta un nódulo mamario de 2 cm a la palpación, de consistencia dura, adherido a los planos profundos. Se solicita una radiografía, la que es informada como Birrads 4. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar nueva mamografía en una año
- b) Solicitar nueva mamografía en 6 meses
- c) Solicitar ecografía mamaria
- d) Derivar para biopsia estereotáxica, con mamótomo
- e) Derivar para tumorectomía, con biopsia excisional

53) Un paciente de 7 años presenta un cuadro de cefalea y fiebre, de 24 horas de evolución. Al examen se constata signo de Brudzinski y Kerning positivos. El resto del examen físico no aporta mayor información. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar antipiréticos
- b) Iniciar antibióticos y antipiréticos
- c) Solicitar hemograma, PCR, sedimento de orina y urocultivo
- d) Solicitar hemograma, pruebas hepáticas e IgM VCA
- e) Realizar punción lumbar y solicitar estudio de líquido cefalorraquídeo

54) Una paciente de 45 años sufre una herida en la mano derecha, con un vidrio. Al tercer día presenta dolor, enrojecimiento y aumento de volumen en la zona circundante. Al examen físico se constata edema, eritema y aumento del calor local en la palma derecha, con compromiso de las primeras falanges del segundo y tercer dedos, de bordes difíciles de definir. No se palpan zonas fluctuantes y la herida no presenta exudado. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar vacunación antitetánica, sin necesidad de antibióticos
- b) Iniciar ceftriaxona endovenosa
- c) Iniciar penicilina más metronidazol endovenosas
- d) Iniciar cloxacilina endovenosa
- e) Resolver quirúrgicamente, bajo cobertura antibiótica con una cefalosporina de primera generación

55) Los niveles elevados de amonio, asociados a asterixis, son característicos de:

- a) Encefalopatía urémica
- b) Encefalopatía hepática
- c) Enfermedad de Parkinson
- d) Delirium

e) Cerebelitis post-varicela

56) Un paciente de 66 años se realiza exámenes de rutina, que demuestran una anemia moderada, con hematocrito de 28%, mactocítica, con VCM de 105 fl, asociadas a trombocitopenia y leucopenia, ambas leves con 95.000 plaquetas y 3.700 glóbulos blancos por milímetro cúbico de sangre. El examen físico no aporta mayor información. Se inicia tratamiento con hierro, vitamina B12 y folatos y se controla un nuevo hemograma a los 60 días, que no muestra cambios significativos respecto al inicial. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Síndrome mieloproliferativo
- b) Leucemia aguda
- c) Leucemia crónica
- d) Síndrome mielodisplásico
- e) Aplasia medular

57) Un paciente de 56 años consulta por disnea progresiva, de 3 meses de evolución. No tiene patologías previas y fuma 1 a 3 cigarrillos diarios. Al examen físico se observa hipocratismo digital y presenta un murmullo pulmonar disminuido en las bases, con crepitaciones gruesas bilaterales. La auscultación cardíaca no demuestra alteraciones. El diagnóstico más probable es:

- a) Tuberculosis
- b) Cáncer pulmonar
- c) EPOC
- d) Fibrosis pulmonar
- e) Insuficiencia cardíaca derecha

58) Una paciente de 22 años acude al servicio de urgencias por cefalea pulsátil, frontal y retroocular. Refiere que presenta cefaleas frecuentes desde hace 5 años, las que muchas veces van precedidas por visión de destellos y que en algunos periodos se hacen más frecuentes e intensas, al punto que debe encerrarse en su cuarto con las luces apagadas. Refiere tomar paracetamol y AINEs de manera frecuente. Desde hace 2 días comienza con cefalea, la que hoy se ha vuelto más intensa, cediendo sólo parcialmente con el uso de naproxeno. El examen físico, incluyendo un completo examen neurológico es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio con AINEs y ergotamínicos
- b) Iniciar carbamazepina oral
- c) Administrar analgésico endovenosos y reevaluar
- d) Solicitar TAC de cerebro
- e) Solicitar punción lumbar

59) ¿Qué alteración es frecuente en los pacientes con panhipopituitarismo?

- a) Intolerancia al calor
- b) Hiperpigmentación cutánea
- c) Amaurosis
- d) Galactorrea
- e) Amenorrea

60) Una mujer de 35 años presenta astenia, adinamia, fiebre intermitente, artralgias y caída del cabello, de 3 semanas de evolución. Al examen se aprecia en buenas condiciones, con signos vitales normales. En el paladar blando se observan 2 úlceras de cerca de 5 mm cada una. Se solicitan exámenes generales, con los siguientes resultados:

Hematocrito: 34%; VCM: 30 fl; glóbulos blancos: 4.600 x mm³; neutrófilos: 78%; monocitos: 9%; linfocitos: 13%; plaquetas: 70.000 x mm³; VHS: 44 mm/h; creatinina plasmática: 2,2 mg/dl; BUN: 28 mg/dl; pruebas hepáticas normales. El diagnóstico más probable es:

- a) Infección por CMV
- b) Infección por VIH
- c) Leucemia aguda
- d) Linfoma
- e) Lupus sistémico

61) Identifique la asociación INCORRECTA entre microorganismo oportunista y cuadro clínico, en un paciente con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana:

- a) Virus herpes 8 – Sarcoma de Kaposi
- b) Citomegalovirus – Coriorretinitis

- c) Cándida – Esofagitis
- d) Toxoplasma gondii – Absceso cerebral
- e) Criptosporidium sp – Meningitis

62) Un paciente de 39 años consulta por fiebre, tos y expectoración mucopurulenta, de 3 días de evolución, con marcado compromiso del estado general, a lo que se le ha agregado dolor torácico derecho, con tope inspiratorio. Al examen físico presenta signos vitales y saturación arterial de oxígeno normales, pero hay disminución del murmullo pulmonar en la base derecha y se auscultan crepitaciones localizadas en ese sector. Se solicita una radiografía de tórax que muestra un área de condensación en el lóbulo inferior derecho, asociado a un derrame pleural moderado. La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio con amoxicilina oral y controlar en 48 horas o en caso de empeoramiento
- b) Enviar a domicilio con amoxicilina más ácido clavulánico oral, indicando control en caso de empeoramiento
- c) Hospitalizar, realizar toracocentesis, con análisis de líquido pleural e iniciar ceftriaxona endovenosa
- d) Hospitalizar, instalar un tubo pleural e iniciar cefotaximo endovenoso
- e) Hospitalizar, administrar diuréticos, iniciar una cefalosporina de tercera generación endovenosa y controlar con nueva radiografía de tórax en 24 horas.

63) Un paciente de 67 años, hipertenso, presenta súbitamente imposibilidad para mover el hemicuerpo derecho, y para hablar. Al examen físico se aprecia hemiparesia M2 de la extremidad inferior derecha con hemiparesia M0 de la extremidad superior derecha, asociado a parálisis de los músculos faciales ipsilaterales. Presenta además afasia de expresión. El diagnóstico más probable es:

- a) Accidente vascular isquémico de arteria cerebral anterior
- b) Accidente vascular isquémico de arteria cerebral media
- c) Accidente vascular isquémico de arteria cerebral inferior
- d) Epilepsia focal
- e) Accidente vascular hemorrágico

64) Un paciente ingresa por un cuadro de palpitaciones de inicio brusco, de 2 horas de evolución. Presenta FC: 150 lpm, PA: 110/80 mmHg, extremidades bien perfundidas y un ritmo regular en 2 tonos en la auscultación cardíaca. Se solicita un ECG que demuestra una taquicardia a QRS angosto, regular, con ondas de serrucho en las derivaciones inferiores. El diagnóstico más probable es:

- a) Fibrilación auricular
- b) Taquicardia sinusal
- c) Taquicardia ventricular
- d) Flutter (aleteo) auricular
- e) Taquicardia paroxística supraventricular

65) Un paciente de 45 años presenta astenia, debilidad muscular, asociado a aumento en el peso. Al examen físico se aprecia atrofia de los músculos de las 4 extremidades, con obesidad de predominio facial y troncular, con algunas estrías oscuras. El diagnóstico más probable es:

- a) Hipertiroidismo
- b) Hipotiroidismo
- c) Síndrome de Cushing
- d) Enfermedad de Addison
- e) Síndrome de ovario poliquístico

66) La polimiositis y la dermatomiositis son parte de las enfermedades del tejido conectivo. Esta última se caracteriza por presentar compromiso cutáneo. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es más compatible con ambas patologías?

- a) Elevación marcada de la VHS
- b) Elevación de la creatinfosfokinasa plasmática
- c) Presencia de ANCA
- d) Debilidad muscular de predominio distal
- e) Sacroileítis bilateral

67) La leucemia mieloide crónica, en sus fases iniciales, suele presentar las siguientes alteraciones EXCEPTO:

- a) Esplenomegalia importante
- b) Importante desviación izquierda
- c) Importante aumento de los leucoblastos de sangre periférica

- d) Trombocitosis
- e) Hematocrito normal

68) Un paciente de 70 años, diabético e hipertenso, en tratamiento con glibenclamida, metformina y enalapril, es traído a urgencias por un cuadro de 3 días de evolución de fiebre, compromiso del estado general y tos productiva. En las últimas horas se agrega sopor y finalmente inconsciencia. Al examen físico está deshidratado, hipotenso, taquicárdico. Al examen físico está en sopor profundo, desorientado, y se auscultan crépitos en el ápice pulmonar izquierdo. Su hemoglucotest resulta Hi. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar suero fisiológico, antibióticos de amplio espectro y drogas vasoactivas
- b) Administrar suero fisiológico e insulina por vía intravenosa y solicitar hemograma, glicemia, electrolitos plasmáticos, creatinina, BUN, cetonas en sangre y una radiografía de tórax
- c) Administrar suero fisiológico e insulina por vía intravenosa, solicitar exámenes e iniciar noradrenalina por bomba de infusión continua
- d) Administrar suero fisiológico, iniciar ceftriaxona y solicitar exámenes
- e) Administrar insulina cristalina, suero glucosado y solicitar exámenes

69) Un paciente de 50 años, sin antecedentes de importancia, presenta ictericia desde hace 4 días, asociada a coluria y acolia. El examen físico no aporta mayor información y se controlan pruebas hepáticas que muestran GOT: 880 UI/l, GPT: 930 UI/l, GGT: 79UI/l, fosfatasas alcalinas: 150 UI/l, bilirrubina total: 4,2 mg/dl de predominio directo, protrombinemia: 95%. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome de Gilbert
- b) Hemólisis
- c) Cáncer
- d) Colédocolitiasis
- e) Hepatitis viral

70) Las causas más frecuentes de síndrome nefrótico en los niños y los adultos son respectivamente:

- a) Nefrosis lipoidea y diabetes mellitus
- b) Enfermedad de Berger y diabetes mellitus
- c) Nefrosis lipoidea y lupus sistémico
- d) Glomerulopatía por cambios mínimos e hipertensión arterial
- e) Glomerulonefritis aguda postestreptocócica y fármacos

Prueba 3

1) Paciente de 55 años, hipertenso, consulta por dolor precordial opresivo, de 70 minutos de duración, asociado a disnea. Al examen físico se aprecia paciente disneico, con presión arterial de 150/100 mmHg y frecuencia cardíaca de 110 lpm. El examen físico segmentario no aporta mayor información. Se realiza electrocardiograma que muestra supradesnivel de segmento ST en DII, DIII y AVF e

infradesnivel del segmento ST en V1 a V4. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar terapia de reperfusión con angioplastia o fibrinolíticos, inmediatamente
- b) Administrar aspirina y realizar ecocardiografía urgente
- c) Solicitar troponinas y decidir manejo según resultados
- d) Realizar manejo médico conservador, ya que el infradesnivel del ST en las derivaciones precordiales contraindica la trombolisis
- e) Iniciar AINEs, como terapia sintomática

2) Paciente de 25 años, previamente sano, consulta por cuadro de larga evolución de ardor epigástrico, irradiado a zona retroesternal, que aparece luego de algunas comidas. También refiere presentar regurgitación frecuente de contenido ácido. El examen físico resulta normal. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar omeprazol a dosis estándar, asociado a medidas generales antirreflujo
- b) Solicitar endoscopia digestiva alta y actuar según hallazgos
- c) Solicitar pHmetría de 24 horas y decidir manejo según hallazgos
- d) Solicitar ecografía abdominal ambulatoria
- e) Realizar tratamiento erradicador de *Helicobacter pylori*

3) Hombre de 53 años, fumador de 50 paquetes-año, se realiza radiografía de tórax como parte de un control de salud. En ella se observa nódulo de 3 cm en lóbulo superior derecho, de bordes irregulares, sin otros hallazgos. El examen físico resulta normal. La conducta inicial más adecuada es:

- a) Derivar para realización de biopsia de la lesión
- b) Solicitar TAC de tórax con contraste
- c) Comparar con radiografías previas
- d) Iniciar antibióticos y solicitar nueva radiografía en 3 meses
- e) Solicitar baciloscopias

4) Mujer de 24 años, cursando embarazo de 28 semanas, sin síntomas ni signos de patología. Se realiza pruebas tiroideas como parte del control prenatal, con los siguientes resultados: TSH: 2,9 (VN: 0,4 – 4,0) y T4: 16,8 (VN: 4 -12). El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad de Basedow-Graves
- b) Elevación de TBG
- c) Enfermedad de Hashimoto
- d) Tiroiditis silente
- e) Hipertiroidismo subclínico

5) La medida más costo-efectiva para prevenir fracturas, en el adulto mayor, es:

- a) Administrar calcio oral
- b) Indicar bifosfonatos por vía oral
- c) Administrar vitamina D
- d) Iniciar sustitución de hormonas sexuales
- e) Indicar programa de ejercicios

6) Hombre de 70 años, consulta por palidez y astenia de 3 meses de evolución, sin otros síntomas. Al examen físico se aprecia paciente en buenas condiciones generales, pálido, eupneico, con presión arterial y frecuencia cardíaca normales. El examen segmentario resulta normal. Se solicita hemograma que muestra hematocrito: 27%, Hb: 8,9 mg/dl, VCM: 67, HCM: 23, Blancos: 6.200, plaquetas: 155.000. El perfil de hierro demuestra ferremia baja, transferrina elevada, con bajo índice de saturación y ferritina muy disminuida. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar sulfato ferroso oral, sin necesidad de realizar más exámenes
- b) Solicitar endoscopia digestiva alta e iniciar hierro oral
- c) Solicitar biopsia de médula ósea
- d) Realizar transfusiones periódicas de glóbulos rojos
- e) Realizar transfusión de glóbulos rojos, de manera urgente y luego iniciar hierro oral

7) Un paciente de 13 años, previamente sano, con su vacunación completa, consulta porque su abuelo, con quien comparte habitación, fue diagnosticado de tuberculosis pulmonar bacilífera, recientemente. No ha presentado síntomas y el examen físico resulta normal. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar PPD
- b) Solicitar radiografía de tórax y PPD

- c) Solicitar baciloscopías de expectoración y decidir manejo según resultado
- d) Solicitar baciloscopías de esputo y cultivo para Mycobacterias
- e) No es necesario realizar ningún examen

8) Paciente hipertensa de 52 años, consulta por haber presentado hemiparesia faciobraquiocrural izquierda y dificultad para hablar, de 7 horas de evolución. Se realiza TAC de cerebro que muestra zona hipodensa en zona frontoparietal derecha. ¿Cuál de las siguientes medidas es la MENOS indicada?:

- a) Realizar estudio de fuente embólica
- b) Realizar estricto control de presión arterial y glicemia, de modo de mantenerlas en rango normal
- c) Iniciar antiagregantes plaquetarios
- d) Administrar oxígeno a 2 litros por minuto, por naricera
- e) Indicar régimen cero

9) Paciente de 65 años, con insuficiencia renal crónica terminal. No ha acudido a sus sesiones de hemodiálisis en la última semana. Es traído a la urgencia en malas condiciones generales, bradicárdico. Se controlan electrolitos plasmáticos, donde destaca potasemia de 8,5 mEq/l. La primera medida a realizar es:

- a) Realizar hemodiálisis de urgencia
- b) Administrar insulina y glucosa endovenosa
- c) Iniciar beta agonistas por nebulización
- d) Administrar gluconato de calcio endovenoso
- e) Administrar suero fisiológico por vía periférica

10) ¿Cuál(es) de los siguientes anticuerpos es(son) específico(s) para lupus eritematoso sistémico?:

- a) Anti-nucleares
- b) Anti-histona y anti-DNA de una hebra
- c) Anti-citoplasma de neutrófilos
- d) Anti-DNA de dos hebras y anti-Sm
- e) Anti-Ro y anti-La

11) Paciente de 14 años, consulta por palpitaciones intensas de 30 minutos de duración. Había presentado 2 episodios previos, de similares características, pero que cedían espontáneamente en pocos minutos. Al examen se ve paciente en buenas condiciones, ansioso, pulso regular a 185 lpm, presión arterial: 122/74 mmHg, eupneico. La conducta inicial más adecuada es:

- a) Realizar maniobras vagales
- b) Administrar adenosina 6 mg endovenoso
- c) Realizar cardioversión eléctrica
- d) Solicitar electrocardiograma
- e) Administrar amiodarona endovenosa

12) Mujer de 33 años, consulta dolor abdominal de 5 horas de evolución, que se inició en epigastrio y que luego se localizó en fosa iliaca derecha, de tipo sordo, intenso. Al examen se aprecia paciente adolorida, FC: 110x', PA: 140/88 mmHg, t°: 37,3 °C axilar. La palpación abdominal demuestra resistencia muscular en FID y signo de Blumberg positivo. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar TAC de abdomen y pelvis urgente
- b) Solicitar Ecografía abdominal y decidir manejo, según hallazgos
- c) Solicitar hemograma, VHS, PCR, hemocultivos e iniciar analgésicos y antibióticos de amplio espectro, endovenosos
- d) Enviar a domicilio con analgesia y antibióticos orales
- e) Resolver quirúrgicamente a la brevedad

13) Paciente de 58 años, diabético, consulta por fiebre, malestar general, tos, con expectoración mucopurulenta y dolor torácico derecho, tipo puntada de costado. El examen físico demuestra crepitaciones en lóbulo superior derecho, asociadas a disminución del murmullo pulmonar en base pulmonar derecha. Se solicita radiografía de tórax que demuestra condensación en lóbulo superior derecho, asociados a derrame pleural derecho, moderado. Se inicia ceftriaxona endovenosa y se solicita estudio de líquido pleural, que demuestra proteínas de 65% respecto al plasma, LDH de 70%

respecto al plasma, pH: 7,09, lactato: 8, abundantes células de predominio polimorfonuclear y tinción de Gram sin visualización de bacterias. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar nueva toracocentesis y evacuar el líquido pleural
- b) Instalar toracostomía (tubo pleural)
- c) Observar respuesta a antibióticos, por 24 horas y decidir manejo según evolución
- d) Agregar cobertura antibiótica contra anaerobios
- e) Agregar antibióticos y fibrinolíticos intrapleurales

14) Paciente de 55 años, consulta por astenia, constipación e intolerancia al frío. El examen físico demuestra bocio difuso, pequeño, sin otras alteraciones. Se solicitan exámenes que demuestran TSH elevada y T4 libre disminuida. El diagnóstico más probable y la conducta más adecuada son respectivamente:

- a) Tiroiditis subaguda e iniciar AINEs
- b) Bocio multinodular tóxico y derivar para administración de yodo radiactivo
- c) Tiroiditis de Hashimoto e iniciar levotiroxina a 1,6 ug/Kg
- d) Hipotiroidismo de causa autoinmune y solicitar anticuerpos anti-TPO y anti-receptor de TSH, decidiendo manejo según resultados
- e) Enfermedad de Basedow-Graves e iniciar betabloqueo y propiltiouracilo

15) La causa más frecuente de muerte en pacientes con leucemia linfática aguda es(son):

- a) Hemorragias
- b) Fenómenos trombóticos
- c) Infecciones
- d) Arritmias cardíacas
- e) Insuficiencia hepática y respiratoria, secundarias a la quimioterapia

16) Paciente de 35 años, diagnosticado de VIH, en tratamiento antirretroviral, sin infecciones oportunistas previas. Se encuentra asintomático y el examen físico resulta normal. Se solicita recuento de linfocitos CD4 con 133 células por mm³. La conducta más adecuada, de entre las siguientes, es:

- a) Mantener tratamiento antiviral y controles periódicos, sin necesidad de tratamientos adicionales
- b) Iniciar cotrimoxazol trisemanal
- c) Iniciar azitromicina semanal
- d) Iniciar fluconazol y cotrimoxazol
- e) Iniciar ganciclovir y cotrimoxazol

17) Paciente de 34 años, consulta por cefalea de varios años de evolución, que se ha hecho más frecuente y más intensa en las últimas semanas. El dolor es de carácter opresivo, de localización temporoccipital, irradiada a cuello. Al examen físico sólo destaca sensibilidad a la palpación de músculos cervicales posteriores. El diagnóstico más probable es:

- a) Migraña sin aura
- b) Cefalea tensional
- c) Síndrome de hipertensión endocraneana
- d) Neuralgia de Arnold
- e) Fibromialgia

18) Un niño de 12 años es diagnosticado de púrpura de Shönlein-Henoch, evolucionando satisfactoriamente, con desaparición de los síntomas luego de 10 días de observación. ¿Cuál es el examen de elección para el seguimiento de este paciente?:

- a) Sedimento de orina
- b) Orina completa
- c) Clearance de creatinina de 24 horas
- d) Niveles de IgA plasmática
- e) El examen físico

19) Paciente de 20 años, consulta por lumbago de 3 meses de evolución, asociado a rigidez matinal de 30 minutos de duración. Es mayor al despertar y cede con la actividad. El examen físico demuestra sólo un grado leve a moderado de rigidez lumbar. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar analgésicos, asociados a relajantes musculares
- b) Solicitar radiografía de sacroilíacas
- c) Solicitar RMN de columna lumbar

- d) Solicitar ANA, ANCA y factor reumatoideo y decidir manejo según hallazgos
- e) Iniciar ejercicios de fortalecimiento de musculatura paravertebral, asociando AINEs

20) Paciente de 50 años de edad, sin antecedentes de patología previa, consulta por palpitaciones de 24 horas de evolución. Había presentado episodios previos, autolimitados. Al examen se aprecia en buenas condiciones, destacando sólo pulso irregular a 128 lpm. El resto del examen físico resulta normal. Se solicita electrocardiograma que muestra arritmia completa por fibrilación auricular. ¿Cuál de las siguientes medidas es la MENOS adecuada, para el manejo de este paciente?

- a) Iniciar anticoagulación a permanencia
- b) Realizar control de frecuencia cardíaca con betabloqueantes
- c) Realizar control de ritmo farmacológico
- d) Diagnosticar fibrilación auricular de tipo paroxístico
- e) Realizar cardioversión eléctrica en caso de falla de los antiarrítmicos

21) Paciente de 55 años, con antecedentes de reflujo gastroesofágico, en tratamiento irregular con omeprazol en una dosis diaria, consulta por dificultad para tragar sólidos de 1 mes de evolución, asociado a baja de peso de 4 kilogramos. No refiere otros síntomas y el examen físico resulta normal. La conducta más adecuada es:

- a) Sospechar acalasia esofágica y solicitar manometría esofágica
- b) Instalar sonda nasogástrica
- c) Solicitar hemograma y test de hemorragias ocultas
- d) Iniciar omeprazol a doble dosis diaria
- e) Solicitar endoscopia digestiva alta

22) Paciente de 75 años, fumador importante, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, secundaria a tabaquismo. Continúa fumando 5 cigarrillos diarios y presenta disnea al caminar 1 cuadra. Se solicitan gases en sangre arterial, que muestran Bic: 25mEq/, pH: 7,40, pO₂: 63mmHg, pCO₂: 37mmHg. El tratamiento más adecuado, de entre los siguientes, es:

- a) Dejar de fumar, vacunar contra la influenza y asociar broncodilatadores inhalados, y corticoides inhalados
- b) Dejar de fumar, vacunar contra la influenza, asociando broncodilatadores inhalados, corticoides orales y oxígeno domiciliario
- c) Dejar de fumar y asociar broncodilatadores inhalados, corticoides inhalados y oxígeno domiciliario
- d) Dejar de fumar, asociar corticoides orales, teofilina, broncodilatadores y vacunar contra la gripe
- e) Dejar de fumar, vacunar contra la gripe y asociar broncodilatadores inhalados, corticoides inhalados, teofilina y oxígeno terapia domiciliaria

23) Hombre de 33 años, asintomático, consulta por presentar hipercalcemia de 12,5 en exámenes de control. Se solicitan niveles de hormona paratiroidea, los que resultan elevados, casi al doble de lo normal. La conducta más adecuada es:

- a) Derivar a cirujano de cabeza y cuello para resolución quirúrgica
- b) Solicitar ecografía de tiroides y actuar según hallazgos
- c) Solicitar cintigrafía de paratiroides
- d) Realizar tratamiento médico con furosemida y bifosfonatos
- e) Realizar biopsia con aguja fina de paratiroides y actuar según hallazgos

24) Paciente de 45 años, consulta porque le indicaron que padecía de anemia. El hemograma constata recuento de blancos y plaquetas normales, Hcto: 30%, Hb: 10,2 mg/dl, VCM: 78. Se solicita perfil de hierro que muestra ferremia plasmática disminuida, transferrina plasmática disminuida y ferritina plasmática elevada. El diagnóstico más probable es:

- a) Talasemia
- b) Anemia ferropénica
- c) Anemia de enfermedades crónicas
- d) Anemia hemolítica crónica
- e) Hemocromatosis

25) El tratamiento de elección para la uretritis gonocócica es:

- a) Doxiciclina 100 mg cada 12 horas por 10 días, por vía oral
- b) Ceftriaxona 1 gr. al día por 7 días, por vía endovenosa
- c) Ciprofloxacino 500 mg por una vez, por vía oral
- d) Azitromicina 1 gr. al día por 3 días, por vía oral
- e) Penicilina benzatina 1.200.000 UI por una vez, por vía intramuscular

26) Un niño de 5 años, sin antecedentes de importancia, presenta cuadro de hiperflexión de extremidades superiores, pérdida de conciencia y luego movimientos repetitivos de todas las extremidades, de pocos minutos de duración. Había sufrido cuadro similar 3 meses antes. Al momento de la consulta se encuentra asintomático y el examen neurológico es normal. La analítica sanguínea resulta normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Epilepsia focal, secundariamente generalizada
- b) Epilepsia primaria tónico clónica
- c) Convulsiones secundarias a alteraciones metabólicas
- d) Epilepsia mioclónica
- e) Tumor cerebral

27) Paciente de 8 años, consulta por aumento de volumen facial. En el examen físico destaca paciente con edema facial, escrotal y de extremidades, con presión arterial en percentil 99 para la edad. Se solicitan exámenes que demuestran Hcto: 35%, blancos y plaquetas normales, creatinina plasmática: 1,7 mg/dl, BUN: 30 mg/dl, sedimento de orina normal, proteinuria de 24 horas: 5 gramos. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar prednisona oral
- b) Iniciar pulsos de corticoides endovenosos a dosis altas
- c) Enviar a domicilio, sin necesidad de iniciar fármacos y controlar en 7 días
- d) Derivar a biopsia renal
- e) Indicar inmunosupresores y corticoides endovenosos

28) ¿Cuál de las siguientes NO es una manifestación del lupus eritematoso sistémico?

- a) Artritis erosiva
- b) Mielitis transversa
- c) Trombosis mesentérica
- d) Síndrome nefrótico
- e) Hepatitis autoinmune

29) Paciente de 55 años, hipertenso y diabético, es llevado al servicio de urgencia por pérdida de conciencia y cese de la respiración de 8 minutos de evolución. Al examen físico se constata paciente sin movimientos respiratorios y sin pulso. Se inician maniobras de RCP y se instala monitor cardíaco que muestra taquicardia ventricular. Luego de cinco ciclos de masaje cardíaco, continúa sin pulso. La conducta más adecuada, de entre las siguientes, es:

- a) Realizar 5 ciclos más de masaje cardíaco
- b) Realizar cardioversión eléctrica, administrar amiodarona endovenosa y suspender el masaje cardíaco
- c) Realizar desfibrilación eléctrica y realizar cinco ciclos más de masaje cardíaco
- d) Administrar adrenalina 1 mg endovenoso y realizar cinco ciclos más de masaje cardíaco
- e) Administrar atropina 1 mg endovenoso y realizar cinco ciclos más de masaje cardíaco

30) Un paciente de 51 años, diagnosticado de cirrosis hepática por consumo crónico de alcohol, actualmente suspendido, consulta por aumento del perímetro abdominal. Al examen se constata ascitis moderada. Se solicita paracentesis diagnóstica que muestra albumina: 1,0 mg/dl, células: 139 por mm³, de predominio polimorfonuclear. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar cefotaximo endovenoso
- b) Iniciar ciprofloxacino oral
- c) Realizar paracentesis evacuadora, con reposición de albúmina
- d) Indicar restricción hidrosalina e iniciar espironolactona y furosemida
- e) Derivar para instalar un TIPS

31) Paciente de 48 años, diagnosticada de tuberculosis pulmonar bacilífera, por lo que inició tratamiento con varias drogas antituberculosas. Se controla con baciloscopías mensuales que muestran los siguientes resultados: 1° mes(+), 2° mes(-), 3° mes(-), 4°mes(+), 5° mes(+). La conducta más adecuada es:

- a) Mantener tratamiento antituberculoso por un mes más y controlar nueva baciloscopía
- b) Solicitar cultivo para mycobacterias y decidir manejo según resultado

- c) Diagnosticar fracaso a tratamiento y derivar a especialista
- d) Solicitar radiografía de tórax, cultivo para mycobacterias y nueva baciloscopia y decidir manejo según hallazgos
- e) extender tratamiento antituberculoso hasta lograr 3 baciloscopias negativas seguidas

32) Hombre de 44 años, consulta por astenia, adinamia y náuseas de 4 meses de evolución, que han ido en aumento. Se controlan exámenes de sangre, entre los que destacan creatinina: 1,1 mg/dl, Cl: 96 mEq/l, Na: 130 mEq/l, K: 5,7 mEq/l. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Hiperaldosteronismo primario
- b) Diabetes insípida
- c) Insuficiencia renal inicial
- d) Síndrome de Cushing
- e) Insuficiencia suprarrenal crónica

33) ¿Cuál de las siguientes situaciones presenta un mayor riesgo de hemorragia vítrea, en un paciente con retinopatía diabética?

- a) Microinfartos retinales
- b) Microaneurismas retinales
- c) Vasos de neoformación en la retina
- d) Presencia de exudados céreos abundantes cercanos a la mácula
- e) Microhemorragias retinales

34) Paciente de 17 años, consulta por aumento de volumen cervical, progresivo, de 4 meses de evolución, asociado a sudoración nocturna y baja de peso de 3 kilos. En el examen físico destacan adenopatías cervicales bilaterales y axilares derechas de consistencia gomosa, no dolorosas y adheridas a planos profundos. El hemograma muestra anemia leve, normocítica. El diagnóstico más probable es:

- a) Linfoma
- b) Leucemia
- c) Bartonellosis
- d) Tuberculosis
- e) Sarcoidosis

35) Paciente de 33 años, se entierra astilla en pie derecho, la que retira in problemas, sin embargo evoluciona con dolor, eritema y aumento de volumen de pie y pierna izquierda. Al examen físico se constata paciente febril hasta 38,8°C, con una placa eritematosa, levemente dolorosa, en pie y pierna izquierda, de 14 cm de diámetro y de bordes difíciles de definir. En los exámenes de laboratorio sólo destaca leucocitosis de 18.000 y aumento de los parámetros inflamatorios. ¿Cuál de los siguientes tratamientos antibióticos es más adecuado para tratar a este paciente?

- a) Flucloxacilina oral
- b) Amoxicilina + ácido clavulánico oral
- c) Cefazolina endovenosa
- d) Ceftriaxona endovenosa
- e) Azitromicina oral

36) Las causas más frecuentes de demencia son:

- a) Enfermedad de Alzheimer y demencia por cuerpos de Lewy
- b) Demencia vascular y demencia frontotemporal
- c) Enfermedad de Alzheimer y demencia vascular
- d) Enfermedad de Alzheimer y demencia frontotemporal
- e) Demencia vascular y demencia por cuerpos de Lewy

37) ¿Cuál de las siguientes NO corresponde a una indicación de hemodiálisis de urgencia en contexto de una insuficiencia renal aguda?

- a) Edema pulmonar que no responde a tratamiento médico
- b) Pericarditis urémica
- c) Hiperkalemia grave, que no responde a tratamiento médico
- d) Hipocalcemia grave, que no responde a tratamiento médico

e) Acidosis grave que no responde a tratamiento médico

38) Paciente de 70 años, consulta por dolor y aumento de volumen de rodilla derecha. Al examen físico se aprecia derrame articular moderado, con mínimos signos inflamatorios externos. Se realiza punción articular que demuestra salida de líquido amarillo, transparente, filante, con recuento celular de 30 células de predominio polimorfo nuclear. La microscopía del líquido articular resulta normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Artritis reumatoidea
- b) Artrosis
- c) Artritis séptica
- d) Artritis por cristales
- e) Artritis traumática

39) Paciente de 55 años, cursando infarto de pared inferior, evoluciona con hipotensión marcada. Al examen físico destaca PA: 75/38 mmHg, FC: 110x', ingurgitación yugular. La auscultación cardíaca demuestra ritmo regular, en 3 tonos, con R4 (+), sin soplos y la auscultación pulmonar resulta normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Rotura de tabique interventricular
- b) Compromiso isquémico de nodo AV
- c) Infarto de ventrículo derecho
- d) Compromiso isquémico de nodo sinusal
- e) Rotura de músculo papilar

40) El tratamiento actual de la úlcera duodenal es:

- a) Omeprazol en doble dosis diaria, a permanencia
- b) Combinación de 2 antibióticos y un inhibidor de la bomba de protones, por 7 a 10 días
- c) Dieta estricta, evitando grasas, condimentos e irritantes
- d) Inhibidores H2 diarios, asociados a antiácidos, según síntomas
- e) Prohibir el uso de AINEs y asociar un inhibidor de la bomba de protones en dosis única diaria

41) Paciente de 45 años, diabético mal controlado, consulta por fiebre, tos productiva, disnea de reposo y finalmente compromiso de conciencia. Al examen se aprecia paciente en malas condiciones generales, con pulso: 140 lpm, regular, presión arterial: 80/40 mmHg, frecuencia respiratoria: 38 rpm, Glasgow: 10. En el examen segmentario destacan crépitos en base derecha y campo pulmonar izquierdo. Se inicia resucitación con suero fisiológico y oxígenos, logrando saturación arterial de 88% a FiO2: 50% y presión arterial: 100/58 mmHg. El tratamiento antibiótico para este paciente debe ser:

- a) Ceftriaxona + Amicacina
- b) Ceftriaxona + Vancomicina
- c) Cefotaximo + Ampicilina
- d) Ceftriaxona + Claritromicina
- e) Cefotaximo + Metronidazol

42) Paciente de 17 años, consulta por astenia y fiebre de 4 días de evolución, hasta 38,9°C, asociadas a odinofagia. Al examen físico destaca faringe eritematosa, con abundante exudado amigdalino, blanco adherente y adenopatías cervicales bilaterales. Se solicita hemograma que muestra Hematocrito: 46%, plaquetas: 230.000, leucocitos: 17.000, con 81% de linfocitos, con un 10% de linfocitos atípicos. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar amoxicilina oral y antipirético
- b) Iniciar aciclovir oral
- c) Solicitar IgM anti-VCA e iniciar tratamiento sintomático
- d) Derivar a biopsia de adenopatía cervical
- e) Solicitar Elisa para VIH, IgM para CMV, IgM para toxoplasma, baciloscopías, serología para virus Epstein Baar, marcadores virales de hepatitis B y C y cultivo faringeo, decidiendo el manejo según resultados

43) Hombre de 25 años que consulta por cefalea de 3 meses de evolución, de localización frontal bilateral y retroocular, de carácter opresivo y pulsátil, que con frecuencia se ve precedido por visión de destellos de luces, de 15 minutos de duración. Los episodios suelen durar cerca de 5 horas y logra alivio parcial, al usar antiinflamatorios o paracetamol. El examen neurológico es normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Cefalea tensional

- b) Epilepsia de lóbulo occipital
- c) Cefalea en racimo
- d) Cefalea secundaria a patología ocular
- e) Migraña con aura

44) Paciente de 22 años, hipertenso de reciente diagnóstico, con presiones arteriales cercanas a 170/100, asintomáticos. Se solicitan exámenes entre los que destacan creatinemia: 0,9, Na: 141 mEq/l, K: 3,1 mEq/l, Cl: 105 mEq/l. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Hipertensión arterial renovascular
- b) Hipertensión arterial esencial
- c) Hipertensión arterial secundaria a insuficiencia renal
- d) Enfermedad de Addison
- e) Hipoaldosteronismo

45) Paciente de 45 años, consulta por artritis de manos, de 2 meses de evolución, asociadas a rigidez matinal de 1 hora de duración. Al examen se aprecia artritis de ambas muñecas, 4 articulaciones MCF en cada mano y 3 articulaciones IFD en cada mano. Se solicita factor reumatoideo y anticuerpos antinucleares, que resultan negativos. El hemograma es normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Artrosis
- b) Artritis viral
- c) Espondiloartropatía seronegativa
- d) Artritis reumatoidea
- e) Vasculitis de vaso pequeño

46) Paciente de 65 años, con insuficiencia cardíaca, secundaria a cardiopatía coronaria de larga evolución, en capacidad funcional III. Consulta por aumento de la disnea basal, de 3 días de evolución, que ahora se hizo de reposo. Al examen se aprecia paciente agitado, taquipneico, con FC: 120 lpm, PA: 160/100, satO₂: 85%. En el examen segmentario destacan yugulares ingurgitadas, auscultación pulmonar con crépitos gruesos bilaterales, difusos, auscultación cardíaca con ritmo regular y galope por R3. La radiografía de tórax muestra cardiomegalia, hilios pulmonares prominentes, redistribución del flujo sanguíneo a los ápices y un patrón de relleno intersticial y alveolar bilateral difuso. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar oxigenoterapia, por mascarilla de alto flujo, asociado a diuréticos de asa por vía endovenosa y amiodarona en infusión rápida
- b) Iniciar diuréticos endovenosos, antibióticos de amplio espectro y oxígeno por mascarilla
- c) Iniciar bloqueadores de calcio endovenosos, asociados a morfina, diuréticos y oxígeno
- d) Iniciar oxigenoterapia, aspirina, morfina, nitroglicerina y realizar coronariografía urgente
- e) Administrar oxígeno por mascarilla, vasodilatadores endovenosos en infusión continua, diuréticos endovenosos y morfina

47) Paciente de 54 años, diabético, colecistectomizado hace 2 días por colecistitis aguda, reingresa al servicio de urgencia por disnea y dolor torácico de instalación súbita, hace 3 horas. Al examen se aprecia paciente disneico, febril hasta 37,9°C, con frecuencia respiratoria de 33 rpm, pulso de 120 lpm, regular y presión arterial de 120/70 mmHg. La auscultación cardiopulmonar no aporta mayor información. El diagnóstico más probable es:

- a) Neumonía intrahospitalaria
- b) Neumotórax
- c) Infarto agudo al miocardio
- d) Tromboembolismo pulmonar
- e) Endocarditis aguda

48) Paciente de 39 años, con antecedente de jaqueca, que trata con ketorprofeno, con varias dosis al día. Consulta en el servicio de urgencia por presentar deposiciones negras, asociadas a hematemesis en una ocasión. Al examen destaca FC: 125x', PA: 102/64 mmHg y palidez. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar suero fisiológico endovenoso y terlipresina
- b) Iniciar reposición de volumen con cristaloides y realizar transfusión de glóbulos rojos urgente

- c) Reposición de volumen con coloides, administrar omeprazol y terlipresina por vía endovenosa y solicitar endoscopia digestiva alta urgente
- d) Reponer volumen con cristaloides, administrar omeprazol endovenoso y solicitar endoscopia digestiva alta de urgencia
- e) Administrar cristaloides, transfundir glóbulos rojos y realizar endoscopia digestiva alta de urgencia

49) La glomerulopatía secundaria a fármacos, más frecuente es:

- a) Glomerulopatía membranosa (extramembranosa)
- b) Glomerulopatía focal y segmentaria
- c) Glomerulopatía mesangiocapilar
- d) Glomerulosclerosis difusa
- e) Glomerulopatía por cambios mínimos

50) Paciente de 37 años, asintomático, se realiza exámenes de laboratorio, como parte de un chequeo médico solicitado porque padece de sobrepeso. Destacan glicemia de ayuno: 111 mg/dl, creatinina normal, colesterol: 240 mg/dl, triglicéridos: 250 mg/dl, bilirrubina: 0,7, transaminasas glutámica y pirúvica elevadas al doble de lo normal y fosfatasas alcalinas normales. La causa más probable de la elevación de las transaminasas es:

- a) Hígado graso
- b) Hepatitis viral
- c) Consumo de alcohol
- d) Síndrome de Gilbert
- e) Autoinmune

51) Un paciente de 44 años, consulta por intenso dolor abdominal epigástrico, constante, de 4 horas de evolución, asociado a vómitos. El examen físico no aporta mayor información. Se solicitan exámenes que demuestran transaminasas levemente aumentadas, bilirrubinemia total: 1,1 mg/dl, lipasa 5 veces el valor normal, hematocrito: 37%, blancos: 15.000, plaquetas: 455.000. La ecografía abdominal demuestra varios cálculos biliares, de pequeño tamaño y barro biliar, sin otras alteraciones. El diagnóstico más probable es:

- a) Pancreatitis aguda litiasica
- b) Colecistitis aguda litiasica
- c) Colangitis aguda
- d) Cólico biliar simple
- e) Colédocolitiasis con hidrops vesicular

52) Mujer de 63 años, fumadora, consulta por disnea de esfuerzo de 5 meses de evolución, que se ha hecho más intensa, hasta ser de pequeños esfuerzos. Al examen destaca disminución del murmullo pulmonar en ambas bases, con crepitaciones gruesas, bibasales. Se solicita radiografía de tórax que muestra engrosamiento intersticial bibasal y espirometría que muestra CVF: 52% del teórico, VEF1: 57% del teórico, VEF1/CVF: 82%. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
- b) Fibrosis pulmonar idiopática
- c) Hipertensión pulmonar primaria
- d) Insuficiencia cardíaca congestiva
- e) Bronquiectasias

53) Paciente de 56 años, asintomático, se realiza exámenes de control, entre los que destacan: calcemia 11,3 (VN: 8,5-10,5), hiperfosforemia, fosfatasas alcalinas elevadas y albúmina: 4 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

- a) Hiperparatiroidismo primario
- b) Hiperparatiroidismo secundario a insuficiencia renal
- c) Hipercalcemia maligna
- d) Hipercalcemia ficticia
- e) Hipervitaminosis D

54) Paciente de 65 años, consulta fiebre y dolor abdominal de 3 días de evolución. Al examen físico sólo lo destaca esplenomegalia importante. Se solicita hemograma que muestra hematocrito: 39%, blancos: 63.000, plaquetas: 250.000. La fórmula diferencial de leucocitos muestra linfocitos: 10%, monocitos: 3%, segmentados: 61%, baciliformes: 16%, promielocitos: 4%, blastos: 1%, basófilos: 2%, eosinófilos: 3%. El diagnóstico más probable es:

- a) Leucemia mieloide crónica
- b) Leucemia mieloide aguda
- c) Endocarditis infecciosa
- d) Mielodisplasia
- e) Mielofibrosis

55) Paciente de 17 años sufre picadura por avispa hace 50 minutos, evolucionando con aumento de volumen de labios, párpados y varias zonas de la piel, con intenso prurito. Luego aparece tos, compromiso del estado general, vómitos y finalmente estridor inspiratorio y disnea. Ingres a taquipneico, con Glasgow 15, presión arterial: 75/35 mmHg, pulso: 130 lpm y saturación arterial de O₂: 93% a FiO₂ ambiental. La medida más importante para el manejo de este paciente es:

- a) Administrar corticoides endovenosos
- b) Administrar adrenalina intramuscular
- c) Administrar antihistamínicos orales
- d) Administrar oxígeno por mascarilla
- e) Administrar broncodilatadores por nebulización

56) Paciente de 55 años, consulta por disnea de esfuerzos CF II, asociada a edema de EEL y disnea paroxística nocturna. Al examen cardíaco destaca desplazamiento del choque de la punta a 5° espacio intercostal en línea axilar anterior y ritmo regular en 2 tiempos, con soplo holosistólico III/VI, mayor en ápex. El diagnóstico más probable es:

- a) Estenosis aórtica
- b) Estenosis mitral
- c) Insuficiencia aórtica
- d) Insuficiencia mitral
- e) Estenosis tricuspídea

57) Adolescente de 17 años, consulta por tos seca, intensa, que aparece en relación al ejercicio y que en algunas ocasiones se acompaña de respiración sibilante. El examen físico y el PEF, resultan normales. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar radiografía de tórax
- b) Solicitar test cutáneo para alérgenos respiratorios
- c) Solicitar prueba de provocación bronquial con metacolina
- d) Iniciar corticoides y broncodilatadores inhalados
- e) Iniciar broncodilatadores, asociados a inhibidores de leucotrienos

58) Adolescente de 16 años, normopeso, consulta por poliuria. Entre sus exámenes destaca glicemia de ayuno de 150 mg/dl, la que se repite a los 7 días con valor de 148 mg/dl. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar dieta y ejercicios y controlar en un mes
- b) Iniciar dieta y ejercicios, asociado a hipoglicemiantes orales
- c) Solicitar test de tolerancia a la glucosa y decidir manejo, según resultado
- d) Iniciar insulino terapia en esquema intensificado
- e) Solicitar creatinina plasmática, electrolitos y proteinuria de 24 horas y decidir tratamiento según resultados

59) Hombre de 66 años de edad, sin antecedentes de importancia, consulta por artralgias, edema de extremidades inferiores, oliguria y febrícula ocasional. En sus exámenes destaca creatinina: 4,3, BUN: 50, orina completa con proteinuria +++ y hematuria microscópica, con 11% de dismorfia, C3 y C4 normales, ANA(-) y ANCA(+) en patrón perinuclear. El diagnóstico más probable es:

- a) Poliangeítis microscópica
- b) Granulomatosis de Wegener
- c) Panarteritis nodosa
- d) Crioglobulinemia
- e) Vasculitis por depósito de IgA

60) Paciente de 70 años, diabético, hipertenso, con historia familiar de cardiopatía coronaria. Se solicita perfil lipídico, como parte de exámenes de control, con los siguientes resultados: Colesterol total: 225, HDL: 35, TG: 220, LDL estimado: 146 La conducta más adecuada es:

- a) Indicar dieta baja en grasas saturadas, colesterol y carbohidratos refinados, sin necesidad de fármacos
- b) Iniciar una estatina
- c) Iniciar un fibrato

- d) Iniciar una asociación entre una estatina y un fibrato
- e) Iniciar ácido nicotínico

61) Paciente de 41 años, dueña de casa, consulta por astenia importante de 3 meses de evolución, a lo que se ha agregado prurito en el último tiempo. El examen físico es irrelevante. En sus exámenes destaca elevación importante de las fosfatasa alcalinas, con bilirrubina levemente elevada y transaminasas normales. Se solicitan anticuerpos antimitocondriales, que resultan positivos. El diagnóstico más probable es:

- a) Cirrosis biliar primaria
- b) Colangitis esclerosante primaria
- c) Hepatitis autoinmune
- d) Hepatopatía infiltrativa
- e) Esteatohepatitis no alcohólica

62) Paciente de 75 años, consulta por dolor abdominal intenso, compromiso del estado general, ictericia y fiebre hasta 39°C. AL examen se observa paciente icterica, febril: 38,8°C, desorientada, con FC: 130 lpm, PA: 86/52 mmHg. Abdomen muy doloroso en hipocondrio derecho. La primera medida que debe tomarse es:

- a) Administrar ceftriaxona más metronidazol endovenoso
- b) Realizar descompresión endoscópica de la vía biliar, mediante CPRE
- c) Resolver quirúrgicamente
- d) Solicitar ecografía de abdomen urgente
- e) Administrar suero fisiológico por vía periférica

63) Hombre de 63 años, consulta dolor abdominal bajo, intermitente, asociado a constipación, de 3 meses de evolución. Refiere no haber presentado dolor abdominal ni alteraciones del tránsito intestinal, previamente. No presenta otros síntomas y el examen físico es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar dieta rica en fibra y controlar en 3 meses
- b) Iniciar lactulosa en 2 dosis diarias, hasta lograr deposiciones
- c) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
- d) Solicitar radiografía de abdomen y pelvis
- e) Solicitar colonoscopia

64) Paciente de 55 años, diabético e hipertenso, asintomático. Se solicitan exámenes como parte de control de salud, con los siguiente resultados: creatinina: 0,7, electrolitos plasmáticos normales, sedimento de orina normal, glucosuria(-), proteinuria +, albuminuria de 24 horas de 130 mg. El diagnóstico más probable es:

- a) Diabetes sin nefropatía
- b) Insuficiencia renal secundaria a diabetes e hipertensión
- c) Nefropatía membranosa, secundaria a diabetes
- d) Nefropatía diabética inicial
- e) Síndrome nefrótico

65) Paciente de 22 años, sin patología previa ni hábitos tóxicos consulta por dolor torácico de 7 horas de evolución, de instalación progresiva, asociada a tope inspiratorio. El examen físico resulta normal. Se solicita radiografía de tórax que es informada como normal y electrocardiograma, que muestra supradesnivel del segmento ST en todas las derivaciones precordiales. El diagnóstico más probable es:

- a) Angina de vasoespástica
- b) Miocardiopatía hipertrófica
- c) Taponamiento cardíaco
- d) Pericarditis constrictiva
- e) Pericarditis aguda

66) Paciente hombre de 75 años, autovalente, con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes tipo 2 y pérdida leve de memoria desde hace 3 a 4 años. Hace una semana lo notan apático y con comportamiento extraño. Hace tres días, salió de compras y un vecino debió traerlo a casa pues no recordaba el camino. Desde hace dos días habla incoherencias, se agita y presenta insomnio. El diagnóstico más probable es::

- a) Enfermedad de Alzheimer

- b) Demencia por cuerpos de Lewy
- c) Trastorno psicótico
- d) Demencia frontotemporal
- e) Delirium

67) El tratamiento antibiótico empírico de la sepsis neonatal incluye:

- a) Ceftriaxona + Vancomicina
- b) Cefotaximo + Metronidazol
- c) Ampicilina + Cefotaximo
- d) Vancomicina + Metronidazol
- e) Gentamicina + Vancomicina

68) Un paciente de 33 años es ingresado por presentar hemorragia digestiva alta, que se acompaña de hipotensión importante, evolucionando con anuria y elevación de la creatinina hasta 4 mg/dl. Luego de reponer volumen y resolver la hemorragia, mediante tratamiento endoscópico, reinicia diuresis a 3.400cc diarias, sin embargo persiste con creatininemias elevadas, cercanas a 3,5. El examen de elección para confirmar la sospecha diagnóstica es:

- a) Electrolitos plasmáticos
- b) Fracción excretada de sodio
- c) Ecografía abdominal
- d) Orina completa
- e) Biopsia renal

69) La fiebre tifoidea, así como otras sepsis por bacterias Gram negativas presentan características típicas al hemograma, conocidas como hemograma tífico. ¿Cuál de las siguientes alternativas representa mejor a un hemograma tífico?

- a) Leucopenia con desviación izquierda y ausencia de eosinófilos
- b) Leucocitosis con desviación izquierda y eosinofilia
- c) Leucocitosis de predominio polimorfonuclear y basofilia
- d) Leucopenia con ausencia de basófilos y eosinófilos
- e) Leucocitosis con desviación izquierda y ausencia de eosinófilos y basófilos

70) Un paciente ingresa por un cuadro de neumonía grave, por lo que se solicitan gases arteriales que muestran pO₂: 82 mmHg, pCO₂: 38 mmHg, pH: 7,18, HCO₃: 14 mEq/l. El diagnóstico del estado ácido base es:

- a) Acidosis respiratoria
- b) Acidosis mixta
- c) Acidosis metabólica
- d) Acidosis respiratoria con alcalosis metabólica
- e) Acidosis metabólica con alcalosis respiratoria

Prueba 4

1) La sospecha clínica de asma debe ser confirmada con:

- a) Prueba de respuesta a los corticoides inhalados
- b) Prueba de provocación con metacolina
- c) Radiografía de tórax

- d) Prick test
- e) PEF (flujo espiratorio máximo)

2) Un paciente de 39 años consulta por fiebre y aparición de una lesión eritematosa, sensible, con aumento de la temperatura local, de 6 cm de diámetro, localizada en el brazo izquierdo, de bordes definidos, asociados a presencia de múltiples adenopatías axilares ipsilaterales. El agente más probable es:

- a) *Staphylococcus aureus*
- b) *Streptococcus pyogenes*
- c) *Escherichia coli*
- d) *Pseudomonas aeruginosa*
- e) Anaerobios

3) Una paciente de 60 años consulta por dolor abdominal tipo cólico, asociado a constipación, desde hace 1 mes. Refiere que en algunas oportunidades las deposiciones presentan algunas estrias de sangre. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad diverticular
- b) Cáncer de colon
- c) Colitis ulcerosa
- d) Enfermedad de Crohn
- e) Amebiasis intestinal

4) Un paciente de 34 años consulta por astenia y constipación. El examen físico es normal y se realiza hemograma que muestra anemia con hematocrito de 33%, VCM: 105 fl, sin alteraciones plaquetarias ni leucocitarias y TSH: que resulta 20 UI/l. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar T4
- b) Solicitar T4 libre
- c) Solicitar cintigrafía tiroidea
- d) Solicitar tiroglobulina
- e) Iniciar levotiroxina

5) Un infarto del lóbulo occipital izquierdo producirá:

- a) Amaurosis izquierda
- b) Amaurosis derecha
- c) Hemianopsia homónima izquierda
- d) Hemianopsia homónima derecha
- e) Hemianopsia heterónima bitemporal

6) Una mujer de 63 años consulta por artralgias de ambas manos de cerca de un año de evolución, que afecta principalmente las articulaciones interfalángicas distales y proximales, asociada a rigidez matinal de pocos minutos de duración. Al examen físico no se aprecian signos inflamatorios. El diagnóstico más probable es:

- a) Artritis reumatoide
- b) Lupus eritematoso sistémico
- c) Artrosis
- d) Síndrome de Crest
- e) Artritis psoriática

7) Una paciente de 69 años, diabética, presenta un síndrome coronario agudo con supradesnivel del segmento ST, que es manejado con trombolisis. Dos días después presenta varios síncope, seguidos de compromiso de consciencia. Al examen físico se aprecia marcada ingurgitación yugular, asociada a hipotensión hasta 70/30 mmHg. El examen cardíaco muestra RR2T con ruidos apagados y el examen pulmonar es normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Reinfarto

- b) Rotura del tabique interventricular
- c) Rotura del músculo papilar
- d) Rotura de la pared libre ventricular
- e) Trombosis de un aneurisma ventricular

8) ¿Cuál de las siguientes asociaciones entre espirometría y patología es INCORRECTA?

- a) VEF1/CVF: 45%; VEF1: 68%; CVF: 87%; sin mejoría post salbutamol - EPOC
- b) VEF1/CVF: 79%; VEF1: 63%; CVF: 57%; sin mejoría post salbutamol - Fibrosis pulmonar
- c) VEF1/CVF: 52%; VEF1: 68%; CVF: 105%; sin mejoría post salbutamol - Derrame pleural
- d) VEF1/CVF: 60%; VEF1: 66%; CVF: 93%; con mejoría post salbutamol - Asma
- e) VEF1/CVF: 80%; VEF1: 105%; CVF: 100%; sin mejoría post salbutamol - Hipertensión pulmonar primaria

9) Un niño de 6 años presenta edema facial y de extremidades inferiores, asociado a orinas espumosas. Sus signos vitales son normales y el resto del examen físico no aporta mayor información. Se solicitan exámenes que muestran proteinuria de 24 horas de 1,2 g/m², clearance de creatinina corregido: 95 ml/min, BUN: 12 mg/dl, complemento normal, ANA negativo, sedimento de orina normal, hemograma normal, albúmina plasmática: 2,5 g/dl, colesterol aumentado. EL diagnóstico más probable y la conducta más adecuada son respectivamente:

- a) Síndrome nefrótico puro e iniciar IECAs
- b) Síndrome nefrótico impuro y solicitar biopsia renal
- c) Glomerulopatía por cambios mínimos e iniciar corticoides orales
- d) Glomerulonefritis mesangiocapilar e iniciar prednisona
- e) Nefrosis lipoídea y observar evolución

10) Un paciente presenta baja de peso y diarrea, con lenteria y esteatorrea. Se solicita test de Sudán que resulta positivo y prueba de D-xilosa que muestra eliminación normal por la orina. La etiología más probable de la malaabsorción intestinal es:

- a) Déficit de enzimas pancreáticas
- b) Giardiasis
- c) Enfermedad celíaca
- d) Linfoma intestinal
- e) Enteropatía perdedora de proteínas

11) Una paciente de 56 años se realiza una mamografía que muestra un nódulo mamario denso, con microcalcificaciones pequeñas, siendo informado como BIRADS 4. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar nueva mamografía de inmediato
- b) Solicitar nueva mamografía en 6 meses
- c) Solicitar nueva mamografía en 12 meses
- d) Solicitar ecografía mamaria
- e) Realizar biopsia estereotáxica

12) La hiperprolactinemia en las mujeres produce:

- a) Polimenorrea y galactorrea
- b) Amenorrea y galactorrea
- c) Náuseas, vómitos y galactorrea
- d) Hemianopsia binasal y galactorrea
- e) Metrorragia y galactorrea

13) Un paciente consulta por dolor periocular derecho muy intenso, asociado a miosis, epifora y rinorrea ipsilateral. El diagnóstico más probable es:

- a) Migraña con aura
- b) Cefalea cluster
- c) Neuralgia del trigémino
- d) Infarto de troncoencéfalo
- e) Tumor cerebral

14) Un paciente de 60 años, fumador y dislipídico, consulta por dolor que aparece en la zona posterior de la pierna derecha, al caminar más de 2 cuadras y que cede rápidamente con el reposo. Al examen físico sólo se constata disminución de los pulsos pedios y tibiales posteriores bilaterales, con mayor compromiso a derecha. Además de dejar de fumar y controlar sus factores de riesgo cardiovascular se debe:

- a) Indicar anticoagulación a permanencia

- b) Indicar resolución quirúrgica
- c) Realizar trombolisis intra-arterial
- d) Indicar ejercicios
- e) Indicar sesiones de aplicación de ultrasonido

15) Un paciente de 56 años, cursando un síndrome neumónico, se realiza una radiografía de tórax, que muestra una zona de condensación, asociado a derrame pleural, el que se punciona, dando salida a un líquido amarillento, con características de exudado, con pH: 7,0, lactato: 9 mmol/l, sin visualización de bacterias a la tinción de Gram. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar antibióticos endovenosos e instalar tubo pleural
- b) Iniciar antibióticos endovenosos y drenar el líquido por toracocentesis
- c) Iniciar antibióticos endovenosos e intrapleurales
- d) Iniciar antibióticos endovenosos y realizar videotoracoscopia
- e) Iniciar antibióticos endovenosos y observar la evolución del derrame

16) El tratamiento de elección de la neumonía por Pneumocystis jirovecii es:

- a) Albendazol
- b) Fluconazol
- c) Metronidazol
- d) Tinidazol
- e) Cotrimoxazol

17) ¿Cuál de los siguientes marcadores es el más específico para lupus eritematoso sistémico?

- a) Anticuerpos anti-DNA de doble hebra
- b) Anticuerpos anti-nucleares
- c) Anticuerpos anti-citoplasma de neutrófilo
- d) Anticuerpos anti-histona
- e) Anticuerpos anti-ribonucleoproteína

18) Un paciente de 25 años consulta por dolor abdominal y diarrea de 6 semanas de evolución, que en algunas oportunidades es disintérica. Al examen físico destaca una masa abdominal en la fosa ilíaca derecha. El diagnóstico más probable es:

- a) Cáncer de colon
- b) Poliposis intestinal
- c) Amebiasis
- d) Enfermedad de Crohn
- e) Colitis ulcerosa

19) Un paciente de 34 años presenta una insuficiencia renal aguda luego de una hemorragia digestiva alta, con fracción excretada de sodio del 5%. El diagnóstico más probable es:

- a) Insuficiencia renal aguda prerrenal
- b) Necrosis tubular aguda
- c) Glomerulonefritis aguda
- d) Insuficiencia renal aguda post-renal
- e) Nefritis intersticial

20) Un paciente consulta por anemia con VCM: 83 fl, además presenta blancos: 9.000 x mm³, plaquetas: 520.000 x mm³. Se solicita perfil de hierro que muestra transferrina aumentada, pero con saturación disminuida y ferritina disminuida. El diagnóstico más probable es:

- a) Anemia ferropénica
- b) Anemia por enfermedades crónicas
- c) Leucemia mieloide crónica
- d) Anemia por déficit de vitamina B12
- e) Mielodisplasia

21) Una paciente de 64 años, hipertensa de mal manejo, con una insuficiencia cardíaca por cardiopatía hipertensiva, en tratamiento con furosemina y enalapril, consulta por palpitaciones y mayor disnea de la habitual. Refiere que ha presentado dichos síntomas en varias oportunidades. Al examen físico se constata pulso irregular a 120 lpm, con RI2T sin soplos y escasos crépitos pulmonares bibasales. El electrocardiograma muestra una taquicardia irregular, con complejos QRS angostos y ausencia de onda P. ¿Qué alternativa es MÁS adecuada para el manejo crónico de esta paciente?

- a) Agregar amiodarona
- b) Agregar aspirina
- c) Agregar betabloqueantes e iniciar anticoagulación a permanencia
- d) Indicar propafenona en caso de síntomas e iniciar anticoagulación a permanencia
- e) Indicar marcapasos

22) Un paciente de 80 años consulta por fiebre alta, asociada a tos con expectoración mucopurulenta y disnea, que ha ido aumentando hasta hacerse de reposo. Al examen físico está desorientado, deshidratado, cianótico, presenta FC: 33 rpm, con retracción intercostal y tiraje, FC: 115 x', regular, PA: 100/60 mmHg, SatO₂: 80%, con oxígeno al 15%. Se auscultan crépitos pulmonares bilaterales y se solicita una radiografía que muestra signos de relleno alveolo-intersticial bilateral, difuso, mayor en las bases. El MEJOR tratamiento antibiótico de entre los enumerados es:

- a) Amoxicilina
- b) Amoxicilina + ácido clavulánico
- c) Ceftriaxona
- d) Ceftriaxona + clindamicina
- e) Ceftriaxona + levofloxacino

23) Una mujer de 45 años consulta por astenia y dolores musculares generalizados, sin otros síntomas. Al examen físico se aprecia dolor a la presión de la mayoría de los grupos musculares, especialmente de los cervicales posteriores, trapecios, supraespinosos, lumbares, extensores de la muñeca y cara medial de los cuádriceps, sin otras alteraciones. El diagnóstico más probable es:

- a) Esclerodermia
- b) Polimiositis
- c) Polimialgia reumática
- d) Lupus
- e) Fibromialgia

24) Un paciente cirrótico por alcohol presenta hematemesis, seguida de ortostatismo. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar suero fisiológico y terlipresina por vía venosa periférica y solicitar endoscopia alta de urgencia
- b) Administrar omeprazol y suero fisiológico por vía venosa central y solicitar endoscopia
- c) Administrar terlipresina y suero fisiológico por vía venosa central
- d) Administrar glóbulos rojos, omeprazol y terlipresina por vía venosa periférica e instalar balón gastroesofágico
- e) Administrar suero fisiológico y propanolol por vía venosa periférica y solicitar endoscopia digestiva alta

25) La enfermedad de Addison se caracteriza por:

- a) Hipokalemia
- b) Hipernatremia
- c) Hiperglicemia
- d) Hiperpigmentación
- e) Hipertensión arterial

26) Un hombre de 23 años consulta por astenia, fiebre y dolores en las costillas y las extremidades. Al examen físico se aprecia pálido, con algunas equimosis en las extremidades. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Mieloma
- b) Leucemia aguda
- c) Leucemia linfática crónica
- d) Linfoma
- e) Púrpura trombocitopénico trombótico

27) Un paciente es diagnosticado de tuberculosis pulmonar, mediante baciloscopías. Se inicia tratamiento antituberculoso con cuatro fármacos y se controla al mes con una nueva baciloscopía que resulta positiva para bacilos ácido alcohol resistentes. La conducta más adecuada es:

- a) Mantener el tratamiento actual
- b) Agregar estreptomicina
- c) Agregar claritromicina

- d) Solicitar PCR para tuberculosis en esputo
- e) Solicitar PPD

28) Un paciente de 60 años, hipertenso de larga data, consulta por dolor torácico muy intenso, de inicio súbito, transfixiante, irradiado al dorso. Al examen físico está hipertenso y taquicárdico, se constata un soplo diastólico y el electrocardiograma muestra una taquicardia sinusal. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar aspirina, oxígeno y nitroglicerina y solicitar troponinas plasmáticas
- b) Iniciar anticoagulación con heparina
- c) Solicitar angio-TAC de tórax de urgencia
- d) Administrar nitroprusiato endovenosos, sin necesidad
- e) Realizar trombolisis endovenosa con rTPA

29) Un paciente fumador importante, es diagnosticado de enfermedad pulmonar obstructiva crónica moderada, mediante la clínica y la espirometría. Presenta disnea al caminar una cuadra y sus gases en sangre arterial resultan normales. La conducta más adecuada es:

- a) Dejar de fumar e iniciar broncodilatadores inhalados
- b) Dejar de fumar e iniciar corticoides inhalados
- c) Dejar de fumar e iniciar broncodilatadores inhalados y corticoides orales
- d) Dejar de fumar, iniciar broncodilatadores inhalados e indicar oxígeno domiciliario
- e) Dejar de fumar, iniciar broncodilatadores y corticoides inhalados e indicar oxígeno domiciliario

30) Un paciente de 49 años presenta un nódulo tiroideo de un centímetro de diámetro, que en la ecografía se muestra con microcalcificaciones, sin adenopatías asociadas. Se realiza punción con aguja fina, cuya citología es compatible con un carcinoma papilar de tiroides. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar niveles plasmáticos de tiroglobulina
- b) Iniciar levotiroxina en dosis altas
- c) Realizar tiroidectomía total en una segunda etapa administrar yodo radiactivo
- d) Administrar yodo radiactivo
- e) Realizar tiroidectomía + linfadenectomía y controlar con calcitonina

31) Un hombre de 45 años, diagnosticado de enfermedad de Chöhn, consulta por ictericia y prurito. Se solicitan exámenes de sangre que muestran GOT: 45 UI/l, GPT: 56 UI/l, FA: 388 UI/l, GGT: 566 UI/l, bilirrubina total: 6,4 mg/dl, bilirrubina directa: 5,0, ANA(-), ANCA(+), AMA(-). El diagnóstico más probable es:

- a) Colangitis aguda
- b) Colédocolitiasis
- c) Cirrosis biliar primaria
- d) Atresia biliar primaria
- e) Colangitis esclerosante

32) El tratamiento del púrpura trombocitopénico crónico suele ser:

- a) Aspirina
- b) Observación
- c) Prednisona
- d) Ácido tranexánico
- e) Transfusiones de plaquetas

33) Un paciente de 34 años presenta un cuadro diarreico autolimitado. Diez días después inicia debilidad progresiva para caminar y para mover las manos. Al examen físico se aprecia además parálisis fácil y arreflexia generalizada. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome de Guillain Barré
- b) Miastenia gravis
- c) Polineuropatía

- d) Botulismo
- e) Intoxicación por marea roja

34) Un paciente de 66 años se realiza una prostatectomía radical, por cáncer de próstata. Al segundo día postquirúrgico presenta de manera súbita, disnea y dolor torácico con tope inspiratorio, asociado a fiebre y tos con expectoración hemoptoica. Al examen físico está taquipneico, con FC: 100x' y PA: 120/80 mmHg. Se aprecia disminución del MP en la base izquierda, con algunos crépitos. El tratamiento del cuadro descrito es:

- a) Ceftriaxona
- b) Corticoides
- c) Heparina
- d) Tubo pleural
- e) Trombolisis

35) Un paciente consulta por disnea de esfuerzos. Se constata elevación marcada del BNP (péptido natriurético cerebral). El diagnóstico más probable es:

- a) Insuficiencia cardíaca
- b) Hipertensión pulmonar primaria
- c) EPOC
- d) Esclerosis múltiple
- e) Esclerosis lateral amiotrófica

36) Una mujer de 20 años consulta por astenia y fiebre de un mes de evolución, asociado a artralgias. Al examen físico se constata marcada disminución del pulso radial derecho y ausencia del pulso radial izquierdo. El diagnóstico más probable es:

- a) Coartación aórtica
- b) Tromboangeítis obliterante
- c) Arteritis de células gigantes
- d) Panarteritis nodosa
- e) Arteritis de Takayasu

37) ¿Cuál de las siguientes NO es una complicación de las tiazidas?

- a) Dislipidemia
- b) Hipocalcemia
- c) Hiponatremia
- d) Trombopenia
- e) Hipokalemia

38) El tratamiento de la úlcera duodenal activa, no complicada, suele ser:

- a) Omeprazol a permanencia
- b) Quirúrgico
- c) Erradicación de *Helicobacter pylori*
- d) Esclerosis endoscópica
- e) Inhibidor de la bomba de protones en una dosis única

39) Un paciente con sobrepeso, asintomático, se realiza una glicemia de ayuno, que resulta 130 mg/dl.

La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar hemoglobina glicosilada
- b) Solicitar test de tolerancia a la glucosa
- c) Solicitar nueva glicemia de ayuno
- d) Indicar dieta, ejercicios e hipoglicemiantes orales
- e) Iniciar insulinoterapia

40) El tratamiento antibiótico de elección de la meningitis bacteriana aguda en un niño de 6 años es:

- a) Cefotaximo + metronidazol
- b) Ceftriaxona + clindamicina
- c) Ceftriaxona + vancomicina
- d) Clindamicina + cefoperazona
- e) Cefotaximo + ampicilina

41) Un paciente sufre un accidente de tránsito, con rotura del bazo, por lo que se realiza esplenectomía, evolucionando positivamente. Probablemente presentará:

- a) Trombocitopenia
- b) Anemia
- c) Leucopenia
- d) Infecciones recurrentes por hongos
- e) Infecciones recurrentes por *Streptococcus pneumoniae*

42) Un paciente presenta una taquicardia regular a 170 x', con complejo QRS de 0,15 segundos (VN: menor a 0,12 segundos). Al examen físico está vigil, orientado y hemodinámicamente estable. El tratamiento de elección es:

- a) Maniobras vagales
- b) Flecainida v.o.
- c) Adenosina e.v.
- d) Amiodarona e.v.
- e) Adrenalina e.v.

43) Interprete los siguientes gases arteriales:

PaO₂: 84 mmHg ; PaCO₂: 22 mmHg ; HCO₃: 16 mmol/l ; pH: 7,48

- a) Alcalosis respiratoria
- b) Alcalosis metabólica
- c) Alcalosis metabólica con acidosis respiratoria
- d) Alcalosis mixta
- e) Insuficiencia respiratoria global con alcalosis mixta

44) Un paciente obeso se automedica levotiroxina en altas dosis para bajar de peso. Presentará todo lo siguiente, EXCEPTO:

- a) Exoftalmo
- b) Temblor
- c) Intolerancia al calor
- d) Polidefecación
- e) Taquicardia

45) Un paciente de 34 años, sin antecedentes de importancia, presenta elevación persistente de las transaminasas en varios perfiles bioquímicos. Se solicitan exámenes complementarios que muestran VHBs-Ag(-), VHBs-Ac IgM(-), VHBs-Ac IgG(+), VHBc-Ac IgM(-), VHBc-Ac IgG(+), VHC-Ac IgM(-), VHC-Ac IgG(+), ANA(-), ASMA(-), ANCA(-). El diagnóstico más probable es:

- a) Hepatitis B
- b) Hepatitis C
- c) Hepatitis A
- d) Hepatitis autoinmune
- e) Esteatohepatitis no alcohólica

46) La hipernatremia muy severa suele producir:

- a) Edema cerebral
- b) Hemorragias intracraneanas
- c) Taquicardia ventricular
- d) Taquicardia supraventricular
- e) Tetania

47) Una paciente consulta por cefalea progresiva, holocránea, intensa, opresiva, asociada a vómitos alimentarios. Al examen físico se aprecia hiperreflexia en la extremidad inferior izquierda y signo de Babinsky. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar TAC de cerebro
- b) Solicitar punción lumbar
- c) Administrar ergotamínicos e iniciar antidepresivos tricíclicos

- d) Administrar oxígeno al 100% y triptanes subcutáneos
- e) Administrar AINES e iniciar anticonvulsivantes

48) Una paciente de 30 años consulta por astenia, debilidad muscular y aumento de peso. Al examen físico se aprecia obesidad de predominio central, con atrofia muscular en las extremidades y estrías en el abdomen. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar somatomedinas
- b) Solicitar cortisol plasmático basal y post-ACTH
- c) Solicitar cortisol libre urinario de 24 horas
- d) Solicitar ACTH y cortisol plasmáticos basales
- e) Solicitar ACTH basal y post supresión con dexametasona

49) Un paciente de 54 años, obeso, sin otros antecedentes de importancia, consulta por dolor torácico, que inició hace 30 minutos, muy intenso, opresivo, irradiado a ambos hombros y asociado a sudoración. Al examen físico presenta FC: 103 x', PA: 130/90 mmHg, RR2T sin soplos y MP(+) sin ruidos agregados. Se solicita electrocardiograma que muestra aplanamiento de la onda T en las derivaciones precordiales anteroseptales, con alteraciones inespecíficas de la repolarización. La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio con AINES orales
- b) Solicitar test de esfuerzo
- c) Solicitar TAC de tórax
- d) Hospitalizar, iniciar aspirina, oxígeno, morfina, nitroglicerina y solicitar enzimas cardíacas seriadas
- e) Solicitar ecocardiografía

50) Un niño de 3 años consulta por tos seca, fiebre hasta 38,7°C y dificultad respiratoria. Al examen físico se aprecia estridor inspiratorio y utilización de musculatura accesorio. El examen pulmonar no aporta mayor información. La etiología más probable es:

- a) Virus respiratorio sincicial
- b) Virus parainfluenza
- c) Virus influenza
- d) Neumococo
- e) Streptococo beta hemolítico grupo A

51) Una paciente de 35 años consulta por dolor en los dedos de ambas manos. Refiere que frecuentemente se vuelven blancos y luego cianóticos, especialmente cuando los expone al frío, durando varios minutos en estas condiciones. Además refiere dificultad para tragar, intermitente, que se ha vuelto más frecuente en los últimos días. Al examen físico se aprecia acartonamiento de los dedos y algunas telangiectasias faciales. El diagnóstico más probable es:

- a) Esclerodermia
- b) Dermatomiositis
- c) Lupus
- d) Endocarditis bacteriana subaguda
- e) Artritis reumatoide

52) Un paciente de 30 años consulta por disfagia progresiva, con mayor dificultad para tragar los líquidos, que en algunas oportunidades es más severa. Además refiere 2 neumonías aspirativas en los últimos 6 meses. El examen más adecuado para el diagnóstico es:

- a) Endoscopia digestiva
- b) pH-metría de 24 horas
- c) Manometría esofágica
- d) Radiografías baritadas
- e) TAC de tórax y abdomen

53) Un paciente de 13 años consulta por hematuria y edema palpebral de pocos días de evolución. Está hipertenso, con exámenes que muestran creatinina: 1,2 mg/dl, BUN: 20 mg/dl, sedimento de orina con 38 hematíes por campo, 15% de dismorfia, 15 leucocitos por campo, proteinuria de 24 horas: 1,2 gramos. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome nefrítico
- b) Síndrome nefrótico puro

- c) Síndrome nefrótico impuro
- d) Síndrome hemolítico-urémico
- e) Tuberculosis

54) Un niño de 9 años consulta por fiebre, odinofagia y malestar general, asociado a aparición de vesículas dolorosas en la faringe, palmas y plantas. El agente etiológico es:

- a) Virus herpes simple
- b) Virus herpes 6
- c) Parvovirus B19
- d) Enterovirus
- e) Virus varicela zóster

55) Un paciente de 36 años presenta fiebre alta, cefalea, mialgias, malestar general y ojo rojo. Refiere haber consumido productos animales sin procesar y haberse bañado en aguas estancadas. Al examen físico se aprecia conjuntivitis hemorrágica y signos meníngeos, por lo que se realiza un punción lumbar, que confirma la presencia de una meningitis aséptica. El agente de sospecha es:

- a) Bartonella
- b) Adenovirus
- c) Leptospira
- d) Borrelia
- e) Brucella

56) Un niño presenta infecciones respiratorias recurrentes, asociadas a un soplo mesosistólico, con desdoblamiento fijo del segundo ruido. El diagnóstico más probable es:

- a) Comunicación interventricular
- b) Comunicación interauricular
- c) Ductus arterioso persistente
- d) Coartación aórtica
- e) Tetralogía de Fallot

57) El tratamiento de un neumotórax espontáneo moderado, NO hipertensivo, es:

- a) Tubo pleural
- b) Drenaje del aire por toracocentesis
- c) Lobectomía pulmonar
- d) Punción del segundo espacio intercostal
- e) Cirugía abierta

58) Un paciente cirrótico avanzado por consumo crónico de alcohol y diabético, en tratamiento con dieta, presenta varios hemoglútest mayores a 200 mg/dl, conprobándose una hemoglobina glicosilada de 8,9%. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar metformina
- b) Iniciar glibenclamida
- c) Iniciar insulina
- d) Solicitar marcadores de autoinmunidad para la diabetes
- e) Solicitar test de tolerancia a la glucosa

59) Las causas más frecuentes de daño hepático crónico y pancreatitis aguda son respectivamente:

- a) Viral y alcohol
- b) Viral y litiasica
- c) Alcohol y alcohol
- d) Alcohol y litiasica
- e) NASH y alcohol

60) Una paciente de 68 años, asintomática, se realiza un hemograma que muestra VHS: 23 mm/h, hematocrito: 32%, Hb: 10,6 g/dl, HCM: 34 pg, VCM: 106 ft, plaquetas: 90.000 x mm³, glóbulos blancos: 3.900 x mm³, linfocitos: 65%, segmentados: 30%, monocitos: 5%. Se solicitan niveles plasmáticos de vitamina B12 y folatos, que resultan normales. El diagnóstico más probable es:

- a) Mieloma múltiple
- b) Leucemia mieloide crónica

- c) Leucemia linfática crónica
- d) Mielodisplasia
- e) Mielofibrosis

61) Una paciente de 65 años consulta por debilidad de las extremidades inferiores, progresiva, sin síntomas sensitivos. Al examen físico se constata atrofia muscular, fasciculaciones, aumento de los reflejos osteotendíneos y del tono muscular. El diagnóstico más probable es:

- a) Distrofia muscular
- b) Polineuropatía
- c) Esclerosis lateral amiotrófica
- d) Esclerosis múltiple
- e) Poliradiculoneuritis desmielinizante

62) Un niño de 6 años presenta fiebre alta, asociada a dolor en la rodilla izquierda, que le impide la marcha. Al examen físico se aprecia aumento de volumen, eritema y aumento del calor local de la rodilla izquierda, con signos de derrame. El diagnóstico más probable es:

- a) Sinovitis transitoria
- b) Enfermedad de Osgood Schlatter
- c) Osteomielitis
- d) Artritis séptica
- e) Artritis traumática

63) La presencia de un soplo diastólico, con refuerzo presistólico, aumento de la intensidad del primer ruido y presencia de chasquido de apertura son características de:

- a) Estenosis mitral
- b) Insuficiencia mitral
- c) Estenosis aórtica
- d) Insuficiencia aórtica
- e) Miocardiopatía hipertrófica obstructiva

64) Un paciente de 68 años presenta un cuadro clínico sugerente de derrame pleural, por lo que se decide solicitar radiografía de tórax que confirma un derrame pleural izquierdo moderado, el que se punciona obteniéndose un líquido amarillento, con LDH: 105 UI/l, proteínas: 4,8 g/dl, adenosín-deaminasa (ADA) 7 UI/l, con 236 células por mm³, de las cuales un 90% son mononucleares. Las proteínas plasmáticas son: 7,2 g/dl y la LDH plasmática es 150 UI/l. El diagnóstico más probable es:

- a) Insuficiencia cardíaca
- b) Síndrome nefrótico
- c) Derrame paraneumónico simple
- d) Tuberculosis
- e) Cáncer

65) Una paciente con amenorrea, en la cual se ha descartado un embarazo, se realiza prueba de progesterona que resulta negativa. Luego se realiza una prueba de estrógenos + progesterona que también resulta negativa. El diagnóstico más probable es:

- a) Anovulación crónica
- b) Falla ovárica
- c) Hipopituitarismo
- d) Amenorrea hipotalámica
- e) Amenorrea de origen uterino

66) Un paciente presenta dolor epigástrico urente, irradiado al tórax, que aparece frecuentemente, especialmente luego de comer. Se solicita endoscopia digestiva alta que muestra una esofagitis distal, sin otras alteraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Solicitar pH-metría
- c) Solicitar videodeglución

- d) Iniciar medidas antirreflujo y omeprazol
- e) Erradicar H. pylori

67) Un paciente de 44 años, asintomático, se realiza toma de presión arterial, que resulta 150/100 mmHg. Se realizan varias tomas en distintos días de la semana, con valores similares. En sus exámenes generales se aprecia creatinina: 0,8 mg/dl, Na: 138 mEq/l, K: 3,9 mEq/l, glicemia de ayuno: 98 mg/dl, colesterol total: 230 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

- a) Hipertensión esencial
- b) Hipertensión renovascular
- c) Nefropatía médica
- d) Hipertensión por hiperaldosteronismo primario
- e) Feocromocitoma

68) ¿Qué lesión presenta un mayor riesgo de desarrollar ceguera en el fondo de ojo de un paciente diabético?

- a) Microaneurismas
- b) Vasos de neoformación
- c) Microrinfartos retinales
- d) Microhemorragias
- e) Exudados céreos

69) Un paciente de 9 años presenta un cuadro de movimientos involuntarios de la pierna derecha, que luego se extienden a la mano derecha, siendo seguido de desconexión del medio, chupeteo y finalmente una convulsión tónicoclónica. Con mayor probabilidad padece de:

- a) Epilepsia mioclónica
- b) Epilepsia tónicoclónica
- c) Epilepsia por crisis de ausencia
- d) Epilepsia atona (atónica)
- e) Epilepsia focal

70) Un hombre de 70 años presenta marcado malestar general y ortostatismo, que inició hace 1 hora. Al examen físico se aprecia FC: 31 lpm, regular y PA: 80/50 mmHg. El diagnóstico más probable es:

- a) Bloqueo AV completo
- b) Enfermedad del nodo sinusal
- c) Bradicardia fisiológica
- d) Síndrome de Wolf-Parkinson-White
- e) Síncope vasovagal

Prueba 5

1) Un paciente de 68 años, hipertenso, consulta por dolor precordial opresivo, de 60 minutos de duración, irradiado al brazo izquierdo. Al examen físico está taquicárdico, con PA: 160/110 mmHg, RR2T y MP+ SRA. Se solicita electrocardiograma que muestra FC: 93 lpm, regular, en ritmo sinusal, con supradesnivel del segmento ST en las derivaciones DII, DII y AVF. Las troponinas plasmáticas son

negativas. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar anticoagulación con heparina
- b) Administrar oxígeno, aspirina, nitroglicerina y solicitar test de esfuerzo
- c) Administrar oxígeno, aspirina, nitroglicerina y solicitar ecocardiograma
- d) Administrar oxígeno, aspirina, nitroglicerina e iniciar trombolisis endovenosa con rTPA
- e) Iniciar AINES orales y solicitar troponinas seriadas

2) Un paciente consulta por astenia, debilidad muscular, náuseas e hiperpigmentación de la cara. En sus exámenes generales además se observa hiponatremia e hiperkalemia. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar cortisol libre urinario de 24 horas
- b) Solicitar ACTH basal y post-dexametasona
- c) Solicitar cortisol basal y post-dexametasona
- d) Solicitar ACTH y cortisol basales
- e) Solicitar cortisol basal y post-ACTH

3) Un adolescente de 17 años consulta por diarrea de 4 semanas de evolución, asociada a dolor abdominal y sensación febril ocasional. En el último tiempo la diarrea se ha vuelto disintérica. El examen físico no aporta mayor información. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar ciprofloxacino
- b) Iniciar metronidazol
- c) Solicitar coprocultivo
- d) Solicitar colonoscopia
- e) Solicitar tomografía de abdomen y pelvis

4) Un paciente de 68 años consulta por astenia, sin otros síntomas. Al examen físico se aprecia algo pálido, sin otras alteraciones. Se solicita un hemograma que muestra hematocrito: 30%, hemoglobina: 10g/dl, VCM: 90 fl, HCM: 30 pg, blancos: 24.000 x mm³, segmentados: 12%, linfocitos: 86%, monocitos: 2%, plaquetas: 130.000 x mm³. El diagnóstico más probable es:

- a) Leucemia aguda
- b) Leucemia mieloide crónica
- c) Leucemia linfática crónica
- d) Mononucleosis infecciosa
- e) Linfoma

5) Un paciente de 55 años consulta por tos con expectoración mucopurulenta, fiebre y dolor tipo puntada de costado. Se realiza una radiografía de tórax que visualiza un derrame pleural izquierdo moderado, el que se punciona, dando salida a un líquido pleural con 1.200 células por mm³, 95% de polimorfonucleares, proteínas: 4,8 g/dl, LDH: 250 UI/l, pH: 7, ADA: 52 UI/l, lactato: 9 mmol/l. Las proteínas plasmáticas son: 6,5 g/dl y la LDH plasmática es: 280 UI/l. El diagnóstico más probable es:

- a) Derrame paraneumónico simple
- b) Empiema
- c) Cáncer
- d) Tuberculosis
- e) Transudado pleural

6) Una paciente de 18 años, sin antecedentes de importancia, consulta por disuria dolorosa y fiebre hasta 39°C de un día de evolución. Al examen físico se constata febril, con FC: 85x', PA: 120/80 mmHg y puño percusión positiva a izquierda, sin otras alteraciones. Se solicita sedimento de orina, que muestra leucocituria +++ y urocultivo que está pendiente. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar ecografía renal
- b) Iniciar nitrofurantoína y controlar en 48 horas

- c) Iniciar ciprofloxacino oral y controlar en 48 horas
- d) Hospitalizar e iniciar ceftriaxona endovenosa
- e) Hospitalizar e iniciar ceftazidina + gentamicina endovenosa

7) Un paciente de 67 años presenta palpitaciones intensas, asociadas a síncope. Al examen físico se aprecia sudoroso, con FC 184x' y PA: 90/60 mmHg. El registro electrocardiográfico muestra una taquicardia regular, a 184 lpm, con ensanchamiento del complejo QRS y disociación aurículo-ventricular. El diagnóstico más probable es:

- a) Fibrilación auricular
- b) Taquicardia paroxística supraventricular
- c) Taquicardia ventricular
- d) Fibrilación ventricular
- e) Flutter auricular con síndrome de Wolf Parkinson White

8) Un niño de 10 años presenta hematuria en varias oportunidades. Al examen físico está en buenas condiciones, con signos vitales normales y sin hallazgos de importancia. Se solicitan exámenes que muestran sedimento de orina con hematuria de 60 GR por campo con 20% de dismorfia, proteinuria ++, creatinina: 0,6 mg/dl, ANA(-), ANCA(-) y complemento normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad por cambios mínimos
- b) Glomerulonefritis aguda postestreptocócica
- c) Lupus infantil
- d) Enfermedad de Berger
- e) Glomerulopatía membranosa

9) Un paciente de 68 años consulta por astenia, constipación y poliuria. Se solicitan exámenes generales que muestran glicemia: 90 mg/dl, albúmina: 3,5 g/dl, calcio: 12,5 mg/dl, fósforo: 7,1 mg/dl, fosfatasas alcalinas: 354 UI/l. El diagnóstico más probable es:

- a) Hipervitaminosis D
- b) Hiperparatiroidismo primario
- c) Hiperparatiroidismo secundario
- d) Hipercalcemia maligna
- e) Hipercalcemia ficticia (pseudohipercalcemia)

10) La lesión del tercer nervio craneal izquierdo producirá:

- a) Ptosis
- b) Miosis
- c) Imposibilidad de mirar a lateral
- d) Imposibilidad de cerrar el ojo
- e) Imposibilidad de mirar hacia ínfero-nasal

11) Un paciente de 70 años presenta fiebre, tos y disnea de 2 días de evolución. Al examen físico está taquicárdico, disneico, con FC: 102 x', PA: 120/80 mmHg, t°: 38,0°C, PaO2: 87% a FiO2 ambiental. La auscultación pulmonar muestra crepitaciones localizadas en la base izquierda. Se solicita una radiografía de tórax que muestra un foco de condensación neumónico en el lóbulo inferior izquierdo. El tratamiento antibiótico más adecuado es:

- a) Ceftriaxona
- b) Amoxicilina + ácido clavulánico
- c) Claritromicina
- d) Ceftazidina + vancomicina + metronidazol
- e) Clindamicina

12) Un paciente de 56 años, cirrótico por consumo crónico de alcohol, consulta por aumento del perímetro abdominal, asociado a dolor abdominal. Al examen físico se aprecia tinte subictérico de las escleras, abdomen con matidez desplazable y signos de la ola. Se solicitan pruebas hepáticas que muestran GOT: 100 UI/l, GPT: 69 UI/l, GGT: 120 UI/l, FA: 120 UI/l, Bili total: 2,8 mg/dl, Bili directa: 2,0 mg/dl. Se realiza paracentesis que muestra salida de líquido peritoneal amarillo, transparente con proteínas de 2,0 g/dl, 350 células por mm3, con 90% de polimorfonucleares. La conducta más

adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Iniciar antibióticos endovenosos
- c) Realizar paracentesis evacuadora
- d) Realizar paracentesis evacuadora e iniciar antibióticos endovenosos
- e) Iniciar furosemida + espironolactona

13) El tratamiento de la neumonía por *Pneumocystis jirovecii*, en un paciente portador del virus de la inmunodeficiencia humana, es:

- a) Cefalosporina de 1ra generación
- b) Cefalosporina de 3ra generación
- c) Metronidazol
- d) Anfotericina B
- e) Sulfametoxazol + trimetoprim

14) Una paciente de 59 años consulta por disnea de esfuerzo, asociada a disnea paroxística nocturna. Al examen físico se aprecia desplazamiento del choque de la punta y se ausculta un soplo holosistólico intenso. El diagnóstico más probable es:

- a) Miocardiopatía hipertrófica
- b) Estenosis mitral
- c) Insuficiencia mitral
- d) Estenosis aórtica
- e) Insuficiencia aórtica

15) Un paciente diabético tipo 2, de larga data, en tratamiento con metformina, presenta disminución de la sensibilidad de las extremidades inferiores. Al examen físico se constata disminución de la sensibilidad termalgésica y vibratoria de predominio distal. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar insulina NPH en 2 dosis diarias
- b) Iniciar antidepresivos tricíclicos y mejorar el control metabólico
- c) Iniciar gabapentina e iniciar insulina en esquema intensificado
- d) Iniciar glibenclamida
- e) Indicar uso de calzado adecuado y revisión periódica de los pies y mejorar el control metabólico

16) Un hombre de 60 años consulta por dolor y aumento de volumen del codo izquierdo. Al examen físico se aprecia eritema, aumento de la temperatura local y signos de derrame articular del codo izquierdo. La radiografía no muestra lesiones óseas. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar hemograma, PCR y realizar punción articular y estudio de líquido sinovial
- b) Solicitar hemograma, PCR y ácido úrico plasmático
- c) Iniciar AINES endovenosos
- d) Administrar antibióticos intrarticulares
- e) Indicar inmovilización con cabestrillo e indicar AINES orales

17) Una paciente de 26 años consulta por constipación de 3 años de evolución, caracterizadas por deposiciones duras, caprinas, cada 4 a 5 días, sin sangre ni restos de alimentos. El examen físico resulta normal. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar colonoscopia
- b) Iniciar antidepresivos tricíclicos
- c) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
- d) Solicitar ecografía abdominal
- e) Indicar aumento en la ingesta de agua y dieta rica en fibra y controlar en 1 mes

18) El factor pronóstico más importante en el cáncer de mama es:

- a) La presencia de receptores hormonales
- b) La presencia de invasión vascular en la histología
- c) La presencia de adenopatías axilares
- d) El tamaño del tumor
- e) El grado de diferenciación histológica

19) Un paciente de 13 años presenta tos en relación con el ejercicio y en ocasiones cuando está expuesto a polvo y humo del cigarrillo. Además ha presentado crisis de disnea, con “silbidos en el pecho”. Al examen físico sólo destaca espiración prolongada, sin otras alteraciones. Se solicita un test de metacolina, que resulta positivo para hiperreactividad bronquial. El tratamiento más adecuado es:

- a) Prednisona oral según horario y salmeterol inhalado en caso de síntomas
- b) Corticoides inhalados en caso de síntomas
- c) Salmeterol inhalado en caso de síntomas y salbutamol inhalado según horario
- d) Corticoides inhalados en caso de síntomas y salbutamol inhalado según horario
- e) Salbutamol inhalado en caso de síntomas y corticoides inhalados según horario

20) Una mujer de 33 años consulta por astenia y debilidad fluctuantes, asociadas a diplopía, que se agrava al realizar deporte. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Botulismo
- b) Polineuropatía
- c) Síndrome de Guillain Barré
- d) Miastenia gravis
- e) Esclerosis múltiple

21) Una paciente presenta un bocio difuso moderado, no doloroso. Se solicita TSH que resulta 12 UI/L. El diagnóstico más probable es:

- a) Tiroiditis de Riedel
- b) Tiroiditis de Hashimoto
- c) Enfermedad de Basedow-Graves
- d) Tiroiditis subaguda de Querverlein
- e) Cáncer de tiroides

22) ¿Cuál de las siguientes alteraciones es MENOS probable de encontrar en un paciente con púrpura trombocitopenico crónico?

- a) Petequias
- b) Equimosis
- c) Hemartrosis
- d) Espistaxis
- e) Gingivorragia

23) ¿Qué medicamentos son los más adecuados para el tratamiento inicial una insuficiencia cardíaca debida a una cardiopatía hipertensiva?

- a) Digoxina, furosemida y losartán
- b) Espironolactona, diltiazem y aspirina
- c) Aspirina, amiodarona y enalapril
- d) Anticoagulantes orales, enalapril y digoxina
- e) Furosemida, enalapril y carvedilol

24) Un paciente de 50 años ha presentado 4 cuadros de sudoración, temblor y palpitaciones de varios minutos de duración, que ceden espontáneamente y que iniciaron hace un mes. En el último episodio además presentó desorientación y agresividad. El examen físico es normal. ¿Qué diagnóstico es más probable de entre los siguientes?

- a) Hipertiroidismo
- b) Tumor cerebral
- c) Taquicardia paroxística supraventricular
- d) Epilepsia
- e) Hipoglucemia

25) Un paciente de 58 años, diabético tipo 2 en tratamiento con glibenclamida 10 mg c/12 horas y metformina 850 mg c/8 horas presenta varios hemoglucotest mayores a 200 mg/dl. Se solicita hemoglobina glicosilada que resulta 9,4%. Su creatinina, pruebas hepáticas, proteinuria de 24 horas, hemograma y electrocardiograma son normales. La conducta más adecuada es:

- a) Aumentar la dosis de glibenclamida
- b) Aumentar la dosis de metformina

- c) Agregar clorpropamida
- d) Reemplazar la metformina por tolbutamida
- e) Iniciar insulina

26) Una paciente de 15 años consulta por un cuadro de fiebre y malestar general de un día de evolución, seguido de aparición de un exantema pruriginoso pápulo-vesicular, con compromiso de la cabeza, tronco y extremidades. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar ibuprofeno y clorfenamina oral
- b) Iniciar paracetamol y clorfenamina oral
- c) Iniciar aciclovir, clorfenamina y paracetamol oral
- d) Iniciar cloxacilina, clorfenamina e ibuprofeno oral
- e) Iniciar aciclovir, cloxacilina, clorfenamina y paracetamol oral

27) Un paciente de 32 años consulta por dolor abdominal muy intenso, que apareció hace 12 horas en el epigastrio y que luego se localizó en la fosa iliaca derecha. Al examen físico se aprecia FC: 93x', PA: 130/86 mmHg, t°: 37,4°C, abdomen sensible a la palpación, con resistencia muscular a la palpación de la fosa iliaca derecha y signo de Blumberg (+). La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar ecografía abdominal
- b) Solicitar TAC abdominal y pélvico
- c) Solicitar colonoscopia de urgencia
- d) Resolver quirúrgicamente de inmediato
- e) Iniciar antibióticos de amplio espectro y resolver quirúrgicamente, de manera diferida, en 3 meses

28) Un paciente de 64 años, fumador de una cajetilla al día, consulta por tos y expectoración mucosa. Se realiza una radiografía tórax de muestra un nódulo pulmonar parahiliar izquierdo, de 3,5 cm de diámetro, que no estaba presente en radiografías previas, realizadas hace 2 años. Se solicita un TAC de tórax que muestra un nódulo pulmonar único en el lóbulo superior izquierdo, con bordes espiculados, sin adenopatías. La conducta más adecuada es:

- a) Controlar nueva radiografía en 3 meses
- b) Controlar con nuevo TAC en 3 meses
- c) Solicitar resonancia magnética nuclear
- d) Solicitar broncoscopia y biopsia
- e) Realizar lobectomía pulmonar y biopsia

29) Un recién nacido de 2 semanas de vida presenta un soplo cardíaco continuo, asociado a crepitaciones pulmonares bibasales. El diagnóstico más probable es:

- a) Soplo funcional
- b) Comunicación interauricular
- c) Comunicación interventricular
- d) Ductus arterioso persistente
- e) Tronco arterioso

30) Un paciente presenta debilidad de las extremidades inferiores. Al examen físico se constata atrofia muscular y debilidad de predominio distal, con presencia de fasciculaciones y disminución del tono muscular y abolición de los reflejos osteotendíneos. El diagnóstico más probable es:

- a) Esclerosis múltiple
- b) Esclerosis lateral amiotrófica
- c) Polineuropatía (denervación)
- d) Síndrome piramidal
- e) Síndrome extrapiramidal

31) Un paciente hipertenso en tratamiento con losartán y atenolol, presenta debilidad y un electrocardiograma que muestra ensanchamiento del complejo QRS, con ondas T de amplitud aumentada. ¿Qué alteración hidroelectrolítica es compatible con este cuadro?

- a) Hipercalcemia
- b) Hipocalcemia
- c) Hipomagnesemia

- d) Hipokalemia
- e) Hiperkalemia

32) El tratamiento de la triquinosis es:

- a) Prazicuantel
- b) Nifurtimox
- c) Niclosamida
- d) Cotrimoxazol
- e) Albendazol

33) Un paciente de 26 años consulta por dolor lumbar, mayor en la noche y en la mañana, mejorando con el ejercicio y asociado a rigidez matinal. Al examen físico destaca disminución en la movilidad de la columna lumbar. El diagnóstico más probable es:

- a) Espondilodiscitis
- b) Raquiestenosis
- c) Artrosis lumbar
- d) Lumbago mecánico
- e) Espondilitis anquilosante

34) Un paciente de 46 años, obeso, diabético tipo 2 en tratamiento con dieta, presenta elevación de las transaminasas hasta valores cercanos a 150 UI/l. Al examen físico se palpa el hígado por 3 cm bajo el reborde costal, siendo levemente doloroso a la palpación. Consume alcohol máximo 2 veces al mes y no utiliza medicamentos. El diagnóstico más probable es:

- a) Hepatitis alcohólica
- b) Hepatitis por virus de la hepatitis B
- c) Hepatitis por virus de la hepatitis C
- d) Esteatohepatitis no alcohólica
- e) Hepatitis autoinmune

35) Un paciente con anemia crónica, normocítica, se realiza un perfil de hierro que muestra disminución de la ferremia, disminución de la transferrina y aumento de la ferritina plasmática. El diagnóstico más probable es:

- a) Ferropenia
- b) Anemia por enfermedades crónicas
- c) Talasemia
- d) Déficit de vitamina B12
- e) Mielodisplasia

36) Un paciente de 50 años consulta por disnea de esfuerzos de 6 semanas de evolución, progresiva, asociada a tos seca. Al examen físico se auscultan crepitaciones pulmonares intensas bilaterales, con campos pulmonares pequeños a la percusión torácica. Se solicita una radiografía de tórax que muestra un infiltrado intersticial bilateral, mayor en las bases. El diagnóstico más probable es:

- a) Neumonía por *Mycoplasma pneumoniae*
- b) Tuberculosis pulmonar
- c) Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
- d) Fibrosis pulmonar
- e) Hipertensión pulmonar primaria

37) Debido al aumento del uso de los dispositivos intravasculares, la etiología de la endocarditis bacteriana ha cambiado. La primera y segunda causa actual de endocarditis bacteriana es:

- a) *Staphylococcus aureus* y *Streptococcus viridans*
- b) *Staphylococcus aureus* y *Streptococcus pyogenes*
- c) *Streptococcus viridans* y *Enterococcus faecalis*
- d) *Staphylococcus coagulasa negativa* y *Streptococcus viridans*
- e) *Staphylococcus coagulasa negativa* y *Enterococcus faecalis*

38) Una paciente de 26 años consulta por orinas espumosas y edema de extremidades inferiores. Al examen físico se constata FC: 70 x', PA: 110/70 mmHg, edema de párpados y de extremidades inferiores. Se solicita clearance de creatinina que resulta 65 ml/min, proteinuria de 24 horas que resulta 3,5 gramos, sedimento de orina con hematuria microscópica y lipiduria, albuminuria: 2,6 g/dl, colesterol: 320 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome nefrítico

- b) Síndrome nefrótico
- c) Síndrome hemolítico urémico
- d) Glomerulonefritis rápidamente progresiva
- e) Glomerulonefritis por depósitos de IgA

39) Una paciente de 30 años consulta por eritema de la cara, sobre el dorso de la nariz y los pómulos, que respeta el surco nasolabial y que suele aparecer luego de la exposición solar. El diagnóstico más probable es:

- a) Dermatomiositis
- b) Esclerodermia
- c) Lupuseritematoso sistémico
- d) Lupus discoide
- e) Arteritis de Wegener

40) ¿Cuál de las siguientes paciente tiene el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico?

- a) Paciente asintomática, que se realiza una ecografía transvaginal que muestra múltiples quistes ováricos bilaterales
- b) Paciente con acné, piel grasa y aumento de la testosterona plasmática
- c) Paciente con oligomenorrea e hirsutismo
- d) Paciente obesa en amenorrea desde hace 4 meses
- e) Paciente con acantosis nigricans y reglas irregulares

41) Un hombre de 45 años consulta por cefalea de larga data, opresiva, de localización occipital, irradiada a la parte posterior del cuello que suele aparecer en la tarde y que se ha vuelto más frecuente en el último tiempo, lo que lo tiene preocupado. Al examen físico no se aprecian signos focales. El diagnóstico más probable es:

- a) Jaqueca
- b) Cefalea tensional
- c) Cefalea cluster
- d) Tumor cerebral
- e) Pseudotumor cerebral

42) La anticoagulación con heparina no fraccionada y con heparina fraccionada se controla respectivamente con:

- a) TTPA y TP
- b) TP y TTPA
- c) TTPA y tiempo de sangría
- d) Tiempo de sangría y TTPA
- e) TTPA y no necesita control

43) Un paciente de 64 años, asintomático, se realiza un electrocardiograma que muestra frecuencia cardíaca de 70 lpm, con un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, Mobitz II, asociado a bloqueo completo de rama izquierda. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar Holter de Arritmias
- b) Iniciar amiodarona
- c) Iniciar verapamilo
- d) Instalar marcapasos definitivo
- e) Observar evolución

44) Un paciente de 80 años presenta astenia, debilidad, náuseas, oliguria e hipo crónico. Al examen físico se aprecia pálido, con asterixis, sin signos focales. El diagnóstico más probable es:

- a) Cáncer
- b) Insuficiencia renal
- c) Cirrosis hepática
- d) Arteritis de la temporal
- e) Síndrome de inmunodeficiencia adquirida

45) Un paciente de 70 años presenta fiebre alta, cefalea y compromiso del estado general. Al examen físico se aprecia signo de Brudzinsky y de Kerning, por lo que se realiza una punción lumbar, que da salida a un líquido cefalorraquídeo turbio, con células: 1.430 x mm³, con 84% de polimorfonucleares y 16% de mononucleares, proteínas: 120 mg/dl, glucosa: 20%. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar tratamiento sintomático
- b) Iniciar drogas antituberculosas

- c) Solicitar baciloscopías de LCR
- d) Iniciar cefotaximo + metronidazol
- e) Iniciar ceftriaxona + ampicilina

46) Un paciente de 29 años consulta por dolor epigástrico urente que aparece varias veces en la semana, especialmente en relación al ayuno, cediendo al ingerir alimentos. El examen físico es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar endoscopia digestiva alta
- b) Solicitar ecografía abdominal
- c) Solicitar pH-metría de 24 horas
- d) Iniciar omeprazol a permanencia
- e) Observar evolución

47) ¿Cuál de las siguientes alteraciones es frecuente de hallar en la artritis reumatoide?

- a) Nódulos de Heberden
- b) Rigidez matinal
- c) Esclerodactilia
- d) Insuficiencia renal
- e) Uveítis

48) Un paciente de 65 años presenta palidez y astenia. Se solicita un hemograma que muestra hematocrito: 28%, hemoglobina: 9,3 g/dl, VCM: 110 ft, HCM: 34 pg, plaquetas: 100.000 x mm³, blancos: 3.200 x mm³. En el frotis se aprecia hipersegmentación del núcleo de los neutrófilos. El diagnóstico más probable es:

- a) Anemia por enfermedades crónicas
- b) Déficit de vitamina B12
- c) Leucemia mieloide crónica
- d) Mielodisplasia
- e) Mielofibrosis

49) ¿Qué gases venosos son más compatibles con un cuadro de vómitos abundantes y reiterados?

- a) pH: 7,29 ; PaCO₂: 28 mmHg ; HCO₃: 13 mmol/l
- b) pH: 7,33 ; PaCO₂: 55 mmHg ; HCO₃: 28 mmol/l
- c) pH: 7,59 ; PaCO₂: 28 mmHg ; HCO₃: 26 mmol/l
- d) pH: 7,50 ; PaCO₂: 42 mmHg ; HCO₃: 32 mmol/l
- e) pH: 7,03 ; PaCO₂: 43 mmHg ; HCO₃: 11 mmol/l

50) Un paciente de 63 años, hipertenso, presenta hemiparesia derecha, de predominio braquial, de instalación brusca, asociada a imposibilidad de hablar y comprender el lenguaje. El diagnóstico más probable es:

- a) Infarto lacunar
- b) Accidente vascular isquémico de arteria cerebral media
- c) Accidente vascular isquémico de arteria cerebral anterior
- d) Accidente vascular isquémico de arteria cerebral posterior
- e) Hematoma talámico

51) ¿Qué examen es el más adecuado para confirmar la sospecha clínica de EPOC?

- a) Espirometría
- b) Test de provocación con metacolina
- c) PEF (Flujo espiratorio máximo)
- d) Radiografía de tórax
- e) Tomografía axial computada de tórax

52) La mejor imagen para evaluar un nódulo tiroideo, con TSH normal, es:

- a) Cintigrafía con yodo radiactivo
- b) Ecografía
- c) TAC
- d) Resonancia magnética nuclear
- e) Radiografía

53) Un paciente de 24 años consulta por angina de pecho, que aparece al caminar 3 cuadras, asociado a síncope relacionados con el ejercicio, en 2 oportunidades. En el último tiempo refiere además disnea paroxística nocturna. Al examen físico se constata pulso amplio, con ritmo cardíaco regular en 3 tiempos, con presencia de un cuarto ruido. El diagnóstico más probable es:

- a) Insuficiencia aórtica
- b) Coartación aórtica
- c) Enfermedad de Kawasaki secuela
- d) Síndrome de Brugada
- e) Miocardiopatía hipertrófica

54) Identifique la asociación INCORRECTA entre la vasculitis y los vasos que afecta:

- a) Arteritis de Takayasu – Aorta y sus ramas
- b) Panarteritis nodosa – Arterias mesentéricas
- c) Poliangeítis microscópica – Capilares y arteriolas renales y pulmonares
- d) Arteritis de células gigantes – Vasa nervorum, arteriolas y capilares del sistema nervioso central
- e) Arteritis de Churg-Strauss – Capilares pulmonares y capilares glomerulares

55) Identifique la asociación INCORRECTA entre la lesión hepática y el cuadro clínico:

- a) Quiste simple – Paciente asintomático con lesión hepática anecogénica, con refuerzo posterior
- b) Hemangioma – Paciente asintomático con lesión hepática hipoecogénica multiloculada
- c) Quiste hidatídico – Paciente asintomático con lesión hepática anecogénica, con pared hiperecogénica
- d) Metástasis – Paciente con baja de peso y múltiples lesiones hepáticas hipoecogénicas
- e) Hepatocarcinoma – Paciente cirrótico, con lesión hepática de 5 cm de diámetro, de ecogenicidad heterogénea y elevación de la alfa-fetoproteína

56) Un niño de 2 años presenta fiebre hasta 38,7°C, asociado a tos seca, de un día de evolución. Actualmente consulta por dificultad respiratoria, asociada a respiración ruidosa. Al examen físico se aprecia agitado, con estridor inspiratorio, sin otros ruidos pulmonares. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar nasofibroscofia
- b) Solicitar radiografía de tórax
- c) Realizar nebulización con salbutamol
- d) Realizar nebulización con adrenalina racémica y administrar corticoides orales
- e) Iniciar oxígeno en altas concentraciones y realizar ventilación a presión positiva

57) Un paciente de 70 años consulta por palidez, baja de peso y fiebre recurrente. Al examen físico se palpa una masa axilar izquierda de 6 cm de diámetro, con varias adenopatías más pequeñas alrededor. El diagnóstico más probable es:

- a) Leucemia
- b) Linfoma
- c) Mieloma
- d) Tuberculosis
- e) Enfermedad por arañazo de gato

58) El tratamiento de la mucormicosis suele ser:

- a) Antimicóticos endovenosos y debridación quirúrgica
- b) Antimicóticos endovenosos
- c) Antimicóticos orales
- d) Antimicóticos tópicos
- e) Sintomático

59) Un paciente de 78 años consulta por dolor en la ingle izquierda, de 1 mes de evolución, que aparece al caminar y que es especialmente doloroso en periodos de mucha actividad. Al examen físico presenta dolor con los movimientos extremos de la cadera derecha, sin signos inflamatorios. Se solicita una radiografía de cadera, que muestra disminución del espacio articular, con superficie articular irregular. El tratamiento más adecuado es:

- a) Paracetamol

- b) Tramadol
- c) Prednisona
- d) Diclofenaco
- e) Quierúrgico

60) Un paciente de 43 años consulta por malestar general, asociado a coriza y tos seca. Al examen físico destaca faringe eritematosa y pequeñas adenopatías cervicales anteriores. El agente etiológico más probable es:

- a) Neumococo
- b) Virus influenza
- c) Virus de Epstein Baar
- d) Rinovirus
- e) Estreptococo betahemolítico grupo A

61) El síndrome de arteria espinal anterior se caracteriza por compromiso de los haces espinotalámicos y corticoespinales bilaterales. Clínicamente se presenta como:

- a) Paraplejía y ausencia de sensibilidad termalgésica en ambas EEL
- b) Anestesia total de la sensibilidad de las EEL
- c) Paraplejía y ausencia de la sensibilidad táctil fina, vibratoria y propioceptiva de ambas EEL
- d) Déficit motor y ausencia de sensibilidad termalgésica en la extremidad inferior derecha y ausencia de la sensibilidad táctil fina, vibratoria y propioceptiva en la extremidad inferior izquierda
- e) Déficit motor y ausencia de sensibilidad táctil fina, vibratoria y propioceptiva en la extremidad inferior derecha y ausencia de la sensibilidad termalgésica en la extremidad inferior izquierda

62) Un niño de 8 años presenta un cuadro de decaimiento, poliaquiuria y náuseas de 4 días de evolución, que en las últimas horas se han acompañado de dolor abdominal y luego desorientación. Al examen físico está soporoso, desorientado, deshidratado y taquicárdico, con respiraciones profundas y saturación arterial de oxígeno de 98%. El diagnóstico más probable es:

- a) Sepsis renal
- b) Hipertiroidismo
- c) Hipercalcemia
- d) Cetoacidosis diabética
- e) Apendicitis aguda

63) Ingresa una paciente de 68 años, con un cuadro de tos, expectoración purulenta y fiebre alta, seguida de disnea y cianosis. El examen físico y la gasometría son compatibles con una neumonía ATS IV. Inicia tratamiento antibiótico, recibe corticoides y apoyo ventilatorio no invasivo con Bi-PAP. Evoluciona con oliguria y elevación de la creatinina, con sodio urinario de 5 mEq/l y sodio plasmático de 130 mEq/l. El sedimento de orina muestra presencia de cilindros hialinos escasos y 3-4 leucocitos por campo. La etiología de la insuficiencia renal es:

- a) Prerenal
- b) Necrosis tubular aguda
- c) Nefritis intersticial
- d) Pielonefritis aguda
- e) Nefropatía por corticoides

64) Un niño de 15 meses presenta un cuadro de diarrea acuosa abundante de 24 horas de evolución, asociado a vómitos alimentarios. Al examen físico está somnoliento, taquicárdico, hipotenso, con los ojos hundidos y las mucosas secas. Se solicitan exámenes que muestran Na: 130 mEq/l, K: 3,6 mEq/l, Cl: 97 mEq/l, pH: 7,30. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar sales de rehidratación oral después de cada deposición diarreica
- b) Administrar sales de rehidratación oral 50-100 ml/kg en 4-6 horas y reevaluar
- c) Administrar suero glucosado al 5% con 2 gramos de NaCl y 1 gramo de KCl por vía endovenosa
- d) Administrar suero fisiológico por vía venosa periférica
- e) Administrar suero Ringer lactato por un catéter venoso central

65) Un paciente presenta una taquicardia regular a 150 lpm, con complejo QRS de 0,10 segundos y con presencia de "ondas de serrucho" en las derivaciones DII y DIII. El diagnóstico más probable es:

- a) Fibrilación auricular
- b) Torsión de puntas
- c) Taquicardia ventricular

- d) Taquicardia paroxística supraventricular
- e) Flutter auricular

66) Una paciente presenta artritis de manos y fiebre ocasional. Se solicitan exámenes inmunológicos, entre los que destaca presencia de anticuerpos antinucleares y disminución del complemento. El diagnóstico más probable es:

- a) Granulomatosis de Wegener
- b) Artritis reumatoide
- c) Dermatomiositis
- d) Lupus
- e) Esclerodermia

67) Un paciente de 49 años, consulta por dolor y eritema en la pierna izquierda. Al examen físico se aprecia una placa eritematosa, de 7 cm de diámetro, con aumento de la temperatura local, de bordes difíciles de definir. El tratamiento más adecuado es:

- a) Cirprofloxacino
- b) Vancomicina
- c) Cloxacilina
- d) Eritromicina
- e) Penicilina

68) Un paciente de 5 años sufre una caída a nivel, golpeándose la cabeza y permaneciendo inconsciente por cerca de 30 segundos. Al examen físico está en buenas condiciones generales, con Glasgow 15 y sin signología focal en el examen neurológico. Presenta una pequeña erosión en el cuero cabelludo frontal, sin otras alteraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio, indicando reconsulta en caso de aparición de signos de alarma
- b) Solicitar TAC de cerebro con contraste
- c) Solicitar RMN de cerebro
- d) Iniciar analgésicos endovenosos y hospitalizar para observación
- e) Iniciar anticonvulsivantes profilácticos y hospitalizar para observación de evolución

69) Un paciente de 23 años consulta por dolor torácico derecho, de rápida instalación, con tope inspiratorio, sin otros síntomas. Al examen físico se constata disminución del murmullo pulmonar derecho, con hipersonoridad a la percusión. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar toracocentesis
- b) Solicitar radiografía de tórax
- c) Puncionar el segundo espacio intercostal
- d) Solicitar dímero D
- e) Solicitar angio-TAC de tórax

70) El gold standard para el diagnóstico de reflujo gastroesofágico es:

- a) La manometría esofágica
- b) La endoscopia digestiva alta
- c) La pH-metría esofágica de 24 horas
- d) Las radiografías baritadas
- e) La videodeglución

Prueba 6

1) Un paciente VIH, sin tratamiento antirretroviral presenta cefalea, malestar general y signos meníngeos esbozados. Se solicita punción lumbar que da salida a líquido cefalorraquídeo, con 200 células por mm³, 90% de mononucleares, glucosa 30 mg/dl y proteínas elevadas. El agente más probable es:

- a) Neumococo

- b) Virus JC
- c) Virus herpes
- d) Criptococo
- e) Listeria

2) Un paciente de 51 años consulta por dolor articular en las manos, de un par de meses de evolución, que se acompaña de rigidez matinal de cerca de 2 horas de evolución. Al examen físico se observa aumento de volumen y eritema de algunas articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales y distales de ambas manos. El diagnóstico más probable es:

- a) Artrosis
- b) Artritis reumatoide
- c) Lupus
- d) Esclerodermia
- e) Artritis psoriática

3) Un paciente de 54 años, hipertenso en tratamiento con enalapril, presenta dolor torácico intenso, opresivo, irradiado al brazo izquierdo y al cuello, que inició hace una hora. Al examen físico presenta FC: 95 x', PA: 140/92 mmHg, FR: 15 x', SatO2: 96%, RR2T sin soplos, MP(+) SRA. Se solicita un electrocardiograma que muestra alteraciones inespecíficas de la repolarización y una radiografía de tórax que resulta normal. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar AINEs y observar evolución
- b) Iniciar aspirina, oxígeno y nitroglicerina y solicitar troponinas plasmáticas
- c) Solicitar angio-TAC de tórax
- d) Realizar coronariografía de urgencia
- e) Realizar trombolisis endovenosa

4) Un paciente de 50 años, fumador, consulta por tos seca y disnea de esfuerzo, progresiva, de 2 meses de evolución, que actualmente le permite caminar una cuadra. Al examen físico se aprecian campos pulmonares de pequeño tamaño, con crepitaciones intensas bilaterales, mayor en las bases. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
- b) Fibrosis pulmonar
- c) Insuficiencia cardíaca
- d) Tuberculosis pulmonar
- e) Bronquiectasias

5) ¿Cuál de las siguientes asociaciones entre el nervio craneal y su función es INCORRECTA?

- a) Oculomotor – Inervación de los músculos recto superior, recto inferior y recto medial
- b) Troclear – Inervación del músculo oblicuo superior
- c) Hipogloso – Inervación de los músculos de la lengua
- d) Facial – Inervación de los músculos masticatorios
- e) Espinal accesorio – Inervación de los músculos trapecio y esternocleidomastoideo

6) Los cilindros eritrocitarios son característicos de:

- a) Síndrome nefrótico
- b) Glomerulonefritis
- c) Síndrome hemolítico urémico
- d) Necrosis tubular aguda
- e) Nefritis intersticial

7) ¿Qué hallazgo es más probable de ser encontrado en un paciente con anemia hemolítica autoinmune?

- a) Hiperbilirrubinemia de predominio directo
- b) Cuerpos de Howel Jolly
- c) Índice reticulocitario elevado
- d) Aumento de la haptoglobina plasmática
- e) Microcitosis

8) Un lactante de 4 meses, con mal incremento ponderal, ha presentado varias infecciones respiratorias bajas y la madre refiere que se cansa al mamar. Al examen físico se auscultan crepitaciones pulmonares bibasales y un soplo cardíaco holosistólico intenso. La saturación arterial de oxígeno es 83%, mejorando a 95% al aportar oxígeno. El diagnóstico más probable es:

- a) Comunicación interauricular
- b) Comunicación interventricular
- c) Ductus arterioso persistente
- d) Tetralogía de Fallot
- e) Coartación aórtica

9) Un paciente diabético de 56 años de edad consulta por aumento de volumen facial y edema de extremidades inferiores. Además refiere orinas espumosas. Al examen físico se constata edema generalizado, con presión arterial normal. Se solicita creatinina que resulta 1,1 mg/dl, proteinuria de 24 horas de 5,8 g, albuminemia de 2,4 g/dl y sedimento de orina con cilindros granulosos y 2-5 eritrocitos por campo. El diagnóstico más probable es:

- a) Nefropatía diabética
- b) Nefropatía membranosa
- c) Glomerulopatía por cambios mínimos
- d) Glomeruloesclerosis focal y segmentaria
- e) Glomerulonefritis mesangiocapilar

10) Un paciente de 30 años consulta por fiebre hasta 40°C, asociado a calofríos, malestar general marcado, mialgias generalizadas y tos seca. El examen físico muestra fiebre y faringe eritematosa, sin otras alteraciones. El diagnóstico más probable es:

- a) Neumococo
- b) Streptococcus pyogenes
- c) Influenza
- d) Triquinella spiralis
- e) Rinovirus

11) El método diagnóstico y el tratamiento de la fiebre tifoidea son actualmente:

- a) Serología IgM y ciprofloxacino
- b) Hemocultivo y cefadroxilo
- c) Serología IgM y cloramfenicol
- d) Coprocultivo y cloramfenicol
- e) Hemocultivo y ciprofloxacino

12) Un paciente de 70 años presenta dolores óseos e hipercalcemia, asociados a aumento de las proteínas plasmáticas totales, con hipoalbuminemia. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Metástasis óseas
- b) Hiperparatiroidismo primario
- c) Linfoma
- d) Leucemia
- e) Mieloma múltiple

13) Una paciente de 30 años consulta por ansiedad, temblor de extremidades superiores, diarrea y palpitations. Al examen físico se aprecia exoftalmos bilaterales, mayor a la izquierda, con retracción palpebral y bocio difuso de tamaño moderado, con soplo tiroideo. El tratamiento más adecuado de la patología descrita es:

- a) Betabloqueo más propiltiouracilo
- b) Betabloqueo más AINES
- c) Yodo radiactivo
- d) Alfabloqueo, betabloqueo y cirugía
- e) Levotiroxina

14) Un paciente presenta cefalea recurrente fronto-parietal, intensa, que se presenta más frecuentemente en los períodos de sobrecarga laboral y al dormir poco, que se agrava con los sonidos y con la luz y que cede al dormir. El examen neurológico es normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Neuralgia del trigémino
- b) Cefalea cluster
- c) Cefalea tensional
- d) Jaqueca

e) Tumor cerebral

15) Un hombre de 64 años sufre caída por la escalera, golpeándose la cabeza. Inicialmente está bien, pero con cefalea persistente, la que aumenta de intensidad varias horas después, agregándose confusión al día siguiente. El diagnóstico más probable es:

- a) TEC abierto
- b) Hemorragia subaracnoidea
- c) Hematoma epidural
- d) Hematoma subdural
- e) Fractura de la base de cráneo

16) Un paciente de 32 años sufre un traumatismo encefalocraneano grave, el que es manejado quirúrgicamente, con buena respuesta. Al tercer día de evolución está en buenas condiciones generales, en Glasgow 15 y se constata natremia de 132 mEq/l, sin otras alteraciones en sus exámenes. La conducta más adecuada para el manejo de la alteración electrolítica es:

- a) Restringir la ingesta de agua libre
- b) Aumentar la ingesta de sodio
- c) Iniciar un diurético tiazídico
- d) Iniciar suero hipertónico
- e) Administrar desmopresina

17) Una paciente de 29 años presenta astenia, fiebre ocasional, mialgias y artralgias de algunas semanas de evolución, asociado a hematuria e hipertensión arterial. Al examen físico se observan úlceras orales. Se solicita hemograma que muestra leucopenia y trombocitopenia, creatinina que resulta 1,8 mg/dl y sedimento de orina que muestra hematuria. La conducta más adecuada para proseguir el estudio es:

- a) Solicitar biopsia de médula ósea
- b) Solicitar anticuerpos antinucleares, factor reumatoideo y radiografía de columna lumbosacra
- c) Solicitar anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo y biopsia renal
- d) Solicitar anticuerpos antinucleares, antiDNA de doble hebra y complemento
- e) Solicitar niveles plasmáticos de creatinquinasa y anticuerpos anti-Jo1

18) Un paciente de 30 años presenta regurgitación y pirosis con frecuencia, especialmente cuando mucho o cuando consume alcohol. Su examen físico es normal. La consulta más adecuada es:

- a) Iniciar omeprazol e indicar medidas generales antirreflujo
- b) Realizar tratamiento erradicador de H. pylori
- c) Solicitar endoscopia digestiva alta
- d) Solicitar pH-metría de 24 horas
- e) Solicitar radiografías baritadas

19) Un paciente de 30 años, sin antecedentes de importancia, presenta un cuadro meníngeo agudo, por lo que se realiza una punción lumbar, que da salida a un líquido turbio, con 1.600 células por mm³, con 95% de polimorfonucleares, glucosa: 25 mg/dl, proteínas 170 mg/dl y visualización de cocáceas Gram positivas en aisladas y en diplos. El agente etiológico más probable es:

- a) Staphylococcus aureus
- b) Listeria monocytogenes
- c) Neisseria meningitidis
- d) Streptococcus pneumoniae
- e) Haemophilus influenzae

20) Un paciente de 70 años, asintomático, presenta un aneurisma aórtico abdominal, infrarrenal, que en la ecografía demuestra ser de 5,4 cm de diámetro. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar aspirina y estatinas
- b) Iniciar anticoagulación con heparina
- c) Observar evolución controlando con ecografías cada 6 meses
- d) Iniciar ácido tranexánico
- e) Resolver quirúrgicamente

21) Un niño de 5 años presenta fiebre recurrente y astenia. Al examen físico se aprecia pálido, con algunas petequias en el tórax. Se solicita hemograma que muestra hematocrito: 28%, hemoglobina: 9,2g/dl, plaquetas: 47.000 x mm³, glóbulos blancos: 2.800 x mm³, con 90% de linfocitos. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución y controlar nuevo hemograma en 7 días
- b) Solicitar biopsia de médula ósea
- c) Iniciar corticoides orales
- d) Solicitar perfil de hierro
- e) Iniciar suplemento de hierro oral

22) Un paciente presenta un derrame pleural, que es puncionado dando salida a un líquido citrino, con 30 células por mm³, 90% mononuclear, 10% polimorfonuclear, proteínas: 2,5 g/dl, LDH: 60UI/l, pH: 7,4, lactato: 2 mg/dl. La LDH plasmática es 180 UI/l, proteínas plasmáticas: 6,5 g/dl. El diagnóstico más probable es:

- a) Tuberculosis
- b) Empiema
- c) Cáncer
- d) Derrame pleural paraneumónico
- e) Insuficiencia cardíaca

23) Un paciente de 68 años sufre un infarto al miocardio, evolucionando con hipotensión y oliguria. Se constata elevación de la creatinina hasta 3,1 mg/dl. Los electrolitos plasmáticos son Na⁺: 135mEq/l, K⁺: 4,2mEq/l y los electrolitos urinarios son Na⁺: 6mEq/l, K⁺: 15mEq/l. La causa más probable de la elevación de la creatinina es:

- a) Infarto renal
- b) Necrosis tubular aguda
- c) Nefritis intersticial
- d) Insuficiencia renal aguda prerrenal
- e) Estenosis de las arterias renales

24) Un hombre de 71 años consulta por astenia, fiebre y debilidad muscular de predominio proximal, especialmente en los hombros y brazos, asociados a cefalea recurrente. El examen físico no aporta mayor información y el hemograma demuestra anemia normocítica, con VHS: 102 mm/h. El diagnóstico más probable es:

- a) Polineuropatía
- b) Polimiositis
- c) Mieloma múltiple
- d) Arteritis de células gigantes
- e) Panarteritis nodosa

25) Un paciente de 65 años refiere vómitos postprandiales frecuentes, que empezaron hace 3 meses, pero que se han vuelto muy frecuentes, de modo que ha bajado 6 kilogramos de peso. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar antieméticos
- b) Solicitar ecografía de abdomen
- c) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
- d) Solicitar endoscopia digestiva alta
- e) Solicitar colonoscopia

26) Una paciente con síndrome de ovario poliquístico probablemente presentará:

- a) Progesterona alta
- b) Estrógenos bajos
- c) Hormona luteinizante alta
- d) Testosterona baja
- e) Galactorrea

27) Un paciente de 56 años es tratado por una neumonía comunitaria, con levofloxacin, evolucionando con diarrea 10 días después de haber finalizado el tratamiento. Además presenta dolor abdominal y fiebre ocasional, por lo que se solicitan toxinas de Clostridium difficile, que resultan positivas. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar doxiciclina
- b) Iniciar claritromicina + amoxicilina
- c) Iniciar amoxicilina + ácido clavulánico
- d) Iniciar metronidazol
- e) Iniciar ciprofloxacino + lindamicina

28) Un paciente de 70 años consulta por fiebre y tos con expectoración abundante, sin disnea. Sus signos vitales son normales y su examen pulmonar muestra crépitos localizados en la base pulmonar izquierda. Se solicita una radiografía de tórax que muestra una zona de relleno alveolar en el lóbulo inferior izquierdo y un hemograma que muestra leucocitosis de 14.000 x mm³. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar tratamiento sintomático
- b) Iniciar amoxicilina oral
- c) Iniciar amoxicilina + ácido clavulánico oral
- d) Iniciar ceftriaxona
- e) Iniciar claritromicina

29) Ingresa a la sala de urgencias una paciente de 65 años, hipertensa, por un cuadro de palpitaciones sintensas y disnea, que empezó hace media hora. Al examen físico presenta FC: 150 lpm, irregular, con PA: 80/36 mmHg, satO₂: 86% y desorientación. La auscultación cardíaca muestra R2T sin soplos y la auscultación pulmonar muestra crepitaciones pulmonares bilaterales, difusas. Se instala el monitor electrocardiográfico que muestra una taquicardia irregular, con complejos QRS angostos y ausencia de onda P. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar amiodarona endovenosa
- b) Administrar adenosina endovenosa
- c) Realizar intubación orotraqueal y ventilación a presión positiva
- d) Realizar cardioversión eléctrica
- e) Iniciar masaje cardíaco

30) Un paciente presenta debilidad de las extremidades inferiores, de predominio distal, asociada a atrofia muscular, hiporreflexia y fasciculaciones. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome piramidal
- b) Miastenia gravis
- c) Síndrome extrapiramidal
- d) Polineuropatía (denervación)
- e) Síndrome cerebeloso

31) Un paciente de 35 años consulta por dolor epigástrico urente, que suele aparecer en ayuno y que cede con la ingesta de alimentos. Al examen físico no se aprecian alteraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar omeprazol
- b) Solicitar ecografía abdominal
- c) Solicitar endoscopia digestiva alta
- d) Solicitar pH-metría de 24 horas
- e) Tranquilizar al paciente y explicarle que no hay necesidad de mayor estudio ni tratamiento

32) Un paciente presenta tos nocturna y en relación al ejercicio, que en ocasiones se asocia a respiración sibilante. El examen físico es normal, al igual que la radiografía de tórax. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar test de metacolina
- b) Solicitar prick test
- c) Observar evolución
- d) Solicitar TAC de tórax

e) Solicitar prueba de difusión de monóxido de carbono

33) Usted recibe a un paciente de 67 años por compromiso de conciencia. Al examen físico se aprecia edematoso, en sopor profundo, con frecuencia cardíaca de 42 x', temperatura: 35,0°C, FR: 12x', sin signos neurológicos focales. Se realiza un hemograma que muestra hematocrito: 27%, VCM: 108 fl, VHS: 20 mm/h, blancos: 5.000 x mm³, plaquetas: 160.000 x mm³, y exámenes generales que constatan glicemia: 60 mg/dl, BUN: 12 mg/dl, creatinina: 0,7 mg/dl, sodio: 131 mEq/l, potasio: 4,6 mEq/l. El diagnóstico más probable es:

- a) Insuficiencia suprarrenal aguda
- b) Bloqueo auriculoventricular de tercer grado
- c) Déficit de vitamina B12
- d) Meningitis tuberculosa
- e) Hipotiroidismo

34) La policitemia vera es un síndrome mieloproliferativo que se caracteriza por todo lo siguiente, EXCEPTO:

- a) Elevación de la eritropoyetina
- b) Riesgo de trombosis
- c) Trombocitosis
- d) Riesgo de evolución a leucemia
- e) Esplenomegalia

35) Un paciente de 45 años, obeso y diabético tipo 2, en tratamiento con dieta, ejercicios y metformina en una dosis de 850 mg cada 12 horas, presenta glicemias elevadas en la mayoría de sus controles y hemoglobina glicosilada de 8,5%. Su creatinina, electrocardiograma, fondo de ojo, hemograma y perfil hepático son normales y su perfil de lípidos muestra LDL: 90 mg/dl, HDL: 40 mg/dl, TG: 150 mg/dl. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar insulina
- b) Agregar glibenclamida
- c) Mantener el tratamiento
- d) Solicitar test de tolerancia a la glucosa
- e) Iniciar una estatina

36) Un hombre de 25 años consulta por lumbago crónico, de predominio nocturno, que cede con el reposo, asociado a rigidez lumbar. Se solicita radiografía de articulaciones sacroilíacas, que muestra signos de sacroileítis y calcificación de los ligamentos vertebrales longitudinales. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar metotrexato
- b) Iniciar ciclosporina
- c) Iniciar corticoides orales e indicar ejercicios
- d) Iniciar AINES e indicar ejercicios
- e) Resolver quirúrgicamente

37) ¿Qué alteración es más sugerente de una isquemia crónica crítica de extremidades inferiores?

- a) Dolor de reposo
- b) Ausencia de pulso pedio
- c) Edema de extremidad inferior
- d) Ecografía doppler con estenosis femoral del 70%
- e) Cambios tróficos de la piel y fanéreos

38) ¿Qué afirmación es FALSA?

- a) Se exigen presiones arteriales menores a 130/80 mmHg a los pacientes hipertensos que tienen diabetes y/o insuficiencia renal crónica
- b) La diabetes es la primera causa de insuficiencia renal crónica
- c) Los IECAS son el tratamiento antihipertensivo de elección en los pacientes diabéticos
- d) La hipertensión renovascular y el hiperaldosteronismo primario suelen asociarse a hipokalemia
- e) Los diuréticos de asa están contraindicados en los pacientes con hiperkalemia

39) El tratamiento antibiótico de elección para una erisipela es:

- a) Vancomicina
- b) Ceftriaxona
- c) Ciprofloxacino
- d) Penicilina
- e) Gentamicina

40) Un paciente de 65 años, con disnea crónica, se realiza una espirometría que muestra lo siguiente:

Valores basales:	VEF1 (%teórico): 54%	CVF (%teórico): 89%	VEF1/CVF: 62%
Post-broncodilatador:	VEF1 (%teórico): 58%	CVF (%teórico): 91%	VEF1/CVF: 65%

El diagnóstico más probable es:

- a) Asma
- b) Fibrosis pulmonar
- c) EPOC
- d) Hipertensión pulmonar
- e) TEP crónico

41) Ante la sospecha de una diverticulitis aguda se debe:

- a) Realizar laparotomía exploradora
- b) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
- c) Solicitar colonoscopia
- d) Solicitar ecografía abdominal
- e) Solicitar enema baritado

42) El tratamiento anticoagulante oral, con cumarínicos, debe ser controlado periódicamente con:

- a) Tiempo de sangría
- b) Tiempo de tromboplastina parcial activado
- c) Tiempo de protrombina
- d) Fibrinogenemia
- e) Hemograma con recuento de plaquetas

43) Es una contraindicación absoluta del uso de anticonceptivos orales:

- a) Obesidad
- b) Promiscuidad sexual
- c) Metrorragia de origen no precisado
- d) Antecedentes familiares de cáncer de ovario
- e) Diabetes tipo 1

44) El síndrome alterno se caracteriza por compromiso somático de un hemicuerpo, asociado a compromiso de pares craneales contralaterales. ¿Qué tipo de lesiones suelen provocar este tipo de síndrome?

- a) Lesiones corticales fronto-parietales
- b) Lesiones de la cápsula interna
- c) Lesiones del tálamo
- d) Lesiones de los núcleos caudado y putamen
- e) Lesiones de troncoencéfalo

45) Un paciente de 70 años presenta una artritis aguda de rodilla, la que se punciona, dando salida a un líquido inflamatorio, con 10.000 células por mm³, con abundantes cristales, compatibles con pirofosfato de calcio, sin visualización de bacterias. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar reposo e iniciar AINES
- b) Indicar reposo, iniciar analgésicos y alopurinol
- c) Indicar reposo, iniciar analgésicos y bifosfonatos
- d) Indicar reposo, iniciar analgésicos, bifosfonatos y alopurinol

e) Indicar reposo, iniciar analgésicos, antibióticos y bifosfonatos

46) Un paciente de 69 años presenta disnea de esfuerzos, que aparece al caminar 2 cuadras. Al examen físico se aprecia un soplo cardíaco diastólico e importante desplazamiento del choque de la punta. El diagnóstico más probable es:

- a) Estenosis aórtica
- b) Insuficiencia aórtica
- c) Insuficiencia mitral
- d) Miocardiopatía hipertrófica
- e) Miocardiopatía dilatada

47) El tratamiento del asma persistente leve es:

- a) Salbutamol según síntomas
- b) Salmeterol según síntomas
- c) Corticoides inhalados según horario y salbutamol según síntomas
- d) Corticoides inhalados según horario y salmeterol según síntomas
- e) Corticoides inhalados según horario, asociados a salmeterol y salbutamol según síntomas

48) Un paciente se realiza un hemograma que muestra hematocrito: 45%, hemoglobina: 15 g/dl, VCM: 90 pg, HCM: 31 fl, plaquetas: 520.000 x mm³, blancos: 48.000 x mm³, linfocitos: 14%, monocitos: 7%, segmentados: 57%, baciliformes: 16%, promielocitos: 5%, blastos: 1%. El diagnóstico más probable es:

- a) Leucemia mieloide aguda
- b) Leucemia linfática crónica
- c) Leucemia mieloide crónica
- d) Infección bacteriana
- e) Infección viral

49) Un paciente presenta hiperkalemia de 6,5 mEq/l. ¿Cuál de los siguientes fármacos es más adecuado para el manejo de este paciente?

- a) Espironolactona
- b) Sulfato de magnesio
- c) Hidroclorotiazida
- d) Betabloqueantes
- e) Insulina

50) Un lactante de 7 meses de edad presenta fiebre hasta 40°C, asociado a irritabilidad, que dura cerca de 48 horas y luego cede, dando paso a la aparición de un exantema papular, raro, con compromiso de la cara, tronco y extremidades. El agente etiológico más probable es:

- a) Virus herpes 6
- b) Virus varicela zóster
- c) Virus Coxsackie
- d) Parvovirus B19
- e) Virus de Epstein Baar

51) Un paciente diabético tipo 1, en tratamiento con insulina en esquema intensificado con 2 dosis de NPH y 3 refuerzos con insulina cristalina presenta los siguientes hemoglucotest promedio:

Pre-desayuno: 80 mg/dl	Pre-almuerzo: 95 mg/dl	Pre-cena: 92 mg/dl
Post-desayuno: 110 mg/dl	Post-almuerzo: 220 mg/dl	Post-cena: 130 mg/dl

Su hemoglobina glicosilada es 8,1%. La conducta más adecuada es:

- a) Aumentar la insulina cristalina del desayuno
- b) Aumentar la insulina NPH matinal
- c) Aumentar la insulina cristalina del almuerzo
- d) Aumentar la insulina NPH nocturna
- e) Aumentar la insulina cristalina de la cena

52) Una paciente de 30 años consulta por diarrea acuosa de 5 meses de evolución, intermitente, con mucosidad, sin sangre ni lentería, que en algunas oportunidades se asocia a distensión abdominal y dolor tipo cólico, que cede con la evacuación. El examen físico es normal. La etiología más probable es:

- a) Autoinmune
- b) Viral
- c) Bacteriana

- d) Parasitaria
- e) Funcional

53) Un paciente de 65 años consulta por fiebre, artralgias, hematuria, edema de extremidades inferiores y luego anuria. En sus exámenes de laboratorio destaca elevación importante de la creatinina y positividad de los ANCA en patrón perinuclear, a títulos elevados. El diagnóstico más probable es:

- a) Lupus eritematoso sistémico
- b) Granulomatosis de Wegener
- c) Arteritis de la temporal
- d) Panarteritis nodosa
- e) Poliangeítis microscópica

54) Un paciente presenta dolor torácico muy intenso, de inicio súbito, seguido de compromiso del consciencia, de 15 minutos de duración. Al examen físico se constata ausencia de respiración y de pulso. Se inicia masaje cardíaco y se instala un monitor electrocardiográfico que muestra asistolia. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar adrenalina intravenosa y continuar el masaje cardíaco
- b) Administrar amiodarona intravenosa y continuar el masaje cardíaco
- c) Realizar cardioversión eléctrica
- d) Realizar intubación orotraqueal, iniciar ventilación a presión positiva con oxígeno al 100% y continuar el masaje cardíaco
- e) Suspender las maniobras de reanimación

55) Un paciente de 65 años consulta por dolor torácico de inicio súbito, que aumenta con la inspiración y que se asocia a disnea tos con escasa expectoración hemoptoica. El diagnóstico más probable es:

- a) Neumotórax
- b) Estenosis mitral
- c) Infarto agudo al miocardio
- d) Disección aórtica
- e) Tromboembolismo pulmonar

56) Una mujer de 48 años consulta por astenia de 2 meses de evolución. El examen físico es normal, por lo que se realiza un hemograma que resulta normal y un perfil bioquímico, donde destaca elevación de las fosfatasas alcalinas y de la bilirrubina. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Lupus
- b) Cirrosis biliar primaria
- c) Hemólisis
- d) Hiperparatiroidismo primario
- e) Linfoma

57) Un paciente de 62 años, hipertenso, mal controlado, consulta por cefalea de rápida instalación, asociada a imposibilidad de mover la mitad derecha del cuerpo, que lleva 1 hora de evolución. Al examen físico se constata una hemiplejía derecha, con hipotonía y arreflexia ipsilaterales. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar anticoagulación con heparina
- b) Solicitar TAC de cerebro
- c) Realizar trombolisis intravenosa con sTPA
- d) Solicitar angiografía carotídea
- e) Solicitar ecocardiografía, ecografía doppler de arterias carótidas y Holter de arritmias

58) ¿Qué alteración es MENOS probable de ser hallada en una enfermedad de Addison?

- a) Hemianopsia bitemporal
- b) Hiponatremia
- c) Hiperpigmentación
- d) Hiperkalemia
- e) Hipoglicemia

59) Un niño de 6 años, presenta epistaxis y aparición de petequias y equimosis, desde hace 5 días. El

examen físico no aporta mayor información y el hemograma muestra trombocitopenia aislada de 45.000 x mm³, sin otras alteraciones. La conducta más adecuada para el manejo del paciente, además de indicar reposo, es:

- a) Observar evolución
- b) Iniciar corticoides orales
- c) Realizar esplenectomía
- d) Realizar transfusión de plaquetas
- e) Iniciar aspirina

60) Un paciente de 56 años, cirrótico por consumo crónico de alcohol, consulta por aumento del perímetro abdominal, asociado a desorientación. Al examen físico se aprecia asterixis, ictericia, ascitis moderada y dolor a la palpación abdominal. El hemograma resulta normal y las pruebas hepáticas muestran GOT: 60 UI/l, GPT: 54 UI/l, GGT: 60 UI/l, bilirrubina: 3,2 mg/dl, albúmina: 3,0 g/dl, TP: 80%. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar paracentesis evacuadora con reposición de albúmina
- b) Realizar paracentesis diagnóstica
- c) Iniciar lactulosa oral y administrar albúmina endovenosa
- d) Solicitar lipasa plasmática, TAC de abdomen y TAC de cerebro
- e) Resolver quirúrgicamente de inmediato

61) Un paciente presenta dolor torácico de 2 días de evolución, con tope inspiratorio, que luego se asoció a marcado malestar general y síncope. Al examen físico se aprecia hipotenso, con yugulares ingurgitadas y colapso "y" prominente en el pulso venoso. El examen pulmonar es normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome coronario agudo
- b) Tromboembolismo pulmonar
- c) Disección aórtica
- d) Taponamiento cardíaco
- e) Neumotórax

62) ¿Qué cuadro clínico es más compatible con una glomerulonefritis posestreptocócica?

- a) Hipertensión, edema, hematuria e hipocomplementemia
- b) Hipertensión, edema, orinas espumosas y oliguria
- c) Hipertensión, edema, oliguria y elevación del complemento
- d) Edema, hematuria, elevación de la creatinina y complemento normal
- e) Edema, oliguria, hemólisis y trombocitopenia

63) La asociación de dolor abdominal, diarrea disintérica, masa abdominal y abscesos perianales recurrentes, es característica de:

- a) Amebiasis
- b) Giardiasis
- c) Déficit de inmunoglobulina A
- d) Enfermedad de Crohn
- e) Cáncer de colon

64) Un paciente de 67 años presenta temblor de las manos, de 2 años de evolución, que apareció primero en la mano derecha. Al examen físico se constata que el temblor aparece durante el reposo y que cede al realizar movimientos. Además se aprecia disminución del braceo y del pestañeo. El resto del examen neurológico no demuestra alteraciones. El tratamiento de la patología descrita es:

- a) Agonistas dopaminérgicos
- b) Antagonistas adrenérgicos beta
- c) Antagonistas adrenérgicos alfa
- d) Inhibidores de la acetilcolinesterasa
- e) Anticonvulsivantes

65) Un paciente con hipotiroidismo debido a una tiroiditis crónica autoinmune, inicia tratamiento con buena respuesta del punto de vista clínico. ¿Qué examen es el más adecuado para controlar el tratamiento?

- a) Niveles plasmáticos de tiroxina
- b) Niveles plasmáticos de tirotrópina
- c) Niveles plasmáticos de tiroglobulina
- d) Niveles plasmáticos de anticuerpos anti-TPO
- e) Frecuencia cardíaca

66) Un paciente de 24 años presenta odinofagia, fiebre y malestar general. Al examen físico se aprecia faringe eritematosa y se palpan adenopatías cervicales bilaterales. Se solicitan serologías que muestran: Toxoplasma IgG(-) IgM(+), Citomegalovirus IgG(+), IgM(-); IgM-VCA(-), IgG-VCA(+); Elisa VIH(-). El diagnóstico más probable es:

- a) Mononucleosis infecciosa
- b) Síndrome mononucleósico por citomegalovirus
- c) Primoinfección herpética
- d) Primoinfección por toxoplasma
- e) Síndrome retroviral agudo

67) Un paciente de 15 años consulta por palpitaciones intensas de inicio y cese abrupto, que le han durado hasta 30 minutos. Al examen físico no se encuentran alteraciones y el electrocardiograma de reposo muestra FC: 72 lpm, regular, con acortamiento del segmento PR, ensanchamiento del complejo QRS y presencia de onda delta. El diagnóstico más probable es:

- a) Flutter auricular
- b) Taquicardia ventricular monomorfa
- c) Síndrome del QT largo
- d) Miocardiopatía hipertrófica
- e) Taquicardia paroxística supraventricular

68) La asociación de abolición del murmullo pulmonar, respiración soplante y matidez a la percusión es sugerente de:

- a) Derrame pleural
- b) Neumonía
- c) EPOC
- d) Neumotórax
- e) Cuerpo extraño bronquial

69) Una paciente de 23 años presenta eritema en las manos, comprometiendo la piel sobre las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales. Además presenta eritema de la piel de los hombros y zona superior del tronco. El diagnóstico más probable es:

- a) Lupus cutáneo subagudo
- b) Lupus eritematosos sistémico
- c) Esclerodermia difusa
- d) Esclerodermia limitada
- e) Dermatomiositis

70) Son parte del tratamiento de las complicaciones de la insuficiencia renal crónica EXCEPTO:

- a) Hiperparatiroidismo secundario – bifosfonatos
- b) Anemia con hematocrito menor a 30% – eritropoyetina subcutánea
- c) Acidosis – bicarbonato de sodio
- d) Hiperkalemia – dieta baja en potasio
- e) Síndrome urémico – diálisis

MIX DE MEDICINA INTERNA RESPUESTAS

Prueba 1	5 C	10 C	15 C	20 D	25 E
1 C	6 B	11 D	16 D	21 D	26 C
2 A	7 A	12 B	17 A	22 D	27 C
3 A	8 B	13 E	18 A	23 B	28 C
4 C	9 A	14 D	19 C	24 B	29 B

30 B	6 B	54 D	30 D	6 C	51 A
31 A	7 D	55 B	31 C	7 D	52 C
32 A	8 B	56 D	32 E	8 C	53 A
33 C	9 D	57 D	33 C	9 C	54 D
34 C	10 B	58 C	34 A	10 A	55 C
35 A	11 A	59 E	35 C	11 E	56 B
36 E	12 A	60 E	36 C	12 B	57 A
37 E	13 E	61 E	37 D	13 B	58 C
38 E	14 B	62 C	38 B	14 D	59 D
39 C	15 E	63 B	39 C	15 A	60 D
40 D	16 A	64 D	40 B	16 E	61 C
41 C	17 D	65 C	41 D	17 A	62 D
42 B	18 B	66 B	42 C	18 D	63 A
43 A	19 D	67 C	43 E	19 B	64 E
44 B	20 D	68 B	44 A	20 A	65 E
45 C	21 D	69 E	45 D	21 C	66 D
46 E	22 D	70 A	46 E	22 E	67 A
47 C	23 C	Prueba 3	47 D	23 E	68 B
48 D	24 C		48 D	24 A	69 E
49 C	25 D		49 A	25 D	70 A
50 B	26 C		50 A	26 B	Prueba 5
51 D	27 D		51 A	27 A	
52 B	28 C		52 B	28 C	
53 D	29 B		53 C	29 A	
54 A	30 B		54 A	30 C	
55 C	31 C		55 B	31 E	
56 B	32 A		56 D	32 C	
57 E	33 A		57 C	33 A	
58 B	34 B	10 D	58 D	34 C	
59 E	35 E	11 D	59 A	35 A	1 D
60 D	36 B	12 E	60 B	36 E	2 E
61 E	37 E	13 B	61 A	37 B	3 D
62 B	38 D	14 C	62 E	38 C	4 C
63 D	39 C	15 C	63 E	39 B	5 B
64 A	40 D	16 B	64 D	40 C	6 C
65 B	41 D	17 B	65 E	41 E	7 C
66 E	42 B	18 B	66 E	42 D	8 D
67 C	43 E	19 B	67 C	43 A	9 D
68 C	44 B	20 A	68 B	44 A	10 A
69 C	45 B	21 E	69 A	45 B	11 A
70 B	46 E	22 A	70 B	46 B	12 B
Prueba 2	47 A	23 A	Prueba 4	47 A	13 E
	48 D	24 C		48 C	14 C
	49 C	25 C		49 D	15 E
	50 C	26 B		50 B	16 A
	51 A	27 D			17 E
	52 D	28 A			18 C
	53 E	29 C			19 A
					20 D
					21 B
					22 C
					23 E
					24 E
					25 E

26 C	2 B	50 A
27 D	3 B	51 C
28 D	4 B	52 E
29 D	5 D	53 E
30 C	6 B	54 A
31 E	7 C	55 E
32 E	8 B	56 B
33 E	9 B	57 B
34 D	10 C	58 A
35 B	11 E	59 A
36 D	12 E	60 B
37 A	13 A(C)	61 D
38 B	14 D	62 A
39 C	15 D	63 D
40 C	16 A	64 A
41 B	17 D	65 B
42 E	18 A	66 D
43 D	19 D	67 E
44 B	20 E	68 B
45 E	21 B	69 E
46 A	22 E	70 A
47 B	23 D	
48 B	24 D	
49 D	25 D	
50 B	26 C	
51 A	27 D	
52 B	28 C	
53 E	29 D	
54 D	30 D	
55 B	31 C	
56 D	32 A	
57 B	33 E	
58 A	34 A	
59 A	35 B	
60 D	36 D	
61 A	37 A	
62 D	38 E	
63 A	39 D	
64 D	40 C	
65 E	41 B	
66 D	42 C	
67 C	43 C	
68 A	44 E	
69 B	45 A	
70 C	46 B	
	47 C	
Prueba 6	48 C	
1 D	49 E	